



“Claro, profundo,
atraente e, às vezes,
engraçado, este livro
fortalecerá sua
prática de DBT.”

**Marsha M.
Linehan**

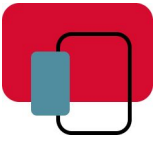
Princípios da terapia comportamental dialética em ação

*aceitação, mudança e
dialética na DBT*

Charles R. Swenson



artmed



Aviso!

Todo esforço foi feito para garantir a qualidade editorial desta obra, agora em versão digital. Destacamos, contudo, que diferenças na apresentação do conteúdo podem ocorrer em função de restrições particulares às versões impressa e digital e das características técnicas específicas de cada dispositivo de leitura.

Este *eBook* é uma versão da obra impressa, podendo conter referências a este formato (p. ex.: “Circule conforme indicado no exemplo 1”, “Preencha o quadro abaixo”, etc.). Buscamos adequar todas as ocorrências para a leitura do conteúdo na versão digital, porém alterações e inserções de texto não são permitidas no *eBook*. Por esse motivo, recomendamos a criação de notas. Em caso de divergências, entre em contato conosco através de [nosso site](#).

Charles R. Swenson

Princípios da terapia comportamental dialética em ação

*aceitação, mudança e
dialética na DBT*

Tradução
Patrícia Alsina

Revisão técnica
Vinícius Guimarães Dornelles

Psicólogo. Mestre em Psicologia: Cognição Humana pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Primeiro e único treinador de Terapia Comportamental Dialética oficialmente reconhecido pelo Behavioral Tech nativo de língua portuguesa. Dialectical Behavior Therapy: Intensive Training (Behavioral Tech e The Linehan Institute, Estados Unidos). Formación en Terapia Dialéctico Conductual (Universidad Nacional de Luján, Argentina). Formação em tratamentos baseados em evidência para o transtorno da personalidade borderline (Fundación Foro, Argentina). Especialização em terapias cognitivo-comportamentais (WP), coordenador local do Dialectical Behavior Therapy: Intensive Training Brazil e sócio-diretor da DBT Brasil.

Versão impressa desta obra: 2024



A Artmed é a editora
oficial da FBTC

Porto Alegre
2024

Obra originalmente publicada sob o título *DBT Principles in Action: Acceptance, Change, and Dialectics*, First Edition

ISBN 9781462536108

Copyright © 2016 The Guilford Press
A Division of Guilford Publications, Inc.

Gerente editorial: *Letícia Bispo de Lima*

Colaboraram nesta edição:

Coordenadora editorial: *Cláudia Bittencourt*

Editora: *Paola Araújo de Oliveira*

Capa: *Paola Manica | Brand&Book*

Preparação de originais: *Mirela Favaretto*

Leitura final: *Netuno*

Editoração: *Ledur Serviços Editoriais Ltda.*

Produção digital: *HM Digital Design*



ASSOCIADO



S974p Swenson, Charles R.

Princípios da terapia comportamental dialética em ação :
aceitação, mudança e dialética na DBT [recurso eletrônico] /
Charles R. Swenson ; tradução: Patrícia Alsina ; revisão técnica:
Vinícius Guimarães Dornelles. – Porto Alegre : Artmed, 2024.
Artmed, 2024.
E-pub.

Editado também como livro impresso em 2024.
ISBN 978-65-5882-192-2

1. Psicoterapia. 2. Terapia cognitivo-comportamental.
I. Título.

CDU 616.89

Catálogo na publicação: Karin Lorient Menoncin – CRB 10/2147

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa,
ao

GA EDUCAÇÃO LTDA.

(Artmed é um selo editorial do GA EDUCAÇÃO LTDA.)

Rua Ernesto Alves, 150 – Bairro Floresta

90220-190 – Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3027-7000

SAC 0800 703 3444 – www.grupoa.com.br

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

Autor

Charles R. Swenson, MD, é professor clínico associado de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da University of Massachusetts e atende adultos, famílias e adolescentes em seu consultório particular de psiquiatria e psicoterapia em Northampton, Massachusetts. Primeiro profissional autorizado por Marsha M. Linehan a oferecer treinamento intensivo em terapia comportamental dialética (DBT), é cofundador da International Society for the Improvement and Teaching of DBT (ISITDBT) e tem mais de 25 anos de experiência na prática, supervisão, treinamento e implementação da DBT em sistemas de saúde mental no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa. Swenson publicou vários artigos e capítulos de livros sobre a DBT e recebeu o prêmio Cindy J. Sanderson Outstanding Educator da ISITDBT, sendo um Distinguished Life Fellow da American Psychiatric Association. Seu site é <https://charlieswenson.com>.

Agradecimentos

Tenho tantas pessoas incríveis a quem agradecer pelo que aprendi e ensinei e pela oportunidade que tive de escrever este livro.

Cindy Sanderson era minha amiga mais próxima, fora minha esposa, até morrer, aos 49 anos, de câncer de mama. Ela era minha amiga de DBT, tendo me ajudado a desenvolver o primeiro programa de DBT para pacientes internados. Fomos professores de *workshops* de DBT por uma década. Éramos fanáticos por basquete juntos. Nunca houve uma mistura tão grande de intelecto, paixão e sagacidade no ensino da DBT. Nunca me diverti tanto ensinando. Jamais esquecerei o dia em que ela enfrentou o fim, quando disse “Charlie, nos últimos 11 anos, perguntei sobre meu câncer: ‘Por que eu?’. Hoje, enquanto estava sentada na varanda olhando a beleza do mundo, pensei, pela primeira vez: ‘Por que não eu?’”. Cindy, obrigado, você é um ser incrível onde quer que esteja, e nós dois sabemos que você teria escrito este livro comigo.

Marsha Linehan tem sido uma amiga, colega, mentora e modelo para mim há quase três décadas, e sua generosidade enriqueceu minha vida mais do que posso explicar aqui. Seu trabalho criou o contexto para o meu trabalho. Os detalhes das sessões de supervisão com ela permanecem comigo 25 anos depois. A história de sua vida e sua busca incansável para resgatar outras pessoas do inferno me inspiraram. Sua capacidade de transitar entre críticas construtivas ferozes em um momento e compaixão, empatia e risadas no momento seguinte é extraordinária. Obviamente, este livro não poderia ter sido escrito sem ela, e toda precisão em minha compreensão da DBT se deve a ela.

Shireen Rizvi é uma amiga querida, uma professora maravilhosa e atenta, uma cientista DBT, uma colega fã de esportes e uma cantora de *karaokê* que catalisou minha carreira de compositor DBT. Com seus alunos da Rutgers University, Shireen leu vários rascunhos dos primeiros capítulos deste livro e forneceu um *feedback* inestimável.

Minha gratidão vai para muitos terapeutas, treinadores e outros heróis. Três me influenciaram profundamente. Com sua mente aberta e coração corajoso, Kelly Koerner aumentou minha própria coragem. Alec Miller sempre ensinou de forma extraordinária e com muita diversão, apesar de sua paixão pelo New York Yankees. Perry Hoffman dedicou seu tempo e abundantes talentos a indivíduos com transtorno da personalidade *borderline* e suas famílias, e tem sido uma fonte de equilíbrio e sabedoria para mim. Meus professores mais importantes foram meus pacientes.

Como nunca tinha escrito e publicado um livro, não sabia o que esperar de um editor. Acho que tive uma experiência incomum e abençoada ao trabalhar com Kitty Moore na The Guilford Press. Kitty estava entusiasmada com este livro bem antes de ele existir. Ela leu todos os capítulos de cada revisão, foi gentil, mas incisiva com sugestões, foi paciente quando a vida interveio para retardar meu progresso e, acima de tudo, foi explícita e incrivelmente encorajadora nos momentos em que eu estava convencido de que minha escrita era terrível e o projeto estava condenado. Tive a sorte de poder trabalhar com ela.

Edward Emery, um psicanalista erudito, tem sido um defensor incansável e um crítico construtivo de meu trabalho e, como meu terapeuta, ajudou-me a encontrar minha voz.

Adorei ser professor, ensinei e aprendi ao lado de pessoas talentosas, comprometidas e compassivas em minha jornada DBT; todas elas contribuíram para este livro de uma forma ou de outra. É uma homenagem a Marsha Linehan que tantas pessoas incríveis tenham permanecido leais e apaixonadas pela DBT. Prefiro não

citar todas aqui, mas elas incluem todos para quem ensinei DBT nos últimos 30 anos, cerca de 30 ou 40 indivíduos dos Estados Unidos e da Europa. Obrigado a todos.

Meredith Gould, PhD, minha esposa e o amor da minha vida, não é uma terapeuta DBT. No entanto, mais do que qualquer outro psicoterapeuta, ela tem sido meu modelo. Ela tem um nível de generosidade, devoção, franqueza, irreverência, genuinidade e compaixão que eu só posso almejar ter. Ela libertou muitos do sofrimento durante sua prática. É minha amiga mais próxima, meu amor mais querido e minha ouvinte. Nossos dois filhos e eu tivemos a sorte de receber seus cuidados e carinho em casa. Ela apoiou a escrita deste livro e o tornou possível. Minha gratidão a ela vai além de qualquer palavra.

Meus dois filhos, Max e Ruben, significam tudo para mim.

Obrigado, pessoal!

Apresentação

Charlie Swenson me ligou em 1987 pela primeira vez. Eu estava conduzindo o primeiro ensaio randomizado controlado de DBT e aprimorando o tratamento, que naquele momento não existia fora do meu laboratório na University of Washington. Charlie explicou que era psiquiatra em Nova York, professor associado de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Cornell University e diretor de uma unidade de tratamento de internação de longo prazo para indivíduos com graves transtornos da personalidade. Seu mentor e diretor médico era Otto Kernberg, psicanalista amplamente conhecido por suas teorias sobre transtornos da personalidade. O programa de tratamento de Charlie baseava-se no modelo de tratamento de Kernberg, agora conhecido como psicoterapia focada na transferência (TFP, do inglês *transference-focused therapy*).

Tendo conhecido meu trabalho por meio de um colega, Charlie perguntou se ele e sua esposa, Meredith, uma psicóloga clínica, poderiam me visitar em Seattle e aprender sobre DBT. Naquela fase, como criadora de uma abordagem de tratamento ainda não publicada para indivíduos suicidas, fiquei chocada com o fato de um psiquiatra, chefe de um programa de tratamento altamente respeitado em um famoso hospital de Nova York, parar tudo para visitar uma psicóloga desconhecida simplesmente porque uma outra pessoa disse a ele que ela tinha o tratamento mais eficaz para os pacientes que estava tratando. Muito incomum, devo dizer. Mais importante, ele era humilde e cuidava apaixonadamente de seus pacientes. Convidei Charlie e Meredith para meu laboratório, e logo me visitaram por cerca de uma semana. Dada a sua formação em tratamento psicanalítico, fiquei ainda mais

impressionada com a disposição de Charlie em abrir os olhos para um modelo muito diferente, baseado no comportamentalismo, no zen e na dialética. Após a visita, Charlie passou a desenvolver um programa de tratamento inteiramente baseado em DBT com um de seus pacientes. Não foi uma tarefa fácil, pois eu havia desenvolvido um tratamento totalmente ambulatorial. O programa de Charlie foi o primeiro programa de internação de DBT e serviu como modelo nessa área por muitos anos.

Durante minha licença sabática no hospital e no programa de Charlie, enquanto escrevia meu manual de tratamento da DBT, visitei sua unidade todos os dias e trabalhei com ele, sua equipe e pacientes. Charlie passou a acreditar na DBT, uma mudança monumental para um psicanalista. Com sua equipe, ele foi um dos 20 participantes do primeiro treinamento intensivo de DBT de 10 dias em 1993. Ele finalmente começou seus próprios treinamentos intensivos, que tem feito desde então. Quando fiz meu primeiro programa de treinamento com Charlie, descobri que ele não apenas conhece o tratamento, mas também é um professor de DBT muito eficaz, criativo, compassivo e carismático. Até hoje, ele é professor de professores, um modelo sobre como tornar a DBT clara e acessível a especialistas e profissionais em todos os níveis. Quando meus alunos e eu decidimos fundar a International Society for the Improvement and Teaching of DBT (ISITDBT), Charlie estava conosco e foi o diretor do programa nos primeiros dois anos de sua conferência anual, em 1996 e 1997. Em 2003, recebeu o primeiro Prêmio Cindy J. Sanderson Outstanding Teacher concedido pela ISITDBT. Nos últimos 20 anos, ele desempenhou um importante papel na implementação da DBT em uma variedade de ambientes de tratamento na América do Norte e na Europa.

Tendo feito tudo isso para milhares de alunos em *workshops*, seminários, consultorias e supervisões, Charlie agora divide sua experiência com os leitores de *Princípios da terapia comportamental dialética em ação: aceitação, mudança e dialética*

na DBT. Não há outro livro assim: claro, profundo, atraente e, às vezes, até engraçado. É fiel ao modelo da DBT e ao mesmo tempo pessoal, parecendo que você está em uma supervisão com ele. Tenho certeza de que fortalecerá sua prática de DBT, onde quer que você esteja.

Marsha M. Linehan, PhD, ABPP

*Professora e diretora do Behavioral Research and
Therapy Clinics da University of Washington*

Prefácio

Estava no 6º ano do ensino fundamental em Albany, Oregon. Eu era um corredor incrivelmente lento. Na aula de educação física, quando todos nos alinhamos para correr o mais rápido possível pelo ginásio, terminei em um constrangedor último lugar. Poderia ter sido menos humilhante se eu não tivesse um, e apenas um, objetivo na vida naquela época: ser um jogador profissional de basquete. Como um rato de academia, procurei academias abertas à noite e nos fins de semana para jogar basquete o máximo possível. Eu tinha algumas vantagens: era alto, inteligente, ambicioso e, com toda a prática, conseguia arremessar com precisão. Mas isso não serviria de nada se continuasse tão lento.

Seguindo conselhos específicos do treinador de atletismo da University of Oregon, nos dois anos seguintes treinei de manhã e à noite para aumentar minha velocidade, agilidade e força. Quando estava no ensino médio, tinha pernas muito fortes, mas não era muito mais rápido. À medida que meus anos de colégio se desenrolavam e enquanto outros jogadores tinham surtos de crescimento, meu ritmo de caracol tornou-se uma desvantagem crescente. Aos 16 anos, meu sonho havia desmoronado. Quando me virei para o golfe como um esporte alternativo e para os estudos, minha sensação principal na época era de que meu sonho de toda a vida havia sido destruído.

Avanço para 1978, 18 anos depois de terminar em último lugar na minha aula de educação física. Eu havia me formado em Medicina, me tornado médico e estava fazendo residência em Psiquiatria na Yale University. Enquanto estava lá, fiz minha formação psicanalítica e me envolvi em vivenciar minha própria psicanálise, conforme exigido pelo programa. Repassei os

dolorosos detalhes do colapso de meu sonho com meu psicanalista. Enquanto lhe contava a história, indiquei que meu ritmo lento era determinado geneticamente por meus pais, que me sobrecarregaram com desvantagens biológicas. Ele fez uma pergunta estranha: “O que faz você pensar que é tão lento?”. Eu respondi: “Porque eu *era* lento! Eu ainda sou lento. Meus tempos para 100, 440 (quarto de milha) ou uma milha são embaraçosos demais para serem mencionados”. Depois de uma pausa, ele perguntou novamente: “Mas o que faz você *pensar* que é tão lento?”. Fiquei surpreso e irritado: “Eu disse, é porque eu *sou* lento! Eu sou um corredor lento. Eu corro devagar e tenho os tempos para provar isso”. Àquela altura, me arrependi de ter trazido o assunto à tona, já tendo a impressão de que ele não se interessava por atletismo. Depois de outra pausa, ele repetiu pela terceira vez: “Mas o que faz você pensar que é tão lento?”. Nesse ponto, eu não tinha certeza de como responder. Minha surpresa agora era choque, minha irritação era raiva absoluta; além disso, senti alguma preocupação por ele. O que estava acontecendo? Ele não me ouviu? Estava tentando me irritar? Estava tendo um AVC? Resolvi parar de falar sobre isso; foi muito constrangedor! Segui em frente.

Mas, fora das minhas sessões psicanalíticas quatro vezes por semana, não “saí” do assunto. Durante minhas sessões habituais de corrida para exercícios, que incluíam correr em uma pista nos campos de atletismo da universidade (o “Yale Bowl”, como era chamado), notei um atleta que frequentemente treinava lá e que claramente levava a sério a corrida. Criei coragem, aproximei-me dele e perguntei: “Tenho visto você aqui muitas vezes. Você é claramente um corredor, e eu não. Sempre quis aumentar minha velocidade e, no passado, trabalhei duro para isso, mas sem resultados. Você estaria disposto a me ver correr e me dar dicas?”. Ele aceitou e me pediu para correr em torno de 37 metros o mais rápido que eu pudesse. Nas semanas seguintes, várias vezes por

semana, ele me ensinou a correr. Fez sugestões, monitorou meus tempos e me incentivou. O que foi tão útil, além de sua atitude voluntária e até devotada, foi a especificidade de suas sugestões.

- “Você é alto, então tem que encurtar seus passos.”
- “Você precisa sentir que seus passos são realmente curtos.”
- “Bata as pernas no chão como se fossem pistões de um motor.”
- “Olhe para a frente, para a pista, não de um lado para o outro.”
- “Você precisa se inclinar para a frente na direção em que está correndo, quase como se fosse cair de cara no chão, o que vai dizer às suas pernas para acelerar.”
- “Você precisa se concentrar no chão à sua frente, e em nenhum outro lugar, e apenas dizer a si mesmo: ‘mais rápido, mais rápido, mais rápido’.”

Implementei suas dicas de treinamento e trabalhei com mais intensidade. Ele reforçou meus esforços com suas sugestões e, em poucas semanas, eu estava correndo mais rápido do que nunca. Corri 1,6 km em 5 minutos e 35 segundos – mais de dois minutos mais rápido do que qualquer corrida similar anterior. Eu tinha quase 30 anos na época e era tarde demais para uma mudança de carreira para a National Basketball Association (NBA), mas foi incrível e maravilhoso ter descoberto que poderia aumentar drasticamente minha velocidade de corrida.

Enquanto isso, não falei sobre meus esforços e façanhas com meu psicanalista. Continuei zangado com ele por suas perguntas repetitivas e sua incapacidade de transmitir empatia. Não queria dar a ele a impressão de que seus comentários me motivaram. Na verdade, sua persistência desagradável plantou sementes de dúvida em minha mente sobre a inevitabilidade do meu déficit de corrida. Seus comentários me motivaram a pensar, me esforçar, pedir suporte técnico e, finalmente, melhorar minha velocidade. Inúmeras vezes refleti sobre sua pergunta repetitiva. Obviamente,

ele não era estúpido. Eu não acho que ele tenha sido insensível e ficou claro que não teve um AVC. Eu nem acho que ele estava tentando me provocar. Concluí que ele estava realmente se perguntando o que me fazia *pensar* que eu era tão lento. Ele deve ter percebido, ao ouvir minha “voz interior”, que eu mesmo estava de fato perplexo com minha própria falta de progresso na corrida. Ele deve ter ouvido, enquanto escutava com seu “terceiro ouvido”, uma falha na minha convincente explicação “genética”. Acho que ele não se importava se eu corria mais rápido; sua preocupação era a história da minha vida interior e a maneira como eu me representava e me entendia. Ele interveio da maneira que fez porque podia ouvir, ou sentir, uma discrepância em meu enredo.

Para mim, com o passar do tempo e refletindo sobre como consegui mudar um padrão de comportamento tão arraigado, a lição que ficou foi a seguinte: *para mudar, precisava de um analista e de um treinador*. Eu precisava de uma pessoa que prestasse atenção à minha história com detalhes suficientes, ouvisse com mais atenção do que qualquer outra e tivesse a coragem de contestar minha explicação convincente. E precisava de outra pessoa que fosse especialista na mecânica, alguém que pudesse me observar correr, prestar atenção aos detalhes da corrida, oferecer sugestões, monitorar meu progresso e fornecer reforços. Talvez a mesma pessoa pudesse ter desempenhado os dois papéis – não sei. O que ficou comigo, porém, e o que permaneceu comigo até este momento, foi a mensagem de que somos capazes de mudar padrões de comportamento muito arraigados e que, para fazer isso, podemos precisar de um “analista” e um “treinador”.

Em 1987, estava em meu quinto ano como chefe de unidade de um programa de internação de longo prazo orientado psicanaliticamente no New York Hospital – Cornell Medical Center, Westchester Division, em White Plains, Nova York. Baseamos nosso trabalho no modelo ego-psicológico de relações objetais de Otto Kernberg, que também foi nosso diretor médico e meu mentor

e supervisor. Durante aquele ano, estávamos tratando de uma jovem que fazia esforços incansáveis para se machucar e se matar. Por meses a fio, ela permaneceu em constante supervisão individual, 24 horas por dia, e ainda assim frequentemente perdia o controle e era colocada em restrições. Fiquei perplexo e preocupado com nossa ineficácia em encontrar uma solução.

Um dia, enquanto ela estava sentada na sala de segurança sob observação, revisei novamente sua história e tratamento. No andar de baixo, acontecia uma conferência sobre transtornos da personalidade. Eu fui até as reuniões e encontrei um colega sênior chamado Allen Frances, que também fazia parte da faculdade de psiquiatria de Cornell e era especialista em transtornos da personalidade. Perguntei se ele estaria disposto a subir e se juntar a mim em uma consulta informal sobre o tratamento dessa paciente. Ele concordou prontamente e em poucos minutos nós dois estávamos sentados no chão da sala de segurança em frente à paciente em questão. O doutor Frances a entrevistou em detalhes. Após cerca de 45 minutos, ele me surpreendeu dizendo a ela: “Tenho uma sugestão para você. Em Seattle, Washington, mora uma psicóloga chamada Marsha Linehan. Ela desenvolveu um programa de tratamento para pacientes com problemas como o seu, tudo em nível ambulatorial. É uma nova abordagem e acho que seria uma boa opção. Por que você não se recompõe, sai daqui e vai até Seattle para conhecê-la?”.

A princípio, fiquei irritado porque o doutor Frances transmitiu essa recomendação diretamente à paciente, sem falar comigo primeiro. Ele não percebeu que isso poderia piorar a situação para minha equipe e para mim, trabalhando com uma paciente que agora havia sido informada de que estaria melhor em outro lugar? Acontece que ele não estava muito preocupado com minha equipe; ele estava mais preocupado com o fato de a paciente encontrar o que precisava. Foi a primeira vez que ouvi falar de Marsha Linehan.

Curioso sobre o trabalho e o programa de Linehan, descobri que ela era uma terapeuta cognitivo-comportamental e especialista em suicídio e comportamentos de autolesão. Eu não estava familiarizado com as terapias cognitivo-comportamentais. Além disso, havia absorvido o viés psicanalítico da época, em que os tratamentos comportamentais eram considerados superficiais em seu impacto, trazendo “mera” mudança comportamental em vez da muito mais desejável “mudança intrapsíquica estrutural”. Localizei o primeiro relatório de Linehan (1987) sobre seu programa de tratamento para pacientes com transtorno da personalidade *borderline* no *Bulletin of the Menninger Clinic*, um periódico de orientação psicanalítica. Foi fascinante ler sobre a aplicação de uma abordagem comportamental em nível ambulatorial aos tipos de indivíduos que estávamos tratando com psicoterapia psicanalítica em uma unidade de internação.

Assim que pudemos providenciar, viajei para Seattle com minha esposa, Meredith Gould, psicóloga clínica e especialista no modelo de tratamento de Kernberg. Passamos mais de uma semana no laboratório de Linehan na University of Washington, que na época era o único local no mundo onde a DBT estava em andamento. Ainda se passariam quatro anos antes da publicação do primeiro ensaio randomizado controlado de Linehan (Linehan, Armstrong, Suares, Allmon, & Heard, 1991) e seis anos antes da publicação de seu manual de tratamento e manual de treinamento de habilidades em DBT (Linehan, 1993a, 2010). Tivemos a oportunidade de ter longas discussões com a doutora Linehan sobre o tratamento e testemunhá-la tratando seus pacientes em vídeo e atrás de um espelho falso.

Eu estava fascinado. O modelo de Linehan era claramente comportamental, incluindo alvos específicos de tratamento definidos comportamentalmente, treinamento de habilidades e *role-play*, todos em desacordo com uma abordagem psicanalítica. Além disso, ela conduziu seu tratamento em uma atmosfera validante e

compassiva, em total desacordo com a objetividade, os limites e a neutralidade técnica de uma abordagem psicanalítica. No entanto, pude ver que a abordagem de Linehan tinha muito em comum com o estilo de Kernberg. Ambos foram rigorosos em sua adesão a seus modelos teóricos e práticos de tratamento; estabeleceram relações intensas com os pacientes dentro de claros marcos de acordos; organizaram agendas de sessão de acordo com hierarquias de prioridades temáticas ou alvos prioritários; e eram falantes, diretos e até confrontadores, com os pacientes. Em 1989, tentei especificar as semelhanças e diferenças entre as duas abordagens em um artigo publicado no *Journal of Personality Disorders*. Eu valorizava a elegância do modelo de Kernberg para entender e intervir com “estados mentais primitivos”. Valorizei a atenção de Linehan aos detalhes comportamentais e ao modelo de treinamento de indivíduos para substituir comportamentos desadaptativos por habilidades. Mais uma vez, vi o valor de ter um analista e um treinador. Resolvi introduzir habilidades da DBT e *coaching* em meu programa psicanalítico de internação.

Minha equipe sênior não tinha nada disso. Na perspectiva deles, a incorporação de elementos do tratamento comportamental, principalmente na psicoterapia, contaminaria e subestimaria o modelo psicanalítico teoricamente consistente. Tendo me precedido em seu trabalho com Kernberg, eles se mantiveram inflexíveis em uma espécie de pureza teórica. Fiquei momentaneamente frustrado, mas meu supervisor e administrador, Richard Munich, encontrou uma alternativa. Observando que o chefe de outra unidade de internação sob sua administração estava deixando o cargo, ele propôs que eu desenvolvesse um programa de internação baseado em DBT. Agarrei-me à oferta e dirigi ambas as unidades durante os 18 meses seguintes, indo e vindo várias vezes por dia, mudando de um modelo para o outro à medida que avançava. Foi uma oportunidade incrível explorar essas duas abordagens, aprender DBT e encontrar mais maneiras

de tratar os pacientes. Recrutei seis colegas para se juntarem à minha equipe sênior na unidade DBT e empreendemos a jornada juntos. No final das contas, nossa primeira tarefa foi aprender a praticar terapias cognitivo- -comportamentais. Devagar, mas com segurança, entendi que a DBT continha o papel do analista (o psicoterapeuta que se concentrava na motivação) e do treinador (o treinador de habilidades). Fiquei feliz por ter encontrado meu nicho.

Em 2013, eu estava praticando DBT com pacientes e a implementei em vários ambientes diferentes onde trabalhei. Forneci treinamento intensivo de 10 dias para mais de 400 equipes de tratamento e dei consultoria sobre sua implementação em mais de 500 programas, variando de internação a ambulatorial, adulto a adolescente, tratamento diurno a residencial, gerenciamento de casos a pronto-socorro e abuso de substâncias a transtornos alimentares. Ter que aplicar DBT em tantas circunstâncias diferentes exigiu rigor e flexibilidade: adesão rigorosa ao modelo baseado em evidências e flexibilidade em adaptá-lo a diferentes populações e contextos (Koerner, Dimeff, & Swenson, 2007). Onde adaptações foram necessárias, aprendi a mantê-las dentro dos princípios de tratamento e as descrevi com mais detalhes para mim. Ao intensificar meu foco nos princípios da DBT em psicoterapia e ensino, descobri que estava mais fluido e criativo do que antes, embora ainda aderisse ao modelo. A dialética de adotar a DBT com rigor e adaptá-la dentro dos princípios tornou-se minha marca registrada. Decidi escrever este livro na esperança de que minha evolução e minhas descobertas ajudem outras pessoas.

Fui cauteloso ao escrever este livro, tentando deixar bem claro que um enfoque terapêutico baseado em princípios não é uma alternativa a uma abordagem baseada em protocolo. Eles andam de mãos dadas, e o uso correto dos princípios aprofundará e ampliará o alcance do terapeuta cujo trabalho segue o manual da DBT. Isso o ajudará a navegar e transformar momentos

desafiadores, a permanecer no caminho certo e a manter o movimento quando surgirem impasses.

Sumário

Apresentação

Marsha M. Linehan

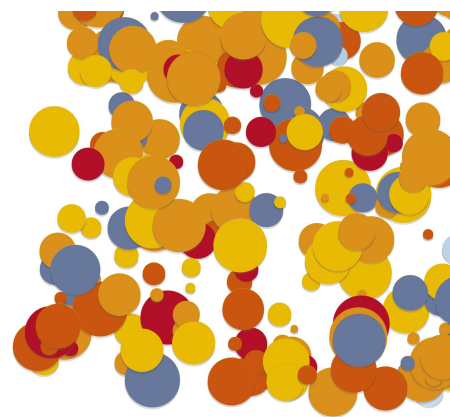
Prefácio

- 1** Começando a terapia: pré-tratamento e a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida
- 2** Apresentando os três paradigmas da terapia comportamental dialética
- 3** O paradigma da aceitação
- 4** O paradigma da mudança
- 5** O paradigma dialético
- 6** A árvore da terapia comportamental dialética: anatomia estrutural
- 7** Metas, estágios, alvos e hierarquia de alvos prioritários
- 8** Dilemas dialéticos e alvos secundários

- 9** Formulação de caso em terapia comportamental dialética
- 10** Comprometimento e estratégias para o comprometimento
- 11** Análise em cadeia do comportamento
- 12** Validação
- 13** Estratégias dialéticas
- 14** Habilidades e treinamento de habilidades
- 15** Prevenção e tratamento de *burnout* do terapeuta

Posfácio

Referências



Começando a terapia

Pré-tratamento e a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida

Mesmo seguindo rigorosamente os manuais de tratamento da terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) (Linehan, 2010, 2018b), o terapeuta ainda se depara com milhares de escolhas a cada sessão. Por exemplo, embora o manual especifique que o terapeuta deve iniciar a sessão revisando o cartão diário com o paciente, não pode dizer ao terapeuta se deve ser frio, firme e assertivo ou caloroso, validante e encorajador no processo. Ele não pode dizer ao terapeuta se deve avaliar o comportamento de não adesão que interfere na terapia ou se deve pedir ao paciente que preencha o cartão ali mesmo. E, além disso, o manual não pode dizer ao terapeuta quando – se é que deve permitir – não cumprir as tarefas do cartão diário, em deferência a outras prioridades.

No tratamento de uma condição grave, crônica e complexa, é uma bênção ter um manual tão abrangente, repleto de metas, estágios e alvos; funções e modos; acordos e pressupostos; protocolos prescritos; dezenas de habilidades; e mais de 80 estratégias diferentes. E é função do terapeuta DBT aprender e praticar todos esses elementos em um nível esperado de aderência. Dada a base de evidências substancial e crescente para a DBT (Feigenbaum et al., 2011; Gutteling, Montagne, Nijs, &

van den Bosch, 2012; Harned, Jackson, Comtois, & Linehan, 2010; Harned, Korslund, & Linehan, 2014; Hill, Craighead, & Safer, 2011; Koons et al., 2001; Linehan et al., 1999, 2002, 2006; Linehan, Armstrong, Suares, Allmon, & Heard, 1991; Linehan, Heard, & Armstrong, 1993; Linehan, McDavid, Brown, Sayrs, & Gallop, 2008; Lynch, Morse, Mendelson, & Robins, 2003; Mehlum et al., 2014; Neacsui, Rizvi, & Linehan, 2010; Rathus & Miller, 2002; Safer, Robinson, & Jo, 2010; Safer, Telch, & Agras, 2001; Telch, Agras, & Linehan, 2001; Turner, 2007; van den Bosch, Koeter, Stijnen, Verheul, & van den Brink, 2005; van den Bosch, Verheul, Schippers, & van den Brink, 2002; Verheul, van den Bosch, & Koeter, 2003), o curso responsável é praticar o tratamento abrangente em DBT como especificado em sua base de evidências. No entanto, até um terapeuta experiente, que pratica DBT de forma aderente, pode descobrir que, muitas vezes, não tem certeza do que fazer *na maior parte do tempo*. Em outras palavras, cada uma das etapas, protocolos e estratégias prescritas pode ser executada de centenas de maneiras diferentes, e os intervalos entre as etapas são maiores do que as próprias etapas. Uma análise em cadeia do comportamento do mesmo episódio de um dado comportamento pode ser realizada de pelo menos um milhão de maneiras diferentes.

Mas é claro que é exatamente por isso que Linehan descreveu a DBT como um *tratamento baseado em princípios* com protocolos. Determinar como realizar as etapas prescritas e navegar pelos intervalos entre elas requer clareza inabalável sobre metas e alvos; tato, *timing* e agilidade; persistência, paciência e coragem; e uma compreensão superaprendida das estratégias da DBT. Por trás dessas avaliações clínicas momentâneas, o terapeuta é guiado por uma compreensão profunda e precisa dos princípios da DBT. Isso é verdade desde o início do tratamento. A primeira etapa é chamada de *pré-tratamento*, mas, para ficar bem claro, pré-tratamento já é tratamento, desde o primeiro minuto. O terapeuta

deve estar preparado com todo o pacote de tratamento da DBT desde o início. Neste capítulo, apresento o papel dos paradigmas e princípios na DBT, considerando o manejo baseado em princípios do estágio de pré-tratamento. Os princípios, dos quais fluem as estratégias e os protocolos, são derivados dos três paradigmas subjacentes à DBT: aceitação, mudança e dialética. Nos próximos quatro capítulos, apresento os paradigmas de maneira mais formal e os princípios que deles decorrem.

ESTRATÉGIAS PRÉ-TRATAMENTO E A CONVERSA SOBRE A VIDA QUE VALE A PENA SER VIVIDA

O paciente que entra em DBT está em um impasse. Ele pode ter pensado em suicídio e talvez até se envolvido ativamente em comportamento suicida. Ele, sem dúvida, fez esforços para melhorar sua vida, com sucesso limitado, temporário ou nenhum. Ao falhar em encontrar uma saída, seja acabando com sua vida ou construindo uma vida melhor, está em um estado de espera. Ele tenta evitar desencadeantes emocionais, mas é quase impossível fazê-lo. Tenta bloquear ou escapar de emoções dolorosas usando comportamentos que trazem alívio, mas muitos deles são autodestrutivos, e o alívio é temporário. O tempo está parado. Os esforços para ter algum alívio substituem os esforços para construir uma vida. Um de meus primeiros mentores, Otto Kernberg (1984), referia-se rotineiramente a um subgrupo de pacientes impulsivos com organização de personalidade *borderline* como tendo suicídio e hospitalização como modo de vida. Afirmações semelhantes podem ser feitas sobre aqueles cujos “modos de vida” giram em torno de autolesão, abuso de substâncias, transtornos alimentares, violência, dissociação e outros comportamentos de “esquiva”. O sofrimento é intenso, a desesperança cresce, e a capacidade de imaginar uma vida que valha a pena ser vivida se esvai. No pré-tratamento, desde o primeiro minuto de terapia, são feitos esforços a fim de fortalecer a motivação do paciente para viver e se comprometer com um plano de tratamento.

Em seu manual de tratamento (Linehan, 2010, pp. 405-414), Linehan descreveu as “estratégias do contrato: início do tratamento” para iniciar a DBT. Ela define de forma clara e precisa as etapas a serem seguidas, que normalmente levam pelo menos

as primeiras quatro sessões e constituem o estágio de pré-tratamento. Após uma avaliação diagnóstica, o terapeuta sequencialmente: 1) apresenta o modelo biossocial ao paciente; 2) orienta-o para as características distintivas da DBT; 3) ajuda a orientar a rede socioprofissional do paciente para o tratamento; 4) revisa os acordos e as regras do tratamento; 5) usa estratégias de comprometimento para obter o compromisso do paciente com a DBT; 6) conduz análises iniciais dos principais comportamentos-alvo; e 7) começa a desenvolver um relacionamento de tratamento colaborativo. O principal objetivo do pré-tratamento é obter a concordância do paciente sobre um plano de tratamento envolvendo um conjunto priorizado de alvos comportamentais e o maior comprometimento possível com esse plano. O manual especifica as etapas a serem seguidas e fornece uma excelente estrutura para começar.

Na terapia cognitivo-comportamental (TCC) de transtornos menos graves, as estratégias de contratação prescritas geralmente funcionam bem para orientar o paciente, chegar a um plano de tratamento racional e específico e estabelecer a credibilidade do tratamento e do terapeuta. Em outras palavras, os passos prescritos pelo manual são suficientes para traçar o curso inicial e começar bem o tratamento. No entanto, ao trabalhar com indivíduos com desregulação emocional grave e crônica (cujas respostas válidas foram amplamente invalidadas pelo ambiente familiar, social e/ou profissional), o estágio de pré-tratamento – na verdade até mesmo o primeiro minuto com o paciente – pode ser desafiador. O terapeuta desenvolve a sequência de intervenção passo a passo no protocolo de contrato de forma aderente, ao mesmo tempo que navega por essas dificuldades iniciais, mantendo os princípios da DBT em mente, permitindo flexibilidade e improvisação. O terapeuta pode seguir o manual, sintonizar-se com o paciente e permanecer hábil no momento.

PRINCÍPIOS DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA E A CONVERSA SOBRE A VIDA QUE VALE A PENA SER VIVIDA

Recentemente, comecei a terapia com uma mulher de 30 anos que teve um episódio de comportamento suicida após meses de episódios diários e repetitivos de condutas autolesivas sem intencionalidade suicida (CASIS). Ela havia sido diagnosticada com transtorno da personalidade *borderline* (TPB) no hospital e foi encaminhada para DBT comigo após a alta. Por telefone, ela disse que “tentaria a terapia”. Quando ela chegou ao nosso primeiro encontro, me pareceu equilibrada, inteligente, perspicaz e cautelosamente disposta a começar. Perguntei a ela: “O que você espera alcançar na terapia?”. Foi como se eu tivesse apertado um botão; ela passou de receptiva e conversadora para raivosa e enérgica. Parecia que eu a tinha ofendido. “Essa é uma pergunta estúpida! Você não sabe nada sobre mim! Por que você acha que posso alcançar qualquer coisa?! Minha vida acabou! Eu tentei de tudo, e isso só me deixou pior! Eu fui ferida... irreparavelmente!”

Menos de um minuto em nosso relacionamento e já estávamos enfrentando dificuldades. Por um lado, essa dificuldade foi fortuita, porque eu já estava experimentando, em primeira mão, alguns dos comportamentos problemáticos que estaria avaliando e tratando. Por outro lado, era difícil saber o que fazer, como responder. Mal sabia eu que minha pergunta sobre suas esperanças para o futuro havia criado um forte sentimento de vergonha e desesperança. Na infância, ela foi tratada como um fracasso e lhe foi dito que nunca seria nada. Para evitar a vergonha e a desesperança, ela aprendeu a evitar pensar no futuro em termos otimistas e a bloquear esforços ativos para melhorar sua vida. Ou seja, eu estava encontrando um bloqueio que vinha sendo construído há muitos anos, cujas origens eram um mistério para mim. Eu ainda não havia estabelecido um

relacionamento e não havíamos feito nenhum acordo sobre o que atingir ou como trabalhar juntos. No entanto, já estávamos em DBT.

É nesse tipo de situação que uma preocupação consciente com estratégias, protocolos e habilidades irá atrapalhar o terapeuta. O ideal é que todos esses movimentos técnicos sejam superaprendidos e estejam prontos para serem usados quando necessário. Mas o terapeuta precisa se mover em resposta ao paciente. A terapia é uma dança, não um seminário, e ficar parado pensando entre as estratégias é perder oportunidades e criar lacunas na sessão e no relacionamento. Minha recomendação ao longo deste livro é que o terapeuta, nesses momentos, seja sábio ao considerar qual caminho seguir, pensando em um desses três paradigmas: aceitação, mudança ou dialética. Cada um deles representa uma direção básica, e, se o terapeuta se mover em uma dessas direções, haverá princípios e estratégias. O *paradigma da aceitação* prescreve apenas estar presente, naquele momento, ouvindo, questionando, validando, elaborando, transmitindo objetividade, emanando compaixão e fornecendo clareza. O *paradigma da mudança* promove o impulso para a mudança comportamental, definindo metas e comportamentos-alvo, avaliando obstáculos, encontrando soluções, insistindo na ação e encorajando o paciente a fechar a lacuna entre os alvos designados e o funcionamento atual. O *paradigma dialético* concentra a atenção no equilíbrio, na síntese e no movimento: equilíbrio entre aceitação e intervenções de mudança, equilíbrio entre posições opostas ao encontrar a sabedoria de cada lado e a síntese das posições contraditórias. Quando o terapeuta se move em direção à aceitação, ele envolve as estratégias baseadas na aceitação da DBT. Quando ele se move em direção à mudança, envolve as estratégias de solução de problemas derivadas da TCC. E quando ele se move dialeticamente, se engaja no pensamento dialético e usa estratégias dialéticas.

Quando a raiva da paciente foi desencadeada pela minha pergunta sobre suas esperanças para o futuro, assumi imediatamente uma postura de aceitação. Abstive-me de “fazer” qualquer coisa, optando por apenas “estar lá” com ela. Tentei ser aberto, curioso, sem suposições ou julgamentos. Pressionar por mudanças parecia desaconselhável, visto que eu tinha tão pouca conexão ou informação, e improvisar com pensamento dialético parecia prematuro. Depois de uma pausa, disse: “Sinto muito. É verdade que ainda não a conheço. Preciso saber tudo sobre suas feridas antes de prosseguirmos”. A paciente pareceu apreciar o pedido de desculpas, sentiu-se validada, tornou-se mais regulada e começou a me contar sobre as tragédias que aconteceram durante os três anos anteriores.

Em outro caso, minha postura inicial de aceitação rapidamente preparou o terreno para uma transição suave em direção à mudança. Comecei minha avaliação de uma mulher de 44 anos que tinha um diagnóstico de bulimia nervosa crônica e severa, uma profunda sensação de vazio, ideação suicida persistente e diagnóstico de TPB, perguntando quais seriam suas metas para o tratamento. Ela respondeu: “Minha única meta é passar por hoje, e nunca tenho certeza se vou conseguir. Não consigo mais pensar no futuro. Não consigo nem pensar em pensar nisso”. Comecei com a aceitação: “Você está me dizendo que sua vida diária é demais para suportar. O futuro mal existe enquanto o presente é impossível”. Ela se sentiu compreendida. “Não penso no futuro desde que tinha uns 15 anos. Não existe tal coisa.” Eu estendi a frase dela adicionando “... ainda”. Foi um desafio gentil e representou uma ligeira mudança de aceitação para pedir a mudança (ou seja, a mudança em seu pensamento). Continuei na orientação para a mudança enquanto seguia a sugestão de que ela já havia tido uma visão de seu futuro. “Eu me pergunto como você imaginava o futuro quando tinha 15 anos, ou antes disso?” Ela prontamente respondeu: “Eu queria ser atriz”. Disse a ela que

estava tentando imaginá-la como atriz, esperando que ela pudesse elaborar. Rapidamente ela descartou a possibilidade: “Isso foi antes. Isto aqui é o agora. Não resta mais nada!”. Pelo menos tínhamos uma imagem de futuro, embora estivesse enterrada em um passado distante. Observe que, de uma perspectiva baseada em princípios, respondi inicialmente com validação, uma estratégia de aceitação; e tendo conseguido diminuir a distância entre nós, alternei para a mudança, desafiando sua negação do futuro – e mesmo que ela negasse novamente, pensei que já era um passo adiante lembrar que ela costumava ter um sonho.

Em alguns casos, quando começam as conversas sobre uma vida que vale a pena ser vivida, o terapeuta age com rapidez e coragem para mudar as estratégias. Depois da avaliação, comecei a terapia com uma mulher cujos problemas incluíam autolesão e alcoolismo. Seu estilo era reservado e educado, embora ela fosse cruel consigo mesma e com os outros quando estava embriagada. Perguntei quais metas ela poderia ter para o tratamento. “Sou vítima da minha própria estupidez. Eu realmente não posso dizer que mereço algo melhor do que tenho. Você parece um bom homem, mas devo dizer, não há saída para alguém como eu.” O conteúdo era desmoralizante, mas algo em seu tom me irritou. Sua descrição sobre mim me pareceu desdenhosa. Parecia um insulto velado, como se ela estivesse dizendo que eu era o tipo de “homem bom” que seria passivo e ineficaz com ela. Na verdade, seu comentário despertou em mim um sentimento que não era nada “bom”. Esses são momentos incertos para um terapeuta, especialmente quando está começando com um novo paciente, imaginando se deve desafiar uma resposta ou esperar e deixar que as coisas se desenrolem. Nesse caso, recuei logo com um tom irreverente. “Na verdade, você ainda não me conhece. Pode ser um grande erro você presumir que sou um homem bom. Eu também não a conheço, e pode ser um grande erro da minha parte presumir que você não merece uma vida melhor e que não há

esperança.” Sua expressão facial se contraiu. Seu tom sugeria aborrecimento em relação a mim, enquanto ela defendia sua alegação de que era desesperada e não merecia ajuda. Sua defesa enérgica de sua desesperança não condizia com desesperança. Paradoxalmente, ela agiu como alguém que pensou que merecia ser acreditado ao explicar por que era tão indigna. Eu recuei um pouco. Disse que estava disposto a esperar e descobrir a verdade enquanto nos conhecíamos. Disse a ela que sentia muito se a havia ofendido e apreciei que ela pudesse se defender. Como costuma acontecer quando um terapeuta usa a irreverência, senti-me energizado e acessível em vez de me sentir derrotado por sua apresentação desamparada. Tive a impressão de que já havíamos encontrado e navegado por um momento agitado, e nós permanecíamos cheios de energia e, talvez, orgulhosos.

A conversa sobre o que faria a vida valer a pena é um ponto de partida natural e um acompanhamento perfeito para o protocolo de contrato passo a passo. Ao acompanhá-lo à medida que entra e sai do tratamento, o terapeuta trabalha para se aliar às metas finais e valores do paciente, ao mesmo tempo em que explica os comportamentos problemáticos que interferem no avanço direcionado a essas metas. Além disso, como vimos nesses exemplos, iniciar a conversa capacita o paciente a ver e trabalhar para um futuro positivo. Se seguirmos obedientemente as etapas do protocolo de pré-tratamento, às vezes ignoramos a oportunidade de envolver o paciente no quadro geral e nas forças motivadoras. Além disso, essa conversa dá ao terapeuta a oportunidade de responder de forma autêntica, pessoal, construtiva e que já molda o tratamento.

Nem todo paciente que entra na DBT apresenta respostas tão desafiadoras no início. Em alguns casos, o terapeuta pode seguir as prescrições passo a passo do protocolo de contrato com pouca necessidade de improvisação. Uma paciente minha, tendo passado a maior parte de três anos em um hospital estadual

devido a comportamento suicida, respondeu prontamente à pergunta sobre as metas: ela queria trabalhar para ter um apartamento, ter um parceiro e voltar a estudar para se tornar advogada. Ela queria ajudar pessoas com transtornos mentais a navegarem no sistema jurídico. Em outras palavras, ela tinha a capacidade de vislumbrar alguns aspectos de uma vida digna de ser vivida, de trabalhar em conjunto para desenvolver um plano de cuidados e se comprometer com ele. Terminamos o estágio de pré-tratamento em quatro sessões e passamos direto para o estágio 1 da DBT, cujo objetivo é estabelecer um melhor controle comportamental. Rapidamente, à medida que seu ímpeto inicial foi desacelerado por sua relutância em participar do grupo de habilidades, seus episódios dissociativos e seus impulsos suicidas, o senso de colaboração e compromisso mútuo desmoronou. Ela parecia dominada por emoções intensas. As coisas pareciam mais preto no branco, e parecíamos mais adversários do que parceiros. Em uma sessão ela estava gritando comigo e tapando os ouvidos, momento em que minha capacidade de improvisar foi testada. Tive que mudar e focar minha atenção na avaliação e compreensão desses problemas comportamentais em sessão. Por um momento, acreditei que havia superestimado seu nível de comprometimento com o plano de tratamento. Como se viu, essa paciente estava firmemente comprometida com as metas do tratamento, mas foi dominada pelo medo, desencadeado por nosso desacordo em um episódio dissociativo e por impulsos suicidas de longa data. Naquela sessão, enquanto eu tentava entender sua desregulação emocional e interpessoal, ela recuperou um melhor controle emocional e reafirmou seu compromisso com o tratamento e sua imagem de construir uma vida digna de ser vivida.

Trabalhei com um número considerável de pacientes que *pareciam* capazes de negociar as etapas iniciais do protocolo de contrato, mas que também apresentavam indícios perceptíveis de que nem tudo era o que parecia. Uma mulher de 33 anos entrou

em tratamento após um episódio de comportamento suicida, quando pulou da sacada de um quarto de hotel. Ela se apresentou em meu consultório como bem-educada, doce e fácil de envolver, totalmente em desacordo com a imagem dela pulando de uma sacada. Ela havia se formado na faculdade, mas em sua família de profissionais muito talentosos, ela ainda era a fracassada e tratada como uma espécie de constrangimento. Quando perguntei como ela achava que o tratamento poderia ajudá-la a melhorar sua vida, disse que sempre quis ser administradora de fundos mútuos e que precisava “se estabilizar primeiro”. Embora eu saiba que alguns jovens podem ficar empolgados em serem administradores de fundos mútuos, sua maneira de comunicar isso para mim parecia vazia e sem corpo, como se fosse ensaiada. Quando perguntei mais sobre sua meta de vida, insinuando que havia algo pouco convincente nisso, ela começou a chorar e disse que ninguém nunca a levava a sério. O que eu não sabia na época é que o diálogo acontecendo entre nós já fornecia uma janela microscópica para a catástrofe central de sua vida: sua tendência de negar algumas de suas qualidades únicas enquanto se colocava em termos estabelecidos por sua família. Embora o restante da sessão tenha transcorrido sem problemas, ela foi direto ao banheiro após a sessão para se cortar, o que descobri quando estava a caminho da sala de espera para atender meu próximo paciente. Nem tudo estava perdido. Eu aprendi rapidamente que era típico dela esconder sua dor, que ela podia parecer competente e confortável quando na verdade estava chateada, que a autolesão era sua estratégia primária e quase automática de regulação emocional e que seu sentimento de vergonha era insuportável. Meses depois, após estabelecer com sucesso o controle comportamental e reduzir seu sofrimento, eu descobriria que o que faria sua vida valer a pena, entre outras coisas, seria ser jardineira e dona de casa. Após um tratamento completo em DBT, ela realizou esse sonho. Uma das lições para levar para casa foi que *muitos*

pacientes não têm acesso a uma imagem de uma vida digna de ser vivida no início do tratamento.

Para alguns, o desafio vem no primeiro minuto de conversa. Para outros, surge durante o pré-tratamento em torno da discussão de um dos acordos ou expectativas de tratamento. Para outros, ainda, as coisas correm bem até que o terapeuta os pressione para um comprometimento mais sério. De qualquer forma, o manejo dessa fase inicial cria um padrão de trabalho conjunto que continua durante o restante do tratamento; mais tarde torna-se, retrospectivamente, a “história de vida inicial” da relação. O terapeuta aprende muito com os encontros iniciais sobre as sensibilidades, habilidades, pontos fortes, vulnerabilidades e capacidades de recuperação do paciente. E o paciente, da mesma forma, aprende muito sobre as sensibilidades, habilidades, pontos fortes, vulnerabilidades e capacidades do terapeuta para improvisar e manter o curso do processo. Como terapeuta, quase se espera enfrentar dificuldades significativas no início, a fim de preparar o terreno para enfrentar desafios juntos com sucesso.

TRÊS TAREFAS NA CONVERSA SOBRE A VIDA QUE VALE A PENA SER VIVIDA

Como deve estar claro neste ponto, vejo a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida tecendo-se implícita e explicitamente ao longo do estágio de pré-tratamento, repleta de dificuldades e rica de oportunidades. Grande parte desse potencial gira em torno de três importantes tarefas terapêuticas. O terapeuta DBT que está atento a essas três tarefas no início do tratamento e está preparado para abordá-las de maneira baseada em princípios tem uma chance melhor de o fazer com consciência e precisão, iniciando bem a terapia. A primeira tarefa é *dialética*, na qual o terapeuta intervirá na dialética ou ambivalência do paciente entre querer construir uma vida que valha a pena ser vivida, por um lado, e querer morrer, por outro. A segunda tarefa é *comportamental*, e o terapeuta pode trabalhar para fortalecer a capacidade do paciente de vislumbrar vividamente uma vida que valha a pena ser vivida e traduzir essa visão em metas realistas e alvos de tratamento. A terceira tarefa é *relacional*, e o terapeuta busca o estabelecimento de um vínculo paciente-terapeuta forte e flexível, aprimorado por meio do encontro e da resolução de experiências adversas juntos durante o pré-tratamento. Pode ser significativo que essas três tarefas sejam sugeridas pelas três palavras do nome da terapia: há uma tarefa *dialética*, uma *comportamental* e uma *terapêutica* (de relacionamento). Como agora consideramos cada uma dessas três tarefas como parte integrante da conversa sobre o valor da vida, lembre-se de que cada uma delas é abordada *enquanto* seguem-se as estratégias de contrato com adesão ao manual, e não *em vez de* fazê-lo.

A tarefa dialética na conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida

Quando o terapeuta começa perguntando sobre as metas do tratamento do paciente, como uma forma de obter uma imagem do que faria a vida valer a pena para esse indivíduo, é provável que ele ative o que poderíamos chamar de dialética “suicídio *versus* vida que vale a pena ser vivida”. Essa “dialética do destino”, como eu a chamo, refere-se à direção que a vida do paciente está tomando, tendo os fins em vista. A dialética “intervencionista” mais comumente discutida na DBT refere-se aos meios estratégicos para chegar lá: uma síntese das forças opostas de aceitação e mudança. Para ilustrar o que quero dizer com a dialética suicídio *versus* vida que vale a pena ser vivida, convido você a imaginar um campo de futebol. Obviamente, um jogo de futebol consiste em uma dialética: a tensão entre dois times, ambos querendo a vitória, indo em direções opostas, jogando um contra o outro. Nessa metáfora, a goleira em uma extremidade do campo representa o suicídio e a morte; a goleira do outro lado é a meta de ter uma vida que vale a pena ser vivida. As equipes adversárias estão buscando, respectivamente, suicídio *versus* uma vida que vale a pena ser vivida. Este é o campo de futebol da DBT, e todo o curso do tratamento é jogado entre as duas goleiras.

Naturalmente, e comumente, o terapeuta DBT entra no campo de futebol da DBT ao lado do time da vida que vale a pena ser vivida, opondo-se ao time de suicídio e morte liderado pelo paciente. Ao fazer isso, no entanto, o terapeuta não está agindo de maneira dialética e pode contribuir para uma transação adversa desnecessária com o paciente. É mais complicado do que isso. O paciente tem, dentro de si, toda a dialética já acontecendo antes que o terapeuta entre em campo. Ele tem ambivalência. Ele quer morrer, para acabar com o sofrimento insuportável. Ele quer viver, esperando que de alguma forma alguém o ajude a sair do inferno e a construir uma vida que valha a pena ser vivida. É até possível que em sua história de vida houvesse quem realmente quisesse que ele morresse e quem quisesse que ele tivesse uma vida boa.

Ou seja, quando o terapeuta entra no “jogo” em campo, os dois times (duas facetas do paciente) já estão se opondo, em um jogo de alto risco, e o terapeuta precisa encontrar a posição ideal para influenciar o resultado.

É claro que o terapeuta DBT está longe de ser neutro em relação ao resultado. Os terapeutas DBT, começando com Linehan, tomam o lado da vida, defendem a construção de uma vida que valha a pena ser vivida. No entanto, pensando estrategicamente, ao tomar partido da vida, há o risco de forçar o paciente a ir para o outro lado da ambivalência. Eu atendi vários pacientes que estavam em tratamento em DBT, e eles tiveram a impressão, provavelmente correta, de que os terapeutas estavam insistindo para que eles “tirassem a ideia do suicídio da cabeça”. Embora muitas vezes seja clinicamente indicado fazer o paciente se comprometer a “eliminar as ideias suicidas”, é mais problemático insistir que “se abstenha dos pensamentos e sentimentos suicidas”. Pedir ao paciente para suprimir pensamentos e sentimentos suicidas provavelmente resultará em sua intensificação.

Requer equilíbrio e, às vezes, coragem do terapeuta para entrar em campo ao lado dos dois “times”, buscando genuinamente compreender a “sabedoria” das formas diretas e indiretas de autodestruição e, ao mesmo tempo, iniciar e promover conversas sobre esperanças e sonhos. A ambivalência do paciente certamente é profunda, tem uma história dolorosa e deve ser abordada dialeticamente, destacando a sabedoria de ambos os lados. Não muito tempo atrás, atendi uma jovem que foi diagnosticada como preenchendo os critérios diagnósticos para TPB. Ela estava em um programa de DBT com terapia individual e um grupo de treinamento de habilidades, mas parecia estar parada há muito tempo. Ela havia sofrido abuso sexual por parte do pai quando era uma criança em idade de latência e foi estuprada várias vezes por um vizinho na adolescência. Durante uma década

de abuso de substâncias quando adolescente, tornou-se “dependente” de autolesão frequente de gravidade moderada aos 20 anos. Viu claramente que o uso de substâncias e a autolesão eram seu arsenal para trazer alívio temporário, mas confiável, do sofrimento emocional, mas também entendia que os dois “vícios” estavam arruinando sua vida. Ela tinha certeza de que, se não tivesse essas duas “estratégias” de regulação emocional (uso de substâncias e comportamentos autolesivos), já teria vindo a óbito por suicídio há muito tempo. Pedi-lhe que me contasse quais eram suas metas, qual era sua visão de uma vida digna de ser vivida. Houve uma longa pausa; na verdade, tive a impressão de que ela havia entrado em estado dissociativo. Chamei seu nome e ela pareceu voltar ao presente. Ela me perguntou o que eu havia perguntado. Eu repeti a pergunta. Ela disse que não tinha ideia de como responder, que realmente não pensava no futuro.

Ficamos momentaneamente presos entre dois polos opostos de uma dialética: de um lado estava a inevitabilidade do suicídio e o objetivo de fazer o que fosse necessário para eliminar a dor; de outro, o conceito hipotético, impossível até mesmo de imaginar naquele momento, de uma vida que vale a pena ser vivida. Por mais que conversássemos, ainda achei impressionante que ela não conseguisse ter nenhuma ideia relacionada ao futuro. Era como se o conceito de futuro tivesse sido apagado de sua consciência, restando apenas um presente agonizante, permeado por um passado perturbador, administrado por comportamentos extremos que a entorpeciam ou distraíam. Voltando à minha metáfora, ela não conseguia ver o campo em direção à goleira da vida que vale a pena ser vivida. Ela conseguiu evitar acabar morta ao se envolver em comportamentos (vícios, autolesão e episódios dissociativos) que não estavam longe da goleira do suicídio e que serviam para evitar a morte, mas não se afastavam dela. A metáfora oferece esta visão adicional sobre padrões comportamentais problemáticos que são autodestrutivos, mas não

(totalmente) suicidas: eles podem prevenir a morte, mas mantêm o paciente preso perto da goleira do suicídio, o que o impede de se mover em direção à vida que vale a pena ser vivida.

Tentei várias formas de extrair alguns elementos de uma imagem positiva do futuro. Pedi-lhe que refletisse sobre o que sonhava quando criança, tentando recuperar uma orientação futura enterrada em seu passado. Mas ela não tinha nenhuma lembrança, exceto por alguns episódios horríveis em que foi assustada ou abusada. Tentei descobrir seus pontos fortes, realizações e valores, esperando que pudéssemos construir uma visão do futuro capaz de ser convincente e realista. Ela reconheceu que, se tivesse um futuro, gostaria de ter um gato, um lugar para morar e que “as pessoas fossem legais umas com as outras”. Era uma imagem nebulosa e indistinta, mas parecia um começo. Tendo usado muitas estratégias de solução de problemas (do paradigma da mudança da DBT) para obter algum tipo de direção e muita validação (do paradigma da aceitação da DBT) para autenticar alguns dos eventos horríveis de sua vida e expressar minha compreensão de seu desejo de morrer, eu ainda me sentia preso.

Na DBT, quando a paralisia permanece mesmo diante de estratégias de mudança ou aceitação, o terapeuta naturalmente se desloca para os princípios e estratégias do paradigma dialético. Libertado ao tomar uma posição de “ambos . . . e” que valida os dois lados da dialética e permite velocidade, movimento e fluxo, abri minha mente para as possibilidades estratégicas. Uma das estratégias dialéticas da DBT é usar uma metáfora que capte o dilema e abra novos caminhos para a conversa. Sugeri à paciente que ela estava à beira da praia onde a vida tinha sido incrivelmente dolorosa, um lugar com condições que a haviam levado ao suicídio. E ela estava olhando para o vasto oceano à sua frente, em um dia nublado em que não conseguia ver muito longe. Sugeri que havia uma ilha lá fora, além do nevoeiro, e lá havia um lar, um

gato e uma vida em que as pessoas eram tratadas com decência. Para chegar lá seria necessário que ela entrasse em um barco e remasse em direção àquela ilha sem saber exatamente onde estava ou como era. Aquele barco era seu tratamento em DBT. Como ela havia me informado que mantinha uma lâmina de barbear especial em seu apartamento, que ela chamava de “graça salvadora”, sugeri que, se visse seu tratamento em DBT como um barco e seu terapeuta como um passageiro, seria importante deixar a lâmina em terra. Ela foi capaz de se envolver com a metáfora. Disse que, se não tivesse a lâmina, precisava de outra coisa, algo que pudesse ajudá-la a superar os momentos insuportáveis, especialmente quando fosse surpreendida por *flashbacks* de abuso sexual. Concordei inteiramente e começamos a considerar que tipos de estratégias poderiam substituir a lâmina de barbear.

O terapeuta não pode simplesmente contornar, suprimir ou anular a ambivalência essencial de vida *versus* morte sem piorar o problema. Enquanto defende firmemente uma vida que vale a pena ser vivida, mantendo uma atitude esperançosa de qualquer maneira que funcione, o terapeuta também deve dar espaço e tempo para que o paciente comunique os pensamentos, sentimentos e desejos relacionados ao suicídio, sem endossá-los como um plano. Linehan afirmou que os terapeutas de DBT precisam realizar duas tarefas essenciais abrangentes ao trabalhar com o indivíduo suicida com TPB: eles precisam 1) ser capazes de “entrar no inferno” com o paciente e ver como ele se parece e se sente e 2) ajudar o paciente a “encontrar a saída do inferno”. É uma metáfora dialética, reconhecendo a validade de ambos os lados: o lado de querer morrer e o lado de querer encontrar a saída sem morrer. É uma síntese de aceitação e mudança. O trabalho de “encontrar a saída do inferno” começa com vislumbrar uma vida que valha a pena ser vivida e que funcione para aquele paciente.

É interessante ver que esse conceito do caminho do meio, embora não nomeado como tal, foi central para o pensamento de Shneidman (1996, pp. 59-61), comumente referido como o “pai da suicidologia” e fundador da American Association of Suicidology. Ele postulou que o pensamento do indivíduo suicida, que acha a vida insuportável e impossível de consertar, se reduz a apenas duas opções: 1) viver com um sofrimento insuportável (que Shneidman denominou *psychache*);^[NT] e 2) tirar a própria vida. Quando as coisas chegam a esse ponto, o risco de suicídio é alto. Na visão de Shneidman, o terapeuta deve, de alguma maneira, inserir uma terceira opção na equação. Essa opção pode assumir muitas formas, mas deve fornecer uma alternativa genuína às outras duas, uma direção diferente. Em alguns casos, essa opção ocorre por meio do apego ao terapeuta ou a outra pessoa. Muitos pacientes que estão morrendo de vontade de morrer lamentam o dia em que começaram a se apegar ao terapeuta (ou a outra pessoa). Em outros casos, a terceira opção é algum tipo de busca.

Lembro-me da determinação de um terapeuta DBT que entrou na vida miserável de uma jovem cuja existência se resumia à escolha ou de uma vida de sofrimento implacável ou de suicídio. Depois de uma longa e contenciosa conversa sobre suicídio *versus* vida que vale a pena ser vivida, no contexto de um apego mútuo crescente e com o apoio da equipe de consultoria em DBT, os dois chegaram a um acordo impressionante. A paciente, que sempre desejou ter sido mais atlética e odiava a ideia de morrer sem nunca ter experimentado maior força física, concordou que assumiria uma determinada tarefa “antes que eu me mate”. A tarefa – impressionante, porque ela nunca havia corrido – era completar a Maratona de Boston. Ela parecia tomar a decisão em “mente racional”, como se estivesse fazendo uma barganha com o terapeuta (diabo), mas depois se manteve firme. Comprometeu-se a treinar por um ano e foi combinado que, se as coisas não melhorassem no final daquele ano, ela poderia se matar. Dados a

sua condição física precária naquele momento e o seu sofrimento constante, foi necessário um esforço incrível dia a dia e passo a passo. Seu terapeuta estruturou o tratamento em torno da meta de uma vida que vale a pena ser vivida de correr a Maratona de Boston. Foi perfeito para a DBT ou qualquer tratamento em TCC. Ela podia visualizar essa meta de longo prazo, que era atraente e poderia ser realista, o progresso aconteceria passo a passo e poderia ser monitorado objetivamente. O suicídio esteve em sua mente o ano todo, mas o foco em uma tarefa positiva a ajudou a inibir os impulsos as- sociados, aumentar sua resiliência e, por fim, completar a maratona. Naquela época, outras coisas haviam mudado. Sua vida, embora ainda difícil, parecia suportável; o relacionamento com o terapeuta ficou mais forte e ela começou a considerar metas significativas.

A tarefa comportamental na conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida

Discuti o caso da paciente que era incapaz de visualizar qualquer resultado futuro positivo através da densa névoa, ou de nomear qualquer meta além da sobrevivência diária. O fato de ela não conseguir vislumbrar uma vida melhor nem nomear nenhuma meta para uma vida melhor era incapacitante em si. Sem uma meta para uma vida que vale a pena ser vivida para competir com o magnetismo sedutor do suicídio, o tratamento perde um grande aliado. Essas são habilidades (de visualizar um estado futuro positivo e realista e de articular metas realistas que levam a esse futuro) familiares dentro de um conjunto maior de capacidades conhecidas como *funções executivas*. Na verdade, a capacidade de vislumbrar um estado futuro desejado (visualmente, se possível) é uma função executiva que recruta todas as outras funções no processo de fazer as coisas. (Outras funções executivas a seguir incluem direcionar recursos para a meta, monitorar o progresso em

direção à meta, inibir atividades alternativas que possam interferir e manter um nível de flexibilidade cognitiva que facilite a solução de problemas diante de vários obstáculos.) Uma vez que conceituamos a falha em visualizar uma imagem positiva e motivadora do futuro e a deficiência em estabelecer metas para tal imagem, como déficits de capacidade, podemos organizar nosso pensamento e nossas intervenções em torno de uma tarefa familiar em DBT: aprimoramento de capacidades ou treinamento de habilidades.

Quando meu filho mais velho tinha 13 anos e eu o ajudava a planejar o verão, perguntei o que era mais importante para ele naquele período. Pela primeira vez em sua vida, ele identificou uma meta que afetaria todo o planejamento do verão, com vários meses de antecedência. Ele fazia parte de um time de hóquei juvenil e estava “no meio da multidão”. Ele se perguntou em voz alta se passar várias semanas em acampamentos de hóquei se traduziria em “se destacar da multidão”. Concordamos que sim, e ele perguntou se eu poderia inscrevê-lo em alguns acampamentos. Isso significaria reduzir muitas de suas atividades favoritas. Ele tinha uma visão que conseguíamos expressar na forma de metas concretas, o que, por sua vez, o ajudava a inibir atividades alternativas que teriam interferido nessa visão, e ele conseguiu manter o plano. Ele começou a temporada seguinte de hóquei mais perto de “se destacar da multidão”.

Quando nossos pacientes têm pouca ou nenhuma capacidade de sonhar, visualizar ou estabelecer uma meta não dependente do humor, é uma desvantagem invisível. Não podemos simplesmente ignorar esse déficit. Precisamos avaliá-lo e usar nosso conhecimento de treinamento de habilidades para abordá-lo. E se o abordarmos logo no início do tratamento, poderemos ajudar a construir ou fortalecer as funções executivas essenciais, fornecer uma demonstração *in vivo* do valor do treinamento de habilidades

e iniciar um relacionamento de tratamento colaborativo focado na aquisição de habilidades e na melhoria de motivação.

Como podemos entender esse tipo de déficit de habilidades em indivíduos com TPB e transtornos relacionados? Vistos no contexto da teoria biossocial da DBT, esses déficits estão dentro das consequências da transação mais ampla na vida do paciente entre suas vulnerabilidades emocionais de base biológica e o ambiente amplamente invalidante com o qual ele interagiu. Nossos pacientes, tendo sobrevivido e sido moldados por ambientes nos quais foram desconsiderados, difamados, criticados, punidos e desprezados, geralmente não eram encorajados a sonhar ou a converter suas ideias e qualidades únicas em caminhos de vida únicos. Na verdade, em um ambiente invalidante, comunicar um grande sonho pode resultar em críticas e humilhações. Com o tempo, transações dolorosas como essas podem estabelecer um elo entre a visão do futuro e a experiência do desprezo e da decepção. A invalidação generalizada pelo ambiente é transformada ao longo do tempo em uma síndrome de autoinvalidação; os indivíduos aprendem a se invalidar e criticar automaticamente, a suprimir esperanças e sonhos e a descartar a expectativa de apoio real ou a perspectiva de sucesso. Eles aprendem que sonhar e chegar lá é para os outros. E, como resultado, falham em construir esse conjunto de habilidades de vida específico e poderoso: vislumbrar um futuro positivo e estabelecer uma meta nessa trajetória.

Quando o paciente inicia o tratamento e perguntamos o que deseja realizar, ou mais especificamente o que faria a vida valer a pena, encontramos todas as variedades de disfunções, muitas das quais expõem claramente esse déficit. É um desafio desvendar até que ponto a incapacidade de vislumbrar o futuro e estabelecer uma meta se deve, na verdade, à *ausência* ou à *fragilidade* da capacidade. Na maioria dos casos, podemos eventualmente localizar a presença de uma capacidade enfraquecida ou distorcida

de sonhar e estabelecer metas, mas que se tornou invisível ou ineficaz devido a um ou mais fatores: sonhar ou estabelecer metas pode estar associado a *pressupostos ou crenças problemáticas*, pode desencadear automaticamente *emoções negativas intensas* com base em respostas anteriores traumáticas ou invalidantes, ou pode resultar de outros *déficits de habilidades associadas* (considere o impacto dos déficits na regulação emocional em geral, na tolerância ao mal-estar ou nas habilidades de *mindfulness*). Além disso, uma vida inteira de padrões de reforço infelizes pode ter extinguido ou punido as atividades de sonhar e estabelecer metas e ter reforçado maneiras mais disfuncionais de lidar com a questão sobre as metas de vida.

Por tudo isso, o estágio de pré-tratamento, iniciado com a primeira conversa, pode fornecer o contexto *in vivo* para avaliar esses déficits de habilidades, começando a entender a natureza e o impacto do ambiente invalidante desse indivíduo e trabalhando para remediar os déficits de habilidades expostos. Se realmente faltar habilidade, existe a oportunidade de construí-la “do zero”, ou seja, intervir na aquisição de habilidades. Essa intervenção envolve 1) orientar o paciente sobre a presença e as consequências do déficit, 2) usar instrução e modelação para ajudar o paciente a passar pelas etapas de construção de uma visão do futuro e estabelecer metas associadas, 3) reforçar as etapas iniciais e 4) garantir que o paciente pratique essas habilidades cruciais. Nos casos em que a habilidade está presente, mas outros fatores interferiram, o terapeuta pode trabalhar em direção a uma formulação dos fatores que interferem e abordá-los com os procedimentos de mudança necessários, como reestruturação cognitiva, exposição, técnicas de controle de estímulos e procedimentos de manejo de contingências para fortalecer a habilidade que está reduzida.

Uma de minhas ex-pacientes lembrou-se de ter sido emocionalmente sensível ao longo de sua vida, inclusive quando

criança. Ela era filha única de pais muito ocupados e egocêntricos. Suportou anos de conversas à mesa de jantar em que os pais a ignoravam completamente, conversando entre si como se ela fosse invisível ou não estivesse na sala. Se falasse, era-lhe dito para parar de interromper; se tocava flauta (era um prodígio), mandavam-na para o porão. Quando ela comunicou uma resposta emocional, foi-lhe dito para parar de tentar chamar a atenção. O ambiente doméstico era tenso, as atitudes dos pais eram severas. Ela começou a se cortar para alívio emocional aos 8 anos e teve seu primeiro comportamento suicida aos 13 anos. Quando a terapia começou e foi questionada sobre o que esperava realizar com o processo, mal conseguia falar. Ela olhou para mim como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Parecia perplexa e não conseguia responder; essa pessoa brilhante que teve a disciplina para se tornar uma excelente flautista não conseguiu dizer uma palavra sobre suas metas de vida. Minha impressão foi que ela estava perplexa e talvez desconfiada de um indivíduo que mostrava interesse sincero em ajudá-la a ter uma vida boa. Passar pelas etapas do pré-tratamento foi um processo lento, hesitante e tortuoso. A invalidação generalizada que ela experimentou em seu ambiente se transformou em autoaversão. Em momentos de incerteza ou ambiguidade, na relação com o terapeuta e outros, antecipava a iminente recorrência da invalidação ambiental.

Eu a orientei para o problema de uma perspectiva de déficit de habilidades. Expliquei que só podia supor que ao longo de sua vida ela não havia sido ensinada ou encorajada a ter um sonho, a compartilhar esse sonho e a estabelecer algumas metas em um contexto de relacionamento como este atual. Ela concordou, detalhando como sua família não havia mostrado interesse em seus trabalhos escolares (era uma ótima aluna), sua música, seus esportes ou sua vida social. O que ela conquistou, o fez sozinha e viveu uma vida de grandes realizações, mas dolorosamente isolada, que a levou a querer morrer. Começamos a trabalhar, a

passos lentos, para que me comunicasse o que gostaria de realizar no tratamento. A princípio, ela não conseguia fazer contato visual quando estava comunicando qualquer esperança. Foi um exercício de exposição *in vivo* que desencadeou medo e vergonha e provocou uma fala autodirigida prejudicial sobre como não deveria esperar ajuda de ninguém. Ela nunca se sentiu à vontade para expressar sonhos e metas de vida, mas adquiriu a capacidade de fazê-lo, ainda que de forma afetada e inibida. Aprendeu rapidamente que a DBT era sobre trabalhar em direção a metas, fortalecer a motivação e aprender e fortalecer habilidades. Começamos bem.

E se o paciente, mesmo com todo esse esforço, não conseguir ter uma visão de um futuro positivo ou uma meta positiva a ser almejada? Isso acontece. Existem várias estratégias possíveis. Uma delas é simplesmente afastar-se do esforço de obter uma declaração relacionada à vida que vale a pena ser vivida ou metas associadas e, em vez disso, concentrar-se em etapas práticas menores e mais imediatas. Em um caso, um jovem paciente não conseguiu articular nenhuma meta maior, mas conseguiu se motivar a colocar sua amada bicicleta de volta em condições de pedalar, imediatamente. Em outro caso, o tratamento se concentrou em ajudar uma paciente a superar seu medo de levar seu gato ao veterinário. Experimentar o sucesso com tarefas menores, até mesmo a tarefa de aprender novas habilidades em grupo, começa a reforçar o esforço exercido e, em última análise, pode levar à capacidade de estabelecer metas maiores. Nesses casos, precisamos reformular uma “vida que valha a pena ser vivida” em metas de vida mais iminentes, minuciosas e práticas (o que o indivíduo fará hoje, esta noite ou amanhã) e adiar o esforço de olhar além do futuro imediato, uma prática que pode ativar barreiras que não cederão em curto prazo.

Outra abordagem para ajudar o paciente a construir sua imagem de uma vida que vale a pena ser vivida com base em

memórias de dias melhores e esperanças anteriores ou sonhos anteriormente reprimidos é iniciar uma conversa sobre seus valores, pontos fortes e talentos. Uma paciente minha com TPB e transtorno depressivo maior com características psicóticas tinha certeza de que sua vida havia acabado. Ela não conseguia imaginar “começar do zero” e gerar uma vida significativa que incluísse relacionamentos viáveis. Ao considerarmos seus valores e pontos fortes, ela falou com admiração sobre aqueles que servem nas forças armadas e na polícia, que colocam sua vida em risco para proteger os outros. Por ter sofrido várias internações psiquiátricas, ela assumiu que essas opções não estavam disponíveis para ela. Mas essa discussão, à qual voltamos várias vezes e durante a qual ela foi cada vez mais explícita sobre seu desejo de proteger os outros, levou-a a investigar concretamente a possibilidade de ajudar a treinar cães para localizar minas terrestres não detonadas em países em desenvolvimento. Daquele momento em diante, a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida tornou-se muito focada, prática e motivadora.

A tarefa relacional na conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida

Uma terceira tarefa que pode ser abordada por meio da conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida durante o pré-tratamento consiste em desenvolvimento e fortalecimento de um relacionamento colaborativo entre terapeuta e paciente. As discussões iniciais sobre as metas permitem que o terapeuta faça várias coisas úteis. Ele se alia à esperança, à mudança, aos sonhos e às metas do paciente e a uma vida que vale a pena ser vivida. Ele valida o sofrimento do paciente e seu desejo de se envolver em comportamentos suicidas e passa a entender a narrativa dentro da qual o suicídio faz sentido, tudo sem validar o suicídio como solução. Ele pode 1) explicar a dialética – a oposição

entre buscar o suicídio e buscar uma vida que valha a pena ser vivida –, 2) validar partes de cada lado da dialética e 3) demonstrar paciência e respeito na tentativa colaborativa de chegar a uma síntese. Ao conceituar os problemas associados de imaginar o futuro e identificar metas como déficits de habilidades, ele aponta o caminho para remediar os déficits de maneira prática, com instruções concretas e práticas deliberadas. O terapeuta pode demonstrar como validar o sofrimento e a sensibilidade do paciente sem tratá-lo como frágil. O objetivo é ajudar o paciente a vivenciar a atmosfera terapêutica como uma atmosfera que estimula a franqueza, a genuinidade, a honestidade e a coragem e que tolera discordâncias e conflitos. Embora essas conversas possam ser desafiadoras e “agitar” um pouco as coisas, para o terapeuta elas são uma oportunidade de se envolver e combinar esperanças, paixão pelo tratamento e respeito pelas posições do paciente.

Linehan delineou as características ideais de um terapeuta DBT, como a de encontrar o caminho do meio entre as posições polarizadas ao longo de três dimensões. Conforme explicitado no manual (Linehan, 2010, pp. 110-113), o terapeuta pode 1) insistir na mudança comportamental no contexto de aceitação profunda, 2) manter-se com uma firmeza convicta enquanto se envolve com flexibilidade empática e 3) demandar exigências de forma benevolente enquanto cuida incondicionalmente (suporte afetivo). A conversa sobre uma vida que valha a pena ser vivida é uma excelente tarefa e estrutura na qual o terapeuta pode encontrar e praticar o caminho do meio entre essas dimensões. Ele insiste em conduzir o paciente em direção a uma vida que vale a pena ser vivida, ao mesmo tempo em que transmite uma validação genuína do desejo de morrer, mantendo-se centrado na meta de uma vida que vale a pena ser vivida, ao mesmo tempo em que permanece flexível o suficiente para ir e vir com a ambivalência do paciente e exigindo que ele trabalhe em direção a uma qualidade de vida mais alta, oferecendo suporte afetivo ao longo do caminho. Obviamente,

um terapeuta DBT que pode genuinamente oferecer uma posição dialética, encontrando a síntese correta dessas polaridades no momento clínico, tem uma vantagem ao navegar em direção a um relacionamento mais forte com o paciente.

Para muitos pacientes, a dificuldade em responder à questão das metas resulta em seu primeiro comportamento de *interferência na terapia durante a sessão*. Como tal, é a oportunidade perfeita para o terapeuta aplicar todo o pacote de tratamento e modelar a abordagem que será usada ao longo do tratamento ao enfrentar situações desafiadoras na vida e no relacionamento terapêutico. É como o primeiro capítulo de um livro ou o prelúdio de uma grande peça musical. E embora o processo passo a passo do uso das estratégias de contrato, conforme descrito no manual, forneça uma excelente estrutura para as primeiras sessões, essas etapas não dizem ao terapeuta o que fazer quando isso não acontecer. Este é tanto um tratamento *baseado em princípios* quanto um tratamento *baseado em protocolo*, e é assim desde o início. Muitas vezes, o terapeuta precisa de todo o pacote de tratamento no primeiro minuto. Se entrar na DBT fosse como entrar em uma piscina, não haveria parte rasa.

Finalmente, a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida é a melhor ilustração para o paciente de que a DBT não é principalmente um tratamento de “prevenção do suicídio”, mas um tratamento focado na construção de uma vida que vale a pena ser vivida. É muito mais motivador lutar por algo que resulte em uma vida melhor do que visar apenas a reduzir uma variedade de comportamentos disfuncionais. Se o paciente consegue melhorar a qualidade de sua vida, o plano, o desejo e a ideia de se envolver em comportamentos suicidas tornam-se naturalmente menos convincentes e menos necessários. Na metáfora do campo de futebol, se o paciente está avançando pelo campo em direção à goleira da vida que vale a pena ser vivida, ele está simultaneamente se afastando da goleira do suicídio e, embora

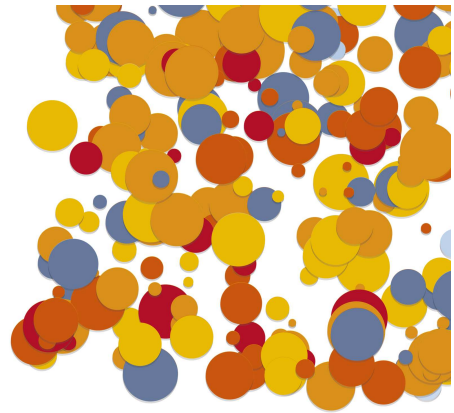
gradualmente, também está saindo da zona em que os vícios, a dissociação, os transtornos alimentares e as CASIS são tão aprisionadores.

COMENTÁRIOS FINAIS

Ao tratar o paciente que quer morrer ou que vive uma vida de estagnação mortal centrada em comportamentos autodestrutivos diretos ou indiretos, encontra-se naturalmente a dialética entre querer escapar do sofrimento por meio da morte e querer ter uma vida com sentido, uma vida que valha a pena ser vivida. Durante o estágio de pré-tratamento na DBT, enquanto executa as estratégias de contrato prescritas, a conversa sobre a vida que valha a pena ser vivida tece seu caminho dentro e fora do processo. À medida que o terapeuta consegue perceber e se engajar nessa importante conversa, ele tem várias oportunidades de abordar tarefas terapêuticas abrangentes. Tem a oportunidade de 1) assumir uma postura dialética em relação à dialética suicídio *versus* vida digna de ser vivida, 2) avaliar e remediar um déficit de habilidades em vislumbrar um futuro positivo e estabelecer metas para chegar lá e 3) construir um vínculo mais forte entre o paciente e o terapeuta por meio da resolução compassiva e eficaz da adversidade inicial na terapia.

Agora, tendo discutido a missão central da DBT (ou seja, ajudar o paciente a construir uma vida que valha a pena ser vivida, aprimorada por uma abordagem baseada em princípios), nos voltamos para uma discussão detalhada dos três paradigmas fundamentais da DBT: mudança, aceitação e dialética, e os princípios que surgem de cada um. ▲

[*psychache*] N. de R.T.: Refere-se ao sofrimento emocional global e invasivo.



Apresentando os três paradigmas da terapia comportamental dialética

Vários anos atrás, assisti ao meu primeiro jogo de hóquei na faculdade. Embora eu não soubesse muito sobre as regras, as estratégias ou os jogadores, era óbvio para mim que havia um jogador particularmente notável. Primeiro porque ele tinha domínio técnico de fundamentos da patinação, manuseio do disco, passe, arremesso e “*checking*”^[NT] (bater legalmente nos jogadores adversários quando eles estão manuseando o disco). Seu conjunto de habilidades técnicas era tão superaprendido e automático que ele parecia não ter que pensar nisso. Segundo, ele parecia ter um elevado senso de consciência, como se sua perspectiva, de um nível acima do jogo, lhe permitisse ver em todas as direções e ver as coisas exatamente como elas eram. Ele parecia calmo, equilibrado e presciente, como se soubesse para onde o disco estava indo antes de qualquer outro jogador. Além disso, ele poderia se mover em quase qualquer direção em resposta às circunstâncias em constante mudança ao seu redor. Em outras palavras, mantendo seu conjunto de habilidades técnicas e sua “consciência da pista de patinação”, ele podia improvisar com habilidade e se mover rapidamente, conforme necessário.

Essas três qualidades – *conjunto de habilidades técnicas, maior consciência e capacidade de improvisação* – são parte integrante do trabalho transformador de qualquer pessoa com alto desempenho, seja na arte, nos esportes, na música, na dança, na

oratória, no empreendedorismo ou em quase qualquer outra iniciativa. Não é diferente para um terapeuta de terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) altamente competente.

O DESENVOLVIMENTO DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA E A PERSPECTIVA DOS TRÊS PARADIGMAS

A DBT começou com os esforços de Linehan para trazer o *conjunto de habilidades técnicas* do comportamentalismo para lidar com o problema de comportamentos suicidas. O comportamentalismo tornou-se a base do paradigma de tratamento inicial da DBT, o paradigma da mudança. Mas os pacientes diagnosticados com transtorno da personalidade *borderline* (TPB) eram emocionalmente sensíveis e reativos, tinham longas histórias de invalidação generalizada e achavam difícil tolerar o tratamento orientado para a mudança. Em resposta, embora mantendo sua convicção de que as estratégias de mudança comportamental seriam eficazes se pudessem ser toleradas, Linehan começou a acrescentar intervenções de natureza diferente. Ela ouviu mais, explorou mais as experiências dos pacientes, reconheceu a realidade dessas experiências e validou os “núcleos da verdade” em padrões comportamentais disfuncionais. Quando essa alternância de intervenções era feita com precisão e compaixão, os pacientes se sentiam compreendidos, mais seguros e mais próximos de seus terapeutas e, em geral, ficavam mais regulados emocionalmente. Linehan percebeu que nesse ponto seria eficaz voltar à agenda de mudança com técnicas comportamentais. Anteriormente em seus ensinamentos de DBT, Linehan descreveu as estratégias cognitivo-comportamentais de solução de problemas como a “pílula de sabor amargo, mas eficaz”, e as estratégias de validação como a “cobertura de açúcar” que ajuda a pílula a ser engolida. Para aceitar os pacientes com compaixão e intervir com precisão, os terapeutas precisavam desenvolver seus próprios *níveis elevados de aceitação e consciência*. O cultivo da aceitação

e da consciência foi fundamentado nos princípios e práticas de *mindfulness*.

Uma vez capaz de equilibrar habilmente as intervenções de mudança com as que envolvem aceitação, contando com o comportamentalismo e o *mindfulness* como fundamentos, Linehan ensinou os terapeutas em DBT a alternarem entre elas, tudo para ajudar os pacientes a se moverem em direção a suas metas para a construção de uma vida que valha a pena ser vivida. Em termos práticos, o tratamento ia e voltava entre pressionar pela mudança, tomar consciência das reações do paciente, comunicar aceitação, pressionar novamente pela mudança e assim por diante.

Ainda assim, o progresso no tratamento frequentemente parava quando paciente e terapeuta entravam em padrões rígidos um com o outro, às vezes com passividade paralisante, às vezes com conflitos insolúveis, muitas vezes ficando polarizados como se estivessem em lados opostos da cerca. Equilibrar paradigmas de mudança e aceitação parecia ser insuficiente. Linehan começou a tecer um terceiro conjunto de intervenções no tratamento, fortalecendo a *capacidade de improvisação* do terapeuta. Essas intervenções, que ajudaram a combater a rigidez, o impasse e a oposição com flexibilidade, movimento e síntese, foram baseadas na filosofia e na prática dialética. A dialética, que tem sido comparada ao estilo musical do *jazz* na DBT, funciona para promover a improvisação. Despojada em sua essência, a DBT eficaz exige que o terapeuta sintetize um conjunto de *habilidades técnicas cognitivo-comportamentais, aceitação e consciência intensificadas e capacidade de improvisar* com a mudança, a aceitação e os paradigmas dialéticos da DBT (todos baseados no comportamentalismo, no *mindfulness* e na filosofia dialética) para alterar padrões comportamentais arraigados e “tirar o paciente do inferno”. Cada paradigma deu origem a conjuntos particulares de estratégias, sendo o núcleo estratégico triádico do tratamento: *estratégias de solução de problemas* do paradigma da mudança,

estratégias de validação do paradigma da aceitação e *estratégias dialéticas* do paradigma dialético.

OS DESAFIOS AO APRENDER A APLICAÇÃO DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA

A simplicidade dessa perspectiva de três paradigmas contrasta com a complexidade de aprender a aplicar a DBT. No início do processo de aprendizagem, os terapeutas podem ser inundados com escolhas. Eles têm que retornar à avaliação comportamental em quase todas as sessões, focar nos alvos de maior prioridade ao longo da sessão, acompanhar a “emoção do momento” predominante de seus pacientes, manter os acordos e pressupostos, aplicar aproximadamente 85 estratégias e uma diversidade de “protocolos estruturais” especializados, assim como ensinar e reforçar mais de 100 habilidades. E, claro, tudo isso deve ser feito mantendo-se alerta e ciente das respostas minuto a minuto de cada pessoa, com tempo e tato. Como se isso não bastasse, os terapeutas DBT muitas vezes fazem tudo isso no decorrer de sessões difíceis de administrar, lidando com questões de vida ou morte e com suas próprias emoções desreguladas. Eu experimentei pessoalmente esses imensos desafios de aprendizado e passei a reconhecer uma certa expressão de medo nos rostos dos terapeutas em treinamento quando começam a sofrer com a sobrecarga de informações.

Não estou apenas descrevendo os desafios dos terapeutas novos na DBT. Dominar o desafio de permanecer fiel ao manual de tratamento, responsivo ao paciente, fiel a si mesmo e focado nos alvos do tratamento requer uma considerável prática e proficiência para terapeutas DBT altamente experientes. Isso é semelhante a um pintor de paisagens que enfrenta uma tarefa assustadora ao selecionar a cor para a próxima pincelada em uma paleta que inclui 150 tons. Fazer uma varredura e selecionar entre 150 cores interromperia completamente o fluxo da imaginação e da pintura e, claro, não é isso que o pintor faz. Em vez disso, as cores são

agrupadas em alguns espectros de cores, como vermelhos, amarelos e azuis. O pintor pode dizer a si mesmo: “preciso de um tom avermelhado”, e então pode considerar rapidamente uma escolha entre as cores desse tom. Ele pode manter sua mente focada no que a pintura exige, manter contato com sua imaginação, localizar com rapidez e fluidez a melhor escolha de cor e prosseguir.

Da mesma forma, diante de um determinado momento de uma sessão, o terapeuta DBT não pode estar pensando em 85 estratégias, vários protocolos e 100 habilidades. Essas intervenções são agrupadas em um punhado de categorias abrangentes: estratégias de avaliação, estratégias estruturais, procedimentos de mudança, estratégias de aceitação e estratégias dialéticas. O terapeuta pode dizer a si mesmo: “preciso pressionar por uma mudança comportamental” e considerar rapidamente as opções entre os procedimentos de solução de problemas, acompanhados por modificações no tom de voz da estratégia estilística direcionada para a mudança da comunicação irreverente. Ele pode, assim, tal qual o pintor, focar sua mente nas necessidades e escolhas do momento, manter contato com o destino e sua imaginação, identificar com rapidez e fluidez a melhor escolha estratégica e prosseguir com a sessão. Com estudo, prática, supervisão e revisão das próprias anotações terapêuticas, a prática torna-se mais intuitiva e automática. Por exemplo, passamos a “saber” quando não podemos forçar mais a mudança e automaticamente adicionamos ou mudamos para a aceitação, aumentando ou deixando de lado completamente a mudança (por enquanto), aceitando radicalmente o momento como é e validando o “núcleo da verdade” na oposição do paciente. Ou, em outro caso, digamos que já passamos da mudança para as estratégias de aceitação, mas o impasse na sessão permanece, a sensação de movimento parou e “sabemos” que devemos nos “tornar dialéticos”, baseando-nos em princípios e estratégias que

estabelecem as posições polarizadas, procurando trilhar o caminho do meio ao longo do qual seja possível gerar movimento.

Esse tipo de fluxo entre paradigmas (o movimento algorítmico do paradigma para os princípios, para as estratégias e de volta à avaliação) simplesmente não estava em minha mente nos primeiros anos de aprendizagem da DBT. Eu ainda estava aprendendo o tratamento estratégia por estratégia, habilidade por habilidade e, ao lidar com o mundo veloz de uma sessão real ao vivo, sei que pareci rígido e deliberado, com minha mente focada em protocolos e estratégias em vez de em princípios ou no paciente. Tenho certeza de que muitos de meus pacientes se sentiram dirigidos, instigados ou arrastados pelas prescrições do manual de tratamento em DBT. Mais tarde, percebi que éramos três na sala: o paciente, eu e o *manual*. Depois que percebi que poderia agrupar as inúmeras intervenções em algumas categorias (avaliação, mudança, aceitação e dialética), pude navegar pelas sessões com mais intuição, velocidade, movimento e fluxo, mesmo enquanto permanecia focado no alvo comportamental atual, acompanhando o paciente e permanecendo em contato comigo mesmo. Experimentei maior liberdade e maior confiança. No léxico das habilidades centrais de *mindfulness* da DBT, tornei-me mais capaz de participar de forma eficaz, fazendo uma coisa de cada vez e adotando uma postura não julgadora. Pude intervir com mais confiança, sabendo que poderia mudar conforme necessário se a intervenção atual fosse ineficaz. Depois de alguns anos de prática, passei a apreciar as enormes vantagens do tratamento baseado em princípios. Vamos dar uma olhada detalhada em como essa perspectiva recém-aprendida funcionou no contexto de uma sessão com uma jovem a quem chamo de Tracy.

EXEMPLO DE CASO DO TRATAMENTO BASEADO EM PRINCÍPIOS

Depois de concluir uma avaliação com Tracy, chegar a um diagnóstico de TPB, concordar com um conjunto de metas de tratamento, orientá-la sobre o tratamento e obter um compromisso inicial com os alvos e o plano, começamos a trabalhar juntos em sessões da maneira padrão. Tracy passou por várias terapias, não conseguiu se beneficiar com tentativas de tratamentos farmacológicos, perdeu a esperança de conseguir ajuda e me procurou como “último recurso”. Sua lista de alvos prioritários incluía uma série de problemas: episódios de comportamento suicida por *overdose* e autoestrangulamento, condutas autolesivas sem intencionalidade suicida (CASIS) de alta frequência e baixa letalidade, episódios ocasionais de direção perigosa em alta velocidade para “tentar morrer”, frequência inconsistente em terapias anteriores, respostas emocionais dolorosamente intensas com mudanças rápidas de humor diariamente, uso diário de maconha para acalmar suas ansiedades e humores, sentimentos terríveis de vazio a menos que estivesse em um relacionamento intenso, um padrão de relacionamentos frequentes de alta intensidade resultantes em mágoas e ressentimento, padrões de gastos erráticos e nenhuma amizade platônica duradoura. Ela preencheu todos os nove critérios para TPB. Descrescia-se como alguém sem rumo, “vivendo como uma sonâmbula”, seguindo um novo caminho todos os dias, e sentia que era “fundamentalmente falha” e “fora de controle”. Quando forneci a orientação usual para os problemas tratados na DBT, reenquadrando os nove critérios diagnósticos como representando cinco categorias de desregulação (emocional, interpessoal, comportamental, cognitiva e do *self*) que são abordadas em quatro módulos do treinamento de habilidades, ela sentiu-se temporariamente esperançosa (mais

organizada, menos estigmatizada e mais capaz de ver um caminho para a recuperação). Esse sentimento positivo desapareceu rapidamente quando nosso tratamento começou.

Durante o primeiro mês, ela chegou às sessões atrasada, desorganizada e pedindo desculpas. Transmitiu a impressão de alguém que estava totalmente perdida e simplesmente apareceu na minha frente. Ela sempre parecia estar no meio de algum tipo de episódio emocional intenso e raramente se lembrava do que havíamos conversado na semana anterior. Começava a sessão quase no meio da frase, como se eu soubesse o que estava acontecendo no seu último incidente de relacionamento problemático. No início de uma dessas sessões, entrou rapidamente, atrasada como de costume, deixou cair a bolsa no chão (tudo caiu dela), sentou-se na cadeira à minha frente e olhou para baixo, sem fazer contato visual, e começou a falar. Ela estava obviamente exasperada, parecia oprimida e, em seu tom, parecia transmitir: “Não se atreva a dizer nada para mim! Não aguento e vou explodir com você se o fizer!”. Em segundos, a sessão foi carregada de emotividade, urgência e impulsividade.

Comecei apenas ouvindo, atento às palavras, à história, ao tom, à postura corporal e às expressões faciais. Eu me orientei para ela naquele momento presente, tentando entender as realidades do que havia acontecido, procurando fazer contato por meio da escuta e da resposta, *intervindo dentro do paradigma da aceitação*, contando com os princípios subjacentes de *mindfulness*. Em segundos, estava usando os três primeiros níveis de validação (completamente alerta e desperto, refletindo seus comentários de volta para ela e articulando o inarticulado) e usando um estilo de comunicação recíproco (alerta, desperto, responsivo ao conteúdo manifesto, caloroso e genuíno). Em mim mesmo, percebi uma pequena dose da urgência e do caos recíproco daquelas mesmas qualidades que ela trazia para o consultório e um desejo de resgatá-la, de encontrar alguma maneira de reduzir seu sofrimento.

Seguindo o paradigma do *mindfulness*, enfatizando a aceitação da realidade como ela é no momento, permaneci na postura de ouvinte, usando essencialmente as habilidades centrais de *mindfulness* da DBT de *observar e fazer uma coisa de cada vez*. A sessão tinha apenas cerca de 45 segundos, o problema da desregulação emocional estava presente na sala, e eu notei que meu atraso era um comportamento-alvo que interferia na terapia. Como mencionado, minha postura foi baseada na aceitação e na tomada de consciência, usando várias estratégias de validação e habilidades de *mindfulness*.

No minuto seguinte, ela despejou a raiva que sentia de seu ex-namorado por querer vê-la novamente. Já tendo visto esse padrão, pude sentir seu ímpeto emocional crescendo de uma forma que poderia se tornar difícil de interromper. Comecei a pensar em como proceder. O que seria consistente com a DBT? Percebi que havia uma dialética: eu poderia ficar dentro do paradigma da aceitação ou poderia começar a pressionar por uma mudança comportamental guiada pelo paradigma da mudança. Do lado da aceitação, poderia continuar a validá-la, o que, talvez, a fizesse se sentir compreendida ao comunicar seus sentimentos sobre o incidente e regulasse suas emoções de maneira mais eficaz. Mas o procedimento da DBT padrão recomendaria que eu pedisse para ver seu cartão diário neste ponto da sessão, como parte da avaliação da semana anterior e da determinação dos comportamentos de maior prioridade – em outras palavras, a mudança de direção. Assim que me ocorreu o pensamento de que era hora de pedir o cartão, pude sentir meu desejo de evitar fazê-lo. Pareceu-me que pedi-lo naquele momento seria como pedir a uma vítima de um acidente de carro em uma sala de emergência suas informações de seguro. Por outro lado, se eu evitasse perguntar, por medo de sua resposta, poderia tratá-la como se fosse frágil, reforçando um padrão disfuncional de comportamento dependente do humor. Com um tom prosaico e “agindo contra”

meu próprio desejo de evitar pedir, interrompi-a, indicando que poderíamos voltar à situação sobre o ex-namorado, e pedi para ver o cartão diário. *Com relação aos paradigmas, passei da aceitação para a mudança e comecei a usar estratégias de solução de problemas.*

Como esperado, ela se sentiu interrompida e agiu como se eu tivesse jogado água fria nela. Ela não olhou para mim e não fez nada para localizar o cartão diário. Parecia magoada e com raiva, mas não falou; na verdade, parecia que havia se distanciado, e se recusou a falar. Eu disse que lamentava tê-la interrompido e que talvez pudesse ter feito isso com mais tato, mas lembrei a ela que na DBT precisávamos definir uma agenda para a sessão se quiséssemos mudar sua vida. Ela ficou calada e tive a impressão de que a havia irritado ainda mais. Embora ela não respondesse às perguntas, senti como se estivesse sendo punido. Vários minutos se passaram. Perguntei novamente se ela poderia expressar sua reação ao que eu havia feito. Senti que estávamos em algum tipo de encruzilhada. Percebi que não tinha certeza do que estava acontecendo com ela e do que fazer a seguir. Tendo introduzido a mudança na sessão, retornei por um momento a uma postura de aceitação. Tentei permanecer alerta a mudanças sutis nas comunicações não verbais e me manter equilibrado. Percebi um desejo de confrontá-la e um desejo oposto de pedir desculpas e resgatá-la.

Ocorreu-me, então, que o que aconteceu entre nós talvez não fosse novidade para ela, mas algo que interferia em seus relacionamentos em geral. Disse: “Tracy, acho que foi um pouco desajeitada a maneira como a interrompi, mas gostaria de saber se isso acontece com você às vezes, e gostaria de saber se nós dois podemos aprender algo com isso que nos ajude?”. Tendo reconhecido que estávamos presos, querendo manter o movimento, tentando reconhecer a validade tanto no que eu havia feito quanto na resposta dela, tentei fazer “dos limões uma

limonada”. Em DBT, essa é uma estratégia dialética. Para revisar: *comecei a sessão dentro do paradigma da aceitação, passei para o paradigma da mudança pressionando-a sobre o cartão diário, voltei à aceitação enquanto ouvia sua resposta raivosa, estava me sentindo travado e mudei para um diálogo do paradigma dialético com uma estratégia de fazer dos limões uma limonada, destacando nossa oposição e buscando a síntese.* Essa mudança acabou com o impasse. Tracy gritou comigo: “Você é um desajeitado na melhor das hipóteses!”, e eu me perguntei como poderia ser um bom terapeuta se interrompia as pessoas. Nesse ponto, ela me disse que havia parado de preencher seu cartão diário esta semana porque era muito difícil e parecia “estúpido”. Passamos a discutir o cartão diário, seu lugar no tratamento e algumas das razões pelas quais ela não queria fazê-lo. Em outras palavras, *estávamos de volta a uma agenda orientada para a mudança usando orientação e renovação do compromisso.* Pelas minhas contas, nesses primeiros minutos eu usei cerca de 13 estratégias de tratamento, mas minha consciência estava mais focada em começar com aceitação, passar para a mudança, voltar para a aceitação, para a dialética e voltar para a mudança novamente. Alternar entre os três paradigmas, em vez de considerar todas as estratégias e habilidades, é uma forma mais eficaz de “navegar” na sessão de DBT.

COMENTÁRIOS FINAIS

Apresentei agora os três paradigmas, coloquei-os no contexto da DBT abrangente e considere como nos movemos para frente e para trás entre eles enquanto navegamos nas sessões com os pacientes. Nos próximos três capítulos, examino com mais detalhes os princípios de cada paradigma e como eles se integram ao tratamento. Mas, para levar o capítulo atual a uma conclusão prática, resumi os principais fatores que mantenho em minha consciência ao passar por uma sessão de DBT – numerosos o suficiente para me fornecerem opções, poucos o suficiente para me ajudarem a me manter organizado e focado.

1. Mantenha o foco no alvo primário, que fornece a agenda geral, e alterne entre os alvos secundários (ou instrumentais), conforme necessário para atingir o alvo primário.
2. Permaneça alerta para a presença de emoções atualmente ativas no paciente, especialmente aquelas emoções desreguladas; a desregulação emocional é a construção central para entender e tratar nossos pacientes em DBT.
3. Mantenha as intervenções consistentes com as diretrizes de tratamento encontradas nos aspectos relacionados a seguir:
 - a. teoria biossocial;
 - b. acordos do terapeuta;
 - c. pressupostos sobre os pacientes;
 - d. pressupostos sobre a terapia;
 - e. estágio do tratamento atual.
4. Use as estratégias estruturais para direcionar as sessões (início da sessão, direcionamento de alvos, revisão do cartão diário, etc.).

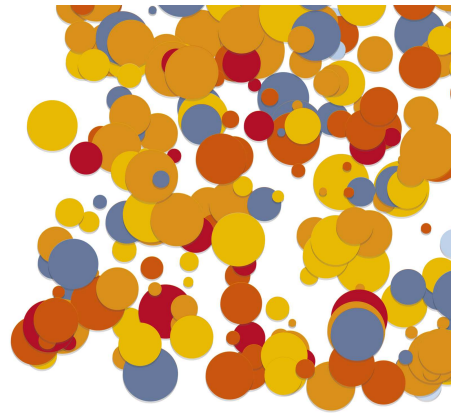
5. Use o protocolo para crises suicidas se o risco de comportamento suicida for aumentado ou iminente.
6. Retorne à avaliação repetidas vezes.
7. Considere qual dos três paradigmas (mudança, aceitação e/ou dialética) é o certo para o momento. Use as estratégias consistentes com essa escolha.

Se fiz parecer relativamente simples definir a direção de um terapeuta DBT selecionando entre três paradigmas, momento a momento, prestei um desserviço ao leitor. Fazer psicoterapia é desafiador, com tantas opções a cada momento e tanta incerteza sobre o resultado de cada uma. No entanto, pode ser útil ter em mente a construção dos três paradigmas, cada um com sua gama de estratégias, especialmente quando se depara com dificuldades. Cada um dos três fornece uma direção, e os terapeutas também podem contar com uma avaliação direta, capacidades intuitivas, consciência plena e capacidade de resposta para “sentir o caminho” a seguir na sessão. O terapeuta move-se para empurrar, mas sente quando empurrar com mais força e quando recuar. Ele chega a uma postura de aceitação, mas determina se deve transmitir ativamente a compreensão ou se deve ficar quieto. Preso entre polos rígidos, ele muda para movimentos intensificados e improvisações, mas de alguma forma intui se seus “movimentos” devem ser grandes ou pequenos, rápidos ou lentos.

Finalmente, ao determinar como e quando mudar entre as três direções paradigmáticas, o terapeuta deve se lembrar de duas ressalvas. Primeiro, o paradigma da aceitação quase sempre deve permanecer presente e influente, mesmo que em segundo plano, ao pressionar por mudanças comportamentais. Um ambiente de validação abrangente é valioso para combater a autoinvalidação generalizada do paciente, facilitando o apego e a alavancagem que ele fornece e apoiando o tratamento orientado à mudança. Em segundo lugar, os três paradigmas não são “iguais” uns aos outros

em ordem de prioridade. A DBT é um tratamento orientado a metas, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é o paradigma orientado a metas e, portanto, central, e os outros dois paradigmas são, em certo sentido, maneiras de ampliar a TCC quando indicado. Tendo apresentado os três paradigmas e como os terapeutas podem se basear neles durante as sessões, examinaremos mais de perto os princípios que acompanham cada um nos próximos três capítulos.

[checking] N. de R.T.: *Checking*, no hóquei, envolve o movimento de um jogador defensivo no qual ele colide com o oponente que está segurando o disco, avançando com o quadril ou o ombro, resultando em uma colisão violenta. O contato tem como objetivo separar o jogador do disco ou simplesmente atrapalhar a jogada. É também uma forma de intimidar o adversário.



3

O paradigma da aceitação

ACEITAÇÃO E *MINDFULNESS* NA PRÁTICA DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA

Para recapitular a história do desenvolvimento da terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*), Linehan começou com o paradigma da mudança, aplicando estratégias de solução de problemas da terapia cognitivo-comportamental (TCC) para o tratamento de comportamentos suicidas. Ela acrescentou estratégias baseadas na aceitação para lidar com o sofrimento do paciente e facilitar o uso da TCC. A essa mistura acrescentou estratégias de uma perspectiva dialética para enfrentar os problemas de rigidez, polarização e conflitos típicos dessas terapias. Mas começamos nossa discussão formal dos três paradigmas com o da aceitação por várias razões. Em primeiro lugar, é o mais antigo dos três, e seu início remonta à vida de Buda, há mais de 2.500 anos. É uma raiz profunda da “árvore da DBT” (ver Capítulo 6). Em segundo lugar, na maioria dos casos, o uso de intervenções orientadas para a aceitação é um pré-requisito para o uso eficaz de estratégias cognitivo-comportamentais e dialéticas. “Entrar no inferno com o paciente”, conforme discutido no Capítulo 1, é essencial para ajudar o paciente a encontrar a saída do inferno e requer escuta cuidadosa e validação, essencialmente aceitação e aumento da tomada de consciência. Em terceiro lugar, idealmente entramos em cada sessão de terapia, grupo de treinamento de habilidades, *coaching* telefônico e reunião da equipe de consultoria com a mente aberta e um coração compassivo e receptivo. Não tenho dados empíricos para provar isso, mas minha convicção, nascida da experiência clínica, é que sou mais eficaz em ajudar meus pacientes a mudarem quando começo a partir de uma postura de aceitação: desperto, alerta, adotando uma postura não julgadora e totalmente presente. Quando estou verdadeira e totalmente

presente no início de uma sessão, meus pacientes percebem. E isso injeta na sessão um senso de relevância e imediatismo. Finalmente, começamos aqui com a explicação do paradigma da aceitação porque no ensino dos módulos de habilidades da DBT, as habilidades de *mindfulness*, que são baseadas na aceitação, são fundamentais e, portanto, são chamadas de habilidades centrais de *mindfulness*. Praticar essas habilidades é essencial para o aprendizado e a prática das outras.

O paradigma da aceitação em DBT é baseado, acima de tudo, nos princípios e práticas de *mindfulness*. *Mindfulness* é uma capacidade inata da mente humana, a capacidade de ver o desenrolar da realidade de forma clara, direta, no aqui e agora, momento a momento, sem “ilusão”. Embora introduzidos por meio da prática de meditação baseada em *mindfulness* por Buda há cerca de 2.500 anos, os conceitos e práticas básicos podem ser encontrados em todas as tradições espirituais ao redor do mundo, bem como nas tradições seculares. *Mindfulness* acontece involuntariamente quando “acordamos” no momento presente. Por exemplo, de repente ficamos atentos, totalmente despertos e alertas para a realidade presente, quando experimentamos uma ameaça à nossa vida ou ao nosso bem-estar. Esse mesmo estado pode ser cultivado intencionalmente por práticas meditativas para trazer a consciência do momento presente a todos os aspectos de nossa vida, aumentando assim nosso bem-estar. Na verdade, a prática de meditação baseada em *mindfulness* ao longo dos séculos deu origem a certos *insights* que formam o núcleo dos princípios do paradigma da aceitação da DBT. Considerando que a totalidade das práticas e percepções da meditação traz conhecimento para o terapeuta DBT, cinco princípios abrangentes são particularmente relevantes:

1. *consciência do momento presente*;
2. *desapego*;

3. *interexistência*;
4. *impermanência*;
5. *“o mundo é perfeito como é”*.

Em conjunto, esses princípios promovem consciência, aceitação e compaixão. Eles estabelecem as bases para as estratégias de validação e o estilo de comunicação recíproca da DBT e constituem um dos principais meios com os quais os terapeutas se regulam durante a terapia.

CONSCIÊNCIA DO MOMENTO PRESENTE

Talvez o conceito e a prática no cerne do paradigma da aceitação – pré-requisito para os outros princípios da aceitação – seja este: o momento presente é o único momento. Quando nossa atenção se fixa no passado, ela se fixa em uma memória, uma história, uma espécie de ficção. Quando nossa atenção é atraída para o futuro, ela é atraída para uma fantasia. Em um retiro de *mindfulness* com Thich Nhat Hanh, ele foi questionado sobre como alguém poderia planejar o futuro se a atenção nunca deixasse o momento presente. Thich Nhat Hanh respondeu que o melhor planejamento para o futuro acontece quando se traz o futuro para o momento presente, não quando se abandona o momento presente para entrar no futuro. O momento presente é o anfitrião; o futuro é o convidado. Ele continuou dizendo que isso também vale para pensar no passado. Pode-se convidar as memórias do passado para o momento presente sem perder a base na realidade do momento presente. A realidade é aqui e agora e está ocorrendo, estejamos conscientes disso ou não. Só precisamos acordar e perceber, e quando o fizermos, essa consciência do momento presente nos transportará e nos transformará, de forma invisível, instantânea, de volta à realidade. Thich Nhat Hanh (1975) chamou esse estado de “milagre do *mindfulness*”.

Quando habitamos o momento presente, com consciência das sensações, percepções, pensamentos e eventos que nele residem, estamos enraizados na realidade enquanto fazemos tudo o que fazemos. Quer estejamos hospedando o passado ou o futuro, ou envolvendo nossos pacientes de DBT na solução de problemas, tentamos nos manter ancorados no momento presente. O indivíduo que é “sequestrado” por memórias de um passado traumático ou ainda é assombrado por um futuro irreal não vive o presente; está, portanto, fundamentado na irrealidade do passado ou do futuro e

tem uma limitação invisível. Luto complicado, estresse pós-traumático, pânico, ansiedade intensa e preocupação estão associados ao tipo de “hiperconsciência” do passado ou do futuro que ofusca o momento presente. Quando os pacientes são tomados por reencenações traumáticas, em alguns casos a ponto de dissociar-se do presente, as técnicas de “aterramento” visam especificamente a ajudá-los a recuperar a consciência do momento presente. Quando os pacientes são tomados pela ansiedade desencadeada pela previsão de resultados futuros catastróficos, os terapeutas habilidosos ajudam a reconectá-los à realidade, pedindo-lhes que observem e descrevam as sensações associadas que ocorrem aqui e agora. Quando pacientes deprimidos experimentam involuntariamente pensamentos perturbadores sobre o passado, o futuro e o mundo, os terapeutas DBT os ajudam a planejar e implementar atividades que trazem sua atenção e consciência para o momento presente. A influência da percepção do momento presente (e a perda da percepção do momento presente) é onipresente, constante e consequente.

Como se aprende no módulo de habilidades centrais de *mindfulness* da DBT, a prática de observar e descrever a realidade do momento presente e participar plenamente dela fornece caminhos para encontrar a sabedoria dentro de si mesmo. A prática de observar e descrever sensações, emoções, impulsos, angústias, respostas comportamentais e situações interpessoais à medida que ocorrem naquele momento é um pré-requisito para participar efetivamente dos outros três módulos de habilidades, nos quais o paciente está tentando mudar as respostas emocionais, tolerar o mal-estar e mudar os padrões de relacionamento.

E para os terapeutas (essencialmente, cada um de nós), que são repetidamente desviados pelas reações emocionais, cognições problemáticas e percepções errôneas dos pacientes à medida que são atraídos para reações ao passado, medos do futuro e interpretações esparsas da realidade presente, a prática de buscar

de volta o momento presente torna-se central para a visão clara, para a aceitação da realidade e para sua autorregulação. Às vezes, quando os terapeutas não estão “vivendo o momento” e percebem esse fato, podem retornar ao momento presente prestando atenção em seu corpo, percebendo o contato de seu corpo na cadeira ou de seus pés no chão, e notando que seu centro de gravidade se desloca para baixo no abdome. Ou seja, a consciência do momento presente está no cerne das habilidades centrais para o autocuidado de cada terapeuta e é completamente necessária para o importante processo na DBT de *aceitar radicalmente a realidade*.

DESAPEGO

De uma perspectiva budista, derivada de mais de 2.000 anos de prática de meditação baseada em *mindfulness*, o apego é a causa-raiz do sofrimento humano, e renunciar ao apego é uma prática essencial para reduzir esse sofrimento. O apego, nesse contexto terapêutico, não se refere ao apego entre os seres. O apego entre paciente e terapeuta é um ingrediente crucial no tratamento em DBT. Em vez disso, refere-se a um apego a crenças, percepções, posses, preferências e estados mentais. Se uma pessoa tem artrite no quadril, como eu, ela sente dor. Se, além dessa dor física, ela está apegada à crença de que não deveria ter artrite ou que não é justo que tenha artrite, então ela está acrescentando sofrimento à sua dor. Se uma pessoa está apegada a permanecer jovem, então as inevitáveis realidades dolorosas que acompanham o envelhecimento são agravadas ainda mais pela crença de que não deveria ser assim. Para a pessoa que se apega à saúde como se fosse o único estado aceitável ou justo, esse apego acrescentará sofrimento ao desconforto natural da doença. Aqueles para quem a dolorosa perda de um relacionamento, de uma pessoa, de um animal de estimação ou de um emprego é simplesmente inaceitável e nunca deveria ter acontecido sofrerão com essa não aceitação, além do luto inevitável. Tendo adquirido a percepção de que a vida é inevitavelmente cheia de dor e que resistir ou protestar contra essas realidades dolorosas causa sofrimento adicional (conhecido respectivamente como a primeira e a segunda nobres verdades do budismo), o Buda então ensinou que o alívio do sofrimento vem do reconhecimento e da aceitação da realidade como ela realmente é, deixando de lado o apego a crenças, percepções, posses e estados mentais (terceira nobre verdade do budismo). A partir desses *insights*, surge o ditado: “A dor é inevitável; o sofrimento é opcional”.

As aplicações dessas descobertas são abundantes na DBT. Certa vez, fui solicitado a atender um indivíduo diagnosticado com transtornos da personalidade *borderline* e antissocial para fornecer recomendações e considerar se ele era um candidato adequado para DBT. Ele estava na prisão (por roubar vários itens eletrônicos de uma loja) e era intolerante com a forma como estava sendo tratado. Em um dado episódio, ele rapidamente ficou emocionalmente desregulado e atacou vários outros presos e um guarda da prisão. Quando o vi, estava em uma cela de isolamento e não podíamos ficar no mesmo ambiente. Eu o entrevistei através de uma janela horizontal de 2,5 x 25 cm em uma porta sólida, a cerca de 1 metro do chão. Tudo o que podíamos ver eram os olhos um do outro. No início da entrevista, perguntei-lhe se ele tinha alguma imagem esperançosa ou significativa do futuro, algo em que pudesse se apoiar. Seus olhos eram expressivos, mais suaves do que eu esperava, e umedeceram quando ele me implorou: “Tudo que eu quero é sair desta cela. Isso só me deixa pior. Eu não aguento! Eu não consigo nem pensar em nada. Você acha que poderia me levar de volta para uma cela normal?”. Eu me compadeci enquanto o ouvia. Senti seu sofrimento e percebi o desejo de defendê-lo. Ele realmente tinha que ficar em isolamento? Imaginei como seria horrível estar isolado.

Juntamente a minha resposta empática à sua situação, que foi mais forte do que esperava, também sabia que ele havia contribuído para seu estado atual em boa parte devido a seus atos e escolhas. De alguma forma, ele havia “conquistado” seu lugar na solitária. Eu estava ciente de um impulso de resgatá-lo, bem como de um impulso de desconfiar dele. Fiquei em silêncio enquanto me permitia absorver essa reação complexa. Apenas me sentei lá, observando a ele e as minhas respostas. Eu estava deixando minha mente se acalmar e, para esse fim, concentrei minha atenção inteiramente em minha respiração (uma inspiração e uma expiração) e esperei que uma resposta de “mente sábia” chegasse.

Ocorreu-me que, além da realidade de estar isolado, das realidades que levaram a essa situação e da realidade de seu desconforto, havia, *além disso*, uma grande urgência. Ele queria sair dali. Isso estava em primeiro lugar em sua mente. Ele era intolerante com sua realidade momentânea.

Eu disse a ele: “Entendo que é horrível para você estar na solitária. Tenho certeza de que seria para mim”.

“Sim, então me tire daqui,” disse de uma forma um tanto exigente, como se eu tivesse autoridade para fazer isso e como se ele tivesse o poder de me comandar. A essa altura da entrevista, não senti nenhuma vontade de resgatá-lo, nem de acusá-lo.

“Eu realmente não tenho autoridade para tirá-lo daqui e não sei por que você está na solitária. Mas eu me pergunto se você poderia simplesmente se acomodar onde está agora, apenas se permitir estar onde está e falar comigo. Se você passar cada segundo convencido de que precisa sair daqui agora mesmo, poderá sofrer ainda mais. Se você pudesse aceitar que está onde está, por enquanto, aceitar verdadeiramente, talvez se sentisse menos chateado. Quem sabe, talvez até acabasse saindo mais cedo se parasse de pensar que tem que sair.” (Este último comentário, fluindo facilmente de uma postura consciente e receptiva, também é um exemplo de “entrar no paradoxo”, uma das estratégias dialéticas da DBT.)

Tenho certeza de que vi uma nuvem de raiva cruzar seus olhos, e ele olhou para o chão e disse: “Então você acha que eu deveria apenas engolir isso?”.

“Não,” eu disse, “na verdade, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que se você parar de pensar que tem que sair imediatamente, parar de contar os minutos e os segundos, talvez você tolere melhor. E então o tempo vai passar e você estará fora”. Eu pensei ter visto uma centelha de interesse em seus olhos.

Esse paciente estava se apegando a um resultado sobre o qual tinha muito pouco controle: a transferência imediata do isolamento.

Seu apego em sair imediatamente estava causando-lhe sofrimento adicional e maior desregulação em suas emoções e ações, perpetuando sua permanência no isolamento. Se pudesse aceitar a realidade e, em vez disso, encontrar uma maneira de apenas estar naquele momento, talvez ele saísse mais rápido.

Quando começamos a conversar, senti uma necessidade imediata de resgatá-lo, tirá-lo de lá. Se eu tivesse permanecido assim, também teria sofrido mais e teria sido de pouca utilidade para ele. Para ajudá-lo, tive que perceber e deixar de lado o desejo de resgatá-lo. Embora esse exemplo tenha surgido de uma situação única, a visita a um paciente na prisão, o processo de apego aos “deverias” ou aos desejos acontece em todas as sessões. Cada sessão nos dá a oportunidade de nos fisgar (apego), de sofrer, de perceber que estamos fisgados (isto é, de acordar) e de nos livrarmos do apego para podermos recuperar nosso equilíbrio.

Vamos revisar as etapas desse exemplo para generalizar esse processo a outros tipos de armadilhas e apegos na terapia. Primeiro, eu me apeguei. Eu “senti sua dor”, simpatizei com seu desejo urgente de sair do isolamento. O apego dele se tornou meu apego antes mesmo de eu pensar nisso. Em segundo lugar, e esta é a chave de todo o processo, *reconheci que estava apegado*. Essa necessidade de resgatar não é incomum no tratamento de indivíduos que apresentam altos níveis de desregulação emocional. Apodera-se de nós o sentimento de que temos de *fazer* alguma coisa. Nos apegamos a fazer algo quando, na verdade, nada precisa ser feito. Se reconhecermos nosso senso de urgência, só então estaremos posicionados para restabelecer nossa liberdade e equilíbrio e só então teremos chance de ajudar o paciente. Em terceiro lugar, abandonar o apego, mesmo quando vemos que estamos apegados, não é necessariamente tão fácil. Nesse caso, fui ajudado pela prática de recuar, entrar em mim mesmo e, com total atenção à respiração, observar cada

inspiração e expiração. Com frequência, precisamos de um veículo como este quando estamos no meio do caminho tentando nos desvencilhar de um apego. Por analogia, se dirigimos um carro com transmissão manual e queremos mudar de uma marcha para outra, precisamos pisar no pedal da embreagem até o fundo. Engatar o pedal da embreagem nos permite desengatar nossa marcha atual e, então, mudar para a nova marcha. Na terapia, rotineiramente ficamos presos em uma “marcha” ou outra e precisamos de um “pedal de embreagem”. Podemos estar empenhados em impedir que nossos pacientes se envolvam em comportamentos suicidas ou condutas autolesivas sem intencionalidade suicida (CASIS), uso de substâncias ou episódios dissociativos. Ou podemos estar empenhados em garantir que nossos pacientes mostrem progresso visível. Ou podemos estar apegados a não nos tornarmos alvo de sua raiva. Quanto mais nos apegamos às coisas sobre as quais não temos controle, mais nos desregulamos emocionalmente, mais sofremos e menos eficazes nos tornamos. Este é um paradoxo interessante da DBT: se nos concentrarmos demais nos resultados nesta terapia orientada para resultados, podemos nos tornar, dia após dia, mais instáveis e menos eficazes em alcançá-los.

Voltando ao exemplo do paciente em isolamento: 1) eu rapidamente me apeguei, como ele, à ideia de tirá-lo de lá; 2) reconheci que estava apegado; 3) consegui mudar de marcha, “deixar ir” meu apego com a ajuda de uma respiração consciente; e agora 4) eu podia ver o dilema do paciente, o sofrimento que ele estava causando a si mesmo por meio de seu apego mais claramente, e então estava em posição de ajudá-lo a lidar com a realidade. Então o paradoxo me ocorreu (que ele poderia sair mais cedo se parasse de tentar sair) e eu poderia comunicá-lo a ele. Sua perplexidade e ambivalência sobre minha sugestão o desequilibraram e abriram a porta para um novo começo. Um

protocolo rápido para este processo pode ser feito da seguinte forma:

1. *Apegue-se* (imediatos, involuntários, automáticos).
2. “*Acorde*” para o reconhecimento do apego.
3. “*Liberte-se*” do apego, possivelmente com a ajuda do *mindfulness*.
4. *Veja a realidade do paciente como ela é*.
5. *Intervenha* estrategicamente para ajudar o paciente com seu apego e sofrimento.

Às vezes, a etapa de deixar ir (nº 3) é muito mais difícil do que eu transmiti. Os terapeutas podem reconhecer que estão em uma “armadilha”, mas não conseguem ver a saída. Por exemplo, certa vez eu estava conduzindo uma sessão familiar de DBT na qual uma adolescente com desregulação emocional e desenvolvimento atípico estava sentada entre seus pais. Eles se alternaram em “tentar colocar algum juízo” sobre sua mendicância recente nas ruas. Ela ficou cada vez mais silenciosa e mal-humorada, e eu tentei tudo o que pude para criar movimento e mudança em um diálogo cada vez mais negativo. Não estava chegando a lugar algum. Eu estava empenhado em mudar essa dinâmica familiar em evolução, que parecia estar além do meu controle, e minha sensação de desamparo e desesperança crescia à medida que eu continuava. Não consegui encontrar uma saída. Sabia o suficiente para entender que estava preso, mas não o bastante para levar a conversa adiante. No exemplo anterior, fui capaz de abandonar meu apego com uma respiração consciente completa, mas neste contexto isso se mostrou insuficiente. Eu precisava de uma estratégia mais substancial para limpar minha mente. Nunca tendo feito isso antes, anunciei uma pausa de cinco minutos, afirmando que não estávamos chegando a lugar nenhum e precisaríamos de um novo começo. Sugeri que cada um de nós levasse cinco

minutos para fazer o que fosse necessário para clarear nosso pensamento e depois nos reuníssemos.

Meu consultório ficava próximo a um grande riacho. Desci rapidamente para lá e, esvaziando minha mente de meus sentimentos de aprisionamento na sessão familiar, apenas observei galhos e folhas flutuando rio abaixo, passando por troncos e grandes pedras. Entrei naquele momento e me permiti observar os detalhes. Pelo menos naqueles poucos minutos consegui sair do ciclo sufocante em que me encontrava. Retornei à sessão, ainda sem saber o que faria a seguir, mas permitindo o estado transitório suspenso e esperando que minha “mente sábia” gerasse uma intervenção diferente. Quando me sentei, disse à adolescente que queria que ela assumisse a direção da sessão. Ela parecia confusa e ansiosa. Eu assegurei que ela não poderia fazer nada pior do que eu. Pedi que trocasse de lugar comigo e ocupei o lugar entre os pais dela. Ela se sentou na minha cadeira, colocou uma prancheta e um pedaço de papel no colo e anunciou, com bastante certeza: “As coisas não estão indo muito bem nesta sessão; precisamos mudar de direção”. Ela era surpreendentemente assertiva, uma mudança radical de sua postura passiva habitual. Todos nós esperamos. Ela continuou: “Acho que precisamos falar sobre como os pais falam com uma filha que os envergonha”. Entramos em uma discussão produtiva sobre o quanto os pais ficaram constrangidos com o comportamento de sua filha nas ruas de sua pequena cidade.

Honestamente, ao rever minha decisão de transformar a paciente em “terapeuta” e me colocar no lugar dela, ainda é um mistério como essa ideia me ocorreu. Talvez tenha sido uma decisão terapêutica de “mente sábia” que evoluiu de “esvaziar” minha mente ansiosa e apenas observar o fluxo de um riacho. Talvez o valor da intervenção tenha resultado simplesmente da mudança de cenário quando as coisas estavam tão travadas. Talvez me posicionar como um “observador” entre os pais tenha

sido fundamental, alterando estruturalmente o equilíbrio de poder na sessão para que a paciente pudesse “pegar emprestado” o poder da posição do terapeuta. Eu não tenho certeza. Mas, em minha experiência, a mudança decisiva de “fazer” para simplesmente “ser” dá origem a todos os tipos de aberturas surpreendentes e imprevisíveis.

INTEREXISTÊNCIA

Em geral, consideramos os limites comuns e necessários (“boas cercas fazem bons vizinhos”); assumimos que cada um de nós tem um “eu” que é único e distinto dos “eus” dos outros; e que os seres, embora conectados uns aos outros, são principalmente separados e únicos. No entanto, de outra perspectiva (uma que emergiu das práticas milenares de meditação baseada em *mindfulness* que exige um relaxamento da percepção e do pensamento convencionais), a realidade não tem limites: a *interexistência* é a regra e o conceito de “eu” é uma ilusão. Tomamos como certos alguns “limites” em nossa vida: os limites entre a vida e a morte; entre si e os outros; entre o passado, o presente e o futuro. Quanto mais de perto e com mais cuidado examinamos esses limites assumidos, porém, mais indistintos eles se tornam. Quando consideramos profundamente o limite em torno do início da vida, é quase impossível, e às vezes controverso, definir esse momento. Quando examinamos a fronteira entre a vida e a morte, ficamos impressionados com a incerteza sobre onde termina a vida e onde começa a morte.

Quando meu pai estava morrendo, sentei-me sozinho com ele, segurando sua mão, enquanto sua respiração ficava cada vez mais lenta, e eu sabia que ele estava morrendo. Eu me senti absolutamente presente e de uma forma profundamente interligada com ele. Reconheci que ele estava em mim e que eu estava nele. Suas respirações começaram a ser espaçadas em 10, 20, 30 segundos. E então pareceram parar totalmente... ou pararam? Na minha experiência, ele ainda estava vivo. Quando sua respiração não voltou por vários minutos, mas ele parecia mais ou menos o mesmo, ainda pensei nele como estando vivo, mas em algum momento do processo ele havia morrido. Ele não estava mais vivo, mas em outro sentido ele estava tão vivo dentro de mim como

sempre esteve. Nunca a fronteira entre a vida e a morte me pareceu tão frágil, tão indefinida. Ele agora estava morto, mas ainda estava vivo. Ele estava em algum lugar, pensei: na sala, na parede, na atmosfera, talvez ainda em seu corpo e definitivamente em mim. Era, para dizer o mínimo, um mistério.

E quando olhamos com o mesmo cuidado para a fronteira entre nós e as outras pessoas, perguntando exatamente onde nós terminamos e elas começam, e que partes delas somos nós, e que partes de nós são elas, novamente perdemos o limite, a definição da fronteira. Quando ensino, geralmente sinto que estou tendo meus próprios pensamentos, apresentando minhas ideias com minha fala e meus gestos. É o meu “eu” falando, meu eu único, e os membros da audiência ouvindo, “ali”. Mas quando tenho uma ideia, falo sobre ela, uso um gesto, às vezes me dou conta de que todas as ideias, palavras e gestos vieram de outras. Meu avô, que foi produtor de leite a maior parte de sua vida adulta, viajava para visitar outros produtores, dando palestras e conduzindo *workshops*. Seu pai veio do sudoeste da Suécia; eu apresento *workshops* no sudoeste da Suécia, talvez para parentes meus, sem que eu saiba. Meu pai era solista no coro de nossa igreja quando eu era menino. Meu irmão mais velho foi campeão nacional como orador no ensino médio. Minhas ideias vêm das ideias dos outros. Ao ministrar um *workshop* ou seminário, sou influenciado a cada segundo por meus alunos nas ideias, palavras, entonações e gestos que escolho. Quando você soma tudo, literalmente nada é exclusivamente “meu”. O conceito de *meu* se dissolve no reconhecimento da *interexistência*, da profunda interdependência. Para o professor budista Thich Nhat Hanh, isso leva a uma compreensão do termo *vacuidade* no budismo: como ele explica, “a flor é feita inteiramente de elementos que não são flores; ela não tem existência independente e individual. Ela ‘inter-é’ com tudo o mais no universo” (1995, p. 11). Estendendo esse conceito para si mesmo, “Charlie Swenson é feito inteiramente de ingredientes não

pertencentes a Charlie Swenson”. *Interexistência* e *vacuidade* andam de mãos dadas.

Tomando emprestada ainda mais uma metáfora de Thich Nhat Hanh, podemos pensar em cada um de nós como uma onda no oceano, indo em direção à costa, desde o nascimento no oceano até a morte na praia. Cada onda tem suas próprias formas, tamanho, velocidade e outras características; tem suas histórias e formas únicas. Em contrapartida, cada onda distinta é composta inteiramente de moléculas de água, assim como todas as outras ondas. Na verdade, uma determinada onda é formada por moléculas de água que faziam parte de outra onda momentos antes. As ondas são historicamente únicas e distintas e estão profundamente interligadas e interdependentes. Somos ondas e somos água. Ambas são verdadeiras, e podemos mudar nosso foco entre as ondas únicas e a água indivisível. Na verdade, ambas as “realidades” são válidas: a realidade histórica convencional que honra a singularidade e a separação, e a verdade profunda da interdependência de todos os elementos o tempo todo, conforme captado no termo *interexistência*.

É apenas um pequeno salto entre essas ideias e a ideia do *não eu*. Sem limites, sem separação, independência ou singularidade, cada um de nós é apenas um rearranjo temporário, em evolução e interdependente de matéria e energia. Experimentando a vida a partir dessa perspectiva, podemos observar nossos pensamentos sem pensar em nós mesmos como os “pensadores”; sentir as nossas emoções sem ser quem as “têm”; e quando agimos, podemos perceber que essas ações em um aspecto não são realmente nossas. Pode ser perturbador e confuso perceber até que ponto essa perspectiva é verdadeira; sob outro aspecto, pode ser bastante libertador e contribuir para uma compreensão profunda da natureza humana. É a sabedoria do não eu, da interexistência, da ausência de limites e da *vacuidade*.

Quando notei pela primeira vez essas ideias nos ensinamentos dos mestres de meditação, elas me pareceram desafiadoras, um pouco estranhas, discutíveis e instigantes. Mas o que esse conjunto de percepções tem a ver com a prática da DBT? Tudo. Quer decidamos notar ou não, o “início” e o “fim” da terapia são difíceis de definir; as fronteiras entre pacientes e terapeutas, entre pacientes e seus contextos sociais, entre terapeutas e suas equipes de DBT e entre as díades paciente-terapeuta e a sociedade em geral são difíceis de especificar; e a resposta à pergunta “Quem fez o quê a quem?” é mais complicada do que parece. Quando a equipe de saúde mental de uma unidade de internação reclama que um determinado paciente está “nos manipulando”, podemos revisitar a mesma circunstância com conceitos do não eu, interexistência e ausência de limites. Logo percebemos que a equipe supostamente é responsável por estabelecer as condições do programa e, consciente ou inconscientemente, reforça alguns comportamentos do paciente e não outros. Também seria válido (mas igualmente inútil) argumentar que a equipe está “manipulando” o paciente para que ele se envolva em certas ações, reforçando-as. Em última análise, determinar quem está manipulando quem se torna menos significativo e útil do que adotar uma perspectiva transacional em que ambas as partes são consideradas responsáveis e a colaboração entre elas é a direção preferida. Na DBT, estamos interessados não tanto em saber quem está manipulando quem, mas em determinar como os comportamentos de ambas as partes estão sendo reforçados.

Na terapia individual, quando meu paciente e eu estamos em desacordo e a sessão é carregada de tensão, luta ou distanciamento, posso “cair” do nível de realidade convencional e auto-orientado no qual geralmente opero, para o lugar de ausência de limites, não eu, interexistência e vazio. Quando faço isso, tudo muda; eu relaxo minha definição convencional do que está

acontecendo e vejo a interação com o paciente por um prisma diferente. Onde eu via uma fronteira entre dois seres separados e independentes em conflito um com o outro, semelhante a ondas separadas colidindo no oceano, agora nos vejo como duas formas interdependentes, feitas dos mesmos ingredientes, ambas mutáveis, transitórias, cada uma definida em parte por sua relação com o outro. Não há limite, nem singularidade, nada nos separando, simplesmente estamos lá. Ambos temos nossas forças, e elas se tornam forças coletivas. Nós dois temos nossas falhas e elas se tornam falhas coletivas. Eu paro de “fazer” e, em vez disso, estou “sendo”. Acho muito difícil descrever esse estado diferente, mas ele coloca nosso relacionamento, naquele momento, em um terreno totalmente distinto. É uma reconceitualização radical e imediata. Eu não nos vejo como duas pessoas, cada uma com sua identidade, em conflito uma com a outra; mas sim como duas partes de uma entidade, unidas em algum tipo de narrativa em desenvolvimento. De forma alguma estou dizendo que isso é “a verdade”. É “*uma* verdade”, uma verdade menos convencional, mais sistêmica e que dá origem a uma abordagem diferente. Pelo prisma do não eu, da ausência de limites, do vazio e da interexistência, estamos todos profundamente juntos “nisto”.

Certa vez, meus dois filhos pequenos estavam brigando pelo controle remoto da televisão enquanto eu fazia alguma coisa na cozinha, bem perto deles. Fiquei muito irritado com o que me pareceu ser a falta de sentido e a batalha desnecessária. Minha tolerância estava diminuindo. Tive vontade de repetir o que costumava fazer: ficar entre eles e a televisão, levantar a voz, possivelmente desligar a TV, e dar-lhes uma palestra sobre cooperarem, cuidarem um do outro ou respeitarem o fato de que eu talvez não quisesse ouvir suas brigas. Ou seja, eu tinha o desejo habitual de “fazer alguma coisa” sobre a situação, que geralmente tinha um desfecho infeliz. Eles estavam “fazendo algo” um com o outro, “fazendo algo” comigo, e então eu “fazia algo”

com eles. Mas nesta ocasião em particular, mergulhei no quadro de “ser”. Eu simplesmente os observei; observei meus próprios pensamentos, sentimentos e impulsos; e deixei de lado meu apego em mudar a situação. Então fui até onde eles estavam sentados, sentei-me entre eles e continuei apenas observando a dança do conflito que estava acontecendo. E enquanto eu estava sentado lá, apenas observando, mas não “fazendo” nada, os dois pararam completamente de brigar. Eles me perguntaram o que estava fazendo e eu disse que só estava ali, apenas percebendo o que estava acontecendo, em vez de dizer a eles o que fazer. O impacto foi imediato: ambos pareciam confusos e um pouco desconfortáveis, mas mais calmos; eles continuaram a assistir televisão e o conflito terminou. Perdeu o ímpeto.

Abandonar temporariamente a construção dos limites e do eu durante a psicoterapia e mergulhar no reino da interexistência em que paciente e terapeuta são profundamente interdependentes um do outro pode expor o terapeuta, por meio da intuição e da contemplação, a outro nível de conhecimento sobre o paciente. Na verdade, o pensamento convencional e racional pode interferir no acesso. Um jovem estava descrevendo para mim as terríveis experiências que estava tendo em um novo emprego. Ele recebeu apenas uma orientação mínima para um conjunto bastante complexo de tarefas pelas quais seria responsável e teve a impressão de que não deveria fazer muitas perguntas. Dia após dia, se sentia sobrecarregado. Diante de tarefa após tarefa, sem a menor compreensão de como realizá-las e sem um meio de obter apoio, ele sentiu que estava “afundando”. Pensou que estava ficando deprimido, sentindo-se cada vez mais estúpido e incapaz e, principalmente, muito sozinho. A certa altura, enquanto contava mais uma semana difícil no trabalho, fechei os olhos por um instante, deixando-me “preencher” com sua experiência, como se fosse a minha. A fronteira entre nós tornou-se permeável e tive uma profunda sensação de solidão e perda. Imaginei ser ele, ficar

preso sem ajuda. Lembrei-me de um estudo que realizei durante a faculdade de medicina, no qual observei crianças pequenas no hospital sem os pais, por dias seguidos. Meus pensamentos voltaram para minha própria história de hospitalizações quando criança, sendo deixado sozinho para lidar com isso. E de repente me lembrei da história do meu paciente, que perdeu a mãe para o câncer aos 13 anos. Então falei: “Eu me pego pensando na solidão e no isolamento e em como pode ser terrível ter que resolver tudo sozinho. E isso me lembra de quando sua mãe morreu e seus familiares o deixaram, aos 13 anos, só com seu irmãozinho e você teve que descobrir tudo sozinho. Eu me pergunto se esta situação de trabalho tem algo a ver com isso?”. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele continuou me contando mais sobre os horrores de ficar só quando sua mãe morreu. Acho que ele se sentiu compreendido e, quando voltamos a conversar sobre a situação do trabalho, ele parecia mais resiliente. Permitir-se acessar o nível de experiência em que os limites diminuem e a intuição sobe pode aumentar o repertório do terapeuta com pacientes difíceis de tratar.

Há um poder significativo adicionado aos nossos repertórios como terapeutas se pudermos nos mover entre duas perspectivas sobre a mesma situação. Do ponto de vista do paradigma da mudança, agimos com os pacientes por meio de avaliação e intervenções orientadas para a mudança, e os pacientes agem conosco colaborando ou se opondo, assumindo ou não um compromisso, cumprindo atribuições ou não, e assim por diante. Essa é a perspectiva do “fazer” no cerne do paradigma da mudança e se baseia na compreensão convencional de si mesmo, do outro e dos limites.

Da perspectiva do paradigma da aceitação, centrado em “ser” em vez de “fazer”, vemos a nós mesmos e nossos pacientes como seres interdependentes, cada um parte do outro, com limites incertos ou dissolvidos, unidos na tarefa da terapia, compartilhando espaço, tempo, energia, matéria, ideias, intenções e assim por

diante. Na perspectiva do “fazer”, há um destino ou uma série de destinos; existe o poder do propósito. Na perspectiva do “ser”, não há destino; existe o poder de ser, ou interexistir, no momento presente. Da perspectiva do paradigma da mudança fluem as estratégias de solução de problemas, o estilo de comunicação irreverente e a insistência em trabalhar com os pacientes para resolver seus problemas de vida. Já na perspectiva do paradigma da aceitação, fluem estratégias de validação, um estilo recíproco de comunicação e a disposição de intervir nos ambientes dos pacientes em seu nome.

Talvez ainda mais profundamente, se você conseguir “sentir” isso, terá uma experiência diferente de dentro para fora, no corpo e na mente, entre essas duas perspectivas, cada uma com seu próprio poder (e depois há o poder de ir e vir entre os dois, que é captado na discussão do paradigma dialético). Experimentar a si mesmo dentro de seu corpo ao “fazer” é diferente da experiência de “ser”. Pode ser a diferença entre inclinar-se para a frente enquanto pressiona para uma mudança comportamental *versus* relaxar o peso do seu corpo no momento, na cadeira, abstando-se de empurrar. Estou tentando expressar que há uma experiência, além da nomeação e do emprego de diferentes conjuntos de estratégias, que diferencia a prática desses dois paradigmas. As experiências sentidas internamente de “fazer” *versus* “ser” podem fundamentar você no paradigma apropriado e preparar o terreno para um tratamento profundo de mudança ou aceitação. O poder e a criatividade de fazer a DBT de forma eficaz estão em unir essas duas perspectivas a serviço de ajudar seus pacientes a construírem uma vida que valha a pena ser vivida.

IMPERMANÊNCIA

Um dos maiores desafios no tratamento de indivíduos com desregulação emocional grave e crônica surge quando a excitação emocional é mais intensa. A paciente acha essas emoções quase intoleráveis e pode reagir a elas como se tivesse fobia de suas próprias emoções. Ela aprendeu que uma fuga rápida para comportamentos como autolesão, violência ou abuso de substâncias é um antídoto eficaz e fica presa em uma vida pontuada por comportamentos problemáticos. Ao mesmo tempo, ao escapar rapidamente e repetidas vezes diante da excitação emocional, ela adquire a crença de que as emoções negativas são terríveis, estáticas e permanentes. Suas fugas rápidas impedem oportunidades de aprender o contrário.

Em nossa unidade de internação, havia uma mulher de 18 anos que foi adotada por um casal mais velho do que a média quando tinha 3 anos. Seu próprio temperamento, desde o início, foi difícil. Ela era mal-humorada, altamente sensível e emocionalmente reativa. Embora seus pais fossem dedicados, gentis e generosos com ela, seus estilos intelectuais bastante descontraídos, calmos e de baixa afetividade contrastavam fortemente com o estilo animado e emocional da menina. Este é um exemplo do fato de que mesmo um ambiente gentil e devotado pode invalidar uma criança devido a uma incompatibilidade de temperamentos. Na adolescência, ela começou a se cortar regularmente como forma de lidar com intensas emoções dolorosas. Sem a autolesão, ela sentia que não tinha saída. Além disso, ela passou a acreditar que essas emoções durariam para sempre se ela não as interrompesse.

Seu grupo de habilidades em DBT tinha acabado de começar um novo módulo, o de treinamento de regulação emocional. Na primeira sessão, os professores apresentaram algumas características básicas das emoções. Uma delas era que as

respostas emocionais são de fato bastante breves em duração se não continuarmos a reativá-las com pensamentos e ações emocionais. Como tarefa prática, os pacientes do grupo foram convidados a estudar “a vida e a morte de uma emoção” na próxima vez que uma emoção intensa surgisse.

Durante a reunião no dia seguinte, ela me perguntou se poderia estar na agenda. Quando a visitei, ela disse a todos que “um milagre havia acontecido na noite anterior”. Ela explicou que, durante uma conversa com a mãe ao telefone, sentiu-se magoada e com muita raiva. Desligou na cara da mãe e foi tomada pelo desejo de se machucar. E então se lembrou da tarefa de seu grupo de habilidades. Ela decidiu apenas observar suas emoções por um tempo. Sentou-se por alguns minutos, caminhou, depois sentou-se novamente, o tempo todo percebendo suas emoções. Ela descobriu que seus sentimentos de mágoa e raiva não apenas aumentaram, diminuíram e mudaram de intensidade nos 20 minutos seguintes, mas também que desapareceram após esse período, momento em que ela saiu com alguns de seus colegas. Sua descrição na reunião foi emocionante, como se estivesse relatando um fenômeno humano recém-descoberto – e era exatamente isso o que significava para ela.

Sim, as emoções são impermanentes, se nos permitirmos perceber isso. Assim são os pensamentos, as ações e as situações em que nos encontramos. O reconhecimento de que a impermanência é a natureza da realidade pode ser transformador. Isso pode ser particularmente útil para terapeutas que sentem como se estivessem enfrentando, sessão após sessão, o mesmo paciente imutável. A frustração cresce e a desesperança se instala, em parte devido à crescente convicção de que nada está mudando, quando, na verdade, não é possível que isso aconteça. Como terapeutas, devemos aprender com a descoberta revolucionária de nossa jovem paciente.

Assim como os outros *insights* discutidos neste capítulo, o reconhecimento da impermanência da realidade também nos transforma como terapeutas de forma profunda, sutil e constante. Pode aliviar nossa angústia, reduzir nosso sofrimento e nos manter no caminho certo na DBT se pudermos simplesmente aceitar que as coisas estão sempre em fluxo. O que parece imutável ou impenetrável na verdade está mudando.

Cada momento é novo, apesar da experiência de ambas as partes de que é velho, imutável e estagnado. No budismo, o termo *mente de iniciante* refere-se à experiência de que o encontro com cada momento é fresco e novo. Como uma onda persistente no oceano, todo problema persistente representa uma formação ou sequência que, por mais inflexível que pareça, é feita de ingredientes em constante mudança, em um contexto de constante mudança. A onda pode parecer a mesma, mas consiste em outra, e outra, e então outra coleção de moléculas de água em orientações que mudam constantemente. Compreendendo essa realidade básica, podemos dizer com convicção: “Isso também passará”. Tornamo-nos mais pacientes, mais resilientes e mais atentos às variáveis que faltam e aprendemos que o “ponto de ebulição” da mudança pode chegar a qualquer momento se mantivermos o calor.

Outro valor de reconhecer a impermanência como um fenômeno permanente é o reconhecimento de que, se as coisas estão indo bem hoje, provavelmente mudarão para pior amanhã, de alguma forma. O que sobe, desce; o que desce, sobe; e se pudermos manter presente esse processo recíproco, seremos menos “feridos” pelas fundas e flechas do infortúnio. O paciente diz: “Mas se eu melhorar as coisas, elas vão piorar de qualquer maneira e será devastador”. Pensando nesse aspecto da impermanência, o paciente evita tentar melhorar as coisas. O terapeuta responde: “Você está certo. Se as coisas melhorarem, provavelmente vão, de alguma forma, piorar, embora nunca sejam como antes. É apenas

uma lei do universo e, se pudermos aceitá-la, podemos experimentar os ganhos e perdas no caminho para uma vida que vale a pena ser vivida como lombadas em vez de vê-los como muros”.

“O MUNDO É PERFEITO COMO É”

Este é outro daqueles *insights* que podem soar bastante simplistas, estranhos e impossíveis. Como o mundo poderia ser perfeito, quando na verdade há tanto sofrimento, transgressão, conflito e incompreensão? Como dizer que tudo tinha que ser como é, que tudo deve ser como é, que tudo é perfeito assim como é? Como um episódio de comportamento suicida, um ataque violento ou uma falha no tratamento podem ser “perfeitos”? A afirmação pode ser confusa, aparentemente inválida, até entendermos que a palavra *perfeito* não está sendo usada de maneira convencional. “O mundo é *perfeito* como é” não significa que as coisas estão bem, que o mundo é justo e correto, que o ambiente é compassivo e misericordioso. Isso não significa que aprovamos o mundo como ele é, ou concordamos com ele. Significa simplesmente que o mundo é exatamente como é, exatamente como deveria ser, considerando tudo o que veio antes. Significa simplesmente que tudo é causado pelo que veio antes. Alguém se envolve em um episódio de comportamento suicida porque, historicamente, levando ao momento presente, todas as causas e condições levaram ao ato de suicídio. Como este momento poderia ser diferente do que é, dado o impacto coletivo de todos os momentos anteriores? Essa perspectiva não é diferente de como um comportamentalista pensa ao avaliar as variáveis controladoras de determinado comportamento, ou seja, ao avaliar as causas e condições que conferem determinada função a um comportamento e o mantêm.

Carma é um princípio que surge do budismo e que se baseia em muito do mesmo pensamento. Significa que tudo agora foi causado por ações anteriores. Dar um passo para o futuro significa construir nosso futuro ação por ação, pelas escolhas, pensamentos, palavras e ações de hoje. Cada semente plantada

hoje tem consequências amanhã. Olhar para trás, para ver como o estado atual surgiu, deve ser equilibrado olhando para o próximo momento e todos os momentos além dele, nos quais as escolhas e ações atuais podem trazer um resultado diferente. Encontrar esse equilíbrio pode ajudar o terapeuta DBT de forma renovada e esperançosa a avançar no tratamento de problemas crônicos e frustrantes. Ações antigas trouxeram resultados atuais; novas ações determinarão novos resultados futuros. As coisas mudam; plantamos sementes agora para que novas coisas cresçam. O tempo pode não “curar todas as feridas”, mas definitivamente resulta em mudança. Para o terapeuta que trabalha com o paciente difícil de tratar, pode ser bastante reconfortante entender que, se ele persistir na prática da DBT nos bons e maus momentos, aplicando sua multiplicidade de diretrizes e estratégias, as coisas realmente mudarão. Na DBT, o terapeuta tem coisas a fazer que podem ajudar a ele e ao paciente a superarem a patologia, que está em constante transformação.

Esse princípio de que o mundo é perfeito como é encontra seu caminho no tratamento em DBT em vários “locais”. Um dos pressupostos da DBT é que, independentemente do que possa parecer, os pacientes estão fazendo o melhor que podem. Outro pressuposto é que, independentemente de como os pacientes parecem estar prejudicando sua própria melhora, presumimos que eles desejam melhorar. Os pacientes podem parecer estar deliberadamente arruinando sua vida, ignorando seus terapeutas, esquecendo-se das habilidades e tendo o mesmo comportamento autodestrutivo repetidas vezes. Como eles podem estar fazendo o melhor que podem? Como pode ser verdade que eles querem melhorar? Essa é exatamente a questão naquele momento para DBT. Se você se permitir abraçar o *insight* de que “o mundo é perfeito como é”, parecerá simples reconhecer o grão de verdade dos atuais padrões comportamentais disfuncionais; a verdade de que tudo tinha de ser como é dado o que tem sido até agora; a

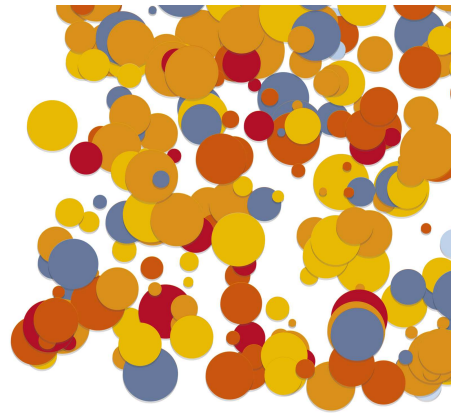
verdade de que os pacientes estão fazendo o melhor que podem; e a verdade de que eles gostariam de melhorar. Então, naquele momento, tratando cada paciente com compaixão e sem julgamento, o terapeuta pode trabalhar com ele para construir uma vida melhor a partir desse momento.

O conceito de carma encontra seu caminho para um terceiro pressuposto sobre os pacientes em DBT: eles precisam se esforçar mais, fazer melhor e estar mais motivados para mudar. Mesmo que tudo esteja como tem que ser dado tudo o que foi, o futuro não está determinado. Todo comportamento agora tem consequências; ações importam. Com cada ação, cada escolha, cada intervenção, vamos abrindo um caminho que levará às condições do futuro, esperançosamente a uma vida que valha a pena ser vivida. Reconhecer que “o mundo é perfeito como é” e que estamos, a cada momento, preparando o terreno para o futuro pode ajudar o terapeuta a continuar a “fazer DBT” mesmo sem sinais imediatos de progresso.

COMENTÁRIOS FINAIS

Articulei os princípios do paradigma da aceitação e as práticas que decorrem desses princípios, como se existissem ao lado e em paralelo com os princípios dos outros dois paradigmas. Mas na prática, idealmente, somos influenciados pelos princípios da aceitação o tempo todo. Como terapeutas, estabelecemos e mantemos um contexto de aceitação, no qual envolvemos cada paciente em uma mudança comportamental que leva a uma vida que vale a pena ser vivida. Tentamos enraizar nossa consciência e a atenção de nossos pacientes no *momento presente*, voltando lá repetidamente, conforme necessário. Notamos as maneiras pelas quais os *apegos* dos pacientes (a certas percepções, crenças, suposições, humores, sensações, previsões e assim por diante) obscurecem seu reconhecimento da realidade “como ela é” e, então, repetidamente tentamos ajudá-los a abandonar esses apegos. Somos informados pelo reconhecimento da implacável *impermanência* da realidade, a singularidade de cada momento e a inevitabilidade da mudança. Reduzindo nossas expectativas em ver as fronteiras convencionais entre nós e nossos pacientes, entre uma pessoa e todas as outras, na verdade entre um fenômeno e todos os fenômenos, em vez disso vemos a profunda *inter-relação* de todos, a maneira pela qual todos são um, e como, nesse quesito, nós e nossos pacientes operamos como um só. Nossas convicções comuns da separação do eu e da singularidade da identidade dão lugar ao reconhecimento de que cada um de nós é feito de todos os outros, de tudo o mais. E apesar da tendência natural de impor julgamentos a nós mesmos e aos outros, cedemos ao entendimento de que, no fundo, tudo surge em resposta a causas e condições do passado e do presente, tudo é como deve ser, tudo é “*perfeito como é*”.

Influenciados por esses princípios da aceitação, intervimos com estratégias de validação e um estilo de comunicação recíproco que inclui responsividade, genuinidade, envolvimento afetivo e autorrevelação. Idealmente, criamos e mantemos uma atmosfera na qual emergem a segurança, a confiança e o apego, proporcionando experiências emocionais corretivas para todos os nossos pacientes.



O paradigma da mudança

Dentro do contexto da aceitação, o terapeuta envolve o paciente na tarefa central do tratamento: fazer as mudanças comportamentais necessárias para construir uma vida que valha a pena ser vivida. O paradigma da mudança abrange as teorias, os modelos, os princípios, os protocolos, as estratégias e as habilidades para provocar mudanças comportamentais, incorporados das teorias e das práticas cognitivo-comportamentais e adaptados ao contexto de tratamento de indivíduos com desregulação emocional crônica e grave. Linehan (2010) organizou a implementação do paradigma da mudança em um protocolo sequencial de solução de problemas, que é usado repetidas vezes nas sessões. Todo terapeuta em terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) aprende esse protocolo. Após a determinação colaborativa de uma lista de alvos prioritários de tratamento e o fortalecimento do comprometimento do paciente com o plano de tratamento, o terapeuta concentra a sessão no alvo de maior prioridade, começando com comportamentos que ameaçam a vida.

1. A sequência começa com uma *análise em cadeia do comportamento*, a técnica usada para identificar as variáveis controladoras do comportamento-alvo.
2. Depois de aplicar uma ou mais análises em cadeia do comportamento a um determinado comportamento-alvo, o terapeuta e o paciente procuram padrões relevantes entre os elos **[NT]** da cadeia. Destacando esses padrões, o terapeuta

gera hipóteses para explicar os padrões, compartilha-as com o paciente e, com ele, chega às hipóteses que fazem mais sentido. Esse processo é conhecido como *insight*.

3. Munido do *insight*, o terapeuta passa para a próxima etapa, a *análise de solução*, que envolve a geração e a consideração de uma série de soluções possíveis que resultarão nas mudanças comportamentais desejadas. Possíveis soluções são compartilhadas com o paciente, e a díade seleciona uma ou mais das soluções a serem implementadas.
4. As soluções envolvem variações e combinações de quatro categorias de *procedimentos de mudança*, cada uma das quais vem de um determinado modelo comportamental ou teoria de mudança.
 - a. Para déficits de habilidades, o terapeuta utiliza modelos e princípios do treinamento de habilidades e aplica *procedimentos de treinamento de habilidades* na sessão.
 - b. Para cognições problemáticas, o terapeuta utiliza modelos e princípios de mediação cognitiva e aplica *procedimentos de modificação cognitiva*.
 - c. Para contingências problemáticas, em que os comportamentos desadaptativos são reforçados e os comportamentos adaptativos não, o terapeuta procura a teoria e os princípios do condicionamento operante e aplica *procedimentos de manejo de contingências*.

d. Finalmente, para aquelas sequências de elos na cadeia nas quais os estímulos provocam emoções automáticas e disruptivas com base em condicionamento prévio, o terapeuta olha para a teoria e os princípios do condicionamento clássico e aplica o *controle de estímulos* e os *procedimentos de exposição*.

5. Ao longo da atenção à mudança comportamental, o terapeuta utiliza *intervenções didáticas* para educar o paciente, *estratégias de orientação* para esclarecer os respectivos papéis do paciente e do terapeuta em relação a um procedimento e *estratégias de comprometimento* para fortalecer o comprometimento do paciente com as tarefas envolvidas.

Esse protocolo é útil para organizar o tratamento orientado para a mudança de cada sessão e foi especialmente útil para mim como recém-chegado à DBT e à terapia cognitivo-comportamental (TCC), pois forneceu uma lista abrangente de tópicos para meu processo de aprendizado. Mas, no calor do momento, em sessões com pacientes difíceis de tratar, nem sempre se pode contar com a aplicação de uma abordagem sequencial passo a passo para a solução de problemas. O terapeuta pode começar movendo-se pela sequência e depois ser desviado para o manejo de comportamentos disfuncionais e perturbadores na sessão. Ou pode embarcar na solução de problemas de um determinado comportamento-alvo e, de repente, no meio da sessão, ouvir sobre outro comportamento-alvo de prioridade mais alta. Ou pode ter chegado a uma solução para implementar, mas descobrir que o paciente não está disposto a colaborar. Em outras palavras, a

apresentação clínica muitas vezes difícil e que muda rapidamente nas sessões exige flexibilidade e fluidez na aplicação das várias atividades de solução de problemas. Por consequência, o terapeuta precisa ter aprendido as estratégias para que possa implementá-las a qualquer momento. Assim como conhecer os princípios subjacentes do paradigma da aceitação ajuda o terapeuta a criar um ambiente validante e partir para a validação conforme necessário, conhecer os princípios ou processos subjacentes do paradigma da mudança permite que o terapeuta pressione por mudanças em circunstâncias que são imprevisíveis e mutáveis.

Embora seja difícil citar alguns princípios subjacentes à mudança, uma vez que a solução de problemas envolve uma gama de estratégias e decorre de várias teorias substanciais, descobri que é possível identificar sete processos centrais que me ajudaram a aplicar o repertório de estratégias de solução de problemas com flexibilidade. Os três primeiros são tarefas ou processos fundamentais orientados para a mudança que ocorrem em quase todas as sessões de DBT: 1) direcionamento de alvos e monitoramento; 2) obtenção de comprometimento; e 3) análise em cadeia do comportamento e formulação de caso. Os outros quatro são tarefas ou processos que fluem de quatro teorias subjacentes de mudança comportamental que são integradas à DBT: 4) teoria do déficit de habilidades; 5) teoria do condicionamento clássico; 6) teoria do condicionamento operante; e 7) teoria da mediação cognitiva. Essas quatro últimas trazem consigo quatro conjuntos respectivos de princípios, quatro modos diferentes de pensar, quatro estilos diferentes de interação terapêutica e quatro conjuntos diferentes de técnicas.

Cada um dos sete processos centrais de mudança na DBT dá forma ao tratamento orientado para a mudança, fornecendo um conjunto de intervenções, bem como uma preocupação generalizada ao longo dele. Por exemplo, embora possamos não

estar aplicando estratégias de *direcionamento de alvos* em determinado momento, a agenda de toda a sessão é orientada para um alvo designado, e desviar-se do alvo pode interferir em toda a organização. Ou, para dar outro exemplo, podemos não estar engajados na estratégia de *modificação cognitiva* em determinado momento, mas estamos cientes da presença latente de cognições problemáticas em toda a cadeia e estamos prontos para abordá-las, de alguma forma, a qualquer momento. Manter os sete processos em mente aumenta nossa flexibilidade para permanecermos conectados aos pacientes, orientados para os alvos e capazes de acessar estratégias de solução de problemas prontamente. Quatro dos sete (direcionamento de alvos e monitoramento, comprometimento, análise em cadeia de comportamento e formulação de caso e treinamento de habilidades) são abordados em detalhes em capítulos separados neste livro e, portanto, brevemente neste capítulo. Os outros três são discutidos com mais detalhes neste capítulo depois de analisarmos o que significa “ser comportamental” na DBT.

“SER COMPORTAMENTAL” NA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA

Antes de lidar com cada perspectiva generalizada orientada para a mudança, vamos primeiro considerar o que significa, de forma mais ampla, “ser comportamental” na DBT, paralelamente a “estar em *mindfulness*” e “ser dialético”. Descrever o que é “ser comportamental” é desafiador, assim como descrever como é andar de bicicleta, ter um sonho ou se apaixonar. Você sabe quando vê, quando sente e quando faz, mas é difícil descrevê-lo sem soar banal ou desajeitado.

Eu o encontrei inicialmente durante minha primeira experiência (de duas) como paciente em uma terapia comportamental. Tendo chegado ao tratamento comportamental vindo de um tratamento psicanalítico, foi um choque cultural, para dizer o mínimo. Era 1987. Eu fazia parte do corpo docente da Cornell Medical School, dirigindo um programa de internação de longo prazo para a organização da personalidade *borderline* com base na teoria psicanalítica das relações objetais. Minha formação até então era em psicoterapia psicanalítica. Eu mesmo fiz tratamento psicanalítico por vários anos, o que começou como parte de meu treinamento analítico. Sabendo que seria considerado para promoção a professor associado no corpo docente da faculdade de medicina em cerca de um ano, tinha noção de que precisava publicar vários outros artigos em periódicos qualificados com revisão por pares. Embora tivesse rascunhos, esboços, anotações e muitas ideias, estavam definhando em meus arquivos pessoais e em minha cabeça. Em minha psicanálise, eu vinha explorando as fantasias, os conflitos e significados associados à publicação (e não publicação) e, embora estivesse grato por aprofundar minha autocompreensão, ainda não estava publicando artigos em periódicos.

Quando expliquei a situação a um colega em uma ocasião social, ele recomendou que eu consultasse um terapeuta TCC em Manhattan que havia ajudado outros membros do corpo docente com “bloqueios de escrita”. Eu estava relutante. Não conseguia imaginar adicionar outro tratamento à minha vida, e minha opinião na época era a de que uma abordagem comportamental era uma aplicação circunscrita e superficial da psicologia para ratos. Ainda assim, respeitei a opinião daquele colega e fiquei curioso e motivado a tentar qualquer coisa para dar um pontapé inicial. Tendo sido exposto à DBT nos meses anteriores, minha curiosidade sobre o comportamentalismo foi despertada. Então marquei uma sessão.

Desde o primeiro momento da minha sessão com Steve, o choque cultural foi drástico. Acostumado com a postura atenta, mas objetiva de cada um dos dois psicanalistas que eu tinha visto, que me ouviram quando comecei a as- sociar livremente, Steve foi pé no chão, prático, direto e acolhedor. Foi desconcertante quando me pediu para tratá-lo pelo primeiro nome; me perguntei o quão competente poderia ser. Seu estilo era mais o de um mecânico de automóveis do que o de alguém que entende profundamente as pessoas. Ele se sentou à minha frente com uma prancheta e um papel em branco no colo. “Com o que posso ajudar?”, perguntou. Expliquei que queria ser promovido; que precisava publicar alguns artigos; que tinha muitas ideias, rascunhos e esboços; mas fora isso não estava fazendo nenhum progresso. “Quantos artigos você precisa publicar?” Eu arrisquei: “Acho que estaria seguro se tivesse seis artigos aceitos em periódicos decentes”. Ele queria uma meta mais específica: “Na próxima semana, descubra exatamente do que você precisa”. Ele pediu os nomes dos periódicos que eu estava considerando. Ainda sem pensar nisso, citei alguns candidatos prováveis. Ele perguntou qual era o prazo e sugeri que provavelmente deveria apresentá-los em seis meses e tê-los aceitos em um ano. Ele pediu detalhes (metas, cronogramas,

nomes de periódicos) e respondi com suposições aproximadas. Cheguei com intenções aproximadamente declaradas e percepções duramente conquistadas; ele se concentrou nos detalhes, exatamente no que eu precisava realizar. Para qualquer terapeuta cognitivo-comportamental, o que ele fazia era bastante comum; para mim, proporcionou um momento “eureka” em relação a uma terapia de solução de problemas. Ainda assim, isso me preocupou. Ele poderia ser muito específico, muito prático, muito otimista e muito ingênuo para lutar contra as forças ocultas que bloqueavam meu progresso até aquele ponto.

Afirmar que havia explorado os obstáculos implícitos em meu tratamento psicanalítico e que talvez ele os considerasse úteis ao trabalhar comigo. Sua resposta foi rápida e direta, não exatamente desdenhosa, mas definitivamente desinteressada. “É ótimo que você tenha aprendido tanto sobre si mesmo, mas por que não pedimos que você escreva os artigos? Se tivermos problemas, talvez alguns desses *insights* sejam úteis.” Outro momento “eureka”: a ação primeiro, o *insight* depois. Ainda assim, era preocupante. Eu já sabia escrever e tinha coisas para escrever. Por que precisaria de um psicólogo, mais novo em idade e experiência, para me ensinar a escrever? Honestamente, me senti um pouco idiota. Segurei minha língua, tentei acalmar meu *self* ferido e apenas segui o programa.

Ele me pediu títulos e esboços para os seis artigos. Eu tinha ideias, disse, mas ele queria títulos e esboços para que eu iniciasse o processo concreto de escrever. Minha primeira tarefa de casa foi criar seis títulos, criar um esboço de duas páginas para o primeiro artigo e levá-los para a sessão na próxima semana. Foi tão prático! Eu estava dividido dentro de mim, uma parte em dúvida e desconfiada; a outra parte aliviada e esperançosa. Ao deixar seu consultório após nosso primeiro encontro, perguntei a mim mesmo: “Se é isso de que preciso, por que preciso dele?”. Durante a semana, continuei com vontade de cancelar nossa próxima sessão

e apenas escrever os artigos. Isso não era psicoterapia como eu havia aprendido; era mais como ter um treinador de golfe ou um professor de piano. Minha psicanálise visava a aprofundar minha compreensão de mim mesmo; minha terapia comportamental visava a resolver um problema identificável. Por vários anos, comparei e contrastei as abordagens. Na verdade, um dos seis artigos que escrevi foi “Kernberg and Linehan: Two Approaches to the Borderline Patient” (Swenson, 1989).

Em uma sessão, aprendi sobre o estilo e a postura de pressionar por mudanças na psicoterapia. Steve era focado, direto e pragmático; seu estilo era prático, amigável e otimista. Não havia nenhum mistério, nenhuma sensação de explorar as profundezas. Ele perguntou minha meta, tornou-a mais específica e a assumiu como nossa meta de tratamento. Nós nos movemos tão rapidamente que senti que já havíamos embarcado em uma jornada juntos. Por mais simples que fosse a mensagem, foi uma surpresa para mim: *para mudar o comportamento, é preciso mudar o comportamento*. Eu já tinha tarefa de casa. O progresso deveria ocorrer *entre* as sessões; as sessões eram para se preparar para o trabalho da semana. Em contraste com meus outros terapeutas, Steve parecia impaciente para se mover; com o tempo demonstrou paciência e persistência.

Cheguei à segunda sessão com seis títulos e um esboço. Steve estava muito satisfeito. Senti-me um tanto embaraçado, como se fosse uma criança, mas também agradecido pelo elogio explícito. Ele leu o esboço do primeiro artigo, intitulado “Projective Identification in the Inpatient Treatment of Borderline Patients”. Embora não estivesse familiarizado com o assunto, Steve rapidamente (e corretamente) avaliou que o escopo do artigo era enorme. “O que você tem aqui é o esboço de *dois* artigos, pelo menos. O que você está tentando fazer, mudar o rumo da psiquiatria ou publicar artigos?” Me passou outra tarefa de casa: examinar 10 artigos em revistas psiquiátricas e avaliar o escopo da

contribuição de cada um. Ele desafiou meu pressuposto de que deveria escrever artigos transformadores, algo que bloqueou minha conclusão de artigos. Ele me preocupou. Por mais que reconhecesse a sabedoria prática de seu argumento, temia que, ao trabalhar com ele, produzisse artigos triviais – o que disse a ele. Ele sugeriu que eu olhasse para os 10 artigos e esclarecesse minhas metas e me lembrou de que era minha escolha o que escrever. Ele era insistente, mas ainda assim parecia que me respeitava e que eu estava no comando. Examinei 10 artigos, achei que eram modestos em suas contribuições e isso me ajudou a reduzir minhas ambições.

Tendo avançado na definição do que escreveria, passamos a como eu escreveria, qual seria a estrutura. Expliquei que escrevo melhor quando tenho cinco ou seis horas livres, nas quais posso gerar ideias, desenvolver ímpeto, pesquisar outras literaturas e escrever. Ele me desafiou novamente, com três argumentos: primeiro, não era realista esperar que eu pudesse acumular cinco ou seis horas em minha programação regular; em segundo lugar, era uma maneira pesada e “custosa” de escrever; e terceiro, não era uma boa maneira de desenvolver ímpeto no dia a dia. Ele sugeriu que eu escrevesse todos os dias, sete dias por semana, durante seis meses, usando blocos menores de tempo agendados no mesmo horário todos os dias. Além disso, sugeriu que eu escrevesse o primeiro rascunho de cada artigo “direto da minha cabeça”, sem a distração e a prática demorada de consultar outra literatura. Como ele disse: “Os artigos estão na sua cabeça – apenas escreva-os!”.

Ele me encorajou a olhar para os próximos seis meses e cancelar todos os compromissos “desnecessários” e a ser implacável ao fazê-lo. Ele queria que eu obtivesse o apoio de minha esposa e de meus colegas de trabalho, para que todos entendessem que meu tempo diário de escrita deveria ser protegido e ininterrupto. Lamentei já ter assumido o compromisso

de me apresentar em um simpósio três meses depois, pois precisaria de tempo para me preparar. Steve me pediu para cancelar. Foi contra meus reflexos. Ele desafiou meu senso de indispensabilidade: “As pessoas cancelam coisas assim o tempo todo”. Eu estava disposto, mas relutante, com medo de decepcionar. Ele me entregou o telefone: “Por que você não cuida disso agora?”. Fiz a ligação, expliquei que surgiram compromissos imprevistos que exigiam que eu cancelasse. Eles ficaram desapontados, mas pareceram entender e aceitar minha desistência. Depois de sobreviver ao sentimento de culpa, me senti liberto e isso aumentou a sensação de ímpeto.

Estabeleci o “plano Swenson”, como o chamávamos. Eu escrevia todos os dias, sete dias por semana, mesmo nas férias, durante seis meses, das 8h às 9h30. Deleguei parte do meu trabalho para outras pessoas. Consegui o apoio da minha secretária para me proteger de interrupções que não fossem emergências. Pedi o apoio de minha esposa para continuar escrevendo durante as férias que havíamos planejado. Decidi não abrir nenhuma correspondência ou *e-mail* durante aqueles 90 minutos, nem mesmo olhar as mensagens recebidas. Confessei que 90 minutos pareciam muito curtos, mas Steve sugeriu que, se eu seguisse esse plano, estaria “escrevendo o tempo todo” no fundo da minha mente, e os 90 minutos seriam suficientes para realmente escrever. Ele antecipou corretamente que às vezes eu gostaria de estender os 90 minutos, se estivesse “no ritmo”. Por motivos que a princípio não entendi, ele se opôs a qualquer prorrogação. Na verdade, me pediu para ligar para ele se eu tivesse muita vontade de continuar depois das 9h30 e pedir sua opinião antes de prosseguir.

Cerca de duas semanas depois, isso aconteceu e liguei para ele. “Steve, estou tendo muitas boas ideias e quero continuar escrevendo.” Steve retornou para mim logo depois que liguei. “Charlie, que bom que você ligou. Absolutamente *não continue* a

escrever. Qualquer coisa que valha a pena preservar ficará em sua mente e retornará amanhã, provavelmente melhor do que antes.” Aceitei sua sugestão com fé e logo o valor ficou claro para mim. A estruturação dos meus períodos de escrita era tão clara e tão confinada aos 90 minutos por manhã, que eu não sentia mais que “precisava” escrever no final do dia. Não fui atormentado pela sensação sempre presente de que deveria estar escrevendo. Experimentei uma sensação de “fluxo” enquanto escrevia e uma sensação de liberdade no final do dia. Depois que o plano Swenson foi implementado, esses seis meses foram os mais produtivos e agradáveis da minha carreira. *Escrever* não estava mais marcado em minha mente como um *fardo*. Terminei cerca de um artigo por mês, enviei seis artigos em seis meses, e, um ano após o início, cinco foram aceitos. Isso foi mais do que o suficiente para me promover.

Não só fiquei surpreso e satisfeito, como também tive minhas primeiras lições sobre os fundamentos de uma abordagem comportamentalista. Começamos determinando minha meta para o tratamento. Dividimos em objetivos específicos. Decidimos um método. Criamos a estrutura na qual o método poderia acontecer. Nos reunimos semanalmente, monitoramos o progresso, concordamos com a direção e enfrentamos dificuldades específicas. Steve era direto em seu estilo, ousado em suas expectativas e otimista em seu tom. Ele desafiou algumas suposições que interferiam na escrita, me incentivou a dar passos desafiadores que eu normalmente evitaria e rotineiramente me reforçou quando eu estava “em serviço”. Ainda assim, ele conseguiu transmitir respeito por mim e senti que éramos uma equipe em uma missão. Ao praticar a DBT, refleti mil vezes sobre essas lições.

Lembro-me da primeira vez que trouxe esse tipo de abordagem direta para um tratamento de DBT. Eu estava atendendo uma paciente que estava prestes a receber alta de uma internação de

três anos em um hospital estadual. Seus padrões comportamentais crônicos eram graves, incluindo episódios de comportamento suicida de alta letalidade e episódios caóticos de uso de álcool. Ela bebia todos os dias quando não estava internada e às vezes conseguia entrar com bebida no hospital. Depois de discutirmos suas metas, pedi a ela um comprometimento com o tratamento em termos gerais, que ela prontamente assumiu. Logo pedi que concordasse em não tirar a própria vida no próximo ano. Ela nos surpreendeu ao concordar.

Então, pedi a ela que se abstinasse de álcool ou qualquer outra substância, de uma vez por todas, no próximo ano. Como ela queria beber todos os dias, isso era quase inimaginável. Insisti em pedir-lhe, calma e definitivamente, como Steve havia feito comigo, que assumisse o compromisso. Eu disse a ela que isso prepararia o terreno para que tivéssemos sucesso em mudar sua vida. Ela estava perplexa e chateada. Recuou, argumentou e me pediu para voltar atrás em meu pedido. Embora reconhecendo a magnitude do pedido e simpatizando com seu medo, pedi que pensasse sobre isso. Terminamos a sessão sem um acordo, mas também sem uma rejeição total. Soube pelo médico dela no hospital estadual que, quando ela voltou da nossa sessão, tudo o que conseguia falar era sobre o “espantoso” pedido que eu havia feito. Isso a encheu de medo e esperança, e ela logo concordou. Seu tratamento foi longo, desafiador e, finalmente, bem-sucedido; olhando para trás, percebo que o tom foi definido durante aquele primeiro pedido.

DIRECIONAMENTO DE ALVOS E MONITORAMENTO

A DBT é, antes de mais nada, uma terapia orientada pela busca de resultados: metas subdivididas em alvos comportamentais específicos a serem alcançados sequencialmente. No início do tratamento, terapeuta e paciente ressignificam de forma colaborativa os comportamentos problemáticos apresentados como alvos comportamentais específicos, entendidos como obstáculos para o alcance das metas do paciente. Os alvos então determinam a agenda do tratamento como um todo e a agenda de cada sessão. O progresso nas metas é monitorado diariamente pelo paciente com cartões diários (formulários de automonitoramento a serem preenchidos todos os dias) e semanalmente pelo terapeuta, com a revisão desses cartões. Terapeuta e paciente monitoram a discrepância entre os resultados almejados e o funcionamento atual, sempre tentando preencher a lacuna. Nesse aspecto, o direcionamento de alvos não é apenas uma atividade que ocorre no início do tratamento ou no início de cada sessão; é uma preocupação constante. A qualquer momento, se um terapeuta DBT engajado em uma sessão fosse interrompido com a pergunta: “Qual é o alvo que está sendo trabalhado agora em sua sessão?”, espera-se que tenha uma resposta. Se perder de vista seu alvo, é mais provável que o terapeuta se desvie, influenciado por outros “motivadores”, como o alívio do sofrimento emocional momentâneo. Em suma, as práticas de definir os alvos, trabalhá-los ao longo do tratamento e monitorar o progresso em relação a eles são uma preocupação central de organização na prática da DBT. Retornaremos a esse tópico em dois capítulos futuros: o Capítulo 7, sobre o direcionamento de alvos, e o Capítulo 8, sobre dilemas dialéticos e alvos secundários.

COMPROMETIMENTO

No sentido estrito, o comprometimento na DBT é um processo para o qual utilizamos um conjunto de sete estratégias definidas. Obtemos um compromisso com os alvos de maior prioridade (p. ex. diminuir os comportamentos de autolesão), com os modos de tratamento (p. ex., participar do treinamento de habilidades em grupo) e com certos procedimentos (p. ex., usar procedimentos de exposição). Mas, conforme discutido em relação ao direcionamento de alvos e ao monitoramento, o processo de obter e manter o comprometimento com o tratamento é uma preocupação ao longo da terapia. A força do comprometimento do paciente naturalmente aumenta e diminui, mas é sempre uma variável crítica para o sucesso, e se não conseguirmos rastrear sua ascensão e queda, corremos o risco de assumir que o comprometimento está presente quando já desapareceu. Quando o tratamento desacelera ou parece parar, o que não é incomum no tratamento de indivíduos difíceis de tratar, nem sempre é devido à diminuição do comprometimento. Mas isso acontece com frequência suficiente para que nós, como terapeutas DBT, tenhamos isso em mente, perguntemos sobre isso e tratemos com estratégias de comprometimento ao longo do processo de tratamento. Consideramos o papel do comprometimento na DBT no Capítulo 10.

AVALIAÇÃO (ANÁLISE EM CADEIA DO COMPORTAMENTO) E FORMULAÇÃO DE CASO

Nos Capítulos 9, sobre formulação de caso, e 11, sobre análise em cadeia do comportamento, consideramos os princípios dessas duas práticas com muito mais detalhes, mas como eles também são condutores constantes e amplamente aplicados da prática da DBT, eu os discuto brevemente aqui. Uma vez que estamos tratando um alvo comportamental especificado, avaliamos as variáveis de controle desse alvo por meio da análise em cadeia do comportamento e, por meio dessa avaliação, chegamos a uma formulação de caso que direciona nosso planejamento e a implementação de tratamento. Sessão por sessão, à medida que implementamos o plano de tratamento, geramos e encontramos novos dados que levam a revisões, implícita e explicitamente, em nossa formulação de caso. Os processos totalmente interdependentes de análise em cadeia do comportamento e formulação de caso tornam-se tão centrais e constantes para o tratamento quanto os processos interdependentes de direcionamento de alvos e monitoramento e a consideração do comprometimento do paciente. Os terapeutas DBT não usam a análise em cadeia apenas como uma estratégia de avaliação e tratamento; pensamos em nossos pacientes em termos de cadeias do comportamento e encaramos o tratamento como uma forma de remodelar suas cadeias do comportamento de disfuncionais para funcionais. A avaliação e a formulação do caso na DBT são organizadas no modelo fornecido pela cadeia do comportamento, e a solução de problemas durante as sessões é explicitamente destinada a fazer revisões na cadeia do comportamento.

Prosseguir na terapia sem uma formulação de caso em evolução, especialmente ao tratar um indivíduo com desregulação emocional grave e crônica, seria como dirigir em território

desconhecido sem um mapa. Fazer terapia sem alvos e monitoramento especificados leva a uma “deriva” terapêutica e a uma abordagem hesitante, semelhante à de dirigir sem um mapa. Embora instintos e intuições sejam cruciais para a prática da DBT, esses tratamentos são muito difíceis e imprevisíveis para prosseguir sem um mapa ou sem revisar esse mapa em resposta aos dados emergentes.

CONDICIONAMENTO CLÁSSICO E PROCEDIMENTOS DE EXPOSIÇÃO

Inseridas dentro da “história” maior que é encontrada em uma cadeia do comportamento detalhada, há várias “histórias” menores em paralelo umas com as outras. Quatro dessas “histórias” menores são manifestações dos quatro modelos comportamentais. E cada um desses quatro modelos dá origem a um conjunto de procedimentos de mudança comportamental que são usados pelo terapeuta para resolver problemas e, portanto, também são considerados “teorias de mudança”. O terapeuta alerta e bem-informado reconhecerá a presença dessas histórias na cadeia enquanto faz a análise em cadeia do comportamento e, como resultado, verificará a presença de certas variáveis controladoras do comportamento-alvo e intervirá para modificar essas histórias. Começamos com a história que é uma manifestação do condicionamento clássico, também conhecido como *condicionamento respondente*.

É uma simplificação muito útil dizer que existem três termos ou elementos essenciais da história do condicionamento clássico. Podemos organizar nosso pensamento em torno desses três termos para fins de avaliação e intervenção. Os três termos são, respectivamente e sequencialmente, o *estímulo*, a *emoção* e a *fuga*. O *estímulo* desencadeia a *emoção*; a *emoção* é desconfortável, possivelmente insuportável; e o indivíduo foge da *emoção* para algum outro comportamento. A *fuga* costuma ser o problema apresentado, como autolesão ou uso de substâncias. Vamos considerar os três termos com mais detalhes.

O estímulo

O *estímulo* é uma sinalização particular no momento presente. É de interesse clínico o fato de que o estímulo tem uma saliência emocional especial para o paciente e tem o poder de provocar automaticamente uma resposta emocional poderosa e muitas vezes dolorosa. Por que esse estímulo no funcionamento atual, que pode ser de valência neutra ou agradável objetivamente, tem o poder de desencadear uma resposta emocional tão forte? O estímulo do funcionamento atual é pareado na memória do paciente com um incidente – ou vários – do passado com valência provavelmente aversiva. Assim, o estímulo do momento presente é pareado com o estímulo do incidente anterior, agora armazenado na memória, e, portanto, a resposta do momento presente é acompanhada pela resposta do incidente passado. O problema, se assim o vemos, é o pareamento entre o estímulo do presente, conhecido como *estímulo condicionado*, e o estímulo do momento passado, agora armazenado na memória, conhecido como *estímulo incondicionado*.^[NT]

A justificativa para os procedimentos de exposição é que o terapeuta apresenta o estímulo do momento presente ao paciente, repetidas vezes, em circunstâncias nas quais o resultado seja não aversivo. Depois de várias tentativas, o estímulo do momento presente está cada vez mais separado da resposta pareada a esse estímulo no passado, e a resposta se torna mais realista e não aversiva. Por exemplo, o indivíduo com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) que armazenou o(s) incidente(s) traumático(s) na memória encontra um estímulo do presente que está pareado de alguma forma com estímulos relacionados ao incidente traumático. O estímulo condicionado atual automaticamente desencadeia uma resposta emocional que é mais apropriada para o incidente traumático do passado. Ao usar um procedimento de exposição, o terapeuta faz o paciente encontrar voluntariamente um estímulo do presente que desencadeia a resposta à memória traumática, repetidas vezes, até que o estímulo atual perca seu

poder de trazer à tona a resposta traumática. Essencialmente, os procedimentos de exposição criam condicionamentos para *quebrar o pareamento entre* o estímulo atual do estímulo do passado.

A emoção

A *emoção* é a resposta desencadeada pelo estímulo. No caso de indivíduos com alta sensibilidade, reatividade emocional e grave desregulação emocional, esse passo na cadeia do comportamento pode ser repentino e doloroso, envolvendo pânico, terror, vergonha, raiva ou outra emoção primária, o que leva a esforços disfuncionais para lidar com isso. O fato de que a resposta emocional foi desencadeada pelo que parece ser um estímulo aparentemente não aversivo pode ser confuso para o paciente e para aqueles ao seu redor e, às vezes, até para o terapeuta, e pode resultar em respostas julgadoras e pejorativas sobre o indivíduo que está passando por esse processo emocional. A experiência repetida do paciente com o estímulo e a emoção dolorosa podem abrir caminho para a fuga de forma tão eficaz e rápida que a emoção parece quase invisível. Em outras palavras, uma vez que essa sequência é estabelecida e se mostra eficaz para evitar a dor emocional, o estímulo parece provocar um comportamento de fuga sem uma emoção entre eles. Então o terapeuta pode precisar imaginar a natureza da emoção da qual o paciente fugiu e avaliá-la.

A fuga

A *fuga* é o comportamento no qual o indivíduo busca modificar ou eliminar a emoção dolorosa. A fuga pode vir na forma de ação (p. ex., autolesão), cognição (p. ex., episódios dissociativos) e/ou emoção (p. ex., passar de uma emoção primária, como medo ou vergonha, para uma emoção secundária, como raiva). Uma vez que a natureza do estímulo pode ser objetivamente não aversiva,

talvez nem mesmo perceptível, e a resposta emocional intensa pode ser evanescente, muitas vezes escondida ainda mais pela supressão, toda a sequência pode se tornar perceptível apenas por causa da fuga. Se isso acontecer em uma sessão de terapia, por exemplo, o terapeuta pode perceber que o paciente ficou subitamente mais retraído, sofreu uma mudança de humor, ficou muito zangado ou ameaçou se autolesionar. O terapeuta que está sempre à procura da “história do condicionamento clássico” pode, então, se perguntar se está encontrando uma fuga e tentar reconstruir os eventos que levaram a ela. Ele faz uma análise em cadeia do comportamento dos eventos da sessão, buscando o estímulo e a resposta emocional. Esquemáticamente, a história do condicionamento clássico, entrelaçada na cadeia, é assim:

- *Estímulo* do momento presente (que automática e instantaneamente provoca uma sugestão na memória de um incidente traumático do passado)
- *Emoção* (fortemente influenciada pela resposta emocional ao incidente passado, conforme armazenado na memória)
- *Resposta de fuga* (muitas vezes um comportamento disfuncional que é um dos alvos do tratamento)

O terapeuta DBT está embasado por essa teoria e está sempre sondando sua manifestação, procurando os estímulos, observando e indagando sobre respostas emocionais insuportáveis, tentando reduzir ou bloquear as fugas. Toda a nossa compreensão do que estamos fazendo na DBT pode ser construída em torno do modelo de condicionamento clássico, caso em que o processo de mudança pode ser conceituado como centrado no procedimento de exposição. Pode-se dizer que estamos sempre tentando: 1) bloquear comportamentos de fuga, o que requer boa cooperação, comprometimento, orientação e habilidades de tolerância ao mal-estar; 2) aumentar a exposição às emoções insuportáveis, o que requer *mindfulness* e habilidades de regulação emocional que ajudam a reconhecer as emoções e então agir contra o impulso de escapar delas; e 3) identificar e “tratar” os estímulos, que geralmente incluem o uso de habilidades de efetividade

interpessoal e procedimentos de controle de estímulos. Como veremos, as outras teorias de mudança também levam a ideias sobre como organizar nosso pensamento sobre o tratamento como um todo, e a arte e a ciência do paradigma da mudança envolvem conhecer todas elas e integrá-las à nossa abordagem.

Agora, tendo explicado a “anatomia” de três termos da história do condicionamento clássico, podemos identificar princípios práticos para lidar com cada um dos três termos.

PRINCÍPIOS DO CONDICIONAMENTO CLÁSSICO NA DBT

Primeiro, sobre o estímulo

O terapeuta...

1. Determina o estímulo real que desencadeou a resposta emocional do paciente, da forma mais específica possível.
2. Certifica-se de que o estímulo usado no procedimento de exposição subsequente corresponda da melhor maneira à sugestão real que geralmente desencadeia a resposta intensa.
3. Mantém o estímulo presente com duração e intensidade suficientes para que a exposição emocional possa ocorrer e um novo aprendizado possa acontecer.
4. Certifica-se de que o estímulo não seja “removido” em consequência à resposta emocional intensificada do paciente (uma prática que reforça o comportamento de fuga, bem como a autoconstrução de “fragilidade” no paciente).

Segundo, sobre a emoção

O terapeuta...

1. Avalia exatamente qual emoção (ou emoções) foi desencadeada pelo estímulo, porque é crucial para o sucesso nos procedimentos de exposição que a emoção problemática seja totalmente ativada.
2. Distingue entre a *emoção primária* que foi desencadeada pelo estímulo e a *emoção secundária* que pode ser desencadeada pela reação à emoção primária e, assim, servir como uma fuga da emoção primária.
3. Garante a duração suficiente da ativação emocional para que uma nova aprendizagem possa ocorrer (normalmente conhecida como processo de *habituação*).
4. Garante que o procedimento de exposição leve, na medida do possível, a um resultado seguro que seja contrário à expectativa catastrófica do paciente (o termo para isso é uma *exposição não reforçada*).

Terceiro, sobre a fuga

O terapeuta...

1. Identifica as maneiras pelas quais o paciente foge da resposta emocional (p. ex., para ação, pensamentos ou emoções secundárias).
2. Trabalha para minimizar a confiança do paciente em *sinais de segurança* como forma de reduzir a resposta emocional.
3. Obtém a cooperação do paciente para *bloquear* a fuga; tendo certeza de que...
4. Todo o procedimento, incluindo o bloqueio da fuga e a eliminação dos sinais de segurança, baseia-se em uma colaboração respeitosa, com o acordo de que o paciente mantém um senso de controle sobre a continuidade do procedimento.

Conforme mencionado, podemos estar cientes da ativação da “história do condicionamento clássico” durante uma sessão quando notamos uma mudança comportamental sutil ou não tão sutil. Percebemos primeiro a fuga, o que pode nos levar a reconstruir os elementos anteriores da história. Certa vez, uma de minhas pacientes chorou a ponto de consumir metade de uma caixa de lenços. À medida que os lenços se acumulavam em seu colo, começaram a cair no chão. Não me ocorreu que os lenços usados estivessem servindo como um estímulo condicionado para essa paciente, provocando uma resposta de culpa e vergonha que não foi mencionada. Percebi que ela parecia desconfortável com o manuseio dos lenços, então perguntei se ela gostaria de descartá-los na minha cesta de lixo. Sua reação foi extrema, pois ela insistiu que, por ser meu consultório e minha lixeira, não queria “sujar a lixeira” com seus lenços e lágrimas. Percebendo que sua relutância em descartar os lenços na lixeira era disfuncional, muito parecida com os comportamentos submissos que faziam parte de sua lista de alvos de tratamento, perguntei sobre sua resposta. Destaquei que isso poderia estar relacionado a alguns de seus padrões submissos em seus relacionamentos e que poderia representar uma oportunidade de mudar o padrão naquele momento. Presumindo que o estímulo era algum aspecto de sua experiência de jogar lenços no chão e que a emoção era alguma versão de

vergonha ou culpa, eu a encorajei a “agir contra” sua resposta tímida, para descartar todos os lenços em minha cesta de lixo com o máximo de convicção possível. Ela seguiu minha sugestão, mas o fez timidamente, como se estivesse apenas se submetendo a mim. Pedi a ela que fizesse de novo, desta vez com um lote de novos lenços, limpos. Ela disse que não achava certo jogar fora meus lenços perfeitamente bons. Pedi-lhe que o fizesse assim mesmo e tentasse gerar uma sensação de liberdade e força ao fazê-lo. Ela mostrou um pouco mais de energia e assertividade, mas ainda estava bastante contida. Na terceira tentativa, agiu com mais força e se surpreendeu ao experimentar uma sensação de liberdade. Ela riu espontaneamente. O ponto principal aqui é que os terapeutas DBT, seguindo os princípios do condicionamento clássico (e descondicionamento, ou exposição), estão alertas para comportamentos de fuga, para a emoção que leva à fuga e para o estímulo que leva à emoção. Quando surgem espontaneamente nas sessões, como neste exemplo, o terapeuta se vê “olhando para trás” na cadeia, começando com a fuga e depois localizando o estímulo e a emoção, reconstruindo a sequência de três termos como forma de compreender e tratar a “função de escape” do comportamento-alvo.

O tratamento de exposição é reforçado por um certo tipo de postura dos terapeutas. Devemos exercitar a autoconsciência, o equilíbrio e a capacidade de autorregulação em resposta a sinais difíceis de ouvir e emoções que podem ser difíceis de suportar. Às vezes, podemos compartilhar o desejo do paciente de fugir. Devemos ser inflexíveis ao ouvir sobre os estímulos e estarmos atentos para nosso próprio desejo de fugir junto com o paciente e prestar atenção às maneiras sutis como ele faz isso. Este é o caso quando o paciente está relatando situações de vida que foram traumáticas e estamos ajudando-o a fornecer a história detalhada e expressar as emoções dolorosas associadas. Torna-se papel da equipe de consultoria nos ajudar a passar por nossa própria

exposição às sugestões evocativas apresentadas por um determinado paciente. Por exemplo, quando comecei a trabalhar com um jovem altamente suicida e intensamente irritadiço que ficou tetraplégico após um trágico acidente, beneficiei-me do apoio equilibrado de minha equipe à minha resposta traumática indireta à história do paciente. Com a ajuda da equipe, pude “passar pelo fogo” das emoções suscitadas pela história desse paciente e, então, me equilibrar e estar presente para ele. Usando todas as seis habilidades centrais de *mindfulness* na DBT para cultivar nossas próprias mentes sábias, podemos genuinamente “receber” cada paciente enquanto modelamos abertura, estabilidade e movimento para seguir adiante.

Precisando estabelecer uma relação de confiança e sentir que este é um contexto seguro para se expor a sinais dolorosos e emoções intensas, o terapeuta age de maneira objetiva, mas compassiva, com o paciente. As habilidades “GIVE” da DBT (aquelas habilidades interpessoais que ajudam a preservar e fortalecer os relacionamentos) são excelentes diretrizes. O terapeuta é *gentil*, o que permite o desenvolvimento da confiança; age demonstrando estar *interessado* pelo paciente, o que promove sensação de segurança; *valida* o paciente, o que resulta no sentimento de compreensão; e adota um *estilo tranquilo*, que ajuda a encorajar a firmeza e a persistência, apesar das ondas de emoção e dos impulsos de fuga.

Enquanto nós, terapeutas DBT, precisamos trazer equilíbrio, consciência e compaixão para seguir o tratamento baseado na exposição, também precisamos agir com clareza, propósito e disciplina em relação à tarefa em questão. Precisamos “liderar o caminho” no procedimento de exposição, conhecendo os passos técnicos a dar e os obstáculos a antecipar. Usamos a precisão para localizar os estímulos exatos e a experiência para engajar adequadamente os pacientes ao expô-los aos estímulos. Precisamos julgar quando é hora de ajudar cada paciente a

avançar para uma versão mais intensiva de exposição e quando manter o curso atual. Conforme aprendido e fortalecido em treinamento e supervisão, trazemos uma abordagem passo a passo dos procedimentos de exposição, sejam eles informais ou formais.

CONDICIONAMENTO OPERANTE E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA

A teoria do condicionamento operante, ou comportamentalismo radical, concentra nossa atenção em uma história diferente de três elementos inserida na cadeia maior. É a história do *contexto*, do *comportamento-alvo* e das *consequências*.

Contexto → Comportamento-alvo → Consequências

O contexto

O *contexto* refere-se ao contexto do estímulo, também conhecido como *condições antecedentes*, no qual ocorre o comportamento-alvo. Dentro desse contexto também estará o estímulo que discutimos em relação à teoria do condicionamento clássico, mas o modelo de condicionamento operante destaca o contexto do estímulo, e seu potencial discriminativo, em todos os seus aspectos e uma outra característica em particular. Como parte da “história do condicionamento operante”, queremos descobrir os *estímulos discriminativos*, aqueles estímulos que sinalizam ao paciente que o reforço pode estar disponível para o engajamento em determinado comportamento, neste caso, o comportamento-alvo. Por exemplo, notamos que uma das pacientes em nosso programa de internação em DBT respondia à sua frustração batendo a cabeça na parede, geralmente durante o turno da noite. Após uma avaliação mais aprofundada, ficou claro que todos esses episódios ocorreram quando determinada integrante da equipe, que trabalhava à noite, estava presente e não estava ocupada. A paciente gostava daquela funcionária e os episódios levavam a um contato mais próximo com ela. O estímulo discriminativo foi a presença, a disponibilidade e a capacidade de resposta daquela pessoa da equipe. Com esse conhecimento foi possível propor

intervenções que levassem à eliminação do comportamento de bater a cabeça.

O comportamento-alvo

O comportamento-alvo é seguido por reforço. Os comportamentos que buscamos mudar na DBT e para os quais usamos procedimentos de manejo de contingências para alterar a história do condicionamento operante são de dois tipos. De forma mais óbvia, trabalhamos os comportamentos-alvo do paciente de acordo com a hierarquia de alvos do tratamento, a qual é organizada no início do tratamento e modificada ao longo do tempo. Também tornamos alvos os comportamentos do paciente que ultrapassam os limites pessoais do terapeuta; se os terapeutas não observarem corajosamente seus próprios limites pessoais e definirem os comportamentos que violam esses limites como alvos, eles sofrerão de *burnout*. Embora a maioria dos comportamentos-alvo dos quais falei neste livro seja de comportamentos problemáticos do paciente, existem dois outros conjuntos de comportamentos relevantes. Primeiro, focamos nos comportamentos adaptativos do paciente para aumentá-los e, ao fazê-lo, contamos com a mesma história do condicionamento operante, considerando como reforçar esses comportamentos. Em segundo lugar, o foco é nos comportamentos do terapeuta que interferem no tratamento; isso é feito dentro da equipe de consultoria e os mesmos princípios são aplicáveis.

Felizmente, os princípios associados ao condicionamento operante são familiares. Todos nós os aprendemos de forma natural em nossa vida. Sabemos o que é reforçar, extinguir e punir comportamentos. Nós fazemos e recebemos isso o tempo todo. Mas o uso desses princípios no tratamento de indivíduos com intensa desregulação emocional requer mais consciência e uma compreensão mais disciplinada de como usá-los.

As consequências

As consequências de interesse para o terapeuta no modelo do condicionamento operante são aquelas 1) contingentes ao comportamento-alvo e 2) que influenciam a probabilidade futura de que o comportamento-alvo acontecerá novamente em um contexto semelhante. Para ilustrar, digamos que, enquanto tomamos café juntos, frequentemente peço dinheiro a você. Eu nunca pago de volta, mal agradeço e parece que não dou valor à sua generosidade. Você se cansa desse comportamento, fica um pouco irritado e me pede para parar. Seu pedido explícito não me impede. Um tanto perplexo, você fica curioso sobre o que está me motivando. O comportamento-alvo é meu pedido repetido de dinheiro. No contexto, os estímulos discriminativos podem incluir várias características: você é mais rico do que eu, você é uma alma generosa, você tem dinheiro com você e age de forma calorosa comigo. Obviamente, você reforçou meus pedidos anteriores, emprestando-me dinheiro, apesar de suas objeções declaradas. Se decidir mudar meu comportamento, agora você tem todas as informações de que precisa: o contexto, o comportamento e o reforçador. O processo de descobrir essas variáveis centrais para a história operante é conhecido como *análise funcional*. Determinamos a “função” do comportamento ao identificar qual problema é resolvido por esse comportamento; no exemplo, é mais provável que a função do meu comportamento de pedir dinheiro satisfaça meu desejo por café. Ou pode acontecer que a função seja obter alguma coisa, qualquer coisa, de você ou incomodá-lo. Esclarecer a função do comportamento, que requer avaliação, determina o que está reforçando o comportamento naquele contexto.

Correndo o risco de repetição para os leitores com experiência em condicionamento operante, a seguir, especificarei os tipos de consequências, ou contingências, que usamos na DBT. Depois de

listá-los e descrevê-los aqui, considero o desafio de utilizá-los no tratamento de indivíduos com desregulação emocional grave.

PRINCÍPIOS DO CONDICIONAMENTO OPERANTE NA DBT

1. **Reforço** é definido como um processo no qual as consequências contingentes do comportamento de interesse, em média, aumentam a probabilidade de que o paciente se envolva nesse comportamento novamente no futuro.
 - a. No **reforço positivo**, a consequência reforçadora é algo **adicionado** à situação (p. ex., elogio, comida, dinheiro).
 - Os reforços positivos mais imediatos provavelmente serão mais potentes do que os que ocorrem com maior passagem de tempo.
 - Uma vez que um comportamento esteja sob o controle de um reforço relativamente contínuo ou altamente frequente, a frequência do reforço pode ser reduzida a um esquema intermitente. Uma vez ocorrido esse ajuste, o reforço pode ser deslocado para um esquema intermitente, mas também imprevisível, conhecido como *reforço aleatório intermitente*. Este último costuma ser uma poderosa forma de reforço e desempenha um papel importante quando consideramos como certos comportamentos altamente disfuncionais no tratamento são reforçados a ponto de serem resistentes à extinção.
 - Se não houver interferência de outros fatores, preferimos que os reforços para os comportamentos adaptativos dos pacientes sejam naturais, ou seja, normalmente disponíveis em seus ambientes naturais, em vez de arbitrários, ou seja, artificiais e improváveis de estarem disponíveis em seus contextos naturais. Ter cuidado na seleção de reforços aumenta a chance de que os comportamentos habilidosos fortalecidos no ambiente de tratamento sejam mais facilmente reforçados pelos ambientes naturais dos pacientes.
 - b. No **reforço negativo**, o reforço é algo **removido** da situação (p. ex., dor emocional, dor física, irritação interpessoal).
2. **Modelagem**. Às vezes, não é realista esperar que, mesmo com reforço, o paciente possa se engajar em um comportamento-alvo esperado. Nesse caso, o terapeuta pode reforçar pequenos passos no caminho para se engajar no comportamento-alvo. Esse processo é conhecido como **modelagem**.
3. Existem duas categorias de abordagens para reduzir ou enfraquecer um determinado comportamento: **extinção e punição**.
4. A **extinção** é um processo no qual o reforço para um determinado comportamento é atenuado ou removido, e, como resultado, o comportamento

visado declina.

a. **Explosão comportamental.** Quando o reforço não está mais disponível ou está desaparecendo, em geral o indivíduo inicialmente responde com um exagero do comportamento que está sendo extinto. Isso é conhecido como **explosão comportamental**. Antecipar essa resposta ao usar a extinção ajuda o terapeuta a evitar o restabelecimento do reforço para o comportamento de forma escalonada.

5. A **punição** é um processo pelo qual as consequências de um comportamento direcionado, que são contingentes a esse comportamento, diminuem a probabilidade de que o paciente se envolva nesse comportamento novamente no futuro, levando, em última análise, à supressão do comportamento. Infelizmente, a punição também pode levar a uma sensação de ser julgado, envergonhado, criticado e/ou controlado, e geralmente só é eficaz na presença da pessoa que aplica a punição. Também falha em ensinar um novo comportamento para substituir o antigo. A punição, se usada, é mais eficaz quando...

- a. o terapeuta a usa com moderação, apenas quando necessário;
- b. é usada com consistência, intensidade e duração suficientes para produzir o resultado desejado, e não mais do que isso;
- c. é feita a partir de uma postura equilibrada, idealmente baseada na compaixão, não em uma posição de julgamento, raiva ou punição.

A mudança bem-sucedida de comportamentos de indivíduos com transtorno da personalidade *borderline* (TPB) com o uso de princípios do condicionamento operante, análise funcional e procedimentos de manejo de contingências pode ser difícil. Algumas das dificuldades resultam da grave desregulação emocional dos pacientes. Outras resultam do impacto duradouro de ambientes de invalidação generalizada. Outras ainda surgem porque o terapeuta é humano e seus comportamentos estão sujeitos a reforço, extinção e punição também.

Como esses pacientes costumam ser muito sensíveis e reativos emocionalmente às suas percepções agudas das emoções dos outros, o uso de contingências precisa ser tratado com cuidado e com base em tentativa e erro, para descobrir o que funciona. É óbvio que tais pacientes provavelmente terão fortes reações às

experiências desfavoráveis que ocorrem quando a extinção e a punição são usadas. Com alguns pacientes, o mínimo de desaprovação pode desencadear emoções intensas, incluindo medo, vergonha, tristeza, culpa, raiva e ódio de si mesmo. A punição deve ser usada com moderação e somente quando o comportamento *deve* mudar (p. ex., bater a cabeça perigosamente) e nada mais está funcionando. Como a extinção envolve a retirada do reforço, ela também é desfavorável. Por exemplo, o paciente em uma sessão pode se envolver em distrações para evitar responder a um tópico perturbador, ao mesmo tempo importante. Se o terapeuta permanecer em silêncio, pode estar inadvertidamente reforçando a evitação. Se, em vez disso, redirecionar a conversa para o assunto perturbador, pode estar extinguindo o comportamento de evitação. Ao fazer isso, o paciente pode ficar desregulado tanto por retornar ao tópico evocativo quanto porque seu comportamento de evitação está sendo extinto. Como regra geral, é sábio combinar o uso da extinção com intervenções calmantes e validadoras. Esses tipos de intervenção podem assumir a forma, por exemplo, de dizer: “Sei que este é um tópico perturbador e faz sentido que você queira evitá-lo, mas vamos ver se podemos encontrar uma maneira de ajudá-lo a enfrentar isto”.

Também pode ser desafiador usar reforço positivo de comportamentos adaptativos em DBT. Por uma série de razões, o paciente pode experimentar esforços padrão para o reforço (p. ex., fornecer aprovação, elogios) como desconfortáveis, até mesmo assustadores. Por exemplo, ele pode sentir que, se está sendo elogiado por seu comportamento adaptativo, agora precisa ser adaptável o tempo todo. Ou pode desconfiar da aprovação porque, em seu ambiente de infância, tal abordagem era seguida de exploração ou rejeição. A confiança é difícil de conquistar quando alguém tem um histórico tão invalidante. O caminho para encontrar as respostas terapêuticas que realmente reforçam os

comportamentos de um paciente (ou seja, que realmente resultam em maior probabilidade de fortalecer esses comportamentos) às vezes requer paciência, engenhosidade e um processo de tentativa e erro.

Reconhecer esses desafios lança luz sobre uma questão mais ampla relacionada ao reforço: a atmosfera das sessões em geral. Dado que esses pacientes foram invalidados e traumatizados e costumam ser emocionalmente sensíveis e reativos, em geral queremos estabelecer uma atmosfera básica de cordialidade, preocupação, compaixão, gentileza e validação. Queremos que nossos pacientes de DBT percebam que estão em uma situação segura para compartilhar suas vulnerabilidades. E queremos que eles percebam que o reforço positivo para comportamentos adaptativos está prontamente disponível para fortalecer abordagens hábeis. Eu discuto a validação mais tarde; por ora, basta observar que queremos que os pacientes tenham experiências nas quais o terapeuta está ouvindo, presente, compreendendo com precisão e sendo o mais verdadeiro possível. Essas experiências definem o padrão acolhedor no qual o reforço para comportamentos funcionais não está longe. Se quisermos extinguir ou punir comportamentos de qualquer tipo, é necessário apenas um ligeiro desvio dessa linha de base.

Mas essa linha de base pode se tornar não terapêutica se for criada uma atmosfera irreal de apreço e acolhimento incondicionais. O paciente pode se sentir seguro, mas com o tempo o terapeuta pode descobrir que sempre que o pressiona para uma mudança de comportamento, mesmo quando faz solicitações e intervenções bastante normativas, essas intervenções desencadeiam respostas negativas intensas. Uma linha de base que transmita cordialidade, paciência, compaixão e validação também deve transmitir uma abordagem de tratamento que promova constantemente a mudança comportamental. Encontrar esse equilíbrio às vezes não é tão fácil. Se eu for muito

acolhedor e com uma intensa postura de aprovação, por exemplo, estou tratando o paciente como frágil, fornecendo segurança e confiança temporárias que levarão à paralisia em longo prazo em um tratamento orientado para a mudança. Por outro lado, se for muito insistente e exigente em relação à mudança, minha abordagem desencadeará memórias de trauma e invalidação, provocará a autoinvalidação e criará uma relação antagônica na qual pressionar pela mudança é quase impossível.

Ao tentar encontrar o equilíbrio certo entre aceitação e mudança para que as contingências sejam eficazes na modificação de comportamentos, os terapeutas enfrentam um desafio adicional. Devido aos ambientes distorcidos em que nossos pacientes aprenderam como responder a estímulos interpessoais, podemos não receber muito reforço deles por desenvolver uma terapia eficaz. Podemos ser abertamente reforçados por sermos acolhedores e aprovadores (p. ex., “Você é o único terapeuta que realmente me ouviu”) e punidos por intervenções voltadas para a mudança (p. ex., “Como ousa me pedir para tentar essa habilidade? Obviamente você não ouviu nada do que eu disse”) e, com o tempo, ter dificuldade em encontrar o equilíbrio certo. Da mesma forma, podemos de fato encontrar respostas terapêuticas que efetivamente reforçam ou extinguem os comportamentos na direção pretendida, mas podemos não discernir a partir da resposta do paciente na sessão se as intervenções são eficazes. Assim, com base nas respostas dos pacientes às intervenções, os comportamentos dos terapeutas às vezes são modelados em uma abordagem de terapia empática que evita tópicos e comportamentos problemáticos, e, outras vezes, os terapeutas não recebem qualquer contribuição dos pacientes para confirmar o valor de seus procedimentos de manejo de contingências. Ambos os casos são exemplos de uma das funções mais importantes da reunião semanal da equipe de consultoria de DBT: os membros da equipe podem reforçar cada terapeuta para fazer uma terapia

eficaz, descobrir o que funciona, ajudar cada um a permanecer flexível e atento ao paciente e manter o ânimo contra as pressões que levam ao *burnout*.

Finalmente, notei outro desafio para os terapeutas DBT no uso habilidoso do manejo de contingências. Como terapeutas, tendemos a querer reforçar *qualquer coisa* que o paciente faça que consideremos adaptativa e a evitar reforçar *quaisquer* comportamentos que nos pareçam desadaptativos. No entanto, ao aplicar o manejo de contingências como uma solução geral para *quaisquer* comportamentos que surgem em nosso caminho, com base no fato de pensarmos que eles são adaptativos ou desadaptativos no momento, falhamos em manter nossa disciplina ao lembrar que estamos apenas visando aos comportamentos que estão na lista de alvos prioritários de tratamento, aos alvos secundários que estão mantendo os alvos primários especificados ou àqueles que estão violando nossos limites pessoais. Inúmeras vezes, ao supervisionar membros da equipe em meus programas de DBT de internação e de hospital-dia, e quando revisei minhas próprias sessões, descobri que aplicamos reforço, extinção e punição a quaisquer comportamentos que nós, pessoalmente, preferimos aumentar ou diminuir, com base em nossos próprios estilos e valores, em vez de manter o foco nos *comportamentos que o paciente precisa mudar para construir uma vida que valha a pena ser vivida*. Esse tipo de prática indiscriminada de procedimentos de manejo de contingências pode diluir a potência dos procedimentos, bem como obscurecer a consciência do que estamos almejando.

Um certo conjunto de qualidades do terapeuta e um tipo particular de postura terapêutica são ideais para a implementação de procedimentos de manejo de contingências. Primeiro, precisamos manter os alvos de cada paciente e nossos próprios limites pessoais em vista durante o tratamento. Simplesmente por nos mantermos focados em alvos e limites específicos,

naturalmente reforçaremos os comportamentos adaptativos do paciente e extinguiremos ou puniremos os desadaptativos. Em segundo lugar, devemos manter uma visão clara das “regras do jogo”: acordos da DBT, protocolos de tratamento, pressupostos sobre pacientes e terapia e regras pertencentes ao contexto em que o tratamento ocorre. Na medida em que estamos alertas e firmes em permanecer no alvo, mantendo os limites e mostrando as consequências de forma clara e rápida, precisamos das mesmas qualidades de um excelente árbitro de futebol. Esse papel requer objetividade, coragem, capacidade de resposta imediata e um senso de proporção para que o reforço seja da potência apropriada e a “punição seja adequada ao crime”. Em terceiro lugar, e mais de acordo com as qualidades ideais para um excelente *personal trainer*, estabelecemos um relacionamento positivo e caloroso com cada paciente; estamos sintonizados com o modo de funcionamento do paciente; somos claros sobre as metas, alvos, capacidades e fatores motivacionais de cada paciente; e intervimos com reforço positivo prontamente e de forma inspiradora em resposta ao progresso ou esforço comportamental.

Encontrar o equilíbrio ideal no manejo de contingências nas sessões pode ser um desafio. Precisamos ser claros sobre o que estamos e não estamos reforçando e com que grau de potência. Há tantas influências em nosso julgamento e perspectiva enquanto estamos no meio da terapia, que pode ser instrutivo 1) apresentar o que estamos fazendo em nossa equipe de consultoria se estivermos nos questionando e 2) observar a nós mesmos em sessões gravadas em vídeo para obter uma perspectiva “externa”. Até me ver em uma gravação, não fazia ideia de que minhas expressões faciais às vezes comunicavam uma mensagem diferente daquela que eu pretendia transmitir.

DÉFICITS DE HABILIDADES E TREINAMENTO DE HABILIDADES

Em um dos meus primeiros grupos como treinador de habilidades, em uma unidade de internação em DBT, eu estava introduzindo a habilidade de efetividade interpessoal de como dizer “não” de forma eficaz. Para começar, pedi a cada paciente, em um breve exercício de *role-play*, que dissesse “não” em resposta ao meu pedido de R\$ 3,00. Eu queria que cada paciente tivesse a experiência bem-sucedida de se envolver em um *role-play*, pois faríamos isso mais vezes à medida que avançássemos. Fiquei surpreso com Sylvia, uma mulher de 40 anos que havia sofrido abusos repetidos na infância e que tinha um estilo interpessoal passivo, quando ela respondeu: “Claro, você pode pegar emprestados R\$ 3,00, Dr. Swenson”.

Eu respondi: “Não, Sylvia, isso é apenas ‘faz de conta’. Vamos tentar de novo. Basta dizer ‘não’. Ei, Sylvia, pode me emprestar R\$ 3,00?”.

Sem hesitar, ela disse: “Dr. Swenson, eu não diria ‘não’ para você se precisasse de dinheiro”.

Tentei novamente. Não consegui que ela dissesse “não”. Era como se a palavra estivesse ausente de seu vocabulário, não pudesse ser produzida por seus lábios. Considerando quantas vezes ela havia sido explorada em sua vida adulta, isso fez todo sentido e pareceu ainda mais importante.

Seu comportamento me fez questionar se a habilidade estava presente em seu repertório, sendo bloqueada por algum(ns) fator(es), ou se a habilidade não estava em seu repertório. Quando perguntei quando e onde ela já havia usado a palavra “não”, ela não respondeu nada. Mas uma paciente do grupo, que a conhecia melhor do que eu, teve sucesso onde falhei.

“Sylvia, e se você tivesse uma filha pequena e ela estivesse se divertindo no parquinho, e um homem estranho chegasse até você perguntando: ‘posso levar sua filha comigo até o rio?’”

Quase antes de sua amiga terminar a frase, Sylvia respondeu, com determinação e força: “Não!”. Então, eu soube com certeza que ela tinha a habilidade em seu repertório e poderia usá-la em nome de uma criança, mas não em seu próprio nome. Isso demonstrou que ela havia adquirido a habilidade, mas a capacidade de usá-la em seu próprio nome havia sido bloqueada por outros fatores.

Começamos a trabalhar com Sylvia para usar a palavra “não” em outros contextos, com práticas em que ela estava defendendo outra pessoa em nossos *role-plays*, e depois fizemos com que ela começasse a usá-la em seu próprio nome. Foi muito difícil para ela, foi contra seus “instintos”, seus reflexos. Parecia estranho. Mas com o apoio dos colegas, ela começou a abrir novos caminhos. Então ela desenvolveu a capacidade de dizer “não”, agora em contextos em que antes era impossível. Ela havia adquirido a habilidade de dizer “não” e começamos a trabalhar para fortalecê-la. Depois de orientá-la para a necessidade disso e de descobrir sua capacidade de fazê-lo em um contexto, ela o praticou repetidas vezes no grupo, com instrução, modelação, apoio e reforços consideráveis.

Não podemos presumir, entretanto, que a aquisição e o fortalecimento de uma habilidade em um ambiente de grupo resultarão automaticamente em seu uso pela pessoa em situações da vida em que seja realmente necessária. A habilidade precisa ser generalizada em contextos relevantes. Como próximo passo, passamos a Sylvia o dever de casa de usar a habilidade em diversas situações na unidade de internação durante o dia. Ela tentou dizer não a vários pedidos: “Sylvia, você aceitaria trocar de quarto comigo?”; “Sylvia, quer dar uma volta comigo?”; e assim por diante. Seus colegas do grupo a apoiaram quando ela realizou

suas tarefas na unidade. Em seguida, queríamos que ela praticasse dizer “não” a outras pessoas que ocupavam cargos de poder e autoridade, pois sua vida foi repleta de exemplos em que foi explorada por pessoas com autoridade. Atribuímos a ela a tarefa de casa de dizer “não” quando as enfermeiras pediam que ela tomasse seus remédios (temporariamente) e quando o médico perguntava se ela poderia se encontrar com ele naquele momento. Ela deve ter dito “não” mais vezes em duas semanas do que em toda a sua vida, e começou a reconhecer um novo senso de autorrespeito ao lado de seu medo. Obviamente, a generalização final dessa habilidade precisaria acontecer quando ela deixasse o hospital.

Enquanto as “histórias” do condicionamento respondente e do condicionamento operante podem ser divididas em três termos cada, a “história” dos déficits de habilidades e de sua remediação está incorporada de forma onipresente em toda a cadeia do comportamento, contribuindo para os comportamentos- -alvo. Encontramos déficits de habilidades tanto no início como no fim da cadeia. Abordamos os déficits de habilidades para regular as emoções, tolerar o sofrimento, administrar a si mesmo em direção às próprias metas, tornar-se mais eficaz nos relacionamentos e estabelecer mais consciência e controle por meio do *mindfulness*.

Conforme argumentarei em detalhes no Capítulo 14 sobre habilidades e treinamento de habilidades, pode-se razoavelmente postular que toda a superestrutura da DBT existe para garantir o aprendizado e a aplicação de habilidades onde elas são necessárias. O treinador de habilidades pode não estar em posição de ver que o paciente que parece aprender uma habilidade está impedido de usá-la por cognições problemáticas (p. ex., “não vai funcionar de qualquer maneira”), por emoções intensas (p. ex., muito assustado ou com vergonha de tentar algo novo) ou por contingências problemáticas (p. ex., o ambiente não vai reforçar o paciente por usar a nova habilidade e, de fato, pode reforçá-lo por

usar os mesmos velhos comportamentos-problema). Portanto, o terapeuta individual, juntamente a qualquer *coach* de habilidades *in vivo*, trabalha com o paciente para levá-lo a ver a sabedoria da habilidade, experimentá-la, praticá-la repetidas vezes e descobrir e resolver os fatores que interferem no seu uso com sucesso. Se qualquer um de nós pensar em quando deliberadamente aprendemos uma nova habilidade para substituir um velho hábito e depois mantivemos o uso dessa habilidade ao longo do tempo, se torna óbvio que aprender e usar uma nova prática pode ser muito trabalhoso. No entanto, se feito, também podemos reconhecer que uma nova habilidade pode mudar uma vida.

No Capítulo 14, sobre habilidades, discuto mais detalhadamente os princípios envolvidos no treinamento de habilidades: sua aquisição, seu fortalecimento e sua generalização. Neste capítulo, abordo brevemente a necessidade de uma “prontidão” para aprender uma habilidade; uma habilidade não pode simplesmente ser ensinada e imposta a um paciente (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). O paciente deve ter a ideia: “preciso dessa habilidade”. Caso contrário, mesmo o melhor ensino do mundo será desperdiçado. Uma vez fui encaminhado para uma mulher de 20 anos com diagnóstico de TPB e anorexia nervosa. Ela estava em terapia com uma especialista qualificada no tratamento de transtornos alimentares e foi encaminhada a mim para treinamento individual de habilidades. A terapeuta, os pais e a própria jovem perceberam que ela precisava de mais habilidades para estar atenta, regular suas emoções e interagir de forma mais assertiva em sua vida interpessoal. Parecia que a magreza havia se tornado seu principal objetivo na vida e a autoinanição sua principal “habilidade”. Desde o início de nossas reuniões semanais, ela se mostrou uma boa aluna e de aprendizado rápido.

Mas depois de quatro ou cinco semanas, comecei a perceber que ela não estava realmente praticando as habilidades fora das sessões. E quando perguntei o que estava interferindo, ela foi

bastante direta sobre a falta de motivação. Disse que achou as habilidades “ótimas”, mas admitiu que tinha pouco interesse em usá-las. “Só quero que meus pais saiam do meu pé”, e queria agradar sua terapeuta. Ela queria que todos a deixassem em paz e permitissem que ela morresse de fome. Por mais magra que fosse (apenas cerca de 2,5 kg acima de um peso medicamente perigoso), ainda invejava aqueles que eram magros, perto da morte, *incluindo sobreviventes do Holocausto quando foram libertados dos campos de concentração!* Ela mostrou pouca disposição para aprender e aplicar habilidades a serviço da mudança de sua anorexia. Então, ofereci-me para trabalhar com ela em habilidades para se comunicar de forma mais eficaz com seus pais e sua terapeuta sobre seus verdadeiros objetivos, mas ela recusou. Quando concordamos em parar, ela reconheceu que, se algum dia desistisse de sua busca pela magreza definitiva, de fato precisaria de muitas das habilidades sobre as quais discutimos.

É desnecessário dizer que o primeiro princípio do treinamento de habilidades é que o paciente precisa reconhecer que *precisa* da habilidade, e verificar isso requer a atenção do terapeuta para o estágio de mudança de “pré-contemplação” (Prochaska et al., 1992). A maioria dos pacientes com quem trabalhei, ao contrário do exemplo da mulher com anorexia, está ciente da necessidade de habilidades, é motivada a aprendê-las, sente-se gratificada quando as usa e, em última análise, valoriza essa parte da DBT. Mas mesmo com o paciente disposto, o instrutor de habilidades eficaz está ciente da necessidade de “vender” cada nova habilidade, ajudando os pacientes a encontrarem sua necessidade específica.

O excelente treinador de habilidades combina qualidades que exemplificam professores de piano eficazes e mães amorosas. A professora de piano sabe como tocar o que está ensinando, sabe como dividir a habilidade de tocar piano em passos ensináveis,

sabe o quão difícil é impulsionar cada aluno e como fornecer reforço individualizado e demonstra alegria pelo processo de aprendizagem. A mãe dedicada e amorosa conhece seu filho e sabe inequivocamente que, para ter uma vida melhor, ele simplesmente deve aprender a fazer certas tarefas.

MEDIAÇÃO COGNITIVA E MODIFICAÇÃO COGNITIVA

Nossa teoria final da mudança, a mediação cognitiva, chama a atenção para mais uma linha da história inserida na cadeia do comportamento que envolve um comportamento-alvo. É a história em que acompanhamos o impacto do processo e do conteúdo do pensamento sobre as ações e emoções subsequentes na cadeia.

Evento desencadeante → Crenças, pressupostos → Ações e emoções

Em essência, a ideia é que nossas ações e emoções são mediadas por nosso estilo e conteúdo cognitivo. Se eu continuar dizendo a mim mesmo “A vida é terrível” e começar a acreditar nisso, acabarei me levando a maior sofrimento e desesperança. Se continuar pensando que a vida é perigosa do lado de fora da minha porta, ficarei cada vez mais ansioso quando precisar sair do meu quarto e provavelmente evitarei fazê-lo. A terapia cognitiva baseia-se nesse modelo e envolve descobrir as crenças negativas profundamente enraizadas e as autoafirmações relacionadas no momento (*pensamentos automáticos*), trazendo-as à luz do dia, submetendo-as a testes e desafios, e experimentando alternativas, formas menos terríveis de pensar.

O mesmo modelo é crucial para a DBT porque indivíduos com importante desregulação emocional, tendo aprendido a pensar em contextos bastante invalidantes, provavelmente serão inundados por cognições negativas, duras, culpabilizantes e autodepreciativas e terão alguns mal-entendidos nas regras de causa e efeito da forma como existem fora de seus contextos de vida estreitos e invalidantes. Considere as seguintes cognições, que não são incomuns para pessoas com TPB:

“Tenho que estar certo; caso contrário, sou uma pessoa má.”

“Quanto mais estranhamente me comportar, mais interessante as pessoas vão me achar.”

“Se ficar sozinho por mais de uma hora, vou me dissolver.”

“Sou totalmente incompetente em tudo o que faço.”

“Sou gordo, feio e estúpido, e todo mundo sabe disso.”

As crenças podem ser tão extremas que podemos ser tentados a pensar que o tratamento para tais indivíduos deve centrar-se na terapia cognitiva.

Ao considerar a relação entre a mediação cognitiva e as outras teorias de mudança na DBT, é importante perceber que as cognições problemáticas são parte integrante de cada uma delas. A pessoa com TEPT que vive com medo de que na próxima esquina haja uma pessoa perigosa é movida pelos elementos da teoria do condicionamento clássico discutidos anteriormente: a história do estímulo, da emoção (respondente) e da fuga. Em torno dessa história de três elementos estão várias cognições compatíveis com essa situação: “As pessoas são perigosas”; “Sou incapaz de discernir se uma situação é segura”; “Se me arriscar de novo, provavelmente serei morto”; “O único lugar seguro para mim é a morte”. O progresso em longo prazo para o indivíduo com TEPT incluirá a modificação da cognição distorcida. A pesquisa mostrou que é possível obter resultados eficazes por meio de terapia cognitiva ou procedimentos de exposição (Ougrin, 2011).

Da mesma forma, para o indivíduo que não tem capacidade de dizer “não”, como era o caso de Sylvia, sempre haverá algum tipo de cognição concomitante, como “Se disser ‘não’, vou me machucar”; “Se disser ‘não’, serei uma pessoa ruim”; ou “As pessoas têm o direito de fazer o que quiserem comigo”. Em outras palavras, é completamente comum descobrir que, quando há um déficit de habilidades prejudiciais, há cognições problemáticas que o acompanham. E quanto a considerar as cognições problemáticas

ao lado da teoria operante da mudança comportamental, o processo pelo qual um comportamento desadaptativo pode ser repetidamente reforçado e, portanto, mantido no repertório de uma pessoa, quase sempre encontramos cognições problemáticas que acompanham os comportamentos problemáticos reforçados. Se o indivíduo que se autolesiona é reforçado pela redução imediata de um turbilhão de intensas emoções negativas, surgem crenças de que essa é a única forma de viver e que abster-se da autolesão seria decidir morrer.

Para reiterar de forma mais concisa: 1) entre as causas de transtornos que envolvem desregulação emocional grave, a transação entre reatividade emocional e sensibilidade, por um lado, e o ambiente invalidante, por outro lado, é central; 2) respostas emocionais condicionadas, déficits de habilidades e contingências problemáticas conspiram para uma vida de evitação, fuga, padrões de comportamento desadaptativos e sofrimento constante; e 3) surgem cognições que são compatíveis e acompanham os componentes situacionais, emocionais e de ação do problema. Como resultado, as cognições podem não ser primárias na causa dos problemas (embora possa ocasionalmente ser o caso de alguns padrões comportamentais para alguns indivíduos) que levam um indivíduo à DBT, mas elas se tornaram uma parte do problema, e resolvê-las é parte da solução.

Seguindo essa forma de pensar sobre o papel da mediação cognitiva na geração de problemas que os pacientes apresentam na DBT, Linehan (2010) recomenda que os terapeutas permaneçam alertas ao surgimento de cognições problemáticas, nunca deixando-as passar sem alguma intervenção, ainda que mínima. Por exemplo, se um paciente dissesse: “Eu simplesmente não sou uma pessoa competente”, o terapeuta poderia responder: “Sim, eu sei, você pensa que não é muito competente”. O paciente, reconhecendo o desafio, pode então continuar: “Mas quero dizer que *realmente não sou* muito competente”. O terapeuta pode

simplesmente parar nesse ponto, tendo sublinhado o pensamento problemático; ou o julgamento clínico pode levar a algo como: “Sim, eu sei que você tem muita convicção de que esse pensamento é verdadeiro”, e assim por diante. Em outras ocasiões, o terapeuta pode apenas responder à declaração negativa de um paciente “Não há solução para isso” com um breve comentário como “Sim, sei que você não acredita que haja uma solução”. Se o pensamento estiver se mostrando persistente e prejudicial, o terapeuta pode comentar: “Esse pensamento continua voltando e está abrindo o caminho para o inferno para você”.

Certa vez, trabalhei com uma jovem inteligente e muito bonita, mas em seu ambiente familiar e escolar passou a ter a firme crença de que era “feia e estúpida”. Demorou um pouco para eu perceber como esses pensamentos eram constantes, como eles espreitavam no fundo de cada consideração sobre se ela poderia melhorar sua vida. Eles me pareceram ter adquirido um *status* independente, um impacto prejudicial, e comecei a atacá-los. Para obter sua concordância em alvejá-los, ela teve que pelo menos considerar que eram seus *pensamentos*, e não necessariamente *fatos*. Tive que reunir algumas evidências para levá-la a esse ponto, como comentários de outras pessoas e opiniões minhas. Levamos o processo de reestruturação cognitiva mais longe do que geralmente é feito no estágio 1 da DBT. Eu a fiz rastrear a presença e a ocorrência desses pensamentos em um registro diário, tentei várias maneiras de desafiá-los e ajudei-a a encontrar maneiras de enfrentá-los. Depois de semanas desse tipo de foco “excessivo” nesses pensamentos, eles se tornaram quase uma piada, pois ela começou a usá-los conscientemente, de forma exagerada, como formas de desculpas.

“Me desculpe, estava atrasada para a sessão hoje. Afinal, sou feia e estúpida.” Eu soube então que havíamos virado a esquina.

Ela havia começado a reconhecer pensamentos como pensamentos.

Esse tratamento, conhecido como reestruturação cognitiva, envolve reconhecer e desafiar o conteúdo do pensamento disfuncional, encontrar declarações alternativas aceitáveis e persuadir o paciente da perspectiva de que os pensamentos são pensamentos, não fatos. Em geral é feito em sessões de DBT com imediatismo, com comentários rápidos do tipo “pincelada”. Ocasionalmente, como no meu exemplo, o terapeuta se concentra em fazer um trabalho mais “reconstrutivo” em cognições específicas.

Junto à reestruturação cognitiva, o outro impulso da modificação cognitiva é conhecido como *clarificação de contingência*. Em essência, este é o caminho para garantir que o paciente entenda as regras da vida, sobretudo aquelas não escritas entre seres humanos, e as regras da terapia. Devido à natureza distorcida dos ambientes de onde vêm muitos de nossos pacientes e ao impacto distorcido da grave desregulação emocional, eles iniciam o tratamento sem compreender as “regras do jogo”, tanto no que se refere à vida quanto à terapia. Não é incomum descobrir que o paciente acredita que ficar doente é a única maneira de manter o apoio e sobreviver; que não há como melhorar e ainda ter apoio. Da mesma forma, é comum pensar que falar e ser assertivo vai estragar tudo. Por outro lado, alguns pacientes acreditam que devem dizer tudo, não esconder nada, que é a única maneira de ser “verdadeiro” e “real”. Estas e outras “contingências” que merecem esclarecimentos são declarações do tipo “se... então”. Os produtos distorcidos desse tipo de aprendizado falho muitas vezes são tão consolidados para o paciente e tão surpreendentes para o terapeuta que passam despercebidos por algum tempo.

Os terapeutas DBT precisam estar atentos a pensamentos errôneos. Não faz muito tempo, eu estava no segundo ano de terapia com um paciente de 35 anos. Frequentemente, com humor,

ele fazia comentários sobre algumas de minhas intervenções que achava surpreendentes e úteis. Na verdade, ele começou a brincar que, se passássemos por uma sessão sem uma dessas “joias Swenson”, ele não saberia o que fazer. Da mesma forma, se considerava sempre certo quando discordava das pessoas, exceto de mim. A maneira como ele comentou sobre esses dois padrões de pensamento fez com que soassem bastante leves, como se ele tivesse uma perspectiva equilibrada sobre eles, mesmo com um toque de humor. Depois que percebi a frequência com que essas crenças apareciam, comecei a pressioná-lo mais sobre elas. No fim das contas, não eram nada leves: eram alicerces, quase regras, para seu funcionamento. Quando desafiei essas crenças, ele ficou primeiro com raiva, depois profundamente triste. Se eu não fosse ótimo e se ele não estivesse certo, então eu era “um merda” e ele um fracasso total. Essas crenças viveram na sala conosco durante a terapia; eram “regras de vida” defeituosas que o resgataram de sentimentos dolorosos de fracasso e humilhação, e uma vez que as vimos pelo que eram (e “clarificamos as contingências”), o teor da terapia mudou em uma direção que parecia mais real, envolveu mais emoções e tornou-se mais produtivo.

A presença de cognições problemáticas no contexto da desregulação emocional deve ser assumida, mesmo que ainda não esclarecida. Evidências podem parecer insignificantes no momento, mas estão por toda parte. A postura do terapeuta inclui uma prontidão para detectar cognições problemáticas, que podem se mostrar mais penetrantes e influentes do que parecem. Nesse sentido, a atenção do terapeuta às cognições, buscando as danosas para o tratamento, assemelha-se ao trabalho do exterminador a quem se pede que detecte e elimine infestações de insetos a partir de rastros pouco visíveis.

Tendo detectado a presença de cognições problemáticas, o terapeuta precisa de habilidade para identificá-las, nomeá-las e,

em alguns casos, desafiá-las de maneira rápida, diplomática e sensível. Essa intervenção se assemelha à habilidade de um artista, um pintor, que pode aplicar pinceladas rápidas durante o processo de pintura, apenas o suficiente para destacar ou revisar um determinado ponto da tela, sem exagerar. Para o terapeuta DBT, a sensibilidade pode envolver primeiro destacar um aspecto válido de um conteúdo ou processo de pensamento problemático e, em seguida, passar para o problema. Por exemplo, ao abordar o indivíduo desconfiado devido ao ambiente traumatizante: “Não é de admirar que você esteja convencido que qualquer um que fale com você está tentando explorá-lo. Deve ser difícil descobrir quando a outra pessoa realmente está falando sério”. Encontrar a sabedoria no pensamento abre caminho para uma intervenção que destaca o componente inválido do pensamento. Em última análise, o terapeuta DBT precisa intervir dialeticamente, destacando os componentes válidos e inválidos do pensamento, ajudando assim o paciente a chegar a uma avaliação de “mente sábia”.

APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE MUDANÇA EM UM CASO

A solução eficaz de problemas envolve a integração de todos os sete processos de solução de problemas abrangentes em sessões. Na seguinte vinheta de parte de uma sessão de terapia DBT, ilustro esse processo de integração. A paciente é uma jovem em um programa de DBT, está no primeiro estágio do tratamento e se comprometeu a eliminar completamente seus frequentes comportamentos de autolesão (*direcionamento de alvos*). Um fator marcante de sua história de infância é que seus pais biológicos eram incapazes de cuidar dela, e ela foi tirada deles e colocada com uma família adotiva após a outra. Tem uma sensibilidade elevada para “ser deixada para trás”, um padrão que surgiu por meio de *análises em cadeia de comportamentos* no início do tratamento e que faz parte da *formulação de caso*. Embora seu relacionamento com a colega de quarto seja estável e duradouro, ela nunca para de pensar que a colega está prestes a deixá-la (*mediação cognitiva*). Em uma sessão específica após um incidente de autolesão, o terapeuta e a paciente elaboraram a seguinte cadeia do comportamento:

Após uma longa discussão entre a paciente e sua colega de quarto,

- a colega de quarto saiu furiosa de seu apartamento.
- Instantaneamente, a paciente experimentou intenso medo, “pânico” e um profundo sentimento de vergonha.
- Quase ao mesmo tempo, pensou: “Nunca mais a verei”, “Destruí outro relacionamento” e “O que há de errado comigo?”.
- No contexto dessas emoções e pensamentos, ela teve uma forte vontade de se cortar.
- Tentou pensar em algo para fazer para tolerar o sofrimento, mas não conseguia pensar em nada, e a intensidade das emoções, pensamentos e impulsos aumentaram.
- Pegou uma faca na cozinha e fez um corte de 2,5 cm em seu pulso, apenas o suficiente para tirar sangue.

- Experimentou uma redução imediata em seu pânico e sentiu-se mais no controle de suas emoções e pensamentos.
- Mandou uma mensagem para a colega de quarto dizendo que havia se cortado, e a colega voltou para o apartamento.
- A paciente ficou ainda mais aliviada.

Nesta sessão, a paciente e o terapeuta *focam* em um comportamento-alvo de alta prioridade, autolesão, e *monitoram* o progresso em um diário. Eles estão engajados na *análise em cadeia dos comportamentos*, que está alimentando uma *formulação de caso* em evolução que afeta as próximas intervenções. Essa paciente demonstra *comprometimento* com o tratamento do alvo, trazendo as informações necessárias e colaborando com o terapeuta para gerar compreensão e mudança. Podemos presumir que se o terapeuta estivesse procedendo sem um alvo definido, ou guiando as intervenções com base na intuição em vez de em uma formulação de caso em evolução por meio de análises em cadeia de comportamentos, e/ou se o comprometimento da paciente com a meta e o processo fosse insuficiente, o tratamento dificilmente teria chance de sucesso. Como esses processos de solução de problemas estão em vigor, o cenário está montado para considerar a cadeia da perspectiva de cada um dos quatro modelos comportamentais discutidos. Mesmo nesta breve vinheta, podemos vislumbrar o papel de todos os quatro na criação de intervenções orientadas para a mudança.

O modelo do *condicionamento clássico* direciona nossa atenção para o papel de um dado *estímulo* (algo sobre a partida raivosa da colega de quarto que desencadeia as emoções intensas da paciente), a *emoção* (a mistura de medo, pânico e vergonha desencadeada pela deixa) e a *fuga* (a redução da intensa dor emocional provocada pela autolesão). Um terapeuta alerta avaliará a natureza específica do estímulo à medida que episódios futuros ocorram. Em algum momento durante o tratamento, se o estímulo específico puder ser identificado, o terapeuta pode envolver o

paciente na exposição (ao estímulo), levando à experiência e à expressão da emoção e ao bloqueio da resposta de fuga (autolesão).

Encontramos os elementos do modelo de condicionamento operante na mesma breve vinheta. O terapeuta pode prestar atenção ao contexto do estímulo no qual ocorreu a autolesão, procurando os estímulos discriminativos que lhe sinalizaram que o reforço ocorreria se ela se cortasse. Tendo caracterizado claramente o comportamento de autolesão, o terapeuta desejaria determinar as consequências contingentes que reforçaram o comportamento, como o alívio de emoções dolorosas e o reconfortante retorno da colega de quarto. Explicar esses detalhes colocará o terapeuta em posição de modificar a natureza dos estímulos que sinalizam a presença de reforço e de considerar mudanças nas consequências do comportamento de autolesão. Como resultado, na próxima vez que a paciente enfrentar contexto e escolha semelhantes (se autolesionar ou não), as consequências podem ser alinhadas de uma forma que reforce não o comportamento de autolesão, mas uma alternativa adaptativa. Pode haver várias maneiras de fazer isso – o terapeuta pode: 1) ensinar, fortalecer e obter da paciente o compromisso de usar comportamentos alternativos habilidosos; 2) garantir que essas alternativas mais adaptativas sejam seguidas por consequências reforçadoras; 3) estabelecer um protocolo pelo qual a autolesão não resulte no retorno da colega de quarto; e/ou 4) direcionar a paciente a preencher uma planilha de análise em cadeia do comportamento referente ao episódio de autolesão, que é então apresentada na próxima sessão de terapia.

A teoria dos *déficits de habilidades* vai (é claro) direcionar a atenção do terapeuta para os déficits de habilidades para que a paciente possa: 1) interagir com a colega de quarto (habilidades de efetividade interpessoal); 2) administrar sua própria sensibilidade e reatividade ao estímulo para que suas emoções não se tornem

intensas e dolorosas tão rapidamente (habilidades de regulação emocional e habilidades de *mindfulness*); 3) regular as emoções intensas de maneira adaptativa, uma vez que elas estejam presentes (habilidades de regulação emocional e habilidades de tolerância ao mal-estar); 4) encontrar maneiras de aumentar sua tolerância às emoções intensas, a fim de evitar a necessidade de usar a autolesão (habilidades de tolerância ao mal-estar); e/ou 5) usar habilidades de *mindfulness* ao longo do processo para trabalhar em direção à consciência, ao equilíbrio e ao controle da atenção e da mente sábia.

A teoria da *mediação cognitiva* chamará a atenção do terapeuta para todas aquelas crenças e pensamentos automáticos que estão desencadeando ou atijando as chamadas de intensa reatividade emocional e perda impulsiva de controle. Se as cognições precederam as emoções e ações intensas ou foram desencadeadas por elas, desempenham um papel na manutenção do padrão comportamental desadaptativo e merecem ser abordadas por meio de clarificação de contingência e reestruturação cognitiva.

Pela lente de cada um dos quatro processos, representando os quatro modelos comportamentais, o terapeuta pode ver como a autolesão é mantida no repertório de comportamentos dessa paciente e pode ver possíveis maneiras de reduzir esse comportamento no futuro. É muito provável que todos os quatro processos estejam funcionando, o que pode dificultar a identificação das variáveis de controle mais importantes. A avaliação comportamental, por meio de análises em cadeia de comportamentos, pode ser utilizada para descobrir isso.

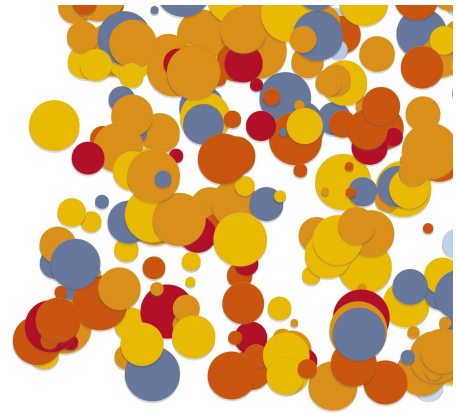
Tendo destacado o valor de extrair as influências de cada um desses quatro processos, é igualmente útil perceber que, na verdade, não existem realmente quatro processos diferentes acontecendo; há uma sequência, uma onda unificada que flui em direção à autolesão e além. As várias forças estão

inextricavelmente entrelaçadas e interdependentes para causar o corte. E ao encontrar a(s) solução(ões) para isso, cada um dos quatro procedimentos de mudança realmente traz mudanças em todas as quatro linhas da história. Por exemplo, se o terapeuta conseguir realinhar as contingências de modo que a autolesão diminua e algum comportamento alternativo seja fortalecido, a paciente: 1) precisará contar com um conjunto de habilidades diferente, que será então fortalecido; 2) mudará a natureza das crenças e cognições de uma forma que se alinhe com os novos comportamentos e contingências; e 3) a sequência comportamental mais adaptativa pode trazer maior sensação de segurança e controle, o que dá à paciente maior capacidade de suportar a exposição aos sinais sem ter que fugir. É importante lembrar que, se o terapeuta está se engajando em um procedimento de mudança, aplicando uma teoria, na verdade ele está abordando os enredos de todas as quatro histórias. Essa percepção pode aumentar a flexibilidade e a liberdade do terapeuta para considerar a utilização de qualquer um dos princípios de solução para mudar qualquer problema. Avaliar com sucesso as variáveis de controle e intervir é, na verdade, um processo de tentativa e erro entre terapeuta, paciente e equipe de consultoria.



[elo] N. de R.T.: O termo “elo” é equivalente ao termo “*link*”. Essa definição é relevante porque em muitas outras obras sobre DBT traduzidas para o português utiliza-se “*link*”. Cabe salientar que nenhum dos dois está equivocado, podendo ser utilizadas ambas as denominações.

[estímulo incondicionado] N. de R.T.: É importante que os leitores aprofundem os conceitos apresentados em livros como Borges et al. (2012), Catatania (1999) e Moreira e Medeiros (2019).



O paradigma dialético

Fui criado no estado de Oregon, onde a indústria madeireira era enorme. Os lenhadores eram aclamados, e as serrarias e fábricas de papel ficavam “*on-line*” 24 horas por dia. Era uma indústria difícil e perigosa. Os madeireiros derrubavam as árvores rio acima e traziam as toras para a serraria. No início da primavera, os rios ficavam entupidos com toras cortadas durante o outono e o inverno. Os bloqueios no fluxo das toras eram comuns, caros, difíceis de evitar e difíceis de desfazer. O trabalho mais perigoso na indústria madeireira era feito pelo condutor de toras. Sua tarefa era manter as toras fluindo, antecipando e evitando congestionamentos ao dispersá-los no início de sua formação. O responsável por essa logística, que naquela época era sempre um homem, corria por cima das toras enquanto elas flutuavam ou atolavam no rio, arriscando continuamente a vida, pois sempre podia escorregar entre duas toras na água. Agilidade, consciência e velocidade eram fundamentais. Uma de minhas primas se casou com um homem que fazia esse trabalho aos 20 anos. Como todos os responsáveis pela logística do fluxo de toras daquela época, ele usava um mastro especialmente projetado, conhecido como *peavey*. Era um longo poste de madeira com uma ponta de metal estrategicamente posicionada perto da ponta que podia empurrar ou puxar toras.

Seria difícil encontrar uma metáfora melhor para a prática da dialética na terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*). Mesmo com a aplicação habilidosa de

estratégias oriundas dos paradigmas da aceitação e da mudança, “bloqueios” são típicos na terapia com indivíduos com desregulação emocional. Trabalhar com pessoas para quem a transação entre uma vulnerabilidade emocional de base biológica e um ambiente de invalidação generalizada se reflete em emoções intensas, alta sensibilidade, alta reatividade, pensamento rígido e dicotômico e uma tendência a extremos em ações e relacionamentos, leva a bloqueios em todos os aspectos de sua vida: em casa, no trabalho, com amigos e na terapia. O terapeuta dotado da agilidade e da rapidez de um condutor de toras, capaz de compreender e utilizar as forças dos opostos em colisão de forma a promover o fluxo, está em condições de:

- criar movimento a partir do impasse;
- transformar posições rígidas e extremas em posições mais flexíveis e realistas;
- destacar os opostos conforme eles surgem e encontrar a sabedoria de cada lado;
- facilitar o surgimento de síntese a partir dos opostos;
- manter um relacionamento colaborativo com o paciente diante de conflitos, padrões rígidos de comportamento e impasses.

As estratégias da DBT para lidar com impasses são as dialéticas. Elas fluem dos três princípios do paradigma dialético, que são derivados de uma visão de mundo dialética e de uma postura dialética de exercer influência. Particularmente adequada para situações de “travamento” durante o tratamento, o uso da dialética pelos terapeutas também faz parte da postura básica ao fazer DBT. Neste capítulo, detalho os três princípios dialéticos: opostos e síntese, pensamento sistêmico e fluxo; discuto a postura dialética que faz parte da prática de DBT; e ilustro como as nove estratégias dialéticas da DBT fluem dos princípios.

PRINCÍPIOS DO PARADIGMA DIALÉTICO

Opostos e síntese

No cerne da dialética está a compreensão de que a realidade consiste em opostos e que a tensão entre eles é resolvida por meio de um processo de síntese. Em sua forma mais simples, a dialética começa com uma *tese*, que é uma proposição de algum tipo. Por exemplo: “O céu é azul”, “Esta é uma família perfeita” ou “Este paciente está fazendo o melhor que pode”. A tese traz seu oposto, chamado de *antítese*. Por exemplo: “Não, o céu na verdade não tem cor nenhuma”, “Esta família está longe de ser perfeita” ou “Este paciente tem que se esforçar mais e melhorar”. Nesse ponto do processo, temos a presença da contradição, com uma tese e uma *antítese*.

Um possível próximo passo pode ser descobrir qual é o mais certo, a tese ou a *antítese*. No entanto, fazer isso não seria dialético. Outro pode ser afirmar que a tese e a *antítese* podem coexistir, lado a lado, sem qualquer necessidade de declarar uma vencedora. Isso também não seria dialético. A abordagem dialética consiste em identificar o núcleo válido da tese e o núcleo válido da *antítese* e então encontrar uma *síntese* que inclua o núcleo válido de cada uma, agora em uma nova proposição. Por exemplo: “O próprio céu não tem cor, mas parece azul para os humanos na Terra por várias razões”; “Esta família tem a aparência de perfeição, mas, examinando mais de perto, é imperfeita, como todas as famílias”; ou “Este paciente está fazendo o melhor que pode e precisa se esforçar mais e melhorar se quiser mudar sua vida”. A nova proposição, seja ela qual for, torna-se agora a nova tese, que produzirá uma *antítese*, e assim por diante. Na dialética, nada fica parado; a verdade evolui à medida que forças opostas chegam a novas sínteses. Este conceito central é tecido em toda a teoria e o tratamento da DBT.

A dialética surge rotineiramente na equipe de consultoria, como abordo no Capítulo 15. Por exemplo, um membro da equipe discorda fortemente de outro em como interpretar o comportamento de um paciente. Ou o líder da equipe desperta oposição nos membros por ser muito rígido ou muito indulgente na aplicação da DBT. Em outro exemplo, a equipe pode estar dividida, com alguns membros querendo passar mais tempo em exercícios de treinamento, enquanto outros querem preservar todo o tempo possível para consultoria. A dialética surge em configurações de treinamento de habilidades em grupo. Por exemplo, os pacientes em um grupo podem querer passar mais tempo compartilhando informações detalhadas sobre si mesmos, enquanto o terapeuta deseja manter o grupo focado em aprender mais habilidades. Ou um membro do grupo de habilidades só quer “ficar sentado” e aprender sem ter que fazer tarefas práticas, enquanto o terapeuta insiste que todos no grupo pratiquem. E a dialética também surge rotineiramente na terapia individual.

Na minha unidade de internação de DBT, um dos psicólogos era Ed Shearin, o qual havia treinado com Marsha Linehan durante os primeiros anos da DBT. Ed tinha um estilo reservado e muito respeitoso, uma abordagem gentil e uma mente brincalhona e inteligente. Ele estava trabalhando com uma paciente de 19 anos em determinado momento, a qual queria deixar o hospital imediatamente. Ela o encontrou no corredor. “Ed, eu quero ir embora. Hoje! Eu quero sair daqui. Não sou mais suicida; este lugar está me arruinando e quero ir embora hoje. Você poderia providenciar isso?” Ela estava perguntando no mesmo dia em que havia se machucado gravemente com uma lâmpada, e de forma alguma Ed concordaria em liberá-la.

“Mas esta manhã você se machucou”, Ed salientou. “Eu também quero que você saia, e estou feliz que queira sair. Vamos trabalhar nisso e fazer acontecer o mais rápido possível, com segurança, mas não pode ser hoje”.

“*Tem* que ser hoje e nada vai me impedir.”

“Admiro seu espírito, mas não pode ser hoje.”

“Eu sei que tenho o direito de ver um juiz. Vou levar vocês ao tribunal.”

Esta seria uma típica dialética, ou polarização, no tratamento hospitalar. Reconhecê-la, esperar, manter-se fundamentado e trabalhar com ela é desafiador, mas incrivelmente útil. A clareza das posições opostas, aliada ao fato de Ed se sentir confortável com isso, possibilitou que ele encontrasse uma síntese criativa.

Ed disse à paciente: “Sim, você tem o direito de nos levar ao tribunal. Você só precisa enviar o que chamamos de ‘aviso de 72 horas’. Você pode obter um no posto de enfermagem. Se preenchê-lo, haverá uma audiência no tribunal dentro de 72 horas e você será internada ou liberada. O juiz decidirá”.

“É isso que vou fazer”, afirmou a paciente.

Ed respondeu: “OK. Acho que, assim que você preencher, deveríamos ter uma sessão”.

“Por quê? Vou embora logo após a audiência.”

“Vou ajudá-la a se preparar para a audiência”, disse Ed. “Podemos trabalhar nas habilidades que você precisará para tornar seu caso o mais forte possível. Podemos até representar.”

“Eu não entendo”, ela rebateu. “Você quer me ajudar a me preparar para vencer vocês no tribunal?”

“Isso mesmo! Quero que você seja o mais habilidosa possível. É disso que se trata este tratamento. E eu sei que você vai precisar de todas as habilidades que puder. Não é fácil apresentar o seu caso contra o hospital. E serei eu quem testemunhará contra você, e sou muito bom nisso. Vamos começar. Quer você ganhe ou perca seu caso agora, quero que sinta que fez o seu melhor.”

A verdade evolui. Quando os opostos se enfrentam, o pensador dialético não procura vencedores e perdedores, mas a síntese, posições ganha-ganha. A paciente de Ed queria sair do hospital. Essa proposição provavelmente foi a síntese de uma oposição

anterior dentro dela, ou entre ela e a equipe do hospital. E, ao propor a saída, ela provocou o resultado oposto, ou seja, não foi liberada imediatamente. Ed representou a oposição, mas como seu terapeuta, ele queria permanecer dialético e encontrar sabedoria em ambos os lados. Havia sabedoria no desejo da paciente de partir. Havia sabedoria na insistência de Ed para que ela ficasse. Ele encontrou uma síntese dos dois lados: seria ele quem argumentaria para mantê-la no hospital até que ela estivesse sob melhor controle comportamental, ao mesmo tempo, ele a ajudaria a apresentar seu caso contra ele da maneira mais habilidosa possível. A síntese veio não apenas em seu convite para ajudá-la a opor-se a ele de forma mais eficaz, mas em sua declaração de que a meta final, presumivelmente para ambos, era aprimorar suas habilidades. Se fosse o marido da minha prima em vez de Ed, trabalhando com seu *peavey* para resolver impasses literais em vez de tratar um paciente, ele poderia ter se alinhado temporariamente com a força de um tronco, empurrando contra o tronco “oposto”, de tal forma que liberasse as duas toras para voltar a fluir rio abaixo. A solução ideal em terapia é encontrar e articular as posições opostas, identificar o que é válido em cada posição e intervir de maneira que permita a síntese.

Quanto mais claramente compreendemos essa natureza essencial da realidade, menos surpreendente é que encontremos oposição e polarização no tratamento. Nós esperamos isso. Em vez de pensar “Como isso aconteceu? Que surpresa! Por que ela se opõe ao que estou dizendo?”, a atitude se torna: “Claro que estamos em lados opostos, é compreensível”. É claro que é estressante trabalhar com indivíduos cuja biologia e história resultam em posturas rígidas que os colocam em oposição a nós. Mas se pudermos realmente compreender a natureza essencial da realidade, em que os opostos estão presentes regularmente, teremos a chance de nos dessensibilizar à oposição. Se pudermos relaxar na consciência da oposição, esperar por ela, talvez até

aprender a apreciá-la, teremos uma chance melhor de trabalhar de forma criativa e produtiva. Nós fazemos a modelação para o paciente que os opostos não precisam ser temidos, mas, em vez disso, podem ser abordados com curiosidade e até servir como o principal ponto do crescimento.

Pensamento sistêmico

Uma paciente de 45 anos chegou ao meu consultório apresentando um problema de alcoolismo. Tínhamos trabalhado juntos por cerca de um mês. Ela era hesitante quanto a desistir do álcool e a fazer terapia. Sua mãe, de 70 anos, me ligou um dia para relatar o quanto sua filha estava bebendo. Ela estava preocupada e me pediu uma atualização sobre o tratamento. Foi um tema na vida de minha paciente, experimentar sua mãe pairando intrusivamente sobre ela desde criança, cruzando os limites da autonomia e da privacidade. Eu disse à mãe que preferia que ela dirigisse suas preocupações diretamente à filha ou pedisse permissão a ela para falar comigo. A mãe desligou na minha cara com raiva. Ela disse à filha que eu era um “idiota controlador” e insistiu para que ela parasse de me ver. Como minha paciente se opunha à mãe, a insistência dela para que parasse de me ver na verdade a ajudou a decidir que eu era o terapeuta certo e que ela continuaria na terapia!

A característica essencial do pensamento sistêmico é que, em um sistema complexo, cada elemento faz parte do todo, sendo, portanto, interdependente de todas as outras partes, e uma mudança em uma delas resulta em uma mudança em todas as outras. Como resultado, se você achar que não pode fazer uma mudança desejada em um elemento, poderá intervir em outro. A paciente alcoólica que acabei de mencionar era hesitante quanto a estar em terapia. Ela e a mãe faziam parte do mesmo sistema familiar. Enquanto minhas discussões com a filha não resultaram

em seu maior comprometimento com a terapia, minha intervenção com a mãe, na qual estabeleci um limite em torno do envolvimento com o tratamento, me ajudou a atingir esse resultado. O fato de podermos mudar o comportamento de uma pessoa intervindo em outra nos permite expandir de forma múltipla o leque de possibilidades terapêuticas.

Eu estava supervisionando uma terapeuta em uma equipe de consultoria em DBT bem estabelecida e bem treinada. A terapeuta estava apresentando um paciente suicida de alta letalidade em sua supervisão. Ela estava muito ansiosa com esse paciente. Perguntei se estava recebendo apoio suficiente de sua equipe de consultoria. Ela me disse que a discussão sobre suicídio era limitada em sua equipe; havia pouco espaço para compartilhar seus medos sobre a possibilidade. Como descobri, o líder da equipe, que também era o terapeuta DBT mais antigo, havia perdido um paciente por suicídio no início do ano. Ele estava controlando sua própria dor e seu medo ao inibir a discussão nas reuniões da equipe, o que limitava a ajuda disponível para minha supervisionada em relação a seu paciente e provavelmente até aumentava o risco de comportamento suicida dele. Como parte da consultoria à minha supervisionada, fizemos uma reunião em que consultei toda a equipe. O encontro altamente emocionante, no qual o líder da equipe compartilhou sua dor pela perda de seu paciente, catalisou um processo de cura nos membros, o que fortaleceu a capacidade de todos conseguirem oferecer consultoria uns aos outros sobre pacientes suicidas. Tudo está conectado.

Treinei um grupo de terapeutas DBT que desenvolveram um próspero programa residencial infantil baseado em DBT localizado em uma grande clínica. A moral dos terapeutas estava alta, as famílias das crianças ficaram satisfeitas e os resultados clínicos foram muito bons. Fazia meses que não via a equipe. Um dos terapeutas me ligou e me convidou para uma reunião de equipe como consultor. A atmosfera na sala era restrita, as discussões

pareciam superficiais e a moral baixa. Ninguém poderia dizer claramente por que me pediram para realizar a consultoria. A nova administradora estava sentada na sala; ela participava de reuniões de equipe para “acompanhar” o que estava acontecendo. Fizemos uma pausa no meio da reunião. No banheiro masculino, um dos terapeutas me informou que não podiam conversar livremente com a administradora na sala. Logo após chegar à agência, ela havia participado de uma reunião de equipe; quando ouviu os terapeutas compartilhando livremente (e de forma saudável) seus pensamentos e sentimentos, declarou: “Não quero mais ouvir reclamações nessas reuniões. Somos profissionais. Não reclamamos”. Um ponto importante é que essa administradora era a responsável pelas avaliações de desempenho no trabalho de todos os profissionais. Intimidados, os terapeutas não registraram diretamente sua discordância. A incapacidade da equipe de abordar abertamente o “elefante na sala” resultou no declínio da equipe, o que, por sua vez, prejudicou a qualidade do atendimento aos pacientes. O clima tenso e improdutivo da reunião de equipe refletia um problema sistêmico, cuja solução demandaria mudanças em vários níveis da organização e em muitos indivíduos.

A lição é que tudo importa. Tudo afeta tudo. Minha conversa com a mãe de minha paciente alcoolista levou a uma aliança terapêutica mais forte com minha paciente. O suicídio do paciente de um líder de equipe resultou na proibição da discussão sobre o assunto na equipe muitos meses depois, aumentando o risco de comportamento suicida de outro paciente. A contratação de uma nova administradora de uma clínica de terapia infantil provocou um estrangulamento no compartilhamento aberto de emoções e pensamentos em uma equipe de consultoria de DBT, afetando negativamente o tratamento dos pacientes e provavelmente prejudicando a reputação da clínica. Quando tentamos entender e influenciar fenômenos importantes na implementação de

programas e no trabalho clínico, precisamos considerar fatores que estão vários passos distantes desses fenômenos.

Durante meu treinamento em psiquiatria e psicoterapia, participei de uma conferência anual de terapia familiar patrocinada por um hospital psiquiátrico particular. Por vários anos, eles convidaram Carl Whitaker, um renomado e criativo terapeuta familiar, que geralmente entrevistava uma família no palco e depois discutia o processo. Ele era um mestre da dialética na terapia familiar.

Certo ano, o hospital optou por apresentar o caso de uma mulher de 30 e poucos anos internada no hospital por quase três meses. Eles ficaram perplexos com sua apresentação e frustrados com a falta de progresso. Não ficou claro se ela estava deprimida, psicótica, com deficiência orgânica ou com falta de disposição, mas o sintoma apresentado era que ela não falava. Ela comparecia às reuniões e seguia as regras, mas não falava com ninguém, nem com seu terapeuta. Esse comportamento estava presente em sua chegada, e o caso estava estagnado, sem andamento. A equipe de tratamento decidiu apresentá-la no contexto de sua família, composta por três irmãos adultos: dois homens e uma mulher. Os quatro sentaram-se no palco em semicírculo, de frente para Whitaker, diante de cerca de 300 profissionais da saúde mental.

Whitaker não se dirigiu à paciente e parecia nem mesmo ver enquanto ela se sentava ao lado de sua irmã, no final do semicírculo. Em vez disso, ele começou perguntando a um dos irmãos, vestido com um belo terno e parecendo bastante ansioso, se ele achava que poderia tirar algum proveito de uma sessão de terapia familiar. “Sim, estou aqui por minha irmã e terei prazer em participar de qualquer coisa que possa ajudá-la.” Whitaker: “Não, não é isso que quero dizer. Quero dizer, você poderia, para sua própria vida, aproveitar algo de uma sessão familiar?”. O irmão: “Olhe, eu quis dizer o que disse; farei qualquer coisa para ajudar minha irmã. Minha própria vida vai bem, obrigado”. Whitaker não

apenas persistiu, mas de repente começou a insultá-lo: “Não posso acreditar que tudo na sua vida esteja bem. Você está um pouco acima do peso, por exemplo, um pouco gordo, e não posso deixar de pensar que pode haver uma camada de gordura ao redor do seu coração. Talvez a terapia familiar possa ajudar a reduzi-la e prolongar sua vida”. O irmão ficou imediatamente vermelho como uma beterraba, claramente envergonhado e furioso. Ele começou a levantar a voz, e Whitaker rapidamente recuou e emitiu um pedido de desculpas superficial.

Ele passou para o irmão número dois. “E você? Existe algo de sua própria vida que você possa levar para uma sessão de terapia familiar?” Irmão número dois: “De fato, minha vida é muito boa, realmente sem problemas. Assim como Paul [seu irmão], estou disposto a fazer qualquer coisa para ajudar minha irmã”. As irmãs apenas ouviram. Whitaker: “Eu não entendo. Você e seu irmão não veem nada em suas vidas que possam melhorar. Por exemplo, você [irmão número dois] é magro, alto, possivelmente meio rígido. Eu me pergunto se você realmente se diverte tanto quanto poderia. Talvez a terapia familiar possa ajudá-lo a relaxar e se divertir mais”. Nesse ponto, a paciente muda explodiu! Sua risada rapidamente se tornou quase incontrolável. A irmã dela começou a rir também, e as duas riam tanto que choravam. Todos os outros ficaram quietos e confusos.

Whitaker perguntou a ela: “Do que você está rindo? Eu não entendo”. Ela conseguiu se acalmar o suficiente para responder, ainda quase rindo: “Não acredito no que você está dizendo! O que você disse aos nossos irmãos é exatamente o que costumávamos dizer a cada um deles quando eram crianças. Costumávamos provocar Paul por causa de seu peso e John por causa de sua rigidez. É tão engraçado”. Sua irmã estava concordando com a cabeça, ainda rindo. Os irmãos pareciam muito desconfortáveis. Whitaker observou que as duas irmãs pareciam ter um relacionamento muito bom. A paciente falou imediatamente: “Nós

tínhamos”. Seus olhos desceram para o chão. “Não temos mais.” Whitaker: “Por que não?”. Paciente: “Desde que minha irmã teve seu segundo filho, ela quase desapareceu do planeta. Eu mal a vejo ou ouço falar dela, ela simplesmente se foi”. A tristeza repentina foi profunda e provocou lágrimas em quase todos. Whitaker permaneceu em silêncio, apenas permitindo que as palavras da paciente fossem ouvidas. Ele então fez uma recomendação. “Eu sei o que você deve fazer. Sua irmã deve se mudar para o hospital com você e vocês duas devem ser pacientes juntas o tempo que for necessário para redescobrir seu relacionamento. Acho que essa é a resposta.” Houve risos, mas ao mesmo tempo uma apreciação de que ele havia chegado ao cerne de algo, a uma compreensão sistêmica da apresentação sintomática. Como veremos, seu estilo de intervenção, que conseguiu movimentar esse impasse, era totalmente coerente com as estratégias dialéticas de Linehan.

Linehan reconheceu que alguns dos terapeutas familiares mais conhecidos foram professores e modelos para ela entender a dialética e incorporá-la à DBT. Carl Whitaker foi um deles. Esses terapeutas eram excelentes em exercer a liberdade, usando abordagens não convencionais para quebrar impasses familiares. Eles eram mestres do inesperado, por meio de tato, *timing* e intervenções estrategicamente paradoxais para romper a estabilidade em um sistema disfuncional e trazer uma nova homeostase. Suas intervenções foram baseadas na convicção de que tudo estava inter-relacionado, que todos afetavam todos e que toda intervenção tinha ramificações sistêmicas. Este é o espírito desse princípio no paradigma dialético. Pensando assim, podemos ampliar o escopo de nossas avaliações, percebendo que uma intervenção em um local, mesmo que a vários passos de distância do fenômeno de interesse, pode provocar uma mudança naquele fenômeno. Aumentamos assim o leque de intervenções nos paradigmas da mudança e da aceitação.

No início da minha carreira, eu estava tratando de um homem de 21 anos com esquizofrenia. Em geral excitável e agitado, ele experimentava sentimentos de êxtase, normalmente baseados em pensamentos delirantes que podiam se transformar instantaneamente em desespero. Minha abordagem foi baseada sobretudo em empatia, sugestões diretas e algumas interpretações. Este não foi um tratamento de DBT. Tentei meticulosamente ajudá-lo a entender o mundo em rápida mudança dentro dele e ao seu redor. Após dois anos de tratamento, precisei encerrar porque estava me mudando para Nova York. Ele se tornou consideravelmente mais fundamentado e estável ao longo dos dois anos. Quando nos aproximamos do final, perguntei se achava que havia melhorado. “Oh, sim! Charlie, estou vivendo com os pés no chão, e não mais com a cabeça nas nuvens!” Perguntei se ele tinha alguma ideia do que havia o ajudado – eu tinha minha própria noção de como ele tinha sido ajudado pela consistência de nosso relacionamento e um pouco da crescente compreensão de seu mundo interior devido ao trabalho interpretativo. Em vez disso, respondendo rapidamente, ele disse: “Lembra daquele sapato que você usava, aquele que tinha o buraco na sola? Isso foi o que mais me ajudou”. Atordoado e intrigado, perguntei por quê. Ele respondeu: “Eu sabia que você e eu estávamos juntos”. Perguntei-lhe se eu tinha estragado as coisas quando comprei sapatos novos. Novamente ele respondeu com rapidez, deixando claro que essas suposições eram bem formadas: “Não; quando você comprou sapatos novos, eu já sabia que éramos parecidos”. Precisamos de lembretes de que nossas hipóteses usuais sobre causa e efeito podem fazer sentido, mas às vezes são muito lineares, excluindo as possibilidades mais amplas que nos chegam do pensamento sistêmico. Linehan inclui uma estratégia dialética, *avaliação dialética*, cuja essência é nos manter fazendo a pergunta: “O que estou deixando de fora da minha compreensão deste problema?”.

O fluxo

O terceiro princípio de uma visão de mundo dialética se sobrepõe consideravelmente ao princípio de aceitação da *impermanência*. A cada segundo, tudo mudou desde o segundo anterior: cada molécula, cada estrutura, cada relacionamento e cada ideia. Pode ser desconcertante, para algumas pessoas até mesmo assustador, aceitar a verdade radical desse princípio: literalmente nada permanece o mesmo. Afinal, ao que resta nos agarrarmos, com o que podemos contar, o que podemos prever? Se quisermos estar em sintonia com a realidade, precisamos estar cientes de que o passado já se foi e que tudo o que pensamos que está por vir é apenas uma fantasia. Tudo o que é, está presente agora. A realidade é uma mistura massiva de diversos ingredientes em constante interação (compare o “movimento browniano” na física), sempre em movimento e em mudança.

Lembrar que tudo está mudando a cada segundo está em oposição direta ao pressuposto comum quando experimentamos as coisas como “paradas”: que nada está mudando. Quando tratamos indivíduos com padrões comportamentais rígidos, tendemos a ficar estagnados, incapazes de avançar ou retroceder, incapazes de provocar mudanças perceptíveis, às vezes visando a um determinado padrão comportamental por meses seguidos com pouca evidência de movimento. Podemos ficar frustrados, sem esperança e tensos. Quando nossa mente se concentra em uma perspectiva cada vez mais restrita na qual a mudança está em falta, a flexibilidade de nosso pensamento pode diminuir e o *burnout* terapêutico surge no horizonte (tanto para o terapeuta quanto para o paciente!). Passamos a acreditar em nossa percepção estática. Invocar esse pressuposto dialético, lembrando-nos de que tudo, em todos os níveis, a todo momento, está mudando, pode abalar nossa perspectiva e fornecer um antídoto para essa paralisia, levando à esperança e ao movimento. Mesmo

que não façamos “nada”, a mudança está chegando. (Na verdade, às vezes, *especialmente* se não fizermos nada, a mudança aparece.)

Certa vez, eu estava tratando de uma mulher com comportamentos de escoriação. Por um tempo, esse comportamento esteve no topo de nossa hierarquia de alvos de tratamento. No final de cada dia, ela registrava em seu diário o número de vezes que havia realizado escoriações, a intensidade desse comportamento e se isso havia trazido algum alívio. Em todas as sessões semanais, revisávamos seu cartão diário e, para focar no comportamento persistente de escoriação, fazíamos uma análise em cadeia cuidadosa do comportamento. Tornou-se tedioso, pois parecia que nunca aprendíamos nada novo, nunca conseguíamos encontrar um novo ângulo ou desenvolver uma solução funcional. É mais difícil conduzir análises em cadeia de um comportamento que está acontecendo quase constantemente do que em um comportamento que ocorre de forma intermitente.

Isso aconteceu no início da minha carreira em DBT, quando eu estava em uma supervisão semanal com Marsha Linehan. Em uma dessas sessões, reclamei com Marsha que minha repetida análise em cadeia do comportamento de cutucar a pele estava se mostrando completamente inútil e que era desmoralizante para mim e para a paciente. “Marsha, é assim toda semana, em todos os detalhes. Nada está mudando. Talvez precisemos deixá-la em paz!” Marsha: “Charlie, você poderia fazer isso, mas não seria mais DBT. Na DBT, continuamos visando ao comportamento de maior prioridade até que o alteremos. Não seguimos em frente só porque é frustrante. E deixe-me dizer algo sobre nada mudar: *simplesmente não é verdade! A cada segundo, cada molécula em seu cérebro e corpo e cada molécula no cérebro e no corpo da sua paciente mudam. Cada célula, cada ideia, tudo. Nada é sempre o mesmo. Lembre-se disso e apenas relaxe, volte, faça outra análise*

em cadeia do comportamento. Algo está faltando; algo está sendo deixado de fora. Apenas continue procurando”.

A princípio, fiquei desapontado, sentindo-me preso a uma situação imóvel e aparentemente imutável. Mas acreditava que era verdade que tudo estava mudando. Eu apenas não conseguia ver ou sentir. Ao longo das sessões que se seguiram, fiquei pensando: “Nada é o mesmo, tudo está mudando, o que estou perdendo?”. Nada poderia ser o mesmo. Durante minha análise em cadeia do comportamento de escoriação seguinte, prestei mais atenção a cada elo microscópico da cadeia, tentei imaginar o que estávamos perdendo. E eis que realmente pensei em algo que nunca havia perguntado a ela sobre aquele hábito. Perguntei, então, o que ela fazia com os pedacinhos de pele que arrancava de seu corpo. Ela ficou mortificada. Geralmente muito reservada e educada, seu rosto ficou vermelho e ela quase gaguejou: “Me dispus a falar sobre tudo o que você perguntou até agora, mas não vou falar sobre isso!”. Ela repetiu a recusa, indignada, ameaçando abandonar a sessão. Fui pego em uma dialética, quando disse a ela: “Não sei o que fazer, porque obviamente você quer que eu retire a pergunta, mas por outro lado, parece que é algo muito importante. Você não pode falar sobre isso, e eu não posso deixar isso para trás”. Depois de três sessões durante as quais estávamos em um impasse sobre minha pergunta, dei a ela um teste de múltipla escolha sobre o que ela fazia com os pedacinhos de pele. Como uma das opções era bem mais humilhante do que aquilo que ela fazia, que era comer os pedaços de pele, ela me contou a verdade com muito constrangimento. Daquele momento em diante, gradualmente seu comportamento passou a ser mais bem controlado e sua terapia mudou para o tratamento da vergonha insuportável em sua vida. A crença no fluxo pode ser um antídoto para a impaciência e a desesperança e resultar na abertura de nossos olhos para novas possibilidades.

Às vezes, na terapia, quando nada parece estar mudando e nenhuma intervenção parece fazer diferença, invoco uma metáfora em minha própria mente como remédio. Me imagino de pé ao lado de uma grossa parede de pedra que é alta demais para escalar e larga demais para contornar. Eu quero chegar ao outro lado, mas não há uma maneira óbvia de fazer isso. Essa parede de pedra também é totalmente impenetrável. Então relaxo. Percebo que se eu continuar parado ali, continuar a procurar o caminho através ou ao redor dela, continuar a empurrar aqui e ali com meus dedos, continuar a olhar para a parede de diferentes ângulos, algo mudará. Talvez eu veja uma rachadura que nunca vi antes, empurre de uma forma diferente de qualquer outro empurrão anterior, ou talvez haja uma mudança sutil na parede, algum deslocamento ou desmoronamento. A parede não é tão sólida quanto pensamos e está mudando. Esse princípio pode nos ajudar a manter o rumo quando parece não haver como prosseguir, ajudar a renovar nossa atenção e curiosidade e a manter o foco e a esperança diante da desesperança e da inquietação.

A POSTURA DIALÉTICA DOS TERAPEUTAS NA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA

Baseando-se no tratamento definido pelos três princípios, os terapeutas DBT podem trabalhar com enorme mobilidade e flexibilidade para prevenir e lidar com impasses e rigidez. A dialética fornece um caminho que amplia a solução de problemas e ajuda a manter as coisas fluindo ou a voltarem aos trilhos. Não fornece um destino. As intervenções dialéticas não são fins em si mesmas, são meios. Quais são algumas das implicações práticas para os terapeutas que adotam os princípios do paradigma dialético?

Por um lado, continuamos nos movendo. Entendendo que tudo está inter-relacionado, que tudo está mudando o tempo todo, que as oposições surgem e que a verdade se constrói ao longo do tempo por meio da síntese dos opostos, seguimos em frente. Mesmo que o trabalho terapêutico no momento pareça travado, seguimos tentando isso, tentando aquilo, continuando a buscar o que ficou de fora, pressionando por mudanças e aceitando as coisas como elas são. Em nossa casa, meus filhos já tiveram um brinquedo que era uma réplica de 60 cm de altura do R2-D2 de *Star Wars*. Quando ativado, R2-D2 começou a marchar em linha reta, arrastando suas pernas de plástico como um soldado marchando em formação. Quando esbarrava em alguma coisa, ele saltava um pouco para trás e então marchava para frente novamente. Ele podia bater na parede, ou em algum objeto imóvel, repetidas vezes, mas cada vez que pulava para trás, era em um ângulo ligeiramente diferente. Com o tempo, ele podia ficar preso por um minuto ou dois, batendo na mesma parede ou objeto fixo, até girar o suficiente para passar pela parede, para outro obstáculo. A vida para o R2-D2 envolvia movimento constante e um obstáculo após o outro. Ele nunca parava (até que o

desligássemos!). Da mesma forma, como terapeutas DBT, continuamos a nos mover, batendo em obstáculos (oposições), voltando, girando (usando diferentes estratégias ou suas variações), repetidas vezes sem progresso visível, até que as coisas se alterem o suficiente para trazer uma mudança clínica. O uso da dialética envolve tentativa e erro, sustentado pelas crenças de que tudo está inter-relacionado, que tudo está em movimento e que sínteses entre opostos sempre podem ser encontradas.

Enquanto as oposições que surgem no decorrer do tratamento podem envolver quase tudo, certos temas são familiares aos terapeutas DBT. Primeiro, e mais fundamental para a filosofia da DBT, é a oposição entre aceitação e mudança. A partir de uma atitude de aceitação, impulsionamos a mudança comportamental na direção definida pelos alvos do tratamento. Pressionando por mudanças, eventualmente acabamos “batendo contra uma parede”. Nós nos recuperamos (avaliamos a situação) e depois avançamos, possivelmente com uma nova estratégia de mudança ou com a mesma estratégia, mas aplicada de maneira um pouco diferente. Podemos chegar à impressão de que o impulso para a mudança, independentemente da estratégia, não está funcionando. Então passamos para a aceitação, usando uma estratégia de validação e um tom recíproco. Abandonamos a mudança e oferecemos aceitação. O paciente se sente mais compreendido. Então, podemos voltar para modificar as estratégias. Seguimos em movimento: R2-D2 fazendo psicoterapia! Pode ser que precisemos encontrar a síntese certa para impulsionar a mudança no contexto da aceitação e, sem dúvida, chegaremos lá por meio de tentativa e erro. Podemos estar mudando tanto, e rapidamente, entre as intervenções de aceitação e mudança, que esse movimento pode formar uma intervenção. Ou, como vimos no exemplo de Ed Shearin e da paciente suicida querendo sair do hospital, podemos encontrar uma forma de aliar-nos a ambos os lados, opostos um ao outro, ao mesmo tempo. O trabalho dialético se baseia na

improvisação, por meio da qual descobrimos sínteses criativas de aceitação e estratégias de mudança.

No início do meu programa de DBT para pacientes internados, concordei em fazer terapia com uma menina de 15 anos. Enérgica e teimosa, tinha tolerância muito baixa para a frustração, era altamente impulsiva e agia como se estivesse determinada a destruir sua própria vida. Como ela estava em constante supervisão, um membro da equipe de enfermagem a acompanhou até meu consultório. Ela entrou e imediatamente foi até minhas estantes. Sem falar, começou a jogar meus livros no chão, fileira após fileira. Eu pedi para parar; ela continuou. Eu disse para parar; ela continuou. Eu disse que ela teria que voltar para a unidade; ela disse que mal podia esperar. Liguei para o posto de enfermagem e eles enviaram um funcionário de volta ao meu escritório para buscá-la. Ela parou de jogar os livros. Nós ficamos lá. Disse: “Acho que foi a terapia mais curta da história”. Ela respondeu: “Graças a Deus!”. Eu disse: “Talvez não sejamos uma boa combinação para trabalhar juntos na terapia”. Foi a vez dela: “Você pode dizer isso de novo!”. Respondi: “Como a terapia não é uma boa maneira de trabalharmos juntos, acho que precisamos descobrir que tipo de relacionamento podemos ter para ajudá-la”. Ela estava estranhamente sem palavras e confusa. “O que você está falando?” Sugeri que nosso relacionamento teria que ser baseado em outra coisa. “O que você gostaria de fazer?” Ela foi rápida em responder: “Quero sair; não tenho permissão para sair há meses!”. Sugeri que poderíamos passear lá fora, se promettesse não fugir. Ela concordou com isso. Eu sabia que ela poderia fugir, mas devido ao curso atual, achei que valia a pena arriscar.

Demos um passeio pelos belos jardins do hospital. A equipe do hospital tinha casas no local. Depois de caminhar várias centenas de metros, a maior parte em silêncio, exceto por suas expressões de alegria por ver o mundo exterior, nos deparamos com um cercado de cães com um labrador preto. Ela começou a falar com

o cachorro: “Ah não! Você está no hospital! Que triste! Qual é o problema? Você sente falta da sua mamãe?”. Ela continuou falando com o cachorro. Conversamos sobre o cachorro. Mal sabia ela que na verdade era o cachorro da minha família, já que morávamos no terreno do hospital. Eu disse isso a ela, que ficou obviamente satisfeita. Ela começou a brincar comigo: “O que, você não tem pacientes suficientes no hospital, então precisa colocar seu cachorro no hospital também?!”. Houve um sorriso. Foi o início de uma série de passeios e conversas e de uma relação terapêutica entre nós, mas não uma *terapia*.

Nossos passeios e nossas conversas com o cachorro e sobre ele representavam uma síntese entre manter uma relação terapêutica, por um lado, e redefinir seus termos de uma forma que fosse aceitável para ela. Este foi um exemplo da estratégia dialética da DBT, *permitindo a mudança natural*, na qual a síntese entre duas posições opostas é encontrada aceitando a mudança, seguindo a direção em que a pressão está sendo aplicada.

Embora a dialética entre aceitação e mudança seja central para a DBT, o terapeuta também equilibra outras posições opostas. Por exemplo, equilibra firmeza e flexibilidade. A necessidade desse tipo de equilíbrio pode entrar em jogo quando o terapeuta está tentando manter o paciente em uma das expectativas do tratamento, como o preenchimento de um cartão diário. Quando o paciente se opõe a completá-lo, pode se tornar um dos muitos impasses no tratamento. O terapeuta orienta o paciente para o motivo pelo qual o cartão diário é importante e insiste firmemente em sua conclusão. “Preciso que você preencha o cartão diário para que eu possa ver como está se saindo todos os dias em seus comportamentos-alvo e suas habilidades.” O paciente pode recusar ou preencher apenas parte. Terapeuta e paciente podem ficar paralisados, enfrentando-se. Ambos os lados podem ficar bastante rígidos. Na verdade, o tratamento feito para encontrar a síntese pode ser valioso e não deve ser apressado. Como Linehan

colocou em sua supervisão de terapeutas, a “terapia do cartão diário” pode ser valiosa, pois “existem tantos ‘cartões diários’ na vida, tarefas que temos de concluir, embora não sejam particularmente agradáveis”. Uma possível síntese em relação ao cartão diário envolve desviar o foco da forma e dos detalhes das expectativas e, em vez disso, focar nas suas funções. Se enfatizarmos as funções de automonitoramento e comunicação de detalhes ao terapeuta, podemos ser mais flexíveis quanto às regras e à forma de revisão. Em um caso, quando estava trabalhando com alguém que tinha dificuldades significativas de aprendizagem e achava o cartão diário muito denso em termos de cognição e números, criamos um novo que era menos denso, visualmente mais atraente e permitia avaliações em escala 1 a 3 em vez de 0 a 5. O paciente estava então disposto a fazê-lo, e até orgulhoso. Quanto melhor os terapeutas entenderem os verdadeiros princípios e funções da DBT, mais flexíveis poderão ser ao lidar com as armadilhas.

Os terapeutas DBT equilibram o suporte afetivo, por um lado, com o desafio dos pacientes a mudar seu comportamento e, por outro, movendo-se com facilidade e rapidez entre os dois para encontrar o equilíbrio que permite que a terapia continue fluindo ao longo dos alvos. Eu estava atendendo um jovem que tinha vários problemas para dormir e comer e era um acumulador, além de apresentar comportamentos suicidas. Eu queria que ele mantivesse um registro de seus padrões de alimentação e sono para uma avaliação mais precisa, mas ele achou isso pesado e recusou. No entanto, insistia em ter o direito de me enviar longos *e-mails* entre as sessões e esperava uma resposta minha. Esse pedido foi realmente um desenvolvimento positivo para ele, já que quase não teve relacionamentos em sua vida, mas foi além dos meus limites pessoais habituais em relação à correspondência por *e-mail*. Eu disse a ele que estenderia meus limites e aceitaria seus *e-mails*, fazendo o possível para responder em tempo hábil

(suporte emocional). O paciente estava visivelmente satisfeito. Eu então disse que, se eu fosse ultrapassar meus limites, queria que ele também ultrapassasse os seus e mantivesse um registro de sua alimentação e seu sono. Ele concordou imediatamente.

Em outro exemplo, o terapeuta mantém um equilíbrio dialético entre o foco nos fatos e nas consequências dos déficits do paciente, por um lado, e o foco nas capacidades do paciente, por outro. Todos nós – e todos os nossos pacientes – temos deficiências e capacidades e damos atenção a ambos no tratamento. Ao tratar uma jovem que estava em transição de gênero, tendo iniciado tratamentos hormonais e planejando fazer uma cirurgia de redesignação sexual, encontrei sua família bastante perturbada. Seus pais estavam confusos, chateados e sem apoio. Ela pedia a aprovação deles, mas o fazia de forma não muito habilidosa, consistindo principalmente em castigá-los por suas atitudes retrógradas. Sempre que eu sugeria que poderia ajudá-la a melhorar suas habilidades de falar com eles, ficava na defensiva e argumentava. Mudei meu foco de seus déficits na comunicação com seus pais para a extraordinária coragem e firmeza (capacidades) que demonstrou ao continuar no difícil caminho em que estava com pouco apoio. Observei que os membros de sua família provavelmente poderiam aprender muito com ela se pudessem ver as coisas de sua perspectiva. Ela então reconheceu que não estava sendo muito hábil ao conversar com eles. Foi quando perguntou se eu poderia treiná-la em suas habilidades de comunicação, o que acabou levando a sessões familiares.

Reconhecer com precisão as posições opostas, encontrar a validade de ambos os lados e alternar para frente e para trás em busca de síntese requer várias qualidades do terapeuta. Primeiro, precisamos ficar alertas, “acordados”, ágeis e receptivos. Em segundo lugar, precisamos manter a velocidade, o movimento e o fluxo, especialmente diante de impasses e conflitos. Terceiro,

quando assumimos posições na terapia, seja em conjunto com um paciente ou no lado oposto, é valioso assumir essas posições com certeza, força e convicção no momento, enquanto ao mesmo tempo estamos dispostos a ouvir e ver a sabedoria do outro lado. Por exemplo, os terapeutas DBT normalmente responsabilizarão os pacientes pelas expectativas do tratamento, em vez de tratá-los como frágeis, mas depois virão em seu auxílio, treinando-os com apoio na tentativa de atender às expectativas que são difíceis para eles. Finalmente, os terapeutas DBT trabalham duro para manter o relacionamento intacto, preservando-o por meio de desafios inevitáveis.

AS ESTRATÉGIAS DIALÉTICAS

Linehan nomeou e descreveu nove estratégias dialéticas. Cada uma elucida uma maneira particular de lidar com o problema de impasses na terapia caracterizados por polarização, rigidez ou estagnação. Eu não detalho as estratégias aqui; elas são descritas e ilustradas com exemplos clínicos no manual de tratamento da DBT (Linehan, 2010). Em vez disso, considero como as estratégias dialéticas fluem dos princípios discutidos anteriormente. Meu foco está em elucidar a “fórmula” essencial para as estratégias dialéticas, de modo que um terapeuta possa até improvisar e criar novas que se encaixem na situação. Ao manter nossa mente nos princípios, enquanto aplicamos as estratégias dialéticas, seremos “dialéticos” no tratamento, ao lado de “sermos comportamentais” e “estarmos em *mindfulness*”. Ser dialético afeta a condução da DBT de forma mais abrangente, de modo que não estamos apenas resolvendo impasses, mas quebrando impasses quase antes que eles aconteçam, por meio do pensamento sistêmico; de velocidade, movimento e fluxo; e da conscientização e síntese de opostos.

A estratégia dialética mais direta é conhecida como *equilíbrio das estratégias de tratamento*. Todos os três princípios dialéticos entram em jogo. O terapeuta enfrenta um impasse no paciente que está preso entre duas posições opostas, ou no relacionamento terapêutico, até mesmo paralisado por posições opostas. Ele tenta uma ou mais estratégias de solução de problemas, resultando em nenhum movimento discernível. Passa para o uso de validação e um estilo de comunicação orientado para a aceitação, mas isso também não leva a nenhuma mudança. Empurrar para mudança pode desencadear muita ansiedade, medo, vergonha ou raiva. Passar para a aceitação pode desencadear desesperança ou desespero. O equilíbrio das estratégias de tratamento se refere

principalmente à aceleração da transição entre solução de problemas (mudança) e aceitação, ou ao uso simultâneo de estratégias de mudança e aceitação. Por exemplo, quando eu era o chefe de unidade em um programa de internação de DBT, uma paciente de 23 anos pediu para falar comigo. Ela reclamou que sua equipe de tratamento estava sendo extremamente rígida em suas tomadas de decisão, se recusando a aumentar seu nível de privilégio por semanas. Tinha a impressão de que ela estava se envolvendo em todos os aspectos do tratamento, mas que eles não gostavam de sua atitude confrontadora. Sentia que estava sendo punida e tinha tentado tudo o que sabia fazer. Embora eu não fosse seu terapeuta, consultei com ela sobre como poderia lidar de forma mais eficaz com a equipe. Sugeri que ela poderia estar violando seus limites pessoais com sua abordagem agressiva e linguagem rude, e que poderia considerar suavizá-los. Ela ficou furiosa comigo por sugerir que ela estava “fazendo algo errado”. Respondendo ao seu tom e à sua rejeição direta de minhas sugestões, provavelmente me tornei um pouco defensivo. Enquanto íamos e voltávamos, parecia que ambos estávamos andando em círculos e não estávamos progredindo. Eu imaginei que essa fosse a natureza de sua interação com a equipe.

Embora tenha começado com a intenção de validar sua decepção e raiva com a equipe, percebi que havia pressionado rapidamente para que ela mudasse sua atitude e abordagem, primeiro em relação a eles e depois em relação a mim. Levei um minuto para refletir, procurando minha resposta da “mente sábia”. De repente e simplesmente “desisti” de tentar mudá-la e perguntei se ela poderia me dar mais detalhes sobre a abordagem da equipe e como isso a afetava. Meu tom era mais caloroso, mais interessado em sua perspectiva, e pude validar vários pensamentos e emoções. Ela detalhou suas queixas, eu validei seus pensamentos e sentimentos e ela então mostrou alguma compreensão do ponto de vista de sua equipe. À medida que as

coisas se “suavizaram” entre nós, continuei a validá-la enquanto voltava para a questão do que poderia fazer de diferente. Nesse ponto, ela foi capaz de considerar fazer algumas mudanças sem se sentir tão ameaçada ou defensiva. Essa mudança foi facilitada por *minha* rápida alternância entre 100% de aceitação e depois 100% de mudança. Cada instância de equilíbrio das estratégias de tratamentoparece diferente de todas as outras, mas cada uma contém esse esforço de tentativa e erro para encontrar o equilíbrio mais eficaz entre a aceitação genuína e a insistência na mudança para estimular o movimento em direção a alvos comportamentais e uma vida que valha a pena ser vivida.

O terapeuta utiliza a técnica *entrando no paradoxo* quando reconhece que o paciente está em uma situação, na vida ou no tratamento, em que duas faces de uma contradição são simultaneamente verdadeiras. Existem muitos exemplos. Na vida: para estar mais presente, é necessário ter atenção ao futuro; para planejar a melhor viagem, é necessário estar plenamente no momento presente; e para ser realmente independente, é importante ter uma capacidade de dependência saudável. No tratamento: se resgatamos repetidamente nossos pacientes, podemos perder a oportunidade de ajudá-los a se salvar; e mesmo que os problemas de alguém tenham sido causados por outros, o paciente precisará resolvê-los sozinho. Nenhuma dessas contradições é difícil de entender, mas se o terapeuta destacar a verdade de ambos os lados no momento, de forma breve e sem explicação, o paciente pode experimentar descrença e confusão, enquanto vagamente reconhece a verdade no que o terapeuta está dizendo. Como menciona Linehan (2010) no manual de tratamento, o terapeuta deve se abster da vontade de explicar ao paciente confuso que o paradoxo “faz sentido”. O objetivo não é educar, mas desviar o paciente de uma posição travada. Essa abordagem terapêutica é um eco do trabalho inovador anterior de Milton Erickson, que era um mestre de intervenções paradoxais

(Haley, 1973). O estilo terapêutico para essa estratégia é ser sucinto, breve e objetivo, declarando verdades que parecem se contradizer. Pode ser possível quebrar o bloqueio do momento, desestabilizando intencionalmente a homeostase paralisante. Por exemplo, o terapeuta pode dizer:

“Seu comportamento faz todo sentido, ao mesmo tempo precisa mudar.”

“Se eu não me importasse tanto com você, eu tentaria te salvar.”

“Você tem o direito de se matar, e eu tenho o direito de te impedir.”

“Se você quer melhorar em estar realmente com os outros, precisa passar mais tempo realmente sozinho.”

Duas outras estratégias dialéticas começam com o reconhecimento de que o paciente está em uma posição desadaptativa, quase convidando o terapeuta a desafiá-lo. O paciente mantém a posição desadaptativa; o terapeuta mantém a posição adaptativa. Ambas as partes se recusam a mudar de posição. De repente, o terapeuta “pula” além da posição desadaptativa do paciente, tomando uma posição ainda mais desadaptativa. Se feito de forma eficaz, o paciente fica momentaneamente surpreso e desequilibrado, permitindo novamente a possibilidade de reposicionamento e movimento. Uma dessas duas estratégias é a do *advogado do diabo*, na qual o terapeuta argumenta a posição desadaptativa do paciente com mais força do que o próprio paciente (p. ex., “Por que você iria querer desistir dos comportamentos de autolesão que foram a sua principal solução para o sofrimento?”). Se feito de forma eficaz, o argumento do terapeuta catapultará o paciente para uma posição mais adaptativa (“Mas eu realmente tenho que desistir dos comportamentos de autolesão: eles estão arruinando minha vida!”). A outra estratégia dialética em que o terapeuta propõe um

comportamento mais desadaptativo do que o paciente está apresentando é chamada de *extensão*. O terapeuta começa com a declaração desadaptativa do paciente, em geral emocionalmente motivada (p. ex., “Estou desistindo da terapia; estou cansado de você”). Em vez de argumentar contra isso, ele estende além do ponto em que o paciente pretendia ir (p. ex., “Então vamos encontrar um terapeuta que possa trabalhar melhor com você; tenho uma lista de possíveis referências nos meus arquivos”), com a esperança de que o paciente deixe o argumento de lado e expresse a emoção que impulsiona o impulso desadaptativo (p. ex., “Você sabe que eu não quero realmente um terapeuta diferente; estou apenas muito bravo com você!”). O terapeuta usa a compreensão da oposição para criar surpresa e estimular o movimento. É característico dessas duas estratégias, assim como de todas elas, que o terapeuta tenha 1) uma sensação intuitiva do estado atual das coisas no paciente e no relacionamento terapêutico e 2) bom *timing* e entrega. Caso contrário, todas essas intervenções falharão.

Novamente, partindo do reconhecimento de que um impasse envolve o equilíbrio não dialético entre duas posições opostas, as estratégias dialéticas de *fazer dos limões uma limonada* e *ativando a mente sábia* são duas maneiras diferentes para os terapeutas reformularem o impasse. *Fazer dos limões uma limonada* chama atenção para a oportunidade que existe dentro da crise atual. Por exemplo, “Eu sei que você odeia preencher o cartão diário; é compreensível, quase ninguém gosta. Mas sua recusa em fazê-lo é perfeita para nosso trabalho, já que a vida apresenta tantas situações como essa, em que você tem que fazer coisas que são tediosas, até mesmo preocupantes, e que fazem pouco sentido. Você deve continuar se recusando a fazê-lo até que faça sentido para você”.

O terapeuta geralmente aplica *ativar a mente sábia* quando o paciente é levado a comportamentos disfuncionais pelo “modo

emocional”. O terapeuta questiona: “Se você estivesse na mente sábia, o que diria sobre esta situação?”. Essa pergunta permite que o paciente mantenha a posição do modo emocional com toda a força necessária, e ao mesmo tempo identifique o que seria uma posição da mente sábia. Metaforicamente, envolve dividir a posição do paciente em duas posturas coexistentes e opostas.

Uma paciente minha, de 47 anos, estava muito desanimada com as condições altamente invalidantes em seu local de trabalho. Ela não podia se dar ao luxo de sair do emprego, não conseguia encontrar outro trabalho com benefícios, e sentia que não aguentaria mais um dia sequer naquela atmosfera opressiva. Durante a sessão, seu humor ficou mais sombrio e seu senso de urgência intensificou. Com apenas alguns minutos restantes na sessão, ela me disse que deixaria o emprego no dia seguinte. Ela já havia chegado a esse ponto no passado, mas não a esse grau.

Perguntei a ela: “Se você sair amanhã, essa decisão virá da mente racional, da mente emocional ou da mente sábia?”. Não estava tão claro para ela, uma vez que ela considerou tanto racional quanto sábio deixar o emprego e se sentia muito emotiva e pressionada. Conduzi uma avaliação mais cuidadosa com ela sobre a contribuição dos três estados mentais e ela rapidamente percebeu que, embora fosse racional deixar o emprego e sábio encontrar outro, a urgência era impulsionada pela mente emocional. Ela concordou em trabalhar comigo em direção a uma transição sábia em sua vida, bem como uma abordagem sábia para tolerar sua vida diária no trabalho.

Metáforas oferecem uma utilidade extraordinária na DBT como construções que podem representar criativamente situações polarizadas e o pensamento sistêmico e que podem permitir o movimento em uma situação que, de outra forma, estaria emperrada. Elas permitem que o diálogo, que pode ter parado, continue em um novo plano, dentro do quadro da metáfora. Mais ambiciosamente, elas abrem a possibilidade de representar

posições opostas e encontrar um caminho em direção à síntese. A variedade de metáforas é infinita. Algumas metáforas podem ser evocadas por um momento e depois deixadas para trás; outras podem se tornar o quadro para um trabalho estendido, fornecendo um ponto de referência conveniente para o terapeuta e o paciente retornarem por semanas ou meses. Metáforas não são apenas mais uma estratégia; elas são integrais para o ensino e a prática da DBT. O manual de DBT de Linehan (2010) está repleto de metáforas em cada capítulo. As metáforas foram emprestadas e adaptadas entre professores e terapeutas na comunidade de tratamento em DBT muitas vezes. A seguir, dou um exemplo de como usar uma metáfora que ouvi pela primeira vez de Linehan e que adaptei para várias situações com diversos pacientes. É especialmente útil para lidar com o paciente que mantém uma postura não produtiva, até mesmo autodestrutiva, ao longo do tempo, apesar da resolução ordinária de problemas e da validação. O paciente está preso, e o terapeuta está frustrado.

Uma estudante universitária brilhante e capaz não estava progredindo na faculdade. Ela não estava fazendo tarefas extraclasse e estava faltando a muitas aulas, assistindo a muita televisão, jogando *video game* todas as noites e fumando maconha todos os dias. Ela agia como se não se importasse, e mesmo que parecesse apreciar minhas intervenções para ajudá-la a mudar, nada mudava. Tivemos o seguinte diálogo:

Terapeuta: Do jeito que eu vejo, você está em uma prisão. É uma prisão que você criou para si mesma. Ela é feita de maconha, *video games*, televisão e negligência com o trabalho universitário, mesmo que você queira se formar. E quando nos encontramos todas as semanas, é como se eu estivesse visitando você na prisão, ouvindo você e dando sugestões, sendo um amigo, confortando você, ajudando você a sobreviver. Mas há outra maneira de visitar alguém na

prisão, na qual eu tento ajudar a pessoa a escapar. Eu trago planos da infraestrutura da prisão, trago colheres, facas e outras ferramentas, certifico-me de que o carro de fuga esteja pronto e planejamos tirá-la de lá. É isso que eu prefiro fazer neste ponto da minha carreira. Quero que você pense se quer que eu a visite como um amigo reconfortante, aceitando que você tenha uma longa sentença, ou se quer ajuda para escapar.

Paciente: Você está dizendo que vai parar de me ver?

Terapeuta: Não, estou dizendo que percebi que quero ajudá-la a escapar da sua prisão. Quero saber se você quer um parceiro assim. Se você decidir que não quer escapar, tenho que decidir se continuo fazendo o trabalho de conforto ou se encontramos alguém mais adequado para esse tipo de trabalho.

Esse diálogo me ajudou a dizer algumas das mesmas coisas que eu vinha dizendo para ela, mas de uma maneira diferente e com um elemento de suspense, que criou um movimento nela. Isso reformulou nosso trabalho juntos e na semana seguinte ela decidiu que queria “sair da prisão”. Começamos a trabalhar nessa tarefa.

Anteriormente, mencionei a estratégia de *permitir mudanças naturais*. Essa estratégia flui a partir de uma compreensão de que impasses resultam da tensão entre opostos e da consciência de que as coisas estão sempre em fluxo. Os impasses, especialmente aqueles relacionados às condições e regras básicas no relacionamento terapêutico, podem ser tratados permitindo a mudança natural em vez de manter todas as condições em vigor. Quando me encontrei por vários meses com um estudante universitário, comecei a perceber que nossas sessões geralmente duravam cerca de 10 a 15 minutos a mais do que meu tempo habitual de 50 minutos. Quando os 50 minutos terminavam, percebia que estávamos no meio de uma discussão importante.

Quando me dei conta disso, senti que estava violando os limites que eu havia estabelecido e fiquei um pouco envergonhado. Trouxe isso para o paciente: “Você notou que geralmente vamos além dos 50 minutos que combinamos?”. Paciente: “Claro, eu notei desde o começo”. Eu: “Por que você não disse nada?”. Paciente: “Eu estava com medo de que você tirasse isso de mim e sinto que preciso disso”. Eu: “Não sei por que, mas talvez haja alguma sabedoria em nos encontrarmos um pouco mais”.

“Como você se sentiria se concordássemos em ter sessões de uma hora e víssemos se isso funciona?” Paciente: “Isso é bom, eu gostaria disso”. Na verdade, eu temia que nossas sessões precisassem ser de 70 minutos, como se a constante subjacente fosse nossa tendência a ultrapassar nosso tempo designado, independentemente do que fosse. Com o passar do tempo, se mostrou funcionar perfeitamente bem nos encontrarmos por 60 minutos.

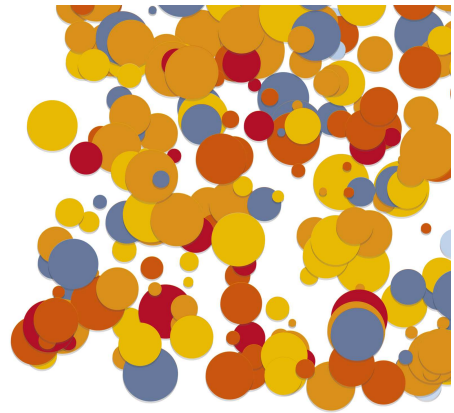
Finalmente, há uma estratégia dialética, *avaliação dialética*, que é aplicada de forma muito ampla. Significa simplesmente que quando enfrentamos um impasse, assumimos que estamos deixando algo de fora e abrimos nossa mente para procurá-lo. Eu dei um exemplo anterior sobre o tratamento de uma paciente que se engajava em comportamento de escoriação. Como você deve lembrar, minha supervisora, Marsha Linehan, insistiu que eu continuasse a avaliar o comportamento com análises em cadeia e que deveria assumir que estava perdendo algo. Ao enquadrar o que eu estava fazendo dessa maneira, como avaliação dialética, percebi que minha mente relaxou e se abriu, e criei uma nova intervenção que quebrou o impasse.

CRIANDO ESTRATÉGIAS DIALÉTICAS

Conforme consideraremos posteriormente, não há razão para limitar o uso de estratégias dialéticas a nove, conforme descrito por Linehan. Duas novas, com a justificativa para o seu desenvolvimento, são apresentadas mais adiante. Existe um tipo de fórmula para criar estratégias quando precisamos delas, baseadas nos princípios de oposição e síntese, pensamento sistêmico e transacional, e fluxo. Essa é uma área em que o terapeuta pode ser criativo e flexível quando as estratégias usuais de mudança e aceitação falham em gerar movimento.

COMENTÁRIOS FINAIS

Por fim, tendo dado tantos exemplos que parecem “fora da caixa”, sinto-me obrigado a deixar bem claro que uma posição dialética ou sua intervenção resultante não é engenhosa, artificial ou uma artimanha. Ela flui naturalmente a partir da “mente de principiante”, uma postura na qual o terapeuta está se esforçando muito para a mudança; aplicou aceitação, validação e compaixão; permanece terrivelmente preso; e deixa sua mente se abrir para mais opções. Essas intervenções surgem de maneira natural ao estar totalmente engajado, prestando atenção, procurando o que está faltando e tentando genuinamente manter a sabedoria de ambos os lados de uma dialética. Elas surgem de uma crença verdadeira de que nenhuma pessoa detém a verdade; que a verdade evolui a partir de vetores opostos em uma realidade na qual tudo está inter-relacionado e tudo está sempre mudando. E surgem de uma abordagem de tentativa e erro em que tudo, dentro dos limites éticos e dos princípios essenciais da DBT, é válido quando as intervenções diretas não estão funcionando. Tudo é justo no amor e na DBT, desde que estejamos tratando dos alvos que levam a uma vida que vale a pena ser vivida pelo paciente.



A árvore da terapia comportamental dialética

Anatomia estrutural

Até este ponto, exploramos a “fisiologia” da terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*); ou seja, como ela funciona e flui. Ao fazer isso, argumentei que um entendimento profundo dos princípios subjacentes do tratamento facilita a flexibilidade, a fluidez e a criatividade sem sacrificar a precisão e o rigor. Trabalhar a partir de princípios nos ajuda a navegar pelos desafios do tratamento sem perder o foco e a direção. Algumas das vantagens adicionais do tratamento ao conhecer e usar os princípios resultam em manter a “imagem completa” em mente: uma visão panorâmica de como o tratamento flui e amplia a conscientização do catálogo de estratégias, habilidades e protocolos.

Ter em mente um panorama geral do *quadro* do tratamento (o que poderíamos chamar de *anatomia* da DBT) também ajuda. Beneficia a equipe que projeta e implementa um programa de DBT, os terapeutas que realizam o tratamento e o consultor que avalia a saúde de um programa para fazer recomendações de melhoria. Para o terapeuta individual, entender a anatomia desejável do quadro do tratamento é inestimável. Ajuda-o a diagnosticar “problemas da organização da estrutura geral do tratamento” que possam afetar a terapia, a catalisar seus esforços para fortalecer e corrigir o quadro (da estrutura geral) e a entender as respostas de seus pacientes ao tratamento geral.

Um número de metáforas tem ajudado no ensino e na prática da DBT. Como descrevo no Capítulo 7, sobre o direcionamento de alvos, a “casa de tratamento em DBT” ilustra o fluxo da DBT do início ao fim por meio de várias etapas, cada uma com sua meta central e com seus muitos alvos específicos. Eu criei a metáfora da “árvore da DBT” para ilustrar a relação dos vários elementos estruturais do tratamento entre si e com o tratamento como um todo. Esses elementos incluem os três conjuntos de princípios; a teoria biossocial; a meta final de uma vida que vale a pena ser vivida; as metas, estágios e alvos; as funções e os modos; os vários conjuntos de acordos feitos por pacientes, terapeutas e equipes; os conjuntos de pressupostos sobre pacientes e sobre terapia; e toda a coleção de estratégias usadas na DBT (que inclui as habilidades). A árvore da DBT, ilustrada na Figura 6.1, funciona como um guia de várias maneiras:

- Para entender a DBT, ela representa este tratamento enorme e multifacetado de uma maneira que nos permite ver todas as partes e suas inter-relações.
- Para implementar a DBT, a árvore serve como um modelo de um programa abrangente, diagramando todos os ingredientes essenciais, permitindo que a equipe de implementação considere a presença e a força de todas as partes do tratamento e como elas se relacionam.
- Para adaptar a DBT a uma população ou contexto diferente, a equipe de implementação pode considerar sistematicamente quais aspectos do programa original do modelo preservar (o máximo possível!) e quais modificar.
- Para consultar um programa de DBT existente, a árvore da DBT serve como um mecanismo para avaliar sistematicamente as raízes, o tronco e todos os galhos, grandes e pequenos, localizando pontos fortes e fracos, levando a um plano para fortalecer o programa.

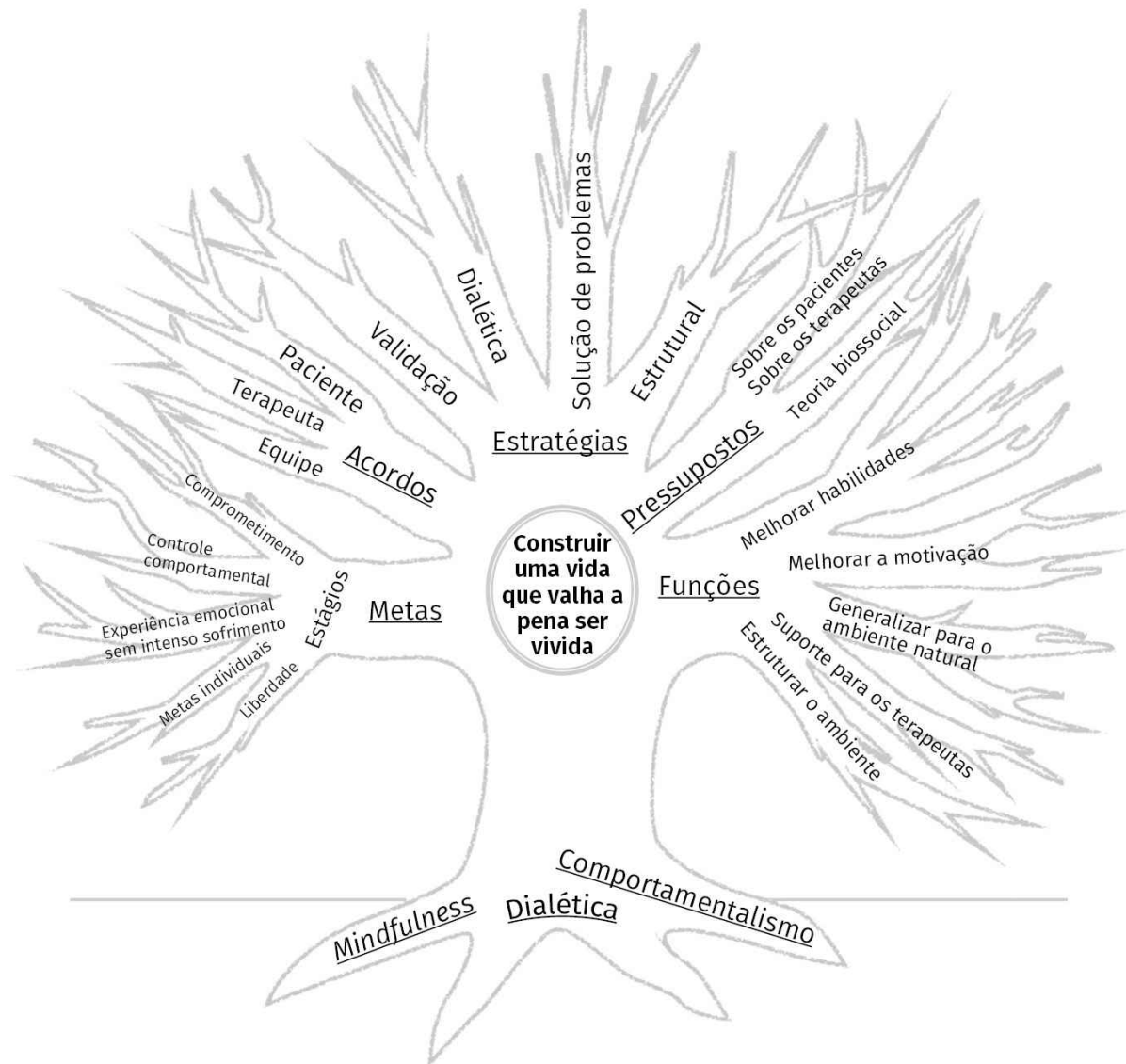


FIGURA 6.1 A árvore da DBT.

FATORES NO CONTEXTO DA ÁRVORE DA DBT

Ao utilizar a metáfora de uma árvore para representar os elementos de um programa de DBT, percebemos imediatamente que a árvore cresce dentro de um ambiente. A natureza, a viabilidade e a força da árvore serão tanto facilitadas quanto limitadas por três elementos ambientais: o *solo* em que as raízes crescem, a *vegetação* circundante e o *clima*. Cada um desses elementos tem seu equivalente no contexto em que um programa de DBT se desenvolve. Assim como a constituição do solo determina a disponibilidade de ingredientes nutricionais para o desenvolvimento da árvore, o contexto intelectual e organizacional em que um programa de DBT cresce vai nutrir ou privar o programa de nutrientes necessários. Da mesma forma que a natureza da vegetação circundante fortalece ou limita as possibilidades de uma árvore específica prosperar, a natureza dos programas e organizações circundantes vai fortalecer ou limitar a probabilidade de que um determinado programa de DBT prospere ali. E assim como as variáveis climáticas de sol, vento, chuva e temperatura selecionam alguns tipos de árvores em detrimento de outros, os recursos disponíveis em um contexto programático determinarão se os programas de DBT recebem o suficiente do que precisam para se enraizarem, crescerem e sobreviverem.

O solo: aceitação, mudança e dialética

Vamos considerar o papel do “solo” com mais detalhes. Um programa de DBT precisa de três tipos de nutrientes de seu solo organizacional, correspondendo aos três paradigmas subjacentes da DBT. Ele precisa de nutrientes que suportem o *mindfulness*, promovendo a aceitação; o comportamentalismo, direcionando para mudanças comportamentais; e a dialética, avançando os princípios da visão de mundo da dialética. O administrador de um

novo programa de DBT, ou o indivíduo avaliando a força de um programa estabelecido, seria sábio em “analisar o solo” em que esse programa cresce, perguntando se inclui os nutrientes para apoiar o *mindfulness*, o comportamentalismo e a dialética. Se forem encontrados desequilíbrios ou deficiências, pode haver maneiras de fortalecer ou reequilibrar o solo para obter a mistura certa.

Eu primeiro implementei a DBT em uma unidade hospitalar psiquiátrica de grande porte que cresceu a partir de uma longa tradição de fornecer um “retiro” compassivo para aqueles com problemas de saúde mental. Belo e pastoral, o hospital era rico em tradições biológicas e psicanalíticas. A pesquisa, com sua ênfase na objetividade, desempenhou um papel importante, assim como o esforço para compreender as pessoas em profundidade e empatizar com elas. Nesse sentido, o solo incluía alguns nutrientes para apoiar as raízes da aceitação na DBT. Além disso, e não inteiramente por coincidência, vários membros da equipe original de implementação da DBT praticavam várias formas de meditação há anos. A “quantidade de *mindfulness*” do solo era rica o suficiente para apoiar as raízes do paradigma da aceitação.

No entanto, o solo apresentava deficiência nos nutrientes que apoiariam as raízes comportamentais da DBT. Na verdade, havia alguns elementos “anticomportamentais”. O comportamentalismo raramente era estudado ou ensinado de forma sistemática, e os líderes de opinião frequentemente faziam comentários sugerindo que a terapia comportamental era simplista e superficial em comparação com a tradição psicanalítica. Uma vez que os membros da equipe de implementação entenderam que a DBT, em sua essência, era uma terapia cognitivo-comportamental (TCC), perceberam que, ao cultivar um programa de DBT, precisariam fortalecer os nutrientes comportamentais do solo. Durante o ano seguinte, aqueles sete indivíduos organizaram treinamento cognitivo-comportamental com professores em uma cidade

próxima. Durante as viagens semanais, os membros da equipe começaram a projetar o programa de internação da DBT. Uma vez que o programa de DBT estava em andamento, as clínicas continuaram a encontrar maneiras de complementar os elementos comportamentais do solo por meio de leitura e participação em grupos de estudo e experiências de treinamento externo. Ainda assim, mesmo com tudo isso, a deficiência nutricional local criou uma vulnerabilidade contínua no programa de DBT, em que os reflexos clínicos permaneceram mais psicanalíticos do que o ideal.

Não é tão fácil determinar se o solo em que um programa cresce contém nutrientes que apoiam as raízes dialéticas da DBT. Enquanto se pode facilmente identificar tradições que incluem *mindfulness*, empatia ou compaixão e aquelas que nutrem uma estrutura cognitivo-comportamental, as que apoiam o pensamento e a prática dialética são menos propensas a serem claramente evidentes. Ainda assim, a familiaridade profunda com um contexto organizacional particular pode tornar possível ver se o solo pode ou não suportar pensamento flexível, criativo e “fora da caixa” ou tolerar e valorizar diferenças e conflitos. Sistemas rígidos e hierárquicos que prescrevem a “maneira certa” de pensar e agir e que mostram pouca tolerância para posições opostas não são tão propensos a nutrir o pensamento sistêmico e os processos dialéticos.

O contexto hospitalar em que desenvolvemos nosso programa de DBT para pacientes internados tinha elementos que facilitavam o pensamento dialético e outros que o limitavam. A organização era fortemente influenciada por um modelo médico com hierarquias organizacionais típicas. A tomada de decisão frequentemente era “de cima para baixo”; a divergência e a não conformidade poderiam ser sujeitas à supressão e à desaprovação. Ao mesmo tempo, era um centro acadêmico com professores e programas altamente criativos, valorizando a inovação. Como uma instituição relativamente grande e complexa, continha vários

“microambientes” que apoiavam a improvisação e abraçavam a sabedoria de valorizar ambos os lados de um conflito. Um fator que permitiu o crescimento improvável de um programa de DBT em um hospital em que predominava a psicanálise foi a localização do programa dentro de um serviço (um dos microambientes) dirigido por um administrador criativo que abraçava uma variedade de modelos concorrentes. Ele valorizava o programa de DBT e servia como um amortecedor entre o programa e as dinâmicas organizacionais predominantes.

Quando eu presto consultoria sobre o projeto inicial de um programa de DBT, normalmente uso a árvore da DBT como um modelo arquitetônico e, ao fazê-lo, levanto rapidamente a questão sobre a natureza do solo organizacional, tentando antecipar as forças e deficiências dos nutrientes e, às vezes, estimular a equipe de implementação a ter ideias para aprimorar a mistura do solo. Apesar das melhores intenções de uma equipe de implementação criativa, uma deficiência séria de nutrientes que suportam *mindfulness*, comportamentalismo ou dialética causará uma divergência do equilíbrio ideal para a DBT.

A vegetação que cerca a árvore da DBT: programas e filosofias no ambiente

Tão crítico quanto analisar e corrigir a mistura do solo é considerar a influência das formas de “vegetação” circundantes, pelas quais me refiro a outras filosofias e programas de tratamento que compartilham o mesmo conjunto de recursos. Durante os anos 1990, quando os programas de DBT começaram a se enraizar nos Estados Unidos e em outros países ocidentais, foi interessante notar onde pareciam prosperar e onde não. No nordeste dos Estados Unidos, onde eu estava localizado e fiz considerável treinamento e consultoria, os programas de DBT floresceram rapidamente em configurações de saúde mental comunitárias que

eram relativamente rurais, mas também tinham alguns recursos orientados à comunidade. Muitas partes dos estados de Maine, New Hampshire, Vermont e Connecticut e a província canadense de New Brunswick serviram como anfitriões para os primeiros desenvolvimentos da DBT. Grandes projetos de implementação financiados pelo estado ocorreram em toda New Hampshire e Connecticut, bem como no centro-oeste. Em contrapartida, houve uma notável ausência de desenvolvimento de programas precoces na cidade de Nova York ou em outros grandes centros urbanos. Por meio do meu trabalho de consultoria em centros urbanos, observei que parecia haver menos “espaço” para os programas de DBT crescerem e prosperarem. A programação de saúde mental era fortemente influenciada pelos principais centros médicos acadêmicos povoados por desenvolvedores de tratamentos dedicados e pesquisadores que favoreciam seus modelos preferidos de atendimento, como a psicanálise, a psiquiatria biológica ou vários tratamentos orientados ao trauma. Quando os praticantes de DBT desenvolveram pequenos programas dentro de ambientes orientados pela psicanálise, os implementadores muitas vezes lutaram por espaço, recursos e respeito. Foi difícil “cultivar a DBT” em um ambiente no qual ela era vista meramente como um protocolo circunscrito que oferecia habilidades especificamente para aqueles com comportamentos autolesivos, em vez de ser vista como um modelo abrangente de psicoterapia para um grupo de transtornos complexos. À medida que a DBT finalmente conquistou respeito com base no crescimento constante de sua base em evidências por meio de ensaios controlados randomizados e apoio entusiasta de terapeutas DBT locais, esses centros mudaram sua atitude e a DBT cresceu em estatura e aplicação.

Em contrapartida, quando a DBT foi introduzida como um novo irmão da família cognitivo-comportamental em contextos já ricos em tratamentos orientados comportamentalmente, ela pôde

prosperar e ocorreu um significativo intercruzamento de programas e recursos entre a DBT e a TCC. Um novo modelo precisa de espaço e tempo para crescer. Ele requer um intercruzamento mútuo entre essa nova abordagem e programas existentes no ambiente circundante. A lição para aqueles que implementam a DBT é considerar a “vegetação” concorrente no contexto escolhido e construir pontes com outras organizações, programas e modelos na área.

O clima: recursos para a árvore da DBT

Assim como o solo e a vegetação, o clima também determina a força de uma árvore. No ambiente natural, por *clima*, refiro-me a certos tipos de recursos: chuva, sol, vento e temperatura. Os recursos correspondentes no ambiente de um programa de DBT incluem dinheiro, tempo, pessoal, materiais, espaço, entre outros. Se um programa de DBT está situado em um centro de saúde mental em um estado ou província que se comprometeu filosófica e financeiramente com o desenvolvimento regional da DBT e se a liderança executiva e clínica do centro de saúde mental apoia sua implementação, o programa costuma prosperar. Há chuva suficiente e sol suficiente. Se um hospital ou sistema de saúde mental envia vários indivíduos para o treinamento em DBT, mas depois não entende a necessidade de alocação contínua de recursos para apoiar o projeto, pode-se comparar a transplantar uma muda durante o verão e depois não fornecer a rega diária necessária.

Certa vez, prestei consultoria para uma agência do setor público em um estado vizinho que havia enviado uma jovem e talentosa terapeuta para um treinamento intensivo em DBT. A agência decidiu que não tinha recursos para enviar mais do que um terapeuta, então ela se juntou a três terapeutas de um programa em um condado vizinho para constituir uma “equipe de DBT” para

o treinamento. Ela trouxe seu novo conhecimento e a paixão por implementar a DBT de volta para sua agência, iniciou um grupo de habilidades em DBT, orientou os pacientes por telefone a usarem suas habilidades e fez o seu melhor para interessar outros terapeutas na DBT. Embora estivesse satisfeito por ter a DBT estabelecida em sua agência, o diretor médico se recusou a apoiar a designação de outro terapeuta para o projeto de DBT. A pessoa treinada em DBT trabalhou duro no ano seguinte, mas sua energia começou a diminuir à medida que ela se esforçava para estabelecer um programa duradouro. Apesar dos tremendos esforços desta dedicada profissional para compensar a deficiência de recursos, o resultado foi uma árvore com áreas de força, nas quais os recursos estavam disponíveis, e áreas de fraqueza, nas quais não estavam. Ciente de seu próprio iminente *burnout*, ela me convidou para uma consultoria clínica e programática. Habilmente, organizou um almoço comigo e o diretor médico (ela pagou por conta própria!). Como aconteceu, essa intervenção levou a uma infusão de recursos que permitiu ao pequeno programa florescer, com ela como a líder da DBT interna, e angariar vários seguidores dispostos. Tão importante quanto os nutrientes do solo e o impacto da vegetação circundante, o programa vive ou morre, prospera ou encolhe, com base nos recursos climáticos que “caem do céu administrativo”. A lição para aqueles que implementam programas de DBT é que o *design* inicial deve levar em conta os fatores contextuais correspondentes ao solo, à vegetação circundante e aos recursos climáticos para definir o escopo e o crescimento projetado da implementação. Avaliar corretamente a realidade contextual antecipadamente levará a um início realista e bem-sucedido, mesmo que menor do que o desejado, em vez de ao sofrimento das dores de cabeça que ocorrem quando faltam os recursos necessários para um início mais ambicioso.

OS GALHOS DA ÁRVORE

Como mencionei, os três principais sistemas da raiz da árvore da DBT representam os três paradigmas e seus princípios associados. O tronco representa a meta final da DBT: uma vida que vale a pena ser vivida. Saindo do tronco, existem cinco galhos grandes; quatro deles (dois de cada lado) representam a estruturação do tratamento, e o quinto (particularmente grande no topo) representa todas as estratégias de tratamento da DBT. Para compreender toda a DBT, é preciso conhecer intimamente muitos detalhes inerentes às raízes, ao tronco e aos cinco galhos. A maioria dos *workshops* de DBT, sejam curtos ou longos, é estruturada em uma agenda que coincide com o que é representado pelas raízes, pelo tronco e pelos cinco galhos da árvore da DBT.

O primeiro capítulo foi dedicado à conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida. O tronco representa essa meta final do tratamento. Se a adaptação particular da DBT é projetada para tratar comportamentos de autolesão, episódios de comportamento suicida, transtornos alimentares, transtornos por uso de substâncias (TUS), transtornos dissociativos, transtornos da conduta ou da personalidade antissocial ou outros, todos eles ainda convergem em torno da meta central de ajudar a construir a versão individual de cada paciente de uma vida que vale a pena ser vivida. Enquanto as raízes e o tronco permanecem os mesmos, os galhos da árvore podem adotar diferentes configurações, dependendo da população para a qual a DBT é aplicada e do contexto de tratamento no qual ocorre.

Emergindo do tronco, existem quatro galhos grandes, dois de cada lado, que representam a maneira como o tratamento é estruturado. Representados na ordem em que os discuto, esses são o *galho de metas*, o *galho de funções*, o *galho de*

pressupostos e teoria, e o *galho de acordos*. Esses galhos individuais têm características em comum. Cada galho representa um elemento estrutural importante e necessário da DBT. Cada galho é maior quando parte do tronco e se estende para galhos cada vez mais refinados. A parte grande de cada galho, mais próxima do tronco, representa um elemento na DBT que é relativamente o mesmo de programa para programa; consiste em um ingrediente necessário de uma estrutura de DBT. Os galhos cada vez mais refinados representam elementos de um programa de DBT que podem ser adaptados ao contexto e à população de pacientes específicos. Em outras palavras, esses galhos mais refinados representam aspectos da DBT que podem ser modificados para se adequar às circunstâncias de cada programa. Em seguida, descrevo cada galho principal com mais detalhes para mostrar como esse processo se desenrola.

O galho das metas

Faz mais sentido começarmos analisando o grande galho que representa as metas, estágios e alvos do programa DBT para cada paciente. Vamos chamá-lo de galho das metas. Saindo do galho das metas mais próximo do tronco, encontramos alguns outros, cada um dos quais representa uma meta principal do tratamento. Cada um deles será o foco de um estágio do tratamento. A DBT busca realizar a vida que vale a pena ser vivida do paciente por meio de uma sequência de estágios, cada um com uma meta. Na DBT padrão para pacientes ambulatoriais, existem cinco metas principais, o que significa que há cinco estágios; e, na imagem da árvore que acompanha o texto, há cinco galhos que os representam.

É importante lembrar que em algumas adaptações da DBT, pode haver um número diferente de metas principais para se adequar às circunstâncias. Por exemplo, na DBT para pacientes

internados em curto prazo, pode haver apenas três estágios, cada um com uma meta: 1) *entrar*, que envolve entrar com sucesso no programa e estabelecer comprometimento com o tratamento; 2) *ficar no controle*, que envolve estabilizar sintomas graves e alcançar o grau necessário de controle comportamental; e 3) *sair*, que envolve o desenvolvimento e a execução de um plano de alta bem-sucedido. Observe que, mesmo que a aplicação de curto prazo da DBT para pacientes internados tenha muitas variações em cada galho em relação à terapia padrão para pacientes ambulatoriais, os cinco principais galhos serão os mesmos: metas, funções, acordos, pressupostos e estratégias. As variações aparecem nos galhos menores.

Vamos agora considerar os cinco galhos menores do galho das metas na DBT padrão para pacientes ambulatoriais.

- O primeiro galho representa a etapa inicial do tratamento, conhecida como *pré-tratamento*, e corresponde à meta de entrar no tratamento, receber orientação, fazer acordos e se comprometer com o plano de tratamento.
- O segundo galho representa a próxima etapa do tratamento, conhecida como *estágio 1*, e tem como foco substituir padrões comportamentais caóticos e destrutivos por maior estabilidade e controle.
- O terceiro galho representa a etapa seguinte do tratamento, conhecida como *estágio 2*, e trabalha na transformação do intenso sofrimento emocional para uma experiência emocional sem intenso sofrimento por meio da melhora no processamento emocional.
- O quarto galho representa a próxima etapa do tratamento, conhecida como *estágio 3*, e aborda metas de vida individuais e aumento da autoestima.
- O quinto galho representa a etapa final do tratamento, conhecida como *estágio 4*, e tem como objetivo estabelecer

um senso de liberdade, significado e alegria sustentada.

Tendo identificado os cinco estágios com as cinco metas gerais em torno dos quais a DBT é estruturada, agora podemos considerar os galhos mais finos que se estendem a partir de cada uma das cinco metas. O trabalho em cada uma delas ocorre por meio da realização de uma série sequencial de alvos de tratamento. Por exemplo, a meta do estágio 1 na DBT é substituir a desordem e a falta de controle por mais estabilidade e regulação. Os alvos de tratamento que levam a essa meta, representados pelos quatro galhos finos que se estendem a partir do galho do estágio 1, são: 1) eliminar os comportamentos que ameaçam a vida; 2) reduzir os comportamentos que interferem na terapia; 3) diminuir os comportamentos que interferem severamente na qualidade de vida; e 4) aumentar as habilidades comportamentais. Às vezes, galhos ainda mais finos se estendem a partir de um determinado galho de alvos de tratamento, representando “subalvos” no caminho para alcançá-los. Por exemplo, quando o terapeuta trabalha com o paciente para diminuir o uso de substâncias, um comportamento que interfere severamente na qualidade de vida, a tarefa é dividida em vários subalvos sequenciais no caminho para eliminar o alvo do uso de substâncias. No Capítulo 7, sobre o direcionamento de alvos, consideramos as maneiras pelas quais o terapeuta da DBT usa a lista de alvos prioritários do tratamento para estruturar a agenda da terapia com um determinado paciente; e como o diretor de um programa de DBT usa as metas, os estágios e os alvos para estruturar uma agenda coerente, eficaz e motivadora para todo o programa.

Quando um terapeuta projeta e implementa um novo programa de DBT para aplicar o tratamento a uma população clínica ou contexto de tratamento que é diferente dos programas originais, ele pode usar a árvore como um modelo. Ele considera cada um

dos cinco principais galhos da árvore da DBT original e pergunta: “Quais modificações devo considerar para cada galho?”. Ao considerar o galho das metas, ele questiona: “Espero que meus pacientes passem pelos cinco estágios e metas gerais no modelo padrão, ou devo considerar uma modificação?”. Para cada uma das metas gerais, ele precisa perguntar: “Espero que meus pacientes passem pelos mesmos alvos de tratamento específicos conforme delineados no modelo padrão, ou devo considerar a modificação dos alvos devido à nossa população ou ao contexto de tratamento?”. E ao definir os alvos de tratamento, ele pode precisar se perguntar: “Os alvos de tratamento são específicos o suficiente, ou devo especificar subalvos mais específicos para algum deles?”. A representação visual fornecida pela árvore ajuda a focar na questão do que será necessário modificar. Por exemplo, quando eu representei a DBT em ambiente hospitalar agudo como uma árvore, houve três metas gerais em vez de cinco, três estágios correspondentes de tratamento e, para cada meta ou estágio, especifiquei os alvos de tratamento para aquela meta ou estágio. O modelo da árvore nos ajuda a considerar sistematicamente a variedade de opções e escolhas ao adaptar a DBT.

O galho das funções

Se nos movemos para o outro lado da árvore, vemos outro grande galho principal se estendendo do tronco, representando as funções da DBT. Assim como o galho de metas rapidamente se subdividiu nas cinco principais metas de um programa DBT padrão, o galho das funções rapidamente se subdivide nas cinco principais funções que encontramos em um programa de DBT abrangente e padrão. Essas cinco funções são para:

1. aprimorar as habilidades do paciente;
2. melhorar a motivação do paciente;

3. generalizar as habilidades do paciente para o ambiente natural;
4. aumentar as habilidades e melhorar a motivação dos terapeutas;
5. estruturar o ambiente de tratamento.

Essas cinco funções se aplicam a todos os programas de DBT abrangentes, em qualquer contexto e com qualquer população de pacientes. Essas cinco funções básicas e específicas são representadas como as partes da ramificação de funções mais próximas do tronco, as partes que permanecem mais constantes em diferentes implementações do programa. Cada uma dessas cinco funções é subdividida em *modos* do programa de tratamento por meio dos quais são realizadas. Os modos podem ser considerados veículos concretos que “transportam” essas funções. Os modos típicos do programa de DBT original padrão em ambulatório foram: 1) treinamento de habilidades (para aprimorar as capacidades do paciente); 2) psicoterapia individual (para melhorar a motivação do paciente); 3) *coaching* telefônico entre o paciente e o terapeuta (para generalizar as capacidades aprimoradas do paciente para o ambiente natural); 4) reuniões de equipe de consultoria da DBT (para generalizar as capacidades e melhorar a motivação dos terapeutas); e 5) o diretor de DBT e o gerente de casos (para estruturar o ambiente de tratamento).

Paralelamente à nossa discussão sobre o galho das metas, esses galhos menores representando os modos de tratamento, cada um se estendendo a partir de um galho maior que representa funções, provavelmente variarão dependendo do tipo de programa de DBT. Por exemplo, enquanto o modo primário em DBT padrão ambulatorial é a psicoterapia individual, a qual serve à função de motivar o paciente, com programas de DBT em ambientes hospitalares e ambientes direcionados para os contextos de moradia parcial, hospital dia (ou outros programas hospitalares

parciais e em programas de atendimento ambulatoriais intensivos), a função de motivação pode ser direcionada em reuniões de terapia em grupo, reuniões comunitárias, *check-in* um a um no ambiente, e possivelmente programação entre pares (em que os pacientes motivam uns aos outros, como ocorre em programas de 12 passos). Em outro exemplo, na DBT padrão ambulatorial, o modo prioritário para generalizar as capacidades dos pacientes é chamada de *coaching* telefônico, mas em sistemas de saúde mental comunitários, o gerente de caso ou “*counselor*”^[NT] pode “transportar” a função de generalização por meio do *coaching in vivo* do paciente na comunidade. Entender essa maneira de modificar os galhos externos da árvore (nesse caso, considerando quais modos seriam mais eficazes em “transportar” certas funções predefinidas) oferece mais criatividade à equipe de implementação ao adaptar os ingredientes essenciais da DBT para condições variadas.

Quando um programa não tem as condições ou recursos para ser verdadeiramente abrangente, seus líderes podem optar por limitar o número de galhos e, portanto, o número de funções de tratamento que se estendem a partir do galho de funções. Em vez de fazer uma implementação abrangente, eles optam por fazer uma implementação seletiva da DBT. Por exemplo, um programa de internação com recursos limitados para DBT pode selecionar as funções de aprimoramento de habilidades (*coaching* de habilidades), generalização de habilidades para o ambiente de internação (treinamento de habilidades pela equipe clínica de primeira linha), estruturação do ambiente de internação (horários, sistemas de privilégios, planos de contingência) e apoio à equipe de internação (reuniões da equipe de consultoria de DBT). Para quem está projetando um programa de DBT, o galho de funções assume o centro do palco porque representa o nível de abrangência do programa e a natureza dos modos, respondendo à

pergunta pragmática: que tipo de tratamento é este e quão abrangente é?

O galho dos pressupostos e da teoria

O próximo galho a considerar, mais fino do que os anteriores, mas de importância crucial, é aquele que inclui a teoria de trabalho e os pressupostos em DBT. Esses dois aspectos da DBT estão localizados no mesmo galho, porque são compostos pelas hipóteses e pressupostos que guiam a prática em DBT. Em última análise, tanto a teoria quanto os pressupostos devem ser submetidos a testes e validação por meio de pesquisas, mas, por enquanto, o galho dos pressupostos representa o que se poderia chamar de “filosofia de trabalho” da DBT. Esse galho rapidamente se divide em dois ramos: um representando a teoria biossocial e outro representando os pressupostos da DBT. Como Linehan (2010, pp. 108-110) detalhou um conjunto de pressupostos sobre pacientes e um conjunto de pressupostos sobre terapia, o subgalho de pressupostos em si se divide em dois. Quase todas as adaptações da DBT incluem a teoria biossocial, conforme originalmente delineada por Linehan (2010, pp. 51-71), e os pressupostos originais sobre terapia e pacientes. No entanto, em determinados casos, em que a DBT é realizada com uma população não padrão ou em um contexto de tratamento não padrão, os implementadores do programa podem modificar um pressuposto ou, mais comumente, adicionar um ou dois pressupostos adequados à situação específica. Por exemplo, alguns programas de DBT com pacientes internados adicionaram pressupostos adequados aos cuidados desses pacientes, como o pressuposto de que a vida de pacientes internados, com portas trancadas e vigilância 24 horas por dia, é estressante; ou outro afirmando que quaisquer habilidades adquiridas em um programa para pacientes internados devem ser generalizadas para a vida

ambulatorial. Programas especializados de DBT para indivíduos com TUS, transtornos alimentares, transtornos da conduta e da personalidade antissocial ou com limitações cognitivas podem adicionar um ou dois pressupostos especializados. Esses são mais bem derivados após o uso do tratamento padrão de DBT por tempo suficiente para perceber quais modificações fazem sentido.

A outra ramificação do galho de pressupostos representa a teoria biossocial. Ele rapidamente se subdivide em três ramos menores que representam os fatores centrais da teoria: 1) vulnerabilidades emocionais baseadas em fatores biológicos; 2) o ambiente invalidante; e 3) a disfunção emocional grave e crônica, que é o produto da transação entre os dois primeiros fatores. Cada um desses três ramos passa por subdivisões adicionais para representar, respectivamente, características das vulnerabilidades emocionais, dos ambientes invalidantes e da disfunção emocional grave. Embora a teoria biossocial da DBT, como originalmente formulada, seja central para quase todas as adaptações da DBT e atualmente tenha um considerável embasamento científico, há ocasiões em que a teoria pode precisar de modificação para se ajustar a uma população com diferentes características. Por exemplo, ao formular os fatores que causam e mantêm os padrões comportamentais em indivíduos com traços de personalidade antissocial, especialistas forenses em DBT sugeriram que o fino galho que representa “aumento da sensibilidade emocional” pode precisar ser substituído por “redução da sensibilidade emocional”.

À medida que prosseguimos para considerar os detalhes dos inúmeros galhos, grandes e pequenos, podemos começar a perceber que mudanças em qualquer um deles podem resultar em mudanças em vários outros. Revisar o galho da “sensibilidade emocional” para o de “redução da sensibilidade emocional” muda a teoria biossocial, o que poderia possivelmente resultar em modificações nos galhos que representam pressupostos, alvos e estratégias. É um lembrete de que o pensamento sistêmico, em

que uma mudança em qualquer parte resulta em mudanças em outras partes de um sistema, se aplica tanto à implementação quanto à terapia em si.

O galho de acordos

O quarto galho a ser considerado é o que representa os acordos feitos em um programa de DBT. Esse galho rapidamente se subdivide em três galhos menores na DBT ambulatorial padrão, representando três conjuntos de acordos: 1) aqueles feitos pelo paciente; 2) aqueles feitos pelo terapeuta; e 3) aqueles feitos pelos membros da equipe de consultoria em DBT. Os acordos feitos pelos pacientes, em vários programas de DBT, incluem certos tipos previsíveis: um de “duração” em relação ao período de tratamento acordado, um de “presença” especificando as expectativas em relação à presença em várias sessões de tratamento; acordos de “alvos de tratamento” especificando que, para estar no programa de DBT, os pacientes devem visar hierarquicamente episódios de comportamentos suicidas e comportamentos que interferem no tratamento; um acordo sobre “treinamento de habilidades” estipulando a necessidade de participar do programa de treinamento de habilidades; e outro de “pesquisa e pagamento” estipulando as obrigações do paciente em relação aos procedimentos de pesquisa e de pagamento. Em certas adaptações da DBT, acordos padrão podem ser modificados, ou acordos especializados apropriados para esse contexto podem ser adicionados. Por exemplo, quando a DBT foi adaptada para adolescentes e suas famílias, o “acordo de duração” foi modificado para um período mais curto (16 semanas em vez de 1 ano), com base na avaliação de que os adolescentes podem experimentar um ano de tratamento como uma eternidade e terão pouca probabilidade de se comprometer com isso. Em DBT para programas residenciais que têm um cronograma diário de grupos e

atividades além do programa de treinamento de habilidades usual na DBT padrão, podem ser feitos acordos em relação à presença em outras reuniões. Em programas de DBT para TUS, frequentemente há acordos em relação aos testes toxicológicos que serão realizados e ao uso de “drogas substitutas” durante o tratamento. Como mencionado ao discutir o galho de pressupostos, as equipes de implementação são aconselhadas a experimentar o modelo padrão, usando os pressupostos e os acordos padrão, e, em resposta à experiência de implementação, considerar a modificação e o acréscimo de acordos conforme indicado. Na implementação, deseja-se permanecer o mais próximo possível do modelo que foi demonstrado como efetivo pela pesquisa e, ainda assim, fazer modificações sensíveis que aumentem o encaixe com as novas circunstâncias (Koerner, Dimeff & Swenson, 2007).

Em paralelo com o galho que representa acordos do paciente em DBT, existem mais dois galhos de acordos: aqueles que representam acordos do terapeuta e aqueles que representam acordos da equipe de consultoria do terapeuta. Linehan (2010, pp. 113-119) listou inicialmente seis acordos em cada categoria. Assim como discutir modificações nos acordos do paciente, os líderes do programa devem revisar cada acordo nessas categorias para ver como ele se encaixa em cada programa individualizado. No caso dos acordos do terapeuta, podemos esperar que a programação adaptada inclua revisões e/ou complementos adequados ao contexto. No caso dos acordos da equipe de consultoria do terapeuta, ainda não encontrei nenhum programa em DBT de qualquer tipo que modifique os seis acordos da equipe originalmente estabelecidos. Eles resistiram ao teste do tempo, pois são incrivelmente eficazes na criação de uma atmosfera saudável na equipe.

O galho das estratégias

Dado que a DBT inclui mais de 80 estratégias, o quinto e último galho a considerar, representado como estendendo-se do topo do tronco, representa os alvos e é conhecido como o galho das estratégias. Os outros quatro galhos representam a estrutura do tratamento (metas, estágios, alvos, funções, modos, pressupostos, teoria biossocial e acordos). Este galho representa o “fazer”. O galho das estratégias, mais apropriadamente representado como surgindo do topo do tronco, rapidamente se subdivide em cinco galhos, cada um ainda bastante grande: estratégias baseadas em mudança, estratégias baseadas em aceitação, estratégias dialéticas, estratégias estruturais e estratégias de tratamento especial. As estratégias baseadas em aceitação estão à esquerda dos outros grupos, representando sua relação íntima com as raízes do paradigma da aceitação, que estão à esquerda dos outros conjuntos de raízes. Da mesma forma, as estratégias baseadas em mudança ficam à direita, assim como os princípios comportamentais são representados como o sistema de raízes mais à direita. As estratégias dialéticas, em algum lugar no meio, paralelas à posição dos princípios dialéticos como o sistema de raízes no meio. Também encontradas relativamente no centro das categorias de estratégias estão as categorias de estratégias estruturais e especiais, orientadas nem para a aceitação, nem para a mudança.

O galho das estratégias baseadas em aceitação rapidamente se subdivide em três galhos menores, representando (respectivamente) as estratégias de validação, as estratégias de comunicação recíproca (um tipo de estratégia de comunicação estilística) e as estratégias de intervenção ambiental (um tipo de estratégia de manejo de casos). Todos esses grupos de estratégias compartilham o foco de aceitar o paciente como ele está no momento. O galho das estratégias baseadas em mudança rapidamente se subdivide em três galhos menores, representando (respectivamente) as estratégias de solução de problemas, as

estratégias de comunicação irreverente (um tipo de estratégia de comunicação estilística) e as estratégias de consultoria com o paciente (um tipo de estratégia de manejo de casos). Todos esses grupos compartilham o foco de buscar a mudança comportamental. O galho das estratégias dialéticas se subdivide em galhos menores que representam as nove estratégias dialéticas descritas por Linehan (2010, pp. 193-210). As estratégias estruturais focam em como o terapeuta DBT estrutura as sessões de terapia ao longo de todo o tratamento. O galho das estratégias estruturais rapidamente se subdivide em cinco galhos menores representando: 1) estratégias de contrato; 2) estratégias de início de sessão; 3) estratégias de direcionamento de alvos; 4) estratégias de fim de sessão; e 5) estratégias de encerramento. Cada uma dessas cinco estratégias estruturais se estende para galhos mais finos representando as etapas e estratégias para sua aplicação. As estratégias especiais de tratamento abordam problemas e questões específicas no tratamento com pacientes que têm disfunção emocional grave e crônica. O galho dessas estratégias rapidamente se subdivide em seis galhos menores representando estratégias para lidar com: 1) crises do paciente; 2) episódios de comportamento suicida; 3) comportamentos que interferem na terapia da parte do paciente; 4) chamadas telefônicas; 5) tratamentos auxiliares; e 6) problemas na relação paciente-terapeuta. E, é claro, cada um desses seis galhos se subdivide ainda mais em etapas e estratégias específicas para realizá-los.

Assim como outros galhos, os galhos maiores de estratégias mais próximos do tronco praticamente não têm variações entre os programas; isto é, todos os programas de DBT usam grupos de estratégias de aceitação, mudança, dialética, estrutural e especiais de tratamento. Mas ao estender cada um desses galhos, a presença e a proeminência de grupos de estratégias e estratégias específicas variam dependendo do programa. Por exemplo, quando McCann e colegas adaptaram a DBT para uso em sua

instituição forense de segurança, eles adicionaram estratégias e habilidades que foram úteis no tratamento de indivíduos com transtorno da personalidade antissocial (McCann, Ball & Ivanoff, 2000). Quando Brown (2016) adaptou a DBT para indivíduos com deficiências de desenvolvimento e cognitivas, ela adicionou um “sistema de habilidades” de 10 conjuntos e uma variedade de estratégias de tratamento para adaptar a DBT às características únicas da população de pacientes.

APLICAÇÃO: MODIFICANDO A TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS

Depois de apresentar a árvore da DBT peça por peça, das raízes ao tronco e todos os cinco galhos, agora demonstro a utilidade da metáfora ilustrando as modificações que foram feitas na DBT padrão quando foi adaptada para uso com indivíduos com TUS. Nessa demonstração, examino toda a árvore, de baixo para cima, considerando onde as modificações são necessárias, percebendo que o mesmo processo poderia ser usado para visualizar modificações da DBT padrão para qualquer população que não seja a população-alvo original de Linehan. Começando pelas raízes, encontramos os elementos, que permanecem os mesmos. Na DBT para TUS (DBT-TUS), usamos os mesmos princípios de aceitação, mudança e dialética que usamos na DBT padrão. Na verdade, a Oração da Serenidade, uma base do Alcoólicos Anônimos e de outros programas de 12 passos, captura perfeitamente os três paradigmas: “Concede-me a serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para saber a diferença”. As raízes convergem então para o tronco, que representa a meta final da DBT: construir uma vida que valha a pena ser vivida. Novamente, não encontramos diferença entre a DBT padrão e a DBT-TUS. O indivíduo com um TUS, além da desregulação emocional crônica e grave, trabalha com o terapeuta para visualizar e construir uma vida que valha a pena ser vivida, alinhada a uma visão esperançosa do futuro consistente com seus valores. Devido ao papel prejudicial do uso de substâncias na vida desses pacientes, os terapeutas que trabalham com essa população podem enfatizar

o ponto adicional de tentar construir uma vida que valha a pena ser vivida *sem depender de substâncias*.

Começamos a encontrar as modificações significativas quando consideramos os principais galhos da árvore. Conforme observaremos, a temática é que, ramificação após ramificação, os fatores mais próximos do tronco na árvore DBT-TUS são provavelmente bastante semelhantes, senão idênticos, aos fatores próximos do tronco na DBT padrão. Mais modificações são encontradas à medida que nos afastamos do tronco para os galhos secundários e terciários. Começando com o galho das metas (veja a Figura 6.2), descobrimos que as principais metas do tratamento, trabalhadas sequencialmente por meio dos diversos estágios, são os mesmos que na DBT padrão. Ambos os tratamentos, se feitos abrangentemente, passam por: 1) obter comprometimento (pré-tratamento); 2) estabelecer o controle comportamental (estágio 1); 3) adquirir a capacidade de experimentar emoções sem intenso sofrimento (estágio 2); 4) buscar metas individuais e autorrespeito (estágio 3); e 5) aumentar a experiência de liberdade, significado e alegria (estágio 4).

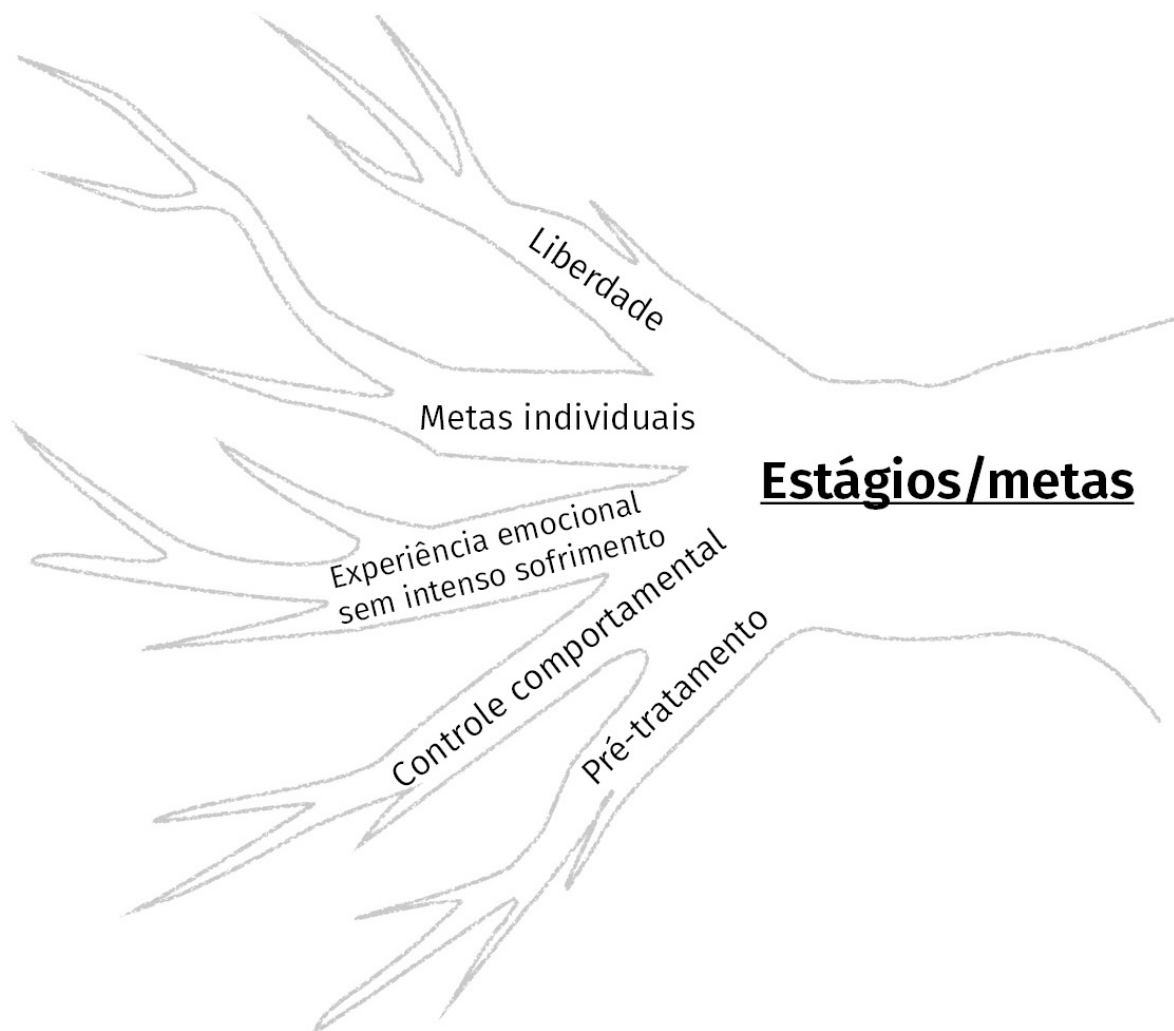


FIGURA 6.2 Metas, estágios e alvos modificados da terapia comportamental dialética para transtornos por uso de substâncias.

Tendo estabelecido que nenhuma modificação é necessária na nomenclatura das cinco metas e estágios, o desafio surge quando decidimos, na agenda de tratamento passo a passo, em qual estágio direcionar o alvo dos comportamentos relacionados ao abuso de substâncias: no estágio de pré-tratamento em que ocorre orientação, acordo e comprometimento?; no estágio 1, em que o descontrole comportamental é abordado?; no estágio 2, em que o sofrimento contínuo é abordado?; no estágio 3, em que problemas da vida são abordados?; ou no estágio 4, em que problemas com liberdade, significado e alegria são abordados? Ter este quadro

para começar ajuda a organizar as questões e descobrir as respostas. Os TUS seriam abordados no pré-tratamento na medida em que haveria uma orientação sobre o tratamento de TUS no programa, acordos sobre as expectativas de padrões comportamentais relacionados a substâncias e o direcionamento desses padrões, e um foco na obtenção do compromisso, o mais forte possível, para reduzir ou abster-se de usar substâncias. Além do pré-tratamento, os TUS são mais comumente abordados no estágio 1, no qual o programa ajuda cada paciente a estabelecer mais equilíbrio, controle e conexão para substituir a instabilidade, a impulsividade e o caos.

No entanto, uma vez que o estágio 1 consiste comumente em trabalhar em quatro categorias de alvos (comportamentos de risco à vida, comportamentos que interferem na terapia, comportamentos que interferem significativamente na qualidade de vida e melhoria de habilidades) a questão permanece sobre onde focalizar os comportamentos relacionados ao abuso de substâncias dentro dessas quatro categorias. Obviamente, se os comportamentos relacionados ao uso de substâncias pertencerem a um padrão de comportamento que ameace a vida iminentemente, eles seriam focados na primeira categoria, a de redução de comportamentos de risco à vida. Embora o uso crônico de substâncias seja um padrão destrutivo que vai degradar a vida e eventualmente poderia resultar em comportamentos de risco à vida, é a exceção e não a regra que o próprio abuso de substâncias seja iminentemente perigoso para a vida. Se os comportamentos relacionados ao abuso de substâncias fizerem parte de um padrão de comportamentos que interferem na terapia, eles seriam focados na segunda categoria, de redução de comportamentos que interferem na terapia. Isso muitas vezes ocorre quando os pacientes rotineiramente perdem sessões porque chegam intoxicados e são incapazes de aproveitar o tratamento, ligam para o terapeuta enquanto intoxicados e,

portanto, não podem usá-lo adequadamente, ou falham em aprender habilidades porque (em sua própria visão) dependem das substâncias para aumentar suas capacidades.

No entanto, na maioria das vezes, descobre-se que o direcionamento dos alvos dos comportamentos relacionados ao abuso de substâncias ocorre na terceira categoria de redução de comportamentos que interferem na qualidade de vida gravemente: padrões comportamentais que erodem contundentemente a possibilidade de resolver problemas de vida, garantindo um caminho em espiral em direção à destruição de esperanças e sonhos. Em geral, o direcionamento dos alvos dos comportamentos relacionados ao uso de substâncias naqueles que concordam em direcioná-los ocorre como a mais alta prioridade no tratamento de comportamentos que interferem na qualidade de vida.

Tendo determinado onde (ou seja, em qual estágio e como parte de qual categoria de alvos de tratamento) localizar o tratamento dos comportamentos relacionados ao uso de substâncias, ainda precisamos especificar os subalvos relacionados ao uso de substâncias que comporão nossa agenda quando tentamos ajudar o paciente a eliminar ou reduzir o uso de substâncias. Não é suficiente simplesmente “reduzir o uso de substâncias”; esse discurso fornece uma meta excessivamente geral. Podemos usar uma estratégia para determinar os subalvos específicos do abuso de substâncias, e essa mesma estratégia pode ser usada ao decompor os comportamentos componentes específicos a serem tratados com outros transtornos, como transtornos alimentares, transtorno da personalidade antissocial, e assim por diante. De fato, aplico essa estratégia para definir a agenda de tratamento para o transtorno de compulsão alimentar no próximo capítulo.

Começamos especificando o comportamento primário a ser reduzido. No caso dos transtornos relacionados ao abuso de substâncias, o subalvo primário é “reduzir ou eliminar o uso”.

Agora, imagine que o paciente tenha parado de usar sua substância principal. Então, provavelmente enfrentaria o desconforto físico da abstinência ou o surgimento de dor física que foi suprimida pela substância. Portanto, o próximo subalvo é “diminuir o desconforto físico”. Indo mais adiante, se o uso da substância tiver sido eliminado e o desconforto físico tiver sido reduzido ou mais bem tolerado, o paciente continuará a enfrentar fissura e impulsos de usar a substância. Portanto, “reduzir fissura e impulsos” se torna o comportamento subalvo que segue “diminuir o desconforto físico”. Se algum desses comportamentos for ignorado ou considerado como resolvido, o paciente corre o risco de retomar o uso ativo da substância. Uma vez que o indivíduo para de usar, diminui o desconforto físico e pode tolerar facilmente a fissura e os impulsos, vários outros subalvos relacionados à substância aparecem em destaque, como reduzir a opção de usar substâncias. Dentro da DBT-TUS, esse tratamento passo a passo de subalvos no uso de substâncias é chamado de “o caminho para a mente límpida”:

- reduzir o uso de substâncias;
- diminuir o desconforto físico associado ao uso de substâncias;
- diminuir fissura, impulsos e tentações de usar substâncias;
- diminuir a opção de usar substâncias;
- diminuir o contato com deixas para o uso de substâncias;
- aumentar o reforço para comportamentos de “mente límpida”;
- atingir a mente límpida (chegar a um estado de espírito resultante do reforço e consolidação de comportamentos de mente límpida).

Para revisar como tudo isso é representado na árvore: os subalvos dentro do caminho para uma mente límpida são mais comumente representados como galhos finos que se estendem a partir do galho, como parte do estágio 1, representando a diminuição de comportamentos que interferem na qualidade de

vida. Embora seja difícil listar todos esses componentes sequencialmente em palavras, a imagem da árvore com seus galhos primários, secundários e terciários vale mais do que mil palavras.

Quando passamos para o galho de funções da árvore da DBT-TUS (veja a Figura 6.3), novamente encontramos basicamente nenhuma modificação nos galhos das cinco funções mais próximas do tronco. Mas à medida que nos estendemos de cada função para os galhos mais finos que representam os modos que “carregam” essas funções, encontramos modificações e acréscimos. Por exemplo, conforme nos movemos de “melhorar capacidades”, onde encontramos os modos típicos de treinamento de habilidades e psicofarmacologia, podemos encontrar modificações no modo de treinamento de habilidades para lidar com certas características típicas daqueles que abusam de substâncias. Quando Linehan, em um relato pessoal, descobriu a taxa extremamente alta de transtornos de ansiedade social entre indivíduos com TUS – o que fez ser desafiador para eles compartilharem suas tarefas de casa em grupo –, ela criou um modo individual para revisão da prática de tarefas, mantendo o ambiente em grupo para o ensino de novas habilidades. Além disso, um “modo de substituição de drogas”, como o uso de metadona e outros agentes químicos para substituir o uso de heroína, foi adicionado à função de melhorar as capacidades. E, ainda, várias habilidades específicas para abuso de substâncias foram adicionadas ao manual e são representadas por acréscimos refinados às habilidades do grupo de treinamento de habilidades.

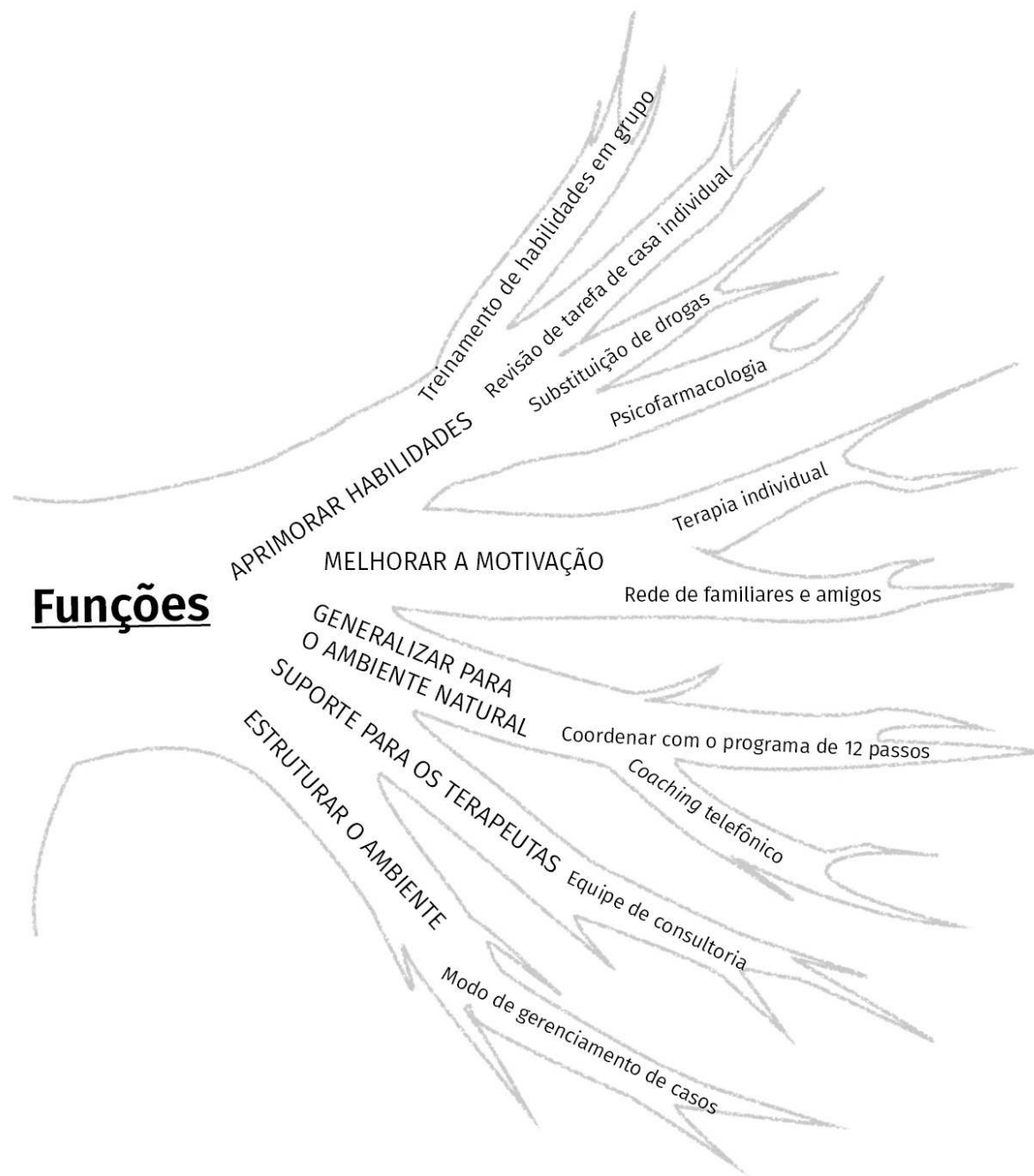


FIGURA 6.3 Funções e modos modificados da terapia comportamental dialética para transtornos por uso de substâncias.

Aprimorar habilidades não é a única função com modificações para o tratamento por uso de substâncias. A função que envolve a estruturação do tratamento, que geralmente é realizada pelo diretor do programa de DBT, é com frequência ampliada por outro modo:

gerenciamento de casos. O gerente de casos ajuda o paciente a estruturar uma vida funcional. Além disso, a estrutura do tratamento pode incluir ainda outro modo, o teste toxicológico aleatório, que é usado para monitorar o progresso. Uma terceira função, a generalização das habilidades para o ambiente natural, que geralmente é realizada por meio de *coaching* telefônico, às vezes é ampliada por meio de colaboração com programas de 12 passos, como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, nos quais o paciente tem um padrinho a quem recorrer em busca de apoio durante a semana. Por fim, estendendo-se a partir do galho que representa a função de melhorar a motivação do paciente, que geralmente é realizada por meio do modo de terapia individual, Linehan (Dimeff & Koerner, 2007, pp. 160-161) acrescentou várias estratégias de apego: uma orientação específica ao paciente sobre o problema de apego, aumento do contato no início da terapia para fortalecer o engajamento, busca ativa pelos pacientes quando eles se perdem do tratamento e construção de conexões com familiares e amigos importantes no início do tratamento. Obviamente, algumas dessas estratégias de apego adicionadas também atendem a outra função: estruturar o ambiente.

As modificações do galho de acordos e do galho de pressupostos e teoria ao adaptar a DBT para TUS são relativamente pequenas e envolvem principalmente o acréscimo de quaisquer pressupostos, acordos e elementos de teoria indicados para direcionar comportamentos relacionados ao abuso de substâncias. Mas as modificações do último galho importante, o galho de estratégias, são significativas e numerosas, identificadas e ilustradas na Figura 6.4. Refiro o leitor a Dimeff e Koerner (2007) para ler sobre as modificações das estratégias para DBT-TUS com mais detalhes. Aqui estão as estratégias:

1. Apego para abordar a deficiência típica na força do apego do paciente que usa substâncias em relação ao terapeuta

(existem várias dessas).

2. Estratégias de reforço arbitrário para reforçar a abstinência.
3. Estratégias de substituição de drogas para reduzir a recaída ao uso da substância primária.
4. Treinamento de habilidades, incluindo o ensino de cada habilidade da DBT aplicada aos comportamentos de uso de substâncias e seis habilidades adicionais adicionadas ao manual para DBT-TUS.
5. Abstinência dialética, referindo-se à modificação das estratégias de comprometimento para o tratamento de TUS.

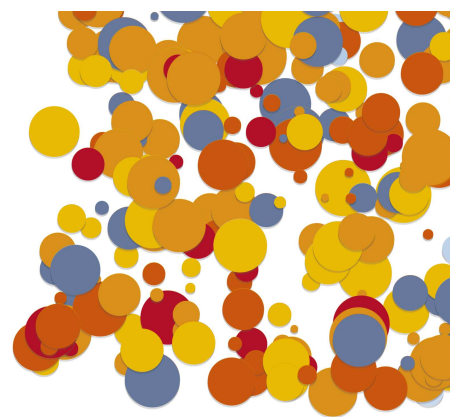


FIGURA 6.4 Estratégias modificadas da terapia comportamental dialética para transtornos por uso de substâncias.

COMENTÁRIOS FINAIS

Ao concluir este capítulo, estou ciente de que esta forma de organizar o pacote completo de tratamento de DBT pode não agradar a todos. No entanto, para fins de compreensão da DBT, destacar as inter-relações de todas as partes, criar um plano para a implementação do programa e orientar as pessoas sobre este tratamento complicado em 30 minutos pode ser inestimável. Assim como fazer um inventário com qualquer lista de verificação, ou como fazer um exame do estado mental nos vários domínios do funcionamento mental, os terapeutas são capazes de identificar áreas de força, fraqueza e deficiência e considerar maneiras de fortalecer o programa. Eu me refiro à metáfora da árvore mais adiante no livro, especialmente ao considerar questões de implementação e de formulação de casos na DBT. ▲

[counselor] N. de R.T.: Os “*counselors*” são uma classe de profissionais da saúde mental nos Estados Unidos que têm licença para tratar questões comportamentais, cognitivas, emocionais e/ou problemáticas relacionadas ao uso de substâncias. Os atendimentos podem ser individuais, de casais, de famílias e em grupos.



Metas, estágios, alvos e hierarquia de alvos prioritários

A resposta de Linehan para o grau substancial de caos, crise e comorbidade característicos de indivíduos com grave desregulação emocional foi estabelecer uma lista clara, com uma hierarquia sequencial e específica de alvos de tratamento comportamentais, conhecida em resumo como “lista de alvos prioritários”. Nas sessões iniciais, terapeuta e paciente colaboram para customizar uma lista de alvos prioritários que servirá como agenda de tratamento. É feita com referência ao modelo de lista de alvos prioritários no manual (Linehan, 2010), que representa o aperfeiçoamento de anos de desenvolvimento e prática de tratamento. É organizada em torno das preferências únicas do paciente, metas para uma vida que vale a pena ser vivida e os obstáculos a essas metas. E é aplicada com uma dose substancial de bom senso, para que a lista seja realista e útil sessão após sessão por semanas, meses, talvez até anos. A lista de alvos deve ser construída para durar. Precisa manter sua forma sob pressão e ao longo do tempo e ser flexível o suficiente para passar por revisões à medida que novas informações surgem. Serve como estrutura temporal da terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*), o plano sequencial de tratamento, tão crucial para o tratamento efetivo quanto a coluna vertebral é para o funcionamento humano. Sem isso, o curso do tratamento pode se desviar ao longo do tempo, mesmo dentro de

uma sessão específica, conduzido por prioridades emocionais em vez de metas comportamentais.

Por mais valioso que seja, o processo de definição de alvos pode interferir no tratamento se for feito de maneira mecânica, muito rígida ou severamente, priorizando a forma do alvo em detrimento da função. Neste capítulo, forneço uma perspectiva profunda e ampla sobre essa estrutura e prática crucial na DBT, para capacitar os terapeutas a estabelecerem ordem a partir do caos e fornecerem uma agenda de tratamento sequencial em meio a preocupações urgentes, enquanto simultaneamente fortalecem a colaboração com o paciente. Depois de examinar mais de perto a natureza do modelo padrão de lista de alvos prioritários, examino como o terapeuta faz o seguinte:

1. Passa da avaliação do paciente para o desenvolvimento colaborativo da lista de alvos prioritários para o tratamento.
2. Usa a lista de alvos prioritários para estabelecer a agenda da sessão no início de cada uma.
3. Provê estrutura nos modos de terapia não individual da DBT (p. ex., treinamento de habilidades em grupo, chamadas de *coaching* telefônico, intervenções de gerenciamento de casos), fornecendo uma lista de alvos prioritários exclusiva para a agenda específica do modo e vinculando a lista do modo à “lista mestra de alvos” criada e usada na terapia individual.
4. Utiliza, como líder de um programa de DBT, o modelo de lista de alvos prioritários para estruturar e manter um programa de DBT viável e abrangente.
5. Modifica, de maneira sistemática, o modelo padrão de lista de alvos prioritários para adaptação da DBT a uma população de pacientes ou a um contexto de tratamento não padrão, de forma a preservar os elementos essenciais do formato padrão enquanto o adapta à circunstância particular.

MODELO DE LISTA DE ALVOS PRIORITÁRIOS

O modelo de lista de alvos prioritários foi discutido no contexto da árvore da DBT (ver Capítulo 6). Para uma breve revisão, há cinco estágios de tratamento, e cada um deles é organizado em torno de uma meta geral. Para alcançá-la, o terapeuta realiza um processo passo a passo para completar um ou mais alvos comportamentais especificamente definidos. Em qualquer ponto do tratamento, o terapeuta e o paciente trabalham em um determinado estágio, focando em uma meta geral; e em qualquer momento durante uma sessão de terapia, o terapeuta e o paciente se concentram em um alvo específico dentro desse estágio. Ter uma lista de alvos clara e detalhada mantém o terapeuta focado em um alvo comportamental de cada vez. Para facilitar a referência, o modelo amplamente conhecido é apresentado a seguir. Note que a meta geral de cada estágio é indicada entre parênteses.

MODELO DA LISTA DE ALVOS PRIORITÁRIOS DA DBT

Alvo global e inerente a todas as etapas (síntese dialética)

Análises dialéticas

Estilo de vida dialético (“caminho do meio”)

Estágio de pré-tratamento (orientação, acordo e comprometimento)

Alvo: aumentar o comprometimento com o plano de tratamento.

Estágio 1 (grave descontrole comportamental → controle comportamental)

Alvo 1: acabar com episódios de comportamento suicida e outros comportamentos que ameaçam a vida.

- Episódios de comportamento suicida e que ameaçam a vida
- Atos deliberados de autolesão, atos agressivos graves
- Aumento significativo na ideação e na comunicação suicidas e agressivas
- Expectativas e crenças relacionadas a suicídio/homicídio
- Processamento emocional relacionado a ideias, impulsos e comunicações de suicídio/homicídio

Alvo 2: reduzir comportamentos do paciente que interferem na terapia.

- Comportamentos de não comparecimento
- Comportamentos não colaborativos
- Comportamentos de recusa
- Comportamentos que interferem com outros pacientes
- Comportamentos que desgastam os terapeutas
 - Forçar os limites do terapeuta
 - Reduzir a motivação do terapeuta para tratar

Reduzir comportamentos do terapeuta que interferem na terapia.

- Comportamentos que desequilibram a terapia
- Comportamentos desrespeitosos

Como priorizar entre comportamentos que interferem na terapia:

1. Comportamentos do paciente ou terapeuta que provavelmente destruirão a terapia
2. Comportamentos do paciente ou terapeuta que estejam interferindo na terapia no momento presente
3. Comportamentos do paciente ou terapeuta funcionalmente relacionados aos comportamentos suicidas
4. Comportamentos do paciente que interferem na terapia semelhantes a comportamentos-problema fora da terapia
5. Falta de progresso na terapia

Alvo 3: reduzir comportamentos que interferem na qualidade de vida.

- Abuso de substâncias
- Sexo de alto risco ou não protegido
- Dificuldades financeiras extremas
- Comportamentos criminosos
- Comportamentos interpessoais seriamente disfuncionais
- Comportamentos relacionados ao emprego ou à escola
- Comportamentos disfuncionais relacionados à doença
- Outros

Como priorizar entre comportamentos que interferem na qualidade de vida:

1. Comportamentos que causam crises imediatas
2. Comportamentos fáceis de mudar em vez de difíceis
 - a. Reforço rápido da solução de problemas ativa
 - b. Fortalecimento da motivação para lidar com problemas mais difíceis
3. Comportamentos funcionalmente relacionados a alvos de ordem superior (autolesão, suicídio, interferência na terapia)

Alvo 4: aumentar as habilidades comportamentais.

- Habilidades de tolerância ao mal-estar
- Habilidades de regulação emocional
- Habilidades de efetividade interpessoal
- Habilidades centrais de *mindfulness*
- Habilidades de autogerenciamento

Estágio 2 (desespero silencioso → experimentação emocional sem intenso sofrimento)

Alvo 5: reduzir o desespero silencioso.

- Reduzir transtornos mentais residuais (transtornos do humor, transtornos de ansiedade, transtornos de controle de impulsos, etc.).
- Reduzir sequelas da invalidação na infância.
- Reduzir estado de exclusão social indesejado (vergonha, sensibilidade, raiva, solidão).
- Reduzir o luto inibido/o vazio/o tédio.

Enquanto busca

- Experimentação emocional sem intenso sofrimento
- Conexão com o ambiente
- Sentido de “bondade” essencial
- Sentido de validade pessoal

Estágio 3 (problemas na vida → felicidade e infelicidade comuns)

Alvo 6: aumentar o autorrespeito.

Alvo 7: reduzir problemas individuais na vida.

Estágio 4 (incompletude → liberdade)

Alvo 8: aumentar a liberdade.

- Consciência expandida
- Experiências culminantes e fluxo
- Satisfação espiritual

METÁFORA DA “CASA DE TRATAMENTO”

Assim como a árvore da DBT, há outra metáfora muito útil, desenvolvida por Linehan, em relação à estruturação da DBT em torno do modelo de alvos prioritários. Esse modelo fornece ao terapeuta o nível necessário de detalhe e ordem para estabelecer a lista de alvos com o paciente e definir a agenda da sessão. A metáfora da casa de tratamento tem se mostrado útil para terapeutas, pacientes e seus familiares ao vislumbrar o fluxo do tratamento do início ao fim, de estágio em estágio. Durante um ano sabático em 1990-1991, no qual estava escrevendo a primeira edição de seu manual de tratamento e livro de treinamento de habilidades, Linehan passou três meses no *campus* de nosso hospital, o New York Hospital-Cornell Medical Center, em White Plains, Nova York. Atuou como consultora em nosso programa de DBT para pacientes internados, que ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Ela morou no local, diretamente em frente à residência de minha família, e todos os dias ia para o nosso programa. Encontrou-se com funcionários e pacientes, revisou e deu *feedback* sobre nosso programa, entrevistou pacientes para nos mostrar como fazer várias estratégias e, às vezes, ajudou a ensinar em nossas sessões de treinamento de habilidades. Durante uma dessas sessões, um paciente perguntou se Marsha poderia fornecer uma visão geral de todo o processo de tratamento. Ela respondeu desenhando a “casa de tratamento da DBT”. Para ela, parecia uma ilustração “rápida e rasurada” para responder à pergunta; para mim e, eventualmente, para nosso programa, tornou-se uma ferramenta padrão para orientação à DBT, e a incorporamos em nosso processo de avaliação. Como metáfora, serve como um modelo para visualizar todo o protocolo de tratamento; para discutir perspectivas diferentes sobre metas, estágios e alvos; e para mostrar com

habilidade como colaborar com pacientes específicos para “se encontrarem” na hierarquia de alvos. Eu ensinei essa metáfora, da maneira como a desenvolvemos, para gerações de terapeutas e desenvolvedores de programas de DBT, e eles acharam útil todas as vezes. Observe a Figura 7.1 enquanto explico a metáfora.

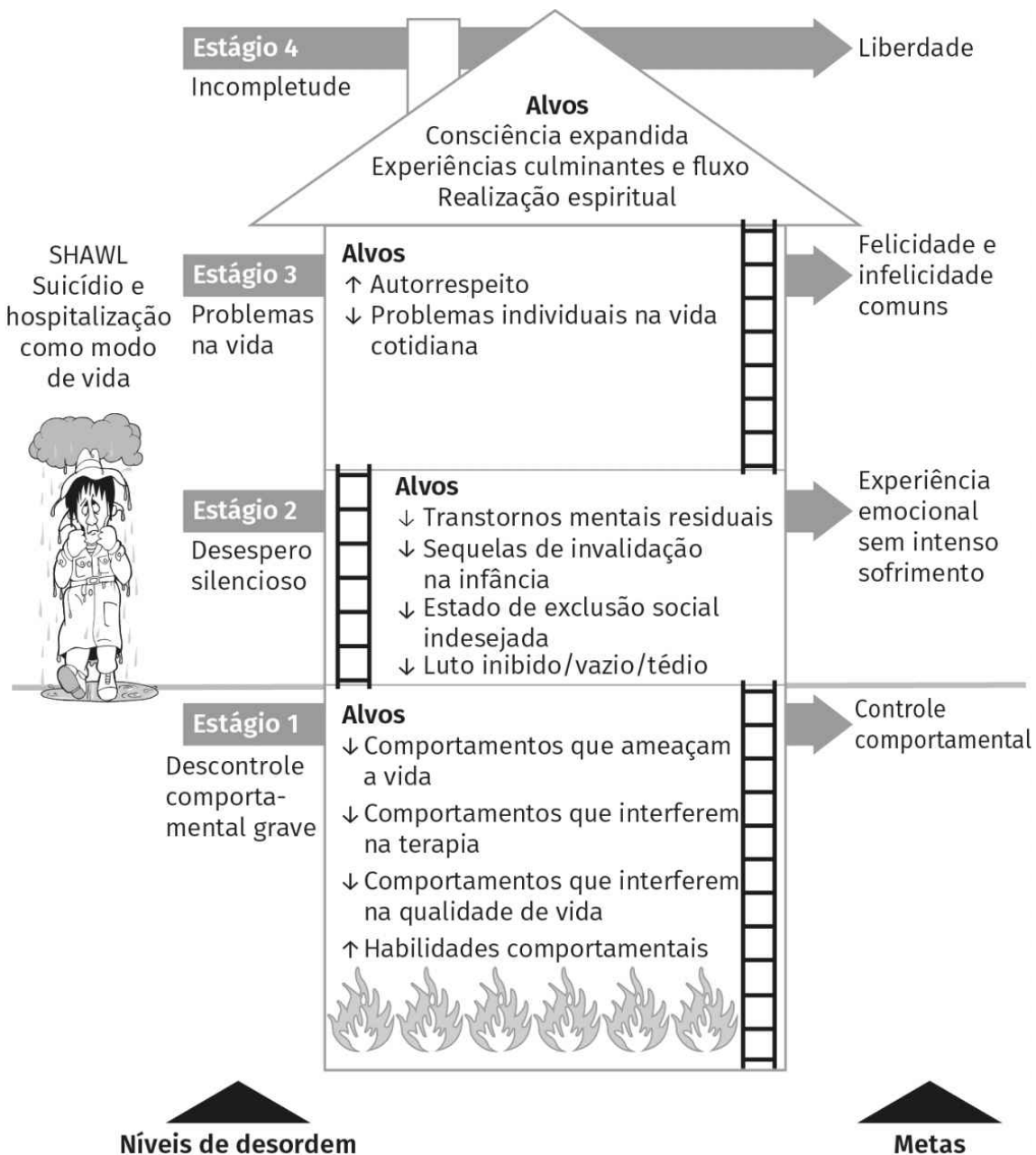


FIGURA 7.1 Casa de tratamento da DBT. Adaptada com permissão de Marsha M. Linehan.

Com seus diferentes andares, a casa representa as metas e os estágios da DBT. O pré-tratamento ocorre do lado de fora da casa, o lugar onde os pacientes são orientados sobre o que acontece na casa, aprendem sobre os acordos e as expectativas e são solicitados a se comprometerem com o trabalho que acontece na casa, começando no porão e subindo até o terceiro andar. O terapeuta usa estratégias de contrato e comprometimento nesse estágio, com o objetivo de fazer os pacientes se comprometerem o máximo possível com o tratamento. Quando ensinei a casa de tratamento em um treinamento intensivo de DBT em 1999, um participante imaginativo (Erik Thompson) adicionou uma peça à metáfora. Ele desenhou uma pessoa do lado de fora, próxima à casa, na terra, com um xale (em inglês, *shawl*) em volta do pescoço para protegê-la das condições climáticas. Uma chuva torrencial está caindo, tornando o xale insuficiente: uma cena que faz a casa parecer mais convidativa. Usando a palavra SHAWL como um acrônimo, ele sugeriu que alguns pacientes considerando DBT têm usado comportamentos suicidas e hospitalização como modo de vida (do inglês *suicide and hospitalization as a way of life*).

Depois de passar pelo pré-tratamento, a maioria dos pacientes avança para o estágio 1, que é retratado como o porão. No porão, o paciente experimenta reatividade emocional intensa e muito sofrimento e regula as emoções com comportamentos que ameaçam a vida, arruinam o tratamento e/ou destroem a qualidade de vida. O porão é ilustrado com chamas saindo do chão, que representam a sensação de queimar no inferno. Indivíduos no porão obtêm apenas alívio temporário de certos padrões comportamentais problemáticos, como autolesão ou abuso de substâncias, e alguns enxergam o suicídio como a única saída. Mas há outro caminho para sair, representado por uma escada que se estende do chão do porão até o teto, levando ao primeiro andar. Esta é a escada de habilidades e comprometimento; eu visualizo

os degraus da escada como as habilidades necessárias para sair do porão, e os dois trilhos que mantêm os degraus no lugar como o comprometimento necessário para continuar. Cada degrau da escada representa o uso de comportamentos adaptativos, substituindo gradualmente os comportamentos problemáticos. O objetivo geral de subir do porão para o primeiro andar representa a substituição de uma grave desregulação e falta de controle comportamental por um controle comportamental. Chegar ao topo daquela escada representa ter vencido os quatros alvos do estágio 1, diminuindo 1) comportamentos que ameaçam a vida, 2) comportamentos que interferem no tratamento, 3) comportamentos graves que interferem na qualidade de vida e 4) aumentando o uso de habilidades.

Chegar ao topo da primeira escada requer controle comportamental, mas não elimina o sofrimento que motivou os comportamentos problemáticos em primeiro lugar. Por essa razão, muitos pacientes chegam ao topo da escada do porão, percebem que a dor intensa ainda permanece e, portanto, “descem de volta ao porão”, voltando aos comportamentos problemáticos recentemente abandonados. A metáfora captura muito bem o dilema clínico, ajudando pacientes e terapeutas a verem a necessidade de “manter-se firme” à medida que sobem mais alto na escada.

Quando o paciente chega ao primeiro andar da casa, ele atingiu o estágio 2 da DBT, cujo objetivo é ser capaz de experimentar emoções intensas de maneira não traumática. Participar das tarefas do estágio 2 pode ser doloroso (p. ex., em alguns casos, envolve o processamento de memórias e emoções traumáticas) e deve ocorrer em uma base sólida de habilidades e comprometimento construída durante o estágio 1. Caso contrário, o estágio 2 pode catalisar um desliz de volta ao porão. Essa necessidade de desenvolver habilidades e manter o controle

comportamental durante o estágio 2 pode ser representada por “cobrir bem” o buraco onde a escada termina no primeiro andar.

Outra escada do primeiro andar, estágio 2, para o segundo andar, leva os pacientes ao início do estágio 3. A natureza da escada no estágio 2 varia de caso a caso, dependendo das principais fontes de sofrimento. Quando o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) desempenha um papel principal, subir a escada representa o tratamento de exposição prolongada. É mais bem definido até o momento no trabalho de Melanie Harned, que sintetizou a terapia de exposição prolongada de Edna Foa com a DBT de Linehan (Harned, Korslund, & Linehan, 2014). Nesse protocolo de tratamento do estágio 2, Harned e colegas recomendam que o terapeuta de um paciente que “desce a escada” para os comportamentos problemáticos do estágio 1 volte temporariamente para as metas e os métodos do tratamento do estágio 1, até que o paciente restabeleça o controle comportamental.

(A propósito, observe que a metáfora da casa de tratamento pode ser um pouco confusa, uma vez que o primeiro andar corresponde ao estágio 2, o segundo andar corresponde ao estágio 3, e assim por diante.)

O paciente que conclui o estágio 2 reduziu a intensidade do sofrimento e aumentou sua capacidade de experimentar emoções sem intenso sofrimento. Então ele pode se concentrar no estágio 3, que ocorre no segundo andar da casa. A meta do estágio 3 é dupla: estabelecer ou restabelecer o autorrespeito e buscar a realização de metas individuais na vida, sejam quais forem. Os métodos de tratamento no estágio 3 (subir a escada para o próximo andar) são menos definidos, em si, e dependem significativamente da natureza das metas individuais. Em termos gerais, a avaliação baseada na terapia cognitivo-comportamental (TCC) e na solução de problemas desempenharão um papel central, complementado por abordagens orientadas para a

aceitação e dialéticas, conforme necessário. Para alguns pacientes, o trabalho da DBT termina com a solução de problemas que ocorre no estágio 3.

O indivíduo que avança para o estágio 4, representado no terceiro (mais alto) andar da casa, busca maior liberdade, significado e alegria sustentada. Os métodos do estágio 4 são os menos definidos de todos os estágios até o momento, mas dependem muito da teoria e da prática de *mindfulness*. A realização das metas do estágio 4 exigirá a manutenção do trabalho realizado desde o porão até o topo. Seja tentando sair do inferno ou chegar ao topo da casa, os três paradigmas da DBT (*mindfulness*, comportamentalismo e dialética) fornecem um vocabulário extraordinariamente poderoso de opções.

Utilizada com pacientes em tratamento, a metáfora pode ser esclarecedora e motivadora. Eles podem facilmente ver que a DBT é um tratamento baseado em estágios e que cada andar da casa representa um passo necessário no caminho para uma vida que valha a pena ser vivida. Para pacientes com descontrole comportamental que entram na DBT querendo pular imediatamente para o processamento de memórias traumáticas, eles podem ver que o processamento de trauma é central para a DBT (no estágio 2), mas que o tratamento deve começar com a construção de uma base de regulação emocional habilidosa. Ver partes do tratamento e sua totalidade em um único diagrama ajuda a orientar os pacientes e a eliciarem um compromisso com o tratamento como um todo.

Seguindo o velho ditado “uma imagem vale mais do que mil palavras”, a metáfora também pode desempenhar um papel significativo na avaliação. Em nosso programa de DBT para pacientes internados, apresentamos a metáfora a cada pessoa recém-admitida. Entregávamos um diagrama da casa e pedíamos ao paciente para desenhar um boneco de palito para representar sua localização na casa de tratamento. Isso levou a algumas

reflexões significativas e até mesmo diálogos transformadores. Uma de nossas pacientes, que tinha uma história traumática terrível e para quem episódios de dissociação eram frequentes e debilitantes, se colocou no andar do porão. Ela desenhou uma caixa quadrada no canto do porão e se colocou dentro dela. Ela explicou que o porão estava “insuportavelmente quente” e que havia encontrado um local toleravelmente fresco dentro da caixa, algo como uma área de refrigeração. Ela relacionou o desenho a seus episódios de dissociação, durante os quais encontrava alívio da dor emocional constante. Ao mesmo tempo, reconheceu que o alívio era temporário, que quando saía da caixa ainda estava no inferno, no porão, sem fazer nenhum progresso. Começamos a discutir com ela o desafio de tolerar habilmente o “calor” e o sofrimento sem entrar na caixa de refrigeração e dissociação.

Outra de nossas pacientes tinha um transtorno alimentar. Ela estava decidida na busca pela magreza e usava os comportamentos habituais da anorexia e da bulimia nervosa para alcançar seu objetivo. Uma excelente aluna na faculdade, ela gerenciava suas emoções intensas e sua quase intolerável sensação de imperfeição, mesmo enquanto tirava boas notas, controlando sua alimentação. Ocasionalmente, seus comportamentos relacionados ao transtorno alimentar fugiam do controle, e ela descia de sua posição como excelente e bem-sucedida estudante universitária para um mundo de compulsão alimentar, purgação, ideação suicida, episódios de comportamentos suicida, negligência consigo mesma e impulsividade. Ela entrava no hospital e foi duas vezes enviada para o nosso programa de internação. Quando foi orientada para a casa de tratamento e solicitada a se localizar nela, ela adicionou um retângulo alto que se juntava ao lado direito da casa. Era estreito e se estendia desde o fundo do porão até o topo do segundo andar. Ela explicou que o retângulo representava um elevador expresso, feito de vidro, que corria entre o porão e o

segundo andar. No segundo andar, ela perseguia metas bem definidas como estudante universitária, enquanto, no porão, experimentava desregulação emocional e falta de controle comportamental, acompanhados de ódio de si mesma. Ela demonstrou claramente seu padrão de ir e vir entre o porão e o segundo andar, entre o inferno e o sucesso universitário. Todos nós pudemos ver, assim como ela, que ela nunca parou no primeiro andar, no qual o tratamento do sofrimento, incluindo o ódio de si, ocorre por meio de exposição e outros métodos. Essa ilustração tangível a ajudou a aceitar que precisava trabalhar mais para estabelecer estabilidade, tolerar o mal-estar e cumprir o estágio 2.

CHEGANDO À LISTA DE PRIORIDADES DIALETICAMENTE

A clareza cristalina de Linehan sobre a lista de alvos prioritários e como usá-la pode parecer fácil. Alguns terapeutas podem negligenciar o fato de que estabelecer a lista de alvos de um paciente não pode ser efetivamente feito simplesmente encaixando os comportamentos-problema do paciente nos lugares certos do modelo. Essa abordagem não se atenta ao fato de que a lista deve ser construída colaborativamente, consistente com a abordagem em estágios da DBT e feita com cuidado e atenção ao que funcionará para o paciente. Impor uma lista de alvos simplesmente não funcionará. Na verdade, trabalhar com o paciente para criar uma lista viável de alvos prioritários é uma oportunidade para 1) ensinar uma maneira eficaz de abordar problemas, 2) construir o relacionamento e 3) modelar os princípios essenciais da DBT. A elaboração da lista de alvos não é uma “preparação” para o tratamento; é o próprio tratamento.

Podemos conceituar esse processo como uma busca por sínteses de duas dialéticas diferentes. A primeira é a dialética abrangente sobre o que está impulsionando a agenda do tratamento: a busca das metas do paciente *versus* a solução dos problemas do paciente. A segunda é uma dialética que emerge quando terapeuta e paciente colocam os vários alvos em uma ordem específica. O terapeuta normalmente se refere ao modelo de alvos prioritários da DBT para chegar racionalmente à ordem de prioridades, enquanto o paciente provavelmente defenderá uma agenda que prioriza a rápida redução da dor emocional. Com relação a cada uma dessas duas dialéticas, o terapeuta trabalha em direção a uma síntese que inclui a validade de ambos os lados.

No que diz respeito à primeira dialética, a agenda do tratamento precisa ser impulsionada pela busca do paciente pelas metas de

uma vida que valha a pena ser vivida, mas também pela redução sequencial de comportamentos disfuncionais. Focar principalmente nas metas, expressas como esperanças, sonhos e etapas práticas, pode contribuir para o otimismo, mas também pode subestimar os problemas a serem resolvidos. Focar principalmente nos comportamentos problemáticos pode levar a uma agenda de trabalho concisa e detalhada, mas pode desencorajar o paciente durante o processo, já que ele começa a sentir que o ponto do tratamento é se concentrar nos problemas em vez de construir uma vida satisfatória. As listas de alvos prioritários mais bem elaboradas são sínteses das metas mais desejadas pelo paciente e dos problemas que estão no caminho.

Eu geralmente começo o tratamento provocando e explorando as metas do paciente, como detalhado no primeiro capítulo, sobre a conversa sobre a vida que vale a pena ser vivida. Ao usar essa perspectiva, os problemas podem ser vistos como dificuldades que interferem na realização das metas. Em geral, registro a dialética em um pedaço de papel. Eu desenho uma linha no meio e, à esquerda, listo as metas articuladas pelo paciente. À direita, listo todos os problemas que foram identificados nas sessões de avaliação e na documentação de provedores de tratamento anteriores. A lista de problemas costuma ser excessivamente inclusiva, com problemas identificados por outros, mas não relevantes para o próprio paciente. Em seguida, o paciente e eu olhamos juntos para as duas listas e esclarecemos quais metas são mais importantes para ele. Olhamos para todos os problemas e consideramos quais interferirão verdadeiramente na realização dessas metas. Dessa forma, a síntese consiste em um processo colaborativo, criando a agenda impulsionada pelas metas do paciente, mas também revestida dos seus comportamentos problemáticos. É mais motivador reduzir o uso de álcool por ser algo direcionado pelos seus valores, suas esperanças e sonhos

concretos, do que reduzir o uso de álcool como um fim em si mesmo.

A primeira dialética surge na determinação do que está na agenda de tratamento; a segunda envolve a ordenação específica de alvos. Por um lado, a ordem priorizada deve estar alinhada com o modelo apresentado anteriormente no capítulo. Por exemplo, comportamentos que ameaçam a vida devem ter prioridade sobre comportamentos que interferem na terapia. Por outro lado, as prioridades devem estar alinhadas com o desejo do paciente de reduzir a dor e construir uma vida que valha a pena ser vivida. Ambas as abordagens são válidas, mas às vezes levam a prioridades conflitantes. Por exemplo, não é incomum os pacientes chegarem à terapia querendo começar processando as memórias traumáticas da vida anterior. Eles podem argumentar que isso é a causa de todos os seus comportamentos problemáticos e, portanto, deve ser abordado imediatamente. É compreensível. É igualmente compreensível que, como terapeutas, estamos cientes de que pode ser contraproducente abordar o trauma de forma muito explícita antes que os pacientes tenham adquirido alguma capacidade de regulação emocional. Os terapeutas provavelmente darão prioridade à tarefa de obter melhores controle comportamental e regulação emocional antes de mergulharem explicitamente nas memórias traumáticas. A diferença entre essas duas perspectivas pode se tornar arraigada. No entanto, se pensarmos dialeticamente, veremos a sabedoria do desejo de cada paciente de prosseguir com o trabalho traumático, ao mesmo tempo em que reconhecemos a sabedoria de começar a estabelecer estabilidade e segurança por meio da construção de habilidades. Cada caso provavelmente será diferente.

Anos atrás, comecei a trabalhar com um garoto de 16 anos, encaminhado pelos pais e pelo orientador educacional por uma série de problemas: explosões de raiva durante as quais ele danificava o quarto, comportamentos de autolesão, uso excessivo

de álcool, afastamento recente dos amigos, baixa crítica sobre relacionamentos sexuais promíscuos, conflito com a família, depressão e desempenho escolar ruim. Parecia que o uso de álcool desempenhava um papel importante em seus outros problemas. Ele fugia de casa nos finais de semana, ia a festas da universidade local, ficava bêbado, às vezes com “apagões”, e acordava em quartos de estranhos sem lembrar de como havia chegado lá, ou era acordado no gramado pela polícia do *campus*. Ele brigava nas festas e às vezes sofria ferimentos significativos sobre os quais mentia para os pais. Descobri que ele havia sido “demitido” de três terapias anteriores porque se recusava a parar de beber.

Dado o quão desencorajado ele havia se tornado, inicialmente nos concentramos no que o faria sentir que sua vida valia a pena. Nos últimos quatro anos, ele achava que sua vida era um turbilhão interminável de empolgação, caos, segredo, autodestruição e perda total do “garoto positivo” que costumava ser. Apesar de seu “eu positivo” ter sido “enterrado”, como disse, ele conseguiu, com encorajamento e reforço repetido da ideia de si mesmo como uma pessoa capaz, lembrar e endossar alguns objetivos que tinha aos 12 anos: ter sucesso na escola, ter amigos melhores, eventualmente frequentar a faculdade e, por fim, conseguir um emprego ajudando outras pessoas. Ao mesmo tempo, ele queria continuar “se divertindo”: ir a festas em repúblicas da faculdade, conhecer garotas, beber álcool e fazer sexo.

Nós construímos as listas de metas e problemas. Concordamos com a maioria dos itens da sua lista de alvos e com a ordem de prioridade dos alvos, salvo uma exceção. Discordamos profundamente sobre o seu uso de álcool. Enquanto eu estava certo de que seus episódios de bebedeira contribuíam enormemente para sua falta de crítica, suas experiências dolorosas, alienação dos colegas, depressão e piora do desempenho escolar, ele não enxergava dessa forma. “Eu amo

álcool, eu realmente amo, e não vou parar.” Ele concordou que queria parar de “fazer coisas estúpidas”, como ele disse, incluindo “fazer coisas estúpidas” enquanto estava bêbado, mas não queria reduzir a quantidade de bebida. Chegamos a uma síntese que nos permitiu avançar com a seguinte lista de alvos prioritários:

LISTA DE ALVOS PRIORITÁRIOS PARA UM PACIENTE COM COMPORTAMENTO DE AUTOLESÃO E ABUSO DE ÁLCOOL

Estágio de pré-tratamento: aumentar o comprometimento.

- Fortalecer o foco em uma vida que valha a pena ser vivida.
- Fortalecer o compromisso com o plano de tratamento.

Estágio 1: aumentar o controle e a estabilidade comportamental.

- Diminuir comportamentos de autolesão.
- Manter o registro de comparecimento às sessões excelente.
- Aumentar comportamentos de colaboração com o terapeuta.
- Manter o registro de comparecimento às sessões de grupo de habilidades excelente.
- Diminuir explosões de raiva com danos ao quarto.
- **(Diminuir o uso de álcool.)**
- **Parar de fazer “coisas estúpidas”.**
 - Parar de dirigir bêbado.**
- **Parar de fazer escolhas ruins em relação ao sexo (especialmente quando bêbado).**
- Fortalecer a frequência e o desempenho escolar.

- Começar a reunir informações sobre faculdades.

- Aumentar a quantidade e a qualidade de amizades.

Estágio 2: aumentar a capacidade de experimentar emoções de forma adaptativa.

- A ser definido conforme aprendemos mais.

Nossa “lista de alvos prioritários de trabalho” inicial sintetizou metas e problemas, bem como a “agenda” do paciente e a minha. As áreas de discórdia na lista estão em negrito. Concordamos em incluir “diminuir o uso de álcool”, mas colocá-lo entre parênteses indica que é um alvo que eu propus, mas com o qual ele não concordou. Incluímos “parar de fazer coisas estúpidas”, já que ele queria acabar com esse comportamento, mas sem nenhuma redução no consumo de álcool. Na prática, concordamos em não direcionar formalmente o uso de álcool, mas mantê-lo sob avaliação. Monitoraríamos o impacto do uso de álcool em outros alvos. Foi uma síntese.

É desnecessário dizer que foi um desafio chegar a um plano de tratamento para “parar de fazer coisas estúpidas” sem direcionar diretamente o uso excessivo de álcool. Mas foi exatamente isso que fizemos. Eu brinquei com ele, dizendo que se desenvolvêssemos uma terapia que ajudasse as pessoas a pararem de fazer coisas estúpidas quando bebiam, permitindo que continuassem bebendo, poderíamos comercializá-la e ganhar milhões. Prosseguimos para desenvolver um conjunto de diretrizes, algo como um “minimanual”, para encontrar maneiras de parar de fazer coisas estúpidas quando ele fosse a festas e bebesse. Subdividimos seus episódios de consumo de álcool em três partes e criamos estratégias e habilidades para cada parte: o que ele poderia fazer antes da festa, durante a festa e depois. Eu

disse que trabalharia com ele nesse plano sob duas condições: 1) ele não dirigiria se tivesse bebido; e 2) se não houvesse mudança em “fazer coisas estúpidas” após três meses, eu interromperia o tratamento.

Ele concordou com ambas as condições e parecia ansioso para começar. Parou completamente de se cortar quase imediatamente, compareceu fielmente às sessões individuais e em grupo, e seu desempenho escolar melhorou. Ele continuou a fazer “coisas estúpidas”, não mostrou mudança em seu consumo de álcool, e, após três meses, houve pouca mudança no padrão. Ele ficou triste quando disse a ele que, de acordo com nosso acordo, eu tinha que parar o tratamento. Cerca de três meses depois, sem tê-lo visto desde que paramos, ele me ligou: “Charlie, acho que sou alcoolista. Posso ir te ver?”. Começamos a trabalhar em seu alcoolismo. Em questão de meses, ele parou de beber, estava frequentando reuniões do Alcoólicos Anônimos, indo bem na escola, começando a procurar faculdades e, na psicoterapia, abordando as maneiras pelas quais ele respondia a um contexto familiar e social inválido adotando um estilo de vida secreto, renegado e abusador de substâncias.

Olhando para trás, acredito que estabelecemos a base para o sucesso desse tratamento em nossa abordagem honesta e difícil no estágio de pré-tratamento, incluindo a conversa sobre uma vida que vale a pena ser vivida, que reavivou suas memórias de esperanças e sonhos anteriormente enterrados, e o cuidadoso processo dialético de estabelecer a lista de alvos prioritários. Nossas diferenças em relação ao que direcionar e em que ordem foram transparentes; a lista de alvos na qual chegamos a um acordo representou uma síntese, de forma que ambos poderíamos “tomar responsabilidade”; e a agenda do tratamento ficou clara enquanto prosseguíamos. Concordamos em discordar sobre o consumo de álcool, dando-lhe um *status* especial ao monitorá-lo, mas não tê-lo como alvo direto. Ao estabelecermos condições com

um prazo limite, ele eventualmente foi convencido, pela experiência, se não pela conversa, de que seu consumo de álcool precisava ser trabalhado. Se tivéssemos evitado o reconhecimento das diferenças e não procurado uma síntese em uma lista de alvos prioritários, essas diferenças poderiam facilmente ter levado a um impasse, resultando em um fim prematuro, como já havia acontecido.

USANDO A LISTA DE ALVOS PRIORITÁRIOS PARA ESTABELECEER A AGENDA DA SESSÃO

No que diz respeito à DBT com cada paciente, envolvendo uma “declaração de missão” de longo prazo – a imagem de uma vida que vale a pena ser vivida, dividida em um “plano estratégico” composto por uma lista de alvos prioritários de tratamento perseguidos em estágios – pode-se dizer que se assemelha a uma empresa. O tratamento dos alvos comportamentais específicos é monitorado e executado em uma reunião semanal (terapia), cuja agenda é impulsionada pelos alvos de maior prioridade do momento. O terapeuta colabora com o paciente na definição da agenda no início de cada sessão, em um processo de direcionamento de alvos.

Após a saudação inicial e um breve, mas importante período de *check-in*, que pode durar de 30 segundos a vários minutos, o terapeuta pede o diário. O cartão é um registro, a ser preenchido diariamente, da ocorrência dos alvos do paciente, incluindo o uso de habilidades. É o “boletim escolar” da semana. Há maneiras mais e menos eficazes de revisar o cartão diário. Ele apresenta oportunidades não apenas para preparar o terreno para a sessão, mas também para fazer a “terapia do diário”, isto é, envolver o paciente em uma prática significativa, modelando os princípios de tratamento e fortalecendo o relacionamento terapêutico. Consistente com os princípios comportamentais, a revisão deve ser disciplinada, focada em alvos e prática – um laboratório para a prática da função executiva: manter metas maiores em mente, lembrar com precisão, monitorar-se consistentemente e reforçar confiavelmente comportamentos em foco. Consistente com os princípios da aceitação, é uma oportunidade perfeita para encorajar o *mindfulness* nas metas do tratamento, validar a dor que resulta em comportamentos-alvo, validar a dificuldade de

permanecer na linha certa e incentivar as capacidades do paciente para completar o diário. Se o terapeuta puder equilibrar os princípios da mudança e da aceitação e usar intervenções dialéticas conforme necessário, a revisão do diário pode resultar em um relacionamento mais forte. Tudo isso exige envolver ativamente o paciente durante toda a revisão, em vez do processo bastante comum em que o terapeuta revisa silenciosamente o cartão e, em seguida, propõe uma agenda de sessão. Com o tempo, o processo de preencher o diário todos os dias e revisá-lo todas as semanas cria uma infraestrutura para consistência e solução de problemas. É o aspecto da DBT que se assemelha às tarefas muitas vezes onerosas da vida doméstica, escolar e profissional que são tão desafiadoras para aqueles com grave desregulação emocional. Se o paciente não conseguir preencher o cartão de forma eficaz ou não o preencher, é uma oportunidade para o terapeuta avaliar e tratar quaisquer comportamentos problemáticos que contribuam para a não conclusão.

Depois de revisar o diário, o terapeuta passa a definir a agenda para a sessão, que é uma forma de responder à pergunta: “Em que alvo(s) trabalharemos hoje?” Por exemplo, eu poderia começar essa breve discussão dizendo: “Considerando que ainda estamos tentando controlar os comportamentos de autolesão, vamos avaliar e trabalhar os fatores que levaram ao episódio de se cortar na quarta-feira, tudo bem?”. E então eu provavelmente adicionaria: “Há mais alguma coisa que você queira falar hoje?”. Entre nós dois, chegaremos a uma agenda orientada por diversos fatores: comportamentos relatados no diário; informações que podem ter chegado a mim durante minha reunião com a equipe de consultoria, na qual ouvi sobre outros modos de tratamento naquela semana; e desejos adicionais do paciente. Criaremos uma agenda de dois ou três itens, raramente mais, incluindo o que precisamos discutir e o que o paciente gostaria de discutir, usando a lista de alvos prioritários do tratamento para estabelecer a ordem

de prioridade. Assim que a agenda estiver definida, passamos a trabalhar o primeiro alvo da sessão, que provavelmente começará com uma análise em cadeia do comportamento. Durante o curso da sessão, é claro, mais informações podem surgir que acrescentem outro item à lista de alvos do dia ou alterem a ordem de prioridade dos alvos na agenda.

Conforme a terapia avança ao longo dos meses, a lista de alvos requer cuidado e atenção. De tempos em tempos, ela precisa ser revisada à medida que alguns alvos são alcançados, novos alvos são adicionados à lista e a ordem de prioridade pode mudar à medida que mais informações surgem. Por exemplo, enquanto o uso excessivo de substâncias pode ter sido trabalhado no início da terapia como um comportamento que interfere na qualidade de vida, pode ascender na lista de alvos para a categoria de comportamentos que interferem na terapia se o terapeuta descobrir que o paciente tem chegado intoxicado às sessões. Ele pode possivelmente subir na lista para um comportamento que ameaça a vida se vier à tona que os episódios de comportamento suicida ou homicida do paciente estão rotineiramente associados ao uso de substâncias. Os aspectos estruturais da DBT, incluindo o uso do diário, a adesão aos acordos e o direcionamento de alvos formal ao final da revisão do diário, podem sofrer desvios durante o tratamento. Estruturas que poderiam ser mantidas com rigor no início, quando o relacionamento era novo, podem ser desafiadoras de manter à medida que a familiaridade entre paciente e terapeuta cresce. Ambas as partes podem facilmente deixar as estruturas desaparecerem à medida que cada um sente que “sabe” o que precisa ser feito sessão após sessão. Manter as estruturas do tratamento requer um tipo de disciplina que às vezes incomoda ambas as partes. Em minha experiência, a disciplina compensa na maioria das vezes e não precisa interferir no desenvolvimento de um vínculo poderoso, que também é fundamental na DBT.

Uma vez tratei uma jovem que, enquanto morava em outro país, havia entrado para uma gangue violenta, sido maltratada pelos membros da gangue e fisicamente abusada, inclusive torturada, pelo marido. Ela escapou do marido e da gangue, o que a colocou em grande perigo. Mudou-se para a área onde eu estava trabalhando e iniciou o tratamento comigo. Ela apresentava TEPT, com presença marcante de sintomas de memórias intrusivas, pesadelos, perturbação do sono, hipervigilância (embora isso parecesse realista) e um medo intenso de deixar seu apartamento. Ela se autolesionava com cortes nos braços todos os dias. Usava substâncias, em especial maconha e ocasionalmente cocaína, para regular suas emoções. Naturalmente, tendia a desconfiar das pessoas, o que incluía a mim. No final da avaliação, quando consideramos suas metas de vida e seus comportamentos problemáticos, estabelecemos a seguinte lista de alvos prioritários do tratamento:

LISTA DE ALVOS PRIORITÁRIOS PARA UMA PACIENTE COM TEPT, AUTOLESÃO E USO DE SUBSTÂNCIAS

Alvos pré-tratamento.

- Aumentar o comprometimento com o plano de tratamento.

Diminuir comportamentos que ameacem a vida.

- Diminuir a autolesão.

Diminuir comportamentos que interfiram na terapia.

- Aumentar a disposição para compartilhar informações com o terapeuta.

Diminuir comportamentos que interfiram na qualidade de vida.

- Diminuir o uso de cocaína.
- Diminuir o uso de maconha.
- Diminuir a evitação da vida comunitária.
- Aumentar relacionamentos sociais seguros.
- Aumentar esforços para conseguir um emprego.

Aprimorar habilidades.

- Aumentar a tolerância ao mal-estar, a regulação emocional, a efetividade interpessoal e as habilidades de *mindfulness*.
- Aumentar habilidades de autogerenciamento.

Diminuir o estresse pós-traumático.

- Diminuir resposta intensa de medo em situações seguras.
- Diminuir a evitação e a fuga de situações.
- Aumentar a aptidão para perceber a probabilidade de comportamentos de risco em outras pessoas.
- Aumentar a capacidade de reconhecer estímulos de trauma.

Em um curto período, a paciente estava comprometida o suficiente para avançar para o estágio 1, que começou com a abordagem dos comportamentos de autolesão. Ela estava especialmente motivada pela perspectiva de tratar o TEPT. No início, ela não concordou que precisávamos abordar os alvos do estágio 1 antes de tratar o TEPT, mas depois de orientá-la com a metáfora da casa de tratamento, ela entendeu e pareceu aceitar o plano de tratamento em estágios. Enfatizei que já estaríamos abordando aspectos do seu TEPT à medida que surgissem no estágio 1, e todo o trabalho no estágio 1 relacionado a comportamentos ligados ao trauma ajudaria em sua preparação

para o tratamento de exposição, que seria o centro do estágio 2. Após cerca de seis semanas de tratamento, durante as quais avaliamos as variáveis de controle de seus comportamentos de autolesão com análises em cadeia do comportamento, ela relatou que não estava mais se autolesionando. Tive a impressão de que, uma vez que ela entendeu que o pré-requisito para abordar as memórias traumáticas e discutir outras coisas em detalhes era parar de se cortar, sua capacidade de fazê-lo foi reforçada. Quando os terapeutas são disciplinados em manter os alvos prioritários, esses tipos de mudanças não são incomuns.

À luz retrospectiva, nossa próxima meta (“aumentar a disposição dela para compartilhar informações com o terapeuta”) se tornou tanto a mais demorada quanto a mais importante a resolver. Apesar de suas declarações positivas sobre mim e sua aparente disposição para se envolver, sua desconfiança mostrou-se profunda e forte. Ela estava retendo informações que eram centrais para seu tratamento: estava na verdade continuando a se cortar, mas mentia sobre isso no cartão diário; continuava a usar substâncias quando afirmava ter parado; e exagerava seus relatos de envolvimento construtivo em sua comunidade. A discrepância entre sua apresentação para mim e seus comportamentos reais durante a semana foi substancial. Ela não estava mudando os comportamentos a que estávamos visando. O impulso de todo o tratamento parou em torno da meta de aumentar a colaboração comigo.

Esse impasse durou vários meses e nos desgastou muito. Ela queria avançar para o tratamento do seu TEPT no estágio 2, mas, ao reter comportamentos em relação às metas do estágio 1, não conseguimos chegar lá. Comecei a pensar se deveríamos contornar esse impasse e tentar fazer o trabalho do estágio 2. Pensei se deveríamos avançar para o processamento das respostas traumáticas, tentando construir confiança e progredir nessa área, o que poderia resultar em mais honestidade sobre

suas metas do estágio 1. Minha equipe ouviu meus pensamentos e validou a frustração que eu estava sentindo, mas apontou que a prática da DBT incluía adesão aos alvos prioritários. Eu já sabia disso, é claro, mas o lembrete compassivo me ajudou a permanecer no caminho certo. Intensifiquei nosso foco no comportamento-alvo de sua desconfiança em relação a mim, evidenciado pela retenção de informações. À medida que analisamos os antecedentes e as consequências de manter a verdade escondida nas sessões, as fontes de sua desconfiança em relação a mim surgiram com mais clareza. Mais importante para esta discussão é o fato de que, quando ela percebeu que não avançaríamos até resolvermos o comportamento não colaborativo-alvo, ela revelou uma informação crucial que havia mantido para si mesma. Seu pai, com quem ela estava morando, havia mentido para ela por meses, dizendo-lhe que falava comigo rotineiramente por telefone. Ele lhe contou qual era minha “verdadeira” opinião sobre como ela “deveria se comportar” e estava usando isso contra ela. Porque seu medo do pai a impedia de desafiá-lo e porque ela temia que, se desafiasse a mim, descobriria que seu pai estava correto, ela nunca me contou o que seu pai disse sobre mim. Uma vez que isso foi exposto e eu pude esclarecer as coisas, a confiança veio rapidamente. Nosso trabalho nessa área também ajudou a ver seu pai com mais clareza.

Em resumo, este caso evidencia a necessidade de a lista de alvos prioritários ser uma estrutura duradoura. Embora essa estrutura seja um produto de tensões dialéticas, que sofre mudanças durante o tratamento e que pode ser usada com alguma flexibilidade, ela é um formato confiável e estável para definir a agenda e monitorar o progresso. O terapeuta DBT se apegue a ela, assim como se leva um mapa ou um GPS para um território desconhecido, mas, assim como o caminhante que precisa mudar de rumo devido a impedimentos imprevistos, o clínico mantém a flexibilidade quando caminhos alternativos se revelam. É uma

ferramenta importante a ser usada na jornada que deve servir ao relacionamento terapêutico, mas não controlá-lo. Encontrar esse equilíbrio é uma arte clínica.

USAR ALVOS PRIORITÁRIOS PARA ESTRUTURAR OUTROS MODOS DE TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA

Fornecer DBT abrangente, inclusiva em todas as cinco funções do tratamento, é fornecer vários modos de tratamento. Um deles é a terapia individual, cuja função principal é melhorar a motivação do paciente. A lista de alvos prioritários discutida até agora neste capítulo é usada para estruturar a terapia individual. Quando o terapeuta individual é o “camisa 10, o meia armador” do tratamento geral, como é o caso da DBT ambulatorial padrão, sua lista de alvos também pode ser considerada a lista principal de alvos que estrutura todo o tratamento. Com o suporte da equipe de consultoria por trás dele, o terapeuta individual é o guardião do tratamento como um todo e da lista de alvos de tratamento primário.

No entanto, outras funções são realizadas em outros modos de tratamento. Por exemplo, a função de melhorar as capacidades do paciente é abordada no grupo de treinamento de habilidades. A função de ajudar o paciente a generalizar habilidades para o ambiente natural é realizada por meio do modo de chamadas de *coaching* telefônico. A função de aprimorar as capacidades e a motivação dos terapeutas é centrada no modo de equipe de consultoria. Cada um desses modos tem uma agenda mais específica do que a ampla agenda do terapeuta individual e uma lista de alvos prioritários muito mais breve e focada. Cada modo é estruturado em torno de sua própria lista de alvos exclusiva, separada, mas relacionada à lista de alvos prioritários do terapeuta individual. A adesão à lista de alvos prioritários específica do modo ajuda a manter o tratamento no caminho certo, centrado na função pretendida.

Como ilustração de alguns princípios na estruturação de listas de alvos prioritários específicas do modo e como usá-las, examino a lista de alvos prioritários do grupo de treinamento de habilidades a seguir. Em ordem de prioridade, os três alvos para o terapeuta que lidera o grupo de habilidades são:

1. Diminuir comportamentos que possam destruir a terapia (ou seja, o grupo de habilidades).
2. Aumentar a aquisição e o fortalecimento de habilidades.
3. Diminuir comportamentos que interferem na terapia.

Primeiro, observe que o segundo alvo, “aumentar a aquisição e o fortalecimento de habilidades”, é a função principal deste modo. Se o líder do grupo tivesse sua preferência, dedicaria 100% do tempo do grupo a essa atividade. Em um grupo que está indo bem, isso é quase sempre possível. O único alvo mais importante do que esse é o primeiro, “diminuir comportamentos que possam destruir a terapia”, e ele é a maior prioridade porque precisa ser. Se um paciente no grupo se comporta de maneira destrutiva para o processo de treinamento de habilidades do grupo, destruindo, assim, a possibilidade de ajudar todos a adquirirem e fortalecerem as habilidades da DBT, esses comportamentos precisam ser abordados até que sejam eliminados. Uma vez tive um paciente com transtorno bipolar que apresentava comportamentos maníacos no grupo de habilidades. Ele estava entusiasmado com todos os tópicos de ensino e com cada indivíduo do grupo, e animado com a possibilidade de que o grupo pudesse mudar sua vida. Ele mal conseguia parar de falar, mesmo quando solicitado. Naturalmente, esse comportamento prejudicou a possibilidade de outros pacientes aprenderem comigo ou entre si, e até mesmo minha capacidade de pensar claramente. Eliminar ou reduzir sua excessiva tagarelice no grupo tornou-se o alvo prioritário mais alto. Apesar de várias advertências e solicitações, o paciente continuou com sua conversa contínua, então encontramos uma intervenção

dialética que honraria seu desejo de aprender as habilidades e, ao mesmo tempo, protegeria a necessidade do grupo de aprendê-las. Colocamos uma cadeira fora do círculo e fizemos um acordo com ele de que, se eu pedisse, ele se mudaria para a cadeira contra a parede, que chamamos de “cadeira silenciosa”. Quando sentado na cadeira silenciosa, ele não deveria dizer nada, mas quando achasse que estava pronto para restringir melhor sua fala, poderia voltar ao círculo do grupo. Esse plano funcionou bem, e pude voltar a ajudar todos os membros do grupo a adquirirem e fortalecerem suas habilidades da DBT.

Liderar grupos de habilidades com indivíduos emocionalmente desregulados pode ser desafiador. O líder encontra passividade, ansiedade social e reatividade emocional, que podem levar a interrupções, inércia, tensão e conflito. Como esses grupos são conduzidos em formato de sala de aula, há pouco espaço para o processamento verbal de comportamentos problemáticos em grupo. Portanto, o terapeuta de grupo precisa estar alerta para manter a estrutura e o fluxo. O que discutimos anteriormente ajudará a guiar o terapeuta de grupo a intervir rápida e firmemente para reduzir ou eliminar comportamentos destrutivos em grupo. Mas observe que a terceira meta, de menor prioridade do que a aquisição e o fortalecimento de habilidades, é reduzir comportamentos que interferem na terapia. Em outras palavras, há uma categoria de comportamentos problemáticos que interferem na terapia e é diferente da categoria de comportamentos que destroem o grupo, e essa é a prioridade mais baixa dos três.

Em um dos meus primeiros grupos de habilidades, havia uma jovem que usava óculos escuros em uma sala com pouca luz e virava sua cadeira para longe de mim e do grupo. Mesmo quando diretamente abordada, ela permanecia em silêncio. Eu tive que decidir se seu comportamento estava prejudicando a terapia ou interferindo na terapia. Seu comportamento estava destruindo minha capacidade de ensinar e a capacidade de outros pacientes

de aprender? Se sim, eu teria que insistir em mudança comportamental imediata. Nesse caso, não estava prejudicando a terapia. Poderia estar interferindo em seu próprio processo de aprendizagem (embora, na verdade, ela estivesse aprendendo durante todo o tempo em que ficou em silêncio e de costas para o grupo). Essa é uma decisão crítica e surge regularmente. A grande maioria dos comportamentos problemáticos em grupo interfere na terapia, mas não a destrói. No caso da maioria dos comportamentos que interferem na terapia, o líder do grupo os ignora, colocando-os em um programa de extinção. Os comportamentos que mais interferem na terapia são rolar os olhos, rabiscar, permanecer em silêncio, não completar a tarefa da prática, recusar-se a entrar em um *role-play*, parecer não prestar atenção e expressar críticas à DBT ou aos líderes do grupo, mas não de uma maneira desmoralizadora para os outros membros do grupo.

A questão de se um determinado comportamento é considerado destruidor ou interferente na terapia pode ser uma questão pessoal para o líder do grupo. Por exemplo, se um determinado padrão comportamental ultrapassa os limites pessoais do líder do grupo, distraíndo-o a tal ponto que ele não pode ensinar efetivamente, então é destruidor de terapia. O mesmo padrão comportamental pode ser menos difícil para outro profissional. À medida que me familiarizei mais com o que considero comportamentos destruidores de grupo e me sinto mais confortável em intervir em tais padrões de maneira rápida e decisiva, ignorando comportamentos que interferem na terapia, meus grupos têm funcionado melhor. Lembre-se de que mesmo que se ignore os comportamentos que interferem na terapia no momento, os persistentes podem ser abordados pedindo ao paciente para lidar com os problemas relacionados na terapia individual. Em geral, tenha em mente que os comportamentos que interferem persistentemente na terapia que ocorrem no grupo podem ser o

alvo de menor prioridade no formato de grupo, mas são bastante elevados na lista de prioridades do terapeuta individual.

Os alvos prioritários usados para estruturar as ligações de *coaching* telefônico desempenham um papel semelhante aos usados para estruturar o grupo. Os três alvos para o terapeuta individual definir e manter a agenda para as chamadas telefônicas iniciadas pelos pacientes são os seguintes:

1. Reduzir episódios de comportamento suicida e comportamento autolesivo sem intencionalidade suicida (CASIS).
2. Aumentar a generalização de habilidades.
3. Reduzir o sentimento de conflito, alienação e distância com o terapeuta.

Assim como ao usar alvos prioritários para o grupo de treinamento de habilidades, o segundo alvo é o trabalho central deste modo. A “ligação telefônica perfeita” seria focada inteiramente em como generalizar habilidades no contexto da crise em andamento. Mas se o paciente estiver passando por um episódio de comportamentos de crise suicida, com potencial alta letalidade, o direcionamento do alvo da generalização de habilidades fica em segundo plano temporariamente, enquanto é realizada uma avaliação de risco de suicídio ou a implementação de um protocolo de crise suicida. Assim que a crise for suficientemente abordada, o terapeuta pode imediatamente voltar a orientar as habilidades usadas diante do alto risco. Observe que o terceiro alvo concentra tanto o paciente quanto o terapeuta nos problemas atuais do relacionamento terapêutico, em que o paciente está sentindo conflito, alienação e distância do terapeuta. De acordo com Linehan (2010, pp. 183, 461), se a ligação não for uma crise suicida ou um pedido de ajuda para generalizar habilidades, mas sim consistir em um contato para discutir problemas no relacionamento, a resposta deve ser uma breve

conversa por telefone, assim como pode acontecer entre dois amigos que estão passando por um episódio de afastamento. Se não puder ser resolvido na ligação telefônica, o terapeuta pode trazer o assunto para a próxima sessão de terapia.

Quando desenvolvi nossa unidade de DBT para pacientes internados, as lições que aprendi estudando os alvos específicos do modo foram extremamente úteis para estruturar o trabalho da minha equipe. Em um programa para pacientes internados, existem vários modos que não estão presentes no tratamento padrão de DBT ambulatorial coberto pelo manual. Quando membros da equipe de enfermagem se encontraram para verificar pacientes por 5, 10 ou 15 minutos, conceituamos isso como o “modo de verificação”. Quando liderei toda a comunidade da unidade em uma “reunião da comunidade”, conceituamos isso como o “modo de reunião da comunidade”. Mesmo no meu trabalho como “chefe de unidade”, considerei isso como o “modo de chefe de unidade”. E em cada caso, começamos com o trabalho principal desse modo e, a partir desse ponto de vista, identificamos outros alvos desse modo e onde eles se encaixam na lista de prioridades. Vimos as verificações em pacientes internados como funcionalmente semelhantes às chamadas telefônicas em DBT ambulatorial. A generalização de habilidades era o trabalho central do modo. Especificamos três alvos, sendo o segundo o trabalho principal desse modo: aumentar a generalização de habilidades para o ambiente do paciente. O alvo mais elevado, semelhante à situação de orientação por telefone, precisava ser comportamentos que apresentavam perigo imediato: episódios de comportamentos suicida, homicida ou destrutivo para a unidade. Os agrupamos em uma categoria, que chamamos de “comportamentos extremos”. O terceiro alvo para as verificações é quase exatamente paralelo ao terceiro alvo para as ligações telefônicas: esforços para reduzir o sentimento de alienação, conflito ou distância do membro da equipe ou do programa como um todo. Ao ter um conjunto claro de

três alvos em ordem de prioridade, que muitas vezes foram o foco dos exercícios de treinamento da equipe, os membros da equipe encontraram um papel claramente definido na unidade, em vez do que eu vi em tantos programas hospitalares, nos quais essas reuniões de verificação extremamente importantes e frequentes carecem de um foco ou estrutura orientadora.

A DBT foi implementada em uma ampla variedade de configurações e com várias populações de pacientes. Como resultado, os programas de DBT desenvolveram uma infinidade de modos, atendendo funções típicas da DBT. Essa multiplicidade ajuda a explicar a flexibilidade da DBT na implementação. Podemos extrapolar a partir da discussão anterior para designar algumas diretrizes para o uso e o desenvolvimento de alvos específicos de modo. Esclarecer a função de cada modo vinculará esse modo aos alvos maiores do programa de tratamento (p. ex., a generalização das habilidades dos pacientes durante o modo de verificação de enfermagem faz parte do alvo maior de melhorar e generalizar as capacidades dos pacientes). Esclarecer a lista de alvos prioritários do modo dará forma e estrutura a ele e ajudará o provedor de tratamento a manter o foco. Em geral, o trabalho central do modo será incorporado ao *segundo* alvo prioritário na lista, e o primeiro alvo prioritário do modo visará àqueles comportamentos que impedem o trabalho central do modo. Se o paciente ataca o terapeuta individual, eliminar o ataque é uma prioridade maior do que o trabalho desejável de melhorar a motivação. Quando um membro do grupo de habilidades é excessivamente crítico com outro membro do grupo, naquele momento reduzir a culpa será um alvo de prioridade mais alta do que ensinar habilidades. Se um paciente em uma unidade de internação tenta se machucar durante uma verificação com um membro da equipe, reduzir o comportamento de autolesão é uma prioridade mais alta naquele momento do que o trabalho de generalizar habilidades para o ambiente. O terceiro alvo prevê

outras questões que podem ser abordadas se os dois primeiros alvos forem alcançados. O terapeuta individual pode entregar a agenda ao paciente; o treinador de habilidades pode abordar comportamentos que interferem na terapia e que não proíbem o ensino de habilidades no grupo, mas que interferem na aprendizagem do indivíduo. E durante uma ligação de *coaching* telefônico, o terapeuta pode focar na reparação de uma ruptura na relação terapeuta-paciente, se não houver um alvo de maior prioridade que precise de atenção. Nem sempre é viável seguir exatamente essa fórmula, pois, em alguns casos, um modo terá uma lista maior de alvos prioritários, mas ainda assim os princípios podem ser aplicados.

USANDO A LISTA DE ALVOS PRIORITÁRIOS PARA ESTRUTURAR E MANTER UM PROGRAMA VIÁVEL E ABRANGENTE

Discutimos a natureza da lista de alvos prioritários na DBT e vimos como ela serve para estruturar o trabalho do terapeuta individual, a agenda de cada sessão e o trabalho de cada modo de tratamento da DBT. Se não fosse por esse tipo de estruturação orientada para alvos, a terapia seria inevitavelmente conduzida pela desregulação emocional, sobrecarregada pelo número e pela magnitude de comportamentos problemáticos e paralisada pela passividade ou pelo conflito persistente. Da mesma forma, a implementação e a manutenção de um programa abrangente de DBT ocorrem em meio a pressões que podem colidir com a filosofia do tratamento ou com a tomada de decisão baseada em evidências. Os líderes do programa enfrentam agendas institucionais globais e invasivas para evitar crises, prevenir atrito entre administradores e seus departamentos, minimizar a utilização de recursos, reduzir as queixas de alto nível por parte de famílias e pacientes e se adaptar a certas personalidades da equipe. Assim como o uso de metas, estágios e alvos prioritários para manter a ordem e a direção na terapia, os líderes do programa fazem a mesma coisa em um contexto mais amplo na implementação da DBT. Manter-se claro e vigilante sobre metas e estágios programáticos abrangentes e sobre alvos prioritários para pacientes em cada modo de tratamento fornece uma espinha dorsal para a tomada de decisão programática que mantém as coisas no caminho certo. Não podemos simplesmente manter uma filosofia de programa abstrata conhecendo os princípios; em vez disso, confiamos em estruturas consistentes com esses princípios.

Quando implementei a DBT em um ambiente de internação, a determinação de nossas metas, estágios e alvos nos guiou, a partir

desse ponto, em decisões sobre tratamento, agendas de treinamento da equipe e comunicação com famílias, administração e outros “terceiros”. Como resultado, ao longo do tempo, as metas, os estágios e alvos se tornaram incorporados como uma “estrutura profunda” dentro do programa. Mesmo quando ocorreram mudanças sísmicas em nosso ambiente fiscal e institucional, essa estrutura profunda nos ajudou a tomar decisões que mantiveram a essência do programa.

Por exemplo, determinamos que uma das nossas metas programáticas gerais era aumentar as capacidades dos nossos pacientes em adquirir, fortalecer e generalizar as habilidades necessárias para buscar suas metas de uma vida que vale a pena ser vivida fora do hospital. Como resultado, mantivemos nosso foco em alvos relacionados a essas tarefas, escolhendo ignorar o trabalho em alguns outros possíveis alvos, ou adiando esse trabalho para o tratamento ambulatorial. Percebemos que seria irrealista visar à eliminação de comportamentos e ideias suicidas em nossos pacientes internados; em vez disso, objetivamos aumentar as capacidades dos pacientes para realizar esse trabalho em tratamento ambulatorial sem hospitalizações repetidas. Não visamos ao grande número de comportamentos que interferem na qualidade de vida que estariam na lista de alvos de um terapeuta DBT ambulatorial; em vez disso, nos concentramos nos comportamentos que interferem na qualidade de vida e que levam ou prolongam a hospitalização. O tempo de internação era muito curto para nos concentrarmos em uma gama de comportamentos, e, em DBT, nossa preferência é abordar os problemas de comportamento no contexto natural da vida. Essas decisões de direcionamento de alvos tiveram implicações para a forma como orientamos os novos pacientes na unidade. Deixamos claro para eles que nosso trabalho não era resolver todos os seus problemas, mas ajudá-los a superarem uma crise e construírem as habilidades para resolver seus problemas fora do hospital. Essa

clareza nos ajudou a manter o foco com os pacientes que ficavam desapontados com a agenda limitada. Muitos pacientes entram no ambiente hospitalar com grandes esperanças de resolver tudo.

Depois de fazer esse trabalho por alguns anos, chegamos a definir nosso programa como resolvendo três metas principais sequenciais, em três estágios. O estágio 1 foi “entrar”, que englobou etapas de avaliação, orientação, desenvolvimento de um plano de tratamento e obtenção de comprometimento com o plano de tratamento. Também incluiu ênfase em estabelecer controle comportamental suficiente para participar dos vários aspectos do programa. O estágio 2 foi definido como “assumindo o controle”: foi a fase intermediária do tratamento, focada em avaliar e tratar comportamentos que provocam e prolongam a hospitalização, com o objetivo de ensinar aos pacientes maneiras habilidosas de evitá-los no futuro em atendimento ambulatorial. O estágio 3 foi definido como “sair”, consistiu na fase de transição da vida hospitalar para a vida ambulatorial e girou em torno da configuração de estruturas ambulatoriais viáveis e na aquisição e no fortalecimento de habilidades para trabalhar alvos importantes sem precisar voltar ao hospital. Uma vez que esclarecemos nossas três etapas, os alvos nos quais nos concentraríamos, os alvos que adiaríamos até a vida ambulatorial e as intervenções que alcançariam esses objetivos, chegamos a um novo e realista nível de organização que fortaleceu nosso programa. Este é apenas um exemplo de como um programa de DBT é organizado em torno de metas, estágios e alvos específicos; como essa especificidade delimita as tarefas do programa; e como mantém todos os vários modos, intervenções e protocolos alinhados uns com os outros em serviço dos alvos prioritários do programa.

O PAPEL DA LISTA DE ALVOS PRIORITÁRIOS NA ADAPTAÇÃO DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA ÀS CONFIGURAÇÕES DE DIFERENTES POPULAÇÕES E *SETTINGS* DE APLICAÇÃO

Neste capítulo, vimos que a lista de alvos prioritários desempenha um papel central na organização e no sequenciamento do tratamento geral, estabelecendo a agenda para cada sessão de terapia individual e de todos os outros modos de tratamento, e até mesmo estruturando todo o programa de tratamento. Quando adaptei a DBT para cuidados hospitalares, percebi que precisava ajustar os alvos prioritários. Eu tinha que projetar um modelo para todo o programa, priorizando as categorias de alvos comportamentais que poderiam ser adaptadas para cada caso. Isso foi um exemplo de como usar metas, estágios e alvos para estruturar o tratamento DBT em um contexto para o qual ele não foi originalmente projetado. Da mesma forma, a especificação é fundamental para adaptar a DBT a qualquer população de pacientes para a qual ela não tenha sido originalmente projetada. Discuti um exemplo disso no capítulo anterior sobre a árvore da DBT, no qual identifiquei e discuti a lista de alvos de tratamento para pessoas com transtornos por uso de substâncias (TUS). Eu precisei localizar onde inserir as metas relacionadas ao uso de substâncias nas maiores categorias de alvos padrão da DBT e depois tive que especificar as “submetas” para o tratamento de problemas por uso de substâncias. A fim de consolidar esta compreensão crescente de como aplicar metas, estágios e alvos a diferentes transtornos e comportamentos problemáticos, concluo este capítulo discutindo a adaptação da DBT a um indivíduo com

transtorno da personalidade *borderline* e transtorno alimentar compulsivo.

Primeiro, em qual categoria geral da lista de alvos padrão da DBT iremos focar os comportamentos relacionados ao transtorno alimentar? Afinal, na semana em questão, o paciente pode apresentar comportamentos de autolesão, ideação suicida, ausência nas sessões de treinamento de habilidades, comportamentos de compulsão alimentar e purgação, padrões interpessoais disfuncionais e má adesão ao tratamento medicamentoso.

Assim como nossas considerações no tratamento de TUS, primeiro determinamos se os comportamentos relacionados ao transtorno alimentar se apresentam como desafios de comprometimento (alvo de pré-tratamento), comportamentos que colocam a vida em risco (categoria de alvo 1), comportamentos que interferem na terapia (categoria de alvo 2) ou comportamentos que interferem severamente na qualidade de vida (categoria de alvo 3). Qualquer uma dessas opções é possível. A paciente pode apresentar ambivalência em relação à intervenção nos comportamentos relacionados ao transtorno alimentar, o que exigirá atenção ao comprometimento durante o pré-tratamento. Ela pode apresentar baixo peso corporal que representa uma ameaça à vida ou apresentar um esôfago danificado secundário a episódios violentos de purgação, que também pode representar uma ameaça à vida. Em ambos os casos, os comportamentos relacionados ao transtorno alimentar serão alvo juntamente com outros comportamentos que colocam a vida em risco. Ela pode mentir sobre seus hábitos alimentares ou ser tão magra que perturba ou distrai o psicoterapeuta. Em ambos os casos, esses comportamentos serão alvo juntamente com comportamentos que interferem na terapia (em um caso, como um comportamento não colaborativo; no outro caso, como um comportamento que viola os limites pessoais do terapeuta).

Mas, na maioria dos casos “comuns” de transtorno de compulsão alimentar, os comportamentos relacionados ao transtorno alimentar serão alvos como parte do conjunto de comportamentos que interferem severamente na qualidade de vida. Se o programa de DBT se especializa no tratamento de transtornos alimentares, esses comportamentos provavelmente serão alvos de maior prioridade entre os comportamentos que interferem na qualidade de vida, a menos que um dos outros na mesma categoria esteja causando uma crise imediata. Se você se lembra, essas considerações são exatamente paralelas às determinações de onde direcionar os comportamentos relacionados por uso de substâncias no tratamento desses transtornos.

Depois de localizar o lugar dos alvos do transtorno alimentar dentro da hierarquia de alvos maior, resta especificar a sequência de subalvos que levam ao tratamento bem-sucedido do transtorno de compulsão alimentar. O mesmo tipo de estratégia usada para a sequência de subalvos do abuso de substâncias é usada aqui. No entanto, isso requer uma familiaridade considerável com o transtorno e como ele é resolvido com sucesso em um processo passo a passo. Para o transtorno de compulsão alimentar, um caminho típico, frequentemente chamado de “caminho para a alimentação consciente”, segue:

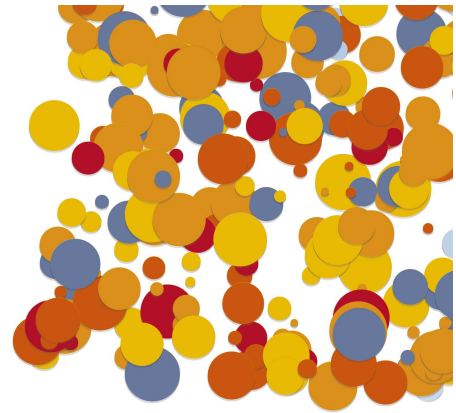
1. Parar de comer compulsivamente e purgar.
2. Eliminar a alimentação sem consciência.
3. Reduzir a fissura, os impulsos e as preocupações com alimentos.
4. Reduzir a submissão à compulsão – bloquear as opções para comer compulsivamente e purgar.
5. Reduzir os comportamentos aparentemente irrelevantes (p. ex., comprar alimentos compulsivos “para ter companhia”).

6. Aumentar comportamentos habilidosos de regulação emocional aprendendo e praticando habilidades dos três módulos: *mindfulness*, regulação emocional e tolerância ao mal-estar.

Com esse nível de clareza e especificidade, o terapeuta DBT está adequadamente preparado para enfrentar o desafio de tratar o transtorno de compulsão alimentar dentro da abordagem geral de tratamento da DBT.

COMENTÁRIOS FINAIS

Nós revisamos a importância central das metas, estágios e alvos da DBT na psicoterapia individual, em outros modos de tratamento, implementação e manutenção de programas de DBT e a adaptação para outros ambientes e populações. Sem essa estrutura crucial no centro da DBT, a terapia e a implementação tendem a se desviar, impulsionadas por prioridades que não se baseiam em tratar o paciente com eficácia e compaixão. É útil ter uma estrutura que especifique não apenas o que tratar, mas também o que não tratar ou o que deixar para mais tarde.



Dilemas dialéticos e alvos secundários

Fazer terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) é como escalar uma montanha. O terapeuta e o paciente precisam traçar juntos o seu curso, preparar todos os equipamentos necessários com antecedência, trabalhar como uma equipe e lidar com uma gama de desafios previsíveis e imprevisíveis ao longo do caminho. O objetivo final na escalada é alcançar o topo – que, na DBT, é o paciente experimentar uma vida que valha a pena ser vivida. Isso geralmente requer escalar vários topos menores ao longo do caminho. Da mesma forma, o terapeuta DBT trabalha com o paciente para escalar vários “pequenos topos” sequencialmente, a fim de alcançar um forte compromisso com a jornada, pôr fim a comportamentos que colocam a vida em risco, superar comportamentos que interferem significativamente na terapia, resolver vários comportamentos que interferem na qualidade de vida, adquirir um repertório de habilidades e prosseguir para escalar os topos dos estágios 2, 3 e 4. Tendo negociado com sucesso a sequência de alvos prioritários, o paciente alcança uma vida que vale a pena ser vivida.

O alpinista muitas vezes pode ver o próximo topo ou localizá-lo em um mapa topográfico. É discreto, definível, está lá para ser alcançado. Sua presença fornece direção e motivação. Mas a verdade é que subir até lá pode exigir atravessar correntezas violentas, escalar rochas íngremes, suportar tempestades repentinas, lutar contra pântanos, perder e encontrar o caminho

várias vezes e superar o desânimo e a fadiga. Em outras palavras, o verdadeiro trabalho de chegar ao próximo topo em vista é o trabalho de atravessar esses desafios. Os topos identificáveis na DBT, os alvos prioritários, também podem ser descritos de maneira bastante sucinta: aumentar o comprometimento, reduzir a autolesão, aumentar a presença nos diferentes modos de tratamento, diminuir o uso de substâncias, entre outros. Para vencer qualquer um desses alvos prioritários, é necessário atravessar a solução de padrões comportamentais complexos – o equivalente da DBT a fortes correntezas, rochas íngremes, tempestades repentinas, pântanos assustadores, fadiga e desânimo. Os pântanos na DBT (os padrões comportamentais complexos e problemáticos encontrados diariamente na terapia) se apresentam como obstáculos que impedem a solução dos comportamentos-alvo principais. Ao fazê-los, tendem a manter esses comportamentos-alvo principais.

Em contraste com os alvos primários discretos e definíveis, esses padrões são tudo menos claros e simples. Eles envolvem constelações de emoções, pensamentos e ações; podem ser extensos, com fronteiras pouco claras. Na verdade, o terapeuta pode não reconhecê-los como padrões e pode acabar colaborando com eles sem perceber. Uma vez tratei uma paciente com uma combinação debilitante de ódio por si mesma, autolesão, abuso de substâncias e violência contra objetos inanimados. Seus comportamentos ocorriam em episódios de descontrole emocional e comportamental, culminando em comportamentos dramáticos de autolesão. Dois meses depois do início da terapia, nosso alvo primário mais consistente, sessão após sessão, havia se tornado a redução do comportamento de autolesão. Durante várias semanas consecutivas, avaliamos esses episódios com análises em cadeia do comportamento. Um padrão gradualmente emergiu: os comportamentos de autolesão funcionavam para encerrar episódios dolorosos de desregulação emocional e descontrole

comportamental; esses comportamentos forneciam um tipo de ponto final, reduzindo rapidamente a dor emocional e criando distrações psicológicas, como deslocamentos ao pronto-socorro e avaliações de crises. Esses episódios resultavam em maior controle comportamental e sensação de alívio.

Uma vez que identificamos a natureza do padrão que levava à autolesão, percebi que estava perpetuando inadvertidamente o padrão. Eu era compassivo e validador ao avaliar os episódios, com a intenção de reduzir a intensidade da vergonha da paciente. Mas aprendi que ela interpretava minha compaixão como uma forma de “perdão”, o que, na verdade, reforçava os episódios. Em outras palavras, eu estava participando de um ciclo disfuncional: 1) sua desregulação emocional, acompanhada de descontrole comportamental, era “resolvida” por meio de um episódio de autolesão; 2) enquanto ela revisava o episódio comigo nas sessões, acompanhada de intensa vergonha, eu respondia com compaixão e validação; 3) ela interpretava minhas intervenções como análogas ao “perdão”, semelhante à sua experiência de confessar seus pecados ao padre católico quando criança; 4) parecia a ela que nossa interação “apagava a lousa”; e 5) essa “confissão” preparava o terreno para outro episódio. Até que eu pudesse entender toda a sequência, não percebi meu próprio papel em reforçar os episódios. Se tivesse sido capaz de reconhecer o padrão comportamental mais prontamente e objetivamente, poderia ter tratado com mais eficiência e de forma mais efetiva.

Nos primeiros anos de desenvolvimento da DBT por Linehan, ao avaliar e tratar os principais alvos de tratamento, ela encontrou uma infinidade de padrões comportamentais problemáticos semelhantes e os categorizou. Apesar de serem diferentes em cada caso, havia temas comuns. Ela notou que eles se apresentavam em pares, de modo que um padrão problemático poderia ser visto como existindo em uma extremidade de uma

determinada dimensão, com outro na extremidade oposta. Os padrões emparelhados muitas vezes pareciam ser opostos polares e, em certos aspectos, pareciam interdependentes entre si. Ela nomeou seis desses padrões, existindo em três pares.

1. Ao longo de uma dimensão relacionada ao tema da modulação emocional, um padrão disfuncional que ela chamou de “vulnerabilidade emocional” ficava em uma extremidade, oposta a um padrão disfuncional chamado de “autoinvalidação”.
2. Ao longo de uma segunda dimensão relacionada ao tema de pedir ajuda, um padrão disfuncional de busca de ajuda chamado de “passividade ativa” ficava em uma extremidade, e um padrão igualmente disfuncional de busca de ajuda chamado de “competência aparente” ficava na outra.
3. Ao longo de uma terceira dimensão relacionada ao tema do processamento de perda e trauma, padrões disfuncionais de “crises implacáveis” e “luto inibido” ficavam em extremidades opostas do *continuum*.

Como esses pares de padrões comportamentais dialeticamente relacionados atrapalhavam o tratamento eficaz dos principais alvos de tratamento, Linehan (2010) chamou-os, coletivamente, de “dilemas dialéticos”. Eles podem ser vistos em relação uns aos outros na Figura 8.1.

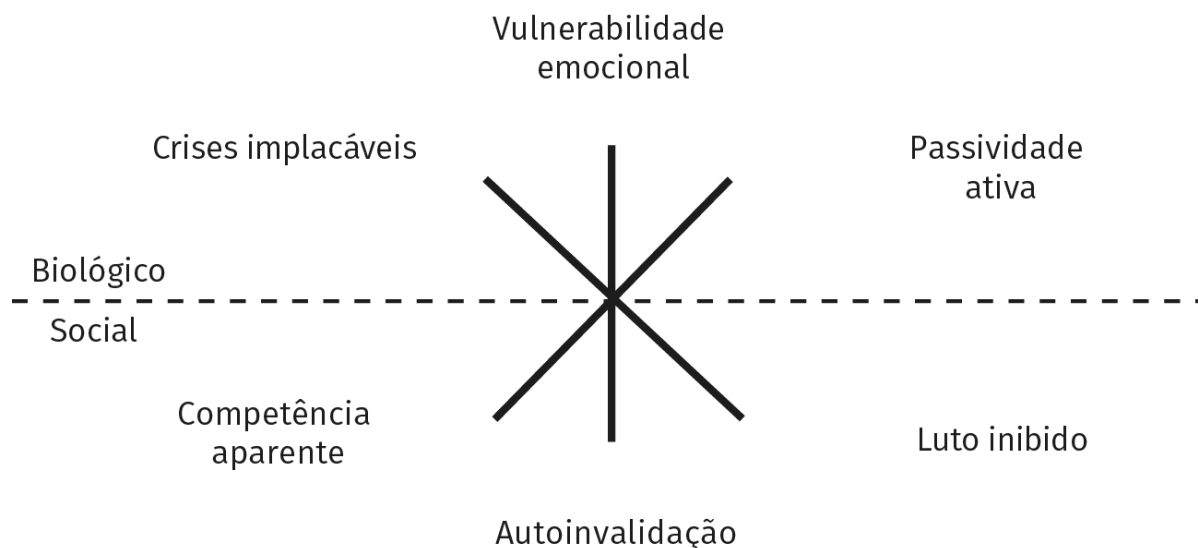


FIGURA 8.1 Dilemas dialéticos.

Observe que as três dimensões se intersectam em um ponto central. Linehan (2010) postulou que os padrões acima desse ponto eram mais influenciados por fatores biológicos, enquanto os padrões abaixo desse ponto eram mais influenciados por respostas ambientais. Por exemplo, em uma das extremidades de uma dimensão, representada pela linha vertical, o padrão de vulnerabilidade emocional é hipotetizado como sendo resultado de fatores biológicos; o padrão de autoinvalidação é hipotetizado como resultado cumulativo das respostas ambientais às vulnerabilidades emocionais do indivíduo. Os três padrões que se pensa serem mais influenciados pela biologia estão relacionados entre si de maneira significativa, e às vezes se apresentam de maneira sobreposta na terapia. Todos representam extremos de sub-regulação ou descontrole de ação, pensamento e/ou emoção. Os três padrões que se pensa serem mais influenciados pelo ambiente também tendem a se agrupar em algum grau e parecem representar extremos de hiper-regulação, ou supercontrole, de ações, cognições e/ou emoções. De interesse, os três dilemas dialéticos propostos por Rathus e Miller (2022) para entender os padrões de relacionamento entre adolescentes e suas famílias

também giram em torno da oposição de padrões de subcontrole (p. ex., excessiva leniência) e aqueles de supercontrole (p. ex., controle autoritário).

Embora os dilemas dialéticos ocupem um papel central na formulação de casos da DBT e na prática clínica, às vezes são subestimados no treinamento e na literatura. Reconhecer, rotular e tratar esses padrões em tempo real durante a terapia é inestimável. Aqui destaco a natureza, as funções e a utilidade clínica dos dilemas dialéticos. Além disso, uma compreensão dos princípios subjacentes ao construto permite que um terapeuta adapte os dilemas dialéticos de forma flexível a cada caso e derive dilemas dialéticos além dos seis propostos por Linehan. Neste capítulo, consideramos: 1) a relação teórica crucial entre a teoria biossocial da DBT e os dilemas dialéticos; 2) a natureza dos três dilemas dialéticos no contexto clínico; 3) como derivamos os alvos secundários na DBT (aqueles padrões comportamentais que causam e mantêm os comportamentos-alvo primários) dos dilemas dialéticos e como os usamos; e 4) como podemos identificar dilemas dialéticos e alvos secundários adicionais.

TEORIA BIOSSOCIAL E DILEMAS DIALÉTICOS

Começando com o manual da DBT abrangente de Linehan (2010), a teoria biossocial da DBT foi descrita detalhadamente em múltiplos contextos. Embora aqui não estejamos interessados em reafirmar ou reconsiderar abrangentemente essa teoria frutífera, uma breve revisão de seus ingredientes essenciais vai preparar o terreno para entender a relação entre a teoria biossocial e os dilemas dialéticos. Atualmente, a teoria é objeto de estudo empírico e um conjunto de hipóteses oferecido para explicar a causalidade e a manutenção de comportamentos-problema tratados na DBT. A proposição geral é que a disfunção emocional crônica e grave resulta de uma transação duradoura entre as vulnerabilidades emocionais biologicamente baseadas de um indivíduo e a invalidação ambientalmente baseada dessas vulnerabilidades. Essa proposição é representada na Figura 8.2.

BIOLÓGICO

Sensibilidade emocional

Reatividade emocional

Retorno lento à
linha de base

Impulsividade

↕
SOCIAL

Invalidação de
respostas válidas

Reforço intermitente
do comportamento
escalado

Simplificação excessiva
da solução de
problemas emocionais

→ **Biológico**
Social

Competência
aparente

Vulnerabilidade
emocional

Crises
implacáveis

Passividade
ativa

Luto
inibido

Autoinvalidação

COMPORTAMENTOS-ALVO PRIMÁRIOS

↑ Comprometimento

↓ Comportamentos
que ameaçam a vida

↓ Comportamentos
que interferem
na terapia

↓ Comportamentos
que interferem na
qualidade de vida

↑ Habilidades
de DBT

↑ Experiência
emocional sem
intenso sofrimento

↑ Solução
individual de
problemas

↑ Autorregulação

↑ Liberdade

FIGURA 8.2 Teoria biossocial, dilemas dialéticos e alvos primários de tratamento.

Linehan (2010) propõe que o termo *vulnerabilidade emocional* abrange três características baseadas em fatores biológicos: 1) sensibilidade emocional acima da média aos estímulos ambientais; 2) reatividade emocional acima da média (amplitude); e 3) retorno mais lento do que a média ao estado basal. As influências biológicas podem ser provenientes de genética, ambiente intrauterino, influências pós-natais radicais de negligência e abuso e/ou trauma psicológico significativo durante o desenvolvimento. Presumivelmente, qualquer pessoa que herde ou adquira essas vulnerabilidades biologicamente baseadas será mais sensível e reativa do que a média esperada da população a estímulos emocionalmente salientes ao longo do desenvolvimento. Ao aprender a experienciar, reconhecer e gerenciar essas

vulnerabilidades, o indivíduo será fortemente influenciado pelas respostas do(s) ambiente(s) relevante(s), como pais, cuidadores, professores, treinadores, pares e a sociedade em geral.

Linehan (2010) propõe ainda que o indivíduo emocionalmente vulnerável criado em ambientes predominantemente validantes aprenderá meios eficazes para conviver e aproveitar a sensibilidade e a reatividade emocionais. Figuras ambientais-chave demonstrarão uma medida de tolerância, compaixão e compreensão das vulnerabilidades e as abordarão com uma combinação de proteção, modelação e orientação eficazes. Esse tipo de resposta cuidadosa e construtiva, quando consistente, é improvável de resultar nos padrões comportamentais do transtorno da personalidade *borderline* (TPB). Mas os mesmos indivíduos emocionalmente suscetíveis que crescem em um ambiente relativamente *invalidante*, no qual as reações às suas emoções na infância são desvalorizadas, enfrentam um risco elevado de desenvolver os comportamentos problemáticos associados ao TPB. Linehan (2010) propôs três características dos ambientes invalidantes que tendem a: 1) julgar, desconsiderar, ignorar, patologizar ou punir de outra forma as respostas emocionais válidas do indivíduo; 2) reforçar intermitentemente a escalada das respostas emocionais; e 3) simplificar demais a facilidade de resolver problemas emocionais. Como resultado, o indivíduo que já está lidando com um excesso baseado na biologia de respostas emocionais mal reguladas não adquire a capacidade de discernir e rotular com precisão suas respostas emocionais, entender suas emoções de maneira compassiva ou usar estratégias para regular essas respostas.

Linehan (2010) destaca ainda quatro habilidades que surgiram em pesquisas sobre o desenvolvimento da regulação emocional em crianças (Gottman & Katz, 1989). Essas habilidades são cruciais para o indivíduo com alta vulnerabilidade emocional: a capacidade 1) de inibir comportamentos inadequados relacionados

a emoções negativas ou positivas intensas; 2) de autorregular a excitação fisiológica associada às emoções; 3) de redirecionar a atenção na presença de emoções intensas; e 4) de se organizar para ações contínuas em prol de um objetivo externo e não dependente do humor. Essas capacidades relativas, que poderiam determinar fortemente a “inteligência emocional” de uma pessoa e o sucesso na vida, parecem ocupar uma localização intermediária entre os fatores baseados na biologia e os baseados no ambiente. Em algumas ocasiões, Linehan sugeriu em seus *workshops* que pode haver alguma evidência de contribuição genética para essas capacidades, mas é fácil ver que sua presença pode ser reforçada ou inibida por fatores ambientais. Muitas vezes, achei útil usá-las como um inventário de capacidades de regulação emocional, que aplico com meus pacientes durante a avaliação e o tratamento.

A teoria é transacional. A exposição prolongada ao ambiente invalidante piora os problemas de vulnerabilidade emocional do indivíduo; essa piora desafia ainda mais o ambiente, que pode se tornar mais invalidante. A transação em espiral eventualmente resulta no problema hipotetizado na DBT como o cerne do TPB: a desregulação emocional crônica e grave. Uma vez que o problema central tenha se estabelecido no indivíduo, em qualquer forma, ele pode ser reacendido repetidamente por encontros com respostas relativamente invalidantes em novos ambientes. Isso inclui encontros na psicoterapia, onde o esforço do terapeuta para mudanças comportamentais quase garante que o paciente se sentirá invalidado e se tornará emocionalmente desregulado. Por mais desconfortável que essa desregulação seja para ambas as partes, ela oferece oportunidades repetidas para o tratamento *in vivo* dos problemas centrais em tempo real.

Os três conceitos primários na teoria biossocial (*vulnerabilidade emocional embasada biologicamente, ambientes invalidantes e desregulação emocional crônica e grave*) são vistos a partir da perspectiva do observador científico externo. Cada conceito é

definido objetivamente, de maneiras que podem, então, ser submetidas à verificação científica. O resultado da transação biossocial assume a forma de certos padrões comportamentais complexos no paciente individual, e esses são os dilemas dialéticos. No entanto, embora a teoria biossocial e os dilemas dialéticos estejam intimamente relacionados entre si, com a primeira dando origem ao último, eles representam perspectivas muito diferentes. Em vez de a perspectiva objetiva e científica da teoria biossocial, os dilemas dialéticos representam a perspectiva subjetiva do indivíduo. Por exemplo, *vulnerabilidade emocional* é um construto definido cientificamente, visto de fora para dentro, quando estamos considerando a teoria biossocial; mas o mesmo termo, quando usado para nomear um dos dilemas dialéticos, se refere à perspectiva “de dentro para fora” de alguém que está sofrendo de respostas emocionais incontroláveis e agonizantes. Da mesma forma, na teoria biossocial, o termo *invalidação* se refere a um construto objetivo com várias características definidas, enquanto o termo *autoinvalidação*, como um dos dilemas dialéticos, se refere à dolorosa experiência subjetiva de autocrítica ou autodesprezo. Nós passamos da linguagem da teoria para a linguagem da experiência pessoal.

Os seis padrões extremos que compõem os dilemas dialéticos representam seis “faces” da desregulação emocional crônica e grave conforme vivenciadas pelo paciente e, no tratamento, vistas pelo terapeuta. Quando compreendidos de forma ideal, os dilemas dialéticos servem como uma janela para os vários resultados dolorosos do processo de desenvolvimento transacional e como uma ponte de entendimento entre terapeuta e paciente que pode fomentar a colaboração na transformação dos padrões. Nem todos os padrões ou dilemas estarão presentes em todos os pacientes de DBT; cabe sempre ao terapeuta avaliar a presença e o papel dos padrões na causa ou manutenção dos comportamentos-alvo primários. Uma vez que os dilemas dialéticos e padrões

específicos são identificados e uma linguagem que fomente a colaboração é desenvolvida, o terapeuta e o paciente podem trabalhar persistentemente na eliminação dos padrões extremos e na substituição deles por habilidades conceitualmente localizadas no caminho do meio entre os dois extremos.

A NATUREZA DOS TRÊS DILEMAS DIALÉTICOS NO CONTEXTO CLÍNICO

Depois de revisarmos a teoria biossocial e considerarmos a natureza geral dos dilemas dialéticos, podemos examinar a natureza de cada um dos dilemas e como cada um é gerado pela influência transacional dos dois polos propostos na teoria biossocial. Em relação ao dilema da *vulnerabilidade emocional versus autoinvalidação*, esses dois padrões extremos e dialéticos opostos resultam quando a criança, que já é emocionalmente vulnerável em um ambiente de invalidação generalizada, está aprendendo o básico de como modular as emoções. Quanto ao dilema da *passividade ativa versus competência aparente*, esses dois padrões surgem quando o indivíduo emocionalmente vulnerável em um ambiente de invalidação generalizada aprende o básico sobre como sentir dor emocional, comunicá-la e pedir ajuda quando necessário. Por fim, o indivíduo emocionalmente vulnerável que está aprendendo o básico de como gerenciar e processar perdas e traumas em um ambiente de invalidação generalizada chega aos padrões dialéticos opostos de *crises implacáveis versus luto inibido*. Em seguida, considero os três dilemas um de cada vez.

Vulnerabilidade emocional versus autoinvalidação

Vamos começar com o processo de aprendizado de como modular as emoções. Quando a criança emocionalmente vulnerável expressa respostas emocionais, muitas vezes carregadas de intensidade e frequentemente aversivas para aqueles que as recebem, ela coloca demandas no ambiente. Se o ambiente não estiver preparado para lidar com essas demandas de maneira

construtiva, as expressões emocionais serão recebidas com baixa tolerância, julgamento severo e rótulos pejorativos. As figuras do ambiente não têm espaço e mostram pouca compaixão para o tipo de resposta que permitiria que o indivíduo experimentasse, “brincasse” com a expressividade emocional. Pouco esforço é feito para ajudar o indivíduo a rotular e tolerar emoções dolorosas. E provavelmente haverá quase nenhum treinamento passo a passo ou modelagem para a criança nas tarefas cruciais de estruturar seu ambiente para reduzir a frequência ou intensidade dos estímulos emocionais; experimentar, tolerar e gerenciar o surgimento de uma resposta emocional; nomear uma emoção uma vez que ela é ativada; regular-se efetivamente diante de emoções fortes; e interromper o impulso e a perpetuação de um processo emocional doloroso.

O indivíduo emocionalmente vulnerável está perdido em ondas de emoções intensificadas que são sentidas como dolorosamente difusas, sangrando em outras respostas emocionais dolorosas. Linehan (2010, pp. 74-78) escreveu que o paciente não tem “pele emocional”; os ventos mais leves podem desencadear surtos de agonia emocional. O paciente pode sentir que as emoções nunca vão parar; a vida é experimentada por meio das janelas dessas emoções. O senso de tempo e perspectiva dá lugar a experiências totalizantes de medo intenso, vergonha, culpa, tristeza, raiva ou outras emoções dolorosas. Sem ter a capacidade de regular o processo, o indivíduo eventualmente encontra comportamentos que aliviam temporariamente a dor implacável. Esses comportamentos são reforçados porque funcionam, e o indivíduo passa a depender deles. Exemplos típicos são episódios de comportamento suicida, ações autolesivas, agressões homicidas, uso de substâncias, episódios de dissociação, abandono do tratamento ou envolvimento em comportamentos interpessoais extremos. Esses comportamentos se tornam a resposta destrutiva, mas confiável, para a vulnerabilidade emocional imparável. É fácil

ver como a vulnerabilidade emocional descontrolada pode levar um indivíduo ao suicídio acidental ou intencionalmente. Na DBT, esses comportamentos se tornam os principais alvos do tratamento a serem eliminados.

A vulnerabilidade emocional é uma manifestação experiencial (uma ampliação) da vulnerabilidade emocional biologicamente baseada observada na teoria biossocial. No outro extremo, a autoinvalidação é uma herança experiencial amplificada da perspectiva implacável do ambiente invalidante. Imitando as figuras invalidantes do ambiente, o indivíduo julga e rotula severamente suas próprias respostas emocionais, ignora e reprime-as até onde for possível, ocasionalmente irrompe emocionalmente de uma forma que traz alguma medida de atenção e suporte e chega a objetivos irrealistas e simplistas para regular as emoções. Em alguns pacientes, parece que a autoinvalidação é o equivalente verbal de se autolesionar cruelmente. Uma paciente falou sobre colocar a mão em um moedor de carne porque era a única coisa que ela podia imaginar que capturaria seu ódio agressivo por si mesma; não é surpreendente que ela tenha sido alvo de ataques difamatórios durante toda a sua infância. Direcionar ataques críticos para si mesmo pode transformar a dor do descontrole (a agonia emocional consumidora, viciosa e sem limites da vulnerabilidade emocional) em dor de excesso de controle: a autodifamação rígida e disciplinada da autoinvalidação. A agonia emocional é substituída por autojulgamento severo, autocontrole, autodisciplina agressiva e ódio por si mesmo, enquanto a atitude do paciente em relação a si mesmo se torna, essencialmente, “Você é um idiota! Você é fraco! Qual é o seu problema?”. Há até uma medida de esperança implícita nas autocríticas: “Se você não fosse tão estúpido, fraco e incompetente, poderia gerenciar sua vida melhor”. No extremo da autonegação, é fácil ver que o grau intolerável de ódio por si mesmo do indivíduo pode levar ao suicídio.

Embora alguns pacientes possam permanecer em um desses padrões opostos por mais tempo do que em outro, em muitos casos, os pacientes alternam entre os dois. Quando se compreende o sabor subjetivo das duas maneiras disfuncionais de lidar com a tarefa da modulação emocional, é possível sentir o fluxo de ida e volta entre elas. Enquanto a agonia emocional continua, o senso de autocritica e ódio por si mesmo por ser tão emocional pode crescer até que essa pessoa passe para a autonegação como experiência predominante. Enquanto está imerso nas garras da autonegação, o indivíduo pode experimentar um crescente senso de descontrole emocional até que a mudança de volta para a vulnerabilidade emocional ocorra. Ao alternar entre esses dois “canais”, não há novo aprendizado de um caminho intermediário, que poderia incluir autoconsciência, autocompaixão, autovalidação e/ou meios habilidosos para modular emoções. Pode haver uma sensação de estagnação e desespero crescente.

Uma vez me pediram para fazer uma revisão retrospectiva minuciosa do caso de uma adolescente que faleceu por suicídio meses depois de ter sido estuprada e subsequentemente humilhada pela distribuição *on-line* de fotografias que retratavam o estupro. À medida que eu juntava a história, aprendi que nos meses finais ela não conseguiu notificar seus pais, as autoridades policiais ou escolares sobre o estupro ou as fotografias, que ela sentia que era motivo de chacota na escola e que vacilava entre tristeza, medo e ódio de seus agressores e terríveis surtos de vergonha, odiando a si mesma por “deixar aquilo acontecer”. Durante um desses episódios de vergonha, ela atacou violentamente suas pernas com uma tesoura, resultando em múltiplos pontos e hospitalização. Quando os detalhes de sua experiência traumática vieram à tona durante sua hospitalização, seus pais sugeriram que ela mantivesse esses detalhes em grande parte para si mesma para que sua posição social na escola não fosse ainda mais comprometida. Eles deram a entender que ela

poderia estar exagerando o grau em que havia sido vítima. De acordo com todas as informações disponíveis, sua biologia e seu ambiente se encaixavam na teoria biossocial, uma vez que ela mostrava altas sensibilidade e reatividade emocionais, e seu ambiente doméstico enfatizava a supressão emocional e a adequação social acima de tudo. Ela estava presa entre os dois polos da vulnerabilidade emocional e da autoinvalidação, a divulgação dos fatos trouxe ainda mais invalidação, ambos os padrões desse dilema dialético se moveram para formas mais extremas, e ela não viu nenhuma saída. Ela faleceu por suicídio e deixou um bilhete em que enfatizava seu ódio por si mesma, omitindo qualquer menção às experiências de invalidação com seus agressores ou seus pais.

Passividade ativa *versus* competência aparente

O segundo par de dilemas dialéticos surge do fato de que toda criança precisa de ajuda com experiências dolorosas. A criança com alta vulnerabilidade emocional no contexto de um ambiente altamente invalidante provavelmente não aprenderá uma maneira eficaz de comunicar a experiência dolorosa e pedir ajuda. Para imaginar como isso pode funcionar, começa pela maneira como a criança experimenta dor emocional de algum tipo. Não tendo ainda desenvolvido capacidades para gerenciá-la e resolvê-la, ela comunica sua dor emocional, de uma maneira ou de outra, para aqueles em seu ambiente, buscando apoio. Em um ambiente relativamente validante, aqueles ao redor da criança podem notar suas expressões de dor emocional, recebê-las com preocupação e interesse e ajudá-la a nomear as emoções. Eles podem então ajudar a criança a resolver o problema que causa a dor emocional, orientá-la sobre como regular as emoções perturbadoras, ajudá-la a tolerar o mal-estar temporariamente e com segurança e reforçá-la por lidar de forma adaptativa. Se o ambiente é altamente

invalidante, as indicações de dor emocional da criança e as solicitações implícitas de apoio são recebidas com algum tipo de consternação, desaprovação, julgamento e/ou rejeição. Como os cuidadores muitas vezes são desregulados ou incapazes de saber como cuidar da criança com dor emocional, suas emoções são vistas como indesejáveis, exageradas, inválidas e até manipuladoras. A invalidação consistente empurra a criança em direção à supressão emocional.

Os esforços da criança para esconder suas emoções e extingui-las, se possível, crescem em um dos dois padrões extremos deste dilema dialético: competência aparente ou passividade ativa. *Competência aparente* refere-se a não expressão do sofrimento emocional no contexto de pessoas que poderiam fornecer ajuda. O indivíduo com essa síndrome não aprende a experimentar ou expressar emoções com precisão e pode desenvolver considerável confusão sobre se precisa ou não de ajuda. Se perguntado como está, essa pessoa pode responder: “Bem”, “OK” ou “Estou bem”, e desviar a atenção ao se concentrar na pessoa que está perguntando. Indivíduos assim frequentemente iniciam a sessão de psicoterapia perguntando ao terapeuta como ele está ou respondem às perguntas do terapeuta com “Não se preocupe, eu vou ficar bem”. A supressão do sofrimento emocional e a importante dificuldade em comunicá-lo às pessoas do ambiente resultam em uma situação na qual ninguém ao redor do paciente realmente conhece seu grau de sofrimento. Por consequência, as pessoas o tratam como se estivesse “bem”. No entanto, ele pode pensar que as pessoas deveriam ser capazes de “ler” seu sofrimento e responder a ele. O fato de que elas não o fazem piora seu senso de isolamento, de ser “desconhecido” e invisível. Esse padrão de muito isolamento pode levar a considerável solidão, ressentimento e desespero, e é fácil ver que, levado a um extremo, pode culminar em suicídio como meio de extinguir uma dor intolerável ou punir um ambiente insensível.

Na situação cada vez mais pressionada que ocorre por trás da máscara de competência aparente, é provável que o indivíduo precise desesperadamente de apoio interpessoal. As tentativas anteriores de obter ajuda foram extintas e punidas. Em certo ponto, ele se volta para o padrão oposto dialeticamente da passividade ativa. *Passividade*, no termo *passividade ativa*, refere-se à abordagem passiva para obter o suporte necessário. No entanto, o indivíduo é “ativo” ao recrutar ajuda, geralmente por meio de uma perda de controle comportamental: um comportamento de crise de algum tipo que desencadeia o suporte das pessoas ao redor. A passividade é ativa, por assim dizer, e funciona para obter suporte. Para ser bem claro, isso não é uma escolha consciente. A passividade ativa é um padrão de comportamento que evolui no contexto de invalidação, que garante atenção e suporte muito necessários e que foi intermitentemente reforçado várias vezes no desenvolvimento. Não é incomum que o sistema de saúde mental reforce o padrão de passividade ativa, oferecendo atenção e suporte apenas quando o paciente evidencia uma perda mais séria de controle. Dado o descontrole comportamental que faz parte do padrão de passividade ativa e a intensidade do sofrimento interno que o impulsiona, é fácil entender que o suicídio possa resultar desse padrão, acidental ou intencionalmente.

Como discutido em relação ao dilema dialético de vulnerabilidade emocional e autoinvalidação, pode ser que um indivíduo evidencie principalmente um desses dois padrões, caso em que o terapeuta o avalia em detalhes e trabalha para reduzi-lo e substituí-lo por meios mais habilidosos de comunicar o sofrimento e pedir ajuda. Mas não é incomum que o indivíduo emocionalmente vulnerável que experimenta sofrimento e precisa de ajuda em um ambiente altamente invalidante oscile entre os dois padrões opostos, nunca aprendendo maneiras adaptativas de resolver o problema no “caminho do meio” entre os dois.

Em um determinado momento, eu estava trabalhando em um programa intensivo de atendimento ambulatorial de DBT. Era o final do dia e quase todo mundo tinha saído. Uma paciente permaneceu, assim como sua terapeuta. A paciente estava experimentando uma dor emocional intensa e não queria voltar para seu apartamento, onde ficaria sozinha. Ela apareceu na porta do consultório de sua terapeuta. Quando perguntada como estava, ela respondeu: “Ótima! Estou bem. Apenas aconteceu de eu ainda estar aqui, então pensei em dizer olá. Mas vou embora agora, vejo que você tem trabalho a fazer”. A terapeuta: “Se você quiser, pode ficar até eu fechar”. Paciente: “Não, acho que vou sair. Te vejo amanhã”. Terapeuta: “OK, boa noite”. Vinte minutos depois, quando a terapeuta fechou o consultório, saiu do prédio e foi ao estacionamento, a paciente estava deitada no chão, na frente do pneu dianteiro direito do carro da terapeuta. A terapeuta falou com a paciente, que permaneceu muda. Ela não se movia quando abordada. A terapeuta chamou a emergência, que a avaliou e a hospitalizou. Este é um exemplo de como um indivíduo em necessidade de ajuda, mas sem as habilidades para pedi-la, pode alternar entre a competência aparente e a passividade ativa na busca por resgate. O resultado provável desse cenário, em que a paciente com intenso sofrimento emocional recebeu a atenção e o apoio da sala de emergência e do hospital, é que os comportamentos “passivamente ativos” foram reforçados.

Depois de anos ensinando DBT, está claro para mim que a passividade ativa é o padrão menos compreendido dos seis padrões comportamentais. O termo é às vezes usado como abreviação para quase qualquer tipo de perda de controle comportamental. Às vezes, os terapeutas usam o termo com um tom de julgamento: “Lá vai ela de novo com sua passividade ativa”. Para mim, isso lembra a forma como os membros da equipe de pacientes em programas orientados psicodinamicamente usam o termo atuação de forma solta para se referirem a quase qualquer

comportamento indesejável, sem referência específica ao significado mais disciplinado do termo na teoria psicodinâmica. No caso da passividade ativa, é importante que tenhamos uma compreensão precisa que nos ajude a abordá-la com empatia.

Com esse objetivo em mente, recorro a uma metáfora que Marsha Linehan usou ao ensinar um *workshop* intensivo (1993, New York Hospital – Cornell Medical Center, Westchester Division, White Plains, New York) para transmitir o significado e a função da passividade ativa. Imagine que acontece um naufrágio perto de uma ilha no meio do oceano. A única sobrevivente nada até a ilha. Ao longo de vários anos, ela aprende a sobreviver: criando um abrigo eficaz, protegendo-se de predadores e dos elementos e aprendendo a se alimentar da terra e do mar. Nenhum navio se aproxima da ilha e apenas raramente um avião passa sobre ela. Supõe-se que ela tenha morrido com os outros do navio, então ninguém está procurando por ela. Embora tenha aprendido a sobreviver, está desesperadamente solitária (compare a experiência interna do indivíduo com competência aparente). Ela permanece atenta ao raro evento de um avião passar baixo. A questão para nós, nesse contexto, é a seguinte: no caso de um pequeno avião passar por cima, baixo o suficiente para enxergar a sobrevivente e sua situação, como ela deveria se comportar quando ele passar? Se o piloto olhar para baixo e ver a situação, com um abrigo bem mantido e uma mulher acenando, ele pode não reconhecer que ela precisa de ajuda. Ele pode até pensar: “Que encantador, romântico e corajoso; eu deveria fazer algo assim também”, caso em que ele pode simplesmente sorrir, acenar e voar embora. Se a única sobrevivente quiser maximizar a possibilidade de que o piloto pouse o avião e a resgate, ela precisa parecer frenética e desesperada. Uma abordagem mais sábia seria colocar seu abrigo em chamas e se debater e rolar no chão, deixando claro que as coisas não estão bem. Usando nosso termo, ela empregaria a passividade ativa como o único meio de obter o

apoio desesperadamente necessário. Entendida corretamente, a passividade ativa é uma estratégia perfeitamente sensata para indivíduos que não conseguem comunicar efetivamente a dor emocional e pedir ajuda. Claro, o caminho mais eficaz seria, se possível, aprender a reconhecer o sofrimento interno, expressar esses sentimentos e pedir ajuda. Isso constituiria o caminho do meio entre os dois extremos.

Crises implacáveis *versus* luto inibido

Enquanto o primeiro dilema dialético gira em torno da modulação efetiva das emoções e o segundo gira em torno da comunicação da dor emocional e do pedido efetivo de ajuda, o terceiro gira em torno do processamento de perdas significativas e eventos traumáticos. Claro que as perdas e os eventos traumáticos, definidos de forma ampla, são comuns no início da vida, mas, para o indivíduo com TPB, geralmente o número de tais eventos está muito além da média; sobrecarga de luto e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) são comuns. Dentro de um ambiente validador, o indivíduo afligido com perda ou trauma é encontrado de maneira solidária, o que o ajuda a reconhecer e processar a perda ou trauma e a desenvolver uma narrativa realista que gradualmente permite que ele coloque isso no passado e siga em frente na vida.

Mas o ambiente parental invalidante, por uma série de razões, não está equipado para ajudar o indivíduo a lidar e processar perdas e eventos traumáticos. Não só os cuidadores demonstram desinteresse nos eventos negativos da vida do indivíduo, como provavelmente comunicam que esses eventos não aconteceram realmente ou não foram tão graves. Podemos lembrar o exemplo mencionado anteriormente neste capítulo, em que os pais da adolescente que foi estuprada e depois faleceu por suicídio minimizaram os eventos traumatizantes de sua filha. Ao invalidar a

natureza ou a extensão da experiência dolorosa, os pais nessas situações insistem implícita ou explicitamente que o jovem enterre sua dor e seus traumas e “pare de reclamar”. Essa mensagem generalizada ativa os dois dilemas dialéticos discutidos anteriormente (vulnerabilidade emocional *versus* autoinvalidação e passividade ativa *versus* luto inibido) e contribui para o terceiro dilema dialético, luto inibido *versus* crises implacáveis. Incapaz de processar ou tolerar o impacto globalmente disruptivo dos eventos negativos da vida e incapaz de obter ajuda efetiva do ambiente para fazê-lo, o indivíduo altamente sensível e reativo reage com desregulação emocional, distraibilidade, pensamento rígido e irrealista, falha na antecipação de consequências e confusão. Nesse estado, age impulsivamente e comete erros de julgamento, resultando no padrão de “crises implacáveis”. Pode ser difícil até mesmo para um terapeuta reconhecer que o padrão de impulsividade e má tomada de decisões, fomentando o caos, está relacionado a uma incapacidade de tolerar e processar respostas a perdas e traumas. Ter consciência desse padrão durante a escuta cuidadosa e o estudo sistemático dos antecedentes pode ajudar o terapeuta a formular o problema “subjacente”: a incapacidade de processar eventos da vida de maneira segura e eficaz. Obviamente, as crises implacáveis, impulsionadas por pensamentos irrealistas e má tomada de decisões, podem levar ao caos, ao desespero e, no caso extremo, ao suicídio.

Enquanto as crises implacáveis são o padrão nesse dilema caracterizado por descontrole global (ou seja, cognições, emoções e ações), seu parceiro dialético, o luto inibido, fortemente influenciado pelo ambiente de invalidação, é caracterizado pelo excesso de controle. O paciente evita automaticamente os sinais relacionados ao luto ou trauma e, quando exposto, tenta escapar o mais rapidamente possível deles e de sua resposta inicial. O indivíduo está constantemente empenhado em bloquear a consciência e apagar a memória de eventos negativos. Como

resultado, perde acesso às memórias desses eventos e eles continuam a assombrá-lo, vivendo nas sombras da vida diária, prontos para retornarem e sequestrarem processos somáticos e comportamentais de imediato. O luto inibido pode resultar em desligamentos temporários da experiência emocional como um todo, o que então prepara o terreno para erupções repentinas de experiência suprimida, resultando em crises implacáveis ou nos outros dois padrões biologicamente conduzidos de passividade ativa e vulnerabilidade emocional. O luto inibido, levado ao extremo, pode resultar em um nível de supressão e desapego que leva à solidão extrema, ao desespero e ao suicídio.

Para resumir, a teoria biossocial postula uma transação que ocorre entre a vulnerabilidade emocional biologicamente baseada e um ambiente invalidante. Carregado com essa transação, o indivíduo empreende os processos de aprendizagem para se relacionar com o mundo e com suas próprias respostas a esse mundo. Três desses processos são modular emoções, pedir ajuda e processar eventos dolorosos da vida. Em vez de desenvolver soluções relativamente equilibradas e eficazes para cada um desses desafios, como poderia ocorrer em condições mais ideais, o indivíduo desenvolve dois tipos de padrões comportamentais extremos dialeticamente opostos. Como cada padrão é intrinsecamente instável e temporário, o indivíduo alterna de um desses padrões para outro, um pouco como ao trocar de um canal de TV ruim para outro, levando a um crescente sentimento de desesperança e impotência. O terapeuta DBT tenta ajudar o paciente a desenvolver, no caso de cada um dos três dilemas, um canal do “caminho do meio” pelo qual ele possa modular efetivamente as emoções, pedir ajuda e processar a perda e o trauma.

DERIVANDO OS ALVOS SECUNDÁRIOS DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA A PARTIR DOS DILEMAS DIALÉTICOS

Como terapeutas da DBT, seguimos as análises comportamentais para avaliar os comportamentos-alvo primários e, assim, identificamos comportamentos e padrões comportamentais que promovem ou mantêm o comportamento-alvo primário. Por exemplo, podemos descobrir que, para um determinado paciente, seus comportamentos de autolesão ocorrem frequentemente no contexto de uma explosão de vergonha. A autolesão está relacionada com a vergonha para esse paciente, e o tratamento da autolesão exigirá o tratamento da vergonha. Melhorar o gerenciamento da vergonha torna-se um “alvo secundário” ou “alvo instrumental”, pois é secundário e instrumental para o tratamento do alvo primário.

Ao caracterizar os três dilemas dialéticos, que podem resultar em seis padrões comportamentais problemáticos, podemos ver que cada um dos padrões pode funcionar para promover ou manter um comportamento-alvo primário. Portanto, a resolução de cada padrão pode se tornar um alvo secundário: o tratamento da autolesão para um determinado paciente pode exigir o tratamento da autoinvalidação, ou o tratamento do uso problemático de substâncias pode exigir o tratamento de uma crise implacável em outro paciente. Além disso, a presença de qualquer um dos seis padrões pode dar origem a dois alvos de tratamento secundários. Por um lado, podemos trabalhar para diminuir o padrão problemático, por exemplo, diminuir a autoinvalidação. Por outro lado, podemos trabalhar para aumentar a aquisição, o fortalecimento e a generalização do conjunto de habilidades que podem substituir o padrão disfuncional, por exemplo, aumentar a autovalidação.

Começando com o primeiro dilema dialético discutido, podemos derivar quatro tipos potenciais de alvos secundários, dois para cada padrão. Com relação ao padrão de vulnerabilidade emocional, trabalhamos para 1) *diminuir a reatividade emocional* e 2) *aumentar* seu “antídoto”, a *modulação emocional*. Com relação ao padrão de autoinvalidação, trabalhamos para 3) *diminuir a autoinvalidação* e 4) *aumentar* seu “antídoto”, a *autovalidação*. Cada um desses quatro alvos secundários refere-se não a comportamentos simples e singulares, mas a um padrão complexo de emoção, cognição e ação, com um perfil diferente em cada caso. Em outras palavras, o esforço para aumentar ou diminuir um determinado padrão que serve como um alvo secundário exigirá uma compreensão dos ingredientes desse padrão. Por exemplo, a “competência aparente” de um paciente envolverá especificidades diferentes da “competência aparente” de outro paciente. O tratamento dos alvos secundários que são derivados dos dilemas dialéticos deve ser individualizado e especificado em cada caso.

Embora pareçam quase a mesma coisa, *diminuir a autoinvalidação* e *aumentar a autovalidação* são dois processos bem diferentes. Por exemplo, vamos supor que eu me odeie, convencido de que sou burro, gordo e feio. Essa autodifamação é baseada na atitude difundida do meu ambiente de invalidação original, mas eu perpetuo essa atitude no meu ódio por mim mesmo. Quase qualquer referência a aparências ou atratividade por alguém ao meu redor provoca uma série de declarações de autoinvalidação, auto-ódio e vergonha, e, eventualmente, eu me corto, o que “me dá o que eu mereço” e ao mesmo tempo proporciona um alívio temporário. Nesse cenário, a redução dos comportamentos de autolesão é o alvo primário; um dos alvos secundários é diminuir a autoinvalidação. Meu terapeuta DBT me fará monitorar meus episódios de autoinvalidação e comunicá-lo sobre os detalhes, e trabalhará comigo estrategicamente para reduzir minha autoinvalidação. Outro alvo secundário seria

aumentar a autovalidação. Em contraste com o esforço para reduzir a autoinvalidação, esse alvo envolveria trabalhar comigo estrategicamente para aumentar minha capacidade de validar meus próprios pensamentos, emoções e ações; isto é, para ver que minhas crenças de que sou gordo, feio e burro são compreensíveis, dada minha história. Isso envolveria direcionar um tom compreensivo e compassivo em relação ao meu próprio sofrimento, minha própria vergonha e a cadeia de eventos que me levou a este ponto. E pode envolver a validação de algumas das minhas habilidades com declarações motivadoras que criam um ponto de vista alternativo em relação a mim mesmo.

Eu estava avaliando os comportamentos-alvo primários de compulsão alimentar e purgação em uma mulher que expressou nojo em relação ao seu corpo. Ela sempre queria ser mais magra. Todos os seus esforços para extinguir seu apetite bastante normal foram malsucedidos, e ela alternava entre restrição e compulsão alimentar. A batalha com seu corpo e seu apetite era angustiante, mas parecia definir uma área, algo como um campo de batalha, na qual ela sentia uma medida de controle e esperança: esperança de que se pudesse reduzir sua ingestão, ela poderia se tornar mais magra e se sentir mais valiosa. Quando não estava lutando contra seu peso, a vida parecia sem sentido, vazia, e ela experimentava ondas de tristeza e desesperança. Ficou dolorosamente claro que quando não estava focada em controlar seu peso, a memória de certas perdas terríveis em sua vida voltava à mente, trazendo luto e tristeza.

Os comportamentos do transtorno alimentar de restrição, compulsão alimentar e purgação foram os comportamentos-alvo primários. Manter esses comportamentos-alvo envolveu vários dilemas dialéticos: vulnerabilidade emocional *versus* autoinvalidação, passividade ativa *versus* competência aparente e o padrão de luto inibido. Identificar os dilemas dialéticos ativos nesta paciente apontou para vários alvos secundários: diminuir a

reatividade emocional, aumentar a modulação emocional, diminuir a autoinvalidação, aumentar a autovalidação, diminuir a passividade ativa, aumentar a solução ativa de problemas, diminuir a competência aparente, aumentar a expressão precisa, diminuir o luto inibido e aumentar o processamento de estímulos relacionados à perda e ao trauma. A batalha para acabar com o transtorno alimentar seria travada dentro do território definido por vários padrões de dilemas dialéticos. Na medida em que o terapeuta tenha especificado os comportamentos problemáticos dentro dos dilemas dialéticos de um paciente em particular, ele pode ser bastante específico sobre como direcioná-los dentro do plano de tratamento.

Enquanto o “primeiro rascunho” de um plano de tratamento pode incluir metas de reduzir a passividade ativa e a competência aparente, o plano mais específico divide essas metas genéricas em detalhes. Com relação ao padrão de passividade ativa, o terapeuta pode estar trabalhando para 5) *diminuir comportamentos que resolvem problemas ao solicitar resgate de outras pessoas* e 6) *aumentar a solução ativa de problemas*. Com relação ao padrão de competência aparente, o terapeuta pode estar trabalhando para 7) *diminuir a dependência de humor* dos comportamentos e 8) *aumentar a comunicação precisa das emoções*. Uma vez que os alvos secundários sejam detalhados o suficiente, o terapeuta pode empregar estratégias da DBT para alcançá-los. Por exemplo, *aumentar a solução ativa de problemas* pode exigir habilidades aprimoradas de regulação emocional que ajudem a reduzir a evitação, melhores habilidades de efetividade interpessoal para aprimorar a capacidade de autoafirmação e dizer “não”, ou habilidades de autogerenciamento mais aprimoradas para fortalecer a função executiva.

Aumentar a comunicação precisa emprega várias habilidades: exercitar a consciência atenta e não julgadora das próprias emoções negativas, expressar as emoções de maneira precisa por

meio de canais verbais e não verbais, verificar se a comunicação pretendida foi recebida e ser específico ao pedir ajuda. Com relação ao alvo secundário de *diminuir a dependência de humor*, Linehan (2010, pp. 159-160) enfatiza que o paciente deve aprender a separar seu humor atual de suas ações atuais, de forma que as ações estejam alinhadas com as metas, não com os humores. O processo de passividade ativa, com sua perda de controle comportamental, é alimentado pela crença profunda de que se deve agir de acordo com o humor atual. Se estou deprimido, eu ajo deprimido; se estou com raiva, devo demonstrar minha raiva; e assim por diante. Se eu precisar de ajuda e ninguém estiver oferecendo, devo agir de maneira que me traga o apoio necessário, mesmo que isso signifique “desmoronar”. Para diminuir a dependência de humor e a passividade ativa, será necessário agir de maneira consistente com minhas metas de longo prazo, não com meu humor imediato. A aceitação radical da realidade, junto com uma série de habilidades de solução de problemas, será crucial para trabalhar esse alvo secundário.

Quando os comportamentos-alvo primários estão funcionalmente relacionados a padrões no terceiro dilema dialético, crises implacáveis *versus* luto inibido, mais quatro alvos secundários estão potencialmente em jogo. Com relação às crises implacáveis, o terapeuta está ajudando a 9) *diminuir os comportamentos que geram crises* e a 10) *aumentar a tomada de decisões realistas e o julgamento*. Com relação ao luto inibido, ele está ajudando a 11) *diminuir o luto inibido* e a 12) *aumentar a experiência emocional*. Novamente, observe que esses são tipos de alvos secundários, e não alvos secundários em si. Os detalhes precisam ser avaliados caso a caso.

Diminuir os comportamentos que geram crises exigirá abordagens diferentes para cada indivíduo, mas o problema discutido sobre a dependência do humor é geralmente importante aqui. Se um paciente “sente uma crise chegando”, ele precisa

aprender maneiras de agir contra esse “sentimento”. O terapeuta precisa desafiar o senso do paciente de que é inevitável ter uma crise após a outra e trabalhar em maneiras de estruturar o ambiente, gerenciar emoções e fazer escolhas comportamentais que reduzam a probabilidade de gerar uma crise. Aumentar a tomada de decisões realistas e o julgamento é o conjunto de habilidades “positivas” exigido aqui. Com frequência, indivíduos com TPB se acostumaram a ser receptores, muitas vezes vítimas, das decisões tomadas por outros e não adquiriram a atitude e a habilidade de determinar o próprio curso, gerar possíveis planos de ação, avaliar esses planos em relação aos possíveis resultados e fazer suas próprias escolhas.

Diminuir o luto inibido deve ocorrer em um relacionamento terapêutico quando a confiança se desenvolveu. Dentro de um contexto seguro, o terapeuta ajuda o paciente a entender que sofreu perdas e traumas cruciais, que estes são reais e causaram impactos reais, que o processo de inibir tais memórias e experiências tem consequências negativas e que, com assistência, esses eventos negativos da vida podem ser abordados com segurança e reflexão sem perder o controle. O terapeuta trabalhará com o paciente para aumentar a vivência emocional em geral, em vez de confiar na inibição como abordagem principal, e a vivência emocional específica em relação a perdas e traumas após mais confiança ter sido desenvolvida e mais habilidades terem sido adquiridas – e após o paciente querer fazê-lo. Parar de inibir o luto e aumentar a capacidade de experimentar emoções exigirá habilidades dos módulos de *mindfulness*, regulação emocional e tolerância ao mal-estar.

Ter o *menu* dos seis dilemas dialéticos e os doze alvos secundários associados ajuda a conceituar o caso e tratar o paciente. Eu já tratei uma mulher de 19 anos que vivia em uma família proeminente na qual todos os membros pareciam ser bem-sucedidos. Eles eram todos atraentes, tinham uma casa linda e,

em sua comunidade, eram admirados ou respeitados. Levou cerca de oito sessões antes que a jovem de 19 anos me revelasse que praticava autolesão. Na verdade, ela estava usando um martelo para esmagar seus pulsos. Ela quebrou ossos duas vezes, em cada caso alegando que estava sofrendo acidentes de *skate*. Quando avaliei o comportamento-alvo primário de quebrar seus próprios ossos, usei os dilemas dialéticos como um *menu* de possíveis variáveis controladoras, como um tipo de procedimento de varredura. Primeiro, considerando a vulnerabilidade emocional e a autoinvalidação, descobri que ela era extremamente crítica em relação a si mesma, considerando-se “uma idiota, uma fracassada e uma grande decepção”. Era emocionalmente vulnerável em relação à vergonha, em particular; quando batia nos próprios ossos, era quase sempre no contexto de se submeter a ataques verbais severos. Em segundo lugar, considerando a passividade ativa e a competência aparente, foi esta última que se destacou. Ela quase sempre se apresentava como atraente, envolvente, capaz e “bem”, correspondendo ao estilo de apresentação da família. Por trás dessa máscara, ela queria morrer, estava intensamente humilhada e vivia com medo de ser “desmascarada”. Sua competência aparente havia impedido que sua dor emocional fosse reconhecida, e foi apenas graças a um orientador universitário perspicaz que ela foi encaminhada para tratamento. Após um curto período em tratamento, ela estava clamando por ajuda. Eu nunca vi evidências reais de passividade ativa que provocava resgate dos outros. Em terceiro lugar, considerando as crises implacáveis e o luto inibido, mais uma vez essa paciente mostrou poucas evidências do padrão baseado na biologia (crises implacáveis), mas evidências proeminentes do baseado no ambiente (luto inibido). No caso dela, não parecia haver perdas notáveis (além da terrível perda de uma infância segura e conectada!) ou traumas pontuais; era mais como se ela se sentisse inválida de forma generalizada em sua família, com seu foco nas

aparências, durante anos. Portanto, em seu plano de tratamento, priorizei o foco na autoinvalidação, na vulnerabilidade emocional à vergonha, em particular, na competência aparente e no luto inibido. Consequentemente, esses quatro padrões sugeriram oito alvos secundários. Eu busquei:

1. Diminuir os julgamentos severos, as críticas e punições que ela direcionava a si mesma.
2. Aumentar a validação de seus próprios sentimentos, pensamentos, ações e forças.
3. Diminuir sua passividade e impotência em relação às suas emoções.
4. Aumentar suas habilidades na modulação de suas emoções, incluindo a vergonha, o que primeiro exigiu maior reconhecimento de suas emoções.
5. Diminuir sua apresentação “mascarada”, que primeiro envolveu ajudá-la a tomar consciência dessa característica automática.
6. Aumentar suas comunicações diretas de sofrimento emocional e sua disposição para me pedir ajuda.
7. Diminuir a supressão em relação às suas memórias e reações à invalidação.
8. Aumentar o processamento das memórias de invalidação significativa.

Não é que eu estava constantemente procurando por esses oito alvos secundários e tratando-os em todas as sessões; é que eu os tinha em mente como uma série de possíveis focos conforme o tempo passava no tratamento, e cada um deles se tornava um projeto em diferentes momentos. Cada um tomou forma em torno de eventos e tendências específicas. Enquanto mantinha meu olhar nos alvos primários, começando pela autolesão, eu observava como esses oito alvos secundários se alinhavam com o alvo primário em questão. Como mencionei, tempo e esforço de

tratamento são gastos nos alvos secundários; é o “trabalho pesado” da DBT.

ALGUMAS SUGESTÕES PARA TRABALHAR COM PACIENTES EM TORNO DE DILEMAS DIALÉTICOS

1. Ao descobrir a presença de um padrão comportamental extremo específico, considere se há evidências da presença do parceiro dialético desse padrão. Por exemplo, se você identificar competência aparente como um padrão, fique atento para elementos de passividade ativa. Às vezes, você pode perceber que, enquanto um indivíduo está envolvido no processo conhecido como competência aparente, mascarando seu sofrimento dos outros, pode haver evidências de crescente sofrimento e tensão sem uma saída adaptativa, preparando o cenário para um episódio de passividade ativa. Pode ser útil ver os dois padrões em conjunto.
2. Ao orientar o paciente sobre a presença de um determinado padrão e tentar cultivar um trabalho colaborativo nesse padrão, veja se você consegue criar uma linguagem que funcione para o indivíduo. Isso pode envolver uma metáfora, uma história ou até mesmo um desenho. É muito difícil focar nesses padrões sem a disposição do paciente, e a disposição costuma ser influenciada pela natureza da orientação e, principalmente, pela linguagem utilizada. Um terapeuta pode escolher o termo *mascarar emoções* em vez de usar o termo *competência aparente*, que soa bastante impessoal e pode ser confuso. Ele pode usar uma metáfora como *reduzir episódios de afogamento* em vez do termo clínico *diminuir reatividade emocional* para um determinado paciente, se isso funcionar melhor. Em um dos primeiros programas de internação em DBT para adolescentes, o programa desenvolveu o termo “*turtling*” (encolhimento) para retirada social e inexpressividade. O “*turtling*” temporário, para então “sair da

concha” e enfrentar a realidade, era adaptativo. Extremos de “*turtling*”, como permanecer na concha para sempre a fim de evitar a vida, eram problemáticos.

3. Ajude o paciente a ver como os comportamentos associados a esse padrão estão ligados e, na verdade, estão perpetuando o comportamento-alvo primário e obtenha a colaboração do paciente no alvo secundário. Por exemplo, se você orientou o paciente sobre a presença de competência aparente quando a dor emocional dele aumenta e o ajudou a nomeá-la e a ver seu resultado (um crescente senso interno de dor emocional, acompanhado por um crescente senso de isolamento e não reconhecimento), destacar como é esse padrão de crescente pressão interna e sem saída interpessoal provavelmente levará a erupções emocionais que podem continuar arruinando sua vida. Se você conseguir que o paciente seja “coproprietário” do padrão e veja quais habilidades serão necessárias para “trilhar o caminho do meio”, você terá uma melhor chance de reduzir o padrão e fortalecer o conjunto de habilidades “antídoto”.
4. Depois que o processo for esclarecido e observado várias vezes, pode ser útil colocar os alvos secundários, usando a linguagem amigável que foi desenvolvida, no diário ao lado dos alvos primários, para que o paciente possa monitorar sua ocorrência e os resultados. Por exemplo, o paciente pode se beneficiar ao monitorar o número de ocorrências diárias de “mascarar”, “autoinvalidação” ou episódios de crise.
5. Quando você identificar um padrão comportamental extremo e alvos secundários associados que estão funcionalmente relacionados a um alvo primário, tente gerar uma ideia concreta, uma imagem, de como esse paciente pode seguir em direção a trilhar o caminho do meio de comportamentos eficazes que possam substituir o padrão problemático. É minha experiência que, quanto mais claramente posso evocar

essa imagem de meus pacientes como indivíduos funcionais em seus domínios particularmente problemáticos de funcionamento e quanto mais posso identificar especificamente conjuntos de habilidades que os ajudarão a atualizar essa imagem funcional, mais provável é que eu faça intervenções construtivas voltadas para habilidades nas sessões.

DE DILEMAS DIALÉTICOS A ALVOS SECUNDÁRIOS E PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO: UM EXEMPLO DE CASO

Um psiquiatra me encaminhou um jovem de 22 anos para tentar a DBT. O jovem procurou o psiquiatra a pedido de sua mãe depois de ser preso por furtar lojas três vezes em três meses. O psiquiatra descobriu que ele também tinha um histórico de autolesão para alívio da ansiedade social e mostrava julgamento impulsivo nos relacionamentos. Estava tirando um ano de folga da faculdade após os episódios de autolesão virem à tona, além de usar substâncias alucinógenas e matar aulas. Ele atendia aos critérios para TPB devido à instabilidade emocional, ao caos nos relacionamentos, a episódios de comportamento suicida e outras autolesões, a um sentimento crônico de vazio e à perturbação de identidade. Ele concordou em fazer DBT.

Durante a avaliação, descobri que sua vida em casa havia sido peculiar e preocupante: sua mãe bebia álcool quase constantemente, seu pai passava a maior parte do tempo no porão, sua irmã tinha uma grave doença autoimune que exigia toda a atenção que os pais podiam dar, e parecia que meu paciente havia se criado sozinho. Ninguém na família o via como alguém com problemas ou precisando de apoio emocional, embora ele fosse instável em seu funcionamento. Em seus relacionamentos com colegas, os outros frequentemente contavam com ele para obter apoio, e ele ressentia-se de que raramente retribuía quando precisava. Ele não pedia apoio, mas achava que deveria ser óbvio. Nos fins de semana, usava substâncias alucinógenas com amigos; sentia que era o único momento em que abria a mente para o que estava acontecendo dentro dele. Ele queria terminar a faculdade, obter um diploma em arte (era um talentoso

escultor) e viajar para a Europa, onde pensava que gostaria de morar.

Ele era obviamente inteligente e envolvente e tinha peculiaridades.

Nas sessões e, às vezes, por meio de longas mensagens de texto, ele relatava coisas que tinham acontecido, às vezes eventos preocupantes resultantes de decisões mal pensadas, como a vez em que seu carro foi roubado depois que o emprestou a alguém que mal conhecia. Sempre que eu mostrava interesse e perguntava mais sobre experiências que me pareciam dolorosas ou problemáticas, me dizia que estava bem, o evento havia terminado, ele havia “aprendido a lição” e queria seguir em frente. Em certo sentido, ele cooperava comigo na terapia e mostrava grande interesse nas habilidades, mas geralmente afirmava “já ter resolvido” todos os problemas antes de vir às sessões.

Nas primeiras semanas de tratamento, seus principais alvos eram 1) parar de furtar, 2) manter uma boa frequência na terapia (já que em terapias anteriores havia apresentado baixa frequência e eventualmente desistido) e 3) “encontrar um amigo que seja como eu, mudando o tempo todo”. Vários meses se passaram desde o último episódio de autolesão. Ele não concordava comigo que o uso de drogas alucinógenas era um comportamento problemático; sentia que estava seguro usando essas drogas e que isso constituía outra “forma de terapia”. No entanto, ele concordou que furtar era um problema e queria parar com isso. Durante nossas primeiras seis semanas, foi flagrado furtando duas vezes. O furto sempre era em lojas grandes, consistia em esconder itens relativamente pequenos sob sua camisa ou casaco, e ele experimentava grande suspense sobre se seria pego.

Fizemos várias análises em cadeia do comportamento de furtar. Ficou claro desde o início que a consequência mais reforçadora do furto para ele, fosse pego ou não, era a sensação de emoção e suspense. Independentemente do estado emocional antes de

roubar, sua imersão no “jogo” do furto o tirava daquele estado e o fazia se sentir melhor. Por consequência, o plano de tratamento focou na redução dos comportamentos de furto e na busca de atividades legais que o ajudariam a reduzir os estados de humor negativos e criar emoções positivas.

Por meio da análise em cadeia do comportamento de vários episódios de furto, passados e presentes, identificamos o seguinte. Primeiro, seu pensamento irrealista, seu péssimo julgamento e os eventos negativos repetidos se encaixavam no perfil de *crises implacáveis*. Segundo, sua insistência de que estava “bem”, que estava “seguindo em frente” e que qualquer sofrimento genuíno parecia ser parte do passado se encaixava no perfil de *competência aparente*. Ele estava mascarando sua dor emocional, repelindo convites para expressar seus sentimentos dolorosos. Esse padrão parecia estar de acordo com sua experiência de que ele era o “OK” na família, que era o mais emocionalmente capaz nas amizades e que ficava chateado que os outros não conseguiam retribuir seu apoio a eles, mesmo que ele não pedisse. O suspense e o drama em torno de cada evento de furto serviam para “resgatá-lo” de estados emocionais negativos insolúveis, e poderiam ser vistos como uma variante de *passividade ativa*, o parceiro dialético da *competência aparente*.

No início da terapia, o orientei aos perfis de crises implacáveis e competência aparente, e começamos a trabalhar no desenvolvimento de sua capacidade de julgamento mais realista para reduzir seus comportamentos geradores de crise e em sua capacidade de observar e descrever seus sentimentos nas sessões, a fim de reduzir a competência aparente e aumentar a expressão emocional precisa. Identificar dois (e em algum grau, três) padrões de comportamento do dilema dialético que pareciam estar associados ao furto, formulando os alvos secundários correspondentes e intervindo para mudá-los, proporcionou um

senso de direção e um rico conjunto de oportunidades terapêuticas.

Mas o que realmente fez a diferença no nosso trabalho conjunto, levando-o a um nível mais profundo e potente, começou com minha observação de que, embora o padrão de *crises implacáveis* estivesse obviamente presente, eu não via evidências claras da presença de seu parceiro dialético, o padrão de *luto inibido*. No entanto, ele parecia se opor a processar eventos negativos e minimizava a natureza invalidante de sua infância. Eu ficava muito mais chateado com suas descrições do que acontecia em casa do que ele. Fiquei convencido de que ele, de fato, se encaixava no perfil de *luto inibido* e insisti com mais força para aprender com ele sobre as perdas em sua vida, o impacto negativo de seus ambientes invalidantes anteriores e atuais e suas reações emocionais a algumas de minhas intervenções menos eficazes.

Ao investigar, logo fui recompensado com referências a “coisas ruins” que às vezes aconteciam no porão quando ele ia ver seu pai. Relutante em revelar algo no início, ele começou a contar história após história de como seu pai, sob a influência de álcool e drogas, implorava ao meu paciente para estimulá-lo sexualmente. Em duas ocasiões, descreveu ter sido espancado pelo pai por se recusar a participar. Ele tinha medo de ir ao porão e medo de não ir, e nunca havia contado a ninguém. Embora as ligações precisas entre essas experiências terríveis e seus comportamentos de furto nunca tenham ficado completamente claras, notou-se que, ao revelar essas lembranças e processar suas respostas emocionais nas sessões, os comportamentos de furto perderam a urgência e desapareceram de seu repertório comportamental. Mais tarde, ele não conseguia se lembrar de por que os “jogos de furto” eram tão atraentes.

Em suma, o que começa com a tentativa de resolver um alvo primário leva ao reconhecimento de dilemas dialéticos que interferem na solução. Uma vez que os dilemas dialéticos são

reconhecidos e detalhados, eles resultam na especificação de alvos secundários. Uma vez que há clareza suficiente sobre os alvos secundários, o terapeuta pode empregar estratégias e habilidades para resolvê-los e, por meio desse processo, resolver o alvo primário.

POR QUE APENAS TRÊS DILEMAS DIALÉTICOS?

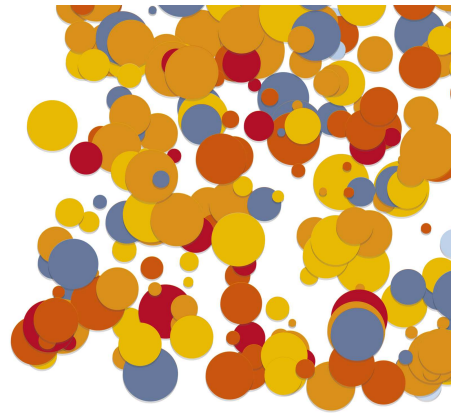
Embora eu não tenha evidências empíricas para o que estou prestes a explicar, achei essa uma maneira produtiva de pensar sobre dilemas dialéticos. Ocorreu-me que cada um dos três dilemas dialéticos representa um resultado disfuncional de um processo de desenvolvimento normativo. Vulnerabilidade emocional *versus* autoinvalidação representa um fracasso no processo de *aprender a modular emoções*, o que toda criança precisa fazer. A criança com maior vulnerabilidade emocional, baseada na biologia, que realiza essa tarefa de desenvolvimento no contexto de invalidação global e invasiva, experimenta dois padrões disfuncionais em relação à modulação das emoções, um mais biologicamente orientado (vulnerabilidade emocional) e o outro mais socialmente orientado (autoinvalidação). A presença de uma emoção forte é processada de uma dessas duas maneiras problemáticas, e o conjunto de habilidades funcionais para modular emoções não se desenvolve.

Da mesma forma, quando a tarefa de desenvolvimento de *aprender a identificar, tolerar e expressar dor emocional com precisão e buscar apoio* ocorre nesse ninho biossocial, dois padrões disfuncionais surgem em vez do conjunto de habilidades funcionais de expressar emoções com precisão e pedir ajuda. A passividade ativa é a mais impulsionada pelo fator biológico, incluindo uma medida de descontrole, e a competência aparente é a mais impulsionada pelo fator social. E quando a importante tarefa de desenvolvimento de *gerenciar e processar perdas e traumas* ocorre no campo de forças transacionais biossociais, o dilema dialético de crises implacáveis *versus* luto inibido é o resultado, o primeiro sendo mais impulsionado pelo fator biológico e o último pelo ambiente invalidante. O fracasso dessas três tarefas de desenvolvimento resulta nos seis padrões de comportamento, cada

um dos quais poderia eventualmente funcionar de uma maneira que mantém comportamentos-alvo primários, incluindo episódios de comportamento suicida.

Então, se entendermos o modelo dessa maneira, não há uma razão *a priori* para haver apenas *três* dilemas dialéticos. Se considerarmos outras tarefas de desenvolvimento que possam ser afetadas negativamente pelos fatores observados na teoria biossocial, podemos descobrir outros dilemas dialéticos. Por exemplo, considere a tarefa pela qual a criança em crescimento se diferencia dos outros em relacionamentos, com limites distintos e claros entre “eu” e “outro”. Pode-se prever dois resultados disfuncionais, um em que a criança está caoticamente superenvolvida com um cuidador e outro em que está desligada em um grau problemático. A criança com neurobiologia do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), que enfrenta a tarefa de desenvolvimento de aprender a aceitar essas características e funcionar efetivamente no mundo, pode acabar, em vez disso, com um dilema dialético, vulnerabilidade extrema ao TDAH *versus* autocrítica de déficits. A criança que experimenta alucinações auditivas no início da vida, ou outras experiências perceptuais incomuns, e que precisa desenvolver um ponto de vista compassivo e aceitador, juntamente com um conjunto de habilidades para lidar com essas percepções, pode evoluir um dilema dialético de “vulnerabilidade alucinatória” *versus* autocrítica. Em outras palavras, em vez de pensar nos três dilemas dialéticos como os únicos possíveis e procurar encaixar todas as formulações de casos neles, podemos pensar neles como três exemplos excelentes e típicos de uma fórmula pela qual o *fracasso de uma tarefa de desenvolvimento resulta em dois padrões disfuncionais relacionados àquela tarefa*. Esse uso da construção subjacente aos dilemas dialéticos nos liberta para 1) avaliar os comportamentos problemáticos de nossos pacientes com uma mente aberta, 2) procurar os padrões comportamentais extremos

que mantêm esses comportamentos, 3) procurar a relação dialética entre esses padrões, 4) vincular os padrões à tarefa que o indivíduo estava tentando realizar dentro do ninho biossocial e 5) tentar mover o paciente dos padrões comportamentais extremos para o caminho do meio específico com seus comportamentos habilidosos.



Formulação de caso em terapia comportamental dialética

Localizada precisamente entre a teoria e a prática está a formulação de caso. A teoria encontra seu caminho no tratamento por meio da formulação de caso, que direciona o planejamento do tratamento e as intervenções. A prática, que inclui avaliação contínua e intervenções de tratamento, gera dados de “resultado” no momento, que informam a formulação de caso, às vezes confirmando-a e às vezes levando a revisões. Assim como um empreiteiro consulta periodicamente os projetos enquanto constrói, o terapeuta consulta a formulação de caso. Como ela é o elo crucial entre a teoria e a prática, podemos esperar que seja a ilustração mais clara, concisa e prática do modelo de terapia específico.

Por exemplo, a formulação de caso na psicoterapia focada na transferência (TFP) de Kernberg (1975) gira em torno da ativação das unidades de relações objetais intrapsíquicas, com representações do eu e do objeto e estados afetivos vinculativos. O terapeuta identifica a divisão intrapsíquica das representações do eu e do objeto à medida que emergem na relação de transferência e intervém para esclarecer e resolver a atividade e os produtos da divisão. A formulação de caso na terapia baseada na mentalização (TBM) gira em torno da ativação e desativação das capacidades e modos de mentalização do paciente. A TBM orienta o terapeuta em direção a intervenções que fortaleçam a capacidade do paciente de mentalizar e de restaurar e manter essa

capacidade diante do aumento da emocionalidade e das pressões de uma relação de apego (Bateman & Fonagy, 2004).

Neste capítulo, examinamos a natureza e o papel da formulação de caso na terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*). Ao contrário de alguns modelos, os terapeutas DBT não “formulam o caso” em si, mas as variáveis que mantêm um determinado comportamento-alvo. A formulação dos comportamentos de autolesão de um indivíduo pode diferir significativamente da formulação do uso de substâncias do mesmo indivíduo. Mesmo dentro da gama de comportamentos autolesivos, a formulação de caso dos comportamentos de se cortar de um indivíduo pode diferir distintamente de seus comportamentos de se queimar.

A formulação de caso começa, em primeiro lugar, identificando o comportamento-alvo de interesse, geralmente o comportamento-alvo de maior prioridade naquele momento do tratamento. Embora seja o caso de o terapeuta DBT avaliar e formular um determinado comportamento-alvo de alta prioridade, na verdade os padrões e as variáveis controladoras descobertos nesse processo provavelmente fornecerão uma “vantagem inicial” na formulação de outros comportamentos-alvo do mesmo paciente. Em segundo lugar, o terapeuta identifica o estágio do tratamento. Isso importa. Abordar um comportamento autolesivo durante o estágio pré-tratamento, quando a meta do tratamento é obter o comprometimento do paciente, é diferente de abordar o mesmo comportamento durante o estágio 1, quando a meta do tratamento é aumentar a estabilidade e o controle comportamental. Esse mesmo comportamento, se reaparecer durante o estágio 2, quando a meta do tratamento é aumentar a capacidade do paciente de vivenciar experiências emocionais sem intenso sofrimento, será formulado de maneira diferente.

PRINCÍPIOS COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS E VOCABULÁRIO NA FORMULAÇÃO DE CASO

O modelo para uma formulação de caso em DBT é a cadeia do comportamento. De fato, a cadeia serve como estrutura organizadora e plataforma para a avaliação e o tratamento de um determinado comportamento-alvo de alta prioridade. Antecedentes serão encontrados à esquerda do comportamento, e consequências, à direita. Durante a primeira análise em cadeia para um determinado comportamento, em colaboração com o paciente para definir os elos anteriores e posteriores ao comportamento, o terapeuta não pode dizer quais desses elos e quais padrões entre eles serão fundamentais para determinar as variáveis controladoras do comportamento. O terapeuta com frequência conclui rapidamente que um certo elo (ou padrão de elos) foi fundamental na perpetuação daquele problema comportamental, apenas para descobrir mais tarde que era um falso sinal, pouco central para a manutenção do comportamento. Em um tratamento de uma paciente que foi estuprada de forma traumática por um amigo e que posteriormente apresentou transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e comportamentos suicidas, inicialmente estava convencido de que a experiência de ser penetrada contra sua vontade era a variável determinante mais importante. Somente mais tarde descobri que o elo mais profundo da cadeia ocorreu uma hora antes daquele momento, quando ela notou, mas ignorou o significado de uma ação relativamente menor de seu bom amigo e futuro agressor, quando ele roçou a parte de trás do pescoço dela quase incidentalmente ao entrarem em um cômodo.

O terapeuta deve proceder com atenção cuidadosa, formulando hipóteses à medida que avança, com a humilde compreensão de que seus primeiros pressupostos provavelmente estarão errados.

É melhor prosseguir com uma atitude de curiosidade e abertura. Na segunda, terceira e quarta vezes em que ele descreve os elos de uma cadeia desse problema comportamental, o terapeuta e o paciente começam a discernir a natureza dos elos e padrões que estão associados, repetidamente, com aquele comportamento. Além disso, a cadeia “genérica” em evolução para aquele comportamento começa a ganhar mais forma e mais detalhes. Depois de várias cadeias terem sido construídas, o terapeuta fica mais confiante de que encontrou padrões associados e, mesmo que eles possam não causar o comportamento, estão pelo menos correlacionados. Eles convidam para uma maior atenção. Ao colaborarem na definição dos elos e padrões controladores, o paciente e o terapeuta podem trabalhar em soluções para esses padrões e, assim, impactar o comportamento-alvo.

Deixe-me dar um exemplo. Comecei a trabalhar com uma mulher que tinha um longo histórico de episódios de comportamentos suicida e autolesivos. Ela também tinha episódios de dissociação, depressão maior crônica e refratária, TEPT baseado em abuso sexual na infância e consumo excessivo de álcool. Por algum tempo, seus comportamentos-alvo de maior prioridade eram seus episódios de comportamento suicida. Em particular, estávamos realizando a avaliação dos episódios por *overdose*. Após várias análises em cadeia, os seguintes padrões começaram a se tornar evidentes:

1. Ela parecia mais propensa à autolesão nos dias em que não havia dormido nada durante a noite anterior.
2. Parecia que as tentativas eram mais prováveis de ocorrer quando ela estava com um grupo de pessoas, em vez de estar sozinha ou com um amigo ou dois.
3. Ela notou um alto grau de auto-ódio na maioria das vezes em que estava com um grupo.

4. Parecia que, naquelas cadeias que incluíam um episódio de comportamento suicida, havia algum tipo de referência antecedente ao corpo dela: por exemplo, “Fui nadar com amigos hoje”, “Percebi que estou ganhando peso” e “Estou com medo de estar pegando uma queimadura de sol”. Após investigação adicional, ela notou que qualquer referência ao seu corpo desencadeava um nojo visceral em relação a si mesma.
5. Episódios de comportamento suicida por *overdose* resultavam em longos episódios de sono e, quando ela acordava, o desejo de se matar havia desaparecido.

Sempre que conseguíamos caracterizar e definir melhor um padrão nessas cadeias, tínhamos outro ponto de entrada em potencial e, portanto, outra solução possível. À medida que lentamente chegávamos a uma cadeia “típica” ou “genérica” para seu comportamento problemático, construíamos cuidadosamente e testávamos um plano de tratamento, ou melhor, uma série de “miniplanos” de tratamento para cada padrão. Por tentativa e erro, descobríamos quais variáveis estavam associadas aos episódios de comportamento suicida, quais variáveis se prestavam a intervenções voltadas para a mudança e quais variáveis precisavam mudar antes que outras pudessem ser abordadas. Um dos desafios de ser um terapeuta DBT, conceituando as variáveis controladoras à medida que a terapia avança, é a prática de manter em mente uma série de hipóteses sobre diferentes “locais” na cadeia, fazendo intervenções de tentativa e erro para esclarecer ainda mais seus papéis e evitando chegar prematuramente a conclusões sobre onde intervir. O processo de formular, reformular e refinar essas formulações ao longo do tempo, investigando e avaliando, intervindo e observando, pode ser uma maneira útil para o terapeuta permanecer engajado em um processo de investigação e intervenção sem ceder à tentação de “saber” qual é a variável

crítica antes que os dados sejam suficientes. Por si só, esse processo de investigação colaborativa é uma atividade terapêutica importante.

Para ser mais claro e prosaico, uma formulação de caso em DBT requer a determinação dos elos e dos padrões da cadeia genérica, e o planejamento do tratamento é baseado nessa determinação. Ocorre de forma colaborativa; envolve uma abordagem lógica (dedutiva) juntamente a intervenções de tentativa e erro (indutivas); e evolui por meio do discernimento sobre padrões que podem ser descobertos pelo paciente e/ou terapeuta. Consistente com as teses centrais deste livro, uma formulação de caso em DBT é moldada, em seu núcleo, ao longo das linhas de um modelo racional, lógico e cognitivo-comportamental, e depois modificada e ampliada ao trazer princípios associados ao *mindfulness* e à dialética. Agora passo para a estrutura racional, baseada na TCC, e, em seguida, considero como essa estrutura é modificada com princípios de *mindfulness* e dialética.

Considere o “vocabulário” de uma cadeia da DBT. É uma representação cronológica e horizontal de um fluxo contínuo de um episódio específico de um dado comportamento, composto por elos e padrões. Cada elo é um comportamento do paciente (uma emoção, um evento fisiológico, uma cognição ou uma ação) ou um comportamento ou característica do contexto ambiental com o qual ele interage. Com base na teoria da DBT e orientados pelos princípios da ciência cognitivo-comportamental em seu núcleo, como terapeutas DBT estamos especialmente interessados em certos tipos de elos. Primeiro, há aqueles elos que refletem a sensibilidade emocional baseada na biologia do paciente, a reatividade e o retorno lento à linha de base. Em segundo lugar, estão os elos que refletem a invalidação do paciente pelo ambiente. Quanto mais soubermos sobre o paciente, mais sensivelmente podemos identificar a vulnerabilidade emocional na

cadeia, e com mais precisão podemos identificar esses eventos contextuais que são invalidantes para ele. Na paciente mencionada anteriormente, não foi fácil reconhecer sinais de vulnerabilidade emocional no início, pois ela os mascarou nos contextos invalidantes que caracterizavam sua vida precoce. Mas, à medida que os sinais sutis de sensibilidade se tornaram mais aparentes e ela passou a reconhecê-los e comunicá-los na terapia, nossa identificação desses momentos se tornou mais precisa e mais frequente. Para cada indivíduo, um “ambiente invalidante” tem uma assinatura única. No caso dela, vivenciava invalidação toda vez que pensava que alguém deveria saber que estava chateada. Embora sua máscara fosse eficaz em disfarçar seu aborrecimento, ela ainda achava que deveria ser óbvio para os outros. À medida que caracterizamos esse tipo de invalidação “invisível”, tornou-se mais evidente que estava acontecendo quase o tempo todo, inclusive na terapia. Nossos “instrumentos de detecção” se tornaram mais sensíveis e válidos e, à medida que fizeram isso, pudemos aprofundar e ampliar nossa compreensão dos padrões causais mais relevantes. Mais importante ainda, começamos a encontrar mais maneiras de ajudá-la a obter o que precisava para modular suas emoções e comunicar seu sofrimento.

Se as duas primeiras categorias relevantes de elos na cadeia DBT são instâncias de vulnerabilidade emocional e invalidação ambiental com referência direta à teoria biossocial, as próximas seis são elos ou sequências de elos que representam qualquer um ou todos os seis padrões comportamentais descritos como opostos polares dos três dilemas dialéticos, discutidos no Capítulo 8. Para revisar, três deles representam a experiência subjetiva do paciente da vulnerabilidade emocional baseada na biologia: passividade ativa, vulnerabilidade emocional e crises implacáveis. Os outros três parecem manifestar a influência do ambiente invalidante: competência aparente, autoinvalidação e luto inibido. Sempre que notamos a presença de elos que parecem fazer parte de um

desses seis padrões, consideramos a possibilidade de que esses elos sejam importantes para determinar e manter o comportamento problemático. Na paciente mencionada, sua “máscara” fazia parte de uma síndrome de competência aparente, que, uma vez identificada, foi vista por ambos como desempenhando um papel enorme em suas espirais crescentes de sofrimento emocional oculto e, finalmente, em seus episódios de comportamento suicida. Privada da oportunidade de encontrar ajuda de maneira construtiva enquanto estava escondida atrás de sua máscara de competência aparente, seus episódios de comportamento suicida serviam como uma função de um pedido de ajuda, que era uma forma de passividade ativa. Suas instâncias de ódio a si mesma e repulsa em relação ao seu corpo eram elos em um padrão de autoinvalidação, um padrão crucial para entender e tratar. Enquanto ela transmitia uma sensação de reserva e controle, “por trás das cenas” estava muito frequentemente (várias vezes por dia) vivenciando episódios de vulnerabilidade emocional: a sensação de que não tinha controle, que suas emoções a estavam dominando, que poderia morrer simplesmente por ter emoções desreguladas. Demorou mais tempo para discernir que um padrão profundo e persistente que perpetuava seus episódios de comportamento suicida envolvia seu luto inibido: ela estava constantemente suprimindo e protegendo contra o surgimento de quaisquer pensamentos ou emoções relacionados ao seu passado traumático. E, ao fazer isso, qualquer estímulo que desencadeasse essas memórias e emoções provocaria episódios de crises de muitos tipos – isto é, crises implacáveis como padrão.

Neste caso específico, todos os seis padrões pertencentes aos três dilemas dialéticos entraram em jogo de forma muito ativa e frequente. Em outros casos, encontra-se a predominância de um ou mais, mas não todos os seis. Há alguns pacientes com transtorno da personalidade *borderline* (TPB) e anorexia nervosa, por exemplo, nos quais os padrões mais proeminentes são aqueles

de supercontrole derivados de um ambiente percebido como excessivamente controlador, caracterizado principalmente por competência aparente (“Estou bem!”), autoinvalidação (“Nunca sou bom o suficiente, nunca estou magro o suficiente”) e luto inibido. Em qualquer caso, a determinação das seis categorias de padrões mencionadas até este ponto, todas consistentes com a teoria biossocial da DBT, contribui para uma crescente compreensão das funções – as forças motrizes e os propósitos – do comportamento problemático. Armado com esse tipo de entendimento baseado em padrões, o terapeuta pode monitorar ainda mais os padrões e propor procedimentos para mudá-los.

Depois, há mais quatro categorias de variáveis controladoras potenciais para as quais terapeuta e paciente devem estar atentos enquanto fazem análises em cadeia do comportamento. Cada categoria é baseada em um dos procedimentos de mudança da DBT, os quais são embasados na terapia cognitivo-comportamental (TCC). Associadas aos procedimentos de manejo de contingência, há as contingências problemáticas que reforçam a prática contínua do comportamento problemático. Na paciente mencionada anteriormente, que raramente dormia o suficiente e para quem o esgotamento parecia desempenhar um papel em seu crescente sofrimento, seus episódios de comportamento suicida por *overdose* poderiam levar seu sofrimento a um fim (temporário) e fornecer-lhe várias horas de sono restaurador. Essas eram contingências que revelavam algumas das funções de seus episódios de comportamento suicida, que poderiam ser levadas em consideração na solução de problemas.

Uma segunda categoria baseada em TCC de variáveis relevantes diz respeito a emoções poderosas que são desencadeadas, automática e instantaneamente, por sinais emocionalmente salientes no ambiente. Assim que descobrirmos o papel único e potente dessas respostas emocionais baseadas em sinais, que são um condicionamento clássico a estímulos

traumáticos e perturbadores, podemos organizar intervenções em torno de reconhecimento, modificação, gerenciamento e, em última instância, exposição terapeuticamente eficaz a esses sinais.

Além dos importantes papéis que contingências e emoções problemáticas podem desempenhar em uma cadeia que leva a comportamentos disfuncionais, há outras duas categorias: cognições problemáticas e déficits de habilidades. Nós “examinamos” cognições disfuncionais como “Sou incompetente”, “Ninguém jamais vai gostar de mim”, “Nunca vou ter sucesso”, “Sou apenas uma semente ruim e mereço todo o castigo que recebo”, e assim por diante. Localizar esses tipos de cognições, trabalhar com o paciente para entender seu papel e apreciar o fato de que são pensamentos, não fatos, fornece outra via para mudar a cadeia. Por fim, as cadeias de comportamento da maioria dos indivíduos com TPB, quando incluem comportamentos severamente prejudiciais, são pontuadas por múltiplos déficits de habilidades em tolerar mal-estar, regular emoções, manter equilíbrio e interagir efetivamente com os outros. Como é óbvio na DBT, o terapeuta rotineiramente tem esses múltiplos déficits de habilidades como alvos.

Tendo identificado oito categorias de elos e padrões derivados da teoria biossocial da DBT e dilemas dialéticos, e mais quatro derivados da ciência cognitivo-comportamental, pode ser útil listá-los aqui antes de adicionar alguns outros.

1. Vulnerabilidade emocional, identificada objetivamente na teoria biossocial como maior sensibilidade, reatividade e retorno lento à linha de base.
2. Episódios invalidantes, nos quais o paciente é invalidado pelo ambiente.
3. Vulnerabilidade emocional, subjetivamente vivenciada como agonizante pelo paciente.
4. Autoinvalidação.

5. Passividade ativa.
6. Competência aparente.
7. Crises implacáveis.
8. Luto inibido.
9. Contingências problemáticas.
10. Emoções problemáticas.
11. Cognitiones problemáticas.
12. Déficits de habilidades.

Como psiquiatra que também tenta determinar se o paciente sofre de um transtorno psiquiátrico que possa ser responsivo a medicamentos psicotrópicos, considero uma 13ª categoria: a presença de uma condição psiquiátrica. Embora seja verdade que quase qualquer condição se manifestará de maneiras já representadas nas 12 categorias listadas, acho clinicamente útil identificar qualquer condição com base biológica que possa indicar o uso de medicamentos psicotrópicos. Se eu determinar que meu paciente apresenta evidências convincentes de um transtorno depressivo maior de natureza moderada a grave, posso intervir nesse transtorno com medicamentos (entre outras intervenções comportamentais). Se meu paciente apresenta evidências de um transtorno bipolar proeminente ou transtorno de pânico, posso considerar opções de medicação para tratar uma dessas variáveis controladoras potentes.

Todos os 13 fatores identificados até este ponto estão focados na apresentação comportamental do paciente e na cadeia do comportamento. Mas ainda há outras variáveis no ambiente do paciente que podem estar impulsionando o comportamento-alvo, ou seja, variáveis contextuais. O primeiro conjunto de variáveis contextuais relevantes pode ser encontrado no contexto familiar-social do paciente. Uma formulação de caso geralmente é incompleta sem identificar interações problemáticas com membros da família ou indivíduos que fazem parte da rede social do

paciente. As intervenções usuais da DBT envolvem consultoria para o paciente para lidar com esses tipos de contextos ambientais, mas, em alguns casos, o terapeuta intervém diretamente nos fatores contextuais: com os indivíduos ou circunstâncias no ambiente. Isso é mais obviamente o caso no tratamento de um paciente adolescente em DBT, no qual a família está envolvida no tratamento, mas também pode ser verdade com pacientes adultos.

O outro conjunto de variáveis contextuais importantes é o daquelas no contexto do tratamento da DBT. Se o terapeuta individual e os treinadores de habilidades em grupo não estiverem “sincronizados” ou a equipe de consultoria não estiver fornecendo apoio suficiente ao terapeuta individual, esses fatores não relacionados ao paciente podem desempenhar um papel discreto e facilitador, culminando em um episódio de comportamento suicida. Eles também devem ser avaliados e atendidos como parte da formulação de caso e, se indicado, parte do tratamento.

O “vocabulário de variáveis controladoras” enumerado até este ponto são aqueles fatores que podem contribuir para a causa ou manutenção de comportamentos problemáticos que queremos diminuir. Igualmente importante é a atenção dada às variáveis que estão suprimindo comportamentos funcionais e habilidosos que queremos aumentar. A construção de habilidades e de padrões de vida construtivos deve ocorrer paralelamente à redução de padrões problemáticos, mas às vezes esse processo se desgasta enquanto nos concentramos na patologia. O terapeuta precisa examinar os elos e padrões funcionais: variáveis contextuais de apoio, padrões comportamentais resilientes e favoráveis em geral e, em particular, uso de padrões comportamentais habilidosos e adaptativos. No caso da paciente mencionada anteriormente com inúmeros episódios de comportamento suicida, seus fatores favoráveis estavam escondidos atrás do caos e da disfunção de sua vida diária, pouco perceptíveis após anos vivendo à beira da morte,

entrando e saindo de hospitais. Pouco reconhecemos, até cultivá-las deliberadamente, que suas habilidades intelectuais eram substanciais, haviam sido importantes em seus anos de adolescência e se mostrariam instrumentais em seu sucesso final no tratamento. Embora ler e pensar fossem “razões para viver” e alicerces de uma vida imaginada anos atrás, eles haviam sido enterrados por muitos anos. Quando ela reconheceu, após questionamento, que não lia um livro há anos e que simplesmente não conseguia acalmar sua mente o suficiente para se concentrar em uma história escrita, concordou com o uso de medicamento estimulante para melhorar sua capacidade de se concentrar na leitura. Em duas semanas, estava lendo novamente, o que se mostrou um grande consolo e foco construtivo para ela. Essa descoberta de um recurso há muito inutilizado acabou sendo um dos blocos de construção em seu progresso. Tão importante quanto reconhecer e ativar fatores comportamentais resilientes subutilizados no paciente, devemos incluir o reconhecimento da relação do ambiente com essas características adaptativas. Se o ambiente não os reforça, ou pior, está até mesmo punindo e suprimindo-os, isso se torna parte da formulação de caso e pode ser abordado no tratamento.

Adicionando os fatores contextuais e os fatores de construção de resiliência à nossa avaliação de vocabulário, temos um *menu* de 17 tipos de elos ou padrões que compõem uma formulação de caso DBT.

1. Vulnerabilidade emocional, identificada objetivamente como maior sensibilidade, reatividade e retorno lento à linha de base.
2. Episódios invalidantes, nos quais o paciente é invalidado pelo ambiente.
3. Vulnerabilidade emocional, vivenciada subjetivamente como agonizante pelo paciente.

4. Autoinvalidação.
5. Passividade ativa.
6. Competência aparente.
7. Crises implacáveis.
8. Luto inibido.
9. Contingências problemáticas.
10. Emoções problemáticas.
11. Cognitiones problemáticas.
12. Déficits de habilidades.
13. Manifestações de um transtorno psiquiátrico com base biológica.
14. Fatores contextuais reforçando comportamentos problemáticos: família, rede social, rede profissional (não DBT).
15. Fatores contextuais reforçando comportamentos problemáticos: programa de tratamento em DBT.
16. Fatores comportamentais resilientes e adaptativos.
17. Fatores contextuais fortalecendo fatores resilientes e adaptativos.

PRINCÍPIOS DE *MINDFULNESS* NA FORMULAÇÃO DE CASOS

Se o *menu* de variáveis controladoras relevantes, derivado da TCC e da DBT, representa o modelo racional semelhante a um plano para a formulação de casos, o modelo é utilizado de maneira adicionalmente informada pelos princípios do *mindfulness* e da dialética. Entre os princípios subjacentes ao *mindfulness* está o desapego aos próprios pensamentos, julgamentos e percepções. Assim como o terapeuta aplica o modelo de maneira científica e o investe com diligência e disciplina, ele também percebe que é uma formulação, um conjunto de pensamentos e de hipóteses. Ter um modelo lógico para aplicar a um conjunto tão caótico e, muitas vezes, confuso de problemas pode ser tentador e satisfatório. No entanto, acreditar nele de maneira a filtrar percepções e intervenções, pré-selecionando dados que o apoiam, pode cegar o terapeuta para a realidade do próximo momento, da próxima sessão, das informações contraditórias às proposições até aquele ponto. Portanto, assim como o terapeuta abraça o modelo como um mapa para a mudança, ele não se apegando a uma equação específica para explicar o resultado da cadeia. E, por mais que esteja convencido de ter criado um certo grau de previsibilidade e ordem, organizado em torno de uma visão do futuro do tratamento e do paciente, ele se deixa, sessão após sessão, residir dentro desse único momento atual, dado que a única realidade é a desse exato momento. A formulação de caso, logicamente derivada, está no passado e pode ou não prever o futuro. No momento presente do tratamento, está a realidade do paciente e do terapeuta, e tudo o que transcorre neles e entre eles a qualquer momento. Se o terapeuta pode aplicar a formulação de caso como um conjunto de hipóteses que informam o momento presente, *mas não o substituem* – se ele prossegue com uma “mente de principiante”,

conforme definido no pensamento budista –, ele permanece aberto a novos dados o tempo todo.

Outro princípio do *mindfulness* envolve o reconhecimento de que tudo na realidade é impermanente. Isso inclui todos os aspectos de uma formulação de caso, por mais convincentes que sejam. Se o terapeuta a vê como uma representação da realidade e reconhece que a realidade está mudando a cada momento, então também perceberá que a formulação de caso escrita está perpetuamente um passo atrás. Se o terapeuta mantiver esse princípio, é mais provável que faça um uso criterioso da formulação de caso, permitindo que ela o guie e o informe na avaliação e no tratamento, sem deixar que o controle.

Por fim, como discutido no Capítulo 3 sobre o paradigma da aceitação, o outro princípio baseado em *mindfulness* sustenta que “a realidade é perfeita como é”. No curso da formulação de caso em constante evolução, o terapeuta mantém em mente que cada elo, cada padrão e toda a apresentação estão “exatamente como deveriam estar”. Em outras palavras, o terapeuta assume a “sabedoria dos dados”, mesmo que ainda não consiga compreendê-los. Permanecendo no momento atual, construindo e deixando de lado a formulação de caso repetidamente, curvando-se à natureza impermanente e em constante mudança da realidade, incluindo a natureza mutável da formulação de caso, e assumindo a sabedoria e “perfeição” de tudo como está neste momento, o terapeuta está então preparado para fazer o uso mais eficaz da abordagem cientificamente baseada para a formulação de casos no contexto da aceitação da realidade no momento. A realidade do momento presente, a realidade do indivíduo sentado diante do terapeuta, supera o “mapa” fornecido pela formulação de caso todas as vezes.

Quando compreendemos completamente que a formulação de caso real, em tempo real, está mudando a cada momento, é possível usá-la ao máximo sem ficar preso a ela. Em certo sentido,

o que quer que seja a formulação de caso explícita não é apenas parcial, mas também está temporalmente atrasada em relação à progressão da realidade. Uma vez trabalhei com um homem na casa dos 20 anos que apresentava episódios de comportamento suicida alternados com ações agressivas deliberadas em relação aos outros. As ações agressivas eram projetadas para assustar os outros, até mesmo fazendo com que temessem por sua vida, apesar de ele não os machucar de fato. Ele estava disposto a se comprometer com um tratamento completo de DBT, participar de um grupo de habilidades em DBT e abordar tanto seus comportamentos suicidas quanto agressivos. Não surpreendentemente, as cadeias do comportamento associadas aos comportamentos suicidas eram bastante diferentes das associadas aos seus comportamentos agressivos. Análises em cadeia do comportamento destes últimos revelaram vários padrões ligados a uma estrutura da DBT. Ao mascarar qualquer sofrimento emocional ou necessidade de ajuda, ele demonstrava competência aparente. A síndrome de luto inibido foi sugerida por sua cuidadosa evitação de qualquer tópico relacionado a perdas anteriores, que foram profundas. Quando ele estava assustando outras pessoas, parecia estar em uma espiral prejudicial com considerável impulso, uma forma de crises implacáveis. Ele apresentava crenças problemáticas (“As pessoas são idiotas, merecem ser assustadas”), respostas emocionais problemáticas (mostrando uma reação agressiva “como estopim” a qualquer comentário que pudesse ser interpretado vagamente como um insulto) e deficiências de habilidades ao antecipar e gerenciar gatilhos perturbadores, ao se aproximar efetivamente dos outros para pedir coisas e ao vivenciar e regular emoções negativas intensas sem ação retaliatória. Trabalhamos a partir de várias cadeias de seu comportamento agressivo e buscamos várias soluções para os elos problemáticos nelas.

Embora sua apresentação fosse complicada, comecei a pensar que eu tinha uma compreensão das cadeias do comportamento típicas dele, até certo ponto de alguma previsibilidade. Um dia, esse paciente chegou à sessão com uma máscara cobrindo o rosto. Pedi a ele que a retirasse, revelando contusões substanciais nas bochechas. Parecia que havia sido espancado. Perguntei sobre isso, e ele disse que tinha se envolvido em uma briga em um bar, o que era um comportamento incomum para ele. Parecia estar quase sorrindo, de uma maneira estranha e desconfortável, como se estivesse orgulhoso, mas em um estado alterado. Experimentei medo, imaginando se tinha alguma intenção prejudicial em relação a mim. Perguntei a ele. Disse que não, mas que havia pensado em dirigir ao redor da minha casa. Deixei claro que qualquer ação desse tipo seria uma violação dos meus limites pessoais e pedi que os respeitasse. Quando ele sorriu em resposta, fiquei ainda mais preocupado e perguntei novamente sobre seus pensamentos, sentimentos e motivações em relação a mim. No final da sessão, me senti mais tranquilizado de que ele respeitaria meus limites e que nossa relação de trabalho razoavelmente boa havia sido reestabelecida. Ao mesmo tempo, percebi que havíamos dedicado pouco tempo à avaliação do incidente que machucara seu rosto.

Nesse ponto do tratamento, eu tinha conceituado as ações agressivas de assustar os outros como comportamentos impulsionados por diferentes variáveis controladoras: uma história de invalidação que incluía espancamentos físicos pelo pai e provocações por outras crianças; um ressentimento latente em relação a qualquer pessoa que parecesse, mesmo que de maneira mínima, insultá-lo ou menosprezá-lo; deficiências de habilidades em regulação emocional e efetividade interpessoal; supressão total de quaisquer pensamentos ou emoções de perda ou trauma; falta geral de progresso em sua vida em direção a metas; e reforço potente dos comportamentos agressivos, pois aumentavam sua sensação de controle e incitavam medo nos outros.

Naquela noite, não consegui dormir. Levantei da cama e sentei na cozinha tomando chá. Me vi pensando nele, perguntando-me o que havia acontecido com seu rosto. Percebi que as contusões estavam simetricamente posicionadas em ambas as bochechas, refletindo uma na outra, pouco prováveis de serem resultado de uma briga. Me questionei se ele mesmo havia causado as contusões, embora não houvesse outra evidência em sua apresentação ou história de qualquer tipo de autolesão deliberada sem intencionalidade suicida. Eu estava perplexo. Me vi deixando de lado minha formulação do caso, como se estivesse “olhando por baixo” dela. Percebi algo diferente imediatamente em meus pensamentos. Vi alguém muito mais vulnerável, assustado, propenso a ser provocado e machucado. Até mesmo seu sorriso na sessão naquele dia se parecia menos como um sorriso de satisfação e mais como um sorriso incontrolável de desconforto. Ainda não conseguia entender o que havia ocorrido, mas iniciei a sessão seguinte como se estivesse começando do zero, sem saber de nada. Perguntei o que havia acontecido, já que ainda mostrava contusões significativas. Ele disse que não estava preparado para me contar. De repente, ocorreu-me que havia passado por uma cirurgia. Lembrei-me de que, antes da sessão em que entrou com a máscara, ele havia perdido duas sessões consecutivas.

Perguntei a ele: “Por que você se submeteu a uma cirurgia?”. Ele pareceu surpreso, não desagradavelmente, mas como se estivesse satisfeito por ter sido descoberto. Disse que tinha alterado o rosto porque sempre o considerara feio. Essa foi a primeira apresentação de um caso bastante desenvolvido e sério de transtorno dismórfico corporal. Ao investigar cuidadosa e compassivamente seus pensamentos e sentimentos sobre seu rosto, que remontavam à sua infância até onde conseguia se lembrar, sua apresentação suavizou e ele começou a parecer bastante deprimido. Com o tempo, foi relativamente fácil perceber

como seus comportamentos agressivos eram parte de uma resposta emocional secundária, uma fuga das respostas emocionais primárias de auto-ódio, autodesgosto e medo dos comportamentos insultantes dos outros em relação a ele. Essa mudança radical de perspectiva levou em direções promissoras.

Nesse caso e em vários outros, observei que chegar a uma formulação de caso com dados consideráveis pode funcionar como uma camisa de força. Às vezes, na verdade, talvez muitas vezes, é sábio abandonar a formulação de caso até aquele momento, assim como uma cobra troca de pele. Formulações de casos são extremamente úteis ao fornecer orientação, mas também podem ser muito restritivas e limitadoras. Pode ser útil pensar que a formulação de caso não representa a realidade, mas fornece uma estrutura com base nas observações até aquele ponto e, ao ficar sobre essa estrutura, talvez o terapeuta tenha a chance de ver a realidade e intervir.

PRINCÍPIOS DIALÉTICOS NA FORMULAÇÃO DE CASOS

Quando adicionamos os princípios da dialética ao processo de formulação de casos, obtemos um processo mais rico, flexível, fluido e criativo. Isso acontece de várias maneiras. Existe a dialética entre a formulação explícita e a implícita do caso. A explícita é aquela que registramos, que incorpora muitos dos elementos baseados em comportamento descritos anteriormente e que nos ajuda a prever comportamentos e a desenvolver intervenções específicas. Mas, na verdade, todos nós, em cada caso, quer conceitualizemos explicitamente ou não, temos uma formulação implícita do caso, um modelo de trabalho não articulado que fica fora da plena consciência. Embora criemos uma formulação nítida e explícita, que nos orienta de forma ponderada enquanto realizamos o tratamento, também operamos com liberdade, abertura e espontaneidade. Nesse último aspecto, intervimos mais, no momento, a partir da formulação implícita. “Sabemos” o que procurar com base em nosso entendimento explícito e educado, e, em outro sentido, “sabemos” o que fazer, guiados pela intuição e por nosso entendimento implícito. Quando testamos o modelo explícito nas sessões e descobrimos que se ajusta à situação, ele pode se tornar implícito ao longo do tempo e fazer parte do nosso modo automático de compreender e intervir. Às vezes, como no caso que acabei de descrever, o modelo explícito, embora inteligente e talvez correto em alguns aspectos, pode restringir nossa compreensão, bloquear nossa percepção das interpretações intuitivas e implícitas dos dados e só mudar quando “acordamos” por um motivo ou outro. No processo de formulação de casos, como uma atividade contínua que se supõe ter formas explícitas e implícitas, é sensato continuar a “acordar” permitindo a entrada de dados que não se encaixam.

A dialética é praticada com movimento, velocidade e fluidez. Nesse sentido, também é útil pensar na formulação de casos como um processo em movimento, experimental e de tentativa e erro. Surgimos com uma ideia, reconhecendo um padrão ou considerando uma solução, e a apresentamos ao paciente. Conversamos sobre isso, consideramos juntos, expandimos e podemos decidir intervir para mudá-la. Na discussão ou com intervenções experimentais com o paciente, podemos aprender verdades importantes sobre a cadeia do comportamento em discussão. Isso é muito semelhante ao trabalho de um bom cirurgião. Ele tem uma “formulação de caso” baseada em histórico, exame físico, resultados laboratoriais e radiológicos, como raios X e várias técnicas de varredura. Ele decide operar e tem uma ideia bastante clara de onde encontrar a patologia e um plano para resolvê-la. Então opera. E, ao fazê-lo, encontra surpresas, anomalias, reviravoltas inesperadas, mais ou menos patologia do que o esperado. Pode descobrir que estava quase perfeitamente correto em seu modelo explícito, que estava parcialmente correto ou até mesmo que estava incrivelmente errado. Ele se ajusta conforme avança; porque usa tentativa e erro, intuição e descoberta, o resultado provavelmente será melhor. É muito parecido quando se dirige com um sistema de posicionamento global (GPS). O GPS fornece uma formulação explícita de como ir de um ponto a outro, mas no processo de dirigir, de olhar pela janela e ver a realidade como ela é no momento, ajustes estão sendo constantemente feitos. É útil trazer o mesmo processo dialético para a psicoterapia.

No cerne do conceito de dialética está a ideia de que qualquer situação atual é produto de uma transação que a gerou. A pessoa que tem repetidos episódios de comportamento suicida pode ter muita vontade de viver, mas não consegue descobrir como ter uma vida que vale a pena ser vivida. Em vez disso, ela se envolve em uma tentativa fracassada de morrer. O indivíduo que vai às

sessões de terapia, mas mal fala, pode estar desejando contato e aterrorizado com isso ao mesmo tempo. Quando encontramos um padrão comportamental persistente que não avança ou retrocede, como se poderia caracterizar estes, podemos procurar a presença de um dilema não resolvido, um conflito temporariamente impossível, uma colisão crônica entre *X* e anti-*X*. E se pudermos pensar dessa forma, podemos extrair os elementos opostos, identificá-los intuitivamente ou explicitamente e buscar promover algum tipo de síntese que permita que as coisas sigam em frente. Supor que a realidade, em sua essência, é repleta de opostos, pode nos levar a procurar os lados opostos, encontrar a validade em ambos os lados e facilitar o movimento em direção à síntese.

Uma vez tratei uma garota de 16 anos que apresentava comportamentos de autolesão, episódios de uso abusivo de álcool com apagões, uma sensação de desesperança de ser bem-sucedida na escola ou na vida e uma sensação crônica de ser uma “estranha” em relação a vários círculos de amizades em sua escola. Nas sessões, ela podia ser pensativa, perspicaz, curiosa sobre si mesma e aberta a considerar uma série de influências em suas escolhas às vezes problemáticas e até perigosas. Mas entre as sessões, especialmente durante as noites de fim de semana, recorria a festas, bebendo muito e agindo com gestos ousados e dramáticos que lhe rendiam atenção significativa como alguém disposta a “ir ao limite”. Em uma ocasião, ela foi a um *show* em sua cidade natal com outras garotas de sua escola e ficou tão intoxicada que desmaiou na calçada. As outras garotas, não querendo expor o comportamento ultrajante da minha paciente (e o delas próprias), levaram-na a um prédio abandonado em vez de ao pronto-socorro. Ela acordou horas depois, sendo observada por várias garotas.

Na minha formulação de caso sobre o uso extremo de álcool por essa garota, incluí vários fatores típicos de uma formulação de caso em DBT. Ela se tornou vulnerável por seu isolamento social,

sua condição de “estranha”, seu afastamento da família (que não sabia desses episódios), sua espiral descendente na escola, sua falta de confiança em seu valor para os outros e pelo fato de ter encontrado uma “solução” temporária para seu desconforto bebendo muito com outros adolescentes. Suas vulnerabilidades eram ativadas quando enfrentava as noites de fim de semana, sabendo que outras garotas estavam socializando juntas e quando se sentia particularmente alienada e sozinha. Uma vez que suas emoções dolorosas de tristeza, solidão e humilhação eram ativadas, ela era relativamente incapaz de modulação eficaz: ou seja, de reconhecê-las, vivenciá-las como emoções transitórias, comunicá-las a pessoas que pudessem entender e usar meios habilidosos para lidar com os sentimentos dolorosos. O caminho experimentado e verdadeiro de ficar bêbada, agir descontroladamente, envolver-se com os outros e ser uma pessoa dramática em vez de reservada era muito tentador para ser trocado por uma noite mais “entediante”. Seu comportamento problemático com o álcool “funcionava” em curto prazo, todas as vezes, e a aproximava cada vez mais de uma posição em que outros cuidariam dela e tentariam protegê-la. Enquanto isso, não fazia nada para fornecer uma solução construtiva de longo prazo para os problemas.

Não havia nada de errado com minha formulação, pelo que eu podia perceber. Era composta por ingredientes sensatos, todos consistentes com um modelo de DBT, levando a algumas sugestões sobre reconhecer suas vulnerabilidades, aumentar o uso de habilidades e estratégias de regulação emocional e encontrar meios para melhorar seu autorrespeito e construir relacionamentos mais significativos. No entanto, como frequentemente acontece, embora essa formulação apontasse para vários ingredientes razoáveis em um plano de tratamento, faltava algo mais próximo da experiência: mais no momento, improvisado, real e sincero na terapia – um ingrediente que

colocaria as coisas em foco de uma forma que pudesse fornecer um “ponto de virada”. Sou tentado a chamar isso de “elemento humano” na formulação de caso, mas isso sugeriria erroneamente que os outros elementos mais explícitos eram menos humanos. Eu me peguei pensando: “Por que essa garota, que tem uma família atenciosa e envolvida, pela qual tem muito afeto, está vivendo a vida de uma adolescente perdida?”. Desviando o foco de qualquer padrão comportamental específico, mas apenas analisando o quadro geral, me perguntei o que não estava funcionando em sua vida. Como os pais dela poderiam estar inconscientes de problemas tão profundos? Como seria tão fácil para ela enganá-los? Em outras palavras, ampliei meu escopo do caso para incluir o “quadro geral”, o padrão maior que ela estava representando e o surpreendente desligamento de sua família razoavelmente bem ajustada. E, ao considerar esse quadro geral, percebi que, de alguma forma, minhas próprias respostas a ela, embora apropriadas e ponderadas, também careciam de certa medida de intensidade. Da mesma forma, percebi que meu próprio senso de indignação e decepção (do tipo que poderia surgir porque ser terapeuta de uma jovem de 16 anos pode evocar sentimentos parentais) parecia surpreendentemente mínimo. Eu senti que ela, de alguma forma, conseguiu se afastar, em relação aos pais e a mim como terapeuta, em um tipo de vácuo, como se fosse uma órfã, tentando encontrar seu caminho na selva de relacionamentos entre pares, como se já tivesse saído de casa. Se fosse identificar a polarização dentro dela agora, em retrospecto, ela estava dividida entre a garota que queria fazer parte de sua família, desenvolvendo-se de forma mais construtiva, e a garota que também queria desesperadamente pertencer a alguém. Ela queria ser importante para alguém, bloquear seus sentimentos dolorosos, e encontrou tudo isso em seus amigos e na bebida.

Na sessão seguinte, mergulhei de cabeça, aumentando minha intensidade e espontaneidade. “O que aconteceu com você? O que

aconteceu com você como filha de seus pais, alguém com um lugar valorizado e um conjunto esperançoso de sonhos de vida? Como é que, bem na minha frente, você se deixou levar para um tipo de lugar marginalizado que a faz sentir-se tão sozinha que precisa beber até ficar inconsciente a fim de encontrar um caminho para ser cuidada? O que aconteceu com você e comigo, para que você esteja fazendo isso e eu esteja de alguma forma aceitando, quando sei que você é capaz de desenvolver sua vida em direções mais construtivas? O que está acontecendo com você, de verdade? Onde você se perdeu? Onde eu a perdi? Onde seus pais a perderam? Onde você perdeu seus pais?” Ela pareceu atordoada. Ela podia sentir a força da minha preocupação e a sinceridade. Ela começou a chorar, e durante os próximos 50 minutos, desabafou uma história de como havia “perdido os pais” enquanto eles entravam em conflito conjugal por causa de seu filho mais velho, que havia fugido de casa e estava se saindo muito mal. Literalmente, se descreveu como uma órfã, encontrando seu caminho nas ruas. Ela sabia que seus pais estavam tão preocupados que estavam cegos para sua própria paralisia e desvio. Aquela sessão provou ser um ponto de virada, devolvendo-a a si mesma, sua versão mais esperançosa e habilidosa, e seguimos para abordar as fontes de sua sensação de ser órfã, eventualmente envolvendo seus pais nas sessões.

Ao refletir sobre esse episódio neste tratamento, fico curioso sobre como cheguei a essa intervenção e como a executei de maneira significativa e eficaz. Isso não seguiu diretamente a formulação de caso que eu estava construindo até aquele momento. E ainda assim, não era incompatível com essa formulação. A formulação explícita, racional e multifacetada como era estava apenas deixando de lado um ingrediente de visão geral, um ingrediente sincero que pudesse “alcançar” a paciente e potencializar sua percepção e seus esforços. Não acho que isso seja um evento incomum. Como terapeuta, atuo seguindo

abordagens bem fundamentadas, em conformidade com protocolos de tratamento, estratégias e habilidades, e estabeleço uma estrutura de compreensão. Acho essencial fazer isso, mesmo que não forneça aquele ponto de virada. A partir dessa estrutura, eu intervenho. E, ainda assim, algo pode estar faltando. Posso ignorar um “elo oculto” na cadeia do comportamento, um fator contextual no ambiente interpessoal ou vocacional do paciente ou uma sensação de desengajamento em mim, no paciente e/ou na família. A *avaliação dialética* é listada como uma estratégia dialética da DBT, que envolve sempre procurar o que está faltando na imagem atual, na formulação atual. Frequentemente, descubro que o que foi deixado de fora é o ingrediente que faz tudo avançar. E, muitas vezes, esse ingrediente ausente não é encontrado por meio de uma revisão lógica do caso, mas de forma mais implícita e intuitiva. Isso faz parte da dialética da formulação de casos. Envolve movimento, fluxo, engajamento e improvisação, encontrando o que foi deixado de fora e olhando além do óbvio. Talvez seria mais justo dizer que uma formulação de caso padrão baseada em comportamento é necessária, mas não suficiente na DBT para enfrentar os maiores desafios.

Lembrando que a visão de mundo da dialética é sistêmica, compreendendo cada elemento da realidade como parte de um sistema e de uma transação, podemos expandir o campo de investigação para o contexto ao redor do paciente. Talvez o comportamento problemático em curso esteja sendo mantido por uma polarização não reconhecida entre paciente e terapeuta, terapeuta e membros da equipe, paciente e familiares, paciente e médico, paciente e sociedade, e assim por diante. Pensar dialeticamente ao formular um caso traz mais elementos de tempo e espaço para a equação. Embora isso possa parecer assustador, ameaçando o terapeuta com um “excesso de possibilidades”, isso não precisa ser vivenciado dessa maneira se o terapeuta considerar o trabalho como um processo contínuo de investigação,

que se desenrola momento a momento, sujeito a forças dentro e ao redor do paciente.

Uma vez avaliei um jovem de 17 anos que apresentava ansiedade devido ao perfeccionismo na área acadêmica, interações sociais rígidas e, como descobri rapidamente, extrema falta de confiança beirando a autoaversão. O que surpreendia é que ele era um aluno da lista de honra em sua escola e um excelente atleta, reconhecido publicamente por suas conquistas. Conheci ele e seus pais durante a avaliação e, pelo que pude perceber, eles o apoiavam e às suas realizações. Enquanto começamos a trabalhar em seu perfeccionismo, rigidez social, sensação de isolamento e falta de confiança, tive a sensação de que estava perdendo algo que me ajudaria a conceitualizar a profundidade de seus problemas. Simultaneamente, eu estava tratando a mãe de uma criança diferente da mesma turma do ensino médio. Coincidentemente, essa mãe começou a falar na terapia sobre a família do menino que tinha falta de autoconfiança. Ela era amiga dos pais dele, mas estava preocupada com a forma como tratavam os dois filhos. Embora ambos fossem altamente competentes e tivessem bom desempenho na escola e nos esportes, os pais falavam de sua filha de 14 anos como se ela fosse uma superestrela e sobre o menino, meu paciente, como se estivesse faltando algo. Embora não pudesse compartilhar essa informação com o menino que estava tratando ou com seus pais, minha formulação de caso mudou para incluir essa possível variável sistêmica. Quase imediatamente, mesmo sem perguntar de forma explícita ao meu paciente sobre sua irmã, ele começou a falar sobre sua sensação de inferioridade em relação a ela. Munido das informações que ouvi da minha outra paciente, pude fornecer uma resposta validadora convincente aos seus comentários e perguntar sobre as diferenças em como ele e sua irmã eram percebidos pelos pais. Nunca sabemos com antecedência onde residem os elementos-chave da formulação de caso: no paciente,

na família, no terapeuta, na equipe ou em outra pessoa ou coisa. Prosseguimos com a mente aberta, alerta para novas observações e surpresas; elas são mais a regra do que a exceção.

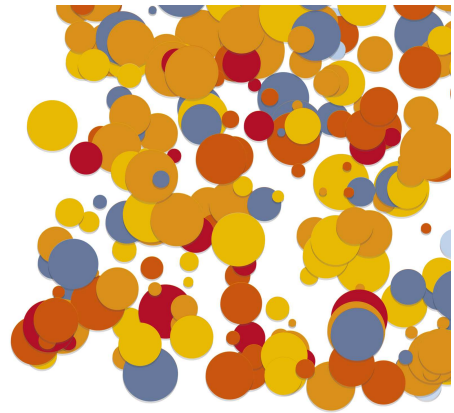
SUGESTÕES PRÁTICAS PARA CONSTRUIR E USAR A FORMULAÇÃO DE CASO

1. Mesmo após realizar apenas uma análise em cadeia de determinado comportamento-alvo, construa sua primeira formulação de caso. É apenas um começo, mas leva a um pensamento cuidadoso e à elaboração de hipóteses, que por sua vez levam a intervenções ponderadas nas primeiras sessões. Depois de uma segunda e terceira análise em cadeia do mesmo comportamento, os novos dados exigirão revisões na formulação inicial do caso, mas sua terapia já terá a qualidade de descobrir as variáveis controladoras de maneira organizada.
2. Mergulhe em sua formulação de caso, para que esteja na ponta da língua durante as sessões, mas ao mesmo tempo solte-a completamente, esqueça-a e conduza as sessões com o coração e a cabeça. Esse movimento dialético entre explícito e implícito, cabeça e coração, explicação abrangente e reações no momento servirá bem a você e ao paciente.
3. Claro que você não precisa se limitar às informações derivadas das análises em cadeia ao desenvolver e revisar sua formulação de caso. Você fará uso de tudo o que aprender sobre o paciente e seus padrões comportamentais, incluindo informações que aprender com a história, com outras pessoas e com a “cadeia do comportamento” que acontece no momento em que você conduz a sessão.
4. Há uma distinção entre análise em cadeia do comportamento e “análise de *missing links*”, mas ambas são semelhantes em natureza e contribuem para a formulação de caso. A análise em cadeia é uma técnica para identificar as variáveis controladoras de comportamentos problemáticos ou ineficazes; a análise de *missing links* é uma técnica paralela

para identificar as variáveis controladoras que explicam a ausência de um comportamento eficaz na cadeia.

5. Trabalhe duro para especificar a formulação do caso. Ao mesmo tempo, perceba que ela não existe na realidade; é simplesmente uma maneira de organizar os dados em um formato que é superposto por nossas mentes.
6. Certos dados são mais relevantes do que outros, e certas hipóteses são consideradas em detrimento de outras, porque alguns tipos de dados e algumas hipóteses são consistentes com uma formulação baseada na DBT. Buscamos evidências de vulnerabilidade emocional, ambientes invalidantes, emoções desreguladas na cadeia, déficits de habilidades, contingências que reforçam comportamentos problemáticos e suprimem comportamentos eficazes e cognições problemáticas. Estamos sempre perguntando, ao revisar um elo da cadeia: este é um elo disfuncional ou funcional? Se disfuncional, podemos imaginar e provocar uma alternativa funcional para alcançar o mesmo objetivo válido?
7. Da mesma forma, nossas hipóteses devem ser consistentes não apenas com os princípios da teoria biossocial, mas também com os pressupostos da DBT (ou seja, a “filosofia prática” da DBT).
8. Ao mesmo tempo, ao considerar hipóteses que expliquem a sequência disfuncional de elos, tente imaginar uma sequência funcional de elos que possa dar certo para este paciente em vez da sequência problemática.
9. Mesmo que a formulação do caso, sujeita a revisões com o passar do tempo, esteja “errada”, ela ainda pode funcionar de forma construtiva para o terapeuta. Isso faz o terapeuta pensar conceitual e estrategicamente e pode organizar experiências e informações confusas ou díspares de uma maneira que promova sua própria regulação cognitiva, regulação emocional e motivação. Ela “limpa o campo” e permite que ele pense.

10. A formulação de caso não precisa ser complexa, especialmente no início do tratamento. Pode consistir em alguns elos que se repetem frequentemente na cadeia, como as mesmas cognições disfuncionais, as mesmas emoções primárias ou secundárias ou o mesmo tipo de evento desencadeador. Em contrapartida, pode ser bastante complexa, envolvendo muitas etapas e sequências, até mesmo reunindo dados de diferentes indivíduos (p. ex., uma formulação sistêmica ou familiar do caso). Um terapeuta DBT precisa ter liberdade para determinar a complexidade e a natureza da formulação de caso de acordo com os dados.
11. Pense na formulação de caso como algo que não acontece apenas na cabeça do terapeuta; pense nela como uma construção colaborativa e dinâmica a ser compartilhada com o paciente, testada nas intervenções e depois alterada como resultado da colaboração e dos processos de tentativa e erro.
12. Para destacar um ponto que foi abordado neste capítulo: quando há dados consideráveis do paciente ou um campo complexo de interação entre o paciente e outras pessoas, você pode considerar deliberadamente uma metáfora para compreender o panorama geral. Se feito de maneira criativa e lúdica, isso pode permitir que você localize conexões entre diferentes elementos que não são tão óbvios e que podem levar a explicações e intervenções mais parcimoniosas. ▲



10

Comprometimento e estratégias de comprometimento

A NATUREZA DO PROBLEMA DO COMPROMETIMENTO

O argumento para usar estratégias aprimoradas de comprometimento na terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) começa com o óbvio: resolver qualquer problema difícil na vida requer um nível suficiente de comprometimento. Pegue um exemplo simples e comum na vida moderna, mas surpreendentemente desafiador de resolver. Imagine que, por motivos de saúde, você queira mudar seus hábitos sedentários e começar a se exercitar em uma esteira por 30 minutos todos os dias. Você adquire uma esteira adequada e a coloca no local mais ideal em sua casa. Certamente, você já tem a habilidade de caminhar e até correr na esteira. Você já demonstrou uma intenção significativa ao criar as condições e comprometeu-se em sua mente. No entanto, você acha a tarefa entediante e penosa, sempre tem algo mais urgente para fazer e evita o exercício com uma infinidade de desculpas. Você pode ter a habilidade de caminhar e correr na esteira, mas a *habilidade de fazer você mesmo caminhar e correr na esteira* não é tão forte ou duradoura. Mesmo o indivíduo que é saudável, bem-intencionado, bem apoiado e bem equipado pode não ter o grau necessário de comprometimento para mudar um padrão de comportamento persistente.

O *comprometimento* não se refere a uma única etapa no processo de mudança de padrões comportamentais. Não simplesmente nos comprometemos e depois fazemos. Não há um interruptor invisível de “liga-desliga” para o comprometimento localizado em algum lugar no corpo ou na mente. Apesar disso, podemos ouvir outras pessoas (pais, professores, treinadores, terapeutas e até nós mesmos) fazerem afirmações definitivas sobre pacientes, movidas pela frustração: “ele não tem

comprometimento”, “ela realmente não quer melhorar”, “ela simplesmente não está pronta para este programa” ou “ele obviamente não tem interesse em se desenvolver”. Quando não estamos no nosso melhor, falamos como se o comprometimento fosse algo tangível, que pertence a um indivíduo e que está presente ou ausente.

Linehan (2010) sabiamente colocou a necessidade de obter um comprometimento logo de início na DBT. A fase de pré-tratamento, acompanhada pela conversa sobre uma vida que valha a pena ser vivida (Capítulo 1), concentra-se exclusivamente em obter um comprometimento suficientemente forte, durável e significativo para levar o paciente por meio dos desafios da mudança comportamental. Mas isso não significa passar de nenhum comprometimento para um comprometimento total, ou obtê-lo de uma vez por todas. Do ponto de vista da DBT, o comprometimento é composto por um conjunto de comportamentos (incluindo pensamentos, emoções e ações) e um conjunto de condições contextuais (incluindo tempo, espaço, materiais, monitoramento e relacionamentos de apoio) necessários para estabelecê-lo, desenvolvê-lo e atendê-lo durante todo o processo de tratamento. E não há uma definição absoluta do que constitui comprometimento; pode ser definido como o que é essencial em determinado caso, para determinada tarefa, a fim de que seja feito o que é necessário para atingir uma meta. Fazer com que alguém corra diariamente em uma esteira requer um alinhamento de conteúdo cognitivo esperançoso e realista, prontidão emocional, padrões de ação facilitadores, uma estratégia para responsabilizar-se e fatores contextuais que permitam e reforcem o comportamento. Como Linehan escreveu em seu manual, “o comprometimento em si é visto como um comportamento, que pode ser aprendido, evocado e reforçado” (2010, p. 268).

Obter um comprometimento para realizar uma mudança comportamental de alguém sem psicopatologia já é desafiador o

suficiente. Se acrescentarmos a isso os encargos adicionais impostos pela presença de sensibilidade emocional e reatividade; uma linha de base de depressão ou alta ansiedade; uma tendência a evitação, desistência e fadiga; e uma síndrome de comportamento dependente do humor, você amplia o problema do comprometimento várias vezes. Se comportamentos autolesivos evoluíram como a estratégia mais confiável e única para trazer alívio emocional, e o terapeuta está pedindo ao paciente para desistir deles e usar comportamentos mais adaptativos que não funcionam tão bem a curto prazo, o desafio é compreensivelmente enorme. Agora considere ainda que o paciente com quem você está tentando obter um comprometimento mais forte foi profundamente modelado por experiências negativas ao fazer tais esforços anteriormente em ambientes invalidantes. O simples pensamento de se esforçar para realizar metas de uma vida que vale a pena ser vivida e intenções construtivas pode evocar memórias de ser ignorado, criticado, menosprezado e culpado. Por exemplo: “O que te faz pensar que você pode fazer isso? O que te faz pensar que você é melhor do que todos nós? Desista!”. Um acúmulo de fracassos na vida e no tratamento infiltram-se nas memórias. Por exemplo: “Não consigo fazer isso, não importa o quanto eu tente e eles não podem me ajudar! Nunca consegui manter nada, nem ter sucesso”. Agora estamos considerando o desafio monumental de fazer alguém com transtorno da personalidade *borderline* (TPB) se comprometer de todo o coração com um desafio definido, seja para entrar no tratamento da DBT, concordar com os acordos na DBT, focar em padrões de comportamento destrutivos que foram reforçados milhares de vezes ou experimentar novas habilidades. A DBT tem uma enorme variedade de estratégias, habilidades e protocolos que facilitam a mudança comportamental, mas nenhuma delas funcionará sem o nível necessário de comprometimento, e o conjunto de comportamentos associados requer atenção durante todo o

processo de tratamento. Se você tem um ótimo conjunto de ferramentas e materiais para construir uma casa e tem as habilidades para fazer isso e os projetos diante de você, ainda assim não construirá a casa se não puder gerar e manter o compromisso necessário para exercer o esforço exigido. Essa realidade básica foi a descoberta que lançou o desenvolvimento e a aplicação generalizada da entrevista motivacional no mundo do tratamento do abuso de substâncias (Miller & Rollnick, 2012).

O conceito de obter comprometimento vai muito além de fazer alguém pensar sobre, falar sobre ou mesmo demonstrar comprometimento em qualquer padrão comportamental. Esse processo é conceituado como: 1) eliciar padrões comportamentais relacionados ao comprometimento de todos os tipos e 2) estruturar um contexto reforçador. Às vezes, é difícil saber se a falha em fazer uma mudança comportamental desejada se deve a um problema de comprometimento. Pode não ser óbvio. Por exemplo, uma pessoa cujo comprometimento é bastante forte pode ser incapaz de realizar uma determinada mudança comportamental porque emoções desreguladas ou cognições problemáticas superam as melhores intenções, ou porque os suportes ou reforços ambientais necessários não estão em vigor. Se o terapeuta nesse caso consegue identificar os fatores que interferem no progresso e focar o trabalho nesses alvos instrumentais, o nível de comprometimento do paciente com essas tarefas geralmente se fortalece.

Por exemplo, uma paciente de 19 anos com TPB e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) passou por uma série de relacionamentos decepcionantes na faculdade, que a deixaram isolada, solitária, deprimida e menos produtiva nos estudos. Ela demonstrou evidências de um forte comprometimento no início da terapia e abordou com sucesso problemas de comportamento suicida e vício em analgésicos. Mas os problemas de relacionamento eram mais persistentes e, às vezes, parecia-me

que ela simplesmente não estava tão comprometida em fazer o necessário para ter relacionamentos mais confiáveis e recíprocos. No entanto, descobriu-se que não era um problema de comprometimento. Ela simplesmente não conseguia ver, nem eu no início do tratamento, como seus comportamentos interpessoais sutis afastavam consistentemente amigos em potencial. Sua tendência de relacionar tudo às suas próprias situações de vida, como forma de entender os outros e se conectar com eles, era feita de tal maneira que levava os outros a pensarem que ela era “egocêntrica”. Esse déficit específico de habilidades sociais não foi abordado de maneira suficiente no módulo da DBT sobre habilidades interpessoais, mas, uma vez que avaliamos corretamente o problema, por meio de um estudo cuidadoso de seus encontros com amigos em potencial, ela aplicou seu conjunto de comportamentos relacionados ao comprometimento para alterar seus padrões de comunicação habituais. Ela experimentou deliberadamente apenas ouvir e validar os outros, percebendo seus impulsos de relacionar tudo à sua experiência sem agir sobre isso, e teve sucesso repentino nos relacionamentos. O que parecia ser um problema de comprometimento era, na verdade, um déficit arraigado de habilidades sociais para o qual ela estava cega – e eu também –, até avaliarmos e tratarmos isso objetivamente.

Em outros casos, nos quais um indivíduo parece estar comprometido, os terapeutas podem descobrir, após inspeção e avaliação mais detalhadas, que o nível de comprometimento não é o que parece ser. Certa vez, concordei em ensinar habilidades individualmente a uma jovem de 19 anos com anorexia nervosa, cujo peso estava perigosamente baixo. Sua psicoterapeuta, que não praticava DBT, queria que a paciente aprendesse habilidades comportamentais para ajudá-la a regular suas emoções, melhorar sua autoestima e se afirmar de maneira mais eficaz nos relacionamentos. A busca implacável da paciente pela magreza parecia ser uma solução multifuncional para essas áreas

problemáticas, e vários meses de psicoterapia de apoio e orientada para o *insight* resultaram em pouca ou nenhuma mudança. A explicação fez sentido para mim, a paciente concordou com a justificativa e os requisitos do treinamento de habilidades, e comecei a encontrá-la semanalmente para ensinar-lhe as habilidades da DBT. No final de cada sessão, eu dava a ela uma tarefa de casa para praticar as habilidades.

Dentro de três a quatro semanas, ficou perceptível que, apesar de sua aparente cooperação durante as sessões, ela estava notavelmente desengajada na prática de habilidades. Ao chamar sua atenção para isso e fazer uma série de perguntas, tentei avaliar se a falta de generalização de habilidades era devido a emoções, cognições, ações ou contingências ambientais problemáticas, ou a um déficit de comprometimento. Eu me perguntava se meu apego a mim era suficiente para me fornecer alavancagem terapêutica, se eu a validava com precisão e eficácia, ou se estava pressionando pela mudança com intensidade suficiente. Na verdade, ela agia como se estivesse apegada a mim, e minhas perguntas de avaliação não esclareceram a situação.

Finalmente, perguntei a ela: “Preciso saber: você realmente, realmente, *realmente* quer usar essas habilidades para mudar seus padrões de comportamento relacionados à alimentação? Porque não parece”. Sem culpa ou vergonha, ela admitiu que a única mudança que desejava em seu comportamento alimentar era aumentar sua capacidade de tolerar e superar a fome, parar de comer totalmente, se livrar de qualquer gordura restante (mesmo “invisível”) e ser o mais magra possível sem morrer. Ela sabia que estava arriscando a vida, mas afirmou que, se a morte fosse um efeito colateral de sua busca, tudo bem; valeria a pena. Foi chocante ouvir isso. Tentei descrever verbalmente como ela ficaria e como seria se tivesse sucesso, para avaliar e desafiar ainda mais sua crença chocante. Com pouca hesitação e um pouco de constrangimento, ela me disse que sempre admirou e até invejou

os sobreviventes do Holocausto saídos dos campos de concentração que via em fotos. Uma vez identificada, parecia que a falta de comprometimento com as metas do tratamento era profunda e inabalável, já que sua imensa capacidade de comprometimento estava totalmente dedicada a metas opostas às declaradas do tratamento. Quando perguntei por que tinha ido tão longe para dar a impressão de que queria aprender habilidades para mudar seus comportamentos, ela admitiu que não queria decepcionar sua terapeuta ou seus pais; não queria que eles soubessem o quanto estava comprometida com a magreza, mesmo que a morte fosse o efeito colateral. Eu trabalhei em busca de uma solução dialética. Dado que ela tinha uma imensa capacidade de comprometimento, mas as metas do tratamento eram opostas às metas atuais, sugeri que reformulássemos as metas do tratamento, de forma que trabalhasse para aumentar sua capacidade de falar a verdade e dizer “não” de forma mais eficaz. Ela pareceu interessada no início, mas sua falta de interesse e comprometimento com esse estilo interpessoal mais assertivo rapidamente se tornou evidente. Em poucos dias, seu peso caiu abaixo de um “peso clinicamente aceitável” e ela foi internada no hospital contra sua vontade.

O problema do comprometimento na DBT é extremamente importante, muitas vezes formidável, às vezes difícil de avaliar e requer atenção durante todo o tratamento, pois varia com o tempo e em relação a diferentes metas e tarefas. Conforme conceituado por Linehan (2010, p. 267), há vários níveis de comprometimento. O primeiro deles é com o tratamento como um todo. Isso inclui o acordo para abordar comportamentos que ameaçam a vida, trabalhar para manter e fortalecer o relacionamento terapêutico, frequentar o treinamento de habilidades e cumprir as outras expectativas da DBT definidas no processo inicial de contrato. O segundo é com os procedimentos típicos de solução de problemas na DBT: treinamento de habilidades, modificação cognitiva e

procedimentos de exposição. E o terceiro é com os acordos e as tarefas específicas feitos dentro do relacionamento da terapia individual. Linehan descreveu sete estratégias de comprometimento para serem usadas repetidamente, integradas à terapia conforme necessário para fortalecer o compromisso inicial e, em seguida, reforçar ou reacender um comprometimento vacilante durante o processo terapêutico. Ao longo dos anos de ensino e supervisão de DBT, vi muitos terapeutas bons que confiam nas sete estratégias de comprometimento de uma maneira excessivamente mecânica. Mesmo que identifiquem com precisão um problema de comprometimento, eles presumem que o próximo passo é usar uma ou mais das estratégias de comprometimento. Experiências como a que tive com a paciente com anorexia fortaleceram minha crença de que os terapeutas DBT precisam de uma compreensão mais aprofundada e de aplicação dos princípios subjacentes às estratégias. Tal compreensão leva a um uso mais fluido, flexível e adaptado dessas estratégias. No restante deste capítulo, primeiro exploro o tema mais amplo do “espírito” do comprometimento; em seguida, considero o papel dos princípios pertencentes aos paradigmas comportamentais, de aceitação e dialéticos, já que eles informam o processo de obtenção de compromisso; e, por último, discuto o uso das estratégias formais de comprometimento nesse contexto baseado em princípios.

O ESPÍRITO DO COMPROMETIMENTO NA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA: “TENTAR” *VERSUS* “FAZER”

Destacar o *espírito* de comprometimento refere-se a algo mais amplo do que qualquer conjunto específico de estratégias ou intervenções; de fato, penso nisso como algo que circunda essas estratégias. Vamos começar entendendo a diferença entre decidir tentar alcançar uma meta e decidir alcançá-la. “Vou tentar fazer isso” é uma afirmação marcadamente diferente de “Vou fazer isso”. Por exemplo, se um professor do ensino médio der uma tarefa difícil à turma, alguns alunos podem dizer: “Vou dar o meu melhor, vou tentar”, e outros podem dizer: “Vou fazer isso”. Por boas razões, o professor gosta de ouvir este último. Se estivesse na base de uma montanha mais desafiadora do que qualquer outra que já escalei, sem saber ao certo se conseguiria chegar ao pico com sucesso, eu poderia dizer a mim mesmo: “OK, isso pode ser difícil, mas vou tentar”. Como alternativa, eu poderia dizer: “Sei que vai ser difícil, mas vou fazer isso!”. Claro que não há como garantir sucesso; mesmo um comprometimento sólido, boa técnica de escalada e resistência pessoal podem falhar diante de um terreno impossível, uma tempestade poderosa ou uma lesão inesperada. Mas minha afirmação aqui é que, mantidas todas as outras coisas iguais, a autoafirmação da pessoa com maior probabilidade de sucesso é a declaração “Vou fazer isso”. É uma atitude ousada; é uma postura desafiadora diante dos “deuses da dificuldade e interferência” e, psicologicamente, aproxima a realização da meta. Mais importante ainda, a reivindicação mais ousada tende a recrutar outros padrões comportamentais e recursos contextuais necessários para ter sucesso. É isso que quero dizer com o *espírito* de comprometimento. O terapeuta que leva o paciente a fazer a declaração ousada de “Vou fazer isso” e que reluta em

aceitar “tentar” como meta provavelmente criará mais impulso e propósito. Considerando que nossos pacientes costumam apresentar sensibilidade e reatividade biologicamente fundamentadas e invalidação ambientalmente difundida, obter esse tipo de compromisso pode ser incrivelmente desafiador e, ao mesmo tempo, extremamente importante. Minha expectativa de que meu paciente possa e se comprometa com a tarefa com a atitude de “vou fazer isso” comunica minha crença em suas capacidades. Obviamente, o terapeuta precisa ter uma ideia aproximada de se o paciente é capaz do que está sendo solicitado e deve ter uma boa ideia de quão alto definir a meta. Em geral, eu preferiria obter um comprometimento de 100% com uma meta menor do que um “vou tentar”, de 75-90%, com uma meta maior.

Trabalhei com uma mulher de 30 anos com TPB, histórico de trauma sexual na infância e uma série de episódios de comportamento suicida de alta letalidade que resultaram em um padrão de internações por muitos anos. Entre outros comportamentos problemáticos, ela recorria a episódios de autolesão diariamente para regular suas emoções. Por volta da terceira sessão, depois que demonstrou interesse em trabalhar comigo em DBT, disse a ela que gostaria que se compromettesse a não se machucar por pelo menos um ano. Ela ficou surpresa, lembrando-me de que tendia a se cortar todos os dias e que achava que isso a ajudava a se manter viva. Também me disse que não queria fazer uma promessa que não pudesse cumprir – a de conseguir parar com os comportamentos de autolesão de uma vez. Eu disse a ela que entendia isso e que respeitava seu comprometimento com a honestidade, mas que tinha ficado claro para mim que ela precisava se comprometer totalmente a parar de se cortar se quisesse ter uma chance melhor de sucesso. Ela me levou a sério e me disse que poderia tentar. Eu disse que a respeitava por estar disposta a tentar, mas que estava mais interessado em que ela fizesse isso em vez de tentar. Eu estava

aumentando o nível de exigência. Ela havia passado por várias terapias de diferentes tipos e me disse que ninguém nunca havia pedido que desistisse definitivamente de se cortar. Ela disse que precisava pensar a respeito, pois era uma ideia assustadora. Voltou ao hospital onde estava morando na época e contou a todos os funcionários e muitos pacientes que eu havia pedido que ela desistisse totalmente de se cortar. Pelo que me foi relatado, não só estava assustada com a perspectiva, mas também mostrava certo orgulho e esperança. Na verdade, nossa terapia começou bem quando ela se comprometeu a não se cortar, o que levou a mudanças comportamentais significativas de forma bastante rápida. Conforme mencionado no primeiro capítulo, a capacidade de visualizar o resultado desejado, de conceber a imagem de uma vida que vale a pena ser vivida, é fundamental para o fortalecimento bem-sucedido do comprometimento.

Como esse exemplo demonstra, as sementes do compromisso e o espírito de comprometimento devem começar no terapeuta, e a equipe de consultoria em DBT deve ajudar cada terapeuta a fortalecer seu comprometimento com a DBT, com as metas de cada paciente e com as tarefas de tratamento realizadas por cada paciente. Esse tipo de compromisso por parte do terapeuta não deve ser subestimado. Certa vez, supervisionei uma jovem e talentosa terapeuta de orientação psicodinâmica que estava nos estágios iniciais de aprendizagem da prática da DBT. Semana após semana, ela relatava seus esforços para incentivar seu paciente a cumprir totalmente a conclusão do diário – uma tarefa não muito fácil em muitos tratamentos de DBT. Semana após semana, seu paciente entregava um diário parcialmente preenchido, e a terapeuta avaliava os fatores que interferiam na conformidade total. Pelo que pude perceber, ela estava seriamente envolvida em trabalhar nesse comportamento-alvo que interfere na terapia, mas a conformidade dificilmente melhorava. Pedi que gravasse as próximas sessões em vídeo para que eu pudesse ver como ela

estava intervindo. Em poucos minutos após começar a assistir a uma sessão de terapia, ficou óbvio que o coração da terapeuta não estava totalmente comprometido em apresentar seu caso. Ela estava disposta a aceitar quando o paciente dizia: “Vou tentar mais na próxima semana”, quando, na verdade, ele já havia dito isso várias vezes antes. Essa terapeuta não estava insistindo no tipo de comprometimento de 100% que seria representado pela declaração: “Vou fazer isso completamente na próxima semana”. Minha suposição era que seu treinamento anterior, que não incluía o uso de procedimentos de automonitoramento, como diários, a deixara um pouco relutante em tornar essas atividades obrigatórias no tratamento. Essa clareza sobre o problema levou a nossos *role-playing* na supervisão, nos quais eu desempenhava o papel de terapeuta pedindo a ela o diário. Ela entendeu imediatamente que o terapeuta precisa abraçar a conclusão do diário como obrigatória. Ela foi capaz de mudar sua abordagem rapidamente, e isso se traduziu em um compromisso mais forte e completo por parte do paciente.

Seria compreensível questionar minha insistência na completa dedicação de “fazer” algo. Afinal, qual é a probabilidade de um paciente que se corta todos os dias conseguir garantir que vai parar completamente de se cortar pelos próximos anos? Não é provável. Mas o que estamos focando aqui ao obter o comprometimento mais forte possível não é uma discussão sobre as chances de sucesso na realidade; estamos falando sobre um estado de espírito comprometido, neste momento. Queremos cultivar e apoiar o paciente a chegar a um estado de espírito comprometido que leve ao recrutamento do máximo possível de comportamentos relacionados ao comprometimento. Se o paciente disser: “Mas e se eu não cumprir meu compromisso, serei expulso do tratamento?”, digo algo assim: “Não, você não será expulso. Se você se comprometer o máximo que puder agora, conseguir lidar com isso mentalmente e fizer tudo o que puder para honrar esse

compromisso, e depois algo anulá-lo ou ele diminuir, vamos descobrir o que está acontecendo e restabelecê-lo. Isso não tem nada a ver com punição, crítica ou expulsão. Fazemos isso assim porque você tem mais chances de alcançar suas metas”.

A abordagem de 100% de comprometimento pode ser considerada *abstinência* se envolver o fim de um comportamento que causa dependência, como o uso de substâncias ou a autolesão, e a abordagem para acabar com a recaída e restabelecer o compromisso pode ser chamada de *redução de danos* (também emprestada do tratamento de abuso de substâncias). A combinação dos dois, enfatizando a abstinência até o ponto da recaída e, em seguida, mudando para a redução de danos após a recaída, foi chamada de *abstinência dialética* na DBT. Embora tenha começado no contexto da aplicação da DBT ao tratamento de transtornos por uso de substâncias (TUS), o conceito foi incorporado à DBT padrão em relação a comportamentos de autolesão. O desafio para cada terapeuta é trazer o comprometimento mais forte para a terapia e insistir no compromisso mais forte do paciente. Com base na minha experiência como terapeuta e supervisor, há pacientes que parecem naturalmente inspirar comprometimento em seus terapeutas, enquanto outros pacientes não recebem o mesmo nível de comprometimento imediato e forte. Quando o espírito de comprometimento está presente, é um recurso valioso, levando o terapeuta a estabelecer o mais alto padrão e buscar a maior mudança, o que então ajuda o paciente a responder da mesma forma. Provavelmente é uma qualidade associada a um apego terapêutico elevado que vem facilmente em alguns casos e não em outros. Os terapeutas DBT devem estar alertas nos tratamentos em que esse tipo de apego terapêutico não é tão forte. Com a ajuda de suas equipes de consultoria, devem trabalhar para gerar o apego, fortalecer seu próprio comprometimento e, assim,

aumentar a probabilidade de eliciar um forte comprometimento em seus pacientes.

CONTRIBUIÇÕES DO PARADIGMA COMPORTAMENTAL

Vários passos típicos para estimular e fortalecer o comprometimento do paciente fazem parte da terapia cognitivo-comportamental (TCC) padrão. Tentamos ser claros e diretos ao estabelecer colaborativamente alvos específicos de tratamento. Criamos meios para monitorar o progresso nesses alvos, principalmente o cartão diário na DBT. Tendo orientado os alvos e as estratégias específicas para trabalhar com eles, orientamos o paciente sobre o problema do comprometimento. Reforçamos as evidências de progresso nas metas e no comprometimento. Quando o paciente não consegue atender a essas expectativas, usamos procedimentos de modelagem, reforçando aproximações sucessivas de comportamentos “no caminho” para os comportamentos desejados. Se descobirmos que a força do compromisso é inibida por pensamentos e crenças disfuncionais, destacamos essas cognições e trabalhamos para revisá-las. Mantemos o foco no treinamento de habilidades no paciente insuficientemente comprometido, já que, às vezes, o compromisso aumenta à medida que ele adquire as habilidades necessárias. Às vezes, o bloqueio no comprometimento é resultado da evitação de certos estímulos que evocam emoções dolorosas; nesse caso, podemos usar procedimentos de exposição para dessensibilizar o paciente à prática de se comprometer totalmente com a mudança. Ao longo da aplicação desses procedimentos de mudança, usamos intervenções didáticas para ensinar o paciente sobre seu funcionamento, tratamento e patologia. Às vezes, esse tipo de intervenção psicoeducacional pode aumentar a compreensão do que é necessário e gerar esperança. Em outras palavras, abordagens típicas de TCC que usamos para tratar ansiedade, depressão e padrões comportamentais disfuncionais podem ser

efetivamente aplicadas para melhorar os comportamentos relacionados ao comprometimento.

Pode surpreender alguns terapeutas DBT a percepção de que, se ter comprometimento for particularmente difícil, a terapia pode se concentrar nessa tarefa por meses. Uma vez, eu estava ensinando os primeiros cinco dias de um *workshop* intensivo de DBT de 10 dias e, nesse contexto, mostrei aos participantes um vídeo de uma sessão na qual Marsha Linehan estava tentando obter e fortalecer o comprometimento de sua paciente em parar de abusar das drogas nas quais era viciada. Ela estava validando a paciente, usando estratégias de comprometimento padrão e reforçando qualquer evidência de comportamentos relacionados ao compromisso. Apesar do que parecia ser uma aplicação eficaz das estratégias, a paciente não se aproximou do compromisso de parar de usar drogas. Mesmo parecendo concordar com grande parte do que Linehan disse, ela não afirmou sua disposição para parar de usar drogas. Seis meses depois, eu estava ensinando a parte 2 do mesmo *workshop*, no qual os participantes vieram por mais cinco dias. Alguém perguntou se eu sabia se Linehan havia tido sucesso em obter comprometimento daquela paciente. Eu não sabia, então liguei para Marsha naquela noite, e ela enviou um vídeo de sua sessão mais recente por correio noturno. (Naquela época, as regulamentações que regem a distribuição e visualização de vídeos de tratamento não eram tão rigorosas.) Assistimos no dia seguinte. Ficamos surpresos ao ver que todo o foco da sessão era a tentativa de obter comprometimento para parar de usar drogas, muito parecido com seis meses antes. Entramos em contato com Marsha e perguntamos sobre o foco contínuo no compromisso se estendendo tanto ao tratamento. Ela explicou que, apesar de nosso desejo de obter comprometimento em quatro sessões, às vezes é um problema mais persistente. Ela se acomodou trabalhando no compromisso de parar de usar drogas. Ela dividiu o conceito de comprometimento em vários comportamentos

relacionados, orientou a paciente a trabalhar nesse alvo e estava usando toda a TCC para abordar os fatores que interferiam no comprometimento. A paciente parecia ser uma parceira semidisposta no esforço de parar de usar drogas. Em outras palavras, o fato de essa terapeuta DBT altamente competente não ter obtido o compromisso necessário, mesmo depois de seis meses, não era motivo para encerrar o tratamento; era motivo para usar todos os princípios, estratégias e habilidades para fortalecer o comprometimento. Como se descobriu, havia algo faltando na formulação, que envolvia um papel não reconhecido de um parente próximo da paciente em fornecer-lhe drogas e reforçá-la por usá-las. Depois que isso veio à tona, Linehan conseguiu obter o tipo de comprometimento que estava buscando.

Portanto, vimos que, diante de problemas persistentes em obter comprometimento, o terapeuta DBT pode acessar todo o paradigma comportamental para ter sucesso. Ele usa alvos, monitoramento comportamental, orientação, intervenções didáticas, análise em cadeia do comportamento, formulação de caso e todos os quatro procedimentos de mudança: procedimentos de manejo de contingências, procedimentos de modificação cognitiva, procedimentos de exposição e treinamento de habilidades. Em conceito, é o mesmo que usar todo o paradigma comportamental para tratar outro comportamento-alvo primário, como autolesão ou abuso de substâncias. Além desses usos específicos das estratégias e procedimentos de TCC, o terapeuta DBT traz uma postura orientada comportamentalmente, consistente com os princípios inerentes à TCC, para o problema do comprometimento.

De acordo com uma abordagem comportamental, o terapeuta usa um estilo inusitado para obter comprometimento: franco, realista, transparente, ousado, otimista, objetivo e disciplinado. Essa postura, por si só, às vezes pode evocar um compromisso mais forte. Às vezes, os terapeutas são desnecessariamente

hesitantes ao pedir mudança, suavizando a abordagem clara e direta, como se o impulso direto para a mudança fosse demais para os pacientes. Mesmo que um paciente se oponha ao impulso direto para uma mudança comportamental definida, o fato de o terapeuta apresentá-la estabelece um tom, comunica direção e esperança e cria uma atmosfera de “eu posso” para a consideração do paciente. Às vezes, estabelecer uma direção e insistir nela, mesmo que o paciente pareça se opor ou não gostar, pode plantar as sementes para o progresso. Do ponto de vista do treinamento de habilidades, o terapeuta modela o conjunto de habilidades interpessoais para alcançar seu objetivo. Ensina os pacientes a pedirem de forma muito específica e clara por seus objetivos e, quando há oposição ou evasão, continuam a pedir por eles, como um “disco arranhado”. Ao pedir comprometimento, o terapeuta pode parecer um disco arranhado também.

CONTRIBUIÇÕES DO PARADIGMA DA ACEITAÇÃO

Os princípios inerentes ao paradigma da aceitação na DBT também orientam os terapeutas que estão trabalhando para aumentar o comprometimento em seus pacientes (e em si mesmos). Como sugerido na seção sobre o espírito de comprometimento, o terapeuta o solicita *no momento presente*. Naturalmente, ele deseja que o compromisso neste momento aumente o comprometimento ao longo do tratamento, mas o foco está inteiramente neste único momento. As lembranças do paciente de fracassos e decepções passadas podem interferir, assim como suas ansiedades sobre se pode realizar a tarefa em consideração. O terapeuta quer que o paciente deixe de lado julgamentos e recriminações sobre o passado ou pessimismo sobre o sucesso futuro, e apenas esteja no presente, evocando uma atitude de comprometimento neste momento. Esta é uma aplicação sutil, mas muito importante, da prática de *mindfulness*. Envolve estar atento ao se comprometer, atento aos vários elementos que o compõem e atento à tendência de julgar o passado e projetar-se no futuro. Quando um paciente ansiosamente pergunta: “Mas e se X ou Y acontecer e eu não puder manter o compromisso?”, o terapeuta aponta que esses são pensamentos assustadores, mas são apenas pensamentos, e incentiva o paciente a trazer sua atenção de volta ao foco em comprometer-se 100% (ou o máximo possível) neste único momento.

Inerente a isso está outro princípio budista, o *desapego*. É desafiador, mas útil, uma vez que o conceito de comprometimento imediatamente atrai a atenção para o futuro, para perceber o apego de como as coisas deveriam ser e deveriam ter sido. Assim que pensamos em nos comprometer com algum padrão

comportamental no futuro, tendemos a nos apegar a ele, a ruminar sobre isso, a avaliar se podemos fazê-lo, a relembrar os momentos em que não cumprimos um compromisso. Multiplicamos nossa ansiedade e nosso sofrimento ao nos apegarmos ao que deveria acontecer, em vez de apenas mantermos o foco, neste momento, em perceber e fortalecer nosso comprometimento. Tendemos (e nossos pacientes tendem) a nos apegar ao fato de podermos fazer o que estamos dizendo que faremos, e a ansiedade associada resulta na diminuição da força de nosso comprometimento. Estou sugerindo que busquemos um compromisso centrado *apenas neste único momento*, embora seja uma declaração sobre o comportamento futuro. Recentemente, pedi a uma paciente, cuja depressão e medo estavam resultando em um padrão de evitação, para “apenas se comprometer, aqui e agora, comigo, que você se levantará amanhã de manhã e, independentemente do seu estado de espírito, se vestirá, comerá algo e irá para a escola”.

Ela respondeu angustiada: “E se eu não conseguir? Nunca consigo prever como me sentirei no dia seguinte ou se posso fazer algo”.

Eu disse: “Ninguém consegue. Isso inclui você. Isso é simplesmente um fato, e não é sua culpa. Você não pode prever como se sentirá. Tudo o que você pode fazer é cuidar disso, e apenas disso, neste único momento. E estou pedindo a você, aqui e agora, para decidir que vai se levantar e ir para a escola amanhã. E quero que você imagine isso, acredite nisso”. “Mas como posso fazer isso?”, ela perguntou, “eu simplesmente não sei o que vai acontecer”.

“Nenhum de nós sabe o que vai acontecer, nenhum de nós. Mas se não nos comprometêssemos com nada, porque não podemos prever o futuro, nunca faríamos nada. Apenas vá para este único momento, crie uma imagem de levantar-se e ir para a escola, uma imagem vívida, e apenas se visualize comprometendo-se com isso.”

Aqui, o terapeuta DBT recorre à vasta literatura de pesquisa que apoia a visualização de um resultado positivo, algo que também é ensinado aos pacientes durante o módulo de habilidades de tolerância ao mal-estar.

Outro princípio associado ao budismo e tecido ao longo da DBT é a compreensão de que o “eu” é uma construção. Como discutido no Capítulo 3 sobre o paradigma da aceitação na DBT, o que chamamos de “eu” é na verdade composto inteiramente de elementos “não eu”. Embora usemos o conceito de “eu” para nos diferenciar dos outros, implicando que há algum ingrediente único que estabelece o “eu” de cada um de nós, essa perspectiva sugere que realmente não há tal coisa. Podemos aplicar o mesmo raciocínio ao conceito de comprometimento. Podemos perceber que *não existe tal coisa como comprometimento, assim como não existe tal coisa como “eu”, e o comprometimento é composto inteiramente de elementos de não comprometimento*. O que estamos convenientemente chamando de *comprometimento* é simplesmente uma coleção de comportamentos que aumenta as chances de fazer a mudança comportamental desejada; não é uma coisa real em si. Não há uma entidade real de “eu” e nenhuma entidade real de comprometimento. Estamos simplesmente trabalhando para aumentar a coleção de elementos, energias ou comportamentos que ajudarão a mover as coisas na direção da meta desejada. Isso é consistente com o princípio budista de vacuidade. Deixar de considerar o comprometimento como uma coisa sólida e única em si, como uma coisa pertencente ao indivíduo, é abraçar o conceito mais amplo de que compreende uma enorme gama de influências interdependentes sem limites.

Ao abandonar o conceito de “eu” e de comprometimento como uma coisa real, é menos provável que caiamos na armadilha de decidir se um paciente tem compromisso ou não e se podemos fortalecê-lo. Nós apenas nos concentramos em mover as coisas na direção desejada. Isso pode nos ajudar a pensar de maneira mais

livre e criativa sobre como aumentar o comprometimento em um indivíduo em relação a determinada meta ou tarefa. Por exemplo, às vezes a abordagem mais eficaz será parar de tentar aumentar o compromisso.

Anos atrás, eu estava em uma reunião social que incluía um dos primos de minha esposa, um homem que havia sido dentista até os 50 anos, mas depois deixou a odontologia para seguir sua verdadeira paixão, ser treinador de tênis. Ele era o técnico de uma equipe feminina de tênis universitário e, em seu time, havia uma jogadora fenomenalmente boa. Ele estava conversando comigo sobre essa jogadora, explicando que era campeã em sua liga e em sua região e que, se desenvolvesse um saque mais forte, ele estava convencido de que ela teria chance de ser campeã nacional. Ele tentou providenciar um treinador de saques para trabalhar com essa jogadora individualmente, mas ela não estava interessada. Ele não conseguia entender. Ele descreveu sua conversa:

Treinador: Se você melhorasse seu saque, poderia ser uma competidora no nível nacional.

Jogadora: Mas treinador, eu ganho todas as minhas partidas e acho que sou muito boa.

Treinador: Eu sei, mas quando você joga contra as jogadoras de alto nível, sua única fraqueza é o saque; se você se concentrasse nisso com treinamento especializado, acho que poderia competir no próximo nível.

Jogadora: Não vale a pena para mim. Eu simplesmente amo jogar e não me importo em jogar no próximo nível.

Meu familiar estava claramente frustrado e se perguntava se eu tinha alguma ideia de como fazê-la aumentar seu comprometimento para chegar ao próximo nível. Eu disse que ele parecia estar mais apegado àquela meta do que ela e que estava

ignorando e invalidando as próprias metas dela, quaisquer que fossem. Ele corria o risco de azedar o relacionamento deles quando ela parecia bastante satisfeita com seu jogo. Ele entendeu o ponto e, eu soube depois, voltou a ela e disse algo como: “Quero pedir desculpas por ter insistido tanto para você melhorar seu saque. Estou ciente de que parece mais a minha meta do que a sua. Você é uma jogadora incrível e ama tênis, e acho que deve fazer exatamente o que faz sentido para você, e não vou insistir mais nisso. Não quero que isso interfira na ótima experiência que tive treinando você”. Ela agradeceu. Uma semana depois, ela perguntou se ele poderia providenciar o encontro com o treinador de saques: “Talvez eu esteja mais interessada nisso do que pensei”.

Assim, destacamos o valor de invocar princípios de aceitação como “momento presente”, “desapego” e o conceito de “interexistência”, que se refere ao não eu e à profunda interdependência de todos os fenômenos. Além disso, às vezes adotamos a perspectiva baseada na aceitação da “impermanência” ou “transitoriedade”.

O comprometimento é transitório em sua natureza

Como tudo o mais na natureza, o comprometimento não é permanente. Composto, como é, de tantos elementos interdependentes, em um mundo onde tudo hoje é diferente do que era ontem, podemos esperar que cada compromisso oscile em força e natureza. Um forte comprometimento hoje para parar o comportamento de autolesão pode enfraquecer amanhã, diante de uma mudança de humor, um encontro estressante, uma mudança em um relacionamento ou um interesse renovado. Um comprometimento fraco hoje pode se fortalecer amanhã, devido à renovada energia física ou clareza mental, a um comentário inspirador de um amigo valorizado ou ao reconhecimento repentino

da importância potencial do objetivo em consideração. Naturalmente, é sensato continuar monitorando o nível e a natureza do comprometimento em cada paciente e permanecer ciente de que os pacientes podem precisar de intervenções voltadas ao comprometimento repetidas vezes durante o tratamento. Em vez de pensar que alguém “deveria” permanecer comprometido no nível mais alto, podemos esperar que altos níveis de comprometimento desapareçam naturalmente, baixos níveis de comprometimento aumentem e, ao compreender verdadeiramente esse fato da vida, podemos relaxar, avaliar e intervir conforme necessário, sem cair na armadilha do que “deveria ser”.

Pode ser útil para nós, como terapeutas, perceber que não podemos “fazer” outra pessoa se comprometer com algo. O comprometimento não está sob nosso controle. Podemos identificar comportamentos relacionados, ajudar os pacientes a considerarem as consequências de várias ações, trabalhar para estabelecer condições que possam aumentar o comprometimento e insistir nisso – ao mesmo tempo em que o deixamos ir. Não causamos comprometimento; intervimos de maneiras que aumentam as chances de que isso aconteça. O nível de comprometimento que procuramos é o “suficientemente bom” (suficiente para realizar o trabalho) e às vezes precisamos perceber nosso próprio impulso de buscar um comprometimento perfeito que é mais do que necessário. E quando descobrimos que, apesar de todos os nossos esforços e dos esforços do paciente, há pouca evidência de que o comprometimento está se fortalecendo, especialmente nos primeiros dias, semanas e meses de terapia, podemos descobrir que é nosso papel “manter” o compromisso para um paciente relativamente não comprometido à medida que ele aumenta e diminui. Não estou defendendo aqui um período de pré-tratamento interminável voltado ao comprometimento; estou simplesmente definindo uma postura, um estado de espírito, do

terapeuta, que, em minha opinião, é mais provável que resulte no comprometimento do paciente.

O comprometimento é perfeito como ele é

O trabalho de aumentar o nível de comprometimento de um paciente com o tratamento ou uma tarefa específica envolve dedicação persistente e inteligente, e às vezes os frutos demoram a amadurecer. O custo dessa devoção terapêutica pode ser a experiência de frustração terapêutica. Nenhuma tarefa difícil é realizada sem alguma frustração. Equilibrar essa frustração, que muitas vezes inclui um elemento de julgamento (“Este paciente não está trabalhando nem metade do que eu estou!”), é o *insight* baseado no budismo de que o mundo é perfeito exatamente como está neste momento. O nível de comprometimento é perfeito como ele é, uma vez que, dadas a história e a evolução de todos os elementos relacionados ao compromisso que influenciam no nível atual, como poderia ser diferente? É como é; é como “deveria” ser. Se abandonarmos nosso apego a como achamos que as coisas deveriam ser, podemos então endossar o ponto de vista de que tem que ser como é. Talvez não saibamos exatamente o porquê, mas podemos presumir isso. Uma vez equilibrado novamente por esse reconhecimento e essa aceitação da realidade como ela é, o terapeuta mais relaxado pode, então, ser capaz de pressionar por um aumento no comprometimento a partir de uma postura mais equilibrada e aberta.

Quando adotamos a perspectiva de que tudo é perfeito como está, incluindo o nível e a natureza do comprometimento em nossos pacientes, isso de forma alguma sugere uma posição fatalista ou resignada. Pelo contrário, não há nada predeterminado sobre se o compromisso aumenta, diminui ou permanece o mesmo; ou seja, *tudo importa*. Cada intervenção relacionada à força do comprometimento pode fazer a diferença. É muito

complicado saber o que fortalecerá o compromisso, já que tudo importa. Será útil adotar um tom desafiador ou recíproco e aceitador? Será mais útil dizer que o comprometimento é fraco ou prosseguir sem mencioná-lo? Seria útil a autorrevelação do terapeuta ao compartilhar uma experiência pessoal que exigiu um comprometimento maior? Quando pressionar e quando soltar? É tão complicado; as escolhas são complexas e há muito a se dizer para manter uma postura observadora e reflexiva em relação a si mesmo, ao paciente e à transação, testando intervenções e observando o que parece funcionar.

Em minha experiência, em situações com pacientes nos quais o comprometimento é difícil, maiores sucessos surgiram a partir de uma atitude de tentativa e erro, avanços e recuos, impulso e puxão, e observando o que funciona, do que as vezes em que apliquei estratégias de comprometimento e obtive sucesso de maneira direta. Talvez o conselho mais importante embutido nessa perspectiva seja que o terapeuta permaneça consciente do nível de comprometimento e mantenha-se firme em aumentá-lo, se necessário. O terapeuta mantém o alvo em vista e tenta qualquer coisa, tudo o que possa funcionar, e observa o resultado no momento. Facilitar o desenvolvimento do comprometimento requer diferentes intervenções com diferentes pacientes, e o terapeuta DBT tem um enorme arsenal do qual pode selecionar o próximo passo.

CONTRIBUIÇÕES DO PARADIGMA DIALÉTICO

De igual valor para expandir as opções imagináveis para estimular o comprometimento estão os princípios do paradigma dialético. O primeiro e mais básico princípio dialético é que teses suscitam antíteses, proposições evocam seus opostos; *a realidade é composta naturalmente de oposições*. Se um terapeuta pressiona explicitamente por um maior comprometimento, ele pode, inadvertidamente, provocar oposição. Se um terapeuta deixa de pressionar pelo comprometimento (como ocorreu no exemplo envolvendo o dentista/treinador de tênis e sua jogadora estrela na seção anterior), ele pode, involuntariamente, provocar maior compromisso. Quando vemos uma postura firme contra o comprometimento, podemos presumir que já há uma luta implícita entre compromisso e não compromisso no paciente, e podemos agir com isso em mente. Supondo que o comprometimento exista em um contexto de oposições, tomamos decisões explícita e implicitamente informadas sobre quando pressionar, quando soltar, quão forte pressionar, quanto validar as causas do não comprometimento, e assim por diante. Agimos e observamos. Como veremos, certas estratégias formais de comprometimento da DBT são baseadas na compreensão de como os elementos evocam seus opostos. Por exemplo, alternamos entre pedir muito pouco, para colocar nosso pé na porta, e pedir muito mais do que o paciente estará disposto a assumir, o que é conhecido como a estratégia da porta na cara. Destacamos a liberdade do paciente para escolher, cientes de que, dadas as circunstâncias, há uma ausência relativa de escolhas aceitáveis. Vamos e voltamos entre pedir ao paciente para enumerar as vantagens e desvantagens de assumir um compromisso de mudança, no que é conhecido como os prós e contras do comprometimento. Ir e vir, empurrar e puxar, destacando opostos, seja usando estratégias de comprometimento

padrão, metáforas ou outras estratégias dialéticas, muitas vezes ajudam o terapeuta a encontrar o equilíbrio certo e a intervenção eficaz e cria uma atmosfera de movimento em vez de estagnação: tudo isso permite a *descoberta* do comprometimento, em vez da criação dele. Trabalhando dialeticamente, mantemos nosso olho na meta final, o aumento do comprometimento, mas nos envolvemos em um processo de busca, denominado *avaliação dialética*, para encontrar o que está faltando na equação atual. Talvez o principal ponto aqui seja que, quando o comprometimento é difícil de ser obtido, é mais provável que seja descoberto em uma atmosfera de busca, flexibilidade e abertura, enquanto observa e reforça cuidadosamente quaisquer influências positivas relacionadas a ele.

Um corolário do princípio de que a realidade é composta por oposições é que, dentro de cada comprometimento, mesmo nos níveis que parecem ser fortes, encontraremos a presença de oposição, talvez mais bem denominada como *ambivalência*. Encontramos a mesma perspectiva na entrevista motivacional. As pressões, por assim dizer, dentro dos elementos do comprometimento, são muitas e podem mudar o equilíbrio a favor ou contra em resposta a tantos fatores. Um exemplo foi dado anteriormente neste capítulo, em que uma jovem com anorexia parecia estar comprometida em aprender habilidades comportamentais, mas na verdade havia uma tensão dentro dela entre querer parecer interessada, o que por si só pode influenciar alguém em direção a um comprometimento mais forte, e absolutamente não ter necessidade das habilidades, já que seus objetivos eram opostos à mudança em seus padrões alimentares. Portanto, o que parece ser um comprometimento forte pode se desdobrar em uma oposição mais complicada entre duas “vozes”. O que parece ser um comprometimento fraco pode obscurecer o que na verdade é forte. Em meu programa de internação de DBT, por exemplo, em nossa reunião semanal da comunidade, uma

paciente levantava a mão todas as semanas para colocar seu item na agenda: “Estou aqui contra a minha vontade; não acho nada neste programa útil e mal posso esperar para sair”. No entanto, essa paciente frequentava todos os grupos, aprendia e praticava habilidades com diligência e estava engajada na psicoterapia. Observar o que ela estava realmente fazendo, em vez de aceitar suas declarações públicas, nos ajudou a relaxar nossa tentação de pressionar por um maior comprometimento. Há o compromisso mantido em particular, o compromisso declarado publicamente e as ações que manifestam o compromisso, e pode haver oposições ocultas entre eles.

O comprometimento está conectado de forma interdependente a todos os fatores sistêmicos

Essa perspectiva sobre o comprometimento foi discutida em relação aos princípios do budismo e à aceitação, baseada na ideia de que não há limites e que tudo está interagindo o tempo todo. Aqui, o foco está no pensamento sistêmico, enfatizando que o comprometimento em um indivíduo pode ser visto como um elemento em um sistema dinâmico com muitos fatores interagindo. Por exemplo, pode ser visto como estando em interação dinâmica com influências de outros membros da família. Certa vez, atendi uma família composta pelos pais e suas duas filhas, com idades de 17 e 20 anos. O problema apresentado era que a filha de 20 anos havia tomado a decisão, há muito tempo considerada e acompanhada de consultorias construtivas, de entrar em um processo de transgênero de modificação de seu corpo que resultaria na transição para a vida como homem. O processo já estava em andamento. Ele já havia passado por algum tratamento hormonal e adquirido algumas características masculinas. Além disso, havia escolhido um nome masculino e estava pedindo aos membros da família para usá-lo, com o pronome masculino. Os

pais estavam extremamente angustiados. A mãe havia feito pesquisas e tivera várias conversas importantes com seu (novo) filho. Ela havia caminhado na direção de reconhecer a realidade da transição e começara a aceitá-la. Estava disposta a respeitar o pedido do filho para usar o nome e os pronomes masculinos. Mas o pai não queria considerar isso, tinha sido incapaz ou não queria aceitar a possibilidade de que a mudança de gênero de sua filha fosse real, e estava teimosamente se apegando à imagem que sempre teve: que sua talentosa e encantadora filhinha se tornaria uma mulher charmosa, carismática e heterossexual e teria sua própria família. O pai se viu sob ataque na primeira sessão, recebendo fogo cruzado de seu filho transgênero zangado e insultado, e de sua esposa mais suave, mas voltada para a mudança. Parecia que a pressão sobre ele para mudar estava provocando uma recusa em se mover nessa direção. Ele estava com raiva, teimoso e se recusava a acreditar que sua amada filha levaria isso adiante. Nenhuma intervenção terapêutica em relação ao pai, mãe ou filho de 20 anos fez as coisas avançarem.

Pensando sistemicamente, sabendo que todos influenciam a todos, questionei em voz alta o que a jovem de 17 anos achava dos planos e pedidos de seu irmão. Ninguém havia perguntado a ela, e ela tinha um comportamento tranquilo. Sem hesitar, ela disse: “Não há nada surpreendente nisso. Ele sempre pareceu alguém que seria mais feliz como menino. Na verdade, isso é o que o torna tão incrível. Então, estou feliz que ele possa fazer isso”. Perguntei a ela como reagiu ao pedido de usar o nome masculino e pronomes. Ela disse que fazia sentido para ela, mas reconheceu e pediu desculpas ao seu (novo) irmão por às vezes voltar a usar pronomes femininos. Foi um momento comovente entre os irmãos, reenquadrando completamente todo o processo como algo positivo, aliando-se ao irmão sem parecer julgar o pai. O pai permaneceu em silêncio. No entanto, na próxima sessão familiar, ele disse que havia decidido trabalhar para aceitar a

mudança em seu (novo) filho e usar o nome e o pronome solicitados, e chorou por vários minutos, dizendo que estava muito triste por estar perdendo sua filha mais velha ou sua imagem do futuro de sua filha. O jovem de 20 anos pareceu compreender a tristeza de seu pai e, olhando diretamente para ele de maneira gentil, acenou e disse: “Pai, eu ainda estou aqui”. O comprometimento do pai em mudar, que parecia uma perspectiva sem esperança, surgiu espontaneamente no realinhamento provocado pelos comentários da jovem de 17 anos.

O comprometimento está constantemente mudando; está em constante movimento

Aqui está outro princípio associado à filosofia dialética que se sobrepõe totalmente ao princípio budista que afirma que tudo é transitório. O comprometimento não é de fato real ou uma coisa sólida. É uma construção que usamos para capturar a confluência de elementos móveis e interativos que influenciam o progresso na direção ou no afastamento de uma meta ou tarefa declarada. Os princípios dialéticos que estamos considerando aqui sugerem que o comprometimento não é apenas uma construção multifacetada, mas também que essa construção está sempre em movimento. Quando me vi tentando despertar um comprometimento mais forte, mas encontrando um “muro” de não comprometimento, foi útil para mim lembrar que o que parece sólido na verdade não é. Se eu continuar parado na frente do “muro”, tentando várias intervenções, deixando o tempo e os eventos acontecerem, relaxando no momento presente, é provável que ele mude: talvez vá desenvolver rachaduras, amolecer, desmoronar ou mudar de natureza, de modo que possamos avançar. Não estou afirmando que isso sempre acontece (há circunstâncias em que o comprometimento, por qualquer definição, não acontece, pelo menos dentro de um prazo tolerável ou realista), mas a postura

informada pela consciência de que o comprometimento está sempre em movimento me leva na direção de resistência, paciência, observação cuidadosa e esforços criativos para intervir ao longo do tempo.

O comprometimento é transacional (assim como a identidade)

Mais uma vez, este princípio contido nas dialéticas capta a ideia de que é muito restrito considerar o comprometimento como uma propriedade do indivíduo. É uma propriedade de uma transação, ou várias transações. Meu comprometimento pode depender do seu apoio ou ser uma reação contra a posição de outra pessoa. A força do meu comprometimento sobe e desce em transação com outras pessoas ou fatores ao meu redor. Ter isso em mente me ajuda a expandir meu foco além dos comportamentos do indivíduo “não comprometido” e a considerar que tipo de transação está em andamento que provoca comportamentos contrários. Se não consigo provocar mudança em um indivíduo ao abordá-lo diretamente sobre seu comportamento, posso ter mais sucesso se conceituar a situação de maneira transacional, entre o paciente e outra pessoa, e tentar influenciar a transação de maneira que motive o comprometimento do indivíduo.

ESTRATÉGIAS FORMAIS DE COMPROMETIMENTO DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA

As próprias estratégias de comprometimento da DBT representam uma interligação de mudança, aceitação e vertentes dialéticas. No uso mais eficaz de cada estratégia, o terapeuta aceita radicalmente o nível atual de compromisso do paciente e, nesse contexto, busca um comprometimento mais forte e específico. Essa é a essência do equilíbrio dialético na DBT entre aceitação e mudança. A maioria das estratégias representa um ato de equilíbrio entre aceitação e mudança: revisar as vantagens de um determinado comportamento problemático ao lado de revisar as desvantagens (prós e contras do comprometimento); pedir uma pequena mudança *versus* pedir uma grande (pé na porta e porta na cara); destacar a liberdade do paciente para escolher *versus* a realidade de alternativas limitadas (liberdade para escolher na ausência de alternativas); e argumentar a favor do não comprometimento de uma maneira que provoque um maior comprometimento (advogado do diabo). Em outros momentos, o terapeuta destaca a relação entre um comprometimento fraco atual e um comprometimento forte anterior, esperando catalisar uma transferência de força para o atual (conectar comprometimentos atuais com comprometimentos anteriores).

Mesmo no uso de uma estratégia comportamental bastante direta, como a modelagem, a serviço do comprometimento, o terapeuta aceita qualquer nível de compromisso disponível e, em seguida, reforça o surgimento de qualquer pequeno sinal de aumento dele. Em outras palavras, o processo de obter um comprometimento mais forte não é uma abordagem concisa e linear ao paciente, como se pudéssemos fazer um “acerto direto” no dilema do comprometimento. As estratégias de

comprometimento, cada uma delas um ato de equilíbrio, estão entrelaçadas em uma dança entre paciente e terapeuta. A conversa resultante é preenchida com movimento entre paciente e terapeuta, entre posições opostas, entre certeza e dúvida. Feita com habilidade, é uma arte que tece todas as seis/sete estratégias em uma conversa fluida que considera os valores, as escolhas diante do paciente e as consequências de escolhas diferentes sem “arrastar” o paciente em direção ao comprometimento.

A aplicação artística das estratégias, com reconhecimento do movimento inerente dentro de cada uma delas e entre elas, é o antídoto certo para o paciente profundamente ambivalente cuja desregulação emocional vem com pensamento dicotômico, negação da inter-relação e medo de ficar preso em mais um ambiente invalidante. Catalisar o comprometimento enquanto está em movimento geralmente traz mais esperança do que tentar obtê-lo a partir de uma parada completa.

Agora, vamos considerar cada estratégia a partir de uma perspectiva baseada em princípios, não para revisá-las, já que são tão bem descritas no manual de tratamento,^[NT] mas para aprimorar a capacidade do terapeuta de usá-las de maneira criativa e fluida.

As seis (ou sete, se a terceira estratégia for contada como duas) estratégias de comprometimento são:

1. Avaliar os prós e contras: vendendo comprometimento.
2. Destacar a liberdade de escolha na ausência de alternativas.
3. Pé na porta e porta na cara.
4. Conectar comprometimentos atuais com comprometimentos anteriores.
5. Assumir a posição de advogado do diabo.
6. Modelar aproximações sucessivas ao comprometimento.

Avaliando prós e contras

Toda a conversa sobre comprometimento gira em torno da avaliação dos prós e contras de assumir um compromisso. Está longe de simplesmente listar prós de um lado da página, contras do outro lado e, em seguida, pesá-los. Idealmente, é uma tecelagem habilidosa entre vantagens e desvantagens de comprometer-se com a mudança comportamental. Minha preferência é começar pelos contras em vez de pelos prós. Peço ao paciente que me explique por que continua a usar o comportamento problemático ou por que não se envolve na mudança. Entro nessa conversa com um espírito de genuína curiosidade, com a abordagem de realmente querer “entender”. Meu objetivo é compreender as razões para a persistência do paciente no padrão comportamental atual a tal ponto que eu mesmo comece a pensar que faria a mesma escolha. Assim que começo a perceber que estou pensando: “Uau, se estivesse naquela posição, faria a mesma coisa”, sinto que cheguei a um lugar potencialmente útil. Dessa posição, posso expressar genuinamente a compreensão das razões do paciente para não se comprometer com a mudança. Posso articulá-la ao paciente e validá-la, superando quaisquer reações de julgamento que tinha antes.

Nesse ponto, costumo mudar para os prós de comprometer-se. Pergunto algo como: “Dado o quanto faz sentido para você persistir no que está fazendo e o quão pouco sentido faz mudar seu comportamento, há alguma razão que pese a favor de se comprometer com a mudança?”. Se eu reconheci com precisão os contras da mudança e me juntei ao paciente naquela posição por um momento, descubro que a indagação sobre os prós flui muito melhor. Em uma sessão de comprometimento com uma mulher de 40 anos que foi seriamente vitimizada na infância, desenvolveu TEPT na adolescência, começou a usar várias substâncias pesadas quando adolescente e, em seguida, adicionou autolesão severa no final dessa fase – comportamentos que continuaram

durante sua vida adulta –, cheguei ao ponto de validar os contras da mudança e, em seguida, disse: “Dado o quão incrivelmente eficaz é para você se cortar, diferente de qualquer outra estratégia simples para trazer alívio imediato, e o quão bem isso tem funcionado, talvez até ajudando você a se manter viva, há alguma razão, qualquer coisa que você possa pensar, que argumentaria a favor de desistir dos comportamentos de autolesão?”. Nesse momento, ela listou prontamente e genuinamente várias razões para a mudança: parar de aumentar suas cicatrizes, já que interferiam em sua vida interpessoal; parar de “machucar outras pessoas”, já que percebeu que magoava amigos ao saberem que ela continuava se machucando; e tornar possível o tratamento do TEPT, já que a maioria das pessoas não a trataria até que parasse de se machucar. Talvez o ponto mais importante a ser feito sobre o uso dos prós e contras (que, como mencionei antes, já são inerentemente dialéticos) seja envolver-se nesse processo com um espírito dialético: indo e voltando, destacando oposições, buscando uma síntese que apoie o comprometimento e permanecendo improvisacional, flexível e criativo ao considerar intervenções e o tempo adequado.

Destacando a liberdade de escolha na ausência de alternativas

Listo essa estratégia em segundo lugar, atrás apenas dos prós e contras, porque também é uma estratégia tecida, repetidamente, ao longo das discussões sobre comprometimento. Em minha opinião, os prós e contras e as estratégias de liberdade de escolha são os pilares intervencionais sempre presentes na conversa de comprometimento, com as outras estratégias aplicadas conforme indicado. Como mencionado, essa estratégia também é inerentemente dialética, equilibrando a liberdade de escolha com a falta funcional de liberdade para escolher. Novamente, a melhor

aplicação é continuar a endossar ambas as posições, tecendo entre elas. Às vezes, destaco que o paciente sempre tem a liberdade de escolher fazer DBT ou não; outras vezes, destaco que não parece haver boas alternativas. Mesmo que, do ponto de vista do paciente, haja falta de liberdade de escolha sobre o que fazer com sua vida neste momento, tornando a DBT a única alternativa viável, o terapeuta quer ajudá-lo a chegar ao ponto em que sua decisão de entrar na DBT seja voluntária.

Muitos programas de DBT foram estabelecidos em ambientes de internação forense com pacientes legalmente obrigados, em prisões e em programas residenciais para adolescentes que são obrigados a estar lá. Ao fazer DBT, torna-se fundamental estruturar o programa e a conversa sobre comprometimento de uma maneira que destaque que há uma alternativa para se envolver na DBT, seja outro modelo de tratamento ou variações na estrutura da DBT conforme apresentado. Nada alimentará mais sentimentos anticomprometimento do que ser forçado a se comprometer; tal coerção cria ressentimento, pseudocomprometimento ou desafio aberto. O terapeuta pode reconhecer que um paciente é obrigado a estar em tratamento e pode validar o ressentimento e a passividade compreensíveis que se seguem. Além disso, ele pode apontar que o tratamento provavelmente será inútil, talvez até contraproducente, se o paciente passar pelas etapas sem ver nenhuma razão convincente para se envolver nele. Ele pode sugerir que a DBT só é realmente útil se o paciente tiver metas, livremente escolhidas, às quais a DBT possa ser aplicada. Às vezes, esse tipo de declaração catalisa uma conversa sobre as metas desse indivíduo naquele ambiente e além. Se o paciente insiste amplamente na falta total de interesse ou de disposição para entrar nos elementos básicos da DBT, o terapeuta pode endossar essa decisão como a escolha “livre” do paciente e, em seguida, apenas destacar suas consequências.

Na minha unidade de internação de DBT, nosso programa de tratamento era inteiramente baseado em DBT. Às vezes, tínhamos um paciente que “recusava” fazer DBT, não queria participar dos grupos, aprender as habilidades ou ir à terapia baseada em DBT. Eu diria a esse paciente que ele sempre tinha uma escolha. Ele poderia entrar no programa de DBT ou poderia optar por não participar. “Mas o que eu faria se não participasse da DBT?” Eu responderia que ele receberia algo mais próximo do “atendimento psiquiátrico hospitalar padrão”. “O que é isso?”, ele perguntaria. “Isso significa que você se levanta todos os dias, anda pela unidade, conversa com enfermeiros e outros funcionários, pode assistir televisão durante horas aceitáveis, será visto por um médico para receber um diagnóstico e tratamento medicamentoso, se indicado, e nós acompanharemos seu progresso até você sair.” Eu era realista, mas aquilo não parecia muito atraente. O paciente tinha a liberdade de escolher, mas uma relativa ausência de alternativas. Se a insistência em não participar da DBT fosse além das primeiras semanas, procuraríamos outro ambiente para encaminhar o paciente, se possível.

Pé na porta e porta na cara

De todas as estratégias de comprometimento, pé na porta e porta na cara são as únicas que orientam o terapeuta a pedir especificamente por comprometimento. Assim que o terapeuta pede ao paciente que se comprometa com uma mudança de comportamento, surgem escolhas terapêuticas. Ele deve pedir ao paciente algo mais do que parece estar disposto a fazer, tentando estabelecer uma meta alta, como “Eu quero que você se comprometa a abster-se completamente de se cortar, beber álcool, usar drogas ou comer compulsivamente e ter comportamentos purgativos no próximo ano!”? Ou deve pedir menos do que realmente espera obter, a fim de estimular e desenvolver a

disposição do paciente, como “Quero que você se comprometa a abster-se completamente de se cortar, beber, usar drogas ou comer compulsivamente e ter comportamentos purgativos apenas na próxima semana, e então revisaremos a semana e consideraremos se renovamos o comprometimento por outra semana”? Ou, ainda, começa pedindo algo próximo ao que acha realista e ao que o paciente pode estar disposto a fazer?

O sucesso dessa estratégia intrinsecamente dialética requer que “sintamos” onde o paciente está em relação ao comprometimento. É suficiente apenas “insinuar” um compromisso e depois deixá-lo de lado por um tempo? Estamos sendo muito cuidadosos se não insistirmos corajosamente no compromisso, um comprometimento de porta na cara? Estamos sendo muito tímidos, muito ousados, muito calorosos e aceitadores, muito insistentes? Não há resposta absoluta. Sem conhecer o contexto, não podemos dizer qual caminho seguir. O que acho útil no espectro de opções do pé na porta e porta na cara é a sugestão de que nos movemos de um lado para o outro nessas posições, estudando as reações do paciente o tempo todo, encontrando nosso caminho para o mais alto nível possível de comprometimento.

Por exemplo, recentemente comecei a terapia com um jovem que, após dois anos de tratamento residencial para comportamentos graves de autolesão e episódios de comportamento suicida, estava entrando na faculdade pela primeira vez. Sua ansiedade antecipatória era extrema e ele não imaginava que conseguiria lidar com as expectativas acadêmicas e a vida social. Como ele disse, ia encarar “um dia de cada vez”. Pressentindo que ele poderia deixar a escola a qualquer momento, quando seu desânimo e ansiedade aumentassem, pedi-lhe que se compromettesse comigo a terminar o primeiro semestre (porta na cara). Ele ficou incrédulo, agindo como se eu fosse louco. Ele disse que era aterrorizante pensar tão à frente; fazia-o sentir-se preso. Eu disse que achei sua estratégia de “um dia de cada vez” boa,

mas que se ele se compromettesse por um período mais longo, apesar de quaisquer oscilações de humor que surgissem, isso nos daria a chance de trabalhar juntos nos desafios. Isso nos daria espaço para respirar. Perguntei se poderia se comprometer com o primeiro mês, 30 dias. Ele disse que ainda parecia muito tempo para pensar, mas se comprometeria a passar pelas primeiras três semanas, 21 dias, porque essa era a última data em que poderia desistir sem pagar a mensalidade integral do semestre. Indiquei o desejo de que pudéssemos olhar além das três semanas, mas elogiei sua coragem e concordei com as três semanas como comprometimento inicial. Foi uma dança, a arte da negociação.

Conectar comprometerimentos atuais com comprometerimentos anteriores

Esta estratégia é uma aplicação direta da teoria do condicionamento respondente ou condicionamento clássico. O terapeuta tenta estabelecer uma conexão entre a situação atual do estímulo, em que o paciente está sendo solicitado a se comprometer com algo aqui e agora, e uma situação anterior de estímulo de natureza semelhante, em que o paciente se comprometeu. Há dois usos principais dessa estratégia. Conforme explicado no manual de Linehan (2010), o primeiro é lembrar o paciente de um compromisso que fez ao entrar no tratamento e que agora enfraqueceu, tentando recuperar o acordo feito anteriormente e, ao fazê-lo, melhorar seu comprometimento vacilante no momento atual. O outro modo, que se feito habilmente pode ser muito eficaz, envolve localizar algo em que o paciente tenha se comprometido para mudar no passado (que tenha resultado em uma mudança bem-sucedida) e tentar conectar o desafio atual.

Comecei a trabalhar com uma mulher de 40 anos que desenvolveu padrões comportamentais de TPB após seu marido

separar-se dela para ficar com outra mulher, deixando-a sozinha para cuidar de seus filhos adolescentes. Ela estava com raiva e tristeza, e o episódio doloroso despertou memórias de ter sido profundamente negligenciada na infância, quando parecia que seus pais desejavam que ela nunca tivesse nascido. Começou a beber álcool todos os dias e noites e teve vários episódios de comportamento suicida moderadamente letais. Uma consequência foi a relativa negligência de seus próprios filhos, que começaram a apresentar comportamentos problemáticos de natureza rebelde. Como resultado, ela era altamente autocrítica. Nas primeiras sessões, formulamos a lista de alvos. Em segundo lugar, para eliminar o comportamento suicida, com o que ela prontamente concordou, sugeri que parasse de beber. Ela estava hesitante. Achava que não tinha força para parar, já que isso estava ajudando a medicar sua tristeza e raiva. Nossa discussão sobre sua posição em relação ao álcool continuou por três sessões. Usamos os prós e contras da abstinência de álcool, destaquei sua liberdade de escolha se queria parar e tecia para trás e para frente entre as estratégias de pé na porta (“Se você pudesse fazê-lo [se não estivesse bebendo], você acha que sua vida e seus filhos seriam melhores?”) e porta na cara (“Quero que você se comprometa agora, a partir de hoje, com seis meses de sobriedade total”). À medida que continuávamos, o que emergiu foi sua crescente estimativa de que seria impossível parar de beber. Perguntei se ela já havia feito algo em sua vida depois de pensar que seria impossível fazê-lo. Ela respondeu que, quando seus filhos estavam indo mal na escola e sua avaliação era que havia uma correspondência fraca entre seus filhos e o estilo de ensino, ela havia tomado uma decisão realmente difícil de tirá-los da escola e educá-los em casa. Ela disse que todos se opuseram e ela não estava certa se seria possível lidar com isso. Depois que o fez, acabou sendo bastante bem-sucedido, e outras famílias a usaram como consultora. Eu perguntei se ela poderia considerar o que foi

preciso para enfrentar aquele desafio de vida incrível e se poderia ver uma conexão e tirar força dessas memórias agora. Este exemplo a ajudou a ver suas escolhas sob uma nova luz e com maior confiança. Bastante rápido, ela estava flertando com a ideia de abster-se, concentrando-se mais praticamente na pergunta: “Mas como farei isso?”.

Assumindo a posição do advogado do diabo

Essa estratégia é possível devido à presença inerente de contradição, neste caso a contradição entre querer mudar e não querer mudar. Imagine que você e seu paciente estão tendo uma “conversa de comprometimento” sobre algum aspecto do tratamento e o paciente está relutante em se comprometer. Por exemplo, você está pedindo ao paciente com um transtorno alimentar que se comprometa a eliminar comportamentos de compulsão alimentar e purgação. O paciente mostra algum interesse em mudar, mas está relutante quando perguntado diretamente sobre isso. Conforme a conversa continua, talvez você intercale outras estratégias como prós e contras ou a técnica de pé na porta e porta na cara e, finalmente, o paciente diz: “Tudo bem, vou parar com a minha compulsão alimentar e purgação”. Pode parecer que o paciente mudou para uma posição comprometida, mas você sente que é uma pseudorresolução, que ele pode estar apenas “cedendo” para dissolver a tensão, para agradá-lo. É exatamente esse conjunto de condições que prepara o terreno para a estratégia do advogado do diabo. A fórmula inclui:

1. O paciente está ambivalente em se comprometer, e a tensão entre o pedido de comprometimento e a relutância em se comprometer é palpável.
2. No decorrer da conversa, a tensão parece diminuir à medida que o paciente afirma ter adotado o compromisso.

3. O terapeuta não confia que a declaração de comprometimento do paciente integre plenamente o nível de dificuldade.

Nesse contexto, então, você desafia o comprometimento declarado argumentando contra ele. Por exemplo, você pode dizer: “Não entendo. Por que você está concordando em parar com os comportamentos de compulsão e purgação quando tem dependido deles tão fortemente para resolver seus problemas emocionais?”. O truque é desafiar o comprometimento do paciente de forma eficaz o suficiente para fazê-lo pensar sobre isso, mas não tão eficaz ou forte a ponto de fazê-lo desistir. No melhor resultado, o paciente argumentará de volta algo como: “Sei que vai ser difícil, mas não consigo ver como posso continuar com a compulsão e purgação para resolver todos os meus problemas. Quero uma vida maior que isso”. Uma vez que o paciente faz um argumento desse tipo a favor do comprometimento (um que soe firme e genuíno), você recua do desafio e diz algo como: “Você precisa se lembrar desse argumento quando as coisas ficarem difíceis”.

Em uma conversa desafiadora e contínua de comprometimento, é provável que tenhamos todas as estratégias em discussão, sem ordem específica, e na prática elas muitas vezes se sobrepõem e se fundem entre si. A mudança de uma estratégia para outra deve ser sutil e suave, tecida como parte de uma conversa normal. Devemos estar concentrados não em empregar estratégias, mas em provocar comprometimento, explorando a ambivalência por meio de prós e contras, criando movimento para frente e para trás com um esforço para fortalecer o argumento, do ponto de vista do paciente, a favor do compromisso. É uma tarefa habilidosa. Muitas vezes, encontro o uso do advogado do diabo em questão de alguns segundos, em uma ou duas declarações. Enquanto exploramos os prós e contras, o paciente pode dizer: “Quero estar na DBT porque sei que tenho que mudar”. Eu posso dizer: “Sim, eu realmente gosto disso em você, e é por isso que você vai ter

sucesso. Mas deixe-me perguntar, só por um segundo. Você percebe que isso vai ser uma das coisas mais difíceis, senão a mais difícil, que você já fez?”. Apenas um toque, apenas um leve desafio momentâneo projetado para testar e fortalecer o comprometimento e provocar uma declaração mais forte do paciente.

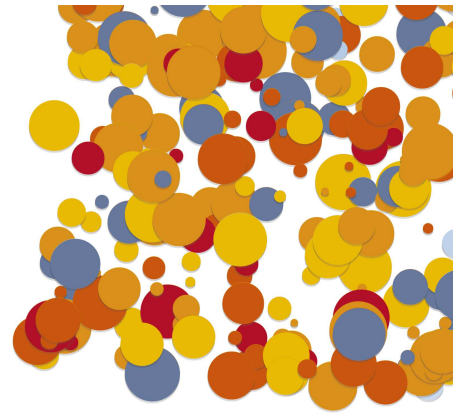
Modelando aproximações sucessivas ao comprometimento

Essa é outra estratégia de comprometimento usada na forma de “pinceladas”, comentários rápidos para reforçar alguma evidência, mesmo que pequena, de comprometimento. O paciente diz: “Realmente não queria voltar para vê-lo hoje; tenho muitas dúvidas sobre entrar em seu programa”. Querendo reforçar a chama de interesse no contexto da ambivalência, o terapeuta pode responder com calor e sinceridade, dizendo: “Fico muito feliz que tenha vindo hoje, mesmo com suas dúvidas. Parece que precisou de muita coragem”. O paciente diz: “Não quero dizer que vou parar de me cortar, porque não tenho certeza se posso parar”, ao que o terapeuta pode dizer “Sei que tem suas dúvidas; e aprecio o quanto é honesto sobre elas. Assim, quando você diz algo, sei que está sendo sincero”. E quando o terapeuta percebe que o paciente relutante em se comprometer está falando com um pouco mais de conforto e confiança na sessão, ele pode simplesmente compartilhar a observação sobre o crescente conforto do paciente na conversa, expressando admiração pelo trabalho árduo que está fazendo para se estabilizar. A prontidão do terapeuta em moldar as respostas do paciente, reforçando aproximações sucessivas a um comprometimento mais forte de mil maneiras, está sempre presente.

COMENTÁRIOS FINAIS

Quando os terapeutas DBT estão eles mesmos 1) comprometidos com o tratamento e a mudança comportamental, 2) comprometidos com a necessidade de comprometimento de seus pacientes, 3) focados em metas ou alvos específicos e 4) têm boas conexões com seus pacientes, eles têm uma ótima chance de promover comprometimento suficiente de seus pacientes ao longo do tempo. Para fazer isso de forma inteligente e habilidosa, é útil compreender e implementar os três paradigmas e seus princípios, manter o “espírito de comprometimento” e apreciar e fazer uso da complexidade e da riqueza de cada uma das estratégias de comprometimento.

[manual de tratamento] N. de R.T.: Aqui refere-se à Linehan (2010).



Análise em cadeia do comportamento

A NATUREZA E AS FUNÇÕES DA ANÁLISE EM CADEIA DO COMPORTAMENTO

A análise em cadeia do comportamento foi descrita de forma clara e detalhada no manual de tratamento (Linehan, 2010) e em muitas publicações desde então. Especialmente durante o estágio 1 na terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*), quando comportamentos problemáticos estão sendo monitorados, avaliados e tratados, a análise em cadeia do comportamento serve como o centro da maioria das sessões de terapia e funciona de várias maneiras:

- Como o principal meio de avaliação para determinar as variáveis controladoras dos comportamentos-alvo prioritários.
- Como o primeiro passo na sequência de solução de problemas baseada em terapia cognitivo-comportamental (TCC; os passos subsequentes sendo *insight*; análise de soluções; procedimentos de mudança, como modificação cognitiva, treinamento de habilidades, procedimentos de manejo de contingências e procedimentos de exposição; estratégias didáticas; estratégias de orientação; e estratégias de comprometimento).
- Como a estrutura organizadora da sessão (a plataforma das sessões de terapia durante o estágio 1) dentro da qual os dados são coletados e organizados, hipóteses são geradas, soluções são consideradas e selecionadas, e procedimentos de mudança são implementados.

A análise em cadeia do comportamento serve para vários outros propósitos na DBT:

- *Formulação do caso*: como vimos no Capítulo 10, a cadeia do comportamento é o modelo para a formulação do caso e planejamento do tratamento, um organizador gráfico útil para

visualizar os elos problemáticos na cadeia e os possíveis medicamentos.

- *Análise de missing links*: além de servir como a ferramenta principal para localizar, considerar e tratar os elos problemáticos na cadeia, o terapeuta também pode usá-la para localizar, considerar e tratar a ausência de elos eficazes que poderiam ter levado a melhores resultados.
- *Fortalecimento de memória e atenção*: a microanálise repetida dos elos na cadeia pode treinar o paciente a prestar mais atenção aos padrões e detalhes comportamentais antes, durante e depois dos comportamentos problemáticos conforme ocorrem durante a semana. De fato, a instrução sobre como realizar a análise em cadeia do comportamento agora está incluída no livro *Treinamento de habilidades em DBT* (Linehan, 2018b).

Ao mesmo tempo, a análise em cadeia do comportamento pode funcionar a serviço de outros grupos de estratégias principais da DBT:

- *Mindfulness*: considerando que o procedimento envolve total engajamento no momento presente, sem julgamento do que quer que surja, e com um foco claro de atenção em obter os detalhes da história, a análise em cadeia do comportamento serve como uma prática contínua de *mindfulness*, fundamentando a abordagem de solução de problemas em uma atmosfera aceitadora e consciente.
- *Exposição*: dado que a análise em cadeia leva a mente do paciente a entrar em contato com elos na cadeia que foram evitados e suprimidos devido ao seu poder de evocar emoções dolorosas, o procedimento muitas vezes serve como exposição, com os elos emocionalmente significativos servindo como estímulos.

- *Modificação cognitiva*: considerando que a revisão da cadeia revela certos pensamentos disfuncionais na sequência que leva ao comportamento problemático, e que o terapeuta pode destacar que esses pensamentos são apenas pensamentos e não a realidade, a análise em cadeia do comportamento se torna um mecanismo de modificação cognitiva.
- *Treinamento de habilidades*: uma revisão da cadeia destaca a presença de déficits de habilidades e serve como uma plataforma em tempo real para o treinamento de habilidades. O terapeuta está atento não apenas aos déficits de habilidades, mas também aos comportamentos adaptativos que aparecem na cadeia, que podem ser reforçados.
- *Procedimento de manejo de contingências*: a condução da análise em cadeia do comportamento muitas vezes também serve como um procedimento de manejo de contingências. O paciente que está cansado da análise microscópica repetida da cadeia às vezes se abstém dos comportamentos problemáticos durante a semana para evitar gastar tempo da sessão analisando a cadeia do comportamento. Quando perguntei a uma paciente como ela conseguiu interromper seu comportamento de escoriação na semana anterior, após meses praticando diariamente, ela respondeu: “Só pensei: vou ficar muito brava se passar outra sessão de terapia fazendo mais uma análise sobre escoriação – é tão entediante!”.

Tudo está na cadeia. Há manifestações da teoria biossocial: evidências de vulnerabilidade emocional e ambientes invalidantes. Além disso, há os padrões comportamentais discutidos no Capítulo 8, os dilemas dialéticos. Também encontramos cognições problemáticas, respostas emocionais automáticas e intensas a estímulos manejo de contingências problemáticas, bem como cognições funcionais e respostas habilidosas. As memórias do paciente, implícitas e explícitas, aparecem na cadeia; portanto, o

histórico de desenvolvimento está na cadeia. Esperanças para o futuro aparecem na cadeia e às vezes são a fonte de crescimento; às vezes, o gatilho para emoções negativas. Evidências de apego ao terapeuta e problemas com o apego ao terapeuta podem ser encontrados na cadeia. Tendo praticado terapia psicanalítica para transtorno da personalidade *borderline* (TPB) por muitos anos, tenho a impressão de que tudo que é encontrado na terapia psicodinâmica também pode ser encontrado na cadeia. Curiosamente, a análise em cadeia do comportamento, o sistema para avaliação e tratamento na DBT, é um sistema horizontal, no qual o terapeuta procura antecedentes “à esquerda” e consequências “à direita”, enquanto o sistema para compreensão e intervenção na terapia psicodinâmica é vertical, com conteúdo manifesto e conteúdo latente: camadas “cada vez mais profundas” de defesas, fantasias e relações-objeto internalizadas. A maioria dos pontos de dados em cada um desses dois modelos pode ser mapeada no outro modelo, muitas vezes exigindo a tradução de termos e conceitos.

O progresso no tratamento é refletido nas modificações das cadeias típicas de cada paciente. Pode-se dizer que no estágio 1 da DBT, o terapeuta conhece o paciente por meio de suas cadeias, intervém nelas e os resultados positivos são refletidos em cadeias transformadas.

Recentemente, uma mulher de 37 anos estava abordando vários comportamentos-alvo na DBT comigo. Um deles envolvia gritar com o marido na frente de seus filhos, fazendo comentários extremamente críticos em relação a ele. Seus gritos eram acompanhados por uma sensação de estar fora de controle de suas emoções e julgamento. Isso levava à emoção de vergonha, que resultava em outros padrões comportamentais disfuncionais, e ela temia que seus gritos estivessem causando um impacto negativo em seus filhos. Ela tinha pouco conhecimento sobre por que estava fazendo isso, por que não conseguia parar de fazer

isso e por que parecia estar fora de controle. Ela tentou repetidamente se dedicar ou se forçar a parar com esse comportamento, mas não teve sucesso. Cada episódio de gritos a convencia ainda mais de sua incompetência e ineficácia como esposa e mãe.

Nós especificamos o comportamento-alvo e começamos usando estratégias de comprometimento para fortalecer seu compromisso em encerrar o comportamento. Em particular, analisamos os prós e os contras, e eu destaquei o ponto de que ela tinha a liberdade de escolher se queria fazer isso ou não. Usei a estratégia de pé na porta para fazê-la se comprometer a parar totalmente o comportamento por uma semana de cada vez, e aproveitei as oportunidades para reforçar qualquer evidência de sua disposição e habilidade para interromper o padrão (modelagem). Seu comprometimento era alto, mas uma vez que ela estava exposta às circunstâncias agravantes, esse compromisso era anulado pela sua desregulação emocional.

À medida que o comportamento se repetiu diversas vezes nas semanas seguintes, tivemos várias oportunidades de buscar as variáveis controladoras mais importantes por meio da análise em cadeia. Em geral começávamos com a descrição que ela fazia da topografia: exatamente o que ela havia gritado, como havia gritado, como havia se sentido durante o comportamento e o que havia notado no rosto de seu marido e filhos enquanto gritava. Voltamos nossa atenção para os seus fatores de vulnerabilidade, que incluíam altos níveis de estresse ao cuidar das crianças e da casa, e ressentimento acumulado em relação ao marido. Em cada cadeia, identificamos um evento desencadeador. Detalhamos os elos da cadeia após o evento desencadeador e que levavam ao comportamento de gritar: seus pensamentos, suas emoções, suas ações, o comportamento do marido e o comportamento das crianças, com atenção especial às emoções que ela estava tentando regular ao longo da cadeia. Depois, nos concentramos

nas consequências do comportamento de gritar e no ambiente ao seu redor. Em particular, estávamos procurando por quaisquer consequências que reforçassem o grito e quaisquer consequências que pudessem levar à supressão de estratégias comportamentais mais eficazes. Encontramos diversas semelhanças nas várias análises em cadeia de seu comportamento de gritar, bem como algumas características únicas para cadeias específicas.

Geramos múltiplas hipóteses sobre as variáveis controladoras do comportamento e listamos várias ideias sobre possíveis soluções. Em relação aos fatores de vulnerabilidade, elaboramos planos para ela cuidar melhor de si mesma com técnicas de manejo de estresse. Em relação aos eventos desencadeadores e fatores situacionais, identificamos escolhas que poderiam ser tomadas para evitar ou modificar as circunstâncias mais agravantes. Em relação aos elos da cadeia entre eventos desencadeadores e gritos, identificamos e desafiamos crenças que resultaram em uma sensação de impotência e praticamos habilidades comportamentais de observar suas emoções, agir de forma oposta aos impulsos associados às emoções, tolerar o mal-estar com várias técnicas e, em geral, incorporar habilidades de *mindfulness* ao longo dos segmentos mais intensos da cadeia. Identificamos várias consequências que reforçaram o comportamento de gritar: 1) interrompeu alguns comportamentos do marido em relação às crianças que ela considerava abusivos; 2) proporcionou um meio para expressar sua raiva em relação a ele e “descarregar” parte do seu ressentimento acumulado; e 3) deu a ela uma sensação de estar no controle, que reverteu sua dolorosa sensação de impotência nessas situações. Em sua mente, ela estava protegendo seus filhos de um pai abusivo, em contraste com a dolorosa lembrança de que, quando criança, sua própria mãe não a protegeu de um pai verbal e emocionalmente abusivo.

Apesar da potência e do imediatismo dessas consequências reforçadoras, o fato é que seus gritos assustavam seus filhos, o

que a levava a um ciclo de culpa, vergonha e impotência. Quando analisamos os possíveis comportamentos eficazes que estava evitando (análise de *missing links*), ela percebeu rapidamente que seu medo do marido a fazia evitar uma discussão assertiva com ele sobre seu comportamento em relação às crianças. Ao longo de toda a cadeia, suas escolhas se tornaram mais claras. Ela cuidou melhor de si mesma, fez escolhas mais sensatas sobre como se relacionar com o marido na presença das crianças e trouxe o marido para uma sessão a fim de discutir seu medo da irritabilidade e raiva dele. Tendo estabelecido mais controle e autoestima e resolvido o “problema do grito”, o foco da terapia mudou para problemas conjugais de longa data.

Como vemos nesse exemplo, a análise em cadeia do comportamento pode ajudar os pacientes a passarem do caos à ordem, da confusão à percepção e da impotência para mudanças comportamentais planejadas. Ela fornece um contraponto à passividade e ao descontrole para o terapeuta e o paciente e estrutura e direção na terapia, complementando uma abordagem atenta e compassiva, empática e validadora. Ela fornece uma escada para descer ao inferno do paciente e para ajudá-lo a sair, e ajuda um terapeuta a pensar claramente em meio ao caos.

Fazer análise em cadeia do comportamento é um procedimento colaborativo em que o terapeuta e o paciente estão construindo algo juntos. Idealmente, isso os une. E enquanto constroem a cadeia, elo por elo, é possível parar a qualquer momento, interromper sua construção e mudar para refletir sobre até aquele ponto: aprofundar a compreensão do elo atual, recuar e considerar padrões que estão surgindo na cadeia, refletir sobre as semelhanças entre a cadeia atual e outras cadeias analisadas anteriormente e pensar em possíveis alternativas para certos elos ou padrões.

No decorrer da identificação dos elos na cadeia, a equipe paciente-terapeuta frequentemente chegará a certos elos que

poderiam se beneficiar da iluminação psicoeducacional. Bem naquele momento, “aproveitando enquanto o ferro está quente”, o terapeuta pode educar didaticamente o paciente sobre o assunto, seja qual for. Por exemplo, ao tratar um sujeito com comportamentos de abuso de substâncias e chegar ao elo da cadeia em que ele sente impulsos ou desejos de usar, o terapeuta pode rapidamente “sair da cadeia” e fazer um segmento didático de três minutos sobre impulsos e desejos. Da mesma forma, ao revisar um segmento da cadeia, o terapeuta pode convidar o paciente a “ficar de fora” por um momento e considerar uma hipótese sobre aquele segmento. “É possível que você estivesse tendo um dia estressante, que seus filhos estivessem inquietos, que a desconexão entre você e seu marido tenha provocado mais ansiedade do que você percebeu, e que sua ansiedade tenha desencadeado sua raiva?” Ou: “Talvez gritar com seu marido reduza sua ansiedade; o que acontece se você não gritar com ele nessa situação?”. Novamente, ao lado da construção da cadeia, há um diálogo reflexivo contínuo entre terapeuta e paciente. No início do aprendizado para realizar análises em cadeia do comportamento, os terapeutas podem, sabiamente, seguir a função de avaliação, simplesmente detalhando uma cadeia elo por elo, adiando as análises de solução e outras etapas de solução de problemas até que a cadeia esteja concluída. Mas os clínicos mais experientes podem efetivamente entrelaçar a solução de problemas dentro e fora da cadeia à medida que ela é iluminada. Por exemplo, em meio à condução da análise em cadeia, o terapeuta pode convidar o paciente a resolver problemas com declarações como estas:

“Você acha que há alguma relação entre o que aconteceu nesta cadeia e o que aconteceu na semana passada?”

“Você consegue imaginar como as coisas teriam acontecido se não tivesse interpretado a declaração dele como algo pessoal

referente a você?”

“Você acha possível que haja um padrão aqui, em que qualquer referência ao seu corpo desencadeia memórias terríveis e vergonha?”

“Você acha que teria se machucado na sala de emergência se soubesse com antecedência que não seria internado em um hospital?”

Em uma sessão recente, enquanto passávamos pelos elos da cadeia a caminho do comportamento de autolesão, outra paciente minha reconheceu que pensou em me ligar para receber *coaching* telefônico quando sentiu vontade de se cortar. Isso já havia sido mencionado antes, e percebi que ela nunca havia me ligado. Com base em discussões anteriores, identificamos um padrão de não pedir ajuda exatamente quando mais precisava. Destaquei o padrão, perguntando a ela se achava que não me ligar era mais um exemplo de não pedir ajuda. Relutantemente, ela admitiu que era verdade. Continuou dizendo que era exatamente quando se sentia pior que não queria pedir ajuda, pois achava que isso sobrecarregaria desnecessariamente a outra pessoa.

Naquele momento, estávamos formulando hipóteses “fora da cadeia”, refletindo sobre um padrão que havíamos identificado. Ao considerar possíveis soluções, sugeri que fizéssemos um *role-play* de um *coaching* telefônico. Como é frequentemente o caso, o *role-play* combinou várias etapas de mudança em um único “pacote”, incluindo modificação cognitiva, treinamento de habilidades e exposição a estímulos que ela estava evitando. Após uma breve orientação e preparação para o *role-play*, ela me “ligou” para receber orientação. A paciente foi hesitante, relutante, como se não tivesse o direito de me ligar. Analisamos isso e dei-lhe *feedback*. Sugeri alguns ajustes e fizemos o *role-play* novamente. Ela se mostrou mais “merecedora” de pedir ajuda, mais eficaz ao fazê-lo. Analisamos o segundo *role-play*, consideramos se poderia

fazer isso “na vida real” e a fiz se comprometer a fazer uma chamada de *coaching* telefônico na próxima vez que estivesse em apuros. Depois, retornamos à cadeia onde havíamos parado e continuamos nossa análise.

Quando a DBT é praticada de maneira competente, o terapeuta rotineiramente alterna entre avaliação, reconhecimento de padrões, análise de soluções e solução de problemas. O terapeuta deve se tornar habilidoso em sair da cadeia, envolver-se em análise de soluções e solução de problemas, mantendo a cadeia na memória de trabalho, depois reorientando o paciente para onde eles estavam. Se isso for feito de maneira eficaz, fluida e concisa, não precisa parecer desconexo, brusco ou forçado. É necessário praticar para chegar ao ponto em que se mover dentro e fora da cadeia, preservando a sua estrutura, mas conduzindo a sessão de maneira fluente que funcione, pareça mais uma conversa e o desenrolar de uma narrativa do que a imposição de um procedimento.

Quanto mais claro e mais habilidoso o terapeuta se torna ao usar a análise em cadeia nas sessões, mais o uso da cadeia também pode ajudá-lo a se regular. Lidar com a desregulação emocional crônica e grave pode ser muito difícil. O terapeuta pode “cair no abismo” com o paciente e não saber o que fazer. Quanto mais ouve, mais compartilha a confusão e desesperança do paciente. Na análise em cadeia do comportamento, ele tem um amigo: um procedimento sistemático, algo como um ritual, enquanto explora e tenta recrutar o paciente para se juntar a ele na busca de soluções. Estabelecer e retornar à cadeia, repetidamente, pode ser algo como uma prática de *mindfulness* para o terapeuta e, depois, para ambas as partes. Em vez de “voltar à respiração, voltar à respiração”, é “voltar à cadeia, voltar à cadeia”. A cadeia é algo para “agarrar-se”, pode ter o efeito de acender uma lanterna quando se está tateando no escuro. Mesmo que não leve rapidamente a uma solução, ela ilumina um caminho.

Como uma prática de “ancoragem”, pode restaurar a ordem, reduzir a desregulação e gerar esperança para ambas as partes.

OS “FUNDAMENTOS” NA REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE EM CADEIA

Os leitores familiarizados com o modelo e a prática da análise em cadeia do comportamento podem pular esta seção, mas para aqueles que são menos familiarizados, esta seção pode servir para apresentar ou consolidar sua compreensão da técnica. A “cadeia” da DBT consiste em cinco categorias consecutivas de elementos, visualizados da esquerda para a direita. Primeiro estão os fatores de vulnerabilidade, as causas ou questões que tornam o paciente mais vulnerável ao evento desencadeador. Em segundo lugar, está o evento desencadeador, um momento significativo que provoca os eventos subsequentes, levando eventualmente ao comportamento problemático. Em terceiro lugar, estão os “elos da cadeia”, uma categoria que inclui todos os comportamentos (pensamentos, emoções, ações, eventos fisiológicos) e eventos no contexto ambiental que se seguem ao evento desencadeador e levam ao comportamento problemático. Em quarto lugar, está o próprio comportamento problemático, descrito objetivamente e em detalhes. Após o comportamento problemático, está a quinta categoria, as consequências do comportamento problemático, com foco especial nos resultados que provavelmente reforçarão a ocorrência futura do comportamento problemático, além daqueles que provavelmente inibirão (extinguirão ou punirão) comportamentos que seriam mais adaptativos.

Ao fazer a análise em cadeia, há uma sequência típica com muitas variações, dependendo das circunstâncias e do julgamento clínico. Em geral, começa-se obtendo o relato específico do comportamento problemático, sua fenomenologia, sem relatar os antecedentes, consequências, interpretações ou julgamentos a respeito. Isso requer alguma disciplina por parte do terapeuta, pois é natural “seguir em frente” a partir da descrição detalhada,

sobretudo porque simplesmente descrever o comportamento pode desencadear ansiedade, vergonha, culpa, raiva, nojo e outras emoções negativas que o paciente, e às vezes o terapeuta, prefeririam evitar.

Tendo obtido uma descrição satisfatória do comportamento-alvo, o terapeuta normalmente passa à busca pelo evento desencadeador. O terapeuta deseja localizar um evento desencadeador que seja suficientemente “próximo” ao comportamento problemático (minutos, horas, talvez um dia) para permitir um relato significativo dos eventos desde o evento desencadeador até o comportamento problemático no período de uma sessão. Poderíamos argumentar que, em uma situação específica, o evento desencadeador foi o “dia do meu nascimento” ou o “instante em que meu bisavô chegou aos Estados Unidos, vindo da Europa”. Embora tal resposta possa fornecer significado, não fornece informações para uma análise em cadeia do comportamento significativa em uma sessão. O terapeuta procura um evento desencadeador que foi um encontro entre o paciente e o ambiente (em vez de um evento privado para o paciente que não foi desencadeado em relação ao ambiente). Há algo um tanto arbitrário em escolher um evento desencadeador específico quando pode haver tantos candidatos. Para extrair o evento desencadeador, o terapeuta pode usar frases como as seguintes:

“Se você estivesse escrevendo um roteiro e quisesse identificar o evento que aconteceu e colocou as coisas em direção ao comportamento problemático...”

“Tente pensar em um momento em que as coisas ainda estavam indo razoavelmente bem e, depois, pense no evento que aconteceu e mudou a história...”

“Tente pensar no fato que aconteceu na cadeia que, se não tivesse acontecido, não teria feito você seguir aquele caminho...”

“Qual você acha que foi o gatilho, o ponto de virada...?”

Observe que, se você conduzisse uma análise em cadeia como sugeri até este ponto, teria caracterizado dois “pontos de dados” ao longo da cadeia: o evento desencadeador e o comportamento problemático. Acho útil, na mente ou no papel, imaginar o evento desencadeador como existente cerca de um quarto do caminho na cadeia e o comportamento problemático em cerca de três quartos do caminho na cadeia. Isso deixa um quarto da cadeia à esquerda do evento desencadeador para a descoberta de fatores de vulnerabilidade, metade da cadeia entre os dois pontos de dados para descobrir os elos da cadeia e um quarto da cadeia à direita do comportamento problemático para a busca de consequências contingentes ao comportamento problemático.

Perceba que a decisão sobre o segmento de cadeia escolhido para análise é, em certo grau, arbitrária, já que a vida é uma cadeia infinita e microscópica. Seleccionamos um segmento que fornecerá uma “história” suficiente para revisar e determinar algumas variáveis essenciais de controle do comportamento problemático. É importante perceber que não existe uma “cadeia real”, como se um especialista fosse descobrir a “certa”. Na verdade, um treinador experiente de DBT testou esse ponto ao representar um paciente passando por uma análise em cadeia do comportamento, apresentando o mesmo cenário exato para cinco especialistas em DBT diferentes e descobrindo que as cinco diferentes cadeias do comportamento eram decididamente diferentes.

Depois de identificar um evento desencadeador, o terapeuta se move “para a esquerda”, a fim de determinar os fatores de vulnerabilidade, perguntando “O que você acha que pode ter o tornado especialmente vulnerável ao evento desencadeador naquele dia?” ou “para a direita”, perguntando “Depois do evento desencadeador, o que aconteceu em seguida?”. Qualquer escolha

pode funcionar perfeitamente bem e, muitas vezes, é simplesmente o fluxo da sessão e a direção do pensamento do paciente que influenciam qual caminho seguir. Depois de determinar os fatores de vulnerabilidade, o evento desencadeador, os elos da cadeia e o comportamento problemático, a última categoria a ser investigada é a das consequências do comportamento problemático. Tendo revisado os elos da cadeia que levam ao comportamento problemático, torna-se natural perguntar: “E depois que você fez X, o que aconteceu?”. Embora essa sequência possa parecer lógica, na verdade, às vezes o fluxo da conversa levará diretamente às consequências a partir da descrição do comportamento problemático. O paciente pode começar a descrever naturalmente as consequências, caso em que o terapeuta também pode seguir nessa direção, obtendo as consequências “quando estão quentes” e, em seguida, retornando ao evento desencadeador.

Se um terapeuta é excessivamente dogmático sobre “construir a cadeia”, incluindo todos os detalhes, o que, obviamente, ele deseja fazer, não deve fazê-lo às custas do relacionamento com o paciente. O terapeuta deve trazer a cadeia para o relacionamento com o paciente, não trazer o relacionamento com o paciente para a cadeia. Em outras palavras, o paciente não deve ser “arrastado” pela condução da cadeia, o que indicaria que a cadeia é mais importante do que ele, como paciente. Se feita corretamente, mesmo uma análise rigorosa da cadeia deve parecer muito natural.

Se eu quiser consertar uma torneira pingando, penso naturalmente nos antecedentes do problema, elo por elo, enquanto considero como proceder. Quando levamos nosso carro a um mecânico, ele precisa saber a natureza exata do problema (definição do problema), o *status* recente e o histórico de reparos do carro (fatores de vulnerabilidade), o início do problema (evento desencadeador) e como as coisas se desenvolveram desde a percepção inicial do problema até a situação atual (elos da cadeia).

A análise em cadeia do comportamento é uma versão formalizada de um processo de investigação humano muito natural e geralmente ocorre melhor com o paciente se for conduzida nesse espírito. O terapeuta diz: “Conte-me mais sobre isso e depois me diga quando começou; quero saber cada passo ao longo do caminho para que possamos descobrir como consertar isso”. Essa maneira de falar geralmente funciona melhor do que se começar com: “Vamos fazer uma análise em cadeia do comportamento sobre esse comportamento”. Queremos convidar os pacientes a contarem suas histórias, a terem uma conversa sobre o que aconteceu, em vez de impor um procedimento terapêutico à conversa. Com alguns pacientes e terapeutas, é útil fazer isso em um quadro branco, diagramando cada elo da cadeia, movendo-se da esquerda para a direita. Essa exibição visual torna a cadeia e a experiência que está sendo capturada muito concretas e envolve os pacientes como colaboradores, usando suas próprias canetas. Comumente, os terapeutas se sentam em frente aos pacientes e desenham a cadeia emergente em um pedaço de papel à medida que os dados surgem. Às vezes, os terapeutas simplesmente conversam com os pacientes, sem fazer anotações ao longo do caminho; mas é frequentemente útil anotar os elementos essenciais da cadeia logo após a sessão, para revisão posterior.

Estou falando aqui sobre encontrar uma síntese para a dialética em que o terapeuta, por um lado, procura uma cadeia rigorosamente definida, preservando simultaneamente um bom relacionamento com o paciente. No fundo da mente do terapeuta, ele é disciplinado, descrevendo a narrativa de maneira cronológica, elo por elo, preenchendo o modelo da cadeia, enquanto permanece fluido, atento e conversador, envolvendo o paciente em um encontro humano que faz sentido para ambas as partes. Isso não é muito diferente da realização de um exame de *status* mental, que exige a obtenção de muitos dados “duros” de uma maneira que não seja experimentada pelo paciente como um interrogatório.

CONTRIBUIÇÕES DO PARADIGMA DA ACEITAÇÃO

Não é surpreendente que o trabalho de fazer análise em cadeia do comportamento com indivíduos que são crônica e severamente desregulados emocionalmente possa ser muito desafiador. Somos bem servidos por saber como conduzir uma análise em cadeia de maneira clara, sequencial e organizada, como uma técnica de solução de problemas descrita anteriormente. Podemos aumentar essa abordagem comportamental com o uso de princípios do paradigma da aceitação e do paradigma dialético da DBT. Essa ampliação será especialmente necessária em circunstâncias em que o trabalho de solução de problemas é interrompido por várias manifestações de desregulação emocional. O terapeuta DBT pode se beneficiar da integração dos seguintes princípios do paradigma da aceitação, conforme discutido no Capítulo 3:

- Estar totalmente presente, inteiramente no momento, 100% acordado.
- Praticar o desapego a ideias ou percepções de como a cadeia deve parecer e como o processo deve fluir.
- Trazer a perspectiva de ausência limites, não eu, vacuidade e interexistência difusa para a prática da análise em cadeia.
- Trazer a perspectiva da impermanência para a prática da análise em cadeia.

Estar totalmente presente

Fazer análise em cadeia do comportamento é uma tarefa cognitiva complexa realizada com um objetivo em mente e obstáculos ao longo do caminho. Anteriormente, descrevemos o desafio de manter um bom relacionamento com o paciente enquanto realiza uma análise em cadeia rigorosa. À medida que o terapeuta se

envolve na cadeia crescente, descobrindo a história, gerando e testando hipóteses, tentando intervenções de solução de problemas na plataforma da análise em cadeia, fazendo resumos e entrando e saindo da cadeia, é fácil acontecer de o trabalho focado no destino de “fazer” substituir a postura orientada para o presente de “estar”. A terapia pode ficar desequilibrada. O foco do terapeuta em “fazer” pode ser experienciado como intrusivo e desrespeitoso, e o paciente pode se sentir mais como um objeto do que um sujeito, mais como um problema do que um coparticipante. Obviamente, a postura ideal do terapeuta seria permanecer totalmente no momento presente enquanto faz análise comportamental e até mesmo enquanto pressiona por mudanças. Essa é a dialética central da DBT: pressionar pela mudança no contexto da aceitação.

De forma realista, a implicação para o terapeuta DBT é começar a sessão totalmente desperto e atento a si mesmo, ao paciente e à transação entre eles, sem olhar para trás, nem para frente. O terapeuta pode alcançar esse estado envolvendo-se em uma prática breve de *mindfulness* antes da sessão: *mindfulness* do corpo, da respiração, dos sons na sala ou de algum outro foco. Uma vez enraizado no momento presente com consciência, o paciente entra na sala e a sessão começa. Ele pode perceber que o terapeuta está realmente lá, com consciência, atenção, compaixão e validação. Então, à medida que o trabalho de mudança comportamental se inicia, será natural (embora infeliz) que o “fazer” (a revisão do cartão diário, a determinação dos alvos da sessão, o início da análise em cadeia do comportamento) interrompa o “simplesmente estar lá”.

Em qualquer ponto que o terapeuta perceba que se afastou de “simplesmente estar lá” (estar acordado, consciente e presente no momento), ele pode retornar. Em alguns casos, isso pode ser simples, começando com a percepção aguda de ter se desviado, seguida por um lembrete mental para retornar ao momento, ao

estado do próprio corpo e mente, à consciência e à interação com o paciente. Em outros momentos, não é tão fácil. Completamente envolvido no trabalho de análise e mudança comportamental, com o foco nos comportamentos-alvo e, às vezes, emocionalmente desregulado pelo trabalho com o paciente, o terapeuta está mais “preso”. Deixar de “fazer”, mesmo que por um momento para retornar ao presente, não é tão fácil.

Sob essas circunstâncias, a chave, mais uma vez, é perceber que isso aconteceu. Uma vez ciente de ter se afastado do momento presente, o terapeuta pode precisar realizar um breve exercício de *mindfulness* para “despertar”. Para mim, isso geralmente assume a forma de perceber as sensações do meu corpo sentado na cadeira, o que pode me levar a me “incorporar” novamente, ou observar uma ou duas respirações completas como uma transição de volta ao presente. Às vezes, apenas deixo meu olhar se concentrar totalmente nos detalhes da expressão facial do paciente. Posso perceber uma corrente emocional anteriormente não reconhecida ao estudar o rosto dele. Em cada um desses casos, o “exercício de *mindfulness*” leva apenas alguns segundos ou talvez meio minuto, e não interrompe meu contato visual ou foco. Em geral, não é perceptível para o paciente. De maneira importante, isso me faz pausar, mesmo que brevemente. A pausa é a manifestação de uma transição de “fazer” para “estar”. Em seu melhor, esse tipo de transição leva a uma suavização do estilo e a uma abertura do coração e da mente. No mínimo, leva a uma interrupção breve do trabalho voltado para a mudança, como “dar uma pausa”. Isso pode permitir que o paciente, ou ambos, simplesmente estejam lá um com o outro, pelo menos por um momento.

Praticar o desapego

O ponto essencial do desapego é “aceitar o que vem”, aceitar radicalmente que, apesar de nossos melhores esforços e maiores esperanças, muitas vezes é o caso de fatores além de nosso controle limitarem o tipo de dados que podemos obter e o tipo de processo que podemos promover. Queremos obter uma análise detalhada das ligações na cadeia, suficientemente microscópica para lançar luz sobre a progressão das ligações. Mas há uma centena de fatores que podem interferir. O paciente pode ter uma memória fraca para as ligações que buscamos, como é típico no contexto de episódios de comportamento de autolesão, uso de substâncias, compulsão alimentar e purgação, comportamentos antissociais e outros comportamentos problemáticos. O uso de substâncias pode turvar a memória de episódios inteiros de comportamento e até mesmo resultar em explicações conspiratórias, de forma que não sabemos no que acreditar. Episódios de amnésia e outros aspectos dissociativos podem ofuscar a memória do que aconteceu. Todos os terapeutas experientes tiveram pacientes que disseram algo como “não faço ideia do que aconteceu de X a Y”. Muitas vezes, estamos analisando eventos que ocorreram vários dias antes e, desde então, o indivíduo foi confrontado por outros fatos estressantes que tornam difícil lembrar o que aconteceu há vários dias. A evitação pode desempenhar um papel, já que qualquer um de nós frequentemente prefere “esquecer” o que aconteceu, ou, se esquecemos efetivamente, preferimos não trazer experiências dolorosas de volta à vida. Não é incomum que pacientes ocultem ou distorçam informações para evitar desagradar o terapeuta ou para evitar serem desleais com a família ou amigos. Além desses fatores comuns e outros, há episódios de má colaboração, conformidade e cooperação durante a sessão. Todos nós já experimentamos a decepção de querer entender o que aconteceu ontem ou o que está acontecendo na sessão, mas ao perguntar sobre isso, a resposta é “Eu não sei”, “Não quero falar sobre isso”,

“Eu não confio em você – por que deveria te contar?” ou “Tanto faz!”.

O princípio budista do desapego visa a lidar com o sofrimento causado quando permanecemos apegados a resultados que não podemos mudar. Tentando “superar a resistência”, “obter os dados apesar do paciente” ou, de outra forma, nos apegarmos ao nosso desejo de obter o que consideramos um nível necessário de detalhes sobre o que aconteceu, ficamos mais frustrados, menos flexíveis, menos conscientes do paciente no momento e podemos acabar invalidando-o. Felizmente, é raro que realmente precisemos de uma análise exaustiva ao longo da cadeia para resolver problemas. Ao deixar de lado nosso apego em obter uma história mais detalhada e aceitar *genuinamente* o que conseguimos obter, podemos, então, aplicar a técnica organizadora da análise em cadeia do comportamento aos *links* disponíveis. Ainda assim, fazemos a modelação de uma maneira de pensar, de investigar e dar sentido às coisas. Podemos fazer isso, quer tenhamos quatro pontos de dados ou 14.

No início da minha prática de DBT, quando estava convencido de que precisava de cadeias detalhadas, era particularmente frustrante quando o paciente tinha pouco a dizer. Lembro-me de ouvir uma vez: “Não faço ideia do que aconteceu durante a noite, só me lembro de que acordei com cortes nos braços”. Eu não tinha certeza se acreditava nele. Como poderia obter informações suficientes para formular e tratar o problema? Acreditando no paciente ou não, eu tinha uma quantidade limitada de informações. Se conseguisse deixar de insistir em conseguir algo que nunca obteria, poderia manobrar com mais flexibilidade, dizendo algo como: “Qual é a última coisa da qual você se lembra da noite passada, antes do ponto em que não consegue se lembrar?”. Conseguimos tudo o que podemos, até o início dos *links* esquecidos e tudo que se segue, começando pelo primeiro momento do qual o paciente se lembra após o episódio esquecido.

No curso do tratamento do alvo prioritário de autolesão, posso encontrar outro alvo, para diminuir a falta de memória do paciente e tentar avaliar também este. Em outras palavras, eu forço para obter a cadeia de eventos para avaliar o alvo e, encontrando má memória ou má vontade, mudo de marcha e tento avaliar e tratar o comportamento que interfere. Em resumo:

1. Tento obter a cadeia de eventos necessária para avaliar o comportamento-alvo prioritário.
2. Encontro um bloqueio de memória ou de colaboração.
3. Persisto, talvez tentando outra estratégia para obter a cadeia necessária.
4. Descubro que o bloqueio é persistente.
5. Aceito radicalmente a realidade do bloqueio.
6. Em seguida, tento avaliar o próprio bloqueio como um alvo comportamental, a fim de avaliar o alvo original.

A sequência é a mesma, esteja eu lidando com um episódio dissociativo, com esquecimento ou não colaboração desafiadora. Em última análise, quando necessário, avalio e trato os comportamentos disfuncionais na sessão que estão interferindo em nossa aliança. O espírito é capturado na Oração da Serenidade dos Alcoólicos Anônimos. Aplicada à nossa situação clínica, seria: “Me dê a serenidade para aceitar o que não posso analisar, a coragem para analisar o que posso e a sabedoria para conhecer a diferença”.

Várias outras perspectivas sobre a análise em cadeia do comportamento podem nos ajudar, como terapeutas, a abandonar nosso apego à cadeia que desejamos obter e aceitar qualquer cadeia que seja possível eliciar. Primeiro, podemos esperar que o processo de análise da cadeia em si ofereça benefícios, mesmo quando os dados são escassos. Mesmo que a cadeia tenha apenas três elos, o paciente pode aprender a habilidade de refletir objetiva e sistematicamente sobre uma sequência comportamental.

Em segundo lugar, como mencionado anteriormente, a prática da análise em cadeia do comportamento pode fortalecer a capacidade do paciente de prestar atenção durante os episódios e registrar e lembrar de mais informações. Terceiro, se usarmos a análise em cadeia como uma maneira estruturada de mostrar genuína curiosidade nas experiências de nossos pacientes, isso pode melhorar o vínculo, mesmo que a quantidade de dados seja mínima. Especialistas em outro modelo de terapia baseado em pesquisa para o tratamento do TPB, terapia baseada em mentalização, descreveram a análise em cadeia do comportamento da DBT como uma forma de mentalização, uma maneira de expressar curiosidade, envolver-se em investigação aberta, conhecer a “mente” do paciente por meio das cadeias. A mentalização é considerada para melhorar o processo de apego seguro. Por último, se conseguirmos deixar de lado a busca incessante por mais informações, dar um passo atrás e identificar o obstáculo que impede a obtenção de informações adicionais, podemos redirecionar a sessão para abordar um comportamento disfuncional presente durante a sessão, que está atrapalhando a conquista do alvo prioritário. Após avaliar e solucionar o obstáculo, a conversa terapêutica pode retomar o trabalho em direção ao alvo prioritário.

Ausência de limites, não eu, vacuidade e interexistência

Os limites em torno de uma determinada cadeia do comportamento não são definidos. Como mencionado, qualquer cadeia específica tem início e fim arbitrários, para fins práticos. A cadeia é, na verdade, um segmento de uma cadeia infinitamente longa. Tão difícil quanto definir onde uma cadeia começa e termina é a designação de a quem ela pertence. É a cadeia do paciente, caso em que o trabalho do terapeuta é revelá-la? É um produto conjunto

de paciente e terapeuta, à medida que trabalham juntos para construir uma narrativa que se assemelha ao que realmente aconteceu? A cadeia representa uma combinação de muitos indivíduos que estiveram na vida do paciente? Se olharmos atentamente, na narrativa do paciente, capturada na cadeia, estão contribuições de pais, amigos, irmãos, empregadores e professores, e uma infinidade de eventos. Uma determinada cadeia também reflete todas as dinâmicas explícitas e implícitas que ocorriam no momento em que foi construída; se o terapeuta conduzisse uma análise em cadeia do comportamento do mesmo incidente exato um dia depois, o resultado seria diferente.

Tudo isso é outra maneira de dizer que a cadeia não tem um “eu” único e estático. Não tem uma identidade própria. É composta por história, presente, futuro; paciente e terapeuta e outros que interagem com eles; pensamentos, emoções e ações de ambas as partes; o contexto no momento, até mesmo o ambiente físico; a imaginação de ambas as partes. É mais como mercúrio líquido do que aço sólido, mais como uma miragem do que um corpo de água. Praticantes de *mindfulness* argumentam que um pensamento não é a mesma coisa que o que ele representa; não é um fato; é um pensamento e apenas um pensamento. Podemos considerar a cadeia do comportamento de maneira semelhante. É uma representação de um episódio na realidade, mas não é a mesma coisa que o que representa. Não é uma narrativa factual; é uma cadeia e apenas uma cadeia, construída conjuntamente a serviço da avaliação e do tratamento.

Ainda assim, é útil se nossa “narrativa da cadeia” estiver o mais próxima possível de uma experiência real, pois esperamos entender algo sobre os padrões comportamentais relevantes e esperamos que nossas intervenções na sessão se traduzam em mudanças comportamentais em sequências semelhantes fora das sessões. Então, nos relacionamos com a cadeia dessas duas maneiras muito diferentes: usamos como uma ferramenta em

direção a uma meta (a avaliação e o tratamento de um alvo de tratamento); e reconhecemos sua insubstancialidade, criatividade e flexibilidade. Portanto, ao mesmo tempo, é uma ferramenta bem definida e substancial e simplesmente uma forma sem limites distintos, sem um eu distinto, composta por ingredientes não relacionados à cadeia de muitos tipos. Podemos, por um lado, usar a cadeia no processo de “fazer” e, por outro lado, podemos estar com a cadeia no processo de “estar” com ela. A percepção aprofundada e a aplicação dessa dualidade nos proporcionam enorme flexibilidade e autonomia.

Eu estava conduzindo uma análise em cadeia do comportamento com um jovem de 17 anos que havia sido hospitalizado porque estava pesquisando na internet maneiras de assassinar sua mãe. Estávamos analisando um incidente em que ele havia ameaçado sua mãe, saído correndo de casa, desaparecido na floresta e, eventualmente, sido detido pela polícia e levado ao hospital. Enquanto revisávamos os elos da cadeia, e quando chegamos ao momento em que ameaçou sua mãe, perguntei se poderia descrever o que sua mãe havia dito e como o rosto dela parecia antes de ameaçá-la. Ele não se lembrou. “Não faço ideia; não consigo me lembrar de nada naquele momento.” Em vez de insistir em detalhes “na realidade”, pedi que ele inventasse. “Apenas me diga o que você acha que pode ter ouvido, o que você acha que pode ter visto, com base no seu conhecimento sobre sua mãe.” Ele contou facilmente o que ela poderia ter dito, acompanhado por uma descrição da provável expressão facial, postura corporal e tom de voz de sua mãe. Para nossos propósitos, incluindo a avaliação de seus comportamentos problemáticos, estava perfeito como estava.

Impermanência

Inerente à perspectiva de não ter limites, não eu (não cadeia) e interdependência, há um entendimento adicional sobre a impermanência da cadeia. Assim como tudo na realidade vem e vai, segundo a segundo e minuto a minuto, a cadeia também. Se alguém fizesse uma análise em cadeia do comportamento às 10h e, em seguida, analisasse o mesmo evento às 11h, a análise seria diferente. Isso não é surpreendente quando você considera que, uma hora depois, cada molécula e partícula subatômica em cada célula do cérebro e do corpo de ambas as partes será diferente; os humores e pensamentos do terapeuta e do paciente serão diferentes; e eventos intervenientes terão ocorrido. A análise não poderia ser a mesma. Essa compreensão pode ser angustiante para o terapeuta que busca a “única cadeia verdadeira” de eventos. No entanto, é uma perspectiva libertadora. Cadeias mudam, perspectivas mudam. A noção de impermanência pode ser especialmente útil para o terapeuta e o paciente que realizam uma análise em cadeia do comportamento após a outra, sessão após sessão, sobre um comportamento problemático que se repete toda semana, aparentemente igual todas as vezes. O ponto aqui é que o comportamento não é o mesmo de antes. Tem que ser diferente. Cada antecedente, cada consequência, cada evento contextual deve ser diferente. O terapeuta pode entrar em cada nova análise com uma mente fresca, com a “mente de iniciante”, como pode ser chamada na prática budista, curioso sobre novas descrições, novos elos e novos contextos e pronto para novos aprendizados. Manter essa postura pode ser transmitido ao paciente pela modelação, já que ele pode estar cansado de “passar pela mesma cadeia de novo e de novo”. Assim que ambas as partes estiverem convencidas de que já percorreram o mesmo caminho antes, a probabilidade de estarem atentas a um novo elo, anteriormente não percebido ou apreciado, ou a uma nova hipótese inexplorada, é pequena.

Por fim, a atitude terapêutica e as intervenções que surgem das visões budistas da cadeia geram atenção, frescor, curiosidade, resistência, compaixão e criatividade. Estar no momento presente, consciente da natureza vazia e sem limites da cadeia, atento à sua impermanência absoluta e não apegado a um resultado específico, liberta o terapeuta para estar totalmente desperto, caloroso e responsivo e validar o paciente de maneira bastante natural. Em contraste com a sensação de estar preso e sobrecarregado com a cadeia, isso cria um sentimento de abertura, possibilidade e esperança.

CONTRIBUIÇÕES DO PARADIGMA DIALÉTICO

Se o terapeuta fizesse uma análise em cadeia do comportamento com um paciente que mostrasse boa capacidade de regular emoções, cooperar no procedimento, manter o foco e uma atitude de confiança, provavelmente poderia prosseguir com pouco uso da perspectiva dialética. Os dois poderiam avaliar o comportamento problemático, gerar hipóteses e soluções, selecionar e implementar soluções, avaliar os resultados e ajustar. Em outras palavras, poderiam se ater principalmente à solução pura de problemas. Mas, com indivíduos de difícil tratamento que vivenciam desregulação emocional grave e crônica, a condução da análise em cadeia do comportamento é assolada por uma gama de dificuldades, algumas quase paralisando o processo de solução de problemas. Conforme discutido no Capítulo 5 sobre o paradigma dialético, os princípios incluem:

- A realidade é composta por oposições inevitáveis; a “verdade” é encontrada por meio da síntese dos núcleos válidos das posições opostas.
- Nossa compreensão da realidade é holística ou sistêmica; tudo está interligado; tudo é transacional.
- A mudança é constante; tudo está em fluxo.

Além disso, a postura dialética é aquela que promove improvisação, síntese, pensamento “ambos... e” em vez de “ou... ou” e um senso de velocidade, movimento e fluxo.

A realidade é feita de oposições

A cadeia do comportamento deve ser um veículo flexível e dialético, inclusivo de forças opostas, “mantendo” ambos os lados de um conflito ou oposição. Em si mesma, a cadeia não cria sínteses a partir de forças opostas, mas como uma estrutura e

como um procedimento que é “vazio” de qualquer viés ou posição própria, é inclusiva e permite trabalhar em direção à síntese. A cadeia pode fornecer o “campo de jogo” no qual as oposições entre terapeuta e paciente podem ser representadas e abordadas. Dentro da cadeia, encontramos oposições que se movem em direção à síntese, oposições entre o paciente e outras pessoas em seu contexto social e profissional, entre o paciente e o terapeuta, entre o paciente e seu próprio eu, entre uma perspectiva biológica e ambiental, e assim por diante. A cadeia é dinâmica e flexível e pode conter múltiplas oposições ao mesmo tempo. Como eu disse no início deste capítulo, tudo está na cadeia; todos os lados estão à mesa. Nesse aspecto, a cadeia, bem administrada, é a estrutura integrativa final na DBT.

Depois de reduzir com sucesso os comportamentos que ameaçavam sua vida (episódios de comportamentos suicida e autolesivos) e um comportamento destrutivo que interferia na qualidade de vida (furar), uma estudante universitária estava trabalhando comigo no próximo comportamento-alvo: diminuir os comportamentos que a colocavam em risco de ser maltratada por homens, enquanto aumentava comportamentos de natureza autorrespeitosa e autodefensiva. Após um incidente de estupro em um encontro, no qual um bom “amigo” do sexo masculino se aproveitou dela, estávamos no processo de realizar uma análise em cadeia do comportamento para identificar as variáveis controladoras em seu comportamento e no contexto. Ao analisarmos as ligações antecedentes em detalhes, ficou claro que, no início da cadeia, ela agiu com firmeza, autorrespeito e de forma autodefensiva. Mas, em um ponto posterior da cadeia, em um momento em que ela queria agradá-lo e não perdê-lo, “baixou a guarda”. Ela não queria ofendê-lo rejeitando-o e não conseguia encontrar uma maneira de agradá-lo e se respeitar ao mesmo tempo. Essa era a tensão e a contraposição de posições naquele ponto específico da cadeia. Em vez de tentar determinar se deveria

agradá-lo ou se deveria ser autodefensiva e rejeitá-lo, tentamos iluminar ainda mais essa oposição dialética. Quando “saltamos da cadeia” por alguns minutos, identificamos a validade de cada posição, em vez de procurar o “certo a fazer”. Procuramos uma síntese, em que ela pudesse obter o que queria dos amigos homens e, ao mesmo tempo, respeitar e proteger a si mesma. Provou ser um “momento dialético” produtivo para ela.

Pensamento holístico e sistêmico

Ao realizar a análise em cadeia do comportamento, é essencial que os terapeutas estejam cientes de que tudo é interdependente e transacional. Nada acontece no vácuo. A maneira como se pensa afeta como se sente; como se sente afeta como se pensa. A maneira como se age influencia e reflete como se pensa e se sente. A maneira como falam com um indivíduo afeta sua reação, e a maneira como reage influenciará como falam com ele. Em uma família, como o pai se dirige à mãe afeta imediatamente cada filho, e a maneira como os filhos se comportam e falam afeta a próxima interação entre os pais. Como pensamos, mesmo que não digamos explicitamente ao paciente, afeta nossos pacientes, e como nossos pacientes pensam nos afeta. A onipresença da interdependência e influência transacional a cada momento geralmente está além da consciência. Mas isso defende que os terapeutas mantenham a mente aberta, sempre cientes de que estamos perdendo algo, prontos para perguntar sobre detalhes, mesmo que pareçam irrelevantes, da forma como um bom detetive faria na cena de um crime. Devemos estar gerando hipóteses constantemente, levantando-as e abandonando-as quando não se sustentam, limpando a mente para outra olhada nos “dados”. O desempenho diligente de uma análise em cadeia do comportamento pode levar a um tipo de pensamento “em túnel” sequencial, eliminando uma gama de possíveis fatores, tendo

assim um impacto restritivo e limitador. Como uma estrutura transacional para nós, a análise em cadeia do comportamento fornece uma maneira racional e produtiva de organizar informações, permitindo a inclusão de uma enorme variedade de elementos, incluindo aqueles que não parecem pertinentes no momento. Se considerarmos flexivelmente uma diversidade de variáveis e explicações, fazemos a modelação desse tipo de pensamento dialético para nossos pacientes. Como Linehan (2010, pp. 120-123) menciona ao discutir a lista de alvos prioritários de tratamento, independentemente de qual meta está sendo abordada, estamos sempre abordando a meta global de aumentar o pensamento e a ação dialética.

Uma consequência interessante do conceito de que todo comportamento é transacional por natureza é a proposição de que todas as cadeias do comportamento também são transacionais. Enquanto o terapeuta e o paciente estão construindo a cadeia do comportamento em relação ao comportamento ocorrido no início da semana, eles estão simultaneamente “criando” ou “vivendo” outra cadeia: a cadeia de eventos que ocorre entre eles na sessão. Vamos chamar a primeira de “cadeia fora da sessão” e a segunda de “cadeia na sessão”. Em geral, ao identificar os elementos na cadeia fora da sessão, o terapeuta e o paciente estão apenas implicitamente cientes da cadeia na sessão. Quando os elos da cadeia na sessão se tornam problemáticos, interferindo na análise em cadeia fora da sessão, eles se tornam mais perceptíveis e podem exigir atenção. De fato, o terapeuta pode mudar da análise elo por elo da cadeia fora da sessão para a análise elo por elo da cadeia na sessão, durante a qual a cadeia fora da sessão permanece “dormente”, por assim dizer.

O terapeuta que mantém a consciência de ambas as cadeias, ou que se move entre elas com consciência e atenção, adicionou uma ferramenta dialética poderosa ao seu repertório. Ele pode começar a perceber a influência transacional entre as duas

cadeias, notando as interseções: comportamentos problemáticos semelhantes, eventos desencadeadores semelhantes, elos semelhantes, fatores de vulnerabilidade semelhantes e manejo de contingências semelhantes. Essa nova consciência naturalmente se transforma em intervenções destacando a transação:

“O que você está me descrevendo parece bem semelhante ao que acontece entre mim e você, não acha?”

“Isso já aconteceu com você aqui, comigo?”

“Percebo que, se eu estiver um pouco mais calado, você se retrai para sua ‘concha’ e agora ouço que você está fazendo isso com sua namorada. Eu me pergunto o que está acontecendo.”

“Você já percebeu que fica mais irritado nos dias em que dorme menos? Eu acho que isso acontece quando me vê depois de uma noite mal dormida.”

Esse tipo de referência cruzada regular entre as duas cadeias se torna outra lente para avaliação e tratamento. Na medida em que o terapeuta e o paciente podem ver que a mesma sequência de elos, resultando em comportamento problemático na realidade externa, ocorre na sessão, o trabalho feito na sessão para resolver o problema de maneira mais adaptativa pode ser generalizado para a realidade externa. Em minha experiência, se o paciente estiver bem orientado e as cadeias forem comparadas com precisão, esse tipo de referência cruzada aumenta a sensação de significado e importância em relação ao trabalho na sessão. Este também é um conceito central na psicoterapia psicodinâmica, na qual os problemas que o paciente tem na realidade externa são enfrentados no campo de batalha da transferência nas sessões.

Eu estava tratando de uma pessoa que destruía seu próprio apartamento e seus objetos sempre que ficava com raiva de seu parceiro. Às vezes, o álcool tinha um papel. Nós revisamos vários

desses episódios com análises cuidadosas de cadeias do comportamento, e embora tenhamos encontrado muitas variáveis que poderiam estar influenciando o comportamento, houve pouca evidência de mudança comportamental. Eu apresentei o problema e minha perplexidade para minha equipe de consultoria. Depois de considerar diversas alternativas sobre variáveis comportamentais e contextuais, um membro da equipe disse: “Sei que pode parecer loucura, mas me pergunto se você está fazendo algo em sessão que está reforçando ou desencadeando os episódios”. Parecia uma ideia forçada; não havia uma conexão óbvia que eu pudesse ver. Outro membro da equipe perguntou se eu poderia fornecer uma descrição mais detalhada da atmosfera e do andamento de nossa sessão terapêutica típica. Um certo padrão, quase uma fórmula, veio à tona. Ela costumava começar essas sessões com uma confissão vergonhosa: “Sei que você vai ficar bravo comigo; eu fiz de novo”. Ela desviava o olhar, abaixava a voz, agia timidamente e comunicava julgamentos severos sobre si mesma. Notei que me sentia como uma espécie de interrogador enquanto seguíamos objetivamente pela cadeia, e ela era a vítima pecadora e arrependida do interrogatório. Em outra metáfora, mencionei que era como se eu fosse um padre e ela estivesse me contando seus terríveis pecados em um confessionário. Na verdade, ela tinha sido criada de maneira bastante rigorosa como católica e estava muito familiarizada com o procedimento das confissões. Conforme conversava com a equipe, percebi que nossas sessões sempre terminavam de forma positiva. Nós faríamos a cadeia do comportamento, encontraríamos soluções, ela se comprometeria a tentar as soluções, ficaríamos ambos esperançosos em relação à semana seguinte, e nosso relacionamento perderia sua tensão.

Eu levei essa perspectiva para ela na sessão seguinte, e ela concordou imediatamente que se sentia como se estivesse confessando pecados, recebendo absolvição (por meio do tratamento comportamental) e sentindo-se purificada, conectada a

mim novamente e esperançosa. Me perguntei em voz alta se esse procedimento, essa sequência, entre ela e eu, poderia estar reforçando os episódios “pecaminosos”. Ela poderia perder o controle de seus impulsos, sabendo (no fundo de sua mente) que poderia vir ao seu “confessionário” de psicoterapia e receber a absolvição. Havia algo satisfatório e completo sobre o processo geral. Ela estava disposta a considerar a possibilidade, mas não tinha tanta certeza. Sugeri que as coisas poderiam ser diferentes se não chegássemos a uma conclusão tão feliz no final dessas sessões. Em vez disso, poderíamos perceber nossa vontade de encontrar um final confortável, mas lembrar a nós mesmos que a verdadeira solução viria se os comportamentos parassem. Do ponto de vista das estratégias de comunicação na DBT, em vez de mudar de um estilo irreverente (orientado para mudança) durante a sessão para um estilo recíproco (orientado para aceitação) no final, eu permaneceria no estilo irreverente até que as mudanças comportamentais reais ocorressem. Quase imediatamente, essa mudança no meu comportamento fez diferença. Pareceu aumentar sua consciência da nossa cadeia na sessão enquanto ela se envolvia na gestão fora da sessão de sua raiva em relação ao parceiro. No final, estávamos fazendo referência cruzada entre várias cadeias: a cadeia externa, fora da sessão, da realidade; a cadeia na sessão; a cadeia conforme evoluía na minha equipe de consultoria; e a “cadeia da confissão” que ela aprendeu em sua criação católica.

Como esse exemplo mostra, é frequentemente produtivo fazer referência de volta às cadeias do comportamento anteriores para adicionar poder explicativo e a credibilidade que vem com o reconhecimento da repetição. Para completar a consideração de quantas cadeias estão realmente em funcionamento durante a revisão de uma cadeia externa, podemos considerar que outra cadeia (geralmente silenciosa) vem da experiência anterior do terapeuta, seja na vida pessoal ou em sessões com este ou outros

pacientes. Algo feito ou dito pelo paciente ativa as cadeias do comportamento anteriores do terapeuta, o que poderia enviesar sua maneira de ouvi-lo e responder a ele. Podemos entender esse processo como uma versão comportamental da maneira como o psicoterapeuta dinâmico descobre e gerencia sua contratransferência, enquanto responde implicitamente ao paciente.

É claro que esse processo de manter várias cadeias em mente assume o centro do palco no tratamento do adolescente e da família na DBT. O terapeuta e o adolescente podem construir uma cadeia de eventos em uma sessão individual, filtrada pela perspectiva do adolescente. Em seguida, em uma sessão familiar envolvendo o adolescente e seus pais, o foco pode se voltar para a questão ainda mais complexa de construir uma “cadeia familiar”, na qual todos contribuem com uma revisão de seus próprios comportamentos e uma perspectiva sobre todos os outros. À medida que os membros da família constroem uma cadeia de eventos combinando várias perspectivas, as possibilidades explicativas se multiplicam e o terapeuta pode ajudá-los a reconhecer que o resultado comportamental do adolescente teve contribuições de todos eles.

Eu estava conduzindo uma análise em cadeia do comportamento familiar com um jovem viciado em várias substâncias. Embora ele tivesse “feito sentido” de seu comportamento em uma sessão individual, construindo uma cadeia, e mesmo que sua própria análise em cadeia tivesse incluído o impacto das interações com seus pais, a cadeia familiar em uma sessão subsequente com a família abriu nosso campo de observação e explicação para um conjunto mais amplo de fatores. Sem o conhecimento do adolescente, que formulou que a crítica severa da mãe em relação à “preguiça” dele foi um evento provocativo que levou a essa instância de uso de substância, a mãe acabara de sair de um encontro doloroso com o pai, que a

criticara por ser muito leniente com o filho. Saindo dessa sessão familiar, todos tinham trabalho a fazer e soluções para gerar. Além do “paciente identificado”, houve pressão em outros membros da família e, na verdade, uma consequência foi a realização de várias reuniões individuais com o pai para discutir seus próprios sentimentos de isolamento e solidão. Isso indiretamente pareceu ajudar seu filho a se comprometer a reduzir o uso de substâncias.

A mudança é constante e tudo está em um fluxo contínuo

Discutido anteriormente como “impermanência” no contexto da análise em cadeia do comportamento, o reconhecimento de que tudo está constantemente mudando, incluindo cada elemento trazido para a cadeia, pode preparar o terreno para a esperança do terapeuta e do paciente que estão presos repetindo a análise em cadeia de um comportamento-alvo repetitivo. Eu frequentemente me lembro: “Isso também vai passar; isso também vai mudar”. Similar ao reconhecimento budista de que “nunca se pisa duas vezes no mesmo riacho”, o terapeuta DBT pode reconhecer que nunca conduz a mesma cadeia duas vezes. A perspectiva de que a mudança está ocorrendo ajuda a combater a sensação de estar preso e paralisado que acompanha algumas terapias e promove uma abordagem da cadeia que é caracterizada pelo movimento.

Apesar de o terapeuta pensar que ele e o paciente estão cobrindo território antigo, simplesmente repetindo o que foi identificado antes e, portanto, sem esperança de mudança, essa perspectiva dialética o ajuda a 1) perceber que as coisas estão mudando e 2) manter um senso de movimento e fluxo na condução da análise em cadeia. Isso pode ser feito de muitas maneiras diferentes. O terapeuta pode alternar o foco entre cadeias distintas. Por exemplo, um adolescente pode mostrar pouca disposição para revisar sua própria cadeia de “má conduta”, mas pode estar

disposto a se envolver em relatar uma cadeia de eventos da família ou de uma de suas amizades; ou o terapeuta pode trazer sequencialmente uma ou outra perspectiva de sua própria história de aprendizado que possa estar relacionada à situação do paciente. O terapeuta é sábio em manter a terapia em movimento, intervindo com qualquer coisa, quase qualquer coisa (dentro dos limites da DBT), para evitar interações prolongadas e repetitivas, como:

“E então o que aconteceu?” – “Eu não sei.”

“Você tem alguma ideia de como explicar o que ela fez?” – “Eu não sei; não é esse o seu trabalho?”

“Eu não quero falar sobre isso.” [repetido várias vezes]

Felizmente, dentro do repertório estratégico e das posturas estilísticas do terapeuta DBT, há muitas opções para manter as coisas em movimento. Quando “travado” em um determinado ponto da cadeia, ou emperrado em obter a cooperação do paciente com o procedimento, o terapeuta pode alternar entre estratégias de validação e uma enorme quantidade de estratégias de mudança. Ele também pode alternar entre um estilo de comunicação irreverente e recíproco. Pode dar um passo atrás e gerar hipóteses e testá-las em voz alta com o paciente. Pode mover-se entre estratégias dialéticas, como metáfora, fazer dos limões uma limonada, estendendo e equilibrando diferentes estratégias de tratamento. Pode passar de um segmento da cadeia para outro; alternar avaliação cuidadosa com hipóteses, soluções e didática; alternar a visão da “imagem completa” da cadeia com os detalhes de determinados segmentos; e alternar entre validação das experiências do paciente e incentivo para a mudança comportamental. Com o tempo, percebo que quanto mais respeito tenho pela cadeia e por seus propósitos, mais clareza tenho sobre sua natureza evanescente e mutável. Quanto mais maneiras tenho

de manter meu equilíbrio e frescor, mais eficaz sou em manter o movimento, mudando, improvisando e, às vezes, apenas observando possíveis aberturas.

OUTRAS QUESTÕES TÉCNICAS AO CONSTRUIR A ANÁLISE EM CADEIA

Nesta seção final, consideramos dois aspectos técnicos na condução da análise em cadeia do comportamento: 1) o uso consciente da linguagem e do tom para aumentar o impacto do procedimento e 2) a seleção contínua de “onde trabalhar na cadeia”. Dado que a análise em cadeia do comportamento é uma avaliação que requer que o paciente recupere eventos detalhados de horas ou dias anteriores, o procedimento é geralmente aprimorado ao tentar trazer a memória à vida na sessão. Primeiro, será mais fácil lembrar detalhes relevantes ao relatar uma memória “quente” do que uma “fria”. Segundo, se soluções forem encontradas para elementos da cadeia durante o processo de revisão, essas soluções serão mais propensas a serem integradas na mente do paciente se a história lembrada estiver “viva” em vez de “morta”. Por fim, a lembrança viva e detalhada de uma memória durante a sessão cria a oportunidade de usar o processo como um procedimento de exposição, ajudando o paciente a se aproximar em vez de evitar, a lembrar em vez de esquecer. Apesar das vantagens de trazer a história à vida durante a análise em cadeia do comportamento, em outras ocasiões pode ser indicado revisar a história com menos intensidade, ajudando o paciente a revisar algo doloroso que aconteceu sem reacender completamente as emoções dolorosas.

Para dar vida à história, o terapeuta pode usar linguagem e tom que promovam a ativação do episódio. Ele pode usar o tempo presente mesmo ao discutir um episódio passado. “Agora você está na cozinha e ainda não considerou pegar a faca que usa para se cortar. No que você está pensando? Quais emoções está experimentando? Existem coisas que você pode fazer para lidar com seus sentimentos desesperados além de recorrer à faca para

se cortar?” Além disso, para aumentar a sensação de que essa “reencenação” está ocorrendo na presença do terapeuta como testemunha e apoiador, ele pode usar o pronome “nós” em vez de “você”: “Agora estamos na cozinha e você ainda não considerou pegar a faca que usou para se cortar. No que você está pensando? Quais emoções está experimentando? Vamos considerar o que você pode fazer para lidar com o seu desespero.” Esses sutis usos do tempo presente e do pronome “nós”, juntamente a um tom de voz que promove a sensação de que “isso está acontecendo agora”, podem aumentar a relevância e fortalecer os usos da cadeia.

Assim que o terapeuta começa uma análise em cadeia com o paciente, surgem perguntas sobre “onde trabalhar na cadeia”. Como mencionado, é provável que comecemos com uma explicação do comportamento-problema e, em seguida, passemos para o evento desencadeante. A partir daí, é provável que nos movamos “para trás” para considerar os fatores de vulnerabilidade, “para a frente” para considerar os elos na cadeia do evento desencadeante para o comportamento-problema ou “pulemos à frente” na cadeia para considerar as consequências reforçadoras do comportamento-problema. Embora essas orientações amplas sejam úteis, ainda restam muitas escolhas para o terapeuta. Ele deveria tentar obter uma “visão geral” da cadeia inteira, uma espécie de resumo do episódio comportamental, antes de se concentrar em certos segmentos para obter mais detalhes? Ou deveria simplesmente prosseguir elo por elo, entrando em detalhes sobre um segmento particular do episódio? Nesses casos, encontrar o equilíbrio certo entre a visão geral, a partir da qual o terapeuta pode tomar uma decisão informada sobre o segmento da cadeia mais imediatamente relevante a ser abordado, e o valor de gastar tempo finito obtendo os detalhes de um segmento específico é fundamental. Na maioria dos casos, tentar obter uma breve visão geral do que aconteceu antes de se concentrar em um

segmento específico. Essa abordagem ajuda a evitar a situação em que o terapeuta passa toda a sessão em um segmento da cadeia, apenas para descobrir no final que há outro segmento que contém comportamentos de alto risco.

Além de obter uma breve visão geral, como o terapeuta decide onde direcionar a atenção na cadeia durante a sessão? Ele pode se concentrar em qualquer lugar, desde o “início” da cadeia, abordando fatores de vulnerabilidade problemáticos ou o evento desencadeante, até o “final” da cadeia, abordando antecedentes próximos ao comportamento-problema ou consequências decorrentes do comportamento-problema. Eu opero com quatro diretrizes em mente, respectivamente relacionadas:

1. à iminência e à gravidade do comportamento-alvo;
2. ao nível de detalhe na memória do paciente;
3. à disposição do paciente em trabalhar em determinado segmento;
4. à minha hipótese sobre o que é funcionalmente mais relevante para o comportamento-problema.

Primeiro, considero a iminência e a gravidade do comportamento-alvo. Se o risco é alto e a repetição do comportamento parece iminente, provavelmente vou me concentrar no final da cadeia, avaliando os fatores que promovem comportamentos de alto risco e encontrando soluções para eles. “Estabilizar o final da cadeia” é consistente com a priorização dos comportamentos de maior risco antes de passar para outros. As intervenções comuns para lidar com problemas no final da cadeia são as habilidades de tolerância ao mal-estar e os procedimentos de manejo de contingências.

Segundo, se a iminência e a gravidade não exigirem priorizar o final da cadeia, o nível de detalhe da memória do paciente para algumas partes da cadeia pode influenciar a direção em que me concentro. Em outras palavras, posso começar avaliando uma área

em que há mais dados e depois passar para outras com menos dados. Em terceiro lugar, se o paciente estiver mais disposto a trabalhar em algumas partes da cadeia do que em outras, posso seguir essas preferências para melhorar nossa colaboração, desde que não violem a ordem de prioridades na lista de alvos.

Por fim, ao escolher onde trabalhar na cadeia, sou influenciado por minhas hipóteses atualizadas sobre quais elementos da cadeia estão mais relacionados funcionalmente ao comportamento-problema. Naturalmente, se eu estiver correto, abordar e mudar esses elos funcionalmente relacionados terá mais chances de impactar a mudança de comportamento. Em um caso, isso poderia me levar a me concentrar intensivamente nos fatores do ambiente que reforçam o comportamento-problema. Em outra instância, posso trabalhar na deficiência das habilidades de regulação emocional que promoveram a desregulação e levaram eventualmente ao comportamento-problema como uma “solução”. De qualquer forma, tento tomar essas decisões de maneira colaborativa, se possível, e ser transparente com o paciente sobre meu raciocínio.

SITUAÇÕES DESAFIADORAS NA ANÁLISE EM CADEIA DO COMPORTAMENTO

Os melhores planos podem falhar. Podemos aprender tudo sobre a análise em cadeia do comportamento, os fundamentos da TCC e os princípios dos paradigmas da aceitação e da dialética e ainda assim enfrentar dificuldades. Embora algumas dessas dificuldades possam estar relacionadas a comportamentos problemáticos do terapeuta, muitas estarão relacionadas a comportamentos desafiadores em alguns pacientes. A seguir, considero cinco dessas situações.

Em primeiro lugar, há o paciente que fornece poucos dados verbais com os quais trabalhar. Ele pode esquecer episódios inteiros ou detalhes significativos, dissociar-se durante a sessão ao ser perguntado sobre determinados segmentos, gerar respostas muito breves com pouca informação baseada em memória ou ficar completamente em silêncio por períodos prolongados. Para reiterar e expandir um comentário feito anteriormente neste capítulo, minha abordagem é geralmente pegar o que posso, analisar o que posso e avaliar e abordar os fatores que interferem no relato. Esse processo é diferente em cada caso, então não há uma fórmula geral. Se acho que há um bloqueio de memória em um paciente relativamente disposto, tentarei provocar mais memórias de um evento crucial, se puder, ou simplesmente trabalhar com a escassez de memórias que tenho. Posso pedir a ele que fabrique alguns detalhes prováveis do que foi esquecido, para que possamos praticar a análise em cadeia do comportamento, com a esperança de fortalecer a memória de sua experiência. Se acho que há um componente voluntário e não consigo determinar como aumentar a colaboração do paciente, tentarei nomear o comportamento voluntário que está impedindo e solicitar sua ajuda na avaliação. Em particular, estou interessado em quais emoções

estão envolvidas. O indivíduo medroso e ansioso pode evitar a discussão das emoções e se retrair nos detalhes cognitivos da história. O sujeito envergonhado e constrangido pode tentar esconder os detalhes humilhantes. O paciente zangado pode apresentar um bloqueio com um senso de desafio para manter o controle sobre a situação. Cada um requer uma abordagem diferente. Se tenho poucas pistas sobre como entender o bloqueio, incluindo o caso em que o paciente está completamente em silêncio, posso usar todas as abordagens em que conseguir pensar, observando se alguma delas elicia uma melhor resposta. Usar tentativa e erro às vezes é o meio mais produtivo de avaliar um bloqueio.

Alguns indivíduos apresentam um grau tão alto de sensibilidade e reatividade emocional durante a realização da análise em cadeia do comportamento que é quase impossível chamar sua atenção para detalhes, hipóteses e soluções. Nesses casos, geralmente abandono meu plano de fazer uma análise em cadeia do comportamento em detalhes, faço o que posso sem causar hipersensibilidade e uso estratégias durante a sessão para reduzir a sensibilidade emocional. Em geral, isso começa com minha validação das emoções do paciente de maneira precisa e eficaz – o que pode durar grande parte da sessão. Essas são oportunidades para incentivar, ensinar ou reforçar habilidades de regulação emocional, *mindfulness* e tolerância ao mal-estar.

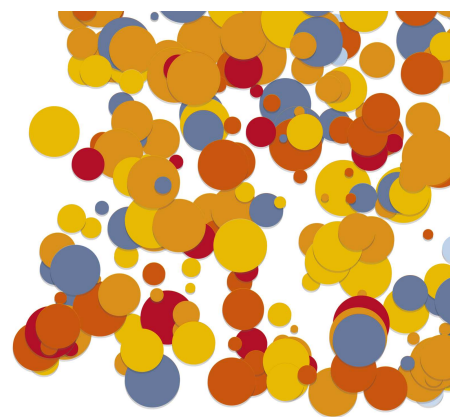
Em terceiro lugar, às vezes, o nível de distração de um paciente interfere profundamente em “obter a história” da cadeia. À medida que a atenção salta de um lugar para outro, ele não consegue elaborar com minúcia em nenhum elo, bloqueando assim qualquer chance de avaliar a cadeia em detalhes. Comumente, esse tipo de resposta do paciente exigirá atenção aos comportamentos que interferem na terapia de mudança de atenção, distração e impulsividade. Eles precisam ser nomeados e avaliados, com a meta de encontrar soluções. No tratamento de adolescentes e

alguns adultos, esses comportamentos podem ser um sintoma de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), então o terapeuta precisa aprender estratégias e habilidades para trabalhar com esses problemas.

Em quarto lugar, já trabalhei com muitas pessoas que parecem compelidas a fornecer um nível excessivo de detalhes para a análise em cadeia do comportamento, tornando quase impossível obter uma visão geral do problema. É difícil não ficar frustrado, e os esforços do terapeuta para avançar na história tendem a aumentar a ansiedade do paciente e piorar o problema. Nesse caso, muitas vezes recuo e avalio a tendência do paciente de fornecer um excesso de detalhes, menciono isso de forma direta como um fator que interfere em “obter uma visão geral” e vejo se é possível encontrar soluções. Com um de meus pacientes que se apresentava dessa forma e tinha diagnósticos de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno de acumulação, fizemos mais progresso quando pude chamar sua atenção para o problema e obter seu acordo em aceitar meu julgamento sobre a quantidade de detalhes necessários. Eu encontrei maneiras de reforçá-lo pela conformidade.

Por fim, todos os terapeutas DBT já trabalharam com pessoas para as quais a imposição de uma estrutura ou procedimento como a análise em cadeia do comportamento desencadeia intensas respostas emocionais resultando em raiva, desafio e obstinação. Tais pacientes podem julgar o terapeuta como intrusivo, insistente, simplista ou insensível, e eles podem sentir que estão sendo “atingidos” ou “punidos” com uma análise em cadeia do comportamento. Eles podem “querer apenas conversar”, não serem forçados a uma exposição estruturada. Novamente, esse tipo de comportamento requer uma avaliação dos fatores individuais envolvidos; não há uma fórmula. A regra geral é identificar e especificar não pejorativamente o fator que interfere no procedimento de análise em cadeia e tentar resolvê-lo. Às vezes, o

terapeuta amplia ou desencadeia o problema ao prosseguir de maneira rígida. A essência de uma análise em cadeia do comportamento é algo muito natural e conversacional, familiar para a maioria das pessoas, semelhante à forma que são abordadas por seu médico ou seu mecânico. Basta obter a história. Não é necessário usar o termo análise em cadeia do comportamento, ou qualquer sinônimo, ou agir como se houvesse algo especial ou diferente nesta parte da sessão. Pode-se simplesmente começar dizendo: “O que aconteceu?”. Depois algo como: “Como isso aconteceu?” ou “Conte-me sobre isso”. Como terapeutas DBT fazendo análise em cadeia do comportamento, podemos simplesmente tentar aprender sobre a história, e nos bastidores podemos enquadrar ou estruturar a história na forma de uma cadeia do comportamento. E há muitas vantagens em fazê-lo!



Validação

Você está passeando com uma criança de 3 anos. Vocês têm um destino. Ao notar um besouro no chão, a criança para. Ela se agacha e fica completamente focada no inseto. Pega um pedaço de graveto que encontra na terra e, o mais gentilmente que pode, toca o besouro com ele, observa o que o inseto faz e o empurra. Você também para e se agacha silenciosamente. Se não fosse pela criança, você nunca teria notado esse besouro. Você observa tudo sobre o besouro, o que a criança faz e como o inseto responde. Você percebe que a criança está imersa na “realidade do besouro” e permite-se estar lá também. É um momento maravilhoso. Você esqueceu tudo no mundo, incluindo a direção em que estava andando com ela, e, momentaneamente, o destino. Você está completamente presente, com a criança, com o besouro, no momento.

Ao fazer isso, você abraça e apoia a existência da criança, seu ritmo, sua curiosidade e seu fascínio. Ela importa, o que ela faz importa, e você transmite, sem nenhuma palavra, que o que ela faz, faz sentido. Você engrandece a criança, apoia implicitamente seus instintos e escolhas e reforça seu interesse pelo mundo.

A validação na psicoterapia tem essa qualidade. Ela pede que você pare e esteja com seu paciente no momento, vendo o que ele vê, ouvindo o que ele ouve, parando ao longo do caminho, deixando de lado por completo a agenda orientada para a mudança por enquanto. Essa presença aprimora seu paciente. Sua agenda, seu interesse, seu ritmo são abraçados e apoiados. Ele se

sente conectado, substancial e significativo. Ele foi reconhecido, apreciado e confirmado. Mesmo antes de uma palavra ser dita, isso é validação. Quando a validação toma forma verbal, o mesmo espírito flui para as palavras.

Definir a validação é um pouco como definir a respiração. Por um lado, já sabemos o que é. Temos familiaridade com o termo e o conceito, e praticamos a validação o tempo todo. “Não é de se surpreender que você esteja chateado depois do que ele te disse” – o indivíduo se sente compreendido. “Faz todo sentido que você desconfie desse cara; ele tem agido de forma imprevisível” – o indivíduo sente que você entende. “Você mostra muita coragem indo à festa sem um par” – o indivíduo se sente reconhecido, confirmado, valorizado. Apenas ouvir, olhar, estar lá com alguém é uma forma de validação. Todos esses são momentos de validação e fortalecem a conexão entre duas pessoas. Não precisamos saber que a validação tem certas características, complexidade e limites até que ela nos falhe. Isso frequentemente acontece quando estamos tratando uma pessoa com alto grau de sensibilidade e reatividade emocional, uma longa história em um ambiente majoritariamente invalidante e, portanto, uma forte tendência à autonegação. Tentamos validar; não funciona. Não conseguimos fazer o tipo de conexão ao qual estamos acostumados. Essas circunstâncias, comuns na terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*), exigem que desenvolvamos uma compreensão mais profunda, precisa e variada do que queremos dizer com validação, especialmente porque a validação desempenha um papel crucial no tratamento.

Linehan (1997) propôs as características definidoras e os requisitos técnicos da validação (o que, por que, se, quando e como validar) em seu artigo sobre o tema. Começo este capítulo revisitando muitos dos pontos relevantes desse artigo e ilustrando-os com exemplos clínicos antes de discutir como os princípios dos

paradigmas de mudança, aceitação e dialética podem expandir nossas capacidades de validação. Eu abordo os seguintes tópicos:

- As funções da validação na DBT
- O que é validação?
- Válido *versus* inválido
- Quais são os alvos da validação?
- Quando validamos (e quando não validamos)?
- Quais são os seis níveis de validação?
- Como os paradigmas de mudança, aceitação e dialética expandem nossas aplicações de validação?

AS FUNÇÕES DA VALIDAÇÃO NA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA

Durante o desenvolvimento da DBT, a validação foi adicionada ao núcleo cognitivo-comportamental do tratamento para equilibrar o impacto desregulador de buscar mudanças. Como Linehan expressou em seus primeiros *workshops* e seminários na década de 1990, a validação forneceu a “cobertura de açúcar” que ajudou o “remédio amargo” das estratégias cognitivo-comportamentais a ser ingerido, ou é “o óleo para lubrificar a máquina de solução de problemas”. Portanto, a primeira função da validação foi ajudar o paciente a manter ou recuperar o equilíbrio emocional durante a solução de problemas. Desde então, a validação provou ter várias outras funções na DBT. Ela fortalece o progresso clínico, funcionando como reforço para a melhoria, intensifica o relacionamento terapêutico e é um dos fatores que mantém o paciente em terapia. Essa função foi observada em um ensaio clínico randomizado controlado, no qual a DBT padrão foi comparada a um tratamento de controle especialmente projetado, a terapia comportamental abrangente (TCA), consistindo apenas nas estratégias de validação da DBT (Linehan et al., 2002). A TCA teve sucesso razoável na redução de sintomas, mas seu impacto mais notável foi observado na taxa de abandono do tratamento de 0%.

Como se poderia esperar da teoria biossocial da DBT, na qual a invalidação desempenha um papel central, a validação ajuda a reduzir a autoinvalidação, aumentando a capacidade de autovalidação. Dado que as estratégias de validação são consideradas o grupo de estratégias mais orientado para a aceitação, é interessante que a validação desempenhe um papel na mudança das respostas emocionais. Um evento desencadeante emocionalmente importante costuma provocar uma resposta

emocional primária aversiva, como a crítica provoca vergonha. Para o indivíduo com transtorno da personalidade *borderline* (TPB), a vergonha pode ser intolerável e desencadeará uma resposta emocional secundária, como raiva ou tristeza, ou uma resposta comportamental disfuncional, como autolesão ou uso de substâncias. Se o terapeuta puder identificar e validar a resposta emocional primária (neste caso, a vergonha) e, ao fazê-lo, puder ajudar o paciente a permanecer em contato com essa emoção, ele começa a aprender novas maneiras de modular a emoção dolorosa. Nesse aspecto, a validação serve como um passo em um procedimento de exposição, uma das quatro estratégias de mudança na DBT.

Quando eu estava ministrando um *workshop* com Marsha Linehan, um participante fez uma pergunta intrigante. “Marsha, se você e apenas mais uma pessoa sobrevivessem a um naufrágio e acabassem em uma pequena ilha remota, sem probabilidade de serem resgatados por muitos anos, e essa pessoa tivesse diagnóstico de TPB, e você só pudesse levar uma estratégia de DBT para usar naquela ilha, qual seria?” Marsha gostou da pergunta, dizendo: “Então você quer saber qual é a aspirina da DBT”. Rapidamente ela respondeu: “Validação. A validação ajudaria nosso relacionamento, que pode ser a parte mais importante. Isso ajudaria meu companheiro de ilha a regular suas emoções e poderia até torná-lo um solucionador de problemas melhor sem ensinar a ele qualquer estratégia de solução de problemas. Às vezes podemos ficar bastante confusos e, se apenas recebermos validação, descobrimos o que fazer”. Validação: a aspirina da DBT!

O QUE É VALIDAÇÃO?

Validação é o ato de substantivar, confirmar ou sancionar o que é. Considere como usamos o termo fora da psicoterapia. *Validamos* resultados de pesquisa, passaportes, resultados eleitorais, argumentos e provas lógicas. Existem três etapas envolvidas na validação. Primeiro, temos que “entender”: devemos reconhecer e entender o fenômeno sendo validado – os resultados da pesquisa, o passaporte, os resultados eleitorais, o argumento ou a prova formal. Em segundo lugar, verificamos a validade: esses resultados de pesquisa, esse passaporte, esses resultados eleitorais, esse argumento ou prova atendem a algum tipo de padrão? Eles fazem sentido em algum contexto, usando algum método de raciocínio? Estamos tentando não apenas reconhecer e entender, mas também certificar que o fenômeno tem algum tipo de “valor de verdade”. Na verdade, apenas a segunda etapa é validação, mas a primeira etapa é um pré-requisito. A terceira etapa envolve comunicar a validade dos resultados da pesquisa, certificar ou carimbar o passaporte, e assim por diante. *Validação* é um verbo transitivo. Validamos *algo*.

Passo 1: reconhecendo e entendendo um comportamento

O primeiro passo, reconhecer ou entender o fenômeno, é sinônimo de empatizar em nosso contexto clínico. Empatizar é reconhecer e entender o predicamento, a experiência e o comportamento de alguém, ser capaz de “se colocar no lugar do outro”. Podemos empatizar com a experiência de alguém sem tentar localizar o “valor de verdade” em sua experiência ou comportamento. A empatia é um pré-requisito para validar, e muitas falhas em validar derivam de uma falha em empatizar. Se eu não tenho ideia do que

é a *decepção* – se não sei qual é a sensação –, meus esforços para validar a decepção de alguém seriam insuficientes e soariam falsos (a menos que eu reconhecesse minha falta de familiaridade no processo). Como veremos em breve, existem certas circunstâncias clínicas em que podemos empatizar, mas podemos escolher parar antes do segundo passo e identificar o “valor de verdade” de um comportamento.

A validade de um comportamento já está presente (ou não) antes de validá-lo. Validamos o que já é válido. Simplesmente confirmamos sua validade; não criamos validade ao validar. Esse ponto pode parecer óbvio, mas alguns terapeutas parecem ser impulsionados por um mandato para validar, mesmo que ainda não saibam o que validar. Reconhecemos e entendemos um pensamento, uma ação, uma emoção, talvez uma capacidade (ou seja, empatizamos) e então podemos optar por validar esse fenômeno. Na DBT, não há valor absoluto atribuído à validação; ela é usada para certos propósitos, mencionados anteriormente, sendo a meta final vencer os alvos do tratamento que levam a uma vida que vale a pena ser vivida. Às vezes, reconhecemos e entendemos um comportamento e estrategicamente retivemos a validação. Eu estava consultando com uma terapeuta experiente em DBT sobre seu tratamento de uma pessoa sensível e reativa que muitas vezes se sentia prejudicada na vida. A terapeuta explicou que sua paciente estava infeliz com sua melhor amiga. A terapeuta queria validá-la e pensava que deveria fazer isso, mas algo estava interferindo, e me perguntou se eu poderia ajudá-la a descobrir como.

Eu perguntei se ela poderia fazer um *role-play* na terapia comigo, em que ela interpretaria a paciente e eu interpretaria a terapeuta. Eu tentaria validar a paciente. Interpretando a paciente, ela começou a reclamar comigo. “Minha melhor amiga não está retornando minhas ligações ou mensagens. Ela está me ignorando. Isso machuca meus sentimentos. Estou tão brava com ela!” Eu

perguntei: “Você sabe por que ela não está retornando suas ligações?”. Ela respondeu: “Só porque o marido dela está morrendo de câncer, nos últimos dias ou semanas de vida, isso não é motivo para me ignorar. Eu também preciso de atenção!”. “Ah”, pensei comigo mesmo, “agora entendi por que é difícil validar a paciente”. Embora sua decepção fosse reconhecível e compreensível, e eu sentisse vontade de confortá-la, sua resposta na verdade estava equivocada. Validar sua decepção com a amiga naquele momento também teria validado sua crença de que a amiga deveria atender a ela, mesmo que o marido estivesse morrendo. Minha resposta instintiva no *role-play* foi irreverente, não validadora; orientada para a mudança em vez de orientada para a aceitação. Continuando o *role-play*, eu disse: “Se você acha que precisa da atenção da sua amiga tanto quanto o marido dela, talvez deva dizer a ela que você também está morrendo”.

“Por que eu faria isso?”

“Talvez sua amiga preste mais atenção em pessoas que estão morrendo.” Ainda interpretando a paciente, a terapeuta ficou confusa por um momento, mas depois disse: “Mas ela *deveria* estar chateada com isso – ele é marido dela há 25 anos! Acho que posso estar esperando demais dela, ou talvez meu *timing* esteja ruim”. Isso eu poderia validar: “Entendo o que você quer dizer, isso faz todo sentido”. E então eu poderia validar sua resposta inicial, sua decepção: “Você está certa, mas também consigo entender por que ficaria decepcionada”.

Passo 2: determinar o “valor de verdade” do comportamento

Linehan (1997) propõe três contextos nos quais determinamos a validade de um comportamento e cinco métodos de raciocínio para fazê-lo. Embora essa lista possa não ser completa, ela oferece um tipo de guia para determinar a validade, e, dentro desse guia,

diferentes pessoas podem encontrar formas distintas de validar o mesmo comportamento em um indivíduo específico. Isso faz parte do que Linehan chama de “encontrar uma pepita de ouro em um balde de areia”, referindo-se às frequentes situações na DBT em que não é tão óbvio o que é válido em um determinado comportamento. Os três contextos são perspectivas de tempo: passado, futuro e presente. Esse comportamento (nesse caso, a decepção do paciente) é válido em relação ao seu passado? Sua resposta emocional é válida em relação ao seu futuro, seus “fins em vista”? É válida em relação ao contexto atual? Os cinco métodos de raciocínio envolvem diferentes tipos de lógica: esse comportamento é válido em relação a alguma autoridade aceita ou em relação a um consenso significativo? É válido com base no raciocínio indutivo (empírico) ou no raciocínio dedutivo? Mais exclusivo para a DBT, esse comportamento é válido com base no raciocínio da “mente sábia”? Mais tarde, na seção sobre dialética na validação, consideramos as situações complicadas em que um comportamento é válido em um contexto, mas não em outro, ou com base em um tipo de raciocínio, mas não em outro.

Validação com relação ao passado

Consideramos um comportamento válido se pudermos entender que ele está alinhado com a história de aprendizado ou constituição biológica única do indivíduo. Quando estou diante de uma plateia em um palco, experimento medo automática e instantaneamente e me afasto da beirada do palco. Esse comportamento não é válido no contexto atual; não há nada a temer. Mas se você conhece minha história de aprendizado ao estar em palcos, o medo instintivo e o afastamento da beirada são facilmente compreendidos. No ensino médio, há 48 anos, eu estava interpretando um papel principal em uma peça de Shakespeare em minha escola (era o Duque de Orsino em *Noite*

de reis), e estava usando uma barba falsa e uma túnica roxa excessivamente longa. Com meus amigos sentados na primeira fila, tendo se comprometido a me distraírem de maneira lúdica durante a apresentação, e no meio de um famoso solilóquio (“Se a música é o alimento do amor, não parem de tocar...”), eu pisei na túnica, meu joelho cedeu, caí no chão e depois do palco! Eu me levantei, voltei ao palco e terminei minha apresentação. Me recuperei no sentido de completar o trabalho, mas meu cérebro mudou para sempre. Eu tinha sido assustado, ferido e humilhado, e meu atual “medo de palco” é válido com relação à minha história de aprendizado em uma única tentativa.

Minha paciente, que havia sido estuprada por um amigo no ano anterior e cujo transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) havia piorado, estava usando várias fechaduras para proteger seu apartamento, mesmo que o agressor morasse longe e não desse sinais de que retornaria, e que a cidade em que morava fosse pequena e relativamente segura. Suas ações não eram válidas no contexto atual, mas eram claramente válidas com relação ao seu passado. Ela estava envergonhada de estar tomando medidas tão extremas; reconhecia que não estavam alinhadas com a realidade atual. Mas sua vergonha diminuiu quando eu me solidarizei com sua posição e validei seus comportamentos com relação ao passado. Eu pude comunicar honestamente que muitas pessoas tomariam as mesmas medidas se tivessem a mesma história e se tivessem desenvolvido TEPT.

Comportamentos válidos com relação ao passado frequentemente serão válidos com relação aos contextos atuais e futuros também. Na primeira sessão de um novo grupo de treinamento de habilidades, uma jovem chegou usando óculos escuros e um casaco pesado e, quando se sentou, virou a cadeira para a parede. Ela não falou com ninguém e não respondeu às minhas perguntas ou comentários. Embora eu tenha achado seu comportamento estranho, não interferiu em minha capacidade de

ensinar e na dos pacientes de aprender, então não fiz esforço para desafiá-la. Depois de algumas semanas, ela mudou: tirou os óculos escuros, virou sua cadeira em direção aos outros membros do grupo e começou a participar verbalmente. Ela parecia ter aprendido todas as habilidades que havíamos abordado. Conforme eu aprendia mais sobre ela, tornou-se fácil reconhecer a validade de seu comportamento com base no passado: ela tinha um transtorno de ansiedade social e tinha sido dolorosamente excluída muitas vezes em sua vida. Ela estava tentando evitar essa experiência. Mas seu comportamento era interessantemente válido no contexto atual, porque “funcionava”; seu comportamento peculiar permitiu que ela funcionasse no presente e alcançasse seu objetivo de aprender habilidades. E também era válido em relação ao seu futuro, no qual ela imaginava aprender mais habilidades que a permitiriam participar da vida. Este é um bom exemplo de que mesmo que um comportamento seja estranho e não convencional, desencadeando desaprovação e discordância, e não se preste rapidamente e facilmente à empatia ou à validação, pode ser válido em todos os aspectos.

Validação com relação ao futuro

Consideramos um comportamento válido com relação ao futuro se estiver alinhado e fizer sentido em relação à visão que o indivíduo tem do futuro, seus fins em vista. Uma colega minha estava insatisfeita com a escola frequentada por seus três filhos, com idade entre 6, 8 e 10 anos. Ela tentou melhorar as coisas na escola e com os professores, mas permaneceu insatisfeita; ainda assim, não queria tirar as crianças da escola, e a educação em casa significava perder valiosas oportunidades sociais, além de complicar a rotina do lar e ir contra o coro de opiniões de professores e conselheiros escolares. No entanto, sua decisão e de seu marido de retirar os filhos da escola e optar pelo ensino em

casa estava alinhada com a visão que tinham para o desenvolvimento educacional das crianças no futuro. Apesar de controversa para muitos, disfuncional do ponto de vista da escola e não alinhada com a própria história de sucesso escolar, essa escolha foi considerada válida em relação aos fins em vista da família.

Há alguns anos, eu avalei um homem de 23 anos cuja vida havia tomado um rumo trágico um ano antes, depois de ter ficado tetraplégico em razão de um acidente. Ele entrou no meu consultório em sua cadeira de rodas e, quando começamos, estava enfurecido, deprimido e suicida. Ele não aceitava uma vida com limitações físicas tão severas e se recusava a participar de vários programas vocacionais para pessoas com deficiência. Sua família e seus amigos ficavam frustrados com sua recusa, a qual atribuíam à raiva pelo que havia acontecido com ele e que nunca mudaria. Seu comportamento parecia inválido para eles, e de fato suas respostas o invalidavam. O que eles não estavam notando era que sua recusa movida pela raiva, naquele ponto no tempo, não era baseada no passado. Era baseada em uma imagem futura dele caminhando. Ele não conseguia entender como uma sociedade que poderia levar humanos à lua e além não poderia construir uma cadeira de rodas melhor. Conforme ele explicava sua visão para mim, isso fazia completo sentido. Sua imagem do futuro era compreensível, era válida; e sua raiva subsequente em relação ao mundo era compreensível. Ele e eu fomos para a internet investigar o estado atual da tecnologia de cadeira de rodas biorrobótica. Nos comunicamos com um professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e outro em Oxford, no Reino Unido, cada um dos quais havia trabalhado em projetos exatamente como os que ele imaginava. Mesmo que a tecnologia ainda não estivesse disponível, a validação do seu ponto de vista (sua raiva baseada em seus fins em vista) o encorajou, aliviou sua raiva e permitiu que seguisse em frente.

Validação com relação ao presente

De enorme importância clínica é o fato de que comportamentos podem ser válidos com relação ao contexto atual. Nesse sentido, os comportamentos são normativos e funcionais. É uma alta prioridade na DBT, com indivíduos cujas histórias de invalidação resultaram em sua própria convicção de que eles não são normais e não são funcionais, validar seu comportamento no contexto atual: “Você é realmente capaz de comportamento válido e normativo no presente”. Os terapeutas treinados para avaliar a adesão à DBT em sessões individuais de terapia “exigem” pelo menos uma instância por sessão em que o terapeuta valida o paciente com relação ao contexto atual (como veremos adiante, isso é conhecido como uma *validação de nível 5*).

Mas isso pode ser complexo. Como decidimos se um comportamento é válido no contexto atual? Por exemplo, é válido alguém soltar gases deliberadamente e com sons altos durante um serviço religioso altamente controlado e solene? Depende. Quando um paciente abandona uma reunião de grupo com raiva em um ambiente terapêutico, é um comportamento válido nesse contexto? Depende. Se um adolescente fuma maconha todos os dias antes e depois de ir à escola, é um comportamento válido nesse contexto? Depende. Precisamos de mais informações em cada um desses casos. E isso nos leva aos cinco diferentes métodos de raciocínio pelos quais determinamos a validade. Estes são de particular valor ao considerar a validade no contexto atual. O comportamento pode ser considerado válido com relação a:

1. *Autoridade aceita*: o comportamento está alinhado com a autoridade aceita?
2. *Consenso*: o comportamento é algo que os outros fariam nesse contexto (todos ou um subgrupo relevante)?
3. *Raciocínio empírico*: o comportamento é válido por meio de raciocínio empírico ou indutivo, baseado em um número de

tentativas passadas?

4. *Raciocínio dedutivo*: o comportamento é válido por meio de lógica ou raciocínio dedutivo?
5. *Mente sábia*: particular à DBT, o comportamento é válido porque está alinhado com a mente sábia do indivíduo, mesmo que não esteja alinhado com nenhum dos critérios anteriores?

Raciocínio com respeito à autoridade aceita e raciocínio com respeito ao consenso. Embora um episódio de comportamento suicida possa ser condenável e perturbador, também pode ser válido no contexto atual, pois pode estar alinhado com mandatos ou valores mantidos e perpetrados por certas *autoridades aceitas* radicais. Em um exemplo clínico, um paciente pode parar todos os medicamentos psiquiátricos, mesmo diante do sucesso aparente. Essa escolha pode não parecer válida, já que a maioria das pessoas na comunidade de tratamento pode desaprová-la. Com relação ao raciocínio empírico, pode parecer uma escolha inválida, já que tentativas anteriores de interromper medicamentos levaram a recaídas sintomáticas e hospitalizações. Pode não parecer lógico, uma vez que o argumento predominantemente aceito clinicamente é que os medicamentos psiquiátricos corrigem desequilíbrios químicos e permitem um funcionamento mais elevado. No entanto, quando descobrimos que o paciente é dedicado à irmandade e aos ensinamentos dentro de uma determinada reunião dos Alcoólicos Anônimos (AA) que se opõe fortemente ao uso de medicamentos psiquiátricos, percebemos que o comportamento é válido no contexto atual com base na *autoridade aceita* dentro do AA e com base no *consenso do subgrupo* de pessoas nessa reunião do AA. Mesmo que gostaríamos que o paciente tomasse os medicamentos por razões clínicas comprovadas, somos sábios em começar reconhecendo a validade da sua posição.

Quando dirigia uma unidade de internação em DBT em um grande hospital psiquiátrico, era rigoroso em esperar que as reuniões começassem no horário. Atrasos rotineiros da minha equipe de terapia para algumas reuniões na unidade me pareciam comportamento inválido, não alinhado com minhas expectativas, com o que seria mais funcional do ponto de vista empírico e com o consenso entre o restante da equipe. Quando perguntei mais sobre seus atrasos, descobri que eles estavam acostumados a chegar atrasados em reuniões hospitalares gerais para terapeutas, para as quais a principal autoridade clínica no hospital nunca chegava no horário. Para mim, o “contexto atual” era a minha reunião de equipe em minha unidade de internação. Para os terapeutas, seu “contexto atual” incluía a conduta de reuniões em todo o hospital. Uma vez que pude ver sua situação e validar seu comportamento com base na *autoridade aceita* dentro do hospital e no *consenso de seu grupo de pares* no hospital em geral, então pude explicitamente solicitar que eles se juntassem a mim para estabelecer uma cultura de pontualidade no nosso programa. Tendo se sentido compreendidos, eles estavam muito dispostos a se juntarem a mim.

Raciocínio empírico. Ao trabalhar com indivíduos com dependências, podemos falhar em ver a validade da mentira, mesmo que ela não seja incomum nessa população. Tendemos a invalidar a mentira. Desaprovamos, podemos nos sentir traídos, e isso certamente interfere no tratamento. Mas assim que olhamos objetivamente, podemos ver a *validade empírica* do comportamento. Por meio de tentativa e erro, o paciente aprendeu que as consequências negativas de dizer a verdade sobre o uso de substâncias, em ambos os contextos de tratamento e pessoal, são mais profundas do que as consequências negativas de mentir.

Raciocínio dedutivo. Uma vez eu assisti Marsha Linehan entrevistando uma mulher com comportamento suicida que visitava o túmulo de sua mãe, cortava os pulsos e sangrava sobre o túmulo. Estávamos perturbados pelo comportamento dela. Não conseguíamos ver a validade disso a princípio. Não parecia ser válido com relação a nenhuma *autoridade aceita*. Certamente não haveria *consenso*, pois os outros não faziam isso. Não conseguíamos ver como *empiricamente válido*, como sendo baseado em sua aprendizagem de tentativas anteriores desse comportamento. Mas com mais investigação, chegamos a ver a lógica *dedutiva* subjacente. Aprendemos que ela sentia muito a falta da mãe e que a ideia de poder misturar seu sangue com o corpo da mãe lhe trazia uma sensação de conforto. A lógica era estranha, mas era lógica mesmo assim. Uma vez que a validamos com relação a essa forma de pensar, ela se abriu mais sobre suas intenções suicidas. Além do conceito de que estava misturando seu sangue com o da mãe, ela tinha a convicção “lógica” de que poderia estar unida com a mãe na morte, deitadas lado a lado, próximas uma da outra. Quanto mais podíamos ver a validade do seu pensamento, mais efetivamente podíamos nos aliar a ela e começar a desafiar sua lógica.

Raciocínio da mente sábia. Consideramos exemplos de comportamento válido com base em autoridade aceita, consenso, raciocínio empírico e lógica dedutiva. Por fim, comportamentos no contexto atual, mesmo aqueles que parecem inválidos pela maioria dos métodos de raciocínio, podem ser válidos por estarem alinhados com a *mente sábia* do indivíduo, ensinada como peça principal do módulo de habilidades centrais de *mindfulness* da DBT. O comportamento é válido porque representa uma interseção criativa e integrativa entre o pensamento emocional e o racional, a intuição e o que simplesmente parece “certo” para essa pessoa. Não faz muito tempo, estava tratando uma mulher de 35 anos que

estava se saindo razoavelmente bem em sua vida até que um evento trágico interrompeu seu relacionamento com a mulher que amava e com quem queria passar a vida. Ela se esforçou muito para manter seu funcionamento e entender e lamentar sua perda, mas a tristeza a dominou e desencadeou um episódio depressivo grave com características psicóticas, uma série de hospitalizações que a traumatizaram ainda mais e uma crescente convicção de desesperança em relação ao seu futuro. Ela era incapaz de trabalhar e de socializar, estava agitada quase o tempo todo, e os medicamentos psiquiátricos ajudavam apenas por reduzirem a intensidade de seus sintomas psicóticos. Ela queria desesperadamente morrer.

Ela veio para uma sessão depois que eu tinha estado fora por uma semana. Estava sorrindo e parecia relaxada pela primeira vez em meses. Contou que havia decidido voltar para onde sua vida havia sido interrompida três anos antes, que havia encontrado um apartamento, que havia sido contratada para o emprego que costumava ter e que estava pronta para começar a vida novamente. Eu fiquei chocado com essa reviravolta incrível, senti uma sensação de descrença sobre um plano tão repentino e audacioso e só conseguia imaginar um resultado terrível após um breve surto de otimismo. Sua família e amigos tentaram dissuadi-la, pensando que era “uma fuga para a saúde”. Mas rapidamente aprendi que sua determinação era sólida e que ela se mudaria em uma semana. Ela concordou em fazer um acompanhamento comigo, viajando uma certa distância para me ver a cada duas semanas.

Sua escolha parecia ser inválida em vários aspectos: com relação à autoridade aceita (principalmente eu naquele momento); com relação ao raciocínio empírico (não havia evidências em três anos de que ela poderia simplesmente “se forçar” a melhorar funcionalmente); com relação ao consenso (nem ela, nem eu sabíamos de algum grupo de indivíduos em sua condição que teria

chance de sucesso nesse cenário); e com relação à lógica dedutiva, era um exagero (“se nada mais está funcionando, por que não voltar ao lugar onde as coisas deram errado?”). Mas ela me disse que sabia, em sua mente sábia, que era a coisa certa a fazer. Ela sentia que “tinha que fazer isso”, que via um “raio de sol” surgindo pela primeira vez em muito tempo, que sabia que seria difícil, mas que se sentia “centrada”. Embora eu não estivesse convencido sobre o seu raciocínio já que ela acabara de sair de um episódio de pensamento psicótico (como poderia distinguir o pensamento da mente sábia do pensamento psicótico?), ela estava determinada a fazer mesmo assim. Como se constatou, foi um passo enorme e positivo para ela, e, embora não tenha conseguido manter a vida que havia retomado, marcou o ponto de virada em seu curso e o início de uma tendência ascendente de vários anos que levou eventualmente a um resultado maravilhoso. Seu comportamento, como penso agora, foi *válido em relação à mente sábia*.

Passo 3: comunicando a validade de um comportamento

Tendo reconhecido e compreendido um comportamento, levando à empatia com a pessoa e tendo determinado o valor de verdade de um comportamento, o passo final na validação é comunicar isso ao indivíduo. Isso pode acontecer de forma não verbal ou verbal, em ação ou em fala. Não importa a forma, o terapeuta basicamente comunica que entende a natureza essencial do problema e os motivos do comportamento em questão. O sucesso da comunicação dependerá não apenas de ter “acertado”, mas também de entender como falar na “linguagem” daquela pessoa. Isso pode exigir uma fala suave, até mesmo silêncio, mas com uma expressão facial específica. Pode exigir uma comunicação muito direta, quase irreverente, para algumas pessoas

experimentarem a validação. Pode exigir desacelerar ou acelerar a fala. Pode até ser difícil validar algumas pessoas a menos que seja falado em sua linguagem.

É inútil ser “preciso” na determinação da validade se a comunicação não é “recebida” pelo paciente. Eu estava tratando uma adolescente que me disse ter ficado chateada depois de falar com sua mãe ao telefone. Pensando que entendia e pretendendo validar, eu disse: “Então você ficou chateada depois de falar com sua mãe”. Com firmeza, ela disse “NÃO!”. Eu não entendi. Ela disse: “Você não entendeu – não foi isso o que eu disse!”. Pedi desculpas e perguntei se ela poderia me contar novamente o que havia acontecido. “Falei com minha mãe ao telefone, e ela disse algumas coisas estúpidas que me deixaram com raiva.” Eu disse: “Então sua mãe disse algumas coisas estúpidas que deixaram você com raiva”. Ela retrucou: “NÃO!”.

Do meu ponto de vista, eu estava apenas tentando entender a fonte de sua raiva e, em seguida, ver se podia compreender a validade de sua reação. Do ponto de vista dela, eu estava completamente perdido. Eu não entendi; não parecia tão complicado (como eu estava errado!). Seu “receptor de validação” me parecia impossivelmente pequeno. Mudei de direção: “Então acho que não estou entendendo você muito bem”. Ela pareceu aliviada: “Sim, você entendeu isso!”. Ela se sentiu validada. Foi necessário um trabalho extra para encontrar uma maneira de validar sua experiência e, na verdade, isso fez a diferença e permitiu que fizéssemos algum trabalho de solução de problemas. Quando validamos, temos que considerar a idade do paciente, seu estilo cognitivo, cultura ou subcultura, vocabulário e particularidades de ritmo e tom. Mais importante ainda, precisamos notar se nossa tentativa de validação foi recebida. Às vezes, precisamos retornar várias vezes, mantendo o esforço de validação.

Finalmente, no fundamento de qualquer “tipo” de validação está o conceito mais profundo: *validação funcional*. Nós apreciamos precisamente a situação do paciente e agimos de acordo. Às vezes, isso envolve validação verbal, como é o caso dos exemplos mencionados. Mas, em outros momentos, validamos por meio de nossas ações. Em vez de comentar sobre as lágrimas de alguém, podemos simplesmente oferecer um lenço. Em vez de simpatizar com a situação de um colega que está sobrecarregado, nos oferecemos para fazer algumas ligações em seu lugar. Em vez de validar verbalmente a sede extrema de nossos filhos durante uma longa e quente viagem de carro sem nenhuma parada próxima, os envolvemos em um jogo que os distraia. Quando entendemos que a validação funcional significa que nossas ações refletem e comunicam uma compreensão da validade do comportamento do indivíduo no contexto da situação, percebemos que toda validação é funcional – às vezes validamos com palavras, outras vezes com ações.

Em geral, as três etapas da validação ocorrem em questão de segundos, sem tempo para reflexão deliberada. Em outras ocasiões, podemos ficar presos em uma ou mais etapas e a validação pode exigir mais trabalho e mais tempo. Podemos não reconhecer ou compreender o que o paciente está comunicando; podemos não ser capazes de nos colocar no lugar da outra pessoa; podemos não ser capazes de ver a sabedoria ou o valor de verdade do comportamento; e/ou podemos ser ineficazes em comunicar nossa compreensão. Se tivermos dificuldade em validar um paciente por um comportamento específico, podemos dividi-lo em três etapas para avaliar a falha na validação.

Nosso entendimento da validação é aprimorado ao entendermos o que a validação *não é*. A validação não necessariamente significa concordância. Validar alguém por algo está separado das próprias atitudes, percepções ou preferências pessoais. Podemos indicar nossa concordância com algo que o

paciente disse, mas isso não é o mesmo que validação. A distinção entre concordância e validação pode ser perdida no calor do momento. Podemos tentar validar um paciente (“É compreensível que você se sentiu atacado por ele”), mas ele se sente invalidado porque na verdade quer nossa concordância (“Eu concordo, você foi atacado por ele”). Às vezes, o terapeuta confunde os dois, pensando que, para validar o comportamento de alguém, deve concordar com ele.

O paciente pode se sentir muito sozinho em sua versão da história, na percepção de indivíduos ou eventos ou no plano de ação pretendido. Podemos ser capazes de validar sua versão, sua percepção ou seu plano – isto é, ver a sabedoria ou a validade à luz de seus contextos passados, presentes ou futuros. Mas se ele não puder obter nossa concordância pessoal com sua versão ou seu plano, ele permanece em sofrimento. Podemos sentir pressão do paciente para concordar com sua versão dos eventos, mas é importante manter a distinção. Alguns terapeutas caem na armadilha de agir como se a solução para o sofrimento dos pacientes fosse concordar com eles; embora fazê-lo possa trazer alívio imediato aos pacientes, também pode reforçar uma dependência não saudável da disposição dos terapeutas em concordar. Essa dependência pode interferir nos esforços para ajudar os pacientes a tolerarem o mal-estar e se validarem.

Os terapeutas também podem ficar confusos com a distinção. Um terapeuta DBT em supervisão comigo disse: “Mas como posso validar a decisão unilateral do meu paciente de parar seus medicamentos? Eu discordo totalmente disso”. Para reiterar: *validar* o comportamento de um paciente é encontrar as bases válidas para isso, de um tipo ou outro. É uma questão completamente separada concordar ou discordar pessoalmente dele.

As mesmas confusões às vezes surgem na distinção entre validação e aprovação. O paciente pode querer nossa aprovação,

não apenas nossa validação. Paciente: “Antes de decidir sair da casa da minha família, quero saber se você aprova”. Terapeuta: “Acho que você sabe que, na minha opinião, será difícil, mas que seu raciocínio faz completo sentido”. Paciente: “Eu sei, mas quero saber se você está a favor disso”. O paciente aqui está pedindo algo mais do que validação; ele quer a aprovação pessoal do terapeuta antes de agir. Em algumas situações, o terapeuta pode transmitir a aprovação da escolha do paciente, o que pode ser eficaz e apropriado. Mas há outras vezes em que os terapeutas desaprovam as decisões, mas ainda podem validá-las. Na minha unidade de internação de DBT, os pacientes podiam entrar na sala de jantar à noite com a condição de que a limpassem depois de fazer seu lanche. Um dos membros da equipe da noite veio até mim uma manhã com uma pergunta: “Charlie, ontem à noite os pacientes não limparam depois de usar a sala de jantar. Eu queria dizer a eles que perderiam o privilégio de lanches noturnos se não limpassem, mas não disse nada porque não parecia muito validador”. Esse membro da equipe, tentando aprender o tratamento, evidenciou confusão: ele estava fundindo a essência da validação com a essência da aprovação. Como discutimos, estava tudo bem destacar as consequências negativas do comportamento dos pacientes, enquanto o validava. “Não é de se admirar que vocês não queiram limpar a sala de jantar; ninguém gosta de fazer isso. Mas vocês sabem que vão perder o benefício de lanchar amanhã à noite se não limparem hoje.”

Por fim, é sábio lembrar que validar alguém não exige um estilo de comunicação cordial; também podemos comunicar a um paciente que seu comportamento faz sentido com um estilo frio. O estilo de comunicação é uma variável independente, não vinculada a se validamos ou não, embora seja mais típico comunicar a validação com cordialidade, já que ambos estão no pacote maior de estratégias de aceitação na DBT.

VÁLIDO VERSUS INVÁLIDO

Os especialistas em DBT frequentemente instruem os terapeutas a “validarem o válido e invalidarem o inválido”. Essa declaração pode ser bastante confusa, considerando que, teoricamente, todo comportamento tem validade. Todo comportamento foi causado por todos os eventos até aquele momento. Como disse em um capítulo anterior, o mundo é perfeito como ele é. Podemos interpretar isso para significar que todo comportamento é válido em relação ao passado. Então, o que os especialistas em DBT querem dizer? Se tudo é válido, por que consideramos alguns comportamentos inválidos? Por que escolhemos validar alguns comportamentos e não outros? A resposta curta é que às vezes escolhemos invalidar comportamentos porque eles interferirão no progresso em direção às metas previamente declaradas do paciente. Eles são inválidos em relação aos fins em vista.

Digamos que nossa paciente abuse de heroína e tenha concordado em entrar em tratamento para se livrar da dependência – esse é um alvo de tratamento de alta prioridade. Se ela continuar usando heroína, há validade nesse comportamento? Sim, claramente há. O comportamento é válido em relação ao passado e à biologia do indivíduo; ela tem uma dependência e podemos ver que, dadas essa história e essa biologia, o uso de heroína é válido. E pode ser válido em relação ao contexto atual, na medida em que pode ser o único meio pelo qual ela consegue aliviar o sofrimento emocional em seu contexto atual, e ela pode, de fato, funcionar de maneira mais eficaz depois de usar. O problema surge se levarmos a validação ao último passo e comunicarmos ao paciente. Uma vez que a validação geralmente também funciona como reforço, provavelmente estaríamos reforçando o uso de heroína – obviamente, essa não é uma boa ideia. Se validarmos nesse contexto, estamos opondo metas muito importantes do tratamento.

Então escolhemos não validar o uso de heroína, mesmo que validemos os desejos de heroína à luz do passado ou validemos o sofrimento emocional no contexto atual, o sofrimento que leva aos desejos. Podemos até invalidar o uso de heroína, desafiando-o e lutando contra ele, para buscar as metas de modificação comportamental. Então, quando os especialistas em DBT dizem para invalidar o inválido, não queremos dizer que seria impossível encontrar validade no comportamento. Em vez disso, queremos dizer que certos comportamentos em certos contextos são *cl clinicamente inválidos*. Como o clinicamente válido e o inválido muitas vezes estão juntos no mesmo emaranhado intrincado de comportamentos no momento, precisamos exercitar precisão e agilidade ao usar a validação de forma eficaz nessas situações. Eu volto a esse dilema em uma próxima seção sobre o uso da validação com princípios dialéticos em mente.

QUAIS SÃO OS ALVOS DA VALIDAÇÃO?

Agora abordamos a questão: o que exatamente validamos? Existem cinco categorias diferentes de alvos de validação: emoções, pensamentos, ações, capacidades e a pessoa como um todo. Embora confiemos nos mesmos três passos para validar cada categoria de alvo, diferentes considerações surgem em relação a diferentes categorias.

Emoções

A teoria biossocial da DBT começa com a proposição de que os pacientes têm um grau de sensibilidade e reatividade emocional mais elevado do que a média, e um retorno lento à linha de base após uma resposta emocional. As respostas emocionais desses pacientes foram invalidadas na infância por um ambiente amplamente invalidante e, ao longo do tempo, eles passaram a responder às suas próprias emoções invalidando-as. Tornou-se automático para eles responderem às próprias emoções julgando-as, odiando-as e talvez até odiando a si mesmos como um todo. Eles adquiriram a tendência de evitar sinais emocionais, suprimir respostas emocionais e escapar de emoções atuais por meio de ações ou emoções secundárias.

Dadas a confusão e a supressão que acompanham a experiência emocional para muitos pacientes da DBT, é importante e validador simplesmente notá-las, perguntar sobre elas, ouvi-las cuidadosamente e encorajá-los a se comunicarem conosco. Observamos quando suas emoções são suprimidas ou obscurecidas, minimizadas ou maximizadas. Empatizamos, imaginando-nos nas situações de nossos pacientes, pensando em como seria ter as mesmas emoções, procurando o “sentido” na presença de uma determinada emoção e comunicando essas compreensões aos pacientes. A DBT precisa ser uma terapia

focada em emoções para fortalecer a capacidade de regulação emocional de cada paciente.

Uma paciente me disse: “Ontem à noite eu estava mandando mensagens para minha amiga enquanto ela dirigia e eu estava em casa, e de repente ela parou de responder. Ela tinha saído da estrada, batido em uma árvore e morrido instantaneamente.” Ela me contou essa notícia chocante de maneira breve, controlada e cortante, suprimindo qualquer emoção. No mesmo instante, me senti emocionalmente desregulado. Senti vontade de chorar e perguntei se ela poderia falar mais sobre como se sentia. Ela disse: “Essas coisas acontecem na vida; ela não deveria estar mandando mensagens”. Eu estava lutando entre minha intensa resposta emocional e seu rápido descarte das emoções. Disse: “Mas era sua melhor amiga”. Ela disse: “Sim, mas você não pode controlar quem vive e quem morre”. Eu recuei dentro de mim, respirei conscientemente algumas vezes, olhei cuidadosamente para a minha paciente. Ela estava fisicamente inquieta, mas parecia estar excepcionalmente quieta. Havia tantas coisas que eu queria dizer e perguntar, mas percebi que seriam mais para mim do que para ela. Fiquei em silêncio por um tempo incomumente longo, talvez três minutos, querendo criar espaço para ela pensar, sentir e se comunicar. Eu estava tentando sair do caminho dela, mas permanecer conectado. De repente, ela disse: “Acho que já tive o suficiente”. Pareceu que ela queria dizer que tinha tido o suficiente da sessão e queria sair. Perguntei: “O suficiente do quê?”. “O suficiente da vida”, respondeu ela. “O suficiente de dor, o suficiente de fazer as coisas direito e depois ser machucada, o suficiente de fazer as coisas erradas.” Suas lágrimas começaram a cair. “Ela era minha melhor amiga, quase minha única amiga. Não sei o que vou fazer. Eu matei minha melhor amiga.” Era quase demais para suportar. Minha tarefa era testemunhar seus pensamentos dolorosos e sua expressividade emocional. Isso é o que queremos dizer por validação emocional. Nos próximos

minutos, ela foi capaz de expressar uma complexa e perturbadora mistura de tristeza, raiva e culpa. Isso nos permitiu nos aproximarmos ao invés de nos distanciarmos um do outro para isolar a dor. Permitiu que ela tivesse suas emoções, visse para onde elas foram e se sentisse compreendida. Eventualmente, foi o início do processo, a continuar por meses, de desemaranhar o impacto do que aconteceu, como aconteceu, quem teve responsabilidade e o que fazer. Foi, para esta paciente, um grande passo em direção à regulação emocional.

Validar emoções pode ser muito difícil. Isso requer permanecer focado na importância de uma emoção, deixando-a surgir no seu próprio ritmo e seguir o seu curso. Muitas vezes, precisamos evitar conscientemente as mil coisas que fazemos como terapeutas para nos poupar, e aos nossos pacientes, do impacto completo das emoções. Às vezes falhamos em reconhecer a presença de uma emoção, subestimamos sua intensidade, falhamos em entender como a emoção se encaixa nas circunstâncias e, como sugeri, às vezes simplesmente não conseguimos regular nossa própria resposta emocional, o que, então, interfere na capacidade do paciente de regular a sua. A consciência das emoções, que evolui para a validação das emoções, é um pré-requisito para alcançar a tarefa principal da DBT: melhorar a regulação emocional do paciente.

No entanto, não validamos todas as expressões emocionais. Às vezes, a expressão de uma emoção é feita em serviço da fuga de uma resposta emocional anterior; ou seja, a emoção secundária serve como uma fuga da emoção primária. Por exemplo, eu poderia escapar de tristeza ou vergonha insuportável por meio de uma intensa expressão de raiva. Se meu terapeuta e eu consideramos a raiva a emoção primária, deixando de ver seu papel na minha fuga da tristeza ou da vergonha, reforçaremos a fuga e perderemos a oportunidade de aumentar a minha capacidade de regular a tristeza ou a vergonha primária. Um terapeuta DBT

precisa estar atento se um determinado comportamento intenso e repetitivo representa uma emoção secundária, ao mesmo tempo em que considera qual é a emoção primária.

Pensamentos

Nós validamos pensamentos. De novo: reconhecemos um pensamento, o entendemos, imaginamos como seria tê-lo, buscamos os fundamentos válidos para o pensamento no contexto do passado, presente ou futuro e comunicamos tudo isso. Na maioria das vezes, esse processo é fácil e automático. Por exemplo, a paciente diz: “Estou envergonhada pelo que eu disse ao meu namorado ontem. Tenho medo de que ele termine o relacionamento”. O terapeuta pode validar esse pensamento de que o relacionamento pode acabar: “Entendo por que você acha que ele pode terminar por causa disso; não foi o seu momento mais equilibrado. Não é de se surpreender que você esteja com medo”. A paciente se sente compreendida; o terapeuta valida o pensamento como compreensível no contexto atual. O terapeuta também pode saber que a paciente perdeu relacionamentos importantes e validar que o pensamento dela pode ser válido com relação ao passado. Com relação ao futuro, o terapeuta sabe que a paciente tem sonhos esperançosos sobre sua vida com esse homem, e é válido para ela se preocupar em perdê-lo. Assim, com relação aos contextos de passado, presente e futuro, o terapeuta pode validar o pensamento sobre perder o namorado. Tendo validado o pensamento, pode passar para a solução de problemas: “Considerando o que você sabe sobre vocês, e como lidaram com mal-entendidos antes, qual você acha que é a probabilidade de ele terminar com você por causa disso?”.

Inerente à validação de pensamentos está a compreensão de que eles são apenas declarações sobre a realidade; não são fatos. É tão fácil esquecer esse ponto importante. Queremos ajudar

nossos pacientes a notarem e reconhecerem seus pensamentos, elaborá-los e encontrarem o que é válido neles. Ao mesmo tempo, queremos transmitir, implícita ou explicitamente, que os pensamentos são apenas pensamentos e que, embora um pensamento possa ter alguma validade, em outras formas pode não ser tão válido. No exemplo citado, é válido ela se arrepender do que disse ao namorado, válido ter o pensamento de que ele poderia deixá-la e válido sentir medo de perdê-lo, mas, dados o histórico e a trajetória do relacionamento e como eles lidaram com problemas anteriores, é inválido esperar que ele termine por causa disso. Embora comecemos validando o que é válido, passamos para a solução de problemas, o que às vezes inclui invalidar o que é inválido.

Entre os cenários mais desafiadores na DBT estão aqueles momentos em que o paciente dá voz a pensamentos suicidas intensos. O terapeuta pode relutar em validar a presença de pensamentos suicidas, temendo que isso de alguma forma valide a ação suicida também. O pensamento de suicídio provavelmente será válido no contexto de uma vida de sofrimento, invalidação, auto-ódio e talvez falta de melhora nas semanas ou meses anteriores. O terapeuta pode ser tentado a insistir que o paciente “tire o suicídio da mesa”, o que implicitamente comunica que não quer ouvir mais sobre o suicídio. O paciente pode sentir que não pode trazer seu pensamento suicida para o terapeuta e, assim, sentir-se ainda mais invalidado. A precisão é importante aqui. Queremos validar o *pensamento* suicida como resposta ao contexto em que se desenvolveu; validar o *pensamento* suicida como fazendo sentido em resposta a um contexto atual impossível e na ausência de uma visão de um futuro viável; e ainda assim invalidar firmemente o *comportamento* suicida. Não podemos tirar as emoções “da mesa” e é irrealista tirar a ideação suicida crônica “da mesa”, mas os terapeutas DBT, mesmo reconhecendo que há validade no ato de suicídio em várias perspectivas, não validam o

plano, a intenção iminente ou a tentativa. Em minha experiência, encontrar o equilíbrio certo nessa área assustadora é útil para o paciente que está “preso” com pensamentos suicidas como resultado natural das circunstâncias da vida e da química cerebral, que se beneficia de poder expressar esse pensamento em um contexto empático e também da posição inabalável do terapeuta contra o ato.

Ações

Validar ações pode se tornar bastante complicado. Enquanto é fácil validar um paciente dizendo: “Não é de se admirar que você tenha se atrasado hoje; você ficou preso no trânsito, o que seria difícil de prever”, outros cenários podem ser mais desafiadores. Por exemplo, imagine que uma criança chega em casa e mostra o boletim escolar com uma nota ruim. Ela é uma jovem ambiciosa que busca obter apenas boas notas e diz aos pais: “Não consigo acreditar que fui tão mal... nunca deveria ter tirado uma nota tão baixa e nunca entrarei na faculdade”. É claro que essa única frase inclui ações (como ela se saiu no teste), pensamentos (“nunca deveria ter ido tão mal”) e emoções (raiva de si mesma e medo de não entrar na faculdade). Ao tentar validar a ação, o pai diz: “Mas você teve outras três provas essa semana, jogou em um torneio no fim de semana e tivemos que ir a um funeral na segunda-feira. Não é de surpreender que não tenha se saído tão bem como de costume, já que não pôde se preparar da maneira que costuma fazer”. Para uma criança, essa resposta pode ser suficiente; pode ser recebida como precisa e empática, como destacando a validade dentro do mau desempenho. Mas para outra criança, essa resposta pode estar fora de foco. Ela pode protestar, dizendo: “Não importa! A vida acontece e você ainda tem que obter boas notas. Eu deveria ter sido capaz de fazer muito melhor”. Quanto mais você valida o mau desempenho, mais a criança fica perturbada. Na

verdade, o pai está localizando a validade no desempenho, mas ao mesmo tempo está invalidando os altos padrões da criança em relação ao seu desempenho. Ela tem altos padrões, possivelmente padrões rígidos; nada “deve” ficar no caminho do sucesso total. É uma das muitas maneiras (mais adiante no capítulo) em que a validação pode ser difícil e pode exigir uma abordagem dialética. Há dois fenômenos que se cruzam neste cenário: o mau desempenho e os altos padrões. Validar o primeiro pode invalidar o segundo. Talvez o pai tenha mais sucesso em validar ambos juntos: “Sei que seus padrões são muito altos, e estamos orgulhosos de você por trabalhar tão duro. Considerando o quão altos são seus padrões, deve ser terrível tirar uma nota mais baixa do que você é capaz.”

Este é o problema que pode surgir ao validar as ações de indivíduos que tendem a ter uma postura rígida ou autoinvalidante. Você valida a ação. O paciente rejeita a validação (o que significa, essencialmente, que a validação pretendida não é validadora), destacando que deveria fazer melhor. O terapeuta, então, é sábio em descobrir os motivos para o “deveria” e validá-lo. Se isso puder ser feito com sucesso, o paciente pode ser capaz de se mover em direção à emoção compreensível de decepção, que pode então ser validada. Todos esses exemplos de validação têm como objetivo reduzir a crença de que os pensamentos são a realidade; reduzir o grau de rigidez no pensamento, emoção e/ou comportamento; e facilitar a experiência e a regulação emocionais.

Capacidades

Validamos capacidades – o que também chamamos de *encorajamento*. Em paralelo à validação dos vários comportamentos que discutimos, validamos as capacidades individuais reconhecendo-as, compreendendo como seria tê-las e apreciando sua importância, vendo como essas capacidades são

válidas dada a história e os contextos atual e futuro, e comunicando que notamos as capacidades e as vemos como válidas. Como os pacientes que tratamos na DBT muitas vezes duvidam de suas capacidades ou não reconhecem algumas de suas realizações como capacidades, é crucial que as reconheçamos e validemos e é importante que entendamos que nossas tentativas de validação podem não ser aceitas.

Uma de minhas pacientes, após passar por três anos de hospitalizações devido a episódios de comportamento suicida e outros problemas, começou a acreditar que não tinha habilidade para construir uma vida. Para ela, tudo parecia sem valor e apenas servia como evidência para que desistisse de tentar. Apesar de ter se mostrado promissora anteriormente, sentia que isso tinha desaparecido e que não tinha nada a oferecer. Compreendi como ela chegou a essa conclusão e acredito que qualquer pessoa que tivesse passado pelos mesmos três anos que ela teria a mesma convicção de falta de capacidade. Eu poderia reconhecer e validar seu desespero e suas crenças pessimistas, e houve muitas oportunidades para fazê-lo. Achei que seria importante validar suas habilidades, mas foi difícil encontrar uma maneira de fazê-lo, já que muitas abordagens poderiam parecer falsas. Quando ela expressou sentir-se inútil, lembrei-me de como ela era uma das pessoas mais compassivas que conhecia. Eu disse: “Sei que esses anos foram difíceis e afetaram sua experiência de ser útil, mas quero que saiba que você tem uma qualidade única que não desapareceu. Se eu estivesse passando por dificuldades e precisasse de ajuda, pediria a você, porque sei que me ajudaria imediatamente. Você é esse tipo de pessoa, e isso ainda está presente mesmo depois de tudo que passou”. Ela sabia que eu estava sendo sincero e agradeceu de forma genuína.

Talvez seja enganoso usar esse exemplo de autorrevelação pessoal em serviço de validação de suas capacidades. Na maioria das vezes, a validação de capacidades é mais comum: o terapeuta

reconhece e destaca as capacidades à medida que surgem durante a sessão ou conforme emergem na história do paciente. Ao contrário da validação de ações, pensamentos e emoções, geralmente o paciente não traz suas capacidades à atenção do terapeuta; elas são reconhecíveis se o terapeuta estiver atento, mas poderiam facilmente permanecer fora da conversa. Há tantas oportunidades para validar capacidades, para simplesmente notá-las, e é minha impressão que subutilizamos essa intervenção útil. Uma paciente completa seu diário, claramente tendo dado toda a atenção a cada classificação; eu destaco sua força em automonitoramento e cooperação com o tratamento. Uma paciente que parecia disfuncional em gerenciar sua vida anuncia para mim que está planejando uma viagem pelo país com uma amiga, e tomou a iniciativa de descobrir a logística. Embora certos aspectos de seus planos possam me preocupar, comento sobre sua capacidade anteriormente oculta de planejar uma viagem assim.

Como os pacientes às vezes se preocupam que, se forem vistos como capazes em um domínio, será esperado deles que sejam capazes ao longo da vida, eles evitam o reconhecimento ou a aceitação de suas capacidades. Essa postura apresenta um desafio técnico. Em primeiro lugar, o terapeuta pode ser sábio em destacar as capacidades usando apenas “pinceladas” breves e um estilo despretensioso. Em segundo lugar, o terapeuta pode querer acompanhar a validação de capacidades com a validação do medo de que, se visto como capaz, seja esperado muito do paciente. Eu usei irreverência ao validar um paciente: “Se eu não achasse que isso te assustaria, diria que você é realmente capaz”.

Pessoa como um todo

Validar respostas comportamentais específicas não necessariamente valida a pessoa como um todo. Por exemplo, posso validar a relutância do meu paciente em participar de um

grupo de treinamento de habilidades, dada sua ansiedade social, de uma maneira que inadvertidamente também sugere que ele é uma pessoa que desiste facilmente. Ao validar a pessoa como um todo, estamos tratando nosso paciente como alguém de substância, relevância, significado e valor intrínseco. Ao falar desse tipo de validação, estamos nos referindo a algo muito próximo do “afeto positivo incondicional” descrito na terapia centrada no cliente de Rogers (1951) ou no que Buber descreve em *Ich und Du [Eu e Tu]* (1923). Precisamos manter nosso profundo respeito pelo paciente, às vezes apesar das respostas comportamentais problemáticas, comunicando que ele está viajando ao nosso lado no caminho da vida como alguém que não é menos merecedor de respeito e compaixão do que nós. Qualquer coisa menos do que isso mina nossa missão.

QUANDO DEVEMOS VALIDAR E QUANDO NÃO DEVEMOS VALIDAR?

Primeiro, pode ser importante afirmar que nem sempre procuramos oportunidades para validar. Como a validação é enfatizada na DBT, alguns terapeutas pensam erroneamente que a validação é o objetivo ou a essência do tratamento. Não é. A meta final é a busca por uma vida que valha a pena ser vivida por meio de metas especificadas. A validação é uma das intervenções que pode ser uma ferramenta para chegar lá; é um meio para um fim, não um fim em si mesma. Às vezes, mostro vídeos de Marsha Linehan conduzindo sessões individuais de DBT. Não raramente, a primeira pergunta da plateia é: “Por que Marsha não validou mais o paciente?”. Há dois problemas com essa pergunta. Um é que o vídeo pode não revelar a presença de validação mesmo que esteja ocorrendo na sala. Pode ser um processo transacional sutil reconhecido apenas pelos dois participantes. O outro problema é que o questionador pode estar pensando que Marsha deveria ter validado mais o paciente. As decisões sobre quando, como e quanto validar são avaliações complicadas e devem ser baseadas mais em se o paciente está progredindo em direção às suas metas do que em algum mandato moral para validar.

Dito isso, é verdade que geralmente usamos certos níveis de validação o tempo todo. Na próxima seção, eu esboço os seis níveis de validação na DBT. O nível 1 e o nível 6 devem estar presentes consistentemente ao longo do tratamento. O nível 1 prescreve que o terapeuta esteja “totalmente alerta” e atento enquanto ouve o paciente. O nível 6 é descrito como “genuinidade radical”, uma postura na qual permanecemos verdadeiramente nós mesmos enquanto nos engajamos com o paciente no tratamento. Se estivermos totalmente alertas, ouvindo com cuidado e genuinamente sendo nós mesmos, tendemos a criar uma

atmosfera de validação na qual os pacientes sentem que são substanciais, significativos e merecedores de respeito. Sobre essa base, aplicamos estratégias de validação mais específicas, descritas a seguir, como exemplos dos outros quatro níveis.

A validação é uma postura que acompanha a avaliação, é um conjunto de estratégias que equilibra a busca por mudança durante a solução de problemas e é o conjunto mais puro de estratégias orientadas para a aceitação na DBT. Embora não haja uma regra que exija o uso de validação durante a avaliação comportamental, muitas vezes essa postura é a mais propícia para descobrir as conexões na cadeia e as variáveis controladoras do comportamento-alvo. O paciente que percebe que estamos interessados na justificativa por trás de seus vários comportamentos é mais propenso a se expressar sobre detalhes de todos os tipos. No entanto, investigar as circunstâncias detalhadas de eventos emocionalmente desencadeadores pode provocar reatividade emocional e levar a evitação e retraimento. E, é claro, durante análises em cadeia do comportamento, mesmo esforços cuidadosos de mudança comportamental podem provocar respostas semelhantes.

Quando estamos buscando mudanças e usando uma infinidade de estratégias de solução de problemas, podemos facilmente subestimar a dificuldade do paciente em tolerar nossas intervenções, mesmo bem-intencionadas. Conforme avançamos em direção à mudança, geralmente precisamos validar a dor emocional e a dificuldade de experimentar novos comportamentos. Ao trabalhar com uma mulher suicida com TPB, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e anorexia, houve um momento em que eu estava convencido de que, se ela pudesse aprender a usar exercícios progressivos de relaxamento muscular e respiração diafragmática, poderia reduzir sua tensão e ansiedade sem comportamentos autolesivos ou comportamentos alimentares desordenados. Enquanto eu a

orientava nessas habilidades, ela começou a ficar ansiosa na minha presença. Ela disse que não queria tentar as habilidades, pois sabia que não funcionariam. Empurrá-la ainda mais nesse momento teria sido contraproducente, mas eu ainda acreditava que ela poderia se beneficiar. Então, parei para pensar no que havia acontecido e perguntei em voz alta, sem acusá-la, o que poderia estar acontecendo. “Parecia que você estava interessada em algumas técnicas para tensão e ansiedade, mas agora parece que eu te assustei. O que aconteceu?” Ela rapidamente respondeu, com medo e cautela: “Não quero me concentrar na minha respiração, mudar minha respiração ou fazer nada em relação à minha respiração!”. Eu perguntei: “Qual é o problema com a sua respiração?”. Sua resposta foi: “Se eu me concentrar nisso, vai parar – eu sei que vai”. Em vez de desafiar a probabilidade científica de que sua respiração pararia se ela prestasse atenção nela, eu procurei a validade em sua afirmação. Certamente, ela não era a única pessoa com transtorno de pânico que experimentava “ansiedade de sufocação”. Eu disse: “Entendo, não é de admirar que você não queira fazer isso. Muitas pessoas com transtorno de pânico pensam a mesma coisa. Por que não deixamos de lado o foco na respiração e fazemos apenas o relaxamento muscular? Pode ser muito eficaz por si só”. Ela estava disposta e ansiosa, e de fato achou que era uma técnica útil.

Nós usamos estratégias de validação para transmitir compreensão e aceitação. Às vezes, durante várias sessões consecutivas, pressionei o paciente a mudar de comportamento e, apesar do grande esforço, o processo foi desgastante para ambos. Percebendo que estou pressionando pela mudança sem equilibrá-la com aceitação, entro na próxima sessão com o plano de “apenas ouvir”, essencialmente para verificar como meu “parceiro na solução de problemas” está se saindo, o que está pensando. É algo como uma troca “coração a coração” sobre como as coisas estão indo e funciona como uma pausa para ambos. Reforça o

trabalho árduo e pode ser eficaz em restaurar o equilíbrio e fortalecer nosso vínculo. Em contrapartida, usar a validação por meio de uma conversa “coração a coração” quando um paciente não tem sido colaborativo ou esforçado corre o risco de reforçar comportamento de solução de problemas passivo.

Às vezes, queremos validar um comportamento de um paciente, mas naquele momento ele está envolvido em um padrão comportamental disfuncional simultâneo que pode ser reforçado pela validação. Lembro-me de que, na minha unidade de pacientes internados de DBT, uma paciente em particular permanecia na cama às 8h30, quando era hora de todos participarem dos grupos. Um membro da equipe de enfermagem foi ao quarto com a intenção de incentivá-la a ir para o grupo. Enfermeira: “É hora de se levantar e ir para o grupo”. Paciente: “Estou tão cansada. Fiquei acordada até tarde depois de uma ligação muito ruim com meu pai. Eu mal dormi”. Mesmo por motivos biológicos, era válido querer ficar na cama. O membro da equipe, tendo aprendido a validar, disse: “Entendo. É muito difícil se levantar depois de ter dormido tão pouco. O que tornou a ligação tão ruim?”. A enfermeira estava fazendo tudo certo até a última pergunta, que abriu vários minutos de explicação. Sua validação inicial com base na falta de sono foi suficiente e sua próxima frase deveria ter sido algo como “Entendo, mas agora venha, você tem que se levantar agora!”. Em vez disso, ela provavelmente estava reforçando o comportamento de procrastinação.

OS SEIS NÍVEIS DE VALIDAÇÃO

Linehan (1997) articulou os seis níveis de validação como seis diretrizes ou estratégias que se constroem mutuamente; estas constituem sua declaração mais concisa de como os terapeutas DBT validam. As três etapas de validação que discutimos no início do capítulo – 1) reconhecer e entender um comportamento, 2) encontrar o valor da verdade no comportamento e 3) comunicar essa compreensão – se encaixam nesses níveis. Os primeiros três níveis fornecem diretrizes para como implementar a primeira etapa e entender o comportamento do paciente (e empatizar com ele). Os próximos dois níveis fornecem diretrizes para encontrar a validade no comportamento. E o nível final fornece diretrizes para validar o indivíduo como um ser completo. Revisamos esses níveis aqui para que tenhamos todos os aspectos técnicos da validação em nossa mente enquanto passamos a considerar como os princípios dos paradigmas de aceitação, mudança e dialética influenciam ou modificam nosso uso da validação.

Validação nível 1

O nível 1 exige que o terapeuta permaneça “inteiramente acordado”, presente por completo, ouvindo com atenção total. Em um cenário ideal, o terapeuta usa o nível 1 constantemente, em todas as sessões de terapia, inclusive durante episódios de solução de problemas. Ao estar verdadeiramente presente, ele cria uma atmosfera que transmite ao paciente: “seu comportamento tem substância, significado, faz sentido e é digno da minha atenção”. Como discutido anteriormente, é um dos níveis que contribui para um ambiente de validação e prepara o terreno para todos os outros níveis. Oferecer a um paciente a presença total é de valor inestimável. É a coisa mais natural do mundo se você se importa com alguém e, no entanto, é muito difícil de fazer. O

terapeuta deve estar ancorado no momento e na realidade atual, totalmente acordado para o que está influenciando o paciente e regulado emocionalmente o suficiente para de fato ouvir. Nesse aspecto, fazer psicoterapia em DBT é em si uma prática de *mindfulness*, com os objetos de consciência sendo as comunicações do paciente, os comportamentos de interesse e a pessoa como um todo.

Uma jovem entrou no meu consultório e sentou-se. Eu havia cancelado sua sessão anterior com apenas um dia de antecedência devido a uma emergência e não pude oferecer uma sessão de reposição. Pedi desculpas por telefone e ela parecia ter aceitado. Quando ela entrou na sessão, eu disse “Oi”. Com uma voz cantarolante, parecendo completamente falsa e aborrecida, ela respondeu com um prolongado “Oi”. Por estar presente, no momento, equilibrado e pronto para ouvir, fui alertado pelo tom de voz e pelos aspectos sutis de seu *timing*, sua postura corporal e falta de contato visual. Eu não sabia exatamente como interpretar isso, mas sabia que algo estava errado. Adivinhei que seu estado distante, mas perturbado, estava relacionado ao cancelamento. Eu trouxe o assunto: “Desculpe ter cancelado da última vez”. Ela respondeu rapidamente com um tom decididamente irritado e sarcástico: “Sim, obrigada! Ótimo *timing*! Tenho certeza de que você tinha algo mais importante a fazer do que me ver”. Isso levou rapidamente a uma revisão do que havia acontecido e de quais foram suas interpretações. Fomos capazes de reparar o rompimento em menos de dois minutos e, na verdade, isso fortaleceu nosso relacionamento. Se eu não estivesse presente, alerta e acordado, teria perdido as dicas sutis, provavelmente teria ficado na defensiva e o assunto teria se agravado.

Fatores que interferem na validação nível 1

Muitas coisas podem dar errado na validação antes de falarmos qualquer palavra para o paciente. Podemos mal ouvi-lo ou não entender suas comunicações verbais e não verbais. Podemos ter pontos cegos e não reconhecer o que realmente importa. Podemos não detectar sua emoção, e nossos comentários subsequentes indicariam que “perdemos o barco”. Podemos notar a emoção, mas subestimar sua intensidade. A presença do dilema dialético de “competência aparente”, causada no paciente em reação a ambientes invalidantes, pode tornar suas emoções difíceis de “ler”. Mesmo que percebamos com precisão a emoção e sua intensidade, é fácil entender equivocadamente que o paciente sente que sua emoção está quase fora de controle. É quase impossível validar com precisão se não detectarmos a emoção, seu nível de intensidade ou a experiência do paciente de estar quase fora de controle.

Podemos falhar em entender que uma tarefa dada ao paciente, aparentemente bastante simples para nós, pode parecer quase impossível para ele. Se reconhecermos o nível de dificuldade experimentado pelo paciente, ainda podemos atribuir a tarefa, mas ao reconhecer sua experiência, podemos validar a dificuldade. Se o paciente se sentir reconhecido e compreendido, sua disposição para se envolver na tarefa pode aumentar. Podemos facilmente subestimar a magnitude do apego do paciente a nós, ou o grau de insegurança associado a esse apego. Podemos assumir que nosso paciente sente o que sentimos, que nosso vínculo sólido sobreviverá a qualquer pequena diferença entre nós, quando na verdade ele teme que o menor tropeço possa levar ao fim. E há muitas maneiras pelas quais podemos deixar de perceber que estamos indo em uma direção enquanto o paciente está indo em outra. Em *workshops*, Linehan chamou isso de falha de “perspectiva de localização”. Achamos que estamos em um lugar no trabalho e o paciente acha que estamos em outro. Uma menina de 16 anos foi encaminhada a mim para psicoterapia devido a seus

múltiplos episódios de autolesão e seu recente ataque físico ao pai. Ela era agradável, cooperativa e engajada. Tive a impressão de que estava bastante interessada em aprender o que a DBT tinha a oferecer. As coisas pareciam estar indo bem. Ao término da sessão, peguei minha agenda para marcar o próximo encontro. Ela se levantou de maneira abrupta e anunciou que precisava sair imediatamente para encontrar sua amiga. Disse: “Devemos agendar a próxima sessão por telefone?”. Ela respondeu de maneira formal: “Não, eu só queria uma sessão e claramente você não me entende”. Obviamente, eu perdi algumas dicas e li mal sua “localização”. Cerca de uma semana depois, ela deixou uma mensagem de voz, muito objetiva, perguntando quando seria nossa próxima sessão. Durante a sessão seguinte, soube verificar sua “localização” e fiquei surpreso ao descobrir que seu estilo cooperativo estava completamente fora de sincronia com sua sensação de desesperança. Sabendo disso, fui capaz de ler as entrelinhas, reconhecer sua desesperança apesar de sua apresentação alegre e validar suas reações.

Validação nível 2

O nível 2, que envolve reflexão, é uma extensão natural do nível 1. Ao já estar acordado, atento e ouvindo, é mais provável que detectemos algo nas palavras ou nos gestos do paciente. Verificamos isso repetindo, até mesmo usando as palavras do paciente. Uma paciente me disse outro dia: “Charlie, na última sessão você me desapontou muito”. Eu entendi, repeti: “Não sabia disso. Eu realmente te desapontei”. Paciente: “Sim, você foi muito intenso”. Ela comunica isso, eu entendo e repito (para confirmar que entendi), e então podemos seguir em frente. Em contrapartida, ao repetir, a paciente pode ouvir que eu realmente não entendi ou não a compreendi com precisão. Ela diz: “Meu marido não me entende”. Eu respondo: “Eu sei, você me disse muitas vezes, você

não se sente entendida por ele”. A paciente ouve que eu não entendi: “Eu acho que você não entendeu. Não é que eu não me sinto entendida por ele. Ele não me entende, nunca entendeu”. Se eu estiver alerta, acordado e ouvir a correção da paciente sobre a minha reflexão, posso tentar novamente: “Acho que entendi errado. Você está dizendo que ele simplesmente não entende. Certo?”. “Certo.” O ato de espelhar o que a paciente está dizendo é fundamental para estabelecer uma conexão mútua. É como uma dança, na qual a reflexão permite a compreensão mútua e revela possíveis lacunas que precisam ser abordadas. Isso ajuda a construir sintonia e um vínculo mais forte.

Fatores que interferem na validação nível 2

Quando vemos nosso reflexo em um lago, ele se assemelha a nós com mais precisão quando a superfície está imóvel. Da mesma forma, quando refletimos algo de volta ao nosso paciente, até mesmo usando as suas palavras, é mais provável que sejamos precisos se estivermos calmos. Nossa própria desregulação emocional pode interferir na validação nesse nível. Se hesitarmos, nos movimentarmos na cadeira, desviarmos o olhar por um instante ou expressarmos nossos comentários em um tom inadequado, distorcemos uma reflexão perfeitamente precisa. Estava atendendo uma paciente que continuamente relatava ter condições médicas graves, mas que, recentemente, eram infundadas. Nosso tratamento foi pontuado por crise após crise. Durante uma hospitalização, ela disse a um médico, que depois me comunicou essa conversa, que estava causando suas próprias condições médicas e era reforçada por receber cuidados médicos presenciais. Na nossa sessão seguinte, falei sobre esses comportamentos. Queria entender e avaliar, com o objetivo de adicioná-los à nossa lista de metas de tratamento. Eu pensei que estava ouvindo cuidadosa e objetivamente. Ela interrompeu: “Você

está cansado de mim?”. Fiquei surpreso com a pergunta, mas logo percebi que estava mais “farto” dela do que havia percebido. Sua desonestidade e sua criação deliberada de problemas médicos, resultando em crise após crise, me atingiram. Minha falta de autoconsciência emocional interferiu em minhas capacidades reflexivas.

Validação nível 3

O nível 3 é um parente próximo do nível 2. Enquanto o nível 2 envolve refletir o que foi comunicado explicitamente, o nível 3 envolve refletir o que foi comunicado de forma *implícita*. O paciente pode dizer que está bem, mas sua expressão facial e seus gestos sutis comunicam o contrário. O terapeuta percebe e reflete de volta: “Você diz que está bem, mas não parece bem”. O paciente pode então sentir-se reconhecido e profundamente visto, ou, ao contrário, pode se sentir exposto e insultado. Assim como no nível 2, o nível 3 envolve fazer uma declaração que pode ou não ser precisa do ponto de vista do paciente. Por exemplo, se continuarmos com o exemplo “Você diz que está bem, mas não parece bem”, o paciente pode então esclarecer: “Não, eu realmente estou bem, mas fui ao dentista antes de vir aqui, e meu rosto está distorcido”. A interação entre os níveis 1, 2 e 3 (ouvir, refletir, encontrar pontos em comum, encontrar diferenças, corrigir erros, reparar rupturas) ocorre quase constantemente em um bom relacionamento psicoterapêutico. É a dança da escuta, do reconhecimento e da empatia. Conforme a interação entre o terapeuta e o paciente se desenrola, o terapeuta tenta manter a atenção à mente do paciente, à própria mente e à interação entre os dois. É uma habilidade refinada, que na teoria do apego é vista como a habilidade central para formar relacionamentos de apego seguros. Envolve escuta cuidadosa, resposta sensível, ajuste, reflexão regular, leitura entre as linhas e obtenção de uma narrativa

cada vez mais elaborada da história do paciente (Bateman & Fonagy, 2004).

Ao descrever a validação, especialmente os níveis 1, 2 e 3, Linehan (1997) não enfatiza o processo de eliciar uma narrativa cada vez mais precisa, rica e elaborada enquanto ouve e questiona. Mas esse processo, destacado por aqueles que praticam terapia baseada em mentalização e psicoterapia orientada psicodinamicamente, se encaixa bem com a validação em DBT. O paciente se sente compreendido e validado não apenas porque ouvimos e refletimos esse ou aquele elemento da comunicação; é também porque entendemos cada vez mais a história por trás dos elementos. Para validar efetivamente, em especial à medida que avançamos para os níveis 4 e 5, precisamos “entrar” no paciente: sua história, as implicações de sua cultura e subculturas, a maneira como experimenta contextos atuais, as esperanças que tem para o futuro, e assim por diante. Os níveis 1, 2 e 3 são os blocos de construção da compreensão.

Validação níveis 4 e 5

Quando chegamos aos níveis 4 e 5, comunicamos ao paciente nossa compreensão de que seus comportamentos fazem sentido de duas maneiras: 1) com relação à sua história e biologia (nível 4) e 2) com relação ao seu contexto atual (nível 5). Na seção deste capítulo em que descrevi como determinar a validade, distingui entre validade baseada no contexto/biologia passado *versus* contexto atual *versus* contexto futuro (fins em vista). Aqui estamos falando sobre como colocar nossa compreensão do que torna um comportamento válido em ação, enquanto nos comunicamos com o paciente em uma sessão.

Vamos usar um exemplo para distinguir uma validação do nível 4 de uma validação do nível 5 e ver alguns dos desafios técnicos de cada um. Minha paciente havia sido criada por uma mãe que

focava exageradamente na aparência da filha. A mãe fazia comentários refletindo seu medo de que a filha engordasse, mesmo que ela mantivesse um peso saudável durante toda a infância. Aos 20 anos, estava obcecada com seu peso e começou a alternar entre compulsões alimentares, purgação e restrição de ingestão. Quando a tratei, aos 30 anos, ela havia superado as ações sintomáticas de seu transtorno alimentar, mas permanecia altamente sensível em relação a seu peso e sua aparência. Ela estava namorando um homem e tinha esperanças em relação ao relacionamento; no entanto, toda vez que ele a elogiava por sua aparência, ela se perguntava se ele na verdade achava que ela estava muito gorda.

Pela primeira vez em anos, ela voltou a ter episódios de compulsão alimentar e purgação. Na sessão seguinte, estávamos realizando uma análise em cadeia dos comportamentos-alvo. Na história, ela e seu namorado estavam jantando com outro casal em um restaurante. Depois de fazerem seus pedidos, pão foi trazido à mesa. Quando ela pegou um segundo pedaço de pão, seu namorado disse: “Querida, você realmente quer isso?”. Ela descreveu que, internamente, suas emoções explodiram, enquanto tentava não demonstrar. Ela sentiu raiva porque ele comentou sobre sua alimentação e humilhada porque o fez na frente dos amigos. Do seu ponto de vista, agora tinha evidência de seus medos mais profundos – que o namorado não gostava do corpo dela. Enquanto contava essa história na sessão comigo, seu terapeuta do sexo masculino, suas emoções estavam intensamente ativadas. Ao usar as validações dos níveis 1, 2 e 3, pude ouvir e entender suas emoções e pensamentos no jantar. Uma vez que compreendi a história, percebi que suas emoções e pensamentos podiam ser considerados válidos nos níveis 4 e 5. Eles eram válidos no nível 4 com base em sua história com a mãe, que a deixou vulnerável a quase qualquer comentário sobre sua aparência ou alimentação. Eles eram válidos no nível 5 com base

no contexto de sentar-se para jantar com seu namorado e outro casal, já que a maioria das pessoas se sentiria constrangida e irritada se o parceiro comentasse publicamente sobre sua alimentação (validação baseada em consenso). Se eu tivesse usado uma validação do nível 4 naquele momento em que uma do nível 5 também estava disponível, mesmo que a tivesse usado com precisão, provavelmente teria sido invalidante para ela em vez de validante. Imagine se eu tivesse dito: “Claro, você ficou chateada. Afinal, com sua história com sua mãe, quase qualquer comentário sobre sua alimentação teria levado ao constrangimento e à raiva”. Embora tecnicamente correto, teria o efeito de ignorar o comportamento inadequado de seu namorado e seria perturbador para quase qualquer pessoa. Isso destacaria sua patologia e ignoraria a natureza normativa de sua reação.

Como diretriz, se o terapeuta estiver ciente de que o comportamento é válido com relação ao passado, bem como válido (e normativo) no contexto atual, o primeiro movimento deve ser uma validação do nível 5. Nesse caso, seria melhor dizer algo como: “Não é de admirar que você tenha ficado com raiva e humilhada – ele realmente foi longe demais. Quase todo mundo teria ficado com raiva e envergonhado”. Você começa destacando o reconhecimento preciso e normativo da realidade do paciente, que pode então se sentir compreendido. Muitas vezes, a validação do nível 4 surgirá naturalmente, iniciada pelo terapeuta ou pelo paciente. Por exemplo, ela poderia ter dito: “Fico feliz em ver que você percebe que ele passou dos limites, mas você sabe, é verdade que eu tenho uma resposta exagerada e acabo ficando em um estado mental ruim”. Ou eu poderia ter seguido a validação bem-sucedida do nível 5 com uma validação do nível 4: “Me pergunto se isso piorou as coisas por causa da sua história com sua mãe?”.

Validação nível 6

Mencionei que a validação no nível 1 (presente, acordado, alerta) em geral opera ao longo da terapia. Diria o mesmo sobre a validação no nível 6, que é chamada de *genuinidade radical*. Em outras palavras, sempre queremos estar presentes, ouvindo e sendo *genuínos*. Mas o que significa especificamente para um terapeuta DBT ser genuíno? Significa que, ao responder aos nossos pacientes, permitimos que nossas respostas genuínas como pessoa se mostrem e sejam parte da conversa. Incorporamos nossas intervenções manualizadas no contexto de nossas respostas genuínas. Como já disse antes, queremos levar a DBT para um relacionamento com o paciente, não trazer o relacionamento para a DBT. Às vezes, os terapeutas “atuam” terapeuticamente, usam a linguagem do modelo terapêutico, seguem as diretrizes, mas não agem como eles mesmos. Praticar a genuinidade radical significa que a maneira como o terapeuta interage com o paciente será semelhante à forma como ele age com amigos e familiares, exceto que ele também estará fazendo terapia. Às vezes, no esforço para ser tecnicamente proficiente, nos afastamos de nossas respostas naturais, que poderiam ter um efeito curativo sobre o indivíduo invalidado.

VALIDAÇÃO E O PARADIGMA DA ACEITAÇÃO

A validação é considerada a forma mais pura das estratégias de aceitação. No entanto, isso não significa que seja usada apenas em serviço da aceitação. Como veremos, também é usada em serviço da mudança comportamental e da dialética. Mas começamos considerando a validação como a forma mais pura das estratégias baseadas em aceitação.

O paradigma da aceitação é baseado inteiramente na consciência do momento presente. O terapeuta localiza sua consciência inteiramente no momento presente, deixando de lado qualquer apego ao futuro ou ao passado. Como tal, o pensamento do momento presente não tem destino e está focado apenas no “ser”, não no “fazer”. Quando o terapeuta consegue entrar e permanecer no momento presente, usando tanto a mente quanto o corpo, o paciente provavelmente notará explicita ou implicitamente que o terapeuta está de fato presente – naquele momento e naquele espaço, acordado e alerta. Esse tipo de presença já valida o indivíduo como um todo. O nível 1 estabelece uma plataforma a partir da qual o terapeuta usa os outros cinco níveis.

Como apontei no Capítulo 3, o paradigma da aceitação envolve a consciência de que a realidade, em todos os seus elementos, é impermanente. Tudo o que existe neste momento não existirá da mesma forma no próximo momento. Tudo muda; tudo é transitório. Este momento é único; as coisas nunca mais serão as mesmas. Embora o reconhecimento da transitoriedade possa ser perturbador, também pode ser libertador porque torna cada momento precioso. Na medida em que o terapeuta, sentado com o paciente, mantém a consciência da impermanência da realidade, ele tratará cada momento como completo e único, e o paciente provavelmente verá o terapeuta como completamente presente e genuíno, notando e refletindo a realidade no momento. Isso

aprimora a validação de nível 1 (acordado, alerta), nível 2 (reflexão precisa), nível 3 (articulação do não articulado) e nível 6 (genuinidade radical). Se o momento for completo e vivo para o terapeuta, praticando a consciência da impermanência, o paciente também sentirá que o terapeuta está presente com ele, naquele momento.

Em seguida, o paradigma da aceitação envolve a consciência de que tudo e todos estão profundamente interconectados. Ninguém é separado e único, e todos são compostos de todos os outros. *Vacuidade* se refere a essa propriedade: que qualquer forma (p. ex., o corpo ou as ideias de alguém) é inteiramente composta por outros elementos, derivados de outro lugar, e, portanto, não há identidade única, nenhum eu único, nenhuma fronteira entre diferentes fenômenos e indivíduos diferentes. Por consequência, o terapeuta mantém uma consciência da profunda inter-relação entre o paciente, ele mesmo e outras entidades contextuais. O terapeuta é composto inteiramente de elementos não terapêuticos, incluindo elementos que vêm do paciente. O paciente é composto inteiramente de elementos não paciente, incluindo elementos que vêm do terapeuta. O reconhecimento desse princípio enfraquece ou dissolve a fronteira entre paciente e terapeuta e cria uma sensação de que os dois são um. O paciente e o terapeuta não são simplesmente companheiros de viagem no caminho da vida, lado a lado; eles estão realmente entrelaçados, interdependentes e operam como um enquanto trabalham juntos. As estratégias de validação entregues a partir dessa perspectiva são naturais. O paciente vê o terapeuta como compassivo e preocupado e sente que o terapeuta “entende”. Isso aprofunda a experiência de validação dos níveis 2 (reflexão precisa) e 3 (articulação do não articulado).

Por fim, o paradigma da aceitação envolve a consciência de que tudo está “como deveria estar” e que “o mundo é perfeito como é”. A resposta a tudo é “claro!”. Esse senso de certeza sobre como

tudo se desenrola aprofunda a comunicação do terapeuta de que os comportamentos do paciente fazem sentido – com base no passado, na biologia e no contexto atual. “Claro” que é assim: tem que ser! Validar a pessoa como um todo dessa maneira, ou validar quaisquer respostas comportamentais específicas, ajuda o paciente a se aceitar: “Eu estou bem”, “Eu posso fazer sentido”, “Meus comportamentos são compreensíveis”, “Eu não sou a pessoa terrível que pensei que era”, e “Não sou frágil demais para construir uma vida que valha a pena ser vivida”.

Como podemos ver nesta breve discussão, o terapeuta que se envolve nos princípios da aceitação (entrando em consciência do momento presente, reconhecendo a impermanência, abraçando a inter-relação e a vacuidade e mantendo a sensação de que as coisas são perfeitas como estão) tende a criar um contexto que é, em si, validador. As estratégias e todos os níveis de validação fluem naturalmente a partir dessa posição.

VALIDAÇÃO E O PARADIGMA DA MUDANÇA

A validação se encaixa perfeitamente no paradigma da aceitação, fluindo naturalmente a partir de seus princípios, como vimos. O que inicialmente não é tão óbvio é que o uso da validação na terapia também é crucial ao envolver o paciente nos princípios e nas estratégias do paradigma da mudança. Como discutido anteriormente, a validação equilibra as intervenções do paradigma da mudança, pois “lubrifica a máquina da mudança”. Além disso, há momentos em que a validação em si é usada para estimular a mudança.

O condicionamento clássico, discutido no Capítulo 4, direciona nossa atenção para um estímulo, uma emoção intensa e uma fuga comportamental. Esse modelo dá origem a estratégias para modificar ou evitar o estímulo (controle do estímulo) e para reduzir a resposta emocional ao estímulo (procedimentos de exposição). Esses procedimentos podem ser transformadores, mas também dolorosos para o paciente. A validação da dor emocional do paciente e da dificuldade de mudar sua resposta é fundamental para ajudá-lo a se engajar nos procedimentos. O terapeuta que está presente, alerta e validando durante um procedimento de exposição promove uma sensação de segurança e controle. E no caso especial em que o terapeuta valida uma emoção primária aversiva, levando o paciente a permanecer em contato com a emoção em vez de escapar, ele pode ajudar a melhorar a capacidade do paciente de experimentar e modular essa emoção.

O condicionamento operante direciona nossa atenção para o contexto do estímulo, um comportamento específico e suas consequências reforçadoras. Durante as sessões, o terapeuta tem consciência de usar a validação quando o paciente está usando comportamentos adaptativos e evitar a validação no momento em que ele se comporta de forma desadaptativa, porque a validação

geralmente funciona como um reforçador. Nesse sentido, a validação é usada como uma estratégia orientada para a mudança, como um procedimento de manejo de contingências para reforçar alguns comportamentos e não outros.

O modelo de mediação cognitiva direciona nossa atenção para a forma como certas crenças ou suposições, em resposta a um evento antecedente, desencadeiam certas emoções e ações. Podemos mudar a cadeia de eventos identificando e mudando certos elementos cognitivos repetitivos. Quando validamos uma crença ou suposição específica (p. ex., “não é de admirar que você acredite nisso; muitas pessoas acreditam”), esperamos fortalecer esse elemento cognitivo, esperando modificar as respostas cognitivas do paciente. Em outras ocasiões, falhamos intencionalmente em validar um pensamento, ou até mesmo o invalidamos deliberadamente, destacando que ele não é credível ou útil, esperando enfraquecer um pensamento no repertório da pessoa. É importante estar ciente do poder da validação em fortalecer alguns elementos da cadeia e enfraquecer outros, incluindo elementos cognitivos.

Da mesma forma que abordamos déficits de habilidades na cadeia do comportamento do paciente, validamos as causas e condições desses déficits. Caso contrário, destacá-los pode gerar vergonha e auto-ódio. Ao validar, ajudamos o paciente a ter uma apreciação equilibrada do déficit e da necessidade de habilidades. Nesse aspecto, a validação pode aumentar a motivação e o comprometimento. Além disso, especialmente considerando que estamos trabalhando com indivíduos que se invalidam devido aos seus ambientes anteriores, nossa validação de seus comportamentos ensina uma abordagem não julgadora, usando-a. Se o paciente puder adotar uma postura de autovalidação como resultado, teremos trazido mudanças comportamentais por meio do uso da validação. Por fim, a validação em si é ensinada como uma habilidade interpessoal importante na DBT, usada pelo paciente

como uma das várias habilidades que ajudam a manter bons relacionamentos, bem como no ensino do caminho do meio, no qual a validação é diretamente ensinada como uma prática entre membros da família.

VALIDAÇÃO E O PARADIGMA DIALÉTICO

A validação desempenha um papel vital ao usar o paradigma dialético para abordar e resolver oposições e posições rígidas. Tendo encontrado as posições opostas em meio à tensão, o terapeuta trabalha para validar o núcleo válido de cada lado. Isso prepara o palco para encontrar uma síntese dos dois lados. Ao trabalhar com a família de uma adolescente cujos comportamentos-alvo incluíam autolesão e abuso de substâncias, as sessões foram quase paralisadas pela tensão. A garota insistia que sua mãe a julgava, desaprovando-a, apesar do comportamento “adequado” da mãe na sessão. A mãe estava indignada por ser acusada de ser julgadora quando via suas sugestões à filha como úteis e de apoio. Como terapeuta, eu conseguia ver a validade de ambos os lados: a mãe claramente pretendia que suas sugestões fossem objetivas e úteis, mas, ao mesmo tempo, seu tom era sutil e persistentemente julgador. Quando o terapeuta pode ver ambos os lados, ainda é desafiador encontrar o caminho para movê-los em direção à síntese. Como a intensidade da garota estava aumentando, comecei por validar suas percepções, dizendo à mãe: “Não acho que você possa ouvir isso em sua própria voz, porque você está realmente tentando ajudar, mas ouço um tom distinto de desaprovação contida. Quando você disse a sua filha que seu comportamento era diferente do das outras meninas na festa, você provavelmente tinha razão de alguma forma, mas ao mesmo tempo soou julgadora, como se estivesse dizendo a ela que ela tinha feito a coisa errada”. A garota claramente se sentiu validada por mim. Ela se posicionou com mais confiança e sua desregulação emocional diminuiu. Enquanto isso, sua mãe parecia um pouco derrotada. Eu mudei para validar a mãe quando falei com a filha, dizendo: “Por mais que eu possa ouvir o julgamento na voz da sua mãe,

realmente não acho que ela percebe. Me parece que ela só quer ajudá-la a evitar reações dolorosas de seus amigos”. Encontrar a validade de cada lado e articulá-los moveu a conversa em direção a uma possível síntese: a mãe estava fazendo seu trabalho como mãe para ajudar sua filha a se comportar de maneira mais eficaz, mas ela apresentava suas observações em um tom que parecia julgador. A filha estava tentando estabelecer maiores independência e autorrespeito e, compreensivelmente, desafiou sua mãe, mas ao fazê-lo, desconsiderou suas intenções construtivas. A partir daí, pudemos trabalhar de forma que a interação honrasse ambos os lados.

Esse processo funciona da mesma forma quando há tensão entre paciente e terapeuta. O terapeuta, tomando uma visão objetiva da interação, tenta validar a posição do paciente, mesmo que ela seja oposta à sua. Uma vez que o paciente se sente compreendido e provavelmente mais bem regulado, o terapeuta pode passar a identificar a validade em sua posição: “Sabendo o que sei sobre você (validação dos níveis 1-3), certamente posso entender sua vontade de se recusar a preencher o cartão diário. Faz todo o sentido para mim (validação do nível 4)”. Além disso, é bastante comum que os pacientes queiram evitar o diário, por muitas razões (validação do nível 5): “Se eu fosse você, talvez também quisesse me recusar. Ao mesmo tempo, preciso das informações que vêm do cartão diário. Não há outra maneira de obtê-las com precisão, e tudo isso ajuda a melhorar a terapia”. O palco está montado para as duas partes encontrarem uma síntese.

O pensamento dialético é sistêmico e holístico, reconhecendo a complexa interação entre todas as partes. Cada entidade é parte de um todo maior, interconectado com outras entidades, e contém dentro dela partes menores, que também estão interconectadas. Quando validamos um indivíduo em um grupo ou família, podemos inadvertidamente invalidar outra pessoa na mesma reunião. É quase inevitável. Da mesma forma, ao validar um fenômeno em

um paciente individual, como seu pensamento, emoção ou ação, podemos estar invalidando simultaneamente outro pensamento, emoção ou ação. Por exemplo, se uma criança é intimidada na escola e sai correndo e chorando, podemos validá-la por deixar o local. Faz sentido. No entanto, em alguns casos, podemos estar invalidando simultaneamente outro aspecto da criança. Ao validar e reforçar o impulso de fugir, podemos estar invalidando suas capacidades de permanecer e enfrentar o agressor. Isso na verdade não é tão incomum. Há sempre tantas tendências em paralelo que, para validar efetivamente uma, precisamos estar cientes das outras que coexistem. Isso pode levar à validação de um fenômeno e, em seguida, de outro.

O pensamento dialético promove a consciência das transações. Não existe tal coisa como uma pessoa ou um comportamento fora de uma transação. Não existe tal coisa como uma intervenção que visa exclusivamente a um único elemento. Uma mudança em uma coisa causa uma mudança em outra. Se eu estou em um relacionamento com você e eu mudo, então você muda. Se eu estou sentindo que minha vida é terrível e, em seguida, algo pior acontece com você, minha vida pode não parecer tão ruim. Quando validamos um indivíduo, isso terá um impacto sobre outros indivíduos. Quando validamos um aspecto de uma pessoa, isso terá um efeito dominó em outros aspectos.

Eu estava atendendo uma mãe e seus dois filhos em terapia familiar. A vida tinha sido cruel com eles nos últimos anos. Quando os vi, cada um parecia estar julgando os outros com rigor. Nenhum dos três parecia ser capaz de validar qualquer um dos outros dois, como se cada um estivesse lutando por sua própria vida. Quando validei um dos meninos, imediatamente o outro apontou que eu não estava vendo seu irmão “como ele realmente é”. Quando validei a mãe em relação à dificuldade de ser mãe sob estresse excessivo, cada menino rebateu o que eu tinha dito explicando que sua mãe estava exagerando seus problemas para obter minha

simpatia. Para ser eficaz, tive que levar a transação em consideração. De fato, decidi encontrá-los individualmente para identificar a validade na perspectiva de cada um antes de reuni-los novamente. E tentei encontrar maneiras de validar cada um deles que não invalidassem os outros de alguma forma. Foi um desafio e um excelente exemplo da importância de ver a dialética da validação.

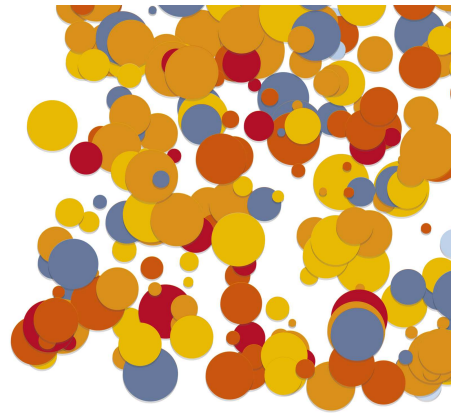
Ao validar, é sábio permanecer consciente de que tudo está sempre em fluxo. Tudo acabou de mudar e tudo está prestes a mudar. A validação é uma intervenção para o momento, reconhecendo algo válido agora e comunicando-o. A entidade a ser validada pode não estar presente na mesma forma daqui a um minuto, e, uma vez validada, não é mais a mesma. Se planejamos a validação com antecedência, o que é uma estratégia razoável em muitos casos, ainda precisamos adaptar o momento e a natureza de nossa validação às circunstâncias da ocasião. Uma validação específica pertence a este momento e não podemos esperar que esse momento dure. E não precisamos evitar uma oportunidade de validar por medo de estar reforçando algo que aconteceu anteriormente. Em minha unidade de internação de DBT, uma paciente perdeu o controle da raiva e ameaçou ferir outro paciente em uma manhã. Foi um momento dramático e assustador. No entanto, no mesmo dia, ela demonstrou gentileza notável em relação a outro paciente durante uma reunião. Um membro da equipe presente na ocasião desejava validar a habilidade dessa paciente em compreender e auxiliar efetivamente um colega, mas decidiu por não o fazer, receoso de que, ao validá-la, estaria de alguma forma compactuando com o comportamento ameaçador demonstrado por ela mais cedo naquele dia. Na verdade, é melhor para o paciente se abordarmos o comportamento problemático com intervenções, incluindo consequências, quando ele ocorre, e depois estarmos abertos e prontos para responder a

comportamentos posteriores com intervenções apropriadas, incluindo validação.

A maioria dos terapeutas acredita que sabe como realizar a validação corretamente. No entanto, em minha experiência como instrutor e supervisor, o erro mais comum dos terapeutas ao validar é não aceitar plenamente o paciente. Em outras palavras, o terapeuta tenta validar a resposta do paciente, mas, temendo que isso enfraqueça a motivação para a mudança comportamental, age de maneira um pouco hesitante. A validação é mais efetiva quando aplicada de forma completa. Naquele momento, o terapeuta deve oferecer a “validação genuína”, a aceitação total e, se for necessário promover a mudança comportamental, se dedicar 100% a esse objetivo em outro momento. Tentar equilibrar ambos os aspectos enfraquece os esforços em ambas as direções. A dialética não é a mesma coisa que um compromisso; ela envolve um comprometimento total com a ação da aceitação e com a mudança. É a essência da dialética em DBT. ▲

COMENTÁRIOS FINAIS

A validação é a manifestação mais pura dos princípios do paradigma da aceitação na DBT. Embora a maioria das pessoas pense que a validação é um conceito e uma prática completamente familiares, na verdade é muito mais complexa. Sua complexidade se torna óbvia quando a usamos na psicoterapia para tratar indivíduos com desregulação emocional, histórico de invalidação abrangente e tendência à autoinvalidação. Neste capítulo, revisei e illustrei muitos aspectos técnicos da validação (funções, definições, alvos e níveis) e depois considere as maneiras pelas quais a validação desempenha um papel na implementação de todos os três paradigmas na DBT. Manter a conscientização dos princípios de todos os três paradigmas leva a uma maior apreciação das oportunidades e limitações da validação e a um nível mais alto de precisão, fluidez e eficácia.



Estratégias dialéticas

A fim de preparar o terreno para esta discussão sobre o uso das estratégias dialéticas da terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*), é importante enfatizar que os três paradigmas centrais fornecem, cada um, uma fonte única de poder que pode ser utilizada em conjunto no intuito de ajudar o paciente a mudar sua vida e alcançar uma vida que valha a pena ser vivida. O paradigma da mudança oferece o *poder do propósito*. Seguindo esse paradigma, identificamos quais metas e alvos desejamos aumentar ou diminuir; asseguramos o comprometimento do paciente com essas metas, alvos e métodos de tratamento; avaliamos as variáveis que controlam cada comportamento-alvo; e organizamos para que o paciente monitore seus próprios comportamentos-alvo. Ensinamos novas habilidades, reforçamos habilidades antigas, estruturamos o tratamento para reforçar comportamentos funcionais, extinguimos e punimos comportamentos disfuncionais; modificamos suposições e crenças problemáticas; e, por meio de procedimentos de exposição, ajudamos o paciente a enfrentar sinais e emoções que foram evitados. O terapeuta conta com disciplina, direção, responsabilidade e monitoramento de divergências para utilizar o paradigma da mudança. Estratégias de comunicação irreverente apoiam o paradigma da mudança, assim como a tendência do terapeuta em usar estratégias de consultoria ao paciente em vez de intervir no ambiente em nome dele. No entanto, como discutimos, o paradigma da mudança é necessário, mas

insuficiente para obter sucesso no trabalho com desregulação emocional crônica e grave.

O paradigma da aceitação acrescenta o *poder da presença*. Utilizamos plenamente as riquezas de estar no momento presente, vendo e aceitando as coisas como elas são, sem julgamento, sem destino, percebendo a interdependência e a impermanência de todos os fenômenos e compreendendo que, como tudo é causado por tudo que veio antes, tudo está como deveria estar. Ao ver as coisas completamente no momento presente, nossa consciência se aguça, a compaixão flui naturalmente e a paciência se expande. Ao adotar esse paradigma, é possível utilizar estratégias de validação e comunicação recíproca, bem como intervenções no ambiente em nome do paciente, quando apropriado, em vez de apenas oferecer consultoria para ele. Ao combinar as abordagens de mudança e aceitação, ampliam-se as opções de intervenção. No entanto, é importante reconhecer que pressionar pela mudança pode muitas vezes gerar resistência, impasses e rupturas no relacionamento com o paciente, frustrando-o e invalidando-o. Em contrapartida, comunicar apenas aceitação pode gerar desesperança e desespero no paciente, que pode sentir que o terapeuta não está ajudando-o a mudar.

Aumentando e potencializando o *poder do propósito* e o *poder da presença*, está o paradigma dialético, que adiciona o *poder da improvisação*. Fortalecido pela compreensão de que este momento, por mais terrível que seja, é apenas um breve instante em um fluxo interminável de tempo; que o fenômeno atual doloroso e resistente, por mais angustiante e deprimente que seja, é dinamicamente interdependente com uma infinidade de fatores contextuais; que a trajetória atual, por mais destrutiva que seja, é apenas uma trajetória em transação com muitas outras; e que a verdade surge por meio da síntese de opostos, em vez de pelo triunfo de um; o terapeuta DBT tem acesso a uma série de estratégias improvisacionais. As estratégias dialéticas multiplicam

exponencialmente as vias de intervenção em direção à síntese, ao movimento, à velocidade, ao fluxo e às soluções criativas. As estratégias dialéticas fornecem uma série de manobras que podem ajudar a romper o impasse do momento e fazer as coisas se moverem novamente.

O terapeuta pode empregar as estratégias dialéticas específicas de maneira flexível, fluida e criativa se, simultaneamente, se mantiver ciente dos princípios do paradigma dialético. Ele pode combinar essas estratégias, já que, em princípio, elas se sobrepõem umas às outras, e pode oscilar entre elas e até desenvolver novas para os mesmos propósitos. Podemos ver uma analogia na aquisição de linguagem em humanos: devido à compreensão intuitiva e biologicamente baseada das crianças da estrutura profunda e das regras da linguagem (conforme os princípios), podem criar construções verbais que se adaptam ao momento e que nunca ouviram antes. Ao considerarmos cada uma das estratégias dialéticas designadas pela DBT e mais duas que considero úteis, podemos observar a relação com os princípios e a sobreposição entre eles, ainda reconhecendo que cada estratégia fornece seu próprio “sabor” dialético único que pode ser mais adequado para um impasse específico no tratamento. Ao considerar as várias estratégias, tenha em mente que elas não são pensadas como estratégias de mudança comportamental; em vez disso, aumentam a solução de problemas, criando movimento, velocidade e fluxo, e mudando trajetórias e desequilibrando criativamente certos dilemas rígidos. Depois de listar todas as estratégias dialéticas do manual de tratamento, começo com a aplicação mais direta dos princípios dialéticos, a estratégia de equilibrar as estratégias de tratamento.

1. Equilibrar estratégias de tratamento
2. Fazer dos limões uma limonada
3. Evocar a mente sábia

4. Interpretar o papel de advogado do diabo
5. Estender
6. Entrar no paradoxo
7. Permitir a mudança natural
8. Usar metáforas
9. Usar a avaliação dialética

EQUILIBRAR ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO

Começamos com a aplicação mais direta dos princípios dialéticos: equilibrar as estratégias de tratamento. Em particular, essa estratégia refere-se ao emparelhamento de uma estratégia orientada à aceitação com uma orientada à mudança, seja simultânea (em paralelo) ou sequencialmente em uma proximidade temporal próxima. Utilizamos a oposição natural entre aceitação e mudança, inerente à realidade. Além dessa manobra estratégica específica, a síntese da aceitação pura com a mudança pura é o tema subjacente em todas as estratégias dialéticas.

Uma vez atendi uma paciente que, ao entrar no meu consultório para cada sessão, ficava perto da porta e se recusava a sentar até anunciar que estava furiosa comigo, que odiava algo que eu havia dito ou feito (ou não dito ou não feito). Em geral, ela concluía insistindo que não poderia continuar o tratamento comigo até que o problema fosse resolvido. Embora sua raiva fosse compreensível, dado os incidentes mencionados (eu poderia imaginar que o que havia dito poderia tê-la ofendido, ferido seus sentimentos ou a decepcionado), a natureza extrema de sua resposta com frequência parecia desproporcional à gravidade relativamente leve da minha ofensa. Seus comentários eram dramáticos. Parecia “exagerado”, drástico e não oferecia o tipo de expressão de raiva que poderia levar a uma discussão. Sua atitude bloqueava o envolvimento ou a solução.

Primeiro, usei várias estratégias orientadas para a mudança de maneira sequencial. Destaquei a natureza problemática de sua comunicação e esclareci que, mesmo que ela estivesse tecnicamente correta sobre mim, seu comportamento, em vez de abrir uma porta para o diálogo, estava fechando-a. Convidei-a a começar de novo e expressar suas emoções, mas com uma abordagem mais habilidosa. Tentei descobrir qual era seu objetivo

ao gritar comigo. Insisti veementemente que ela parasse de falar comigo daquela maneira e pedi que se sentasse e me contasse como se sentia. Tentei reforçar qualquer esforço que ela fizesse para se envolver comigo na solução de problemas. Perguntei em voz alta que tipo de pensamentos ou suposições informavam sua apresentação intensa. Pedi-lhe para observar e descrever suas emoções o mais precisamente possível. Esses esforços quase não aumentaram a colaboração, a comunicação habilidosa ou a autorreflexão. Ela não estava aberta a questionamentos ou mudanças; ela expressou sua convicção de que eu a havia ferido, o que tornava sua resposta totalmente apropriada, e sugeriu que eu nunca deveria fazer isso (seja lá o que fosse) novamente ou então ela não poderia continuar o tratamento comigo.

Quando não houve progresso na solução de problemas orientada para a mudança, decidi mudar para os princípios e estratégias do paradigma da aceitação. Abandonei temporariamente a agenda de mudança e procurei validar as respostas da paciente, comunicando-me com gentileza, autenticidade, compaixão e uma dose de autoexposição. Eu apenas ouvi, tentei permanecer presente e prestei atenção cuidadosa às suas palavras, seus gestos, expressão facial, tom de voz e às minhas próprias respostas internas. Tomei cuidado para não contestá-la ou sugerir que ela precisava mudar algo em sua abordagem. Fiz o que pude para permitir que ela se expressasse do início ao fim, na esperança de que, ao se sentir ouvida e compreendida, sua reatividade emocional diminuiria e ela agiria de maneira mais habilidosa. Em vez disso, suas declarações exageradas continuaram, como se ela fosse insensível à validação. Pareceu-me quase como se suas emoções estivessem intensificadas. Então, ela de repente se recolheu em sua concha, sentando-se quieta e desesperançosa diante de mim.

Insistir na mudança agravou ainda mais seu estado, assim como deixar a mudança de lado e usar vários níveis de validação.

Eu estava perplexo. Essa é a espécie de circunstância que levou Linehan a importar o pensamento e as estratégias dialéticas para a DBT. Reconhecendo que estávamos presos, tentei encontrar uma síntese do uso de estratégias de mudança e aceitação no momento, improvisando enquanto avançava. Acho difícil nomear os passos pelos quais se entrelaçam aceitação e mudança em um momento como esse. Não tenho outra fórmula além de permanecer sintonizado com o paciente, aceitar verdadeiramente sua reatividade, sem julgamento, manter a convicção de que as coisas precisam mudar e prosseguir com a mente aberta. Continuei essa postura por mais duas sessões, ambas começando da mesma maneira disfuncional. Finalmente, no início da terceira sessão desse tipo, encontrei, por tentativa e erro, o “ponto ideal”: uma intervenção que sintetizava aceitação e mudança e que foi mais frutífera. Comecei a sessão com um estado de espírito mais relaxado, talvez mais disposto a improvisar e sem um roteiro em mente. Eu havia chegado a um lugar em meus sentimentos sobre ela que era ao mesmo tempo compassivo e firme. Enquanto ela estava na porta, me enchendo de raiva novamente, parecendo estar completamente exasperada comigo e, ao mesmo tempo, um pouco distante ou desapegada, falei com ela com firmeza. “Quero que você se sente agora mesmo e me ouça. Tenho algo a dizer para você.” Ela agiu como se estivesse surpresa, talvez até um pouco assustada comigo. Parou seu discurso e se sentou. Continuei. “Você está fazendo isso de novo. Você entra na sessão, sem ter tido contato comigo desde o último encontro, fica na porta e desabafa comigo, parecendo um personagem de desenho animado com raiva. Você faz isso de uma forma meio distante, como se não tivéssemos um relacionamento humano real. Sabe de uma coisa? Nós *temos* um relacionamento e, fora esses episódios, é realmente bom. Eu trato você como uma pessoa e você me trata como uma pessoa; você é muito inteligente e muito simpática, e é realmente bom. Mas quando você fica chateada comigo (o que

está tudo bem) e começa a sessão como fez hoje, é algo totalmente diferente, algo quase irreal. Você entende o que eu quero dizer?”

Ela ficou atônita e não falou de imediato. Depois perguntou: “É realmente como se fosse um desenho animado?”. Eu respondi: “Realmente é. Quando você fala comigo dessa maneira, é como se estivesse falando com algum tipo de objeto inumano. Você fala *para* mim, não *comigo*. Sei que há muitos motivos para estar chateada comigo – não estou negando isso, nem dizendo para suprimir esses motivos, estou apenas pedindo que você reconheça que há outra pessoa aqui com você, alguém que sente, pensa, se importa e reage. Só quero que você fale comigo”.

Em seguida, prosseguimos de uma forma mais humana e conectada. Com o tempo, pudemos avaliar sua “raiva em estilo de desenho animado”, que, como se descobriu, ajudou-a a escapar de emoções persistentes de vergonha de que algo estava realmente muito errado com *ela*. Ao refletir sobre minha intervenção, acho que funcionou porque encontrei uma maneira de pedir com firmeza uma mudança comportamental, ao mesmo tempo em que permanecia humano, genuíno e atencioso. Consegui insistir em melhorar nosso relacionamento no contexto de destacar como ele já era bom.

Na maioria das vezes, *equilibrar estratégias de tratamento* é mais simples do que este exemplo, felizmente. Por exemplo, o terapeuta pode dizer: “Percebo que você se sente dessa forma, e isso faz muito sentido (validação); mas quero que você expresse isso de maneira diferente, de uma maneira que funcione (pedindo por mudança)”. A justaposição rápida ou simultânea de aceitação e mudança costuma ser o suficiente e ajuda a encontrar o equilíbrio que atende à necessidade do indivíduo por aceitação e mudança simultaneamente. Seja um exemplo desafiador ou mais fácil, estou convencido de que o segredo dessa estratégia de *equilibrar estratégias de tratamento* é que o terapeuta tenha um pé

firmemente ancorado na aceitação e o outro firmemente ancorado na mudança e mantenha um bom contato com o paciente.

FAZER DOS LIMÕES UMA LIMONADA

Mesmo antes de os terapeutas estudarem DBT, a maioria já está familiarizada com essa estratégia dialética. *Fazer dos limões uma limonada* é um provérbio onipresente em nossa cultura, referenciado quando procuramos oportunidades em uma crise; outras metáforas para a mesma ideia incluem ver sol após uma tempestade ou o ditado “quando uma porta se fecha, outra se abre”. Qualquer que seja a metáfora, ela representa um espírito de esperança ao reformular uma experiência negativa ou vê-la de outro ângulo. Dada a natureza transacional da realidade e o ponto de vista sistêmico que faz parte da dialética, sempre podemos ver que um fenômeno está em transação com outro. Uma perspectiva negativa está em transação com uma positiva; uma perspectiva estreita está relacionada a uma mais ampla.

Em DBT, há inúmeras oportunidades para *fazer dos limões uma limonada*. Com o paciente que se recusa a preencher um cartão diário, o terapeuta pode começar com uma avaliação, passar para a validação do desejo de evitá-lo e depois seguir para a solução de problemas das variáveis controladoras associadas à não conformidade com o diário. Se o padrão persistir, o terapeuta pode “ser dialético”, *fazendo dos limões uma limonada*: “Na verdade, é perfeito se você continuar a não preencher o cartão diário, porque podemos fazer a ‘terapia do diário’ pelo tempo que for necessário. Como preenchê-lo é tão semelhante a tantas outras tarefas desinteressantes, mas essenciais na vida, qualquer progresso que façamos neste problema pode ajudá-lo em outras áreas”. Observe que, nessa estratégia, o terapeuta transmite aceitação e endosso do comportamento problemático, juntamente à insistência paciente, mas implacável, em mudar.

Muitas vezes, o impasse, o bloqueio ou a paralisia ocorrem dentro de uma visão restrita, limitada e sufocante da realidade

momentânea, como se o indivíduo estivesse em um quarto muito pequeno sem portas ou tivesse rastejado por um túnel e ficado preso. O terapeuta reconhece e “aceita” a visão restrita do paciente, mas depois comunica uma perspectiva mais ampla sobre espaço, tempo e/ou contexto. O terapeuta pode sentir como é para o paciente estar no quarto pequeno sem portas ou preso no túnel incapaz de se mover, mas não está limitado a essa perspectiva. Ele pode manter a consciência de que este momento é apenas um instante passageiro no tempo, por mais terrível que seja. Ele pode perceber que na verdade existem várias portas pelas quais o paciente poderia sair do quarto pequeno. Por mais convencido que o paciente esteja sobre sua visão restrita da realidade, o terapeuta percebe que ele está em transação e que ele (e outros) pensa de forma bastante diferente. O terapeuta sabe que existem muitas maneiras de sair da armadilha e confia que a visão estreita do paciente será alterada à medida que interage com uma visão mais ampla. Quando o paciente chega ao ponto de ver apenas “limões”, o terapeuta pode imaginar várias receitas de “limonada”.

Resolver problemas dolorosos com pacientes (episódios de comportamento suicida, episódios dissociativos, comportamentos que interferem na terapia, comportamentos relacionados ao uso de substâncias, e assim por diante) sempre tem um lado positivo, pois codifica a memória de resolver um problema difícil, que pode servir como plataforma ou modelo para futuros esforços de solução de problemas. Reparar uma interrupção terrível no relacionamento terapêutico pode prenunciar um relacionamento mais forte e um conjunto de habilidades aprimorado para resolver outros problemas de relacionamento. Chegar atrasado à terapia oferece a oportunidade de resolver a questão do atraso ou aprender com ela. A experiência dolorosa de perder um namorado pode abrir a possibilidade, em alguns casos sem precedentes, de aprender a enfrentar problemas sem depender completamente de outra pessoa. A lista continua e, se um terapeuta tem uma mentalidade

de *fazer dos limões uma limonada*, isso pode ser interpolado naturalmente, de forma fluida e quase imperceptível na interação terapêutica de maneira a permitir movimento e improvisação contínuos.

Um problema potencial com essa estratégia é que ela é fácil demais de usar. O terapeuta pode se tornar hábil em apontar a possível “limonada”: isso pode soar quase banal e, portanto, ser menos eficaz. Às vezes, essa estratégia serve a uma função autoprotetora para o terapeuta, que encontra uma maneira de enquadrar e desviar a dor do paciente, sem realmente ter absorvido o grau da dor. Duas entregas das mesmas palavras exatas ao aplicar a estratégia de fazer dos limões uma limonada, usadas no mesmo contexto com o mesmo paciente, mas por terapeutas diferentes, podem ser completamente diferentes. Em um caso, o esforço para extrair oportunidades de uma crise impede que o terapeuta reconheça o sofrimento; o paciente então sente como se o terapeuta o estivesse tratando de maneira trivial e dispensável. No caso em que o terapeuta claramente “entendeu” (entrou no inferno com o paciente e pode ver o quão ruim é), ele pode oferecer a mesma intervenção de “oportunidade a partir da crise”, e o paciente, sentindo a compaixão, está mais disposto a considerar outro ângulo. Ao usar estratégias dialéticas como essas, que têm o potencial de deixar o paciente se sentindo “enganado” ou desconsiderado, se depende muito da profundidade, da sinceridade e da integridade do relacionamento – das quais a maior parte é comunicada implicitamente e ao longo do tempo.

Algumas das utilizações mais eficazes da estratégia de fazer dos limões uma limonada acontecem sem uma declaração explícita sobre essa abordagem. O paciente pode estar compartilhando as profundezas de seu desespero, possivelmente a convicção de que o suicídio é a única saída ou que usar drogas ilícitas é a única maneira de sobreviver. O terapeuta está ouvindo

com compaixão, sem julgamento, servindo como testemunha do lado sombrio da experiência do paciente. A essência subjacente dessa estratégia baseia-se no fato de que, mesmo ao absorver a terrível circunstância ou o desespero do paciente, o terapeuta mantém a capacidade de ter uma perspectiva mais ampla, uma atitude mais esperançosa e uma convicção de que algum tipo de significado ou progresso pode surgir da circunstância. Ele acredita que navegar com sucesso pelo desespero pode trazer ao paciente ferramentas valiosas. De certa forma, o terapeuta está praticando a estratégia de fazer dos limões uma limonada em sua própria mente; ele abre seu coração e sua mente para o desespero do paciente, mas mantém a capacidade de imaginar e encontrar a limonada. A estratégia de fazer dos limões uma limonada não precisa ser dita como tal; se o terapeuta puder experimentar a “limonada” enquanto estiver em contato com os limões do paciente, isso pode proporcionar uma abertura dialética sem palavras que sintetiza o desespero com a possibilidade.

EVOCAR A MENTE SÁBIA

Em um popular programa de perguntas e respostas da televisão estadunidense, quando os participantes se deparam com uma pergunta desafiadora e não têm certeza da resposta, eles podem usar uma “ajuda” e telefonar para um amigo. Na DBT, *evocar a mente sábia* é a opção equivalente. Quando tanto o paciente quanto o terapeuta estão presos e não sabem para que lado se virar, o terapeuta pode direcionar o paciente a acessar sua mente sábia para uma perspectiva mais astuta (e, também, o terapeuta pode, e deve, tentar evocar a mente sábia em si mesmo). É claro que o pré-requisito é o paciente ter adquirido e praticado a habilidade de *evocar a mente sábia*, que é ensinada no grupo de treinamento de habilidades e pode ser ensinada na terapia individual. O terapeuta pode dizer algo tão simples quanto: “O que você acha que a mente sábia diria sobre isso?”.

No meio de uma sessão difícil, minha paciente de 34 anos ficou muito frustrada comigo. Nada parecia ajudar. Ela começou a se levantar e ficou claro que pretendia sair da sessão. Ciente de que seu impulso para sair era forte e que eu provavelmente não mudaria sua mente naquele momento, usei a *evocação da mente sábia* para provocar uma breve pausa e catalisar uma reflexão adicional no momento.

Eu disse: “Vejo que você está saindo e não vou tentar impedi-la, mas posso lhe fazer uma pergunta antes de ir?”.

Ela gritou de volta para mim: “O quê!?”.

“Eu só quero saber se, ao decidir sair, você está na mente racional, mente emocional ou mente sábia.”

Ela foi definitiva: “Você sabe muito bem que estou na mente emocional!”.

“Posso te fazer mais uma pergunta então?”

De novo: “O quê?”.

“Se você estivesse na mente sábia, o que você acha que faria?”

Sua resposta foi imediata: “Eu simplesmente ficaria aqui sentada e diria o quão idiota você é!”.

Apenas agradei e ela saiu, embora com um momento de hesitação. Isso não a impediu de sair da sessão, mas, do meu ponto de vista, foi um passo significativo para ajudá-la a expressar diretamente sua raiva. Nós poderíamos trabalhar nesse passo mais tarde.

Essa habilidade é um antídoto perfeito para o processo de pensamento estreito, rígido e dicotômico que pode acompanhar facilmente a crescente pressão e o conflito entre polos opostos. Comportamentos disfuncionais surgem desse tipo de impasse e oferecem uma maneira estruturada de “apertar o botão de pausa” e convidar os pacientes a buscarem dentro de si uma resposta mais complexa e ponderada. É como se o paciente dissesse: “Minhas emoções são muito intensas, as escolhas são poucas, é uma emergência e preciso excluir informações complexas e evitar pensamentos cuidadosos”. E é como se o terapeuta afirmasse: “Entendo que suas emoções são intensas e seus impulsos são fortes, mas quero que você faça uma pausa por um momento e considere qual seria a sua ‘resposta da mente sábia’ para esta situação”.

No meio de uma sessão familiar, um garoto de 15 anos chamado Josh se sentiu encurralado. Sua mãe estava sentada em silêncio, mas seu pai o acusava com raiva de sair de casa à noite para fumar maconha com os amigos e ameaçava mantê-lo em casa durante todo o ano letivo. Embora houvesse alguma verdade nas suspeitas, o garoto sentia que seu pai estava sendo injusto. Do ponto de vista de Josh, o pai era controlador, abusivo e tornava quase impossível relaxar em casa à noite. Ele disse que tentava se comportar em casa para que o pai não gritasse com ele e, em seguida, precisava de uma “válvula de escape para o estresse”, que encontrava fumando maconha. Apesar de argumento de Josh

ser razoável, seu pai ficou ainda mais enfurecido, insistindo para que o filho revelasse onde conseguia a maconha e onde a escondia. Josh também se exaltou: “Você é um hipócrita! Você não quer que eu use a única coisa que me dá algum alívio, mas bebe cerveja todas as noites!”. Cada parte estava aumentando a tensão, e Josh e seu pai afirmavam posições cada vez mais rígidas. Pai: “Você vai ficar de castigo o ano todo”. Josh: “Se você não me quer aqui, é só me dizer – simplesmente saio de casa e vou morar na rua!”. Eu me vi preso, incapaz de encontrar uma intervenção útil.

As coisas estavam piorando. Eu tive que intervir. “Pessoal! Pausa! Não estamos chegando a lugar nenhum. Essas não são boas soluções. São extremas. Quero que todos nós paremos um pouco. Vocês todos sabem o que é a *mente sábia* a partir do treinamento de habilidades para familiares. Quero que façamos um intervalo. Se separem por cinco minutos e façam o que for preciso para entrarem em contato com a mente sábia. Depois, vamos voltar a isso.”

Foi uma intervenção difícil de fazer. Eu não tinha ideia do resultado. Tanto o pai quanto o filho pareciam zangados comigo por interromper a discussão. Eles me olharam como se a ideia de parar e localizar a mente sábia fosse estúpida. Esses tipos de intervenções exigem que entremos de cabeça e prossigamos com ousadia e esperança, sem saber se ajudarão, tolerando as dúvidas do(s) paciente(s). Depois de entrar em uma intervenção como essa, é melhor tentar fazê-la “até o fim”.

Josh perguntou se poderia dar uma caminhada e eu concordei, desde que ele voltasse em cinco minutos. Os pais se sentaram em silêncio. A mãe olhou melancolicamente pela janela. Josh retornou em cinco minutos. Continuamos. Agradei a todos por tentarem fazer isso funcionar e disse que sabia que todos queriam que as coisas melhorassem. Perguntei se algum deles tinha conseguido uma perspectiva da mente sábia. Pela primeira vez desde que a sessão começou, a mãe de Josh falou. Ela estava cheia de

emoção. “Estou tão triste com o fato de isso virar uma briga. Acho que todos estamos com medo. Estamos com medo de que Josh esteja tomando algumas decisões ruins. Só não queremos que ele arruíne sua vida. Estamos preocupados e não sabemos o quanto devemos nos preocupar. E acho que é natural que Josh não queira ser controlado; ele só quer tomar suas próprias decisões. Eu não acho que ele realmente queira sair de casa, e mantê-lo em casa por um ano é demais.” Ela se virou para o filho, chorando: “Querido, nós te amamos muito. Sinto muito que as coisas não estejam confortáveis em casa. Só não queremos que você tome decisões ruins. E estou tão triste por estarmos em uma batalha como esta. Tão triste”. Sua sinceridade foi desarmante. Ela se virou para o marido. “Querido, eu sei que você ama o Josh, mas às vezes acho que está tentando controlá-lo um pouco demais. Nós tínhamos muito mais independência quando tínhamos a idade dele; ninguém nos vigiava tão de perto. Cometemos nossos erros. Ele precisa cometer alguns dos seus próprios erros.” Enquanto o desacordo continuava, a pausa e o equilíbrio e a autenticidade da mãe acalmaram as chamas e prepararam o terreno para uma negociação mais produtiva.

Embora geralmente enfatizemos o que a intervenção pode fazer para ajudar o paciente a encontrar equilíbrio e síntese, às vezes isso é muito valioso para o terapeuta. Ao tentar *evocar a mente sábia*, permitindo algum tempo e espaço no meio de um momento estagnado, os terapeutas também têm a chance de pausar, recuar e tentar localizar sua própria mente sábia. O *mindfulness* é valioso de forma abrangente na DBT para a regulação de pacientes e terapeutas, e evocar a mente sábia é a técnica dialética para inserir o *mindfulness* no momento acalorado presente.

INTERPRETAR O PAPEL DE ADVOGADO DO DIABO

Com essa estratégia, o terapeuta surpreende o paciente defendendo a “posição do diabo”. Assim como o paciente defende a posição pró-tratamento, dizendo o que acha que o terapeuta quer ouvir, o terapeuta assume a posição oposta. Isso geralmente ocorre quando o terapeuta e o paciente estão discutindo se o paciente está disposto e pronto para se comprometer com o programa de tratamento ou com uma expectativa específica dentro dele. Assustado e desanimado com a perspectiva, o paciente inicialmente se recusa a se comprometer. O terapeuta usa estratégias de comprometimento. De repente, o paciente parece superar suas dúvidas, dizendo algo como: “Eu vou fazer isso, vou me comprometer com o tratamento pelo próximo ano para abandonar a autolesão e o suicídio. Ok? Eu vou fazer isso”. Apesar do aparente impulso em direção ao comprometimento, o terapeuta tem suas dúvidas. Afinal, não é esse o paciente que, há apenas alguns minutos, não conseguia imaginar assumir um compromisso? Não é ele que, apesar de afirmar se comprometer agora, no passado não conseguiu manter tais intenções? E não parece um pouco que o paciente está apenas dizendo essas palavras para tirar o terapeuta de suas costas? O terapeuta vira a mesa. Ele pula para o outro lado e desafia a disposição declarada do paciente. “Você tem certeza de que quer entrar nisso? Você se lembra de que isso vai ser difícil, uma das coisas mais difíceis que já fez? Tem certeza de que não quer mais tempo antes de se comprometer com algo assim?” Se funcionar, o paciente então diz algo como: “Eu tenho que fazer isso – as coisas estão realmente ruins na minha vida e eu não tenho muita escolha”. O terapeuta fortaleceu o compromisso do paciente ao ser o *advogado do diabo*.

Essa estratégia dialética deve ser usada com sutileza e perspicácia. O terapeuta, reconhecendo que o paciente está superficialmente resolvendo a ambivalência ao afirmar se comprometer, divide-se em duas partes: a parte que deseja reforçar qualquer indício de comprometimento e a parte que desafia a profundidade do comprometimento. O terapeuta seria imprudente em aceitar a declaração de comprometimento do paciente se parecer exagerada. Por outro lado, se o terapeuta simplesmente argumentar com sucesso contra o comprometimento, ele pode convencer o paciente de que será muito difícil. O terapeuta precisa encontrar o caminho do meio entre essas duas posições. O paciente deve perceber que o terapeuta está argumentando contra assumir um comprometimento, mas ao mesmo tempo sentir que ele está promovendo-o.

Embora comumente usado para fortalecer o comprometimento, o *advogado do diabo* também pode ser usado em outros contextos. Eu atendi um jovem que morava com os pais e nunca havia morado sozinho; uma das metas do tratamento era estabelecer uma vida independente. Ele afirmava repetidamente que queria ser autônomo em relação aos pais, mas não tomava as medidas necessárias para que isso acontecesse. Seguindo sua liderança, trabalhei com ele para resolver os problemas, mas não progredimos para que ele morasse fora da casa dos pais. Validei seus medos de independência e a evitação das etapas necessárias. Ainda assim, não houve movimento. Enquanto isso, seus pais estavam em conflito entre si sobre a dependência deles em relação ao filho, e frequentemente discutiam. Percebendo o quão presos estávamos, mudei para a estratégia do *advogado do diabo*. Argumentei que ele deveria deixar de lado suas esperanças de independência por enquanto. “Percebi que suas intenções de sair de casa vêm em um momento ruim para seus pais. Eles estão discutindo muito, parecem infelizes juntos e acho que precisam de

você em casa para mediar os conflitos. Os problemas deles podem levar anos para serem resolvidos, se é que serão resolvidos, mas como filho deles, é seu trabalho ajudá-los.”

Ele imediatamente rebateu: “Mas você está me pedindo para adiar minha vida para ajudá-los, e nem sabemos se isso ajudará”.

Continuei defendendo o “diabo”: “Sim, entendo o que você está dizendo, mas você não pode ficar com eles pelo menos mais dois anos para que possam se reorganizar?”.

Ele respondeu: “Mas são dois anos da minha vida, e eu já estive lá por muito tempo”. Ao virar a mesa, argumentando contra a independência, sua determinação em sair de casa foi fortalecida. Ele então estava na posição de me convencer de que *deveria* sair de casa, o que proporcionou mais impulso do que antes. Alguém pode levantar uma questão sobre esse tipo de intervenção paradoxal na DBT. Afinal, como seu terapeuta, eu realmente não queria que ele ficasse com os pais por mais dois anos. Parece ser antitético à postura radicalmente genuína que caracteriza a DBT. O problema é relativamente menor se, de fato, 1) o terapeuta se preocupa e respeita o paciente, 2) vê o resultado como muito importante e 3) esgotou outras intervenções para efetuar o resultado. É uma intervenção manipuladora, virando a mesa para fazer o paciente reconsiderar sua evitação em se mover em direção à independência. Qualquer dano à integridade do relacionamento pode ser reparado depois do fato se o coração do terapeuta estiver no lugar certo. Ocasionalmente, há uma tensão, uma dialética, entre duas prioridades da DBT; nesse caso, a prioridade em cumprir a meta acordada a serviço de construir uma vida que valha a pena ser vivida e a prioridade de ser radicalmente genuíno. A síntese é ser radicalmente genuíno ao *interpretar o advogado do diabo* com base no profundo cuidado com a vida do paciente.

Tendo revisado quatro das estratégias dialéticas, fica claro que cada uma oferece um sabor diferente da mesma intervenção. Em

cada caso, quando ficamos presos na terapia, reconhecemos que a realidade atual é composta por elementos opostos e contraditórios. Qualquer energia em direção ao movimento terapêutico é cancelada. Ao mudar nossa posição, onde nos posicionamos em relação à polarização (*equilibrar estratégias de tratamento, fazer dos limões uma limonada, evocar a mente sábia ou interpretar o advogado do diabo*), interrompemos a polarização rígida, liberando energia e movimento, o que então pode, esperançosamente, resultar em uma nova e mais viável realidade. Eu continuo a demonstrar essa fórmula de diferentes maneiras nas estratégias dialéticas restantes.

ESTENDER

É apenas um pequeno passo do *advogado do diabo* para *estender*. Ambas as estratégias são aplicadas a uma situação em que o paciente está preso em um padrão improdutivo ou destrutivo e em ambas o terapeuta pula para o lado inesperado do argumento. O terapeuta usa a extensão quando está trabalhando com uma situação em que o paciente emite algum tipo de ameaça para se envolver em um comportamento problemático. Por exemplo: “Quero sair do tratamento agora”, “Não quero mais ir trabalhar”, “Quero me matar”, “Eu deveria apenas parar de lutar contra meus desejos e me drogar o quanto eu quiser”. Mas o terapeuta tem a impressão de que o paciente não está realmente e profundamente comprometido com essas posições patológicas. Seu palpite é que a pessoa está usando ameaças como uma maneira de expressar emoções fortes. O paciente diz: “Quero desistir da terapia”, mas o terapeuta sente que essa não é a verdadeira intenção, mas sim uma comunicação dramática de descontentamento com o terapeuta. O paciente diz: “Acho que preciso passar alguns dias no hospital”, mas o terapeuta sente que essa “ameaça” é uma forma de pedir ao terapeuta que leve seu sofrimento mais a sério. O paciente está desafiando o terapeuta e espera que ele se oponha ou, pelo menos, questione as ameaças: “Você realmente não quer desistir da terapia” ou “Não acho que você precise ir para o hospital – vamos trabalhar de outra maneira para construir segurança”. Mas, tendo já tentado resolver problemas de maneira direta e com validação, o terapeuta adota uma postura surpreendente, *estendendo* a ameaça do paciente para além do que foi declarado. “Você quer desistir da terapia comigo? Ok, tenho uma lista de indicações; vamos encontrar um bom terapeuta para você.” Ou: “Você precisa passar algum tempo no hospital? Vamos encontrar um ambiente de longo prazo – talvez seja essa a

maneira de suprir suas necessidades”. Se o terapeuta avaliar corretamente a situação, é provável que o paciente se oponha à proposta de estender a ameaça para além da sua zona de conforto. “Você sabe que eu não quero desistir da terapia! Estou apenas muito bravo com você.” Ou: “Não preciso passar muito tempo no hospital! Preciso ter mais apoio na minha vida!”. Se o terapeuta encontrar o equilíbrio certo, aceitando e *estendendo* a ameaça do paciente enquanto a desafia implicitamente, assumindo uma posição mais disfuncional do que a do paciente, pode resultar no argumento do paciente por uma posição mais funcional. Ao mudar o alinhamento das forças entre disfunção e funcionalidade, novas oportunidades podem surgir. Como abordei sobre o aparente sacrifício da genuinidade radical na interpretação do *advogado do diabo*, a *extensão* também é manipulativa. Novamente, o aspecto manipulativo parece necessário se outras intervenções não ajudarem, e, se feito com preocupação sincera e respeito pelo paciente, as consequências negativas para o relacionamento são facilmente reparadas.

A *extensão* nem sempre é uma resposta adequada às ameaças ou intenções disfuncionais. Se o paciente não está ambivalente quanto à ameaça, *estendê-la* pode apenas reforçar a resposta disfuncional. No contexto que exige o uso da extensão, o terapeuta deve estar ciente de dois elementos: 1) o paciente comunica uma ameaça manifesta ou intenção disfuncional, mas 2) a ameaça manifesta funciona para comunicar e disfarçar uma agenda latente. Por exemplo, a ameaça manifesta pode ser desistir da terapia; a agenda subjacente pode ser a comunicação de raiva com o terapeuta. Ou, a ameaça manifesta pode ser o anúncio de um paciente de 15 anos que está saindo de casa para morar nas ruas; a agenda subjacente é comunicar que ele não está sendo levado a sério ou cuidado em casa. Se o terapeuta simplesmente trabalhar com a ameaça manifesta com estratégias de solução de problemas, ele perderá a agenda latente e perpetuará o impasse.

Se tentar abordar a agenda latente diretamente (“Acho que você está com raiva de mim e é por isso que está ameaçando me deixar”), o paciente nega e fortalece a ameaça manifesta. Ao *estender* a ameaça, o terapeuta aparenta apoiar e até mesmo amplificar a ameaça manifesta, mas está realmente precipitando um desequilíbrio ao virar a mesa. Se funcionar corretamente, o paciente pode agora declarar a agenda subjacente. O terapeuta diz: “Vamos tirar você dessa casa e seguir em frente; devemos olhar para alguns abrigos para moradores de rua onde jovens de 15 anos possam morar?”. O paciente é pego de surpresa, para de argumentar sobre sair de casa e pode contra-argumentar: “Eu não quero de fato sair de casa! Eu apenas odeio estar lá!”. Agora o terapeuta e o paciente podem mudar para a solução de problemas sobre o ambiente doméstico.

Se o terapeuta está compreensivelmente frustrado com o paciente e se tornou emocionalmente desregulado e desequilibrado, a *extensão* pode falhar. A sugestão de que faça algo ainda mais patológico do que está ameaçando fazer pode parecer uma rejeição e um truque do terapeuta. Essa estratégia, como outras estratégias dialéticas, bem como as estratégias de comunicação irreverente da DBT, deve ser usada por um terapeuta que está fundamentado na compaixão e consideração pelo paciente, se sente emocionalmente equilibrado no momento e pode ler com precisão sua ambivalência.

ENTRAR NO PARADOXO

As pré-condições para usar efetivamente a próxima estratégia são: 1) o paciente está preso em um padrão rígido de pensamento, ação e/ou emoção; e 2) o terapeuta, olhando de uma perspectiva mais ampla, consegue ver uma maneira alternativa, até contraditória, de entender esse padrão. Então, o terapeuta reformula o padrão rígido do paciente, geralmente de maneira objetiva, sem mais explicações, o que o atinge como absolutamente errado ou impossível. Por exemplo, trabalhei com uma paciente hospitalizada que, embora determinada a desistir de seu comportamento de autolesão, não teve sucesso em fazê-lo. Ao explicar por que ela não conseguia desistir do comportamento, um fator citado foi que não suportava a solidão de administrar a vida de forma independente. Sua convicção rígida era que ela “deveria” ser independente, o que significaria lidar com tudo sozinha. Eu lhe disse: “Sua coragem é admirável, mas você não sabe que, para ser verdadeiramente independente, você precisa depender profundamente dos outros?”. Ela ficou quieta e parecia um tanto intrigada ou confusa. Por mais tentado que eu estivesse em explicar o que queria dizer, permaneci calado. O valor dessa estratégia depende, em parte, de permitir que os pacientes fiquem com sua confusão naquele momento. Eu não tinha realmente dito nada confuso, surpreendente ou paradoxal; é simplesmente verdade que todos nós nos tornamos mais independentes depois de ter sido dependentes de outros com sucesso. Mas, para a paciente, isso pareceu paradoxal naquele momento. Ela estava presa no compromisso de fazer algo totalmente sozinha, e minha declaração reformulou sua crença de maneira surpreendente.

A intervenção terapêutica não cria um paradoxo; ela cria uma consciência de já estar em um. Para reiterar, parte do que faz essa intervenção funcionar para desequilibrar a situação e criar

movimento é que o terapeuta a entrega de maneira objetiva, sem mais explicações. O objetivo não é ensinar ao paciente algum pedaço de informação; o objetivo é criar desequilíbrio e movimento. E os princípios dialéticos a partir dos quais o terapeuta extrai são que 1) a realidade consiste em oposições, 2) tudo é transacional (ou seja, uma pessoa pode minar a interpretação de outra pessoa, reformulando-a) e 3) a mudança é constante.

Em outro exemplo de *entrar no paradoxo*, digamos que o paciente, seguindo as instruções do terapeuta, liga para ele entre as sessões a fim de receber orientações de habilidades diante de crises. As ligações se tornam frequentes e extremamente numerosas. Além disso, o paciente ignora todas as sugestões do terapeuta durante o *coaching* telefônico. O terapeuta fica frustrado e aponta o problema para o paciente, que, percebendo que está sendo solicitado a ser mais cooperativo, se sente insultado. Percebendo que magoou os sentimentos do paciente, o terapeuta faz um esforço para validar os sentimentos feridos. Ainda assim, o paciente continua com raiva, faz ligações frequentes e não muda os comportamentos problemáticos. As coisas estão emperradas. Percebendo isso e voltando-se para uma intervenção dialética, o terapeuta pode usar *entrar no paradoxo*. Transmitindo uma mistura de aceitação e mudança ao mesmo tempo, o terapeuta diz: “Eu me preocupo demais com você para permitir que continue fazendo as ligações telefônicas do jeito que você faz, então estou pedindo que pare de fazer as ligações”. Claro, não há contradição profunda aqui: o terapeuta se preocupa com o paciente e precisa limitar as ligações telefônicas um tanto ineficazes para preservar o relacionamento. Mas o fato de o paciente estar imerso na convicção de que precisa fazer todas as ligações e estar momentaneamente alheio à perspectiva mais ampla significa que é um paradoxo para ele: “Se você se preocupa comigo, como pode tirar algo de mim?”. Ele está confuso, intrigado, instável; há um desequilíbrio, e algo diferente pode acontecer. Uma maneira de

pensar sobre intervenções dialéticas é que elas catalisam ou permitem uma mudança no roteiro usual (emperrado).

PERMITIR A MUDANÇA NATURAL

Esta estratégia oferece mais uma resposta (potencialmente) terapêutica para o momento em que os opostos estão colidindo. Em geral, a utilizamos quando há discordância ou tensão em torno das condições do tratamento. Talvez o paciente sinta que as sessões são muito longas, muito curtas, muito raras ou muito frequentes. O paciente, especialmente um adolescente, pode achar que se sentar em um consultório, encarar um terapeuta e conversar seja opressivo. Um paciente pode querer dar um presente ao terapeuta, o terapeuta pode recusar e ele se sentir dolorosamente rejeitado. O paciente pode querer desviar da agenda típica das sessões, e o terapeuta querer se ater a ela. Uma vez trabalhei com uma jovem cujos comportamentos-alvo incluíam furtos, autolesão e uso de substâncias alucinógenas. Reconheceu que todos eram prejudiciais para ela, mas não queria falar sobre eles. Insisti em avaliar os fatores que mantinham cada um desses comportamentos. Ela achou que meus métodos eram “ultrapassados”, com base em “conceitos limitados” sobre como ela funcionava, e insistiu que faria o que fosse necessário para interromper os comportamentos. Ela queria falar sobre sua música e seu interesse em “artes sombrias”. Nossa luta persistiu por algumas sessões. Senti que ela poderia ser teimosa demais para tratar; ela achou que eu era rígido e controlador demais. Ela revelou sua convicção secreta de que era um oráculo e que poderia se curar; só precisava que eu a ouvisse. Estávamos em um impasse. Decidi *permitir a mudança natural*. Disse a ela que poderia determinar a agenda de nossas sessões e poderia me relatar suas descobertas como oráculo, contanto que me informasse semanalmente sobre seus furtos, autolesão e uso de drogas. Ela estava disposta a preencher um cartão diário que incluía esses alvos. De fato, ela interrompeu total e imediatamente

os furtos e a autolesão; o uso de drogas persistiu e discutimos isso repetidamente; ela não estava disposta a vê-lo como um comportamento problemático: “Isso abre as portas da minha mente para novos conhecimentos”.

Uma vez, trabalhei com uma mulher de 45 anos com padrões comportamentais limítrofes e problemas significativos com o funcionamento executivo. Cuidar de seu apartamento, carro, cachorro e acompanhar suas consultas médicas e psiquiátricas era avassalador. Ela não tinha emprego e vivia de pagamentos por invalidez. Estava sempre esquecendo e perdendo coisas, o que tornava sua vida quase impossível de gerenciar. Eu me encontrava com ela uma vez por semana durante 50 minutos e ela frequentava um grupo de habilidades de DBT. Grande parte do tempo de sessão era dedicado ao caos resultante de seus problemas de autogestão. Ambos sentimos que uma vez por semana era insuficiente, mas ela não podia pagar duas vezes por semana comigo, mesmo com um preço significativamente reduzido. Sugeri que poderia ser mais útil se nos encontrássemos duas vezes por semana, por 25 minutos cada vez, e focássemos em ajudá-la a se manter no caminho certo. Ela não ficou feliz em concordar com sessões mais breves, mas aceitou a mudança. Ambos ficamos surpresos com o quão útil isso acabou sendo. Ela conseguiu usar 25 minutos de maneira muito mais eficiente do que 50 minutos, e conseguimos progredir em suas habilidades de autogestão com monitoramento e solução de problemas mais frequentes.

Ao permitir a mudança natural, há um risco de violar outros princípios importantes da DBT, e esses fatores devem ser levados em consideração na decisão de fazê-lo. É importante destacar que, ao resolver conflitos permitindo a mudança natural nas condições do tratamento, o terapeuta pode estar reforçando a evitação. Para um terapeuta, insistir na consistência do tempo, local e condições das sessões é algo razoável. Se essas estruturas desencadearem emoções negativas no paciente, o terapeuta geralmente seria

sábio em não “remover os estímulos” para aliviar o sofrimento. A posição ideal para um terapeuta DBT é manter o enquadramento e o modelo de tratamento, reconhecer as reações negativas do paciente, encontrar a validade nas reações e ajudá-lo a se ajustar ao enquadramento. Para o paciente, lidar com expectativas realistas pode proporcionar uma valiosa oportunidade de aprendizado que pode ser generalizada em muitas circunstâncias da vida. Portanto, é importante considerar se estamos reforçando comportamentos disfuncionais ou proporcionando alívio de curto prazo às custas da evitação de longo prazo. Eu não tenho uma fórmula para decidir quando manter o enquadramento e quando permitir a mudança natural; a consciência dessa dialética potencial permite ao terapeuta considerar as prioridades e tomar uma decisão terapêutica de “mente sábia”. Por exemplo, no caso da paciente mencionada anteriormente com problemas graves de autogestão, foi uma decisão desse tipo para mim a de contornar o tempo usual de terapia e ser flexível em relação a um tipo diferente de programação. Embora não quisesse fazer uma prática regular de alterar o enquadramento, isso me pareceu estar de acordo com seu modo de funcionamento e os alvos imediatos do tratamento.

Permitir a mudança natural, embora seja uma estratégia dialética formalmente definida usada em certas circunstâncias, também representa um processo que ocorre de maneira mais sutil ao longo do tratamento. Em quase todas as sessões durante a primeira etapa do tratamento, encontramos momentos desafiadores, oposições, contradições e momentos de crescente tensão. Estes geralmente representam um desafio momentâneo, exigindo ajustes do terapeuta para manter o fluxo, resolver conflitos e preservar a colaboração. O terapeuta está sempre decidindo sobre o grau em que deve “ir com o fluxo” *versus* desafiar o comportamento. Todo o tratamento é baseado na capacidade de definir condições de tratamento, mantê-las, pressionar por mudanças, aceitar as coisas como elas são e

encontrar a síntese dos dois no momento. *Permitir a mudança natural* como uma estratégia cristalizada e como um conjunto sutil de decisões no momento faz parte dessa iniciativa dialética. Enquanto pressionamos implacavelmente por mudanças, também incorporamos a mensagem dos Beatles: “*Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be* [Deixe estar, deixe estar, deixe estar, deixe estar, sussurre palavras de sabedoria, deixe estar]”.

USAR METÁFORAS

Outra resposta dialética a um impasse é incorporar essa dialética em uma metáfora ou história, de tal maneira que catalisa mais pensamentos, movimentos e improvisações. O manual de Linehan (2010) está repleto de metáforas, e o uso delas é uma parte essencial da prática da DBT. Quando bem feito, permite que um processo mais criativo e lúdico ocorra em relação a um conflito em que a possibilidade de solução e movimento parece ter parado. Transformar e energizar uma oposição rígida que esgota ambas as partes por meio de uma reformulação metafórica pode ser eficaz. Recentemente, uma paciente minha vinha enfrentando uma série de crises emocionais e, em cada uma delas, pedia que eu ultrapassasse os limites da minha prática habitual para ajudá-la a se recuperar. Ela me deixava mensagens ameaçadoras dizendo que, se eu não tomasse mais medidas, como ir até ela, ligar para alguém, passar longos períodos ao telefone, fazer acordos especiais para vê-la em horários em que eu não estava disponível, cancelar férias, etc., ela não conseguiria sobreviver. Eu lhe disse que meu trabalho era ajudá-la a aprender a nadar cada vez mais efetivamente, mesmo em águas agitadas ou tempestades, quando necessário. Eu era seu instrutor de natação. E disse a ela que, além disso, ela às vezes precisava de um salva-vidas, quando as condições estavam muito difíceis para nadar, alguém para resgatá-la para que pudesse continuar. Ela precisava de um instrutor de natação e um salva-vidas. Expliquei que, se eu fosse seu instrutor de natação, não poderia ser o salva-vidas. Há salva-vidas na comunidade, como eu disse a ela – salas de emergência, linhas diretas de crise, outros recursos –, e eu precisava que ela confiasse nesses recursos para que eu pudesse me dedicar a ajudá-la a aprender a nadar. Ela poderia me ligar para receber orientação ao enfrentar uma crise para ajudá-la a aplicar suas

habilidades, mas isso era diferente de chamar um salva-vidas. A discussão abriu a porta para uma troca mais ampla sobre como suas várias necessidades poderiam ser atendidas e o que ela poderia esperar de mim.

Criar uma *metáfora* para uma situação que é muito carregada, complexa ou confusa para permitir uma consideração colaborativa comum pode fornecer o veículo para esclarecer questões e avançar. Como discuti no Capítulo 9 sobre a formulação de caso, tornei uma prática padrão incluir uma metáfora, na formulação de um caso, que captura os dilemas centrais como eu os vejo. Se for eficaz, essa metáfora permite que toda a equipe tenha uma compreensão integrativa do caso, o que promove o diálogo e a criatividade na solução de problemas. Por exemplo, em várias ocasiões, comparei o plano de tratamento passo a passo a uma escada. Com o paciente, começamos no degrau inferior e subimos, passo a passo, até o topo, onde há uma vida que vale a pena ser vivida. Definimos o degrau superior, nossa meta final, o mais claramente possível, e, em seguida, definimos cada degrau no caminho para essa vida. Cada degrau é crucial para toda a escalada, e devemos concentrar a atenção em cada degrau, um de cada vez. A metáfora representa a tensão entre focar a atenção na vida que vale a pena ser vivida no topo e focar a atenção em cada degrau.

Em outro caso, a paciente passou por repetidas hospitalizações por seus episódios de comportamento suicida, mesmo enquanto vários recursos comunitários eram usados para ajudá-la a construir uma vida fora do hospital. Em geral, ela melhorava durante a internação e, em seguida, era liberada com um plano envolvendo várias modalidades – psicoterapia, psicofarmacologia, centro de acolhimento, grupo de habilidades de DBT, programa diário ou outra atividade diária e plano de crise. Dentro de dias ou semanas, ela começava a apresentar comportamentos de crise no contexto de cada modalidade, seus episódios de comportamento suicida se

intensificavam e, após duas ou três visitas à sala de emergência, ela era hospitalizada novamente. Ela era notória entre os profissionais da região onde morava, e quando nos encontramos para consultoria, havia cerca de 20 profissionais presentes, desde seu terapeuta, seu psiquiatra e o treinador de habilidades em grupo até a equipe de crise, um gerente de casos, seus prestadores de serviços hospitalares e até mesmo um capitão da polícia local. Com um arranjo de tratamento tão complexo, mostrou-se útil encontrar uma *metáfora* que reunisse todos eles com a paciente. Comparando a situação a um grande jogo de *pinball*, a paciente era representada pela bola. Quando a bola rolava para o “ponto mais baixo da gravidade” na parte inferior do jogo, isso representava sua admissão e permanência no hospital por um tempo. As pás que eram ativadas para evitar que a paciente caísse no ponto baixo (hospital) representavam os esforços na sala de emergência para enviá-la de volta à comunidade em vez de hospitalizá-la. Mesmo que as pás tivessem sucesso em mandá-la de volta para o tabuleiro do jogo (sistema de tratamento comunitário), ela inevitavelmente voltaria para a sala de emergência, como se fosse puxada pela gravidade. Depois de um curto período no hospital, ela seria “lançada” do hospital de volta à comunidade, onde saltaria de um local para outro, como se estivesse quicando em cada um deles. Como os movimentos da bola no jogo de *pinball*, seus movimentos na comunidade tornaram-se mais intensamente impulsionados e agitados. A metáfora permitiu que cada prestador na sala visse sua própria parte no funcionamento da máquina como um todo. Usando a *metáfora*, o grupo conseguiu discutir opções para “mudar o jogo”. Tivemos uma discussão produtiva sobre maneiras de inclinar o jogo para que o ponto mais baixo da gravidade, o “local de descanso”, não fosse o hospital, mas um local desejável na comunidade. Surgiram várias ideias e a metáfora serviu como uma estrutura e um ponto de referência por meses.

O terapeuta DBT pode encontrar uma infinidade de metáforas em todo o manual de tratamento e, particularmente, no capítulo sobre estratégias dialéticas. Mas o que é mais difícil de descrever é como um terapeuta ou uma equipe cria uma metáfora que se encaixa em uma situação clínica. Para algumas pessoas, metáforas surgem facilmente; para outras, não. O terapeuta não precisa criá-las durante a sessão (embora possa ser útil se tiver essa facilidade). Encontrando-se preso em um de seus casos, o terapeuta pode apresentar os detalhes à equipe de consultoria e perguntar se alguém consegue pensar em uma metáfora para representar o dilema. Se possível, o terapeuta e a equipe encontram a(s) dialética(s) embutidas(s) no impasse e tentam imaginar uma síntese das forças opostas. Munidos de uma maneira de descrever as oposições e possíveis sínteses, os membros da equipe podem trabalhar em um processo de *brainstorming* que procure uma imagem ou uma história (uma analogia em que forças semelhantes estão embutidas), idealmente uma metáfora, com a qual o paciente possa se relacionar. O atleta pode se beneficiar de metáforas esportivas, o músico de metáforas musicais, e assim por diante.

Vamos analisar um exemplo. Imagine que alguém comunique pensamentos suicidas durante as sessões. O terapeuta fica preocupado com o possível suicídio. Como resultado, sua atenção se estreita, focando mais na prevenção do suicídio do que na construção de uma vida viável. Do ponto de vista do paciente, a preocupação suicida serve como solução, definindo uma saída para o sofrimento. Para o terapeuta, o pensamento suicida do paciente é um problema que interfere nas suas capacidades terapêuticas. Como poderíamos afirmar a dialética? Por um lado, o terapeuta precisa se sentir seguro e equilibrado o suficiente para fazer uma boa terapia; por outro lado, o paciente precisa ser capaz de comunicar sua dor, seu sofrimento e suas preocupações suicidas. Se o terapeuta não estiver equilibrado e seguro, a terapia

piora. Se o paciente não conseguir comunicar a intensidade das emoções, elas aumentam em força. Em busca de uma metáfora, o terapeuta pode procurar uma cena semelhante em que encontre um indivíduo tentando ajudar outro com seu sofrimento, enquanto se desequilibra por esse próprio sofrimento. Vem à mente uma cena em que uma pessoa está se afogando em um lago e outra está tentando resgatá-la. A pessoa que se afoga, desesperada para se manter viva, agarra-se ao socorrista, correndo o risco de puxá-lo para debaixo d'água. Ambos estão em risco. Os socorristas aprendem técnicas para se aproximarem do indivíduo que se afoga e salvá-lo sem serem puxados para debaixo d'água. Essa metáfora pode direcionar a discussão para abordagens seguras e eficazes para lidar com as preocupações suicidas do paciente sem “ser puxado para baixo”.

Em outra *metáfora* para a mesma situação clínica, a equipe pode comparar o dilema à situação em que uma pessoa em risco iminente de suicídio (o paciente) está parada na borda de um prédio, ameaçando pular para a morte, enquanto o socorrista (o terapeuta) se inclina para fora de uma janela, tentando estabelecer uma conexão na qual o paciente se sinta ouvido e compreendido. Se o socorrista conseguir se manter seguro e envolvido com o paciente, talvez uma solução segura possa ser encontrada. Em outra *metáfora* para a mesma situação, um soldado (o terapeuta) em uma zona de guerra encontra uma bomba (os impulsos suicidas do paciente) que pode explodir se for manuseada de forma insensível. Como o soldado poderia se aproximar da bomba e desarmá-la sem ser explodido? Como você pode ver, qualquer uma dessas possibilidades tem pontos fortes e fracos. Encontrar a “metáfora certa” é uma busca desnecessariamente impossível; um terapeuta e a equipe podem sentir a liberdade de brincar, criar e encontrar uma metáfora que se adeque às circunstâncias.

USAR A AVALIAÇÃO DIALÉTICA

A estratégia final de dialética no manual de tratamento, embora talvez seja a que direcione todas as outras, é a da *avaliação dialética*. Quando nos sentimos presos e o trabalho usual de solução de problemas e validação falha em criar movimento, podemos deliberadamente nos perguntar: “O que estou deixando de notar? O que está faltando na minha compreensão da situação?”. Tendo tentado várias soluções sem sucesso e nos frustrado cada vez mais, às vezes ficamos presos em nosso pensamento e acreditamos ter esgotado as possibilidades de entender o problema. Ficamos convencidos de que se pudéssemos fazer um pequeno ajuste, se fôssemos um pouco mais inteligentes, se o paciente fosse um pouco mais cooperativo, conseguiríamos a mudança que precisamos. É como se estivéssemos operando um microscópio para ver algo que permanece um pouco borrado, mas só usamos um nível de ampliação. Se pararmos, dermos um passo atrás naquele momento e perguntarmos: “O que estou ignorando? O que está faltando na equação?”, podemos mudar para um nível diferente de ampliação, abrindo nossos olhos para outras opções de compreensão. Podemos perceber que não estamos considerando o impacto do relacionamento terapêutico, a influência da dinâmica familiar, o papel do comprometimento cognitivo ou de uma deficiência de aprendizagem, a pressão de um processo psicótico não diagnosticado, a presença erosiva de uma condição médica ou um aspecto oculto do contexto ambiental do paciente. Talvez estejamos deixando de levar em conta que o paciente nunca se comprometeu com o trabalho em questão, mas estamos agindo como se tivesse. Talvez estejamos negligenciando o fato de que o paciente não tem as habilidades para realizar o que estamos pedindo, mas tem vergonha de nos dizer. Ou talvez a intensidade

da vergonha ou do medo subjacentes seja maior do que imaginamos. Ou, em alguns casos, quando terapeutas sobrecarregados se perguntam: “O que estou deixando de enxergar nessa situação?”, podemos perceber que não estamos recebendo apoio suficiente de nossas equipes de consultoria e precisamos pedir mais. As possibilidades são infinitas. Estamos sempre deixando de ver algo (alguma perspectiva, fato, dinâmica, fator relacionado ao tratamento), então, se estivermos presos em um impasse no tratamento, devemos automaticamente perguntar: “O que estou negligenciando?”. Talvez não encontremos uma resposta satisfatória, certamente não imediatamente, mas fazer a pergunta e talvez mudar o nível de ampliação altera tudo e pode proporcionar um ponto de virada.

Eu estava trabalhando com uma pessoa em seus 30 e poucos anos que tinha anorexia e transtorno da personalidade *borderline*. Parecia que toda semana ela teria outra crise de vida – moradia, relacionamentos, medicamentos, finanças, acidentes, etc. Sessão por sessão, trabalhávamos em cada uma. Quaisquer planos que ela fizesse para melhorar sua situação de vida eram eclipsados por sua última crise. Ela aprendia habilidades no grupo de treinamento, mas seu julgamento ruim e as crises repetitivas interferiam na prática das habilidades. Ela se relacionava com homens com problemas graves, frequentemente envolvendo abuso de substâncias, o que trazia mais crises. Ficou frustrante. Às vezes, sentia que finalmente estávamos “virando uma esquina” e colaborando em um bom plano. Mas, em cada caso, outra crise aparecia e nosso trabalho era desfeito. Eu me perguntei: “O que estou perdendo?”. Falei com minha equipe de consultoria sobre isso e fiz a pergunta à minha paciente. Perguntei em voz alta: “Você tem alguma ideia do porquê de não estarmos progredindo?”. Sua resposta foi reveladora. “Acho que você se importa mais com meu progresso do que eu. Não tenho certeza se realmente quero progredir. É difícil imaginar uma vida que corre sem problemas.

Acho que seria totalmente sufocante.” Fiquei completamente surpreso. Ela tinha demonstrado um bom engajamento em torno de metas identificadas e eu tinha deixado passar completamente sua ambivalência em relação à melhora. Ela pôde, então, articular uma variedade de medos sobre como seria a vida se ela progredisse. De repente, fez sentido que ela provavelmente não fosse progredir a menos que abordássemos seus medos subjacentes de sucesso.

Outra maneira de questionar “O que estou deixando de fora da minha compreensão atual?” é perguntar quais são os elos relevantes na cadeia do comportamento que estamos perdendo. Nunca podemos ter consciência de todas as emoções, pensamentos, ações e eventos ambientais relevantes na cadeia que leva a um comportamento-alvo. Podemos assumir que estamos perdendo elos – às vezes, importantes, e, às vezes, o elo mais importante. Isso nos mantém curiosos, humildes e nos leva a entender que, embora a *avaliação dialética* possa ser particularmente útil quando o tratamento está parado, também é uma estratégia que usamos constantemente – já que *sempre* há coisas deixadas de fora.

Se mantivermos em mente que uma forma de pensar dialética é sistêmica, holística e transacional, podemos sempre expandir nosso “campo de visão” para incluir outro conjunto de transações, outro subsistema do sistema maior, e assim podemos localizar as transações relevantes e os fatores sistêmicos que deixamos de fora. No momento em que pensamos ter esgotado nossas opções, uma ampliação de nosso “campo visual” revela centenas ou milhares de interconexões que poderiam dar lugar a uma intervenção.

Às vezes, o paciente está preso por causa de uma conexão com um membro importante da família que está preso. Supervisionei um terapeuta que tratava um menino de 15 anos, o qual se recusava a ir à escola e não parecia deprimido, mas com raiva, e

não dizia por que não estava frequentando a escola. O terapeuta começou a se encontrar com o paciente no contexto de sua família, que incluía seus pais e uma irmã mais nova. O menino ficou em silêncio durante as sessões, olhando para o chão. Após duas sessões, durante as quais os pais compartilharam sua exasperação e preocupações com o filho, o terapeuta perguntou a eles sobre seu próprio relacionamento um com o outro. O pai olhou para baixo. A mãe olhou para ele e perguntou por que estava desviando o olhar. Ele ficou quieto. O filho olhou para o pai (eu estava observando atrás de um vidro unidirecional). A mãe tentou redirecionar a conversa de volta para suas preocupações sobre o filho. O afastamento do marido era óbvio e preocupante, mas a sessão terminou sem uma solução real.

No início da sessão seguinte, a mãe anunciou que o pai havia se mudado para o sótão, não estava mais dormindo com ela e não estava participando de outras reuniões familiares. Ele começou a falar, com um tom de raiva em relação à esposa, depois começou a chorar e admitiu que se sentia perdido, deprimido e tinha pouca esperança em relação ao futuro. Como se constatou, ele estava clinicamente deprimido e estava profundamente infeliz com seu casamento. Na semana seguinte, o filho voltou espontaneamente para a escola sem dizer mais nada sobre isso. O filho e a filha foram dispensados das sessões e o tratamento se concentrou na depressão e na falta de esperança do pai e no próprio casamento. Como se constatou, por razões que permaneceram obscuras, a recusa do menino em ir à escola parecia estar em transação com o estado de espírito de seu pai. É sábio manter sempre a humildade, permanecer aberto a explicações ocultas e perceber que a resposta à pergunta “O que estou deixando de notar?” pode abrir caminho para a solução de problemas.

CRIE SUAS PRÓPRIAS ESTRATÉGIAS DIALÉTICAS

Uma vez que apreciamos que a natureza essencial das estratégias dialéticas é criar movimento onde havia impasse e encontrar síntese entre forças opostas, percebemos que as nove estratégias dialéticas identificadas por Linehan (2010, pp. 192-211) e discutidas neste capítulo são apenas algumas das milhares de estratégias potenciais. Terapeutas competentes em DBT que abraçam a essência subjacente das estratégias dialéticas mantêm o movimento em face da estase, continuam a ampliar o campo de investigação em reação à rigidez e ao estreitamento, mantêm os olhos na natureza transacional dos fenômenos comportamentais e sempre continuam a perguntar o que está sendo deixado de fora. Essa mentalidade leva a “ser dialético” em vez de apenas usar estratégias dialéticas.

Para ilustrar como um terapeuta pode inventar e usar novas estratégias dialéticas, menciono duas aqui que funcionaram para mim: *soltar a corda* e *ser o cachorro*. *Soltar a corda* é, é claro, uma metáfora em si. Quando percebo que caí em uma luta com um paciente em meus esforços de solução de problemas e que a luta se tornou não produtiva e cansativa, imagino que o paciente e eu estamos envolvidos em uma guerra de puxar, cada um segurando extremidades opostas de uma corda e puxando um contra o outro, sem nenhum lado ganhando. Então, simplesmente imagino soltar minha extremidade da corda. Dito de forma mais prosaica, deixo de lado meu apego ao meu lado do argumento. Esse conceito pode ser encontrado em outras estratégias dialéticas, como *permitir a mudança natural*. Mas, às vezes, eu apenas acho útil, por si só, imaginar a guerra de puxar e deixar de lado minha extremidade da corda, para ver o que acontecerá em seguida.

Eu estava tratando uma adolescente que mal falava durante os primeiros três meses de terapia comigo. Ela falava nas sessões familiares que eu tinha com ela e seus pais, nas quais ensinava habilidades a eles, mas não em sessões individuais. Ela se sentava de lado para mim, tinha cabelos longos e eu quase nunca via seu rosto. Sempre parecia zangada e ressentida, me tratava como se eu fosse ridículo e inútil e, no entanto, continuava a vir às sessões – enquanto havia abandonado a escola. Eu tentei tudo o que pude pensar para envolvê-la em uma conversa, incluindo algumas das estratégias dialéticas. Nada funcionou. Estava se tornando difícil continuar como seu terapeuta. Um dia entrei na sessão com uma mentalidade diferente. Senti que não havia sentido em continuar tentando envolvê-la em um diálogo. Simplesmente comecei a falar e contei a ela sobre algo que havia acontecido comigo no dia anterior:

Terapeuta: Ontem levei meu filho de 2 anos comigo para colocar os pneus de neve no carro. Ele queria ver enquanto eles levantavam o carro e trocavam os pneus. Eu estava parado no estacionamento atrás do prédio, segurando-o nos meus braços, enquanto assistíamos o mecânico trabalhar. De repente, um garoto que estava dando marcha à ré em um carro me acertou por trás. Eu fui jogado para frente no chão.

Paciente: *(De repente ela vira a cabeça em minha direção, o cabelo voa para o lado, e eu consigo ver o rosto dela pela primeira vez.)* O que aconteceu com seu filho?

Terapeuta: *(Estou um pouco chocado, e posso notar que a pergunta dela é sincera.)* Eu tive muita sorte. O cara percebeu que bateu em algo ou alguém, e parou de dar ré. Eu caí para frente e bati meus joelhos com força no chão. Segurei meu filho o mais alto que pude, e meus cotovelos também bateram no chão. Meu filho está bem. Na verdade, ele achou muito legal que em poucos minutos apareceu uma

ambulância, um carro de polícia e um caminhão de bombeiros do prédio ao lado. Eles me levaram no caminhão de bombeiros e enfaixaram meus joelhos, mas não precisei ir para o hospital.

Paciente: *(Ela parece cautelosa, até desconfiada, de mim.)*
Deixe-me ver seus joelhos. *(Ela quer uma prova.)*

Terapeuta: Ok. *(Eu levanto minhas calças, e, graças a Deus, as ataduras estavam nos meus joelhos.)*

Paciente: *(Ela age como se eu tivesse passado em um teste.)*
Ok.

Isso provou ser um ponto de virada na terapia. Tentei descobrir o que havia quebrado o bloqueio naquela sessão, para que eu pudesse entender a “fórmula” que a deixou mais envolvida. Talvez ela se sentisse mais confortável quando eu falava com ela mais como um amigo fala com um amigo, diferente de um terapeuta falando com um paciente. Ou talvez tenha feito diferença para ela que eu forneci um exemplo em que estava ferido e vulnerável, e que o bem-estar do meu filho estava em perigo. Eu nunca saberia com certeza, mas sabia que tinha tropeçado em algo que funcionou, e tentei replicar isso. Comecei as próximas sessões falando sobre episódios da minha própria vida em que eu estava vulnerável, em que fazia coisas erradas, ou em que pessoas próximas a mim estavam em perigo. Ela notavelmente suavizou suas reações comigo, sentou-se de frente para mim, e começou a se abrir sobre sua própria vida. Dentro de algumas semanas, estávamos trabalhando em seus problemas.

Eu chamei essa estratégia dialética de *ser o cachorro*. Em vez de pensar na paciente como um cachorro e em mim mesmo como um treinador, usando princípios de aprendizagem, pensei em mim mesmo como o cachorro e ela como a treinadora. Como o cachorro, eu estava procurando por reforço. O reforço veio na forma da disposição da paciente em falar comigo. Como um bom

“cachorro”, continuei gerando novos comportamentos até que um deles fosse recompensado; então tentei fazer mais do mesmo. Essa estratégia, que se baseia no princípio dos opostos (preservando a tensão entre o paciente e eu, mas pensando em mim mesmo como o “cachorro”), também segue o pensamento sistêmico, no qual novos comportamentos surgem quando os papéis são invertidos. Isso tem funcionado bem para mim em situações muito difíceis.

ESTRATÉGIAS DIALÉTICAS NO CONTEXTO DOS PARADIGMAS DE MUDANÇA E ACEITAÇÃO

Naturalmente, as estratégias dialéticas representam a síntese dos paradigmas de mudança e aceitação. Em cada um deles, o terapeuta está ao mesmo tempo buscando a mudança e aceitando as coisas como são. Isso é óbvio no *equilíbrio das estratégias de tratamento*. Ao *evocar a mente sábia*, o “lugar” para encontrar a síntese é a mente sábia. Ao *fazer dos limões uma limonada*, por assim dizer, o terapeuta “aceita” o momento angustiante ou disfuncional, ao mesmo tempo em que o reformula em uma perspectiva otimista e orientada para a mudança. Ao usar tanto o *advogado do diabo* quanto a *extensão*, o terapeuta não apenas aceita a posição disfuncional do paciente, mas a leva ainda mais longe, na esperança de que o novo desequilíbrio precipite a disposição dele para adotar uma posição mais orientada para a mudança. Ao *permitir a mudança natural*, o terapeuta aceita a atual alteração do quadro de tratamento, em vez de tentar colocá-lo de volta no lugar, e, ao fazer isso, estabelece um novo quadro, que pode se prestar melhor a uma pressão para a mudança. Ao *entrar no paradoxo*, geralmente o paciente experimenta o terapeuta apoiando-o, aceitando-o, ao mesmo tempo em que “se posiciona contra ele”, insistindo que mude (p. ex., “Eu me importo muito com você [aceitação] para permitir que continue a me ligar [mudança]”). Ao *usar metáforas*, o terapeuta encontra uma maneira de representar a tensão dialética, geralmente entre aceitação e mudança, o que permite o diálogo e a descoberta criativa de uma síntese. Ao *usar a avaliação dialética*, o terapeuta que descobre que não pode facilitar o movimento usando estratégias de mudança ou aceitação, pergunta: “O que estou deixando de fora em minha compreensão atual, a fim de aumentar a formulação do caso e abrir portas para outras intervenções?”.

Podemos entender as manobras das estratégias dialéticas a partir da perspectiva dos princípios subjacentes ao paradigma da mudança. Afinal, a intenção é gerar mudança: movimento onde há paralisia, síntese onde há polarização ou uma perspectiva mais ampla quando o pensamento é estreito e rígido. Queremos agitar as coisas, mesmo que temporariamente, permitindo um novo resultado. Seja qual for a natureza do impasse particular, podemos entendê-lo como um segmento de uma cadeia do comportamento que se tornou rígida e previsível. Se olharmos para isso a partir da perspectiva do condicionamento clássico, podemos estar inserindo uma pista diferente na equação (por exemplo, “Você tem certeza de que quer se comprometer com este tratamento?”), que então gera uma resposta comportamental diferente. Ou, ainda dentro do modelo do condicionamento clássico e dos procedimentos de exposição, podemos bloquear a fuga do paciente de suas emoções ao eliminar o conflito com o terapeuta (por exemplo, “Talvez seja melhor você continuar se recusando a preencher o cartão diário, para que possamos trabalhar nesse problema”).

Ou podemos ver o segmento rígido da cadeia do comportamento a partir da perspectiva do condicionamento operante. Nesse caso, algumas intervenções dialéticas removem a recompensa de um comportamento problemático específico e fornecem recompensa por uma resposta diferente. Por exemplo, ao “virar a mesa” usando o *advogado do diabo* ou a *extensão*, o paciente que foi recompensado por se opor à posição do terapeuta está agora na posição confusa de ter que gerar comportamentos pró-tratamento para permanecer em oposição. Reorganizar as coisas de uma maneira surpreendente ou temporariamente confusa (por exemplo, *entrando no paradoxo*) remove o resultado previsível que pode ter sido reforçado pela sequência previsível, abrindo a porta para uma mudança no padrão.

A maioria das estratégias dialéticas destaca ou desafia um padrão de pensamento disfuncional (mediação cognitiva da

mudança comportamental), modelando uma nova forma de pensar ou pelo menos abrindo a porta para isso. *Evocar a mente sábia* sugere e modela que alguém pode se referir à sua mente sábia para mudar um processo de pensamento. O *uso de metáforas* reformula um processo de pensamento que ficou preso e problemático, abrindo portas para novas formas de pensar. *Permitir mudanças naturais* sugere que às vezes podemos adaptar e ajustar as cognições em vez de insistir que a realidade se ajuste às suposições e crenças de alguém.

Finalmente, do ponto de vista do paradigma da mudança, o uso do pensamento dialético e a “busca do caminho do meio” com estratégias dialéticas podem ser apresentados como uma habilidade para o paciente aprender. Se o paciente pode entender as abordagens dialéticas “de dentro”, aprendendo a usar a habilidade, isso pode criar um solo mais fértil para essas intervenções.

A consciência dos princípios subjacentes ao paradigma da aceitação molda o uso das estratégias dialéticas também. O uso efetivo das estratégias dialéticas exige que o terapeuta experimente um grau significativo de liberdade juntamente com uma sintonia com o pensamento do paciente, tanto explícito quanto implícito. Para que o terapeuta esteja completamente presente e aberto ao momento, permitindo mais liberdade e espontaneidade, ele precisa reduzir a barreira entre si e o paciente, a fim de perceber o que está acontecendo dentro do paciente. Isso ajuda o terapeuta a encontrar a formulação e o equilíbrio adequados para oferecer estratégias dialéticas. Isso é semelhante à habilidade de um bom comediante de *stand-up* que pode ler com precisão as respostas explícitas e implícitas do público. O terapeuta é ainda mais aprimorado ao deixar de lado um senso de propósito e direção no momento, usando as estratégias para destacar fatores ocultos ou desequilibrar a situação atual. Depois que a estratégia dialética teve seu efeito, pode ser possível retornar às estratégias

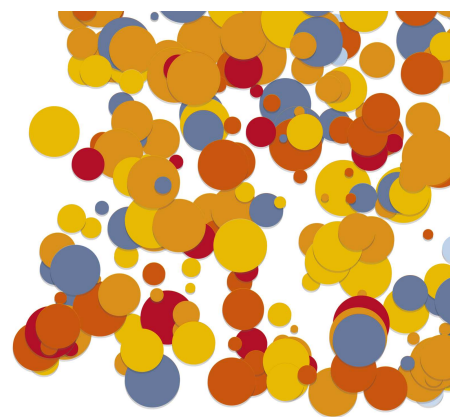
de solução de problemas direcionadas a metas e alvos. Finalmente, para que o terapeuta aceite que as coisas estão como “devem ser”, mesmo que sejam angustiantes, é de grande ajuda libertá-lo do pensamento julgador que pode interferir na posição não julgadora ideal para fornecer estratégias dialéticas.

COMENTÁRIOS FINAIS

As estratégias dialéticas são uma solução perfeita para indivíduos com disfunção emocional grave e crônica. A tendência ao pensamento rígido e a processos polarizados encontra seu antídoto em estratégias que ajudam a abalar o *status quo*, a encontrar a sabedoria em ambos os lados de um argumento e a trabalhar em direção à síntese. Essas estratégias incluem *equilibrar estratégias de tratamento, fazer dos limões uma limonada, estender, interpretar o papel de advogado do diabo e entrar no paradoxo*. A tendência a narrativas simples e perspectivas estreitas é contraposta pelo pensamento sistêmico complexo e realista que surge de uma perspectiva mais ampla. Incorporamos o pensamento sistêmico por meio do *equilíbrio de estratégias de tratamento, da evocação da mente sábia e do uso da avaliação dialética*. A tendência a ficar preso é abordada pelo reconhecimento de que a realidade está sempre em fluxo e a terapia está sempre em movimento. O fato de que a DBT tem tantas opções estratégicas para escolher, e que as estratégias dialéticas em particular fornecem intervenções adicionais especialmente projetadas para situações difíceis, torna essa terapia viável.

Para usar essas estratégias de forma eficaz, precisamos de algo diferente do que o uso eficaz de estratégias de solução de problemas e validação. Precisamos encontrar situações difíceis, experimentar impasses, estar “contra a parede”, reconhecer as posições opostas na dialética e, nesse contexto, permitir que nossas mentes relaxem o suficiente para saltar para intervenções criativas que podem ou não funcionar. Essas estratégias surgem, no melhor dos casos, de um senso de liberdade diante da paralisia. Descobri que é útil, ao enfrentar um encontro clínico difícil e polarizado, experimentar essas estratégias em minha mente ou em

simulações. Não há substituto para a prática e a disposição para tentar, falhar, tentar novamente, falhar novamente, aprender e ajustar.



14

Habilidades e treinamento de habilidades

DE TERAPEUTA PSICANALÍTICO A TREINADOR DE HABILIDADES

Quando eu aprendi sobre terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) no final dos anos 1980, fiquei intrigado com as habilidades. Dados os meus 10 anos de prática psicanalítica, eu estava cético em relação à afirmação de que algo tão “superficial” poderia resultar em mudanças comportamentais duradouras. Ainda assim, visitei Seattle e, enquanto estava sentado atrás de um vidro unidirecional, assisti Marsha Linehan ensinar uma sessão de treinamento de habilidades para seis mulheres com transtorno da personalidade *borderline*. Várias coisas chamaram minha atenção. Em primeiro lugar, em contraste com a postura objetiva e tecnicamente neutra da psicanálise, ela era muito calorosa, direta e encorajadora. Ela agiu de maneira muito natural, assim como agiu comigo. Em segundo lugar, enquanto as pacientes estavam obviamente ansiosas (era a primeira sessão de um novo grupo) e algumas delas mal conseguiam falar, Marsha era amigável e otimista. Ela agiu como se estivesse cercada por estudantes ambiciosos, confortáveis e animados, e persistiu com esse tom até que os membros do grupo comesçassem a relaxar e agir como estudantes interessados. Em terceiro lugar, embora seu estilo fosse casual, ela era rigorosa ao ensinar habilidades e insistia que as pacientes as aprendessem. Sua visão geral dos módulos era bem organizada, precisa e motivadora. Ela equilibrou seu estilo acolhedor com uma agenda estruturada e meticulosa. Em resumo, ela combinou as habilidades empáticas e reflexivas de um psicoterapeuta com as habilidades de estruturação e exigência de um bom treinador.

Em retrospecto, percebo que ver Marsha em ação abriu uma porta para mim. Embora eu tenha escolhido uma carreira por meio da psicanálise, eu havia abandonado qualquer esforço para

perseguir outra paixão: treinar basquete. Por meio da DBT, poderia imaginar encontrar minha própria síntese de terapia e treinamento.

De volta a Nova York, nem todos estavam tão satisfeitos com minha nova direção. Como mencionei no Prefácio, quando tentei introduzir elementos da DBT em meu programa de psicoterapia psicanalítica de longo prazo para pacientes internados, membros da minha equipe sênior se opuseram fortemente a “diluir” nossa abordagem. O obstáculo foi temporário. Foi-me permitido desenvolver um programa diferente de pacientes internados usando os princípios da DBT. Nossos esforços de implementação começaram pelo aprendizado das habilidades por nós mesmos; depois as ensinamos aos pacientes em grupos. Conforme nos tornávamos mais hábeis e confiantes em ensinar as habilidades, os pacientes forneciam críticas positivas, nos incentivando a continuar.

Os passos identificáveis em nossa jornada à medida que nos tornamos treinadores de habilidades foram paralelos aos passos do próprio treinamento de habilidades. *O primeiro passo no treinamento de habilidades é a aquisição de habilidades, trazida por meio de instrução e modelação.* Depois de ensinarmos as habilidades a nós mesmos, trabalhamos em maneiras de instruí-las aos pacientes. Até escrevemos uma palestra para cada habilidade a fim de garantir que pudéssemos articular como fazer cada uma delas. E rapidamente reconhecemos que, além de instruir os pacientes, tínhamos que realizar a modelação das habilidades. Tínhamos que mostrar a eles como fazer as habilidades, ou, para as habilidades mais internas (p. ex., habilidades de *mindfulness*), tínhamos que explicar sobre a prática. Claro, isso significava que precisávamos conhecer as habilidades por dentro e usar a autorrevelação no ensino. Assistimos a trechos de filmes populares em que as habilidades eram usadas, ou não. Isso não era um “seminário” sobre habilidades de DBT, era uma sessão de

treinamento pontuada por assistir filmes e realizar a modelação das habilidades nós mesmos.

Tínhamos que chamar a atenção dos pacientes. Aprendemos rapidamente que nosso interesse pelas habilidades não necessariamente se traduzia no interesse deles. Para adquirir as habilidades, teriam que prestar atenção, e percebemos que tínhamos que trabalhar duro para chamar sua atenção. No entanto, mesmo que o conteúdo das habilidades fosse maravilhoso, não chamaria a atenção deles. Ajudou quando nós mesmos experimentamos as habilidades, aplicando-as em nossas vidas pessoal e profissional. Então, pudemos ensinar com mais convicção e empatia. Ainda assim, frequentemente sentíamos que éramos um grupo de generais ousados marchando nossas tropas até o topo da colina na batalha – mas nossas tropas ficavam para trás na base da colina. Eu lembrei do primeiro grupo que eu havia testemunhado, no qual Marsha trouxe uma energia constante, otimista e um senso de facilidade para uma cena repleta de mau humor, irritabilidade, relutância e franca desobediência. Ela empurrou de forma gentil, mas firme, suas tropas em direção ao topo da colina – apoiando-as, persuadindo-as, conectando-se com elas, ganhando-as pouco a pouco. Tentamos imitar Marsha, equilibrando nosso ensino com charme, entretenimento e humor e nosso senso de urgência com infinita paciência.

Em geral, era fatal começar um grupo dizendo algo como “Todos, virem para a página 27” ou “Me digam o que acham dessa habilidade”. As respostas eram rígidas e mínimas. Éramos forçados a ser criativos, conectados e até dramáticos às vezes. Aprendemos a introduzir o tópico de habilidades de regulação emocional chamando para uma discussão descomplicada e pessoal sobre emoções em nossas vidas (nossas e dos pacientes). Podemos começar perguntando: “Alguém aqui tem alguma emoção?”. Depois de termos uma discussão descomplicada sobre nossas emoções, podemos fazer a transição para as lições. Em

outras ocasiões, tentamos introduzir o módulo de habilidades de regulação emocional pedindo a todos que cantassem uma música animada e familiar, algo como *“Take Me Out to the Ball Game”*. Nós ficávamos agitados e bobos. Logo após terminar a música, pedíamos a cada pessoa para observar se cantar a música havia mudado suas emoções. Em geral, as emoções mudavam para o positivo. Passávamos rapidamente para ensinar como todos nós temos a capacidade de mudar nossas emoções voluntariamente, escolhendo nossas ações e pensamentos. De repente, chegamos à ideia central do módulo todo, e o ensino de habilidades específicas poderia seguir.

Às vezes, era difícil chamar a atenção dos pacientes ao começar o módulo de habilidades de efetividade interpessoal, especialmente dado que o primeiro folheto é genérico e chato. Uma vez, cheguei, me sentei e comecei a ensinar o módulo. Dentro de um minuto, minha colega de ensino (e nossa psicóloga clínica), Cindy Sanderson, chegou e sentou-se diante de mim. Ela cumprimentou o grupo, abriu seu manual de habilidades e anunciou: “Ok, grupo, é hora de começar!”. Eu rapidamente a interrompi e disse a ela que eu já havia começado. Ela respondeu: “Mas é *minha* vez de ensinar!”. Eu respondi com um tom irritado: “Cindy, nos reunimos nesta semana e concordamos que eu ensinaria este módulo”. Cindy voltou com mais do que um tom irritado: “Isso não é verdade, Charlie. Você e eu decidimos explicitamente que *eu* ensinaria este módulo. Não posso acreditar que você está fazendo isso comigo na frente deste grupo!”.

Eu fui implacável, assim como ela. As nossas vozes aumentaram e a retórica se tornou mais acusatória. Os olhos dos pacientes se arregalaram; eles mal podiam acreditar que estavam testemunhando uma briga pública entre dois líderes da unidade. Com certeza, tínhamos a atenção deles. Isso foi planejado com antecedência, mas uma vez iniciado, foi intenso. De repente, paramos a discussão. Eu me levantei ao lado do quadro e

perguntei aos pacientes se eles conseguiam identificar problemas na maneira como Cindy havia tentado me convencer a deixá-la ensinar. Eles listaram vários. Perguntei se conseguiam ver problemas na maneira como eu a havia recusado. Eles listaram muitos. Nós escrevemos tudo. Estávamos bem no cerne do módulo (como pedir habilidosamente o que você quer e como dizer habilidosamente “não”) antes de eles perceberem.

O segundo passo no treinamento de habilidades é o fortalecimento das habilidades, que é alcançado por meio de ensaio comportamental (prática) com feedback e treinamento específicos. Tendo aprendido o conteúdo e praticado nós mesmos as habilidades, começado a dominar as artes de instruir e fazer a modelação e melhorado nossa capacidade de chamar a atenção dos pacientes, começamos a nos preocupar se eles realmente estavam incorporando as habilidades em seu repertório diário. Talvez tenhamos presumido que, se “vendêssemos” as habilidades o suficiente, eles as comprariam e as usariam. Isso simplesmente não era verdade. Algumas vezes, questionei os pacientes que haviam concluído a nossa sequência de treinamento de habilidades e fiquei tanto espantado quanto desanimado com os resultados. Qual era o sentido de um excelente ensino se as habilidades não fossem incorporadas? Meu treinamento como terapeuta psicanalítico não me preparou para insistir que os pacientes mudassem seu comportamento e praticassem as habilidades. Um ponto de virada para mim foi quando percebi que o treinamento de habilidades é mais como o treinamento de basquete, no qual as instruções e a modelação são seguidas pela insistência de que os jogadores pratiquem os novos movimentos e, em seguida, treina-se com *feedback* detalhado. Aceitando o desafio com o zelo de um convertido, me comprometi a prescrever práticas para todas as habilidades e, em seguida, treinar os pacientes em suas práticas. O processo começou a ser divertido! Por mais óbvio que pareça agora, foi uma revelação para mim que,

para mudar o comportamento, é preciso *mudar o comportamento*. A introspecção não é um fim em si mesma; é um passo em direção à mudança comportamental. A ênfase de Linehan (2010) em “arrancar novos comportamentos” do paciente em cada sessão me impressionou muito.

O *terceiro passo do treinamento de habilidades é a generalização das habilidades, o processo de aplicar novas habilidades em todos os contextos relevantes da vida. Isso acontece por meio da programação de generalização, seguida de prática e treinamento em ambientes relevantes*. Como novos treinadores de habilidades, havíamos integrado efetivamente os dois primeiros passos (procedimentos) de todo o treinamento de habilidades, aquisição e fortalecimento, mas precisávamos focar mais no terceiro e último, a generalização. Uma experiência pessoal, no contexto do ensino de profissionais da saúde mental para aprendizado de habilidades de DBT, me ajudou a avançar nesse passo crucial. (Um dos grandes valores de ensinar aos outros é finalmente entender, pessoalmente, a lição que está sendo dada.) Naquela época, eu estava me preparando para ensinar um *workshop* de dois dias sobre o treinamento de habilidades de DBT com meu amigo e colega Alec Miller. Estávamos em Detroit, Michigan. Tínhamos um público de 400 pessoas e a gerente do evento era uma mulher jovem, bastante formal e obviamente muito profissional, que eu não tinha conhecido antes. Como era comum para mim, acordei cedo no primeiro dia, pensando no *workshop* e ponderando sobre um dos enormes desafios no treinamento de habilidades: ensinamos todas as habilidades do currículo, semana após semana, quer os pacientes precisem delas ou não. Eu sabia, por experiência pessoal, que ninguém aprende uma habilidade a menos que veja e sinta sua necessidade.

Por exemplo, durante o meu segundo ano de faculdade de medicina, estudei equilíbrio ácido-base. Era uma matéria

complexa, difícil de entender. Parecia bastante acadêmico. Eu poderia passar no exame, mas sabia que não tinha dominado o conteúdo. Durante o meu terceiro ano de faculdade de medicina, fui designado para cuidar de um paciente que tinha um problema de equilíbrio ácido-base não diagnosticado. Naquela noite, ele estava em agonia. Conversei com ele, verifiquei sua pressão arterial e pulso, fiz um exame físico, retirei sangue para avaliação laboratorial, estudei sua urina e fiz uma gasometria arterial para determinar a oxigenação de seu suprimento sanguíneo. Ao reunir os dados, percebi que o homem tinha um problema de equilíbrio ácido-base, possivelmente baseado em falência renal. Ele estava piorando, e meu conhecimento insuficiente sobre equilíbrio ácido-base de repente parecia uma deficiência que ameaçava sua vida. Com concentração intensificada, sentei-me por uma hora com meus livros de medicina, revisando rápida e intensamente o material sobre equilíbrio ácido-base. Dentro daquela hora, “entendi”. Aprendi. *Aprendi porque precisava.*

À medida que se aproximava das 8h30 daquele dia, me comprometi a compartilhar essa percepção com os participantes do *workshop*. Precisávamos ajudar nossos pacientes a perceberem por que precisavam das habilidades. No melhor espírito de modelação dessa lição, queria demonstrar aos participantes que eu precisava das habilidades de regulação emocional da DBT enquanto ensinava o *workshop*. Como poderia mostrar a eles que precisava das habilidades enquanto as ensinava? Tendo ensinado tantos outros, estava confortável com o processo. Como poderia criar desconforto emocional em mim enquanto ensinava, para que precisasse praticar as habilidades? De repente, lembrei-me de que, quando criança, eu sonhava que era encontrado despido, nu, no meio de uma sala de aula. Isso sempre me causava grande sofrimento (e alívio quando acordava). Sabia que, se ficasse despido diante da plateia enquanto ensinava, ficaria muito consciente de mim mesmo, envergonhado e

emocionalmente distraído. Decidi despir-me até a cintura enquanto começava o *workshop* (ainda estava ciente de certos limites de decoro, graças a Deus!).

Pensei em contar a Alec Miller, meu professor auxiliar, ou à gerente do evento, mas sabia que, se contasse com antecedência, não ficaria tão ansioso. Então, mantive isso para mim. Quando comecei o *workshop*, em pé atrás de um púlpito, tirei minha gravata. Coloquei-a na mesa ao lado de Alec. Então tirei meu paletó e o coloquei ao lado da gravata. Pausei. Então desabotoei minha camisa social e a tirei, colocando-a na cadeira ao lado de Alec. Ele me olhou com choque e preocupação, colocou a mão em meu braço e disse: “Charlie, você está bem?”. Eu disse a ele que estava bem. Eu não estava realmente bem, pois estava completamente envergonhado e consciente de mim mesmo. Comecei a ensinar o segmento da manhã, explicando que ninguém nunca aprendeu uma habilidade se não precisasse dela, dizendo-lhes que usaria minhas habilidades de regulação emocional naquela manhã enquanto ensinava, porque precisava delas. Eu tinha a atenção deles! Em serviço da modelação das habilidades para os participantes, eu havia encontrado uma maneira de generalizá-las para aquele contexto.

Para os terapeutas que são novos na DBT e que me perguntam como começar, geralmente sugiro que aprendam as habilidades e depois as ensinem a um indivíduo ou a um grupo. Nesse processo, você aprende que, para mudar comportamentos, você precisa mudar comportamentos; para ensinar as habilidades, você mesmo precisa aprendê-las; para ensinar as habilidades aos outros, você precisa chamar a atenção deles; e que as pessoas não aprendem a usar novas habilidades a menos que percebam que precisam delas. Na curva de aprendizado, ao se tornar um treinador de habilidades, você descobre, em primeira mão, a necessidade de todos os três passos do treinamento de habilidades: aquisição, fortalecimento e generalização de habilidades. Por fim, você

aprende muito sobre o tratamento comportamental em geral começando por aprender e ensinar os “comportamentos substitutos”.

O CAMINHO PARA UMA VIDA QUE VALHA A PENA SER VIVIDA É PAVIMENTADO COM HABILIDADES

Nos últimos 15 anos, começando com pesquisas sobre o uso de treinamento de habilidades da DBT (sem terapia individual) para pessoas com transtornos alimentares (Safer et al., 2001) e um estudo sobre o uso de treinamento de habilidades (sem terapia individual) para a população idosa deprimida (Lynch et al., 2003), ficou cada vez mais claro que o treinamento de habilidades da DBT é eficaz por si só. Nosso entendimento atual da pesquisa é que a aquisição e o uso de habilidades da DBT reduzem a desregulação emocional, o que medeia reduções nos comportamentos-alvo primários, como episódios de comportamento suicida, comportamentos de autolesão, comportamentos de uso de substâncias, comportamentos de transtornos alimentares, e assim por diante (Neacsiu et al., 2010). Entre esta pesquisa, a publicação recente da 2ª edição do manual de habilidades de Linehan (2018b) e a publicação recente do manual de habilidades da DBT para adolescentes (Rathus & Miller, 2022), o valor do treinamento de habilidades foi para o primeiro plano na DBT.

Se formulamos todo o tratamento à luz da pesquisa que comprova a importância central das habilidades, podemos ver que cada uma das várias estruturas, protocolos e grupos de estratégia estão preocupados com a aquisição, o fortalecimento e a generalização de habilidades. A meta final da DBT é construir uma vida que valha a pena ser vivida; essa construção acontece em etapas, e cada uma delas envolve mudanças comportamentais. A mudança comportamental resulta da substituição de comportamentos desadaptativos por comportamentos habilidosos. No seu cerne, a prescrição para alcançar uma vida que valha a pena ser vivida na DBT se resume a uma sequência longa de

passos, e cada passo envolve a substituição de comportamentos desadaptativos por comportamentos adaptativos: *em vez disso... aquilo*. Em vez de ser desatento... seja atento. Em vez de ser submisso... seja assertivo. Em vez de desregulação emocional... use estratégias de sobrevivência a crises. Em vez de evitar o desconforto... aproxime-se. Em vez de ser levado pelo passado... observe, aceite, deixe ir e siga em frente. Em vez de acreditar e agir de acordo com distorções cognitivas... gere conscientemente crenças mentais realistas e sábias. Em vez de ter comportamentos de autolesão para aliviar o sofrimento... use estratégias de sobrevivência a crises.

Longe de ser um “acréscimo” ou “uma das muitas opções”, uma análise cuidadosa revela que as habilidades estão integradas em todo o tratamento. Por exemplo, cada uma das cinco fases de tratamento da DBT gira em torno do uso de habilidades para alcançar metas sequenciais. Durante o pré-tratamento, a meta é fazer o paciente se comprometer com o plano de tratamento, o que requer um aumento nas habilidades para tomar uma decisão diante de desesperança, evitação, confusão, medo e outros comportamentos problemáticos. Durante o estágio 1, cuja meta é substituir a desregulação comportamental por controle comportamental, o trabalho envolve a substituição de comportamentos desadaptativos que colocam a vida em risco, interferem no tratamento e interferem na qualidade de vida por habilidades comportamentais. Como parte desse trabalho, tentamos substituir os padrões desadaptativos conhecidos como *dilemas dialéticos* (vulnerabilidade emocional, autoinvalidação, passividade ativa, etc.) por padrões comportamentais habilidosos (modulação emocional, autovalidação, esforços ativos para buscar ajuda conforme necessário). A estratégia central de organização durante o estágio 1 é a análise em cadeia do comportamento, que consiste na elucidação microscópica de elos na cadeia, destacando a presença de comportamentos desadaptativos, o uso

de habilidades e déficits no uso de habilidades. A meta é localizar elos desadaptativos e déficits de habilidades e, em seguida, substituí-los por habilidades.

A meta do estágio 2 é substituir a experiência emocional com intenso sofrimento por uma experiência emocional sem intenso sofrimento. Usando reforço contínuo de habilidades comportamentais enquanto envolvemos os pacientes em procedimentos de exposição, ajudamos a fortalecer as habilidades necessárias para abordar estímulos emocionalmente evocativos em vez de evitá-los, permitindo experienciar uma emoção em vez de escapar dela. Embora diversas estratégias sejam usadas para alcançar esse objetivo, todas as estratégias visam ao aprimoramento das habilidades de regulação emocional.

Os estágios 3 e 4, embora bem menos definidos, também podem ser entendidos como o aprimoramento de conjuntos de habilidades para as metas gerais: resolver problemas a serviço da construção de uma vida de “felicidade e infelicidade comuns” (Linehan, 2010) e experimentar mais alegria, significado e liberdade sustentados na vida diária.

Linehan, em *workshops* nos últimos anos, propõe quatro maneiras de abordar qualquer problema. Cada uma delas envolve a aplicação de um conjunto de habilidades.

1. Resolver o problema requer habilidades de solução de problemas, muitas vezes derivadas das habilidades de efetividade interpessoal.
2. Mudar a resposta emocional requer habilidades de regulação emocional.
3. Tolerar o sofrimento de forma mais eficaz requer habilidades de tolerância ao mal-estar.
4. Permanecer infeliz envolve o uso contínuo de comportamentos desadaptativos em vez da substituição por habilidades.

O treinamento de habilidades é um dos quatro procedimentos de mudança na DBT, os outros três sendo a modificação cognitiva, a exposição e os procedimentos de manejo de contingências. A modificação cognitiva compreende a aquisição, o fortalecimento e a generalização de um conjunto de habilidades que visam às cognições problemáticas e aos erros no processamento de informações, tentando substituí-los por processos mais realistas e funcionais. Os procedimentos de exposição promovem respostas habilidosas aos estímulos evocativos e às emoções dolorosas. Em vez de evitar reflexivamente estímulos e escapar das respostas emocionais subsequentes, o paciente aprende a evitar a evitação, bloquear as respostas de fuga e permanecer em contato com os estímulos por tempo suficiente para que ocorra uma nova aprendizagem. E em vez de ser sobrecarregado pelas respostas emocionais ou suprimir globalmente as respostas aos estímulos, o paciente é ensinado a usar com aptidão certas habilidades de regulação emocional e certas habilidades de tolerância ao mal-estar para permitir um nível ideal de exposição sem resultar em trauma adicional. Os procedimentos de manejo de contingências não ensinam novas habilidades em si, mas envolvem a recompensa de comportamentos habilidosos enquanto extinguem e ocasionalmente punem comportamentos não habilidosos. E, de fato, na 2ª edição do manual de habilidades, no contexto do ensino de “habilidades do caminho do meio”, Linehan (2018b) ensina aos pacientes como entender esses princípios de aprendizagem para que possam usá-los habilidosamente para si mesmos.

Outra estrutura essencial para a DBT é a divisão de todas as intervenções da DBT em cinco funções de um tratamento abrangente. Esse formato também pode ser entendido como centrado na aquisição, no fortalecimento e na generalização de habilidades. 1) Ao aprimorar as capacidades, aumentamos os comportamentos habilidosos dos pacientes. 2) Ao generalizar habilidades para os ambientes naturais dos pacientes,

adicionamos intervenções para promover o uso de habilidades em contextos relevantes. 3) Ao melhorar a motivação dos pacientes, aumentamos sua motivação para usar as habilidades. 4) Ao estruturar os ambientes dos pacientes, encontramos maneiras de garantir que o uso de habilidades seja reforçado neles. E 5) ao melhorar a motivação e as capacidades dos terapeutas, estamos aumentando seu conjunto de habilidades para manter a motivação e fazer terapia corretamente – o que, por sua vez, resulta no aumento dos conjuntos de habilidades dos pacientes. Não há dúvida de que a DBT, por meio de seus estágios, metas, alvos, funções, modos e procedimentos de mudança comportamental, é, em seu núcleo, um tratamento para substituir comportamentos desadaptativos por habilidades.

HABILIDADES SÃO COMPLICADAS

Nossa familiaridade com as habilidades pode criar a ilusão de que o treinamento de habilidades é a parte “fácil” da DBT. Mas a facilidade com que podemos identificar as habilidades necessárias e usar o manual para apresentá-las aos pacientes esconde a complexidade real de ensinar (e aprender) uma nova habilidade de fato.

Para o paciente (para qualquer um de nós!), aprender uma habilidade (*adquiri-la, fortalecê-la e generalizá-la*) envolve a aplicação coordenada de vários comportamentos muito específicos em tempo real, apesar das pressões internas e dos microambientes em constante mudança. Assim como a compreensão da teoria das partículas em física foi enriquecida e complicada com a descoberta de subpartículas, a prática de treinamento de habilidades na DBT é aprimorada e complicada ao perceber que cada habilidade consiste em um agregado sincronizado de *sub-habilidades*.

Por exemplo, considere a habilidade de pedir a seu companheiro algum tempo sozinho dizendo “Por favor, me deixe ter algum tempo sozinho”. Na verdade, fazer esse pedido habilidosamente requer um conjunto de várias sub-habilidades. Primeiro, você deve ter consciência do desejo de ter tempo para si mesmo. No entanto, se você subordina reflexivamente seus próprios desejos aos dos outros, pode ser impossível perceber isso – nesse caso, é impossível aprender toda a habilidade. Em segundo lugar, embora você possa estar ciente de que quer um tempo para si mesmo, uma série de fatores pode interferir na sub-habilidade de ter disposição para pedi-lo. Talvez você pense que não merece ter esse tempo ou esteja convencido de que não deve incomodar seu parceiro. Em terceiro lugar, mesmo que você esteja ciente do seu desejo e disposto a pedir o que deseja, para fazê-lo

com sucesso, você precisa integrar várias outras sub-habilidades: ser tático, usar um bom momento e encontrar a postura e o tom de voz ideais para transmitir seu pedido. Escolher as palavras que transmitirão com mais eficácia o que você deseja e influenciarão seu parceiro a concordar com você é outra sub-habilidade em si mesma. Toda essa empreitada também depende da habilidade de “ler” a mentalidade de seu parceiro, antes e durante o pedido. É um conjunto de habilidades complexas e sutis para responder, em tempo real, às respostas do seu parceiro à medida que você faz o pedido, já que pode precisar se ajustar enquanto o faz. Pode parecer bastante tedioso enumerar todas as sub-habilidades envolvidas em fazer um pedido habilidoso, e na maioria dos contextos isso é inútil. Mas quando se ensina uma habilidade a uma pessoa que tem dificuldade de usá-la, pode ser necessário dividi-la em sub-habilidades para diagnosticar e tratar os impedimentos.

A pessoa que tem déficit em habilidades e cuja vida não vai bem como resultado quase nunca atribui seus resultados decepcionantes à falta de habilidades; ela quase sempre assume que há algo mais errado com ela ou com as pessoas ao seu redor. Como é difícil resolver um problema quando não se pode ver sua infraestrutura! O treinador de habilidades que entende que o “diabo está nos detalhes” (que os detalhes são déficits de habilidades [e déficits em sub-habilidades], que os déficits de habilidades podem ser substituídos por habilidades e que, para isso, são necessárias diligência, precisão e compaixão) pode mudar a vida do paciente. E esse treinador de habilidades perceberá que não pode diagnosticar os impedimentos a uma habilidade sem ver ou ouvir sobre a prática da habilidade pelo paciente. Ele precisa ver, dividir em partes, fazer sugestões específicas de treinamento, fazer o paciente aplicar novamente e trabalhar em direção a uma prática mais integrada, suave e eficaz da habilidade em questão.

Apoiar a prática de uma habilidade quando o paciente está generalizando-a para seu ambiente requer um nível igual de diligência. Tive uma paciente em um grupo de treinamento de habilidades que estava começando um emprego como barista em uma cafeteria. Ela havia passado pela maior parte do currículo de treinamento de habilidades, e estávamos identificando quais habilidades ajudariam com sua intensa ansiedade social ao lidar com os clientes. Ela planejava usar a habilidade de “fazer uma coisa de cada vez” para não se sentir sobrecarregada. Além disso, planejava regular suas emoções e tolerar o mal-estar observando sua respiração e fazendo pausas ocasionais. Ainda assim, a paciente e eu esperávamos desafios sérios na implementação dessas habilidades em seu “mundo real”. Era um trabalho movimentado, e ela não queria contar ao seu chefe o quão difícil era lidar com encontros simples. Um dos pacientes do grupo de habilidades sugeriu que todos se revezassem indo lá para vê-la, pedindo café e fornecendo apoio e reforço. Na verdade, eles criaram uma programação para que, durante suas primeiras duas semanas no trabalho, alguém do grupo fosse lá a cada duas a três horas. Isso a ajudou a usar as habilidades e a estabelecer *momentum* no trabalho durante as primeiras etapas. Imagine se pudéssemos encontrar esse tipo de apoio para a *generalização* de habilidades o tempo todo!

HABILIDADES, CONEXÕES E A CADEIA DO COMPORTAMENTO

Eu estava trabalhando com uma jovem que entrou em tratamento por episódios de comportamento suicida, ideação suicida, transtorno de compulsão alimentar e disfunção interpessoal grave. Seus padrões interpessoais repetitivos eram de dois tipos. Quando achava que alguém era competente ou admirável, ela experimentava auto-ódio e vergonha. Quando pensava que alguém era menos competente do que ela, ficava intensamente irritada com essa pessoa. O resultado de qualquer um desses padrões a deixava distante dos outros e incapaz de preencher a lacuna. Como resultado, estava isolada e solitária.

Depois que seus padrões suicidas e comportamentos alimentares compulsivos diminuíram no início do tratamento, passamos a focar cada vez mais na disfunção interpessoal. Ao analisar as cadeias relacionadas a todos os seus alvos de tratamento, desde comportamentos suicidas até disfunção interpessoal, foi possível identificar um certo padrão. Descobrimos que no início de cada cadeia, um evento antecedente disparava a convicção de que algo estava profundamente errado com ela, a ponto de ela querer acabar com a própria vida. A vergonha associada podia ser temporariamente reduzida por meio de compulsão alimentar seguida de purgação. Foi nesse contexto que entendemos as origens de sua irritabilidade com os outros que eram mais ou menos competentes do que ela: quando a convicção de que algo estava profundamente errado era ativada, ela desviava seu auto-ódio para os outros. Ficou mais claro que a declaração *“há algo profundamente errado comigo”* era um elo discreto e previsível, uma espécie de “ponto de mudança” por meio do qual suas cadeias do comportamento passavam a caminho de resultados sociais e emocionais indesejáveis. Começamos a

avaliar e direcionar esse elo. Identificamos inúmeros eventos que provocavam a crença “*há algo profundamente errado comigo*” e as consequências típicas desse elo. Compreensivelmente, a paciente queria entender as influências precoces da vida que a levaram a se sentir dessa maneira, e exploramos alguns aspectos relevantes de sua história de aprendizado. Esclarecer o contexto histórico foi interessante, mas não levou à mudança comportamental. Eu reconheci que precisávamos ser muito específicos sobre a cadeia de comportamentos que levavam a essa resposta cognitiva disfuncional, “roteirizar” um padrão de resposta mais adaptativo e ajudá-la a substituir efetivamente a resposta adaptativa pela disfuncional.

Felizmente, em algumas ocasiões esse padrão disfuncional surgia durante as sessões comigo, em resposta a algo que eu dizia ou fazia. De fato, à medida que prestávamos mais atenção, podíamos ver que surgia em quase todas as sessões. Sua convicção de sua “maldade” era acionada tão silenciosa e automaticamente que ela não tinha ideia de que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Quando notávamos, ela já se sentia desmoralizada, já havia se afastado de nossa interação, estava convencida de que era uma “pessoa má” e não conseguia ver uma saída. Tínhamos que encontrar uma maneira de mudar o curso da cadeia que levava ao elo problemático. Ver claramente o papel avassalador dessa convicção de uma única frase, anteriormente não identificada, foi um momento poderoso de *insight* para ela.

É claro que esse único elo em particular, a autoafirmação de que “*há algo profundamente errado comigo*”, gradualmente se ligava a uma resposta mais complexa que incluía componentes emocionais e de ação. A autoafirmação exercia um impacto paralisante, operando como uma farpa que eventualmente leva a uma resposta inflamatória que não pode mais ser ignorada. Às vezes, surgia como raiva em relação à outra pessoa, o que

disfarçava o ódio em relação a si mesma. Em outras ocasiões, ela se tornava inexplicavelmente inarticulada, cautelosa e rígida em seu pensamento quando algo havia acontecido entre nós que ativava seu auto-ódio. Ainda assim, a solução tinha que envolver a remoção da farpa – ou seja, ver a autoafirmação escondida, mas prejudicial, e substituí-la por alternativas adaptativas. Com o tempo, mesmo antes do processo de autocondenação vir à consciência, ela e eu começamos a ser capazes de “sentir” a presença desse complexo incoerente, de autodúvida e auto-ódio, à medida que entrava na conversa.

Ao “pegá-lo” mais cedo, ela ganhou uma medida maior de controle. No ponto em que podia vê-lo e senti-lo enquanto acontecia, quando ela podia “segurá-lo” em vez de seguir os velhos padrões, tornou-se possível para nós desenvolver habilidades para modificação do seu pensamento de que *“há algo profundamente errado comigo”*. Ao longo do tempo, ela experimentou várias habilidades. Uma delas era observar e descrever qualquer evento desencadeante que tivesse acionado sua crença de que era ruim e, em seguida, encontrar uma maneira não julgadora de reformular sua interpretação do evento. Por exemplo, um episódio intenso de autocrítica foi desencadeado durante uma sessão de terapia quando sugeri algo para ler. Ela ficou inibida e mais rígida. Eu apontei o padrão. Imediatamente, ela “se pegou no ato” de se odiar. Rapidamente identificou o evento que a provocou: ela havia interpretado automaticamente minha sugestão de algo para ler como uma indicação de que eu achava que ela era estúpida. Ela parou, recuou e observou seu auto-ódio, sua vergonha, as sensações corporais associadas, e descreveu suas observações para mim. Ao ver o processo enquanto acontecia, o impacto negativo já havia sido amenizado. Eu a incentivei a reformular minha sugestão de maneira não julgadora e não condenatória. Uma vez que ela viu que tinha opções, ela reformulou minha comunicação. Em vez de dizer para si mesma:

“Ele acha que eu sou estúpida, então está me indicando algo para ler”, ela disse a si mesma: “Ele me respeita o suficiente para sugerir algo para ler”.

Em outros momentos em que seu auto-ódio foi ativado, ela usou a habilidade de “verificar os fatos” da situação, procurando evidências de que era uma “pessoa ruim” e que havia feito algo errado. Embora às vezes ela pudesse identificar maneiras pelas quais estava decepcionada consigo mesma, raramente conseguia encontrar evidências de que era de fato uma pessoa ruim. Ao se familiarizar mais com sua própria cadeia do comportamento, ao localizar os elos ou sequências disfuncionais e ao ter um conjunto de opções habilidosas à mão para substituir os elos disfuncionais, essa paciente se tornou mais versátil em quebrar o processo invisível e rígido antes que se solidificasse e causasse danos. Ela se tornou mais capaz de pensar em si mesma de maneira objetiva e realista e de se flagrar cedo no caminho dos antigos padrões de autocrítica.

Este exemplo nos leva ao trabalho relacionado às habilidades que ocorre dentro do modo de terapia individual. O terapeuta ajuda o paciente a trazer habilidades para sua vida e para as sessões. Ele divide as habilidades em sub-habilidades quando isso ajuda o paciente a entender os impedimentos e apontar o caminho para soluções. O terapeuta encontra onde e como o paciente pode “inserir” habilidades específicas na cadeia do comportamento à medida que se desenrola. Isso muitas vezes requer um trabalho cuidadoso, compassivo, preciso e dedicado. Em geral, para fornecer o valor completo do treinamento em habilidades, o terapeuta precisa “entrar nas trincheiras” com o paciente, manter a situação estável, iluminar o processo, permanecer engajado e intervir na substituição de elos e no estudo e mudança da dinâmica interligada. O trabalho é gradual e às vezes tedioso, mas quando um paciente aprende uma habilidade para substituir um elo disfuncional na cadeia, uma vida pode ser transformada.

QUALQUER HABILIDADE PARA QUALQUER SITUAÇÃO

Em *workshops*, Linehan explicou que o maior teste para um treinador de habilidades em DBT é encontrar uma maneira de usar qualquer habilidade em qualquer situação. Em outras palavras, ela propõe que as habilidades em DBT são “ferramentas multiuso”. Para fins heurísticos, categorizamos os módulos de habilidades como “módulos de aceitação” (habilidades centrais de *mindfulness*, habilidades de tolerância ao mal-estar) ou “módulos de mudança” (habilidades de regulação emocional, habilidades de efetividade interpessoal). Essa categorização é congruente com a dialética geral de aceitação e mudança em DBT e fornece uma maneira fácil de apresentar as habilidades aos pacientes. No entanto, a proposição de que existem “habilidades de mudança” e “habilidades de aceitação” é excessivamente simplista e limitante. Na verdade, as habilidades são agregadas de comportamentos específicos (sub-habilidades) realizados em sincronia. Uma habilidade específica pode servir a uma infinidade de funções em diferentes contextos, e, dentro de uma habilidade, pode haver sub-habilidades com “subpropósitos” diferentes. As habilidades são altamente versáteis. Uma pessoa habilidosa tem muita flexibilidade. As habilidades de *mindfulness*, apresentadas como um módulo de aceitação, podem ser poderosos agentes de mudança. A validação, embalada dentro do módulo de habilidades de efetividade interpessoal orientadas para a mudança, fornece aceitação a serviço de mudar o comportamento de outra pessoa. A validação em outro contexto, no qual validamos a emoção primária de alguém, pode resultar em uma exposição maior a essa emoção, com o resultado de uma modulação emocional melhorada (e mudada). “Agir de forma oposta” ao impulso associado a uma emoção (uma das habilidades de regulação emocional orientadas

para a mudança), embora possa ser usada para mudar respostas emocionais, também pode ajudar o indivíduo a agir com aceitação em relação a uma realidade desagradável da qual ele tem o impulso de fugir. A realidade é muito complexa e dialética em sua natureza, e as habilidades são muito versáteis e complexas em si mesmas, para ficarmos com categorias simplificadas de habilidades de aceitação e mudança. A mudança requer aceitação. Aceitação requer mudança. Qualquer habilidade pode ajudar com a aceitação, mudança e síntese dialética. O currículo de habilidades multifuncionais da DBT é versátil, e cada habilidade tem o potencial de ser usada para mudança, aceitação ou dialética.

USANDO PARADIGMAS E PRINCÍPIOS DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA NO TREINAMENTO DE HABILIDADES

O trabalho de um treinador de habilidades é estruturado e roteirizado, conforme descrito no *Treinamento de habilidades em DBT* (Linehan, 2018b). Em primeiro lugar, ele mesmo precisa dominar as habilidades. Em segundo lugar, orienta os pacientes sobre as metas do treinamento de habilidades e as diretrizes para participação. Organiza a agenda da sessão de acordo com três alvos prioritários: 1) impedir comportamentos que destroem a terapia; 2) aumentar a aquisição e o fortalecimento de habilidades; e 3) reduzir comportamentos que interferem na terapia. O treinador segue um programa predefinido e, em cada sessão, conduz o grupo por uma sequência que passa por uma prática de *mindfulness*, revisão de tarefas de casa, intervalo, ensino de novas habilidades, atribuição de tarefas de casa e encerramento. Ele aprende os meios preferidos para lidar com cartões diários, revisar as tarefas dos participantes, lidar com a falta de cumprimento de tarefas de casa e manejar comportamentos problemáticos no grupo.

Além disso, o treinador de habilidades de DBT traz um arsenal de estratégias da DBT para seu trabalho em grupo. Ele implementa o protocolo de treinamento de habilidades em grupo padronizado com estratégias de solução de problemas, comunicação irreverente, validação, comunicação recíproca e estratégias dialéticas. Além disso, suas intervenções surgem dos mesmos paradigmas e princípios que informam o trabalho do terapeuta individual quando implementa o direcionamento, a análise em cadeia do comportamento, a formulação do caso, o comprometimento e outras estratégias. Dessa forma, o grupo é baseado nos mesmos fundamentos que o restante da DBT, criando

uma sinergia entre o formato do grupo e outros modos. Como o treinador de habilidades está trabalhando para manter um grupo de indivíduos emocionalmente desregulados no caminho certo para aprender todas as habilidades de maneira oportuna, ele enfrenta empurrões e puxões, momentos animados e segmentos parados, e descontrole e supercontrole comportamentais. Ao se ancorar nos princípios da DBT, dos quais as estratégias fluem, ele traz mais flexibilidade, fluidez e confiança para o seu trabalho em grupo. Ao informar e respaldar os protocolos e estratégias com princípios, o terapeuta pode aprimorar a precisão e o rigor do treinamento de habilidades, entregá-lo com mais presença, consciência e aceitação e navegar pelos desafios com maior velocidade, movimento e fluxo.

Princípios do paradigma da mudança

Assim como é feito na terapia individual, o treinador de habilidades em grupo organiza a agenda da sessão de acordo com os alvos prioritários. Seu alvo mais importante e necessário é a redução dos comportamentos que destroem o grupo. Quando esses comportamentos não estão presentes, seu alvo prioritário consiste na aquisição e no fortalecimento de habilidades pelos pacientes no grupo. Este é o alvo preferido, já que o treinador preferiria, se possível, gastar 100% do tempo da sessão nele. O terceiro alvo prioritário é a redução dos comportamentos que interferem na terapia por parte dos membros do grupo, ou seja, aqueles comportamentos que interferem na aprendizagem individual, mesmo que não contribuam para a destruição do grupo para os outros. Podemos considerar o processo de direcionamento como um princípio, já que ele está constantemente fornecendo direção ao grupo. Acompanhando o foco no direcionamento está o monitoramento do progresso comportamental. Isso acontece com a ajuda do diário, no qual o treinador de habilidades pode revisar o

progresso de cada paciente na utilização das habilidades a cada semana.

Tendo estabelecido a direção e a persistência por meio de direcionamento e monitoramento, o treinador de habilidades impulsiona o grupo e cada membro dentro dele em direção ao comprometimento máximo possível para aprender e usar as habilidades. Ele trabalha para 1) chamar a atenção dos membros do grupo para as tarefas, 2) estabelecer relação e cultura que encorajam a participação e a esperança, e 3) utilizar as estratégias de comprometimento da DBT conforme necessário com cada membro. Muitas intervenções dos líderes do grupo e o tom com que são entregues são impulsionados pelo contínuo foco no direcionamento, no monitoramento e no comprometimento.

Além dessa agenda, com o intuito de ajudar cada paciente a notar e superar obstáculos para a aquisição e o fortalecimento de habilidades, o treinador de habilidades é informado pelos princípios de mudança comportamental que estão por trás dos quatro procedimentos de mudança na DBT.

1. A teoria do déficit de habilidades propõe que as deficiências no repertório de habilidades do indivíduo são responsáveis pelos processos e resultados problemáticos e que o treinamento de habilidades é a solução.
2. O modelo de mediação cognitiva das emoções e ações postula que crenças problemáticas levam a comportamentos problemáticos e sugere procedimentos de modificação cognitiva como solução.
3. O modelo do condicionamento clássico, ou respondente, propõe que o pareamento de estímulos na mente do indivíduo resulta em reações emocionais intensas a estímulos relativamente neutros e que essas emoções intensas levam a respostas comportamentais problemáticas; estratégias de

controle de estímulos e procedimentos de exposição são prescritos como tratamento.

4. O modelo do condicionamento operante, ou instrumental, propõe que comportamentos problemáticos direcionados são reforçados por consequências e que o uso efetivo de procedimentos de manejo de contingências é a solução.

Teoria do déficit de habilidades

Manter esse modelo em mente alerta o terapeuta para certos tipos de fenômenos e o direciona para certos tipos de intervenções em todo o grupo. O treinador de habilidades que está rotineiramente procurando por déficits em habilidades emocionais e interpessoais conforme ocorrem no ambiente do grupo é mais provável de notá-los quando ocorrem e abordá-los imediatamente. Na medida em que a DBT é fundamentalmente um “modelo de substituição”, ajudando o paciente a fazer “isso em vez de aquilo”, o treinador de habilidades desenvolve “reflexos de substituição”, destacando reflexivamente déficits de habilidades e sugerindo imediatamente ou criando alternativas comportamentais. O terapeuta pode dizer: “Por que você não olha para mim enquanto fala comigo sobre sua tarefa de casa para ver minhas reações em vez de assumir que estou te criticando?” ou “Você acha que poderia expressar sua raiva comigo sobre essa tarefa sem gritar ou me xingar?”. O terapeuta não só aproveita as oportunidades no momento para obter comportamentos mais habilidosos do paciente, como aproveita todas as oportunidades para reforçar quaisquer comportamentos habilidosos que surjam por conta própria. Em outras palavras, enquanto segue o currículo e ensina as habilidades, ele está aplicando simultaneamente princípios de treinamento de habilidades quando os déficits se tornam perceptíveis e quando as habilidades são aplicadas. Na melhor das hipóteses, o resultado é um laboratório de treinamento de

habilidades, no qual novos comportamentos são experimentados, comportamentos habilidosos são imediatamente reforçados e a moral aumenta. Na pior das hipóteses, se for feito de forma muito rígida e sem equilíbrio, esse tipo de foco implacável em substituir déficits por habilidades pode ser opressivo. A aplicação dos princípios de habilidades deve ser equilibrada com sensibilidade, *timing* e tato.

Nós aplicamos os princípios de treinamento de habilidades não só com cada indivíduo, mas também ao estabelecer uma atmosfera ótima para todo o grupo, tentando criar uma cultura baseada na prática. O terapeuta não apenas recomenda prática *in vivo* entre as sessões e segue com a revisão das tarefas de prática, como também promove uma rotina de “fazer de novo” dentro do grupo de habilidades. “Agora que você recebeu alguns comentários sobre seu *role-play*, tente novamente” ou “Agora que todos vocês tiveram a chance de ver como é continuar ‘observando’ enquanto andamos pela sala e de ouvir um ao outro ‘descrever’ a experiência, vamos fazer isso de novo por dois minutos e ver o que vocês notam desta vez”. A prática de fazer de novo no ambiente do grupo cria a sensação de que também há segundas chances na vida, que a vida pode ser mais perdoável e modificável do que se pensava anteriormente, que as oportunidades para mudar estão em toda parte e que “erros” podem ser oportunidades para mudança e melhoria em vez de constrangimento e auto-ódio.

Os três passos do treinamento de habilidades discutidos anteriormente neste capítulo (aquisição, fortalecimento e generalização) não precisam ser usados de maneira sequencial. Eles são altamente interdependentes, não precisam ser feitos em uma sequência rigorosa e, juntos, moldam todo o treinamento de habilidades. Por exemplo, a atenção ao terceiro passo da generalização de habilidades desde o início da sequência fornece uma justificativa para a aquisição e o fortalecimento de uma

habilidade. Em outras palavras, vincular o ensino e o fortalecimento da habilidade (aquisição e fortalecimento) ao seu destino (generalização) desde o início fortalece todo o processo. Isso é semelhante ao professor de matemática que vincula a equação em discussão a problemas da vida real como uma forma de aumentar o senso de relevância, aumentando assim a motivação. Em suma, a atmosfera do grupo que é conduzida com os princípios de treinamento de habilidades em mente é amplamente influenciada pela substituição de déficits por habilidades, pela prática de novos comportamentos e pela vinculação das novas habilidades aos contextos relevantes da vida dos pacientes.

Teoria de mediação cognitiva

Mantendo a teoria de mediação cognitiva em mente, o treinador de habilidades está alerta à presença de cognições problemáticas à medida que ocorrem nos membros do grupo. Assim como o treinador de habilidades desenvolve reflexos de substituição para perceber déficits de habilidades e sugerir substituições mais habilidosas, ele também tem “reflexos cognitivos” para perceber cognições problemáticas à medida que ocorrem, destacando-as imediatamente de uma maneira ou de outra e às vezes sugerindo substituições cognitivas na hora. Ele pode responder ao paciente que diz “Eu simplesmente não consigo”, dizendo: “Esse tipo de pensamento certamente não ajudará você a mudar; que tal tentar “eu acho que posso fazer isso, mas sei que será realmente difícil?”. Em outras ocasiões, sua intervenção pode ser tão breve quanto uma pincelada, destacando momentaneamente que a convicção pessimista de um paciente é um pensamento em vez de um fato e, em seguida, seguindo em frente. A ênfase do treinador em que “erros de pensamento”, como julgar, culpar, catastrofizar, superestimar e generalizar em excesso, são acompanhamentos

naturais de estados de humor difíceis e ansiedade e são resultados naturais de ambientes invalidantes cria um contexto de validação para o reconhecimento de cognições problemáticas, ao mesmo tempo em que aponta que elas são “nada mais do que pensamentos”. Tratar pensamentos problemáticos como comportamentos que podem ser reconhecidos e mudados, assim como ações deficientes podem ser reconhecidas e mudadas, acrescenta ainda mais à atmosfera de laboratório mencionada anteriormente.

Teoria do condicionamento clássico

No condicionamento clássico (ou respondente), um estímulo específico, que pode ser relativamente neutro em um sentido objetivo, automaticamente desencadeia uma emoção intensa, porque o estímulo é emparelhado na mente do paciente com estímulos anteriores que desencadearam experiências dolorosas. Por exemplo, ter uma conversa objetivamente “inofensiva” com um homem pode desencadear um medo intenso porque está emparelhado na mente do paciente com experiências anteriores com homens em que conversas supostamente inofensivas precederam comportamentos abusivos. O indivíduo pode refletir sobre a evitação de qualquer proximidade com o estímulo evocativo e escapar de qualquer experiência da emoção dolorosa. A evitação e a fuga impedem novos encontros com o estímulo e a emoção, o que, por sua vez, impede oportunidades de aprendizado corretivo. Procedimentos de exposição bloqueiam as respostas de evitação e fuga e ajudam o paciente a estabelecer e manter contato com o estímulo e a emoção por tempo suficiente para que ocorra um novo aprendizado. Esse novo aprendizado leva a uma resposta mais razoável e objetiva ao estímulo.

Ao visualizar o grupo de habilidades por meio dessa perspectiva, o treinador de habilidades fica alerta a fenômenos

semelhantes à medida que ocorrem no grupo. Em primeiro lugar, percebe que, ao trabalhar com indivíduos que experimentam uma disfunção emocional crônica e difundida, os estímulos estão em *toda parte*. O contexto do grupo apresenta estímulos neutros que podem desencadear ansiedade, pânico, susto, repulsa, raiva, tristeza, amor e outras respostas intensas. A presença de vários outros pacientes, ou um paciente em particular com características específicas, pode desencadear sentimentos de pânico, associados a memórias de ter sido preso, provocado, intimidado ou maltratado por outros. A entrega de *feedback* crítico construtivo, mesmo que formulado em termos gentis, pode desencadear memórias e sentimentos relacionados a pensamentos de acusação, vergonha e rejeição anterior na vida. A expectativa de revisar as tarefas práticas no contexto do grupo pode desencadear em pacientes memórias e emoções de exposição, vergonha e abuso físico. A lista continua. O treinador de habilidades permanece alerta a essas possibilidades, percebendo que, devido ao aprendizado anterior, um “galho” para uma pessoa pode ser uma “cobra” para outra pessoa. Ele leva a sério as respostas de cada um, está pronto para validar uma variedade de reações diferentes à mesma experiência e está pronto para sugerir que cada indivíduo, dentro do contexto do grupo, encontre maneiras de lidar com os estímulos normativos do grupo e lidar com as respostas emocionais sem interferir no aprendizado, engajando-se em comportamentos de evitação e fuga.

O indivíduo que rotineiramente evita esses estímulos e, assim, escapa de respostas emocionais acionadas por eles, quando na verdade os estímulos não são inerentemente perigosos para sua vida ou bem-estar, está inadvertidamente perpetuando essas respostas padronizadas. As implicações para o treinador de habilidades são várias. Em primeiro lugar, ele precisa estabelecer um ambiente de grupo objetivamente seguro e solidário, para que as respostas emocionais avassaladoras ocorram em um contexto

que não é, de fato, aversivo. Por conseguinte, o treinador de habilidades mantém uma atitude básica de tranquilidade, amizade e responsividade. Além disso, enquanto valida as fortes respostas emocionais dos pacientes e seu impulso de evitar e escapar, o treinador de habilidades age consistentemente a favor da não evitação e do não escape, de “aguentar firme” e lidar habilidosamente com os estímulos. Ele reluta em modificar os estímulos reais, a menos que sejam realmente problemáticos, já que fazê-lo apenas reforça a evitação e o escape e comunica a mensagem de que o paciente é muito frágil para a vida normativa de um grupo de habilidades bem conduzido. O treinador de habilidades cria uma atmosfera de grupo que apoia todos trabalhando juntos para notar e confrontar os estímulos e as reações condicionadas de forma clássica, por meio de: 1) escanear rotineiramente as respostas emocionais acionadas e os comportamentos de evitação e escape; 2) reconhecer e validar as respostas e impulsos acionados; 3) manter estímulos onde estão se forem normativos e não perigosos; e 4) incentivar cada paciente a enfrentar habilidosamente os estímulos e as emoções em vez de fugir e se esconder. Uma atmosfera de coragem e resiliência para todo o grupo se traduzirá em coragem e resiliência para cada membro.

Pode parecer óbvio, mas também pode valer a pena mencionar que o uso de princípios de procedimentos de exposição, que fluem da teoria do condicionamento clássico, é parte integrante do treinamento de habilidades. Pedir a um paciente para abandonar um comportamento desadaptativo habitual e substituí-lo por uma resposta nova e mais habilidosa automaticamente expõe o paciente a emoções e pensamentos que podem ser desconfortáveis e angustiantes. Nesse ponto, o treinador de habilidades deseja ajudar o paciente a *permanecer* com o novo comportamento, encontrar as respostas temidas, não evitar e não fugir, além de trazer novo aprendizado mantendo contato com os

estímulos. O treinador de habilidades transmite uma atitude de “você pode fazer isso”, “agente firme” e “eu posso ajudá-lo a lidar com esses estímulos” por meio de comentários e ações. Essa é outra razão pela qual as práticas e os exercícios em grupo, como *role-playing*, podem ser tão úteis. Eles fornecem a oportunidade perfeita para ajudar o paciente a se *aproximar* de uma situação temida, agindo opostamente à tendência de ação. Igualmente importante, o treinador de habilidades assegura a cada paciente, quando solicitado a fazer algo novo e assustador, que ele pode optar por sair, adiar ou fazê-lo em seu próprio ritmo. Os pacientes precisam estar no controle de suas próprias exposições.

Teoria do condicionamento operante

Manter a teoria do condicionamento operante em mente aumenta a consciência do terapeuta sobre a presença contínua e o poder de recompensa, extinção e punição. Não há um minuto sequer em um grupo de habilidades sem a influência das contingências sobre o comportamento atual. Como tal, o treinador de habilidades tenta estabelecer uma cultura na qual comportamentos habilidosos são rotineiramente reforçados e comportamentos desadaptativos não são. O reforço deve estar disponível para o esforço aplicado, riscos assumidos, participação e prática; para a colaboração intragrupo de apoio, validação e respostas de apoio uns aos outros. Ajuda se os treinadores de habilidades forem otimistas (sem serem irreais), operarem com um senso de facilidade e interesse e trabalharem para uma atmosfera de grupo que inclua humor, cordialidade e diversão. Essas qualidades de uma cultura de grupo, consistentemente cultivadas pelos treinadores, criam um ambiente de aprendizagem que reforça a presença, o esforço, a participação, a colaboração e a aprendizagem de novas habilidades.

Tendo consciência de que diferentes indivíduos são reforçados por diferentes respostas, pode ser desafiador para um líder em um ambiente de grupo saber como reforçar diferentes membros. Na verdade, o que reforça um indivíduo pode até ser aversivo para outro. Por exemplo, o terapeuta pode usar elogios para um membro do grupo porque serve como reforço para ele, enquanto outro indivíduo no mesmo grupo, para quem o elogio é aversivo, pode recuar da participação porque “os elogios estão no ar”. Embora não haja uma resposta simples para essa questão, o líder de grupo habilidoso que mantém uma apreciação dos princípios do manejo de contingências gradualmente conhecerá cada paciente o suficiente para reforçá-lo de acordo.

Princípios do paradigma da aceitação

Anteriormente, foram identificados e discutidos cinco princípios associados ao paradigma da aceitação da DBT: 1) consciência do momento presente; 2) desapego; 3) interexistência; 4) impermanência; e 5) “o mundo é perfeito como é”. Tecer esses princípios de forma abrangente na condução de um grupo de treinamento de habilidades contribui para um contexto no qual a conscientização e a aceitação do momento presente são promovidas e no qual estratégias de validação e estratégias de comunicação recíproca são usadas com frequência.

Consciência do momento presente

A prática de *mindfulness* que inicia cada sessão de treinamento de habilidades, além de modelar o uso prático de uma habilidade de *mindfulness*, traz a atenção de todos para o momento presente. Esse esforço para deixar o passado e o futuro de lado em favor de habitar o momento presente estabelece o tom de aceitação e consciência quando o grupo começa. Isso serve como um limiar pelo qual todos os indivíduos na sala entram na sessão, e o

treinador de habilidades trabalha para estender o estado de aceitação e momento presente para o restante da sessão em grupo. Se o grupo é agradável ou desagradável não é o ponto principal. Assim como as práticas de *mindfulness* que se concentram na consciência do momento presente (p. ex., “este momento é o único momento” ou “apenas esta” [durante a inalação] respiração [durante a exalação]”), o líder trabalha para trazer o grupo inteiramente para a sessão atual. Ele faz o que pode para chamar a atenção de todos e transmitir que esse grupo é significativo, relevante, até precioso. Embora a agenda do grupo esteja sempre cheia e haja a tendência a se apressar, a consciência do momento presente ajuda a criar uma sensação de amplitude que é reforçada por pausas, reflexões e práticas breves.

Desapego

Esses grupos podem ser difíceis. Mesmo que o grupo seja bem estruturado e bem gerenciado, e mesmo que as habilidades sejam bem ensinadas, sempre há desafios quando reunimos seis a oito indivíduos com disfunção emocional, padrões de pensamento dicotômico, funcionamento interpessoal problemático e tendência a julgamentos sobre si mesmos e os outros. O clima pode estar cheio de ansiedade e tensão, tédio e inquietude, pessimismo e cinismo – muito diferente do clima otimista e colaborativo ideal. O treinador de habilidades tem a oportunidade de modelar a facilidade e o fluxo como um contraponto à tensão e à ansiedade, a paciência e a compaixão como um contraponto à inquietude e ao julgamento, e a aceitação do momento atual como ele é como um contraponto às vontades de evitar e escapar. Dado que a disfunção emocional em todo o grupo pode criar um ímpeto para afastar a realidade do momento e se apegar a “como as coisas *deveriam* ser”, é a oportunidade perfeita para o terapeuta modelar o desapego. Ele pode “deixar ir” seu apego ao “grupo ideal” e

realmente abraçar o grupo *como ele é*, com todas as suas falhas. Ele pode (metaforicamente, e em alguns casos, realmente) sorrir para o desconforto, sorrir para os julgamentos e abraçar o momento com todas as suas tensões e promessas. Além de ensinar as habilidades do dia, o treinador tem a chance de demonstrar reações tolerantes e habilidosas à disfunção emocional, fornecendo assim uma experiência corretiva. Praticar o desapego no momento atual com o grupo como paciente pode fornecer o equivalente ao terapeuta que, ao tratar uma fobia, modela a abordagem da fobia com calma em contraste com a evitação, a fuga e o terror do paciente.

Previsivelmente, o momento em que o treinador de habilidades inicia as revisões das atribuições de prática dos pacientes gera ansiedade e autoconsciência aumentadas. Os pacientes podem antecipar serem colocados em evidência, expostos por não estarem praticando, ou criticados por serem menos que perfeitos. É uma oportunidade para o terapeuta modelar o desapego à “prática de tarefa de casa como deveria ser”, ao mesmo tempo em que aceita e trabalha com o desempenho real dos pacientes.

Interexistência

O treinador de habilidades que pode permanecer consciente da profunda inter-relação momento a momento e da influência mútua entre todos os indivíduos na sala e que pode ver como o grupo funciona como um organismo único, sem fronteiras e sem *selves* separados, pode contribuir para o senso de que “estamos todos juntos nisso”. Através dessa lente, o treinador de habilidades é composto inteiramente por membros do grupo, e os membros do grupo são compostos inteiramente pelo treinador de habilidades e uns pelos outros. Todos são tratados como iguais. Todos são tratados como indivíduos que estão no caminho de construir uma vida que vale a pena ser vivida, adquirindo e fortalecendo

habilidades; todos os caminhos estão entrelaçados e são mutuamente influentes. Todos importam. Se alguém está ausente, todos estão parcialmente ausentes. Se alguém participa voluntariamente, então, até certo ponto, todos participam voluntariamente. Ao visualizar o grupo dessa maneira, como uma equipe, trabalhando em prol das mesmas metas, com membros influenciando uns aos outros minuto a minuto, empurrando todos em direção a suas metas de viver uma vida que valha a pena ser vivida, o terapeuta ajuda os membros do grupo a se sentirem como partes significativas e interconectadas. Sentir-se como partes integrantes de um todo positivo (não apenas *selves* separados, mas parte de algo maior) oferece aos pacientes um antídoto para o isolamento e a estagnação.

Impermanência

O princípio da impermanência surge naturalmente em conjunto com os outros princípios discutidos até agora. Reconhecemos que o momento presente, a sessão atual do grupo, é o único momento, a única sessão do grupo. Não apegados, tentamos deixar de lado o julgamento de que “deveria ter sido diferente”. Todos os participantes do grupo chegam ao ponto em que se sentem mutuamente influenciados uns pelos outros, onde se sentem parte de um todo maior. Assim como cada um desses princípios serve como um antídoto para experiências de dor, tensão, solidão, evitação, fuga e julgamento, a consciência da impermanência do grupo, de cada sessão do grupo e da passagem de cada momento de cada grupo pode ser um antídoto para a sensação desesperançosa de que tudo (ruim) permanece o mesmo, que nada nunca muda. O terapeuta mantém o grupo avançando, comentando sobre o progresso feito no currículo. Ele destaca as mudanças que os pacientes fazem e as diferenças entre os pontos de vista expressos na reunião. Enquanto ouve, enfatiza suas

contribuições, suas descobertas e suas maneiras únicas de descrever suas observações. Ele cria um sentido de movimento, descoberta e mudança. Ele conecta um determinado comentário do paciente a um anterior feito por esse paciente ou outra pessoa. De vez em quando, ele comenta sobre a singularidade do grupo em particular, comunicando implicitamente ou explicitamente a sensação de que esse grupo é especial, que todos no grupo estão trabalhando para mudar suas vidas e que o tempo está passando. Apesar da sensação de que “nada está acontecendo” para alguns indivíduos, ou de que as mesmas coisas acontecem repetidamente, o líder do grupo reforça a ideia de que as coisas estão constantemente mudando, que nada é o mesmo. É muito importante para o treinador de habilidades em grupo, quando sente que o grupo está parado e nada está acontecendo, lembrar que na verdade está mudando constantemente, que mais está acontecendo do que se pode ver, que as oportunidades estão presentes e que, se as coisas parecerem difíceis, “isso também vai passar”.

O mundo é perfeito como é

O grupo é “perfeito como é”, cheio de indivíduos, cada um dos quais “é perfeito como é”. Todos no grupo estão fazendo o melhor que podem, dadas todas as circunstâncias até o momento. Como poderia ser diferente, quando levamos em conta a história – tudo que levou a este momento? Trabalhamos repetidamente para reconhecer, aceitar e validar o funcionamento atual do grupo e de cada pessoa nele. Antídoto para a tendência de julgar e controlar uns aos outros e a nós mesmos, o indivíduo e o grupo que conseguem incorporar essa realização podem se estabelecer no momento atual, deixar de lado os julgamentos, não precisam agarrar ou se apegar ao “que deveria ser”. Eles podem permitir a

interdependência de todos no grupo e podem se concentrar no trabalho em questão: a aquisição e o fortalecimento de habilidades.

Na medida em que o treinador de habilidades em grupo pode incorporar e promover esses cinco princípios ao liderar o grupo, ele tem a chance de mover todos na direção de consciência e aceitação, reduzindo o julgamento de si e dos outros, simplesmente fazendo o trabalho do grupo e trazendo uma cultura em que é “um por todos e todos por um”.

Princípios do paradigma dialético

Como mencionado, quatro princípios estão associados ao paradigma dialético, conforme segue:

1. As oposições são inerentes à realidade; a verdade evolui por meio da síntese.
2. Os fenômenos estão inter-relacionados de maneira holística e sistêmica.
3. Tudo é transacional, inclusive a identidade.
4. A mudança é constante; a fluidez é a regra.

O instrutor de habilidades que consegue incorporar esses princípios vai promover a tolerância à diferença e ao conflito; a busca pela síntese em vez de determinar quem está certo; a sensação de velocidade, movimento e fluxo; e o sentimento de cada membro como parte do todo maior, em vez de sozinho e separado.

A realidade é preenchida por oposições; a verdade evolui por meio da síntese

Como acontece em todos os processos de grupo, o grupo de habilidades experimentará a emergência de um conflito após outro. As oposições são a regra, não a exceção. Surge uma discordância tensa entre um paciente e um instrutor de habilidades, ou entre

dois pacientes. Um conflito entre um paciente e seu psicoterapeuta ou psiquiatra é trazido para o grupo, e diferentes pacientes se alinham em lados opostos da discordância. Alguns pacientes querem “aprofundar” a explicação de suas circunstâncias, enquanto outros querem ficar na superfície. Ou, como no caso de um dos meus grupos, todos os pacientes querem fazer mais compartilhamento de coração para coração, enquanto estou tentando manter o foco nas habilidades. Há o conflito sempre presente entre a quantidade de conteúdo para ensinar e a quantidade de tempo disponível. Um paciente pode querer ficar em silêncio e recolhido para se proteger, mas maior participação resulta em mais aprendizado. Dois membros do grupo querem aprofundar um relacionamento privado, mas isso pode entrar em conflito com uma diretriz do grupo sobre relacionamentos privados. Isso continua e continua. Uma coisa é certa: o conflito é esperado. O instrutor de habilidades que entende isso não se desequilibra à medida que os conflitos surgem. Ele tem a oportunidade, repetidas vezes, de oferecer modelação para uma abordagem dialética à oposição: especificar os dois lados do conflito, buscar a validade em cada lado e mover a discussão em direção a encontrar uma síntese que preserve a validade em ambos os lados. O processo de valorizar as forças opostas e encontrar a síntese é reforçado repetidas vezes, criando um senso de confiança no grupo de que o ponto de vista de todos será valorizado e que as diferenças são normais e não precisam ser destrutivas. É outro aspecto da experiência corretiva de estar no grupo.

Fenômenos são inter-relacionados de forma holística e sistêmica

Este princípio se sobrepõe ao princípio de interdependência orientado para a aceitação. Todos no grupo fazem parte de um todo maior e são definidos, em certa medida, pelo todo. O todo do

grupo é definido pelas contribuições dos indivíduos. Uma mudança em um resulta em uma mudança em todos. Assim como o terapeuta familiar pode abordar o “paciente identificado” abordando outros membros da família, o treinador de habilidades em grupo pode abordar um membro do grupo abordando outros ou abordando o grupo como um todo. Linehan (2010) explicou o equilíbrio dialético entre paciente e terapeuta por meio da metáfora de uma gangorra equilibrada sobre uma corda bamba acima do Grand Canyon, em que os movimentos de uma das partes influenciam intimamente as experiências e os movimentos da outra. É necessária uma versão em grupo dessa metáfora para capturar a inter-relação requintada e imediata entre os indivíduos e entre si, os indivíduos e o todo. Podemos considerar os membros do grupo viajando juntos em um bote inflável de borracha descendo um rio de água cristalina. O grupo, com o líder no comando, deve navegar em condições em constante mudança que podem levar à perda de um membro ou ao naufrágio do barco. Mantendo essa metáfora em mente, o líder do grupo de habilidades provavelmente pensará de forma sistêmica ao encontrar maneiras de responder a tensões e obstáculos dentro do processo de grupo e manter todos os membros no barco e o barco à tona.

Em um dos primeiros grupos que coliderei, no contexto de um programa de tratamento diurno, tínhamos um paciente que estava na fase maníaca do transtorno bipolar. Ele demonstrava enorme entusiasmo pelo grupo e estava animado com cada habilidade e cada membro. Seu discurso pressionado e excessivo e sua euforia se tornaram uma influência disruptiva. Era fácil perceber que ele estava afastando todos. Por um lado, era um membro entusiasmado do grupo que realmente queria aprender as habilidades. Por outro, sua patologia o levava a ser disruptivo. Por um lado, ele queria participar totalmente. Por outro, as outras pessoas queriam que ele ficasse quieto. Tive a impressão de que

todos os outros ficariam mais felizes se pedíssemos que ele deixasse o grupo, mas claramente ele queria estar lá. Como líder, procurei uma síntese. Eu tinha que fazer algo para mudar o *status quo*, mas não queria expulsá-lo. Discuti isso com meu colíder e minha equipe de consultoria. Chegamos a um plano que representava uma síntese. Ele foi permitido no grupo, à mesa com todos os outros, até que se tornasse verbalmente muito avassalador. Ele receberia um pedido para suprimir sua vontade de falar. Se não pudesse cumprir, seria pedido que se sentasse em uma cadeira contra a parede, longe da mesa. Nessa cadeira, a regra era que ele não podia falar, mas podia ouvir tudo o que estava acontecendo. Dessa forma, poderia continuar aprendendo. Quando sentisse que poderia estar na mesa sem sobrecarregar os outros com seu discurso, poderia retornar. Ele ficou satisfeito com o plano porque havia sido expulso de muitos grupos no passado, e nossa abordagem honrou seu desejo de aprender. Ele saiu e voltou para a mesa algumas vezes nas próximas semanas, e isso parecia funcionar para todos. Nós o mantivemos no barco com os outros.

Tudo é transacional, incluindo a identidade

Este princípio está interligado com o anterior, enfatizando a maneira holística e sistêmica de entender a interação do grupo. A identidade de um indivíduo não é estática e isolada; é parte de uma transação. Eu sou um professor na medida em que estou em transação com um aluno. Sem o(s) aluno(s), não sou um professor. A identidade de cada membro do grupo não é estática e isolada; especialmente depois que o grupo se formou, a identidade de cada indivíduo no grupo é baseada em um conjunto de transações. Em relação a alguns grupos, me sinto um excelente professor. Sinto-me confiante, o ensino parece fácil e tudo o que faço parece funcionar. Em outros grupos, me sinto desajeitado e ineficaz.

Minha confiança diminui, perco a segurança nas minhas escolhas de ensino e toda a experiência se parece com empurrar uma pedra morro acima. É notável o quanto posso me sentir diferente sobre mim mesmo com base nas transações. Isso me ajuda quando percebo o quanto meu senso de mim mesmo depende de transações. Posso observar meus altos e baixos internos, tentar notá-los sem julgamento, tentar perceber como são influenciados pelas transações no grupo e permanecer focado na agenda de ensino. Perguntando-me como cheguei a me sentir tão ineficaz, posso perceber que um paciente no grupo me trata como se eu fosse burro e que essa única pessoa tem um impacto desproporcional sobre mim. Chego a sentir que a resposta desse único paciente a mim está definindo minha identidade em relação a todo o grupo. Se puder ver objetivamente que isso está acontecendo, posso abordá-lo dentro de mim. Ou posso notar que o grupo como um todo parece retraído, com baixa motivação, e então perceber que sua retração me levou a me sentir ineficaz. Eu me vejo trabalhando cada vez mais para envolver todos, mas não funciona. Me sinto como um fracasso. Uma vez que eu possa ver objetivamente que há um problema a ser resolvido, mas sem atribuir o problema somente à minha ineficácia, tenho uma melhor chance de abordar a queda do grupo com maior facilidade e confiança, evitando uma mudança negativa em minha identidade.

Ao perceber o quanto meu próprio senso de identidade como professor pode oscilar dependendo das transações com um membro do grupo ou com todo o grupo, assumo que isso é o caso para cada membro do grupo. Se um paciente se sente reconhecido, validado e valorizado no grupo, é mais provável que ele opere efetivamente. Se o treinador de habilidades puder manter essa compreensão em mente, ele pode observar os tipos de transações que podem explicar o comportamento de cada membro. O paciente que adquire a identidade de “paciente-problema”, “forasteiro” ou “*prima donna*” provavelmente sofrerá

com as transações resultantes. O terapeuta que percebe a natureza e o impacto das transações na identidade e no comportamento de cada membro pode encontrar maneiras de intervir para equilibrar ou mudar as transações.

Em um dos meus grupos de habilidades, no qual havia seis pacientes, apenas um deles estava em terapia individual comigo. Todos os outros tinham outros terapeutas. Quando o grupo começou, minha paciente em terapia individual desempenhava um papel construtivo com os outros e adotava uma postura ativa na aprendizagem das habilidades. Dois meses depois, ela parecia mais retraída no grupo, mais irritável e menos ativa na prática de tarefas de casa. Ela não havia dito nada na terapia individual que pudesse me ajudar a entender a mudança. Notei que, durante o intervalo, costumava estar ocupada no celular quando os outros estavam conversando entre si. Perguntei-me se as transações que ela teve com os outros no grupo poderiam explicar a mudança em seu comportamento. Na terapia individual, prossegui com a questão. No início, ela não sabia como explicar a mudança em seu comportamento. Disse que se sentia menos envolvida no grupo e não muito querida. Ela simplesmente assumiu que não era muito agradável. Conforme revisamos os dois meses, pudemos ver que seu senso de identidade no grupo havia mudado, assim como a transação com os outros membros. Depois de um começo positivo no grupo, outros membros aparentemente começaram a se distanciar dela. Ela sentiu que eles se ressentiam dela por ser uma aluna ávida, uma “exibida”, em particular porque era minha única paciente entre eles. Lembrei que ela havia feito comentários no grupo sobre discussões que havia tido comigo na terapia individual, o que excluía o resto deles e pode tê-los levado a esse ressentimento. Ela citou comentários que apoiavam essa hipótese. Foi útil para ela perceber que seu declínio no senso de identidade pode ter resultado dessa transação em vez de algo intrinsecamente ruim sobre ela. Ela trabalhou na mudança da

transação, tornando-se parte do time, dando *feedback* positivo aos outros membros e se distanciando de mim durante as sessões em grupo. A transação mudou e seus sentimentos sobre si mesma se tornaram mais positivos.

A mudança é constante

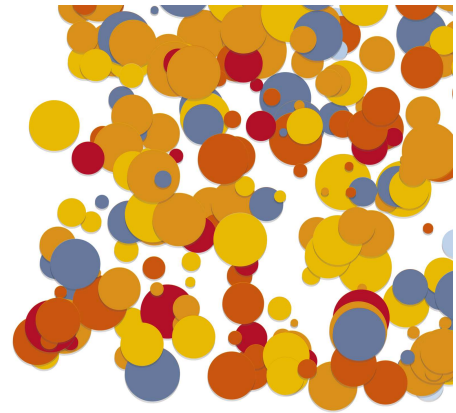
Este princípio da dialética tem seu equivalente no princípio orientado para a aceitação da impermanência. Dentro do grupo, tudo está em movimento, tudo está mudando, nada fica igual por um minuto, apesar da sensação às vezes de que as coisas estão estáticas e presas. As oposições estão surgindo e caindo, as sínteses estão ocorrendo, todos estão influenciando todos os outros e o senso de identidade de todos está evoluindo em resposta à interação do grupo. O treinador de habilidades que pensa que o grupo está preso e estagnado pode sentir que cabe a ele criar movimento. Enquanto desafia o grupo a se tornar mais ativo, ele pode pensar em si mesmo como a força do movimento, enquanto pensa no resto do grupo como unido por trás da estase. Se, em vez disso, permanecer ciente de que a mudança está ocorrendo de fato, que as forças estão trabalhando “abaixo da superfície”, ele pode deixar de pressionar tanto, enquanto observa e intervém com menos pressão e mais imaginação. Em vez de assumir que as forças da mudança estão localizadas nele, em oposição às forças de preservação localizadas nos pacientes, ele assume que a mudança está realmente em andamento e que é seu papel avaliar a situação e facilitar essa mudança em direção à aquisição e ao fortalecimento eficaz de habilidades.

Quando eu estava ensinando habilidades interpessoais a um grupo restrito e retraído, me vi trabalhando duro para ensinar de maneira mais animada e divertida. Ainda assim, sentia como se estivesse tentando arrastar um batalhão de soldados relutantes para a batalha. Sentia-me frustrado e ineficaz. Eu estava cobrindo

o material, mas não envolvendo o grupo com sucesso. Assim como mencionei anteriormente, cheguei a sentir que cabia a mim movimentar o grupo, como se tivesse que injetá-los com energia. Lembrei-me de que, apesar de todas as aparências, o grupo estava cheio de energia e estava em constante mudança. Imaginei isso como um rio no inverno com uma superfície de gelo que parecia sólida e presa, mas com uma forte corrente de água fluindo por baixo. Eu tinha que descobrir como quebrar o gelo e permitir que a energia movesse os membros do grupo para maior envolvimento, para que pudessem aprender de forma mais ativa. Uma vez que enquadrei o problema nessa metáfora, uma intervenção me ocorreu. Percebi que poderia estar participando da estagnação ao pressioná-los para se envolverem. Em vez disso, comecei a próxima sessão, sem mais introduções, envolvendo cada um deles em *role-playing* nos quais meu papel era o de um pai distante e teimoso, enquanto eles interpretavam os papéis de crianças pedindo ao pai para se envolver com elas. Eles gostaram do exercício. Foi divertido, bastante animado e pudemos identificar maneiras mais e menos habilidosas de pedir a alguém para mudar. Ao me colocar no papel do objeto imóvel e colocá-los no papel da força de mudança, o gelo foi quebrado e a mudança foi visível e produtiva.

COMENTÁRIOS FINAIS

A tensão e a oposição são inerentes às configurações de grupo. Embora a agenda estruturada de um grupo de treinamento de habilidades, focado na tarefa de aprender e praticar habilidades, ajude a estabelecer a ordem de uma sala de aula bem gerenciada, as tensões e oposições ainda estão presentes o tempo todo. Estratégias lineares de solução de problemas, incluindo uma gama de opções, ajudarão a manter o grupo no caminho certo. Estratégias orientadas para a aceitação baseadas em *mindfulness* e na validação ajudam os pacientes a reduzirem o sofrimento e tolerarem o mal-estar. Ainda assim, as tensões surgem dentro e ao redor de cada sessão de grupo. O treinador de habilidades que está familiarizado com os princípios da oposição em direção à síntese, com o pensamento sistêmico, com a forma como as transações podem influenciar a identidade e com o princípio do fluxo (movimento e mudança constantes) tem uma infinidade de ferramentas para permitir o conflito, validar ambos os lados de um conflito, encontrar sínteses, ampliar sua perspectiva sobre conflitos atuais e manter a velocidade, o movimento e o fluxo. Os membros do grupo aprendem muito ao fazerem parte de um processo no qual a polarização é tratada de forma dialética.



Prevenção e tratamento de *burnout* do terapeuta

Tratar indivíduos com desregulação emocional crônica e grave, mau julgamento e impulsividade desafiaria as capacidades de qualquer terapeuta em permanecer presente, conectado e envolvido. Como qualquer terapeuta da terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) atestaria, somos repetidamente expostos a estímulos evocativos relacionados ao paciente dentro e fora das sessões. A esperança implacável dos pacientes pode provocar nossa própria falta de esperança, tristeza e impotência. Sua abordagem passiva para solução de problemas pode ser desmoralizante e frustrante. Ameaças de suicídio podem desencadear medo, ansiedade e, às vezes, raiva. Quando os pacientes direcionam sua raiva para nós, podemos sentir medo, ansiedade, ressentimento e frustração. Pacientes cuja desregulação contínua é conhecida dentro da comunidade social e profissional circundante podem nos causar vergonha e constrangimento. Podemos temer que nossa reputação esteja ameaçada, que nossa incapacidade de ajudá-los tenha se tornado “pública” e às vezes podemos até enfrentar consequências legais ou profissionais potenciais. Quando lidamos com pessoas emocionalmente desconectadas e de alto risco, podemos sentir ansiedade e incerteza, o que nos leva a fazer esforços frenéticos para estabelecer uma conexão com elas. Essas experiências podem nos levar a nos desconectar diante de nossos aparentes fracassos em envolver o paciente.

A forma como lidamos com respostas emocionais dolorosas e válidas influencia tanto a qualidade do tratamento quanto nosso próprio equilíbrio e resiliência. Nosso estilo de enfrentamento é modelado por nossas histórias pessoais como indivíduos e terapeutas, nossos valores e nossas filosofias de tratamento. Além desses fatores pessoais, nosso comportamento e nossas atitudes serão modelados pelas respostas de outras pessoas com quem interagimos em torno do cuidado de nosso paciente.

Já orientei muitos terapeutas experientes que admitiram se sentirem desequilibrados ao trabalhar com indivíduos diagnosticados com transtorno da personalidade *borderline* (TPB). Uma terapeuta experiente, altamente respeitada em sua comunidade como uma profissional empática e sábia, estava tratando um homem de uma grande família de classe trabalhadora, na qual conflitos, ameaças físicas e brigas eram a norma. O tratamento focava em seu “problema de controle da raiva”. Ele havia sido preso várias vezes por violência contra seus irmãos, quando sentia que eles não tratavam sua mãe com o respeito suficiente. Embora a psicoterapia fosse uma experiência nova para ele, parecia disposto a avaliar seus episódios de raiva e experimentar soluções. Ainda assim, ele trazia uma “tensão” para a terapia que era vagamente ameaçadora às vezes, e sua raiva aumentava quando a terapeuta desafiava suas interpretações dos comportamentos de seus irmãos. Ela ficou intimidada com seu estilo irritável e as ameaças implícitas e evitou desafiá-lo ainda mais.

Embora seu comportamento tenha mostrado pouca mudança nos primeiros seis meses de tratamento, ele repetidamente elogiou e agradeceu a terapeuta por sua compaixão e compreensão. Sua gratidão a ajudou a persistir, talvez tenha ajudado a tolerar seus medos e ansiedade. Ela não apresentou esse caso em supervisão de qualquer tipo, nem estava interagindo com uma equipe de consultoria. Quando percebeu que esse paciente não havia feito

nenhum progresso visível em seis meses de tratamento, ela me consultou. Ao me apresentar o caso, parecia calma e racional, mas à medida que expôs suas experiências e reações a ele, suas emoções fortes surpreenderam ambos. Ela rapidamente percebeu que estava suprimindo suas emoções. Reconheceu, pela primeira vez, que estava temendo as sessões com ele. Sentiu medo dele e vergonha de sua ineficácia, se sentiu impotente e sem esperança. Ela antecipava o dia em que ele estava agendado com uma ansiedade que afetava outras sessões também. Enquanto falava comigo, olhava para baixo e agia como se tivesse cometido um crime ou um pecado.

Embora o tratamento desse paciente tenha sido difícil – e o seria para a maioria dos terapeutas –, o nível de *burnout* dessa terapeuta não se deveu apenas a ele. E suas experiências de ansiedade, medo, impotência e vergonha não foram, em si mesmas, a causa do *burnout*. Estas foram respostas emocionais primárias naturais e válidas a estímulos dentro da relação terapêutica, que todos nós enfrentamos no tratamento de alguns indivíduos. O surgimento do *burnout* começou no momento em que ela suprimiu suas primeiras respostas emocionais negativas. Sua abordagem ficou desequilibrada. Em prol da supressão, ela evitou alguns dos estímulos, se abstendo de qualquer confronto, minimizando a importância de suas respostas emocionais e se apoiando excessivamente em intervenções suaves e validadoras. Ao evitar afirmações que o inflamariam e explorar empaticamente os precursores de seus episódios de raiva, ela esperava conquistar sua confiança, permitindo assim um trabalho mais orientado para a mudança. Em vez disso, sua irritabilidade persistiu, e ele assumiu pouca responsabilidade por seus episódios de raiva. Na verdade, ela se tornou mais passiva e tímida, se tornou mais um alvo de sua raiva e se sentiu presa no relacionamento com ele. Ela não conseguiu agir em seu próprio benefício.

A supressão de suas crescentes respostas emocionais levou à sua proliferação, como é geralmente o caso. Conforme percebia o quão emocionalmente desregulada estava e quanto sofrimento estava suprimindo, ela gradualmente foi capaz de compreender sua situação, recuperar sua confiança e abordar diretamente o estilo intimidador e a falta de responsabilidade do paciente. Eu a ouvi com respeito ininterrupto e sem julgamento, o que permitiu que ela se abrisse. De uma perspectiva, a essência do tratamento do *burnout* é que o terapeuta tem a oportunidade de contar a “história do *burnout*”, experimentar e expressar as emoções associadas (anteriormente suprimidas) em um contexto sem julgamentos, no qual as consequências negativas antecipadas não se concretizam. É fácil imaginar que, se essa terapeuta não tivesse procurado ajuda, suas respostas emocionais a esse paciente poderiam ter imobilizado suas capacidades ainda mais, o tratamento teria um final ruim e a confiança da terapeuta seria afetada. O *burnout* do terapeuta tem um alto custo para todos os envolvidos. Felizmente, nesse caso, foi detectado cedo o suficiente.

Essa história nos permite documentar os passos no caminho para o *burnout* do terapeuta em todas as suas variações. Como terapeuta, supervisor e líder de equipe de consultoria em DBT, experimentei e vi essa história se desenrolar inúmeras vezes. A sequência comum de eventos acontece aproximadamente como indicado. O terapeuta:

1. Pode já estar experimentando vulnerabilidade emocional devido a circunstâncias profissionais ou pessoais não relacionadas ao paciente.
2. Encontra-se exposto repetidamente a estímulos evocativos relacionados ao paciente em questão.
3. Experimenta uma variedade de emoções negativas dolorosas.
4. Acha que deve ser capaz de lidar com elas sozinho.

5. Tenta suprimir as emoções que estão surgindo.
6. Faz ajustes e compensações na terapia para lidar com a pressão interna crescente, mas sem enfrentar suas respostas emocionais.
7. Não reconhece a proliferação e a intensidade crescente das emoções suprimidas.
8. Engaja-se em comportamentos (erros de omissão e comissão) para escapar das emoções dolorosas que estão surgindo, o que causa um desequilíbrio problemático na relação terapêutica.
9. Sente-se cada vez mais abalado pela falta de confiança em sua própria capacidade de tratar esse paciente.
10. Pode continuar a achar que suas táticas de evasão começam a impactar seu funcionamento geral com outros pacientes, o que leva à perda de confiança em seu trabalho terapêutico em geral e pode até transbordar para sua vida pessoal. Neste ponto, o terapeuta está sofrendo de um caso completo de *burnout* do terapeuta.

Não é incomum que, em casos que levam ao *burnout*, as áreas de dificuldade ou vulnerabilidade do terapeuta pareçam, em retrospecto, uma combinação perfeita com as áreas de dificuldade ou vulnerabilidade do paciente, criando uma “tempestade perfeita”. No caso de outro terapeuta que pediu orientação, o problema começou quando uma paciente de 25 anos com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) reclamou que se sentia insegura em todos os aspectos de sua vida, mas afirmava se sentir segura com ele. Ela o elogiou por sua estabilidade e compaixão, o que era uma fonte de orgulho para o terapeuta. No entanto, ele começou a se sentir bastante exausto e um pouco ressentido com os pedidos frequentes por apoio fora das sessões. Ele estava frustrado com a abordagem passiva que ela tinha para resolver os problemas em sua vida, que não mudou muito quando ele a desafiou. Apesar de

suas afirmações de que a terapia a ajudou, seu comportamento não mudou. Ele tentou controlar sua desmotivação, ressentimento e frustração, pois estava encorajado pelo fato de que ela, pelo menos, parecia se sentir segura com ele. Ele não compartilhou suas reações negativas com ela, pois achava que isso interromperia seus sentimentos de segurança. E não compartilhou nenhum detalhe de suas dificuldades com sua equipe de consultoria DBT porque, em sua opinião, este não era um caso desafiador em comparação com muitos outros tratados pelos membros da equipe.

No terceiro mês de terapia, a paciente começou uma sessão pedindo para se sentar mais perto do terapeuta. Na verdade, ela queria sentar-se bem ao lado dele. Ela explicou que isso a faria se sentir mais próxima dele, mais “com ele” e, portanto, mais forte para enfrentar seus problemas de vida. Ele se sentiu desconfortável com o novo arranjo de assentos, mas concordou com base na aparente apreciação e no nível aumentado de conforto dela. Na sessão seguinte, ela atribuiu alguns ganhos que havia feito à disposição dele em deixá-la sentar-se ao seu lado. Ela pediu educadamente que ele desse um passo adiante e permitisse que ela segurasse sua mão durante as sessões. Ela garantiu que não era nada sexual, que sabia que ia além dos “limites usuais de uma terapia”, mas argumentou que a levaria a se sentir mais segura e mais confiante. Ela comunicou a ele que sentia estar à beira de um avanço positivo em sua vida, e esse suporte adicional a ajudaria a dar o próximo passo. O terapeuta sentiu-se profundamente desconfortável com a direção das coisas. Este pode ter sido o primeiro momento em que ele percebeu que havia se acomodado demais, havia suprimido demais e agora estava “em apuros”.

Ele relatou essa parte da história com um sentimento de humilhação, mas isso era insignificante em comparação ao que aconteceu a seguir. Ele se sentiu incapaz de dizer não ao pedido

dela, apesar de seu desconforto, e concordou em deixá-la segurar sua mão durante a sessão. Em retrospectiva, sentiu como se estivesse “sob o controle dela”. Explicou que suas ações não estavam associadas a sentimentos sexuais em relação à paciente, mas eram alimentadas de forma mais poderosa por um crescente sentimento de impotência em relação a ela. Ela o havia recompensado novamente e novamente por sua disposição em violar seus próprios limites pessoais, havia punido quaisquer intervenções mais confrontacionais e ele havia perdido o controle do tratamento.

Tendo chegado a esse ponto, no qual estava suprimindo reações fortes e fazendo o que era necessário para evitar a raiva da paciente em relação a ele, ele se tornou consciente de uma emoção adicional: o medo. Ele tinha medo de desafiá-la e temia por sua reputação se suas violações de limites se tornassem conhecidas por outras pessoas. Sentindo-se como um fracasso e como se tivesse se tornado uma vítima, tendo dificuldade para dormir e começando a duvidar se deveria continuar nessa carreira, marcou uma consultoria comigo. Ele e sua paciente tiveram mais uma sessão antes do nosso encontro. Nesta, falando como se fosse uma criança ao fazer um pedido inofensivo a seu pai, a paciente perguntou ao terapeuta se ele permitiria que ela se sentasse em seu colo para se sentir “ainda mais segura”. Pela primeira vez, ele rejeitou um dos pedidos dela. A paciente ficou em silêncio, levantou-se, foi até a janela e pegou uma viga de madeira que a segurava, tentando atacá-lo com ela. Felizmente, ele conseguiu bloquear o ataque e escoltá-la até a sala de espera. Depois que ela o insultou e ameaçou, ele chamou a equipe de crise local e a paciente foi hospitalizada.

Ao ouvir uma história como essa, muitos assumem que esse terapeuta deve ser diferente de nós, deve estar psicologicamente prejudicado. No entanto, este era um terapeuta altamente qualificado, com boa experiência e um sólido conhecimento de

DBT. Ele nunca havia passado por nada parecido durante um tratamento antes, e estava completamente humilhado. Dadas as circunstâncias e o “paciente certo”, qualquer um de nós pode sofrer de *burnout* em terapia e tomar decisões que parecem inimagináveis no momento. Quanto mais pudermos entender a “fórmula” do *burnout*, mais provavelmente seremos capazes de encontrar e usar antídotos.

***BURNOUT* RESULTANTE DA DESREGULAÇÃO EMOCIONAL DO TERAPEUTA**

O *burnout* resulta da regulação emocional disfuncional do terapeuta, como ilustrado por esses exemplos. No primeiro exemplo, a terapeuta reprimiu seu medo da raiva do paciente; no segundo, o terapeuta reprimiu sua consciência de seu ressentimento pelas demandas da paciente e sua frustração com a passividade dela. A repressão, em ambos os casos, levou ao desequilíbrio, pois os terapeutas tentaram, heroicamente, fomentar confiança e envolvimento, mas sem reconhecer ou abordar suas próprias emoções negativas. Enquanto isso, cada um deles se tornou mais emocionalmente angustiado e tentou lidar com isso sem buscar ajuda de outros. As emoções negativas proliferantes levaram a dificuldades mais amplas, afetando os terapeutas bem além das sessões. Cada terapeuta se tornou mais sensível e reativo, emocionalmente fatigado e envergonhado. A autoconfiança despencou.

Esses passos na progressão em direção ao *burnout* do terapeuta mostram uma semelhança impressionante com os passos descritos na teoria biossocial da DBT para explicar a causa e a manutenção dos padrões comportamentais limítrofes. Embora a teoria biossocial postule uma desregulação crônica e difusa da regulação emocional que afeta vários domínios da vida, podemos usar a mesma teoria para analisar a desregulação emocional do terapeuta em relação a um caso específico e explicar como o terapeuta desenvolve alguns dos padrões comportamentais limítrofes no relacionamento com o paciente. A ampla variedade de comportamentos problemáticos do terapeuta associados ao *burnout*, que poderíamos chamar de *comportamentos de burnout*, decorre diretamente da desregulação emocional do terapeuta em relação ao paciente ou dos esforços para lidar com ela. Enquadrar

nossa compreensão do *burnout* em termos da teoria biossocial da DBT nos fornece uma conceituação compatível com a DBT que abre a possibilidade de usar os princípios e as estratégias da DBT para prevenir e tratar o *burnout*. Como argumento, essa abordagem fornece à equipe de consultoria um quadro e um “plano de tratamento” para ajudar o terapeuta com o *burnout*.

TEORIA BIOSSOCIAL E O *BURNOUT* DO TERAPEUTA

A teoria biosocial postula uma transação entre dois fatores e os resultados dessa transação. O primeiro é um “fator pessoal” e o segundo é um “fator ambiental”. O fator pessoal é a vulnerabilidade emocional do terapeuta, em particular, aquela ativada no tratamento do paciente. O fator ambiental inclui as características invalidantes ou não validantes do ambiente relacionadas ao tratamento dessa pessoa em particular. Com o tempo, a transação resulta na desregulação emocional do terapeuta, que afeta suas emoções, ações, pensamentos e fisiologia. Suas tendências a evitar, suprimir e escapar das respostas emocionais, em vez de enfrentá-las, expressá-las e processá-las, apenas exacerbam o problema.

A vulnerabilidade emocional do terapeuta

Seguindo a teoria biosocial da DBT, podemos identificar três características do fator pessoal, a vulnerabilidade emocional do terapeuta relacionada ao paciente: 1) alta sensibilidade emocional aos estímulos relacionados ao paciente; 2) alta reatividade emocional assim que as emoções são evocadas; e 3) retorno lento à linha de base emocional.

A alta vulnerabilidade emocional pode ou não ter sido um fator proeminente no desenvolvimento ou na vida pessoal geral do terapeuta, mas é hipotetizado que esteja presente em relação ao tratamento do paciente em cujo contexto seu *burnout* ocorre. Ele se tornou altamente sensível e reativo a estímulos associados ao paciente. Estressores em sua vida pessoal ou profissional, não relacionados ao paciente, podem contribuir para sua vulnerabilidade. Além disso, ele pode ter descoberto que

características dessa pessoa em particular envolvem exclusivamente suas emoções intensas, sejam elas positivas ou negativas ou ambas. Todos nós nos deparamos com certos pacientes (e outras pessoas em nossa vida) que “mexem conosco”, “nos irritam”, “ativam nossos gatilhos” ou apenas fornecem uma combinação perfeita para algumas sensibilidades baseadas em história ou biologia. Uma vez que a sensibilidade do terapeuta é ativada em relação a alguém, os estímulos desencadeiam reações de alta amplitude. Depois de várias dessas, as emoções do terapeuta em resposta a esse paciente são lentas para retornar à linha de base, aumentando a probabilidade de que o próximo estímulo relacionado provoque uma forte resposta. Depois de um tempo, a resposta geral do terapeuta a esse paciente é modelada por sua necessidade de gerenciar sua vulnerabilidade, o que pode ser enfraquecedor e estressante.

Quando me refiro a *estímulos relacionados ao paciente*, incluo não apenas interações dentro ou fora das sessões, mas o contato com familiares, outros profissionais, colegas terapeutas, agências e solicitações de documentos sobre o paciente. Em nosso programa de tratamento diurno de DBT, um jovem pós-doutorando em psicologia estava tratando uma paciente altamente suicida. Ele participava da supervisão individual e da equipe de consultoria. Como era seu único caso de DBT e porque ele se importava profundamente em causar uma boa impressão em seu supervisor e na equipe, era altamente sensível sobre se seu trabalho era visto de forma favorável. Ele orientou sua paciente sobre a política de *coaching* telefônico, com a qual ela era encorajada a ligar para ele a fim de receber treinamento de habilidades em uma crise. Ele começou a receber cada vez mais ligações durante dias, noites e fins de semana. Além de suas ligações, começou a receber ligações da mãe da paciente, que estava preocupada que sua filha morresse. Ele não sentia que seu *coaching* estava ajudando-a a usar habilidades, mas sabia que era uma prática esperada em

DBT. Ele informou à equipe de consultoria sobre as ligações telefônicas, mas com medo de estar recebendo mais ligações do que deveria, não transmitiu a extrema frequência das ligações, sua natureza ineficaz ou as chamadas adicionais da mãe. Ele fez parecer que tudo estava indo bem, mesmo que em particular estivesse ficando cada vez mais angustiado.

Em pouco tempo, ele passou a temer a perspectiva de outra ligação dela. Em termos da teoria biossocial, sua vulnerabilidade emocional em relação a essa paciente tornou-se pronunciada: ele era altamente sensível a qualquer sugestão relacionada a ela, suas reações emocionais (mantidas em sigilo) eram intensas, e, mesmo com “tempo livre” do programa, ele não conseguia reduzir seu sofrimento. Posteriormente, descobrimos que sua ansiedade em relação à paciente foi acompanhada por suas dúvidas sobre suas próprias habilidades. Ele sentia vergonha de estar escondendo informações da equipe e chegou a se sentir como um “farsante”. Embora tivesse membros da equipe dispostos a apoiá-lo, se sentia preso e isolado em seu tratamento com essa paciente. Ele até temia voltar para casa no final do dia porque antecipava que uma mensagem de correio de voz (da paciente ou da mãe dela) estaria esperando por ele.

Durante uma reunião da equipe de consultoria, outros terapeutas observaram que ele estava mais retraído. Um deles estava preocupado com a “moral” desse terapeuta. Os membros da equipe expressaram preocupação e perguntaram como as coisas estavam indo. Incapaz de manter sua fachada de “tudo normal”, ele compartilhou, relutante e choroso, que estava recebendo mais de uma dúzia de ligações por dia dessa paciente e de sua mãe, que se sentia muito ineficaz e isolado, e que temia que, se ela se matasse, isso arruinaria sua carreira. Ele estava completamente envergonhado, mas com o encorajamento e a validação da equipe, foi capaz de expressar todas as reações que havia suprimido. Com alguma ajuda adicional em supervisão

individual, foi capaz de reformular o tratamento dentro de seus limites pessoais e com um protocolo de crise bem definido. A paciente ficou angustiada com as mudanças, mas com alguma validação, tranquilização e solução de problemas pelo terapeuta, ela foi capaz de permanecer em tratamento e, em última análise, se beneficiar dele.

O ambiente invalidante do terapeuta

Consideramos as características do fator pessoa da teoria. O outro fator refere-se ao ambiente em torno do terapeuta, em particular, o *microambiente* em torno do tratamento desse paciente em particular. Esse microambiente provavelmente inclui outros membros da equipe de consultoria, qualquer supervisor individual no caso, pessoal administrativo relacionado, outros profissionais fora da equipe de DBT que trabalham com o paciente, familiares e o próprio paciente. O terapeuta pode ter transações com qualquer um desses envolvidos em relação ao paciente, ao seu tratamento e às suas respostas emocionais. De relevância especial para a teoria e a progressão do *burnout* são aquelas transações em que os membros do ambiente estão invalidando-o (em geral inadvertidamente) ou não o validando, sobretudo em relação às suas vulnerabilidades. O terapeuta que sofre de desregulação emocional em relação ao tratamento de um paciente em geral está profundamente consciente das respostas do ambiente ao tratamento, ao paciente e às suas reações ao tratamento. Ser vulnerável o coloca em um estado de *alerta*. Ele provavelmente notará se suas comunicações forem tratadas, seja de forma sutil ou não tão sutil, com desprezo ou crítica. Enquanto a natureza da invalidação do indivíduo com TPB pode envolver negligência e abuso bastante graves, a natureza da invalidação de um terapeuta pelos que o rodeiam é provavelmente mais sutil, mesmo que bastante difundida.

Certas características da cultura típica de configurações clínicas podem adicionar à experiência de invalidação e vulnerabilidade. Em primeiro lugar, a terapia acontece em particular e raramente é vista por mais alguém. Em segundo lugar, embora a DBT seja um tratamento com base em evidências, e o terapeuta e a equipe possam estar coletando e documentando resultados, o terapeuta compreensivelmente está incerto sobre se seu trabalho é aderente ao modelo e eficaz com o paciente. Em terceiro lugar, o terapeuta trabalha em um ambiente social em que a autossuficiência é valorizada; ele pode pensar que não precisa de muita ajuda. Por fim, esses são pacientes e problemas muito difíceis de tratar, e os riscos podem ser altos. Em resumo, na maioria das configurações clínicas, o próprio contexto, antes mesmo de começar com um determinado paciente, pode estar cheio de fatores que aumentam a vulnerabilidade dos terapeutas. Linehan (2010) definiu a DBT de tal maneira que todo terapeuta deve fazer parte de uma equipe de consultoria. As equipes incentivam todos os membros a compartilharem os aspectos vulneráveis de seu trabalho, e todos os membros da equipe fazem seis acordos, incluindo um “acordo de falibilidade”, afirmando que todos na equipe são falíveis. Tentando aumentar a conexão e o compartilhamento e diminuir a defensividade, a equipe trabalha para estabelecer condições em que os terapeutas são mais propensos a expressarem com precisão as dificuldades que estão tendo em seu trabalho.

Como mencionado, a invalidação em um contexto de equipe pode não ser óbvia. De uma forma ou de outra, o terapeuta pode se sentir invalidado pelos outros membros da equipe. Por exemplo, se ele tem uma forte resposta emocional a um paciente e a expressa a outros profissionais, sua resposta pode ser considerada “excessiva” ou “inapropriada”. Essa visão crítica raramente será declarada de maneira direta, mas o terapeuta pode sentir essa crítica sutil de qualquer maneira. Desaprovação, crítica e julgamento podem ser comunicados mais pelo que não é dito do

que pelo que é dito, ou mais no tom sutilmente julgador de perguntas e sugestões. Como o terapeuta pode tender a agir de forma autossuficiente e competente, mesmo quando não se sente assim, e os membros da equipe podem agir com respeito e sem julgamento, mesmo quando não se sentem assim, o terapeuta que expressa respostas emocionais negativas e fortes relacionadas ao paciente para a equipe pode sentir que os comentários respeitosos e validadores carecem de autenticidade e profundidade. Ele pode sentir-se “invalidado por empatia fraca”, semelhante à sensação de ser “condenado por elogios fracos”. O *feedback* não verbal da equipe pode ampliar sua sensação de isolamento e incompetência. Dadas suas fortes respostas emocionais, ele pode sentir-se preso em três opções, nenhuma das quais oferece uma solução: 1) expressar as emoções na equipe e correr o risco de invalidação; 2) expressá-los para o paciente e correr o risco de invalidá-lo; ou 3) suprimi-los com o risco de aumentar a desregulação emocional. A equipe de consultoria está em uma posição-chave para ajudar o terapeuta a encontrar uma opção melhor: fornecer validação genuína quando o terapeuta expressa suas emoções e ajudá-lo a avaliar e resolver os problemas subjacentes às suas reações.

Nos dois exemplos citados, um em que o terapeuta seguiu, passo a passo, em direção a comportamentos seriamente inapropriados que incluíram contato físico, impulsionado pelo medo da paciente; e o outro em que o jovem terapeuta tolerou um número insuportável de chamadas de *coaching* telefônico sem informar sua equipe, as equipes de consultoria foram, na verdade, genuinamente respeitosas e solidárias. Elas não pareciam ser severas, críticas, negligentes ou ativamente invalidantes. Ainda assim, havia algo na transação entre os terapeutas, a “cultura” da equipe de consultoria e o ambiente profissional mais amplo que reduziu a abertura emocional dos dois terapeutas conturbados, aumentou a supressão de respostas emocionais intensas e bloqueou sua disposição de pedir ajuda. É sábio para as equipes

de consultoria assumir que os terapeutas podem reter vulnerabilidades emocionais e se apresentar como confiantes e capazes mesmo quando ocorre *burnout*. Nesse sentido, as equipes devem adotar uma postura proativa na busca de evidências de *burnout* e abordá-las.

Acompanhando essa “síndrome” de invalidação ou não validação generalizada em nosso campo, e ainda mais elaborada em alguns ambientes clínicos, há uma simplificação não declarada da tarefa, muitas vezes difícil, de regular nossas emoções em resposta aos nossos pacientes. A maioria das pessoas age como se os terapeutas “devessem” ser capazes de tolerar e gerenciar produtivamente a raiva, ameaças, episódios de comportamento suicida, comportamentos violentos e maneira passiva de lidar com os problemas da vida dos pacientes, sem muita necessidade de validação ou apoio para si mesmos. O ambiente clínico sutil, mas muito invalidante, reforça inadvertidamente os terapeutas por agirem como se se sentissem competentes e por suprimirem respostas emocionais negativas, a menos que – e até que – elas se intensifiquem ao ponto em que não possam mais ser suprimidas. Quando um terapeuta “quebra” ou “explode”, recebendo finalmente reconhecimento e apoio, a equipe está reforçando apresentações de terapeutas intensificadas com um cronograma de reforço intermitente. O padrão resultante tende a reforçar comportamentos de terapeutas intensificados no ambiente da equipe, enquanto suprime uma expressão mais rotineira de emoções negativas.

Consequências para o terapeuta

Essa transação entre as vulnerabilidades do terapeuta relacionadas ao paciente e o ambiente profissional, clínico e da equipe, que é sutil, mas invalidante, tem várias consequências. Em primeiro lugar, tendo se adaptado a um ambiente invisivelmente

invalidante em que se encontra, o terapeuta está propenso a invalidar suas próprias respostas. Ele se torna autocrítico e cauteloso, duvidando de suas habilidades. Fica inseguro quanto ao seu julgamento e suas intuições clínicas. Em segundo lugar, é provável que oscile entre suprimir suas respostas emocionais ao paciente na maior parte do tempo, enquanto em algumas ocasiões é dominado por respostas extremas. Finalmente, pode seguir o exemplo do ambiente em simplificar excessivamente a tarefa do terapeuta de regulação emocional em relação aos seus pacientes.

A transação contínua entre a vulnerabilidade emocional do terapeuta e os ambientes invalidantes causa distorções e excessos na abordagem ao paciente. Ele pode começar a evitar os estímulos relacionados ao paciente aos quais se tornou sensível. Ao não mencionar certos tópicos na terapia, evitar certos tipos de intervenções que provocarão as respostas emocionais do paciente, “esquecer” acidentalmente as consultas ou deixar de retornar chamadas telefônicas, negligenciar a necessidade de acompanhar colaborações ou documentação relacionadas ao paciente e não ter discussões sobre seu paciente em reuniões de equipe, ele se afasta do modelo de tratamento. Mesmo com toda essa evasão, os membros da equipe podem não perceber que o terapeuta está se tornando desregulado no tratamento de determinada pessoa.

Em particular, o terapeuta a caminho do *burnout* pode achar cada vez mais difícil validar as respostas emocionais do paciente. A validação vem de uma posição de consciência e compaixão, ambas as quais podem estar comprometidas, e requer um esforço ativo para se colocar no lugar das experiências do paciente quando, na verdade, o terapeuta pode ter aversão a ouvi-las. Por não querer “entrar em uma discussão” com o paciente ao sondá-lo ou confrontá-lo, pode mostrar pouca atenção ou reação aos comportamentos emocionais significativos, mas menos extremos, do paciente. O terapeuta pode até começar a criticar a falta de autocontrole ou as respostas emocionais extremas do paciente –

uma reação que espelha os ambientes invalidantes anteriores. O paciente reconhece todas essas dinâmicas implícita ou explicitamente e pode gerar comportamentos mais extremos que chamarão a atenção do terapeuta, resultando no reforço intermitente dos comportamentos escalados.

Além de evitar estímulos relacionados ao paciente, o terapeuta pode se envolver em outros comportamentos para escapar de suas respostas emocionais dolorosas. Ele pode se distanciar do paciente, esquecendo o que foi dito mesmo um minuto atrás. Pode se engajar em uma versão mais superficial da terapia, recuando para tópicos seguros ou lugares-comuns. Um psiquiatra ou outro prescritor pode mudar a discussão para o campo da psicofarmacologia e problemas médicos em vez de lidar com material emocionalmente evocativo. Pode reagir de maneira exagerada a alguns incidentes nas sessões enquanto subestima outros. Pode se ver olhando para o relógio quando ainda restam 20 minutos, pensando no que acontecerá após a sessão. Fora das sessões, quando o processo de *burnout* está avançado, pode tentar evitar pensar no paciente, mas experimentar pensamentos intrusivos sobre ele que se estendem para sua vida pessoal e podem resultar em insônia.

O impacto do *burnout* do terapeuta no paciente e no tratamento

Em resumo, o terapeuta emocionalmente desregulado age de várias maneiras que provocam ainda mais desregulação emocional no paciente, cujos padrões de reação então provocam ainda mais desregulação no terapeuta. Surge uma espiral de *burnout* transacional. Sem controle, o terapeuta pode caminhar em direção ao afastamento quase total, prejudicar o paciente, querer terminar a terapia e até mesmo querer mudar de carreira. A terapia muitas

vezes já está morta antes que alguém perceba, o que prejudica ambas as partes.

A prevenção e o tratamento do *burnout* de cada membro da equipe é de papel exclusivo da equipe de consultoria de DBT!

Ainda não mencionei que o *burnout* do terapeuta é normal. Assim como os bombeiros devem se preparar para a possibilidade de, em algum momento, sofrerem alguma lesão por queimadura ou inalação de fumaça, os terapeutas DBT devem se preparar para a possibilidade de, ao trabalharem com indivíduos emocionalmente desregulados, em algum momento, também se tornarem emocionalmente desregulados. É necessário assumir isso como uma possibilidade esperada a qualquer momento para qualquer terapeuta da equipe. Uma das principais funções de uma equipe de DBT é antecipar e gerenciar ativamente o *burnout* do terapeuta, idealmente prevenindo-o sempre que possível, detectando-o quando ocorre e tratando-o quando já ocorreu.

APLICANDO OS PRINCÍPIOS DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DO *BURNOUT* DO TERAPEUTA

A fidelidade ao modelo de DBT requer reuniões regulares de todos os terapeutas na equipe de consultoria, conduzidas de acordo com certas diretrizes e acordos. Não é uma supervisão opcional, como acontece em muitos modelos de tratamento, mas parte integrante do programa. A função da equipe é atender à motivação dos terapeutas e ao aumento de sua capacidade de conduzir a DBT com adesão ao manual. Dado que a desregulação emocional do terapeuta pode interromper a terapia e prejudicar sua autoconfiança e bem-estar, uma prioridade alta para a equipe é antecipar, detectar, prevenir e tratar a desregulação emocional em cada membro da equipe. Isso é uma parte substancial do que significa dizer que a equipe de consultoria DBT oferece “terapia para o terapeuta”, inspirando-se no modelo de tratamento da DBT e seus princípios. Considero três etapas na prevenção e no tratamento do *burnout* em equipe: 1) detecção do processo de *burnout*; 2) prevenção do *burnout* por meio da aplicação consistente dos princípios da DBT; e 3) tratamento do *burnout* uma vez que este tenha se enraizado, também utilizando os princípios da DBT e estratégias associadas.

Detecção do *burnout*

Os membros da equipe de consultoria não devem esperar pela apresentação evidente do *burnout*, em vez disso, devem realizar uma triagem proativa de si mesmos e uns dos outros em busca de evidências. A triagem ativa é importante por causa da atmosfera típica dos ambientes clínicos, na qual os terapeutas recebem a

mensagem consistente de gerenciar o sofrimento emocional relacionado ao paciente em particular.

Metaforicamente, os membros da equipe devem procurar indicadores de *burnout* em si mesmos e nos outros da mesma forma amorosa que os macacos se limpam, procurando por insetos nos pelos e removendo-os. Quais são os indicadores da presença do *burnout*? Alguns deles são diretos, anunciando a presença da doença, e outros são indiretos, sugerindo que o *burnout* pode estar em andamento. Nenhum desses indicadores fornece evidência convincente de que ele está presente, mas são indicativos da necessidade de investigação e observação mais detalhadas.

INDICADORES DIRETOS

1. *“Estou esgotado”*. O terapeuta relata o problema à equipe sem rodeios.
2. *Desejo prematuro de terminar*. O terapeuta, querendo escapar dos estímulos e emoções, sugere que pare de atender o paciente quando há pouca evidência para apoiar essa sugestão.
3. *Declarações francamente julgadoras sobre o paciente*. Tais declarações sugerem que o terapeuta está reagindo às suas próprias respostas emocionais difíceis em relação ao paciente e as expressa na forma de críticas.
4. *Desbalanceamento marcante na terapia*. Os membros da equipe notam que o terapeuta está adotando uma resposta notadamente desequilibrada. Ele pode estar: a) extremamente focado na mudança comportamental enquanto presta pouca atenção à validação; b) extremamente empático e validador enquanto ignora a pressão pela mudança; c) abordando o paciente com demandas e limites com pouca flexibilidade; ou d) oferecendo extrema flexibilidade e suporte afetivo no contexto de quase nenhuma demanda ou limite.

5. O *burnout do terapeuta é sugerido pelo paciente*. Às vezes, o paciente é o primeiro a “denunciar” o *burnout*, perguntando diretamente ao terapeuta por que mudou tão significativamente e se ele ainda “se importa”. Às vezes, o paciente traz isso à atenção do treinador de habilidades ou de algum outro membro da equipe em vez de diretamente ao terapeuta.

INDICADORES INDIRETOS

1. O *terapeuta parece emocionalmente vulnerável*. Os membros da equipe notam que o terapeuta está mais sensível, reativo, deprimido, irritável, triste ou emocional do que o habitual. Isso pode surgir no contexto de um caso ou pode ter ido além de um caso e ser geral.
2. O *terapeuta parece sutilmente julgador/desrespeitoso/desequilibrado em relação a um paciente específico*. Os membros da equipe observam a mudança, que é significativa, mas não tão extrema quanto o indicador direto mencionado. Os membros da equipe indagam gentilmente sobre suas percepções.
3. O *terapeuta evidencia desequilíbrio em relação à equipe*. Ao discutir sobre o paciente em questão, o terapeuta pode mostrar respostas extremas ou desadaptativas nas reuniões da equipe: é mais retraído, mais argumentativo, mais errático ou, em alguns casos, surpreendentemente protetor em relação a ele. Os membros da equipe notam a mudança e indagam sobre causas e condições. O *burnout* do terapeuta é uma possível explicação.
4. O *terapeuta desvia dos pressupostos, acordos ou teoria biossocial da DBT*. Os pressupostos, acordos e teoria biossocial da DBT definem diretrizes e uma filosofia prática que ajudam o terapeuta a andar pelo “caminho do meio” entre

aceitação e mudança, resultando em um cuidado compassivo e eficaz. O terapeuta que normalmente opera dentro dessas diretrizes é percebido como tendo se afastado delas em uma direção ou outra e, portanto, está se movendo para fora da conformidade com o manual de tratamento. (Note que este ponto significa que todos os terapeutas DBT devem estar familiarizados com os pressupostos, acordos e teoria!) Os membros da equipe perguntam gentilmente sobre as mudanças, questionando-se se são manifestações precoces de *burnout*.

5. *O terapeuta permite violações repetidas de seus limites pessoais.* Cabe aos membros da equipe apoiarem uns aos outros na definição e observação de seus limites pessoais. Quando reconhecem que os limites pessoais de um terapeuta parecem ter se ampliado ou estreitado em relação ao habitual, ou notam que seus limites são extremos o suficiente para resultarem em consequências disfuncionais para o paciente ou para si mesmo, eles perguntam se o terapeuta gostaria de consultoria sobre o caso ou os limites, em particular.

Prevenindo o *burnout*

Os três paradigmas da DBT e o uso dos princípios que fluem de cada um fornecem todas as ferramentas necessárias para a equipe ajudar a prevenir a desregulação emocional em cada terapeuta. A equipe estabelece uma atmosfera de aceitação de acordo com os cinco princípios do paradigma da aceitação. Nesse contexto, quando um terapeuta pede ajuda à equipe, ele é recebido de maneira alerta, validadora e não julgadora, o que encoraja uma descrição aberta e precisa da história que levou à sua desregulação. Uma vez que parte do problema se deve a respostas de supressão, evitação e fuga, a resposta da equipe já

oferece alívio e compaixão, o que promove a autoaceitação no caminho para a melhoria da modulação emocional.

No contexto validador, a equipe é guiada pelos princípios do paradigma da mudança para direcionar os comportamentos problemáticos, garantir o comprometimento do terapeuta em resolver o problema, trabalhar para avaliar as variáveis controladoras, chegar a uma formulação de caso dos comportamentos e síndrome de *burnout*, selecionar soluções entre as possibilidades presentes nos quatro modelos comportamentais na DBT e implementar soluções com acompanhamento em reuniões subsequentes. O terapeuta com *burnout* se beneficia do uso ativo dos princípios de aceitação pela equipe, e o uso dos princípios de mudança e uma sequência racional de solução de problemas também pode gerar esperança onde a fé de que há “um caminho a seguir” pode ter se perdido. Discuto o papel dos princípios de mudança com mais detalhes quando nos voltarmos para o tratamento do *burnout* estabelecido do terapeuta em equipes.

Por meio dos princípios do paradigma dialético, a equipe injeta um conjunto diferente de “ingredientes” no processo que pode ajudar na prevenção e no tratamento da síndrome de *burnout*. Esses princípios fornecem um quadro para reconhecer e resolver com sucesso a oposição no tratamento, ampliar a perspectiva sobre os fatores sistêmicos que contribuem para o impasse terapeuta-paciente e reconhecer que a mudança está sempre acontecendo, independentemente da aparência de paralisia e estagnação. A dialética fornece formas de lidar com os tipos de posições e conflitos rígidos, as perspectivas estreitas e a estagnação que acompanham a síndrome de *burnout*. Os princípios dialéticos são discutidos adiante no que diz respeito à prevenção do *burnout* e, em seguida, na próxima seção, no que diz respeito ao tratamento do *burnout* estabelecido do terapeuta.

O paradigma da aceitação na prevenção do burnout

É crucial destacar que um terapeuta cujos colegas de equipe sejam abertos, presentes, conscientes, alertas, amáveis e compassivos terá mais chances de se abrir, compartilhar vulnerabilidades, expressar emoções surgidas durante o tratamento e pedir ajuda. Estabelecer um ambiente de abertura é um desafio, mas deve ser mantido como um ideal para toda a equipe. Isso começa aplicando o princípio de *estar presente no momento*. A equipe inicia sua reunião com uma prática de *mindfulness* para ajudar os terapeutas a deixarem as preocupações de lado e se concentrarem no momento presente. Os membros praticam as habilidades básicas de *mindfulness* da DBT: observar, descrever, participar, permanecer sem julgamento, permanecer em *mindfulness* e interagir efetivamente. Algumas equipes designam um “observador” dentro da equipe, que monitora a participação consciente nas reuniões e toca um sino de *mindfulness* a fim de alertar todos para momentos de julgamento e comportamentos não conscientes. Convidar todos os membros da equipe a retornarem repetidamente ao momento presente cria uma expectativa de que, se alguém levantar questões delicadas e emoções vulneráveis, será recebido com “todos os olhos e ouvidos”. Os membros provavelmente estarão alertas e sintonizados uns com os outros e naturalmente praticarão os três primeiros níveis de validação (escuta atenta, reflexão precisa e verbalização de expressões não verbais do paciente, como emoções, pensamentos e comportamentos). Como as manifestações do *burnout* podem não ser reconhecidas ou relatadas pelo terapeuta afetado, os membros da equipe despertos e alertas, enraizados no momento presente, são mais propensos a notarem mudanças sutis uns nos outros, realizando triagem para o *burnout* e cuidando das manifestações em cada um.

Uma vez que a DBT é um tratamento baseado em evidências, repleto de uma ampla variedade de elementos, cabe a cada terapeuta praticar o tratamento inteiro com fidelidade. Por consequência, é tarefa da equipe ajudar cada membro a praticar corretamente. No entanto, em algumas equipes, o esforço pela adesão pode resultar em uma atmosfera que sufoca a abertura, a partilha de vulnerabilidades e a apresentação de trabalhos que violam elementos no manual. Se o terapeuta fica excessivamente preocupado com a adesão a ponto de omitir algumas de suas emoções, pensamentos e ações em relação ao paciente, ele falha em reconhecer a realidade de suas respostas, alimenta sua própria vergonha e perde a oportunidade de obter ajuda. Uma atmosfera de equipe desequilibrada, excessivamente focada na conformidade, pode piorar o *burnout* em vez de resolvê-lo.

As equipes excessivamente focadas na mudança na verdade não estão aderindo ao manual. Já que um equilíbrio entre mudança e aceitação representa uma boa prática de DBT, a equipe de consultoria deve refletir esse equilíbrio também. Isso não é um desafio pequeno. As equipes precisam se concentrar na adesão, no desempenho e na melhoria de cada terapeuta e, simultaneamente, manter uma atmosfera de presença, calor humano, autenticidade, abertura e compaixão. A reunião da equipe deve alternar entre aceitação e mudança, mudança e aceitação, várias vezes. O princípio da aceitação de desapego pode ser muito útil para todos ao alternar entre mudança e aceitação. Quando os membros da equipe começam a ouvir um colega terapeuta apresentar uma situação de caso difícil, que pode exigir a partilha de sua vulnerabilidade, muitas vezes precisam temporariamente “deixar ir” o apego a “o que deveria ser” e apenas ouvir “o que realmente é”. Ao deixar de lado o impulso de corrigir, criticar ou melhorar seu colega, ouvem a descrição precisa do que está acontecendo, escutam o que o terapeuta quer da equipe em vez de o que ele “deveria” estar pedindo e encontram a validade nas

respostas do colega. Os terapeutas responderão a esse tipo de respeito e abertura com maior disposição para compartilhar honestamente, mesmo que não estejam orgulhosos de suas respostas. Depois da parte inicial da consultoria, que envolve escuta e avaliação precisas, os membros da equipe podem ajudar o terapeuta a melhorar sua abordagem terapêutica da situação se ele desejar.

Na medida em que os membros da equipe podem aplicar o princípio da *interexistência*, reconhecendo a profunda interdependência de todos, eles têm mais probabilidade de agir como parte de um único organismo em vez de como indivíduos totalmente separados. Como resultado, o poder da equipe e os recursos disponíveis para cada membro aumentam. Cada terapeuta está na equipe e a equipe está em cada terapeuta. Cada paciente de cada terapeuta é paciente de todos. Ao se tornarem vulneráveis apresentando material potencialmente doloroso uns para os outros, cada terapeuta é um paciente às vezes e um terapeuta para seus colegas em outras ocasiões. As definições de papel mudam; todos desempenham todos os papéis. Participar do espírito de *interexistência* permite que cada terapeuta compartilhe de forma significativa, “se apoie” na equipe e dependa dela como um parceiro confiável. A desregulação emocional em um terapeuta se torna um ponto de preocupação para todos; se torna, em certo sentido, a desregulação emocional de todos. A qualidade íntima de apoio fica com cada terapeuta, de modo que mesmo quando ele está fazendo terapia, é como se a equipe estivesse fazendo terapia. Na verdade, Linehan recomendou que, se um terapeuta de uma equipe for chamado para uma audiência judicial como resultado do suicídio de um paciente, toda a equipe deve comparecer, deixando claro que todos são um. Obviamente, as chances de reconhecer indicadores de *burnout* e ajudar um terapeuta a processar a resposta emocional são muito maiores nesse contexto de equipe do que em um grupo de indivíduos

separados e não relacionados, cada um deles cauteloso em relação aos outros.

Reconhecer o princípio da *impermanência* – afirmando que tudo, incluindo as coisas que valorizamos e as coisas que tememos, é transitório – promove o desejo de viver dentro, apreciar e valorizar o momento presente. Cada momento de cada reunião da equipe é fugaz, precioso, único e passará imediatamente. Se os membros da equipe estiverem praticando de acordo com esse princípio, eles terão mais probabilidade de “comparecer”, compartilhar material vulnerável e cuidar bem uns dos outros. Em resumo, cada momento importa. Mesmo que o momento presente seja desagradável e não esteja produzindo uma solução desejável, eles sabem que é temporário, que as coisas estão mudando e que “tudo vai passar”. Os terapeutas podem ser capazes de habitar o momento precioso, reconhecê-lo e deixar de lado a necessidade de controlá-lo. Torna-se mais fácil permitir e até confiar no surgimento de possibilidades. A *impermanência*, em conjunto com a *consciência do momento presente* e o *desapego*, ajuda cada terapeuta a simplesmente estar no momento, deixar de controlá-lo, reconhecer sua natureza transitória e se envolver na prática do tratamento. Para o terapeuta que está “em cima do muro” em relação a compartilhar sentimentos vulneráveis e dificuldades na terapia, a atmosfera resultante será mais propícia para ele “se jogar”. A prevenção do *burnout* se torna uma consequência natural.

“O mundo é perfeito como é.” Tudo tem uma causa. Cada terapeuta está fazendo o melhor que pode, dado tudo o que aconteceu antes. A equipe procura a validade do comportamento do terapeuta na terapia e nas reuniões. Os comportamentos podem ser válidos no contexto da história ou da biologia, ou seja, da experiência anterior do terapeuta. Eles podem ser válidos em relação ao contexto atual, em que sua resposta comportamental pode ser a mesma que a de muitos nas circunstâncias. Seus

comportamentos podem ser válidos em relação às suas metas em vista. Embora haja um lugar para entender os comportamentos de um terapeuta avaliando as variáveis controladoras que estão causando uma progressão em direção ao *burnout*, não há lugar para julgá-lo. O terapeuta que está considerando apresentar eventos de seu tratamento de um paciente, incluindo sua falibilidade e vulnerabilidade, é muito mais propenso a fazê-lo se a equipe realmente age como se “*o mundo fosse perfeito como é*”.

Em resumo, a equipe de consultoria que cria um contexto acolhedor para todos, combinando os princípios de consciência do momento presente, o desapego, a interdependência, a impermanência e o “perfeito como é” cria um contexto que inclui todos; isso valoriza a diferença em vez da conformidade; ouve e avalia em vez de assumir; apoia o tipo de interdependência que fortalece cada participante; e permite a discussão de assuntos sensíveis, dolorosos e comoventes. Todo terapeuta e cada paciente de cada terapeuta são os beneficiários dessa riqueza. A moral e a resiliência de cada terapeuta aumentam e o risco de *burnout* diminui.

O paradigma dialético na prevenção do burnout

A implementação dos princípios do paradigma dialético também serve para fortalecer a equipe de consultoria. O uso desses princípios adicionará um sabor de flexibilidade, criatividade e inclusão de todas as perspectivas; movimento, velocidade e fluxo; e uma disposição para permitir a expressão completa de posições opostas em um processo dialético que se move em direção à síntese.

Os membros da equipe de DBT frequentemente discordam, o que pode ser produtivo ou destrutivo. Um terapeuta argumenta que outro é muito rígido ou muito flexível com seu paciente. Outro acredita que a equipe gasta muito tempo em conversas informais e

práticas de *mindfulness* e pouco tempo em consultoria. Outro sugere que o líder está sendo muito rígido em relação à fidelidade à DBT, e o líder responde que este é justamente o objetivo! Quando uma discordância é resolvida, outra surge. E as que não são resolvidas podem se tornar feridas crônicas dentro da equipe, crescendo ao longo do tempo até que as coisas se tornem muito desconfortáveis e o ambiente pareça inseguro.

Na verdade, quando os membros da equipe têm diferentes respostas, ideias e estilos, essa diversidade, se tolerada e valorizada, expandirá os recursos e as possibilidades. Idealmente, cada terapeuta se sentirá livre para ser ele mesmo na equipe, mesmo que cada um esteja participando dentro das diretrizes da equipe e dos princípios abordados neste livro. Porém, se os membros da equipe não se sentem confortáveis com conflitos entre eles, este não é o caso. Como observado, um princípio do paradigma dialético é que a realidade é composta de opostos; que uma proposição, ou tese, provocará a proposição oposta, ou antítese. Por exemplo, o líder de equipe ambicioso, querendo que todos pratiquem DBT o mais perfeitamente possível, provocará uma opinião oposta de alguém na equipe de que é importante aplicar DBT com flexibilidade. Uma vez que um conflito existe, a abordagem dialética não é escolher o que é correto. O pensamento dialético não é um pensamento “ou ... ou”, mas uma síntese que emerge de duas perspectivas válidas. Nas reuniões, a implementação de processos dialéticos oferece uma maneira de aumentar o conforto com o conflito e ver o enorme valor nele. É o processo perfeito para aplicar a situações em que as diferenças levaram a impasses, o que faz parte da fórmula do *burnout*. Se a equipe puder lidar com conflitos de forma dialética, os membros saberão que as diferenças são não apenas seguras, mas também desejáveis. Quando um processo dialético está em vigor, os terapeutas expressam mais perspectivas, encontram mais soluções e correm mais riscos uns com os outros.

Quando a equipe aceita o conflito, isso ajuda a prevenir o *burnout* de várias maneiras. Em primeiro lugar, se todos se sentem incluídos e percebem que suas contribuições são valorizadas e não rejeitadas, há uma sensação aprimorada de segurança e colaboração. Em segundo lugar, se alguém teme que suas experiências ou pontos de vista sejam incorretos ou incomuns, um ambiente acolhedor o encoraja a se comunicar, confiando que, em um processo dialético, a validade de sua posição será respeitada. Caso um terapeuta esteja experimentando desregulação emocional, mas sinta vergonha de expressar suas emoções ou comportamentos, é possível que ele esteja mais propenso a fazê-lo se puder prever uma resposta inclusiva e respeitosa. Quando a equipe é capaz de operar dialeticamente, respondendo a posições opostas com o objetivo de buscar uma síntese, ela se torna mais flexível e segura em última análise.

Já orientei várias equipes que, por sua própria admissão, eram “muito gentis para seu próprio bem”. Os terapeutas não submergiam intencionalmente conflitos e diferenças, mas o faziam quase de forma automática. E pode ser agradável estar em uma equipe em que todos parecem concordar uns com os outros o tempo todo. Ainda assim, é inimaginável em um empreendimento tão complexo como a DBT, com pacientes desafiadores e terapeutas propensos à desregulação emocional, pensar que todos compartilham a mesma perspectiva o tempo todo. Acredito que vale a pena para uma equipe trabalhar na capacidade de discordar, de conter posições opostas de maneira que torne mais seguro e produtivo fazê-lo. Em consultorias e treinamentos, as equipes podem trabalhar deliberadamente na expansão de suas capacidades dialéticas, encenando desacordos, usando formatos como debates formais ou *role-plays*, em que os membros da equipe deliberadamente assumem posições opostas e, em seguida, trabalham em como validá-las e buscar a síntese. Um pouco de prática vai longe no fortalecimento da capacidade de

gerenciar desacordos produtivamente e, assim, aumentar a segurança e a flexibilidade na equipe.

O *pensamento sistêmico* ajuda a gerar novos ângulos para um problema obstinado: novas perspectivas sobre a formulação e novos caminhos de abordagem. A compreensão de que qualquer entidade específica (um paciente, um terapeuta, outro membro da equipe, um membro da família, etc.) é sempre parte de um todo maior e que uma mudança em qualquer uma das partes resulta em uma mudança em todas as outras partes, abre um universo de opções que poderiam ter sido ignoradas. Por exemplo, às vezes, quando um terapeuta fica preso no tratamento, ele pode se sentir um fracasso. Ele está fechado para outras opções. Seu pensamento se estreita e ele se sente sozinho e desanimado. Mas, na DBT, as perspectivas podem ser ampliadas “entregando” o paciente à equipe. Isso pode ser feito por meio de *role-plays* de várias maneiras: 1) o terapeuta pode interpretar o paciente e um membro diferente da equipe interpreta o terapeuta; 2) o terapeuta pode interpretar a si mesmo como terapeuta, enquanto outra pessoa interpreta o paciente; ou 3) o terapeuta pode assistir enquanto um membro da equipe interpreta o terapeuta e outro interpreta o paciente. Novas perspectivas são abordadas, novas soluções surgem e a equipe começa a “dominar” o tratamento. O terapeuta preso individualmente emerge com novas ideias e uma visão expandida. Ainda mais concretamente, o terapeuta pode convidar um membro da equipe para se juntar a ele em uma sessão com o paciente. Ele poderia até mesmo pedir a um terapeuta diferente para se encontrar com o paciente por algumas semanas como parte da consultoria.

No meu tratamento de um rapaz de 17 anos, parecia que falávamos línguas emocionais diferentes. Eu gostava dele e tentava ajudá-lo com sua depressão, intenções suicidas e comportamentos de uso de substâncias, mas de alguma forma sempre acabávamos ficando presos. Se fizesse uma sugestão a

ele, por mais gentil que fosse, ele agia como se estivesse criticando-o e tentando “remodelá-lo”, como ele dizia. Com a ajuda da equipe, tentei diferentes intervenções, incluindo várias estratégias de solução de problemas, estratégias de validação e algumas estratégias dialéticas, como o uso de metáforas e fazer dos limões uma limonada. Não importava o que eu fizesse, acabávamos no mesmo impasse: parecia que eu o estava criticando ou tentando controlá-lo. Eu estava ficando frustrado, um pouco sem esperança e correndo o risco de um estágio mais avançado de *burnout* do terapeuta.

Um dos membros da equipe se perguntou se eu estava de alguma forma inconscientemente “interpretando o papel” de alguém na família do garoto, possivelmente o pai, com quem ele mal falava. Ela sugeriu que eu me encontrasse com o adolescente e seu pai, apenas para ver o que aconteceria nesse arranjo. Segui a sugestão dela. Na reunião, me vi em desacordo com o pai repetidamente, não importa sobre o que discutíamos, como se fôssemos irmãos em uma briga perpétua. O garoto comentou sobre meu conflito com o pai e fez alguns comentários perspicazes e sugestões habilidosas. Os comentários dele refletiram uma compreensão profunda do processo de brigar e do impacto prejudicial da crítica. Aquela sessão levou a uma mudança refrescante em nosso relacionamento. O pensamento sistêmico e as intervenções informadas de forma sistemática direcionam a atenção para o todo maior e suas diversas partes, o que pode abrir territórios inexplorados e manter o processo em movimento.

Quando um terapeuta ou uma equipe está “preso”, pode parecer que o tempo nunca passa, com a frustração e a desesperança aumentando constantemente. Na verdade, a partir da perspectiva do terceiro princípio dialético, o *fluxo*, a experiência de estar parado é uma ilusão. O terapeuta e a equipe que conseguem lembrar desse princípio da realidade no momento de um impasse percebido podem escapar do aprisionamento ilusório. Se ficarmos

parados, as coisas vão mudar. Se nos movimentarmos, as coisas vão mudar. Podemos contar com isso; apenas não podemos sempre perceber quando está acontecendo. Quando uma equipe faz consultoria sobre uma questão persistente que um terapeuta enfrenta na terapia individual ou que os membros da equipe enfrentam entre si, em situações que promovem o *burnout*, os problemas podem parecer insolúveis e o tempo pode parecer insuportavelmente longo. É nesses momentos que um membro da equipe pode lembrar aos outros que, apesar das aparências, na verdade tudo está se movendo e mudando a cada momento e que as opções surgirão com o tempo. Essa perspectiva pode aliviar a sensação de aprisionamento, facilitar a paciência e ajudar todos a reconsiderarem de que forma criar movimento, velocidade e fluxo. Às vezes, esforços frenéticos para trazer mudanças podem realmente interferir com a mudança, enquanto verdadeiramente “deixar” de tentar mudar as coisas permite que o movimento ocorra e novas perspectivas surjam.

Encontrar validade em posições opostas, procurar a síntese do que é válido em cada uma, expandir nosso campo de observação com o pensamento sistêmico e lembrar que o fluxo é constante, em todos os níveis de cada sistema, promove a solução de conflitos, abre intervenções abordando o sistema maior e paciência e movimento. Os princípios dialéticos facilitam um quadro mais flexível dentro do qual se pode detectar e prevenir o *burnout* do terapeuta e suas manifestações na equipe de consultoria. Por fim, agora menciono as abordagens baseadas em princípios para a resolução do *burnout* do terapeuta quando ele já está bem estabelecido.

Tratamento do *burnout* do terapeuta pela equipe de consultoria

Agora passamos para a aplicação passo a passo dos princípios de mudança ao trabalhar em equipe com um terapeuta que está sofrendo de um nível moderado a grave de *burnout*.

O paradigma da mudança no tratamento do burnout

O trabalho explícito no *burnout* começa com o processo de focalização. Não surpreendentemente, o alvo de maior prioridade para a equipe será a consultoria com um terapeuta cujo paciente está exibindo comportamentos de alto risco que ameaçam a vida. A segunda prioridade mais alta para a equipe é a consultoria com um terapeuta que está experimentando ou demonstrando evidências de *burnout*. Em alguns casos, um terapeuta colocará a si mesmo na agenda, pedindo ajuda com o *burnout* ou a desregulação emocional. Em outras ocasiões, o terapeuta pode não reconhecer que está em um caminho em direção ao *burnout*, mas os membros da equipe podem notar indicadores e perguntar sobre eles. A busca ativa por pistas de *burnout* nos membros da equipe, se tratada com respeito e validação, pode ajudar a detectá-lo precocemente e impedir que prossiga para a espiral de *burnout* terapeuta-paciente transacional discutida anteriormente.

Em uma equipe, uma terapeuta muito capaz de terapia cognitivo-comportamental (TCC), que estava encarregada de um programa de tratamento diurno de TCC e que costumava pedir ajuda à equipe, ficou cada vez mais silenciosa ao longo de várias semanas. Quando questionada diretamente se tinha algo para a agenda, ela simplesmente dizia: “Todo mundo está bem”. Isso era tão incomum para ela e tão improvável de ser verdade, dada a natureza estressante de seu programa, que seus colegas ficaram perplexos e preocupados. Conforme estabelecemos a agenda da reunião, perguntamos se ela precisava de ajuda, e ela respondeu com ressentimento e uma recusa firme em estar na agenda. Um membro da equipe persistiu, e ela ficou abertamente irritada e

mandou-o se afastar. Foi difícil tanto questionar mais quanto deixar a questão de lado. A equipe ficou em silêncio. Quando um dos membros que era amigo da terapeuta perguntou “Como podemos ajudar?”, ela irrompeu em lágrimas e suas preocupações vieram à tona. Para começar, ela tinha um paciente de alto risco em seu programa e estava frustrada com o terapeuta do paciente. Expressou desânimo em relação ao seu programa como um todo e à sua competência como líder. Terminou dizendo que “sempre soube” que estava na área errada e estava pensando em deixar a saúde mental por completo. Nada do que ela disse era totalmente novo para os membros da equipe, mas o nível de intensidade e desesperança era muito além do que qualquer um havia conhecido. Foi como se um abscesso tivesse sido drenado e uma pressão intensa tivesse saído. Após um momento de silêncio, ela agradeceu à equipe pela paciência e foi possível começar a acessar as variáveis da pressão e do desespero que ela estava sentindo. É importante notar que o processo de direcionamento de alvos nem sempre é simples em casos de *burnout*, pois a supressão de respostas e a vergonha sobre a própria efetividade muitas vezes fazem parte da história.

Além disso, é importante perceber que, às vezes, o que parece ser um caso de *burnout* relacionado ao tratamento de um paciente ou de um grupo pode ter origens muito distantes do ambiente clínico. Em um exemplo, os membros da equipe notaram que uma terapeuta parecia muito angustiada e extraordinariamente crítica ao falar sobre seu trabalho com um paciente. Ela estava relutante em falar sobre isso. Quando um colega a pressionou um pouco, ela quase gritou a notícia, que era nova para todos, de que havia sido diagnosticada com câncer. Seu *burnout* não foi resultado da terapia, mas estava afetando o tratamento de todos, em especial seu paciente mais difícil. Os membros da equipe, atordoados e preocupados, perguntaram se poderiam ajudar. Eles se ofereceram para ajudar em qualquer caso, quaisquer grupos, e apoiá-la mais

pessoalmente, se isso fosse possível. Ela expressou apreço, mas informou que tinha bons apoios e outros lugares para controlar suas emoções. Ela perguntou se poderia simplesmente continuar a participar da equipe na medida do possível, porque ela achou que isso “normalizava” sua situação. Esse exemplo pode ajudar a esclarecer que quando falamos da equipe de consultoria como “terapia para o terapeuta” na DBT, isso não significa que seja uma forma de “terapia pessoal”. Trata-se de “terapia para o terapeuta”, na medida em que estamos ajudando uns aos outros no contexto do tratamento de pacientes.

Quando uma equipe identifica que um terapeuta está pedindo ajuda com problemas associados ao *burnout*, o terapeuta idealmente fornece uma descrição detalhada da situação, incluindo eventos, pensamentos, ações e emoções. É comum que membros da equipe cometam o erro de começar a fazer sugestões muito rapidamente, sem antes fazer uma avaliação cuidadosa. O ideal é que a equipe ouça a descrição do problema com atenção e, em seguida, pergunte o que o colega acha que a equipe pode fazer para ajudá-lo. Eles podem ter enfrentado um desafio semelhante em seus próprios casos e estão ansiosos para compartilhar suas soluções. Podem conhecer o paciente, seja por meio de contato prévio como terapeuta ou em um grupo de treinamento de habilidades, e ter uma impressão imediata do problema e do que precisa ser feito. Embora as sugestões possam ser bem-intencionadas e até mesmo úteis, elas podem desencadear uma resposta defensiva. O que precisa vir a seguir é uma avaliação cuidadosa. Na maioria das vezes, depois de o terapeuta descrever o problema, é melhor que alguém diga algo como: “Agora que você explicou o problema, diga-nos o que acha que podemos fazer para ajudá-lo”.

Às vezes, um terapeuta não quer sugestões, apenas quer ser ouvido e compreendido, e isso é o suficiente. Em outros momentos, quer ideias sobre como conceitualizar a situação. Às

vezes, realmente quer sugestões sobre como resolver o problema com o paciente. E, ocasionalmente, pede ajuda especificamente para regular suas próprias emoções, que podem ter se tornado avassaladoras. O trabalho dos membros da equipe é descobrir que tipo de ajuda o terapeuta procura, não fornecer tudo o que ocorre a eles.

Identificar e monitorar andam de mãos dadas; uma vez que a progressão do terapeuta em direção ao *burnout* seja abordada em uma reunião da equipe, ela deve ser revisitada na agenda em reuniões futuras para obter atualizações e permitir a solução contínua de problemas.

O *comprometimento* é essencial como parte da solução de problemas em uma equipe de consultoria, assim como na condução da terapia individual. Esse ponto se refere tanto ao nível de comprometimento da equipe com cada terapeuta quanto ao nível de comprometimento do terapeuta em direcionar seus comportamentos problemáticos e suas emoções angustiantes relacionadas ao tratamento. Participar de uma equipe de consultoria em DBT requer “assinatura” dos seis acordos da equipe de consultoria e a combinação para ser pontual e consistente com a presença. Nas próprias reuniões, espera-se que os terapeutas estejam completamente presentes e atentos uns aos outros, não distraídos por outros trabalhos, telefones celulares ou discussões paralelas. Nos últimos anos, ao explicar suas últimas ideias sobre equipes de consultoria durante seminários, Linehan argumentou a importância de todos que participam de uma equipe de consultoria serem “vulneráveis”, o que significa que todos estão praticando DBT de uma forma ou de outra. Ninguém está sentado “fora” do círculo vulnerável de terapeutas que estão compartilhando seu trabalho. Ter um, dois ou mais “observadores” que não estão praticando DBT pode inibir a disposição de alguns de compartilhar suas falhas. Por exemplo, ter administradores na equipe para mantê-los informados sobre os desenvolvimentos da equipe ou ter

terapeutas não DBT presentes para aprenderem sobre DBT pode interferir na atmosfera ideal. Em resumo, a equipe de DBT é mais como uma “unidade de combate” lidando com o conflito do que um seminário ou reunião administrativa. O tempo é precioso, a presença é preciosa e estar “totalmente dentro” é crucial. Na presença desse tipo de comprometimento manifesto, os terapeutas serão mais propensos a se comprometerem também. Não é incomum que dinâmicas interpessoais problemáticas dentro da equipe interfiram no comprometimento total dos terapeutas com ela. Se esse for o caso, isso constituiria um comportamento generalizado que interfere na equipe e deve ser colocado na agenda para ser direcionado a fim de avaliá-lo, resolvê-lo e restaurar um senso completo de comprometimento e participação. Na minha experiência, dinâmicas problemáticas podem ocorrer em reuniões típicas (não DBT) de equipes interdisciplinares em saúde mental, nas quais as discussões geralmente são menos pessoais e os membros não costumam compartilhar vulnerabilidade, e ainda assim um bom trabalho pode ocorrer. Mas esses processos interferem seriamente no trabalho de consultoria em equipes DBT.

Os próximos passos dependem do que o terapeuta quer e precisa. Se ele quer ajuda com a avaliação, formulação e solução de problemas em relação ao seu *burnout*, o modelo fornecido pela análise em cadeia do comportamento se torna útil. Os membros da equipe tentam entender claramente os comportamentos de *burnout*, como a evitação de estímulos relacionados ao paciente, o afastamento do paciente nas sessões, atitudes e declarações críticas em relação ao paciente, violações não abordadas de seus próprios limites pessoais, níveis debilitantes de ansiedade ou vergonha associados ao paciente, e assim por diante. No esquema de análise em cadeia do comportamento, conforme imaginamos a “história de *burnout*” seguindo da esquerda para a direita na cadeia, os comportamentos de *burnout* ocupam o mesmo lugar na cadeia que os comportamentos-alvo prioritários do paciente na

terapia individual. Por exemplo, no exemplo anterior do terapeuta que atendeu aos pedidos de aumento de proximidade física durante as sessões, a equipe analisaria a decisão disfuncional do terapeuta de permitir que a paciente segurasse sua mão. Esse seria o comportamento sob avaliação, e o objetivo seria identificar as variáveis controladoras do “comportamento de segurar a mão”. Apenas para deixar esse ponto bem claro: embora a questão central do *burnout* seja a desregulação emocional do terapeuta, o envolvemos em uma análise em cadeia de pelo menos um de seus comportamentos problemáticos que decorrem da desregulação. Isso é mais focado, mais alinhado com o tratamento comportamental, mais congruente com o tipo de análise em cadeia do comportamento que fazemos com pacientes na DBT e, no geral, mais produtivo do que fazer uma análise em cadeia em construtos maiores, como *burnout* ou *desregulação emocional*.

A equipe escuta os fatores de vulnerabilidade. Há fatores no terapeuta ou no ambiente, em relação a esse paciente ou não relacionados a ele, que tornaram o terapeuta vulnerável aos desafios do tratamento? Se sim, o remédio pode incluir abordar esses fatores, os quais podem incluir estressores recentes na vida do terapeuta, circunstâncias estressantes no ambiente de tratamento, carga excessiva de casos, suicídio recente ou outro resultado adverso em algum caso, e assim por diante. Em relação ao paciente em particular, o terapeuta pode estar vulnerável em relação a certos aspectos da apresentação, como uma tendência a ameaças e violência, ou episódios frequentes de comportamento suicida. O terapeuta pode experimentar vulnerabilidade porque o paciente apresenta problemas que são semelhantes aos que o terapeuta já teve, ou o paciente pode ter conexões na comunidade que se sobrepõem às do terapeuta, aumentando um senso de visibilidade e autoconsciência. Qualquer um ou todos esses fatores, que antecedem mesmo um minuto gasto juntos na terapia, podem ser significativos de viés no *burnout*.

A equipe está atenta a eventos desencadeadores, momentos-chave na relação terapêutica que provocam a trajetória em direção à desregulação crescente do terapeuta. Por exemplo, quando percebi que estava caminhando para o *burnout* em relação ao tratamento de uma paciente em particular, pude rapidamente identificar um momento-chave naquela trajetória, um evento desencadeador, como a manhã em que ela quebrou uma lâmpada na minha sala de espera antes de uma sessão comigo, alegando que estava frustrada com a vida. Isso me pegou de surpresa. Embora eu tenha imediatamente insistido que ela consertasse a lâmpada e pagasse por isso, percebi mais tarde que emocionalmente suprimi minha resposta e sub-reagi à minha própria raiva. Eu a mantive sob pressão para consertar a lâmpada, mas em um nível mais íntimo entre nós, eu estava mais retraído e indulgente. A partir desse ponto, uma espiral ocorreu em que ela violou vários acordos e limites e eu continuei a fornecer contingências insuficientemente firmes. Logo ela estava fora de controle comportamental e eu estava sobrecarregado com fortes emoções negativas. Foi útil para mim localizar o “início da cadeia” e depois ver como aquela cadeia prosseguiu, elo por elo, para os comportamentos de *burnout*, como o forte desejo de parar de trabalhar com ela.

À medida que a equipe trabalha com o terapeuta para esclarecer os elos na cadeia que resultaram em comportamentos de *burnout*, certos elos se destacam como importantes, e padrões emergem. À medida que padrões emergem e são observados pelo terapeuta e pela equipe, hipóteses podem ser geradas e testadas. No exemplo anterior, surgiu um padrão em que eu estava sub-reagindo aos comportamentos deliberados da paciente. A equipe e eu sabíamos que esse não era um padrão com todos os meus pacientes, levantando a questão sobre minha reação a essa paciente, em particular. Eu estava com medo dela e, portanto, era indulgente demais? Eu era cuidadoso com ela por causa de um

pressuposto de que ela era frágil e não podia tolerar confrontação? Eu tinha medo de que se a desafiasse de maneira apropriada aos seus comportamentos, ela desistiria da terapia? Esses são os tipos de hipóteses e perguntas que surgirão na avaliação do caminho para o *burnout*, e as respostas determinam a busca por soluções. Como ficou claro na avaliação do meu *burnout* em evolução nesse caso, eu estava sendo excepcionalmente cuidadoso no tratamento dessa paciente. Ela era uma universitária que estava mostrando um aumento na desregulação comportamental em sua vida, seu irmão havia falecido por suicídio recentemente e o colega que a encaminhou a mim era um amigo próximo da família dela. Percebi que meu manejo desequilibrado da desregulação da paciente em meu consultório era produto desses vários fatores e era um elo na cadeia para minha própria desregulação emocional e *burnout*. Fui capaz de restaurar o equilíbrio no tratamento com uma consciência mais ampla dos fatores contribuintes.

Ao revisar a cadeia com o terapeuta e encontrar elos e padrões relevantes, a equipe trabalha com o terapeuta em direção a uma formulação do fenômeno de *burnout* particular. Novamente, são necessárias disciplina e objetividade dos terapeutas da equipe para não propor suas soluções favoritas antes de fazer a avaliação.

A formulação do caso integra princípios dos quatro modelos comportamentais que fazem parte da DBT. Associadas a cada modelo estão possíveis soluções. Pode ser que as intensas respostas emocionais do terapeuta tenham sido desencadeadas por estímulos do paciente ou associados ao paciente, como no condicionamento clássico. Alinhado com o modelo de condicionamento operante, um terapeuta pode ser reforçado pelo paciente por uma terapia que acalma e valida, enquanto é punido quando pressiona por mudanças comportamentais, e, como resultado, o terapeuta fica desequilibrado. O terapeuta pode ter sido reforçado por violar seus próprios limites pessoais, o que

resultou em uma situação intolerável para ele. O terapeuta em modo de *burnout* frequentemente chegou a pressupostos ou crenças disfuncionais sobre o paciente, sobre a terapia e/ou sobre si mesmo, como esperado no modelo de mediação cognitiva. Finalmente, os déficits de habilidades do terapeuta podem ser destacados – déficits tanto no conjunto de habilidades para conduzir a DBT (estratégias de tratamento) quanto no conjunto de habilidades ensinadas aos pacientes em DBT. Faltando um conjunto completo e ativo de estratégias e habilidades apropriadas para a situação que poderiam ajudar o terapeuta a manter o controle e o equilíbrio terapêutico, ele pode recorrer a padrões automáticos de reação que se desviam da DBT. Cada um dos quatro modelos comportamentais traz consigo uma teoria de mudança, incluindo um repertório de soluções, que podem ser úteis para o terapeuta. Em seguida, considero o uso de cada modelo no tratamento do *burnout* do terapeuta.

Princípios do condicionamento clássico no tratamento do burnout

Como pode ser observado nos exemplos mencionados, o terapeuta com *burnout* provavelmente é muito sensível a certos estímulos relacionados ao paciente que se repetem. Esses sinais automaticamente disparam reações emocionais que são dolorosas e difíceis de gerenciar. A equipe pode ajudar o terapeuta a se tornar mais consciente da natureza e do impacto dos estímulos e da natureza involuntária de suas respostas a eles. Com esse tipo de compreensão e apoio, ele pode usar estratégias de controle de estímulos, evitando alguns sinais e modificando outros. Por exemplo, ele pode mudar o horário da sessão de um paciente para um momento do dia em que é mais resiliente, ou trabalhar diretamente com o paciente para modificar certos comportamentos que interferem na terapia e que ultrapassam seus limites pessoais.

Às vezes, quando o padrão comportamental acionado pelos estímulos é mais evidente, a equipe pode trabalhar por meio de procedimentos de exposição, apresentando deliberadamente sinais semelhantes ao terapeuta em reuniões de equipe ou por meio de tarefas na terapia com o paciente. Por exemplo, uma vez tive uma paciente que respondia a todas as minhas intervenções como se eu estivesse interrompendo-a, tirando-a do caminho certo e arruinando seu tratamento. Decidi falar menos e ouvir mais, assumindo que à medida que nosso relacionamento crescesse e sua confiança em mim aumentasse, minha contribuição se tornaria mais aceitável e importante para ela. Durante as semanas seguintes, esse padrão continuou. Ainda assim, de vez em quando eu intervinha, e em cada caso ela ignorava, rejeitava ou contrariava minha intervenção. Suas reações às minhas intervenções se tornaram um sinal provocativo para mim. Eu antecipava suas respostas com ansiedade e, quando elas aconteciam, sentia imediatamente irritação e ressentimento. Eu sabia que as coisas estavam piorando quando comecei a detestar o som de sua voz. As sessões se tornaram difíceis, e eu desejava que ela cancelasse.

Durante a avaliação desse padrão, os membros da equipe hipotetizaram que eu estava particularmente provocado por seu tratamento desdenhoso em relação às minhas intervenções. Essa hipótese soou verdadeira para mim, já que eu sabia que normalmente tinha fortes reações em minha vida pessoal se fosse ignorado. Concordamos que, em um *role-play*, um deles interpretaria um paciente que estava desconsiderando minhas intervenções. Fizemos isso várias vezes, o que se tornou bastante divertido, enquanto eu comecei a me dessensibilizar para o impacto das respostas desdenhosas e a experimentar diferentes maneiras de responder. Na terapia com a paciente, eu quase esperava pelo seu tratamento negligente em relação a mim, e me tornei mais equilibrado e direto em minha resposta. Esse processo

desempenhou um papel significativo em reverter minha trajetória em direção ao *burnout*.

Em praticamente todas as experiências de *burnout*, certos estímulos relacionados ao paciente adquirem o poder de desencadear fortes emoções negativas no terapeuta. Podem ser explosões de raiva do paciente, respostas irritáveis, expressões de desesperança ou passividade diante de desafios. O que antes poderia ter despertado curiosidade no terapeuta, eventualmente se torna um ponto de gatilho para respostas emocionais intensas e incontroláveis. Na maioria das abordagens significativas de tratamento da síndrome de *burnout* do terapeuta baseadas em equipe, o modelo de condicionamento clássico e os procedimentos de controle de estímulo e exposição com prevenção de resposta podem desempenhar um papel útil. A chave é encontrar uma maneira de combinar o estímulo relacionado ao paciente com algum estímulo na reunião da equipe, para provocar a resposta emocional completa, e explorar várias opções para que o terapeuta experimente a resposta e aja de maneira oposta ao impulso que a acompanha.

Princípios de condicionamento operante no tratamento do burnout

No *burnout* do terapeuta, às vezes fica evidente que as consequências contingentes dos seus comportamentos o levaram a respostas desadaptativas, incluindo a supressão emocional – a fórmula para o *burnout*. Se a equipe puder ajudar o terapeuta a ver esses processos com mais clareza e reforçar respostas terapêuticas adaptativas, o equilíbrio pode ser restaurado e o *burnout* reduzido.

Por exemplo, o terapeuta pode reconhecer com mais precisão que introvertidamente sofreu modelagem na direção de violar seus limites pessoais “pelo bem do paciente”, suprimindo suas

inevitáveis respostas emocionais. A equipe pode orientar sobre a modificação dos limites para combiná-los com sua própria zona de conforto. Ao fazer isso, o terapeuta recebe reforço da equipe por comportamentos que estão sujeitos a punição pelo paciente. Além disso, a equipe pode ajudar o terapeuta a determinar maneiras eficazes de apresentar seus limites modificados ao paciente. O terapeuta deve estabelecer limites que funcionem para ele, esclarecê-los ao paciente, tranquilizá-lo e validá-lo, reforçando-o consistentemente por permanecer dentro desses limites, e usar procedimentos de modelagem, extinção e punição para chegar a uma solução viável. Isso pode ser difícil. O terapeuta pode se sentir envergonhado por ter estendido seus limites na medida em que o fez e requer uma abordagem de equipe não julgadora para ver o problema com clareza antes de resolvê-lo. Ele provavelmente teme as reações do paciente ao reduzir seus limites, ou, ainda, pode acreditar que o paciente se beneficia de limites mais amplos. Pode ser difícil pesar objetivamente os benefícios de longo prazo ao definir os limites que precisa *versus* os benefícios de curto e longo prazo para o paciente ao manter limites mais amplos. Os esforços da equipe podem ser cruciais nesse momento para ajudar o terapeuta a pesar os prós e contras, ao mesmo tempo em que permanece consistente em reforçar o terapeuta por observar efetivamente seus limites. Como observado, as consequências negativas de longo prazo do *burnout* podem ser graves e, uma vez bem estabelecidas, é difícil revertê-las.

O uso de procedimentos de manejo de contingências da equipe vai muito além do contexto de reforçar limites pessoais. Em cada consultoria com cada terapeuta, a equipe está reforçando alguns comportamentos e extinguindo e punindo outros. Os membros da equipe devem pensar cuidadosamente em reforçar comportamentos que estejam alinhados com o modelo de tratamento e eficazes na terapia. Como o terapeuta está sujeito a um conjunto de contingências do paciente, ou de outras pessoas

associadas ao paciente, a equipe precisa ser consistente em reforçar bons comportamentos terapêuticos quando outros podem estar reforçando terapia ineficaz. Certa vez, eu estava tratando uma adolescente que não queria falar comigo. Após alguns meses, comecei a pensar em desistir dessa paciente, pois ela parecia totalmente desinteressada em mim. Eu achava exaustivo suportar as sessões e o que percebia como seu silêncio e desdém cínico em relação a mim. Quando apresentei minha “vontade” de parar com ela à minha equipe, um dos terapeutas insistiu que eu não tinha como saber com certeza como a paciente se sentia em relação a mim e se estava se beneficiando, mesmo em seu silêncio. Ele sugeriu que eu imaginasse que ela estava ligada a mim, escolhendo vir quando não precisava estar lá, e ele e outros da equipe reforçaram minha persistência, paciência e imaginação de ligação. Como acabou acontecendo, pouco tempo depois eu encontrei uma maneira de fazê-la se envolver em conversa, e algumas das abordagens da equipe foram confirmadas.

Princípios de mediação cognitiva no tratamento de burnout

Este exemplo também demonstra a aplicação no grupo de outra modelagem comportamental e seus princípios: *mediação cognitiva*. Ao chegar à crença de que a paciente não estava ligada a mim e só tinha sentimentos de desprezo, mesmo que ela não tenha explicitamente compartilhado seus pensamentos comigo, acabei me sentindo desencorajado e sem esperança. Quando membros da equipe notaram que eu estava interpretando de forma pessimista seu comportamento e me lembraram que eu não tinha acesso aos fatos, percebi que estavam corretos. Minhas emoções e impulsos em relação a ela estavam sendo guiados por um conjunto de crenças sobre ela, não fatos. Então fui capaz de reconhecer meus pensamentos pessimistas nas sessões seguintes e considerar outras interpretações de seu comportamento. Isso

aliviou a pressão sobre mim de “fazê-la se envolver”, o que permitiu que um processo de conexão e envolvimento se desdobrasse lentamente. Em todos os casos de *burnout* de terapeutas de que me lembro, os pressupostos e crenças disfuncionais do terapeuta sobre o paciente, a terapia e/ou ele próprio, mesmo que não fossem os fatores iniciais para o *burnout*, tornaram-se importantes variáveis de manutenção. Na avaliação e no tratamento do *burnout*, os membros da equipe precisam estar atentos às cognições do terapeuta, dispostos a destacá-las como pensamentos em vez de fatos, e sugerir interpretações alternativas.

Durante uma reunião da equipe, uma das terapeutas estava discutindo sobre um paciente com ideias suicidas. Tive a impressão de que ela estava superestimando a probabilidade de um episódio de comportamento suicida letal, uma vez que o paciente nunca havia se envolvido em comportamentos suicidas. Percebi que havia ouvido esse tipo de interpretação dessa terapeuta em relação a outros pacientes, e isso sempre causava a ela muita ansiedade e às vezes ressentimento do paciente por falar sobre suicídio. Perguntei se ela poderia explicar seu pensamento sobre o alto risco de suicídio do paciente. No curso da discussão na equipe, ela reconheceu que esta era uma área de ansiedade e confusão para ela. Como ela colocou, “Prefiro errar ao assumir que um comportamento suicida sério está chegando, em vez de ser pega de surpresa”. Como descobrimos, houve um suicídio em sua família quando ela era jovem, e ela ainda estava operando com suposições que a poupariam de outro evento catastrófico, outra surpresa devastadora. A equipe ficou então alerta à “vulnerabilidade cognitiva” dessa terapeuta em relação aos pacientes com ideação suicida, o que ajudou a fornecer consultoria para ela e a prevenir o *burnout* com esses pacientes.

Princípios da teoria do déficit de habilidades no tratamento

do burnout do terapeuta

Por fim, a equipe de consultoria pode implementar os princípios do quarto modelo comportamental, a *teoria do déficit de habilidades*, engajando o terapeuta em procedimentos de treinamento de habilidades. Os membros da equipe estão atentos aos pontos fortes e fracos na aplicação da DBT uns dos outros, o que é uma função explícita da equipe de consultoria. No esforço conjunto de adquirir todas as estratégias no arsenal da DBT, fortalecer a prática dessas estratégias por meio de estudo, prática e reforço mútuo e generalizá-las para o tratamento do paciente ou a condução de um grupo de habilidades, os membros da equipe fortalecem a prática da DBT uns dos outros. Ter à disposição uma gama de estratégias, cada uma vinculada aos princípios do tratamento, inevitavelmente é útil no tratamento do *burnout*. Cada terapeuta pode usar os mesmos conjuntos de estratégias, seja trabalhando com o paciente ou participando de reuniões da equipe. O uso da mesma linguagem pelos membros da equipe e o compartilhamento do objetivo de dominar as mesmas estratégias e habilidades potencializa um processo de equipe mais eficaz. Os membros da equipe usam estratégias de validação uns com os outros, todas as estratégias de mudança e estratégias dialéticas. Por exemplo, como discutido antes, a equipe usa procedimentos de manejo de contingências, como o reforço dos comportamentos do terapeuta, para ajudá-lo a usar procedimentos de contingência, como observar limites pessoais, de forma mais eficaz com o paciente. Para retornar à teoria biossocial do *burnout*, na qual o terapeuta está lidando com a desregulação emocional no contexto de invalidação ou não validação, o tratamento do terapeuta requer um ambiente validador, no qual a equipe usa estratégias da DBT para aumentar a eficácia do terapeuta na gestão da desregulação emocional durante o tratamento do paciente.

Princípios do paradigma dialético

Nesta seção, o foco é em como os princípios dialéticos podem auxiliar a equipe a ajudar seus membros a quebrarem os “bloqueios” prolongados que caracterizam a maioria dos casos estabelecidos de *burnout*.

Em uma equipe de consultoria em um programa de tratamento diurno baseado em DBT, uma das terapeutas também era uma excelente enfermeira. Ela se orgulhava de manter seu conhecimento e suas habilidades médicas enquanto também era uma terapeuta DBT de primeira linha. Uma de suas pacientes tinha vários problemas médicos, incluindo diabetes, convulsões e hipertensão grave, e frequentemente tinha que faltar a um dos grupos devido a queixas médicas; nessas ocasiões, ela às vezes procurava sua terapeuta, que tentaria ajudá-la com o problema médico. Parecia aos outros membros da equipe, alguns dos quais tinham essa paciente em seus grupos, que os incidentes médicos estavam aumentando e que a paciente estava deixando os grupos com mais frequência. Em uma reunião da equipe de consultoria, uma das líderes de grupo sugeriu à terapeuta que, por ser tão experiente e disponível em relação aos problemas médicos, ela provavelmente estava reforçando comportamentos mais disfuncionais do que resolvendo. A terapeuta ficou magoada e irritada, sentindo-se acusada de ser inadequada e insensível. Ela aumentou o tom de voz: “Você acha que eu não penso nisso? Você acha que é fácil tratar essa pessoa? Por que você não a trata? Eu estou cansada de todos vocês!”.

Foi uma explosão repentina, não prevista por ninguém, já que sua colega era quase sempre estável e composta. Parecia que um problema de *burnout* havia sido repentinamente lançado na sala, e sua desregulação emocional se tornou a desregulação emocional de todos. Os membros da equipe sentaram-se em silêncio, tentando se recompor e descobrir o que fazer. A terapeuta que

levantou a questão pediu desculpas à sua colega e disse que não queria acusá-la de nada, mas estava apenas curiosa. A terapeuta que tratava a paciente parecia um pouco envergonhada por sua própria explosão, mas era difícil consolá-la.

Finalmente, alguém da equipe disse: “Me pergunto se há uma dialética aqui”, sabendo que conflitos intensos muitas vezes resultam da falha em validar ambos os lados. Outra terapeuta seguiu sua deixa: “Quando você pergunta isso, me faz pensar se podemos dizer quais são os lados opostos. Por um lado, a terapeuta enfermeira está fazendo tudo o que pode, tentando descobrir como ajudar uma paciente que está doente e emocionalmente perturbada; e, por outro lado, há a possibilidade de que ela seja tão boa nisso que esteja inadvertidamente reforçando os comportamentos. Eu não sei”. A chave para a eficácia dessa terapeuta em fazer esta declaração foi sua atitude verdadeiramente não julgadora; ela estava realmente tentando enquadrar o conflito como resultante de *duas posições opostas, mas igualmente válidas*. Uma vez que a dialética foi identificada na forma de duas declarações opostas, mas válidas, a discussão poderia prosseguir. A terapeuta parecia aceitar a validação. Ela explicou que estava “muito preocupada” em reforçar os comportamentos médicos, que tinha considerado, e sentia-se presa pelos problemas médicos muito reais que sabia como tratar. Ficou especialmente chateada quando a paciente saiu de uma reunião em grupo para vê-la, alegando que seus sintomas médicos tornavam a participação em grupo impossível. Ela sentia que já estava sofrendo de *burnout* nesse caso, mas estava envergonhada porque via os outros membros da equipe como mais competentes do que ela e queria resolver o problema sozinha. A equipe, uma vez que a dialética foi nomeada e discutida, trabalhou em conjunto em uma *síntese* envolvendo um protocolo que reconhecia que a paciente às vezes precisava de suporte médico, mas que não procuraria ajuda de sua terapeuta durante as sessões em grupo,

com base na possibilidade inadvertida de reforçar sua baixa participação no programa. Se ela precisasse sair dos grupos por motivos médicos, precisaria buscar atendimento médico, mas não da terapeuta, e relatar aos líderes do grupo sobre o resultado. Além disso, a terapeuta pediu ajuda da equipe para chegar à sua própria política, que a eliminaria do processo de tratamento médico como um todo, já que essa não era sua função.

O *burnout* quase sempre envolve uma dialética não resolvida, na terapia ou na equipe, às vezes em ambos os contextos. O paciente quer algo, o terapeuta quer o oposto, e a solução envolve a capitulação ou do paciente ou do terapeuta, levando à supressão de emoções negativas. Em seguida, a dialética entra no contexto da equipe: o terapeuta tem um ponto de vista, outros membros da equipe têm um ponto de vista oposto; um se submete superficialmente ao outro, mas o conflito continua não resolvido. A fórmula dialética em ambos os contextos é surpreendentemente útil, mesmo que não seja fácil: 1) identificar sem julgar as posições opostas; 2) encontrar e afirmar a validade em ambas as posições; 3) buscar explícita e colaborativamente uma síntese genuína que honre ambos os lados; e 4) implementar a síntese e avaliar o resultado.

Nesse processo, várias estratégias dialéticas da DBT podem desempenhar papéis instrumentais. Estratégias de tratamento equilibrado podem ajudar a honrar ambos os lados de um conflito aplicando tanto a aceitação quanto a mudança. Fazer dos limões uma limonada, estender, interpretar o advogado do diabo, evocar a mente sábia e entrar no paradoxo são todas ferramentas criativas que incluem dois lados opostos e criam movimento. Elas foram extensamente abordadas no Capítulo 13. É importante lembrar que elas podem ser utilizadas tanto em um processo de equipe de consultoria quanto na terapia.

Ao se aproximar de um impasse, o terapeuta ou a equipe recorre à estratégia de *avaliação dialética*. Todos se perguntam e

procuram o que foi deixado de fora da equação. Em um caso, uma terapeuta da equipe descreveu seu trabalho muito frustrante com uma paciente que se diagnosticou com fibromialgia. Em todas as sessões, a paciente reclamava de sua dor e deficiência e descrevia um incidente após o outro em que a equipe de saúde descartava suas queixas como sendo “coisa da sua cabeça”. Reclamava que todos em sua vida simplesmente esperavam que ela continuasse como se nada estivesse acontecendo. Ela estava constantemente irritada, e, depois de meses, a terapeuta estava prestes a concluir que nada poderia trazer mudanças. Como a terapeuta ponderou, “É como se ela estivesse em um prédio em chamas, inclinando-se para fora de uma janela no segundo andar, e todas as semanas eu colocasse uma escada na janela para ajudá-la a sair, e todas as semanas ela apenas empurrasse a escada para longe e continuasse reclamando que logo morreria de calor e negligência”. A terapeuta estava prestes a desistir, mas não conseguia ver uma saída.

O líder da equipe perguntou a ela se participaria de um *role-play* em que interpretaria sua paciente reclamando enquanto outra pessoa na equipe interpretaria a terapeuta. O restante da equipe assistiu. Estávamos procurando coisas que poderiam ser deixadas de fora de nossa compreensão. O *role-play* foi esclarecedor. Foi muito frustrante para o indivíduo que interpretava o papel da terapeuta, que descobriu que nenhuma intervenção funcionava. Essa foi a melhor forma de validação para a terapeuta, que também teve a chance de se “sentar na cadeira da paciente” e ver como era difícil ser tão difícil. Isso aumentou sua empatia pela paciente e sua curiosidade sobre as causas da posição dela. A terapeuta sentiu-se mais unida à equipe. Eles conseguiram fazer um *brainstorming* juntos. Pensando de forma dialética, uma terapeuta sugeriu uma estratégia dialética de ampliação: “Por que você não valida a experiência dela de que o mundo é frio e duro, que ninguém entende como é frustrante, e sugere a ela que suas

reclamações podem não ser suficientemente fortes. Você pode convidá-la a fazer reclamações mais vigorosas e descritivas, incluindo reclamações sobre você como terapeuta”. Ela estava sugerindo que a terapeuta, em vez de se afastar das reclamações da paciente, estimulasse mais delas.

A terapeuta achava que isso simplesmente reforçaria a postura passiva e sofredora da paciente, mas estava disposta a tentar, primeiro em um *role-play* e depois com a paciente. Isso se mostrou interessante. A paciente não sabia o que dizer. De certa forma, ela se sentiu mais profundamente validada pela terapeuta do que em qualquer momento anterior, mas também disse: “Eu reclamo o tempo todo e não ajuda. Você não acha que eu mesma deveria tentar fazer algo a respeito?”. Isso veio para a paciente como uma ideia nova. Embora esse ponto de intervenção dialética, em que a terapeuta “brincou com opostos” de uma maneira diferente, não tenha transformado o caso, ele abriu uma porta para uma nova linha de diálogo que tornou o processo menos exaustivo para a terapeuta. Esses tipos de intervenções na equipe, assim como na terapia, não necessariamente resolvem o problema, mas criam desequilíbrio e movimento em uma situação que tem sido dolorosamente estática por muito tempo.

Intervenções baseadas em *pensamento sistêmico* também podem desempenhar um papel transformador quando o *burnout* é o problema. Em uma equipe, um terapeuta confessou que havia cometido um erro flagrante com seu paciente. Ele estava envergonhado e hesitante em seu relato do que havia acontecido na sessão anterior. Como um terapeuta jovem, ele temia a desaprovação de seus mentores e colegas. A paciente apresentava um transtorno fictício, afirmando ter várias condições médicas graves, inclusive com risco de vida, porém nunca apresentava evidências de patologia. Isso despertava a simpatia das pessoas, mas depois causava raiva quando concluíam que ela havia “inventado” a condição “apenas para chamar a atenção”. O

terapeuta sabia que os outros respondiam à sua paciente com desprezo, o que o levou a sentir simpatia por ela, até perceber que ela estava fazendo a mesma coisa com ele. Ela lhe disse inequivocamente e de maneira crível que tinha câncer de pâncreas, só tinha algumas semanas ou meses de vida, e pediu sua ajuda em como aproveitar ao máximo seus últimos dias. Ele ficou profundamente comovido e concordou em ajudá-la a se concentrar no final; no entanto, pouco antes da sessão seguinte, recebeu um telefonema do médico dela na qual soube que a história era completamente fabricada.

Ele ficou chocado, impressionado com a natureza cativante e crível da história, e envergonhado por sua “credulidade”. Ele gostaria de ter algum tempo para se estabilizar antes da sessão, mas ela já estava na sala de espera. Como uma maneira de ganhar tempo, ele disse a ela que havia um imprevisto e que precisava começar a sessão mais tarde. De volta ao seu consultório, sentou-se em sua cadeira com a intenção de praticar *mindfulness* e alcançar maior equilíbrio e clareza. Ele adormeceu e só acordou quando ouviu batidas na porta – era o fim do tempo designado para a sessão e sua paciente estava batendo com raiva para chamar sua atenção. Como tinha outro paciente vindo e não tinha tempo para vê-la, foi à porta, explicou que o imprevisto havia levado mais tempo do que o esperado e reagendeu com ela. Ele estava envergonhado por seu comportamento.

Na reunião da equipe, quando o terapeuta contou essa história e esperou pela desaprovação esperada, ninguém sabia o que dizer. Alguém perguntou o que ele precisava da equipe. Ele disse que precisava ser fuzilado, e estava falando sério. Os membros da equipe ouviram com compaixão. Eles validaram que adormecer nas circunstâncias era compreensível. Quaisquer declarações gentis e validadoras foram rejeitadas. Ele estava convencido de que todos estavam apenas evitando dizer o que realmente pensavam, que ele era um “fracassado”. O líder da equipe sugeriu

que eles ouvissem a história completa e fizessem uma análise em cadeia do comportamento-alvo de adormecer. O terapeuta não queria participar e então se desculpou por ser tão difícil. Todos na sala ficaram em silêncio, percebendo que estavam presos.

Então, um membro da equipe prosseguiu contando a história de uma vez em que adormeceu durante uma sessão em que uma paciente falava sobre o momento em que foi estuprada. O primeiro terapeuta, lutando com seu remorso, ficou surpreso ao ouvir que alguém tão competente havia feito isso. Outro membro da equipe sugeriu que todos na sala contassem sobre seus piores momentos em terapia. O efeito em todos, incluindo o terapeuta humilhado, foi palpável. Erros dramáticos foram reconhecidos, o humor melhorou. Houve um reconhecimento implícito de que os erros, mesmo os graves, fazem parte do trabalho. É por isso que um dos seis acordos da equipe de consultoria é o acordo da falibilidade.

Quando uma equipe de consultoria “é dialética”, isso adiciona um enorme potencial para prevenir e tratar o *burnout* se for usado para complementar, e não substituir, abordagens padrão dos paradigmas de aceitação e mudança. *Ser dialético* significa elucidar posições opostas quando há um impasse e depois avançar em direção à síntese. Isso significa expandir a perspectiva do terapeuta e da equipe para levar em conta o pensamento sistêmico. E significa reconhecer que o movimento nunca para e que é útil manter as coisas em movimento na terapia e na equipe. Isso catalisa o pensamento criativo e improvisacional e ações que incluem correr alguns riscos diante da incerteza. Reconhecer que a equipe é um sistema e que mudanças em qualquer membro podem trazer mudanças para todos abre a porta para uma infinidade de intervenções baseadas na dialética.

COMENTÁRIOS FINAIS

A equipe de consultoria é um modo de DBT. Como tal, é outro contexto de tratamento no qual utilizam-se os paradigmas e princípios que fundamentam a prática da DBT. Muito mais do que ser uma reunião para falar sobre o tratamento, é uma reunião para *praticar* o tratamento. E um dos objetivos da reunião da equipe de consultoria (a identificação, a prevenção e o tratamento do *burnout* do terapeuta como um evento esperado) é de alta prioridade. Ao conceituar o *burnout* em termos da teoria biossocial da DBT, assim como conceituamos a desregulação emocional de nossos pacientes, abrimos o caminho para usar o restante do tratamento para nos ajudar. Ao praticar os princípios de aceitação, mudança e dialética na prevenção e no tratamento do *burnout*, não apenas trabalhamos na solução do *burnout*, mas também reforçamos nossas capacidades para o tratamento como um todo.

Posfácio

O processo de escrever este livro nos últimos três anos me mudou, exigindo um esforço disciplinado para considerar como um foco baseado em princípios na terapia comportamental dialética (DBT, do inglês *dialectical behavior therapy*) expande minhas opções, aumenta minha flexibilidade e permite a criatividade – tudo isso sem comprometer um foco na adesão. Embora tenha encontrado minha própria maneira de descrever as ideias aqui contidas, usando uma infinidade de exemplos de casos, não há nada neste livro que não estivesse presente ou antecipado pelo brilhante trabalho de Marsha Linehan. Se você encontrou algo de valor nestas páginas, devo isso a ela, a meus pacientes, a minhas equipes de consultoria e a meus colegas.

Este Posfácio tem como objetivo reapresentar os paradigmas e os princípios de forma acessível, concisa e memorável, tornando mais fácil para os leitores lembrá-los e levá-los para as sessões de terapia, como eu faço. Quando foco minha atenção nos princípios, descubro que as estratégias surgem em minha prática sem precisar procurá-las. A sensação aumentada de liberdade e fluidez tem me ajudado a navegar por momentos difíceis na terapia.

TRÊS PARADIGMAS, 15 PRINCÍPIOS

A justaposição e a síntese dos paradigmas de mudança, aceitação e dialética, ou, mais precisamente, os paradigmas cognitivo-comportamental, de *mindfulness* e dialético, fornecem uma base poderosa para tirar nossos pacientes do inferno da disfunção emocional crônica e grave. Minha suspeita é que os três paradigmas também fornecem uma excelente base para resolver problemas na vida em geral: como lidar com doenças crônicas ou cuidar de um parceiro em declínio, como ser pai de adolescentes ou gerenciar a vida familiar, como enfrentar a adversidade no trabalho e até mesmo como chegar ao mais alto nível de desempenho. Extrapolar os princípios da DBT para além da situação clínica será assunto para outro livro. Agora, concentro-me em cada um dos três paradigmas, apresentando os cinco princípios de cada um.

Mudança (terapia cognitivo-comportamental)

1. *Direção* (direcionamento de alvos)
2. *Força* (comprometimento, apego, contingências)
3. *Persistência* (monitoramento, contingências, equipe de consultoria)
4. *Inteligência* (avaliação comportamental, formulação de caso, plano de tratamento)
5. *Técnica* (protocolos, estratégias, habilidades)

Os cinco primeiros princípios são os componentes principais do paradigma da mudança. Eles são as chaves para resolver problemas persistentes na terapia. Nessa seção, cada um desses princípios é amplamente declarado em prol da brevidade. O primeiro é *direção*, manifestado na DBT como *direcionamento de alvos*. Trabalhar em direção a um alvo recruta outros princípios e

atividades de solução de problemas. Os alvos do paciente constituem o plano de tratamento; os alvos do terapeuta envolvem mover o paciente em direção à realização de seus alvos. Os melhores alvos são convincentes, claros, específicos, realistas e definidos em colaboração. A ausência de uma direção é vista na *deriva*. Com *direcionamento de alvos*, refiro-me ao estabelecimento, à priorização e à utilização dos alvos prioritários do tratamento, ao reconhecimento e à busca dos alvos secundários do tratamento e ao recrutamento do engajamento do paciente em procedimentos terapêuticos (p. ex., análise em cadeia do comportamento ou cartão diário).

O segundo princípio de mudança é a *força*, manifestada na DBT como fortalecimento do *apego*, obtenção de um *comprometimento* com um alvo específico e *reforço* do apego e compromisso. Sem força suficiente, não podemos resolver o problema-alvo. Muitos problemas na terapia resultam de força insuficiente, e o terapeuta que pode aumentar seus próprios apego e compromisso, assim como os do paciente, tem melhor chance de alcançar os resultados desejados.

O terceiro princípio de mudança é a *persistência*, que envolve manter força suficiente em direção aos alvos identificados ao longo do tempo. Embora o tratamento possa começar com um surto de direcionamento e comprometimento, a persistência requer impulso e resistência. O terapeuta DBT insiste na prática de *monitorar* o progresso em relação aos alvos do tratamento, o que se refere ao automonitoramento do paciente no cartão diário toda noite e à revisão semanal pelo terapeuta. Monitorar alvos e níveis de comprometimento ao longo do tratamento leva à persistência. A equipe de consultoria ajuda o terapeuta a manter-se no caminho certo em relação aos alvos, a gerar força suficiente em si mesmo e no paciente e a persistir no tratamento. Em parte, esses esforços são alcançados por meio de identificação, prevenção e tratamento do *burnout* profissional.

Direção, força e persistência são ingredientes necessários, mas não suficientes, para resolver problemas persistentes. O quarto princípio é a *inteligência*. Usando *avaliações comportamentais* repetidas, orientadas por uma *formulação de caso* em evolução baseada na teoria e nos pressupostos da DBT, chegamos a um *plano de tratamento* e o ajustamos para impulsionar os alvos com força, persistência e inteligência.

O quinto princípio de mudança envolve o uso de *técnicas* adequadas para alcançar as metas. Para o terapeuta, a técnica requer *protocolos e estratégias*. Os terapeutas DBT precisam ter *expertise* em estratégias cognitivo-comportamentais, protocolos e estratégias específicas da DBT e no conjunto de *habilidades* da DBT. Caso contrário, toda a direção, força, persistência e inteligência do mundo não se unirão para efetuar a mudança terapêutica.

Aceitação (*mindfulness*)

1. *Consciência do momento presente*
2. *Impermanência*
3. *Desapego*
4. *Interexistência*
5. *Perfeito como é*

O primeiro princípio de aceitação é *consciência do momento presente*, no qual nos referimos ao esforço de trazer atenção, repetidamente, para o momento presente, sem julgamento. A consciência da presença e a prática repetida de retornar ao momento presente comunicam ao paciente, de muitas maneiras, “meu querido paciente, estou presente, estou aqui por você agora”.

O segundo princípio de aceitação, *impermanência*, refere-se à aguda consciência do terapeuta de que este momento presente e singular é o único momento, e nunca vai se repetir. Isso aprofunda a participação do terapeuta no momento, o que,

esperançosamente, ativa um engajamento semelhante pelo paciente. Por meio da consciência repetida da impermanência de tudo neste momento, o terapeuta comunica ao paciente, de muitas maneiras, “junte-se a mim neste momento precioso, neste momento único”.

O terceiro princípio de aceitação, *desapego*, refere-se à prática do terapeuta de deixar de lado os apegos a várias crenças e percepções. O apego às crenças do que “deveria” estar acontecendo, mas não está, do que “deveríamos ser capazes de fazer como terapeutas”, mas não estamos, e do que nossos pacientes “deveriam estar fazendo”, mas não estão, leva inevitavelmente ao sofrimento e à desregulação. Ao deixar de lado esses tipos de apego, enquanto se concentra em “simplesmente” praticar a DBT, o terapeuta cultiva e preserva o frescor, a liberdade e o equilíbrio enquanto permanece focado nos alvos.

Como quarto princípio de aceitação, *interexistência* refere-se a várias percepções fundamentais: que de certa perspectiva não há tal coisa como fronteiras, não há tal coisa como um *self*, que qualquer entidade é constituída inteiramente por outras entidades (também conhecido como “sensação de vazio” no pensamento budista) e que o grau de interdependência entre todos os fenômenos é profundo e constante. A consciência e a prática de interdependência facilitam a dissolução das fronteiras entre paciente e terapeuta, promovem a sensação de que “estamos juntos nisso” e aumentam a autenticidade e a reciprocidade do terapeuta. A consciência do não *self* nos ajuda a perceber que nossos comportamentos são influenciados pelo contexto e por contingências tanto quanto os comportamentos dos pacientes. Somos capazes de ver a realidade de forma mais objetiva e considerar as influências mútuas que afetam todos os envolvidos: terapeutas, pacientes e contextos.

O quinto e último princípio de aceitação, *perfeito como é*, refere-se à compreensão de que tudo emerge de causas e condições e

que, portanto, tudo está exatamente como deveria ser. Flui da consciência dessa realidade um conjunto completo de estratégias de validação. Esse princípio promove a aceitação radical da realidade, reduz o sofrimento que resulta da negação da realidade e ajuda o terapeuta a manter equilíbrio e frescor.

Dialética

1. *Oposição*
2. *Síntese*
3. *Pensamento sistêmico*
4. *Processos transacionais*
5. *Fluxo*

O primeiro princípio dialético é o da *oposição*. Reconhecemos que a realidade naturalmente consiste em forças opostas: isto é, que *X* provoca *–X*. Tensão, conflito, caos e confusão são geralmente manifestações da presença de oposição entre duas ou mais posições. Ao reconhecermos a presença ubíqua da oposição em nós mesmos, entre a equipe, entre pacientes e terapeutas, dentro dos pacientes e entre pacientes e seus ambientes, mantemos nosso equilíbrio diante da oposição.

O segundo princípio dialético da *síntese* começa com a busca pelo núcleo válido de verdade em cada lado de uma oposição. Em vez de decidir entre as duas posições, buscamos a validade em ambas e tentamos preservá-las. Enfatizamos um processo de busca pela síntese em vez de chegar a uma conclusão, mesmo que precisemos chegar a uma conclusão também. Uma vez que encontramos a validade em ambas as posições, permitimos que a síntese ocorra de forma que ambos os núcleos de verdade sejam preservados em uma nova construção. A busca pela síntese é um alvo constante e global na DBT, enquanto procuramos os alvos prioritários e secundários.

Com o terceiro princípio dialético do *pensamento sistêmico*, avaliamos e tratamos o fenômeno ou conflito do momento ampliando nosso ponto de vista para abranger as variáveis sistêmicas que impactam no momento. Esse princípio amplia nossa perspectiva na avaliação das variáveis controladoras e no tratamento do alvo ou conflito atual. Cada elemento é uma parte de um sistema multipartido, provavelmente de vários sistemas, e mudanças nas outras partes mudarão esse elemento. Cada elemento também tem partes dentro dele e, portanto, é um “todo”, contendo partes, bem como uma parte de outros totais. Qualquer mudança em cada parte mudará o todo e cada parte associada.

O quarto princípio dialético é algo como uma subseção do terceiro e envolve a consciência e uso dos *processos transacionais*. Cada elemento ou fenômeno está em transação com outro (ou mais). A identidade de alguém não “está sozinha”, mas é determinada de maneira transacional. A identidade muda quando a transação muda. Reconhecer os processos transacionais como a regra, não a exceção, ajuda-nos a avaliar os fatores que mantêm um determinado comportamento ou identidade, apontando-nos para formas de mudar comportamentos ou identidades por meio da mudança de transações.

O quinto princípio dialético envolve a compreensão do *fluxo*, que se sobrepõe ao princípio de aceitação da *impermanência*. Tudo, em todos os níveis, até cada célula, molécula e subpartícula, está sempre em movimento. Quando pensamos que “nada está acontecendo”, que as coisas estão paradas e que a mesma coisa é repetida vezes sem conta, é uma ilusão que disfarça o fato de que o movimento continua. Se abordamos um fenômeno sem fazer nada, a mudança continua. Se o abordamos fazendo algo, a mudança continua. O terapeuta DBT, consciente de que o movimento é constante, envolve o paciente no tratamento, mesmo em “situações difíceis”, com rapidez, movimento e fluidez.

FINALMENTE...

Neste livro, tentei esclarecer a compreensão e a prática dos princípios na condução da DBT. Consideramos as vantagens de uma abordagem baseada em princípios e como ela aumenta e fortalece a prática aderente ao modelo. Espero que, ao focar nos princípios e fornecer uma variedade de exemplos clínicos, o leitor seja capaz de fortalecer a prática da DBT com maior flexibilidade.

Referências

Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2004). Mentalization-based treatment for BPD. *Journal of Personality Disorders*, 18(1), 36–51.

Borges, N. B., Cassas, F. A. et al. (2012). *Clínica analítico-comportamental: aspectos teóricos e práticos*. Artmed.

Brown, J. (2016). *The emotion regulation skills system for cognitively challenged clients: A DBT-informed approach*. New York: Guilford Press.

Buber, M. (1923). *Ich und Du [I and thou]*. Leipzig, Germany: Insel Verlag.

Catatania, A. C. (1999). *Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição* (4. ed.). Artmed.

Dimeff, L. A., & Koerner, K. (2007). *Dialectical behavior therapy in clinical practice: Applications across disorders and settings*. New York: Guilford Press.

Feigenbaum, J. D., Fonagy, P., Pilling, S., Jones, A., Wildgoose, A., & Bebbington, P. E. (2011). A real-world study of the effectiveness of DBT in the UK National Health Service. *British Journal of Clinical Psychology*, 51(2), 121–141.

Gottman, J. M., & Katz, L. F. (1989). Effects of marital discord on young children's peer interaction and health. *Developmental Psychology*, 25, 373–381.

Gutteling, B. M., Montagne, B., Nijs, M., & van den Bosch, L. M. C. W. (2012). Dialectical behavior therapy: Is outpatient group psychotherapy an effective alternative to individual therapy?: Preliminary conclusions. *Comprehensive Psychiatry*, 53(8), 1161–1168.

Haley, J. (1973). *Uncommon therapy: The psychiatric techniques of Milton Erickson, M.D.* New York: Norton.

Harned, M. S., Jackson, S. C., Comtois, K. A., & Linehan, M. M. (2010). Dialectical behavior therapy as a precursor to PTSD treatment for suicidal and/or self-injuring women with borderline personality disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 23, 421–429.

Harned, M. S., Korslund, K. E., & Linehan, M. M. (2014). A pilot randomized controlled trial of DBT with and without the DBT prolonged exposure protocol for suicidal and self-injuring women with borderline personality disorder and PTSD. *Behaviour Research and Therapy*, 55, 7–17.

Hill, D. M., Craighead, L. W., & Safer, D. L. (2011). Appetite-focused dialectical behavior therapy for the treatment of binge eating with purging: A preliminary trial. *International Journal of Eating Disorders*, 44(3), 249–261.

Kernberg, O. F. (1984). *Severe personality disorders*. New Haven, CT: Yale University Press.

Koerner, K., Dimeff, L., & Swenson, C. (2007). Adopt or adapt: Fidelity matters. In L. A. Dimeff & K. Koerner (Eds.), *Dialectical behavior therapy in clinical practice: Applications across disorders and settings* (pp. 19–36). New York: Guilford Press.

Koons, C., Robins, C. J., Tweed, J. L., Lynch, T. R., Gonzales, A. M., Morse, J. Q., et al. (2001). Efficacy of dialectical behavior therapy in women veterans with borderline personality disorder. *Behavior Therapy*, 32, 371–390.

Linehan, M. M. (1987). Dialectical behavior therapy for borderline personality disorder: Theory and method. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 51(3), 261–276.

Linehan, M. M. (1993a). *Skills training manual for treating borderline personality disorder*. New York: Guilford Press.

Linehan, M. M. (1997). Validation and psychotherapy. In A. Bohart & L. Greenberg (Eds.), *Empathy reconsidered: New directions in psychotherapy* (353–392). Washington, DC: American Psychological Association.

Linehan, M. M. (2010). *Terapia cognitivo-comportamental para transtorno da personalidade borderline: guia do terapeuta*. Artmed.

Linehan, M. M. (2018a). *Treinamento de habilidades em DBT: manual de terapia dialética comportamental para o paciente* (2. ed.). Artmed.

Linehan, M. M. (2018b). *Treinamento de habilidades em DBT: manual de terapia dialética comportamental para o terapeuta* (2. ed.). Artmed.

Linehan, M. M., Armstrong, H. E., Suares, A., Allmon, D., & Heard, H. L. (1991). Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. *Archives of General Psychiatry*, 48, 1060–1064.

Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M.Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., et al. (2006). Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs. therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. *Archives of General Psychiatry*, 63(7), 757–766.

Linehan, M. M., Dimeff, L. A., Reynolds, S. K., Comtois, K. A., Welch, S. S., Heagerty, P., et al. (2002). Dialectical behavior therapy versus comprehensive validation plus 12-step for the treatment of opioid dependent women meeting criteria for borderline personality disorder. *Drug and Alcohol Dependence*, 67(1), 13–26.

Linehan, M. M., Heard, H. L., & Armstrong, H. E. (1993). Naturalistic follow-up of a behavioral treatment for chronically parasuicidal borderline patients. *Archives of General Psychiatry*, 50, 971–974.

Linehan, M. M., McDavid, J., Brown, M. Z., Sayrs, J. H. R., & Gallop, R. J. (2008). Olanzapine plus dialectical behavior therapy for irritable women meeting criteria for borderline personality disorder: A double blind, placebo-controlled pilot study. *Journal of Clinical Psychiatry*, 69(6), 999–1005.

Linehan, M. M., Schmidt, H., Dimeff, L. A., Craft, J. C., Kanter, J., & Comtois, K. A. (1999). Dialectical behavior therapy for patients with borderline personality disorder and drug dependence. *American Journal of Addiction*, 8(4), 279–292.

Lynch, T. R., Morse, J. Q., Mendelson, T., & Robins, C. J. (2003). Dialectical behavior therapy for depressed older adults. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 11(1), 33–45.

McCann, R. A., Ball, E. M., & Ivanoff, A. (2000). DBT with an inpatient forensic population: The CMHIP forensic model. *Cognitive and Behavioral Practice*, 7, 447–456.

Mehlum, L., Tormoen, A. J., Ramberg, M., Haga, E., Diep, L. M., Laberg, S., et al. (2014). Dialectical behavior therapy for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: A randomized trial. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 53(10), 1082–1091.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2012). *Motivational interviewing: Helping people change* (3rd ed.). New York: Guilford Press.

Moreira, M. B., & Moreira, C. A. (2019). *Princípios básicos de análise do comportamento* (2. ed.). Artmed.

Neacsui, A. D., Rizvi, S. L., & Linehan, M. M. (2010). DBT skills use as a mediator and outcome of treatment for borderline personality disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 48(9), 832–839.

Ougrin, D. (2011). Efficacy of exposure versus cognitive therapy in anxiety disorders: Systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 11, 1–6.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. *American Psychologist*, 47(9), 1102–1114.

Rathus, J. H., & Miller, A. H. (2002). Dialectical behavior therapy for suicidal adolescents. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 32(2), 146–157.

Rathus, J. H., & Miller, A. L. (2022). *Manual de habilidades em DBT para adolescentes*. Sinopsys.

Rogers, C. (1951). *Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory*. New York: Houghton Mifflin.

Safer, D. L., Robinson, A. H., & Jo, B. (2010). Outcome from a randomized controlled trial of group therapy for binge eating disorder: Comparing dialectical behavior therapy adapted for binge

eating to an active comparison group therapy. *Behavior Therapy*, 41(3), 106–120

Safer, D. L., Telch, C. F., & Agras, W. S. (2001). Dialectical behavior therapy for bulimia nervosa. *American Journal of Psychiatry*, 158, 632–634.

Shneidman, E. (1996). *The suicidal mind*. New York: Oxford University Press. Swenson, C. (1989). Kernberg and Linehan: Two approaches to the borderline patient. *Journal of Personality Disorders*, 3(1), 26–35.

Telch, C. F., Agras, W. S., & Linehan, M. M. (2001). Dialectical behavior therapy for binge eating disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(6), 1061–1065.

Thich Nhat Hanh. (1975). *The miracle of mindfulness*. Boston: Beacon Press.

Turner, R. M. (2007). Naturalistic evaluation of dialectical behavior therapy-oriented treatment for borderline personality disorder. *Cognitive and Behavioral Practice*, 7, 413–419.

van den Bosch, L. M. C., Koeter, M., Stijnen, T., Verheul, R., & van den Brink, W. (2005). Sustained efficacy of dialectical behavior therapy for borderline personality disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 43, 1231–1241.

van den Bosch, L. M. C., Verheul, R., Schippers, G. M., & van den Brink, W. (2002). Dialectical behavior therapy of borderline patients with and without substance abuse problems: Implementation and long-term effects. *Addictive Behaviors*, 27(6), 911–923.

Verheul, R., van den Bosch, L. M. C., & Koeter, M. W. J. (2003). Dialectical behavior therapy for women with borderline personality disorder. *British Journal of Psychiatry*, 182, 135–140.

Conheça Também



DIMEFF, RIZVI & KOERNER (Orgs.)

Terapia comportamental dialética na prática clínica: aplicações em diferentes transtornos e cenários – 2.ed.



LINEHAN, M. M.

Terapia cognitivo-comportamental para transtorno da personalidade *borderline*: guia do terapeuta



LINEHAN, M. M.

Treinamento de habilidades em DBT: manual de terapia comportamental dialética para o paciente – 2.ed.



LINEHAN, M. M.

Treinamento de habilidades em DBT: manual de terapia comportamental dialética para o terapeuta – 2.ed.



STUNTZ & LINEHAN

Enfrentando o câncer: habilidades da terapia comportamental dialética (DBT) para lidar com suas emoções e equilibrar as incertezas com esperança

Sobre o Grupo A

O Grupo A está preparado para ajudar pessoas e instituições a encontrarem respostas para os desafios da educação. Estudantes, professores, médicos, engenheiros, psicólogos. Profissionais das carreiras que ainda não têm nome. Universidades, escolas, hospitais e empresas das mais diferentes áreas. O Grupo A está ao lado de cada um. E também está nas suas mãos. Nos seus conteúdos virtuais. E no lugar mais importante: nas suas mentes.

Acesse

0800 703 3444

sac@grupoa.com.br

[Rua Ernesto Alves, 150](#)

Floresta • Porto Alegre / RS

CEP: 90040-340

grupo a⁺